

Sistema documental *completo*

Los ocho documentos que gobiernan y operan el centro, en un solo cuaderno: qué creemos, qué apostamos, qué se decide y cómo se ejecuta, fase a fase y puesto a puesto.

VERSIÓN 32.0

SEPTIEMBRE 2026

OCHO DOCUMENTOS

631 PÁGINAS

USO INTERNO

CONFIDENCIAL

No medias sonrisas.

Documento de uso interno y confidencial. Contiene información económica, laboral y estratégica. No se difunde fuera de la organización sin autorización expresa de la Dirección General.

Qué hay dentro

01	GOBIERNO	4
	Plan de Dirección	80 pág.
	Qué creemos, qué apostamos y las quince decisiones que se someten a la Junta	
02	DERIVADO	84
	Presentación de Junta	44 pág.
	Cuarenta y tres diapositivas extraídas del Plan de Dirección, para la sesión	
03	PLAN	128
	Plan Maestro de Marketing	59 pág.
	Setenta y seis acciones sobre los doce estados del paciente	
04	TRONCAL	187
	Manual Maestro de Operaciones	202 pág.
	Las catorce fases del recorrido del paciente, los seis puestos y la puesta en marcha	
05	VISTA OPERATIVA	389
	Protocolos por puesto	19 pág.
	El protocolo del centro visto desde cada uno de los seis puestos	
06	TRONCAL	408
	Protocolo de Primera Visita	90 pág.
	Las doce fases de la primera visita, minuto a minuto	
07	TRONCAL	498
	Otros documentos del sistema	127 pág.
	Los catorce documentos de apoyo, del compendio maestro al programa de cuidado	
08	INSTRUMENTO	625
	Los números del centro	7 pág.
	Los diez indicadores y los cinco números, mes a mes	

Todas las piezas comparten número de versión y fecha. Cada documento existe además por separado, en su propio archivo, y el sistema entero cabe en una sola página web que funciona sin conexión.

Documento de gobierno · Uso interno · Confidencial · Junta Directiva

No medias sonrisas. Ni medias decisiones.

Centro de Excelencia Implantológica Alma
Calle Progreso 2 · Ourense

Plan de Dirección · v32.0
Septiembre 2026 · versión única del sistema

23 apartados · 6 partes · 15 decisiones
Lectura completa 55' · resumen 3'

El planteamiento

Un plan, no un informe

Un informe cuenta lo que ha pasado. Un plan afirma qué creemos que es cierto sobre este mercado, qué apostamos en consecuencia, y bajo qué condiciones estaríamos equivocados.

Este documento contiene las tres cosas. Estado del proyecto, línea base, riesgos y hoja de ruta —lo que cualquier memoria trae— y además el mapa competitivo, el foso que estamos construyendo, la economía unitaria con sus escenarios, la lógica de creación de valor de empresa, el pre-mortem, la asignación de capital, la trazabilidad de cada acuerdo, el puente hasta el objetivo de 1,2 M€ con su cartera de nueve campañas, y los dos cuadernillos: quince hojas de acta y nueve fichas de campaña. Cada afirmación lleva su naturaleza marcada —**hecho**, **modelo** o **pendiente**— para que la Junta sepa en todo momento sobre qué está deliberando. No hay una sola cifra presentada como dato propio que no lo sea.

Lectura 55' Resumen ejecutivo: 3 minutos	Decisiones 15 Se someten a aprobación en esta sesión
Riesgos críticos 5 Con propietario y mitigación asignados	Sistema documental 17 Documentos operativos vigentes
Objetivo 1,2 M€ Facturación anual en el ejercicio tercero	Ventana crítica 100 d Lo que no se fija ahora se vuelve costumbre

Manifiesto · La regla que ordena todo lo demás

Media sonrisa es la que se hace a medias: el corte que nadie ve y el paciente sí nota.

No hablamos de estética. Hablamos de la mitad que se recorta cuando hay prisa, cuando falta una pieza, cuando el paciente no va a protestar. La sonrisa que se entrega funcionando pero sin explicar. La revisión que se agenda «cuando llame». El presupuesto que se firma sin que nadie haya dicho en voz alta qué pasa si falla.

Esa mitad invisible es exactamente donde se decide si un centro es bueno o es excelente. Y es la única parte del negocio que ningún competidor puede copiarnos comprando una máquina.

Por eso el lema no es publicidad. Es el criterio de aceptación de cada acto clínico y de cada decisión de esta Junta.

-
- | | |
|----|---|
| 01 | Lo que no está escrito no existe. Si un estándar no puede verificarse en una lista, es una intención, no un estándar. |
|----|---|
-
- | | |
|----|---|
| 02 | El paciente no compra un implante: compra dejar de esconder la boca. Todo lo que no reduzca ese miedo es coste, no valor. |
|----|---|
-
- | | |
|----|--|
| 03 | Ninguna decisión clínica se toma en el sillón sin diagnóstico completo. La prisa es la primera causa de media sonrisa. |
|----|--|
-
- | | |
|----|---|
| 04 | El precio no se defiende con descuento, se defiende con evidencia. Un descuento del 10 % se lleva por delante una parte del beneficio muy superior al 10 %. |
|----|---|
-
- | | |
|----|--|
| 05 | El tratamiento no termina cuando se coloca: termina cuando el paciente vuelve por su cuenta. Alma Te Cuida es la forma contractual de esa frase. |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 06 | Un error contado a tiempo es información. Un error escondido es un pasivo. La escalada de incidencias existe para hacer barato el primero. |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 07 | El equipo no se motiva, se ordena. Nadie da lo mejor de sí en un puesto donde no sabe qué se espera de él. |
|----|--|
-
- | | |
|----|---|
| 08 | Todo lo anterior se cumple también cuando nadie mira. Ese es el único test que importa. |
|----|---|
-



CONTROL DEL DOCUMENTO

Qué es esto, quién responde y cómo se cita

La Junta delibera sobre documentos controlados: con propietario, versión, fecha de aprobación y trazabilidad de cambios. Este bloque existe para que cualquier acuerdo pueda referirse a un apartado concreto de una versión concreta.

CAMPO	CONTENIDO
Título	Plan de Dirección para la Junta Directiva
Versión	v32.0 · Septiembre 2026 · versión única de todo el sistema
Clasificación	Uso interno · Confidencial · No difundir fuera del órgano
Propietario	Dirección General
Elaborado con	Los 17 documentos operativos del sistema Alma: los 3 troncales y los 14 de apoyo, censados en el apartado 0.1
Destinatarios	Miembros de la Junta Directiva
Aprobación	Pendiente · se solicita en esta sesión
Próxima revisión	Trimestral, o ante incidencia grave

CÓMO LEER LAS MARCAS

MARCA	SIGNIFICA
 HECHO	Está construido, documentado y verificable hoy en el sistema
 MODELO	Cálculo derivado de supuestos explícitos, recogidos en el apartado 18. No es un dato del centro
 PENDIENTE	Requiere una decisión, un dato o una validación externa que aún no existe

Advertencia de método

Este documento **no contiene ni una sola cifra real de explotación del centro**, porque la línea base económica está en construcción. Donde hace falta un orden de magnitud para razonar, se emplea un rango sectorial identificado como supuesto de trabajo —no verificado y no atribuible a este centro— y se marca como  MODELO. Sustituir esos rangos por los datos reales es la primera tarea del trimestre.

Cómo citar en acta

Cada apartado lleva su marca de sección (apartados 1 a 23) y cada decisión su código (D1 a D15). Un acuerdo se recoge, por ejemplo, como «Aprobada D3 en los términos del 17 de la Memoria de Dirección v32.0». Los documentos operativos se citan por su nombre y versión, que es la misma para todos: Manual Maestro v32.0, Protocolo de Primera Visita v32.0, Otros documentos del sistema v32.0.

Censo documental

Un sistema documental que no se cuenta a sí mismo acaba contradiciéndose. Esta es la lista completa de lo que existe, con su clase y su propietario. **Cualquier cifra sobre «cuántos documentos hay» sale de aquí y de ningún otro sitio.**

PIEZA	CLASE	QUÉ CONTIENE	PROPIETARIO	VERSIÓN
Plan de Dirección	Gobierno	Este documento. Dirige y decide; no ejecuta nada	Dirección General	32.0
Manual Maestro de Operaciones	Troncal	Las 14 fases del recorrido del paciente, los 6 puestos, RACI, indicadores e incentivos	Dirección de Centros	32.0
Protocolo de Primera Visita	Troncal	Las 12 fases de la primera visita, minuto a minuto	Dirección de Centros	32.0
Otros documentos del sistema	Troncal	Los 14 documentos de apoyo , del compendio maestro al programa de cuidado	Dirección de Centros	32.0
Plan Maestro de Marketing	Plan	Las 76 acciones posibles sobre los 12 estados del paciente, con dueño, coste y semáforo legal	Dirección General	32.0
Los números del centro	Instrumento	Los 10 indicadores y los 5 números, mes a mes	Gerencia	32.0
Presentación de Junta	Derivado	43 diapositivas extraídas de este Plan de Dirección; no contiene nada que no esté aquí	Dirección General	32.0
Portada del sistema	Índice	Puerta de entrada; sin contenido propio	Dirección General	32.0

Documentos troncales 3 Manual Maestro, Protocolo de Primera Visita y Otros documentos del sistema.	Documentos de apoyo 14 Viven dentro del tercer troncal, numerados del 1 al 14.
Documentos operativos 17 La suma de los dos anteriores. Es la única cifra que debe citarse al hablar del sistema operativo.	Piezas en total 22 Los 17 operativos, el Plan de Dirección, el Plan Maestro de Marketing, la presentación, el instrumento de captura y la portada.

La regla de versión única

Todas las piezas del sistema comparten número de versión y fecha. No hay documentos de una edición conviviendo con documentos de otra.

Se publica el sistema entero o no se publica: si un documento cambia lo suficiente como para merecer versión nueva, la reciben todos. Es más caro de mantener y es la única manera de que una cifra citada en Junta signifique lo mismo en los siete archivos.

01

RESUMEN EJECUTIVO

Dos minutos

Si la Junta solo lee una página, esta es la página.

La apuesta, en una línea

Un centro que resuelve lo que otros rechazan y que no termina la relación cuando cobra.

Sobre esa frase se ha construido un sistema operativo completo: qué se hace en cada minuto de la visita, quién responde de cada cosa, qué queda registrado y cómo se mide. La ventaja competitiva no es el equipamiento —lo reivindican todos— sino la ejecución sistemática y la relación a largo plazo.

Qué está hecho ■ HECHO

El sistema operativo, completo

Diecisiete documentos operativos vigentes —tres troncales y catorce de apoyo, censados en el censo documental— que cubren el recorrido del paciente en catorce fases, los seis puestos, la puesta en marcha, la verificación del centro, la innovación y la captación. No es un plan: es normativa interna aplicable desde hoy.

Qué falta ■ PENDIENTE

Los números propios y quince decisiones

La línea base económica no está cerrada y hay quince decisiones de gobierno —precios, garantías, marca, presupuesto de captación, programa de cuidado, sedación, flujo digital, responsables funcionales, regla de innovación, prelación del capital, condición de segunda unidad, suelo de inversión en el sistema, disparadores de Junta extraordinaria, obligatoriedad del cuidado en el cierre y objetivo de facturación— que bloquean o condicionan el resto del plan.

Qué se pide hoy

Decidir, no informarse

La Junta no tiene que validar el sistema operativo: tiene que resolver las quince decisiones del apartado 17, autorizar el presupuesto del primer año y fijar la fecha de la revisión trimestral.

Las cinco ideas que sostienen la memoria

#	IDEA	CONSECUENCIA PARA LA JUNTA
1	La ventana de los 100 días es irrepetible	Lo que no se establezca en el primer trimestre se convierte en costumbre y multiplica su coste de corrección
2	El activo más frágil es el equipo, no el equipamiento	Cero bajas voluntarias es un objetivo de Junta, no un asunto de recursos humanos
3	El producto pendiente heredado es obligación y riesgo a la vez	Es la primera fuente de reclamaciones en clínicas adquiridas; se cuantifica y se ejecuta antes de captar nada nuevo
4	La secuencia manda: sostener → recuperar → fidelizar → captar	Invertir en captación con la cartera propia desatendida es la peor asignación de recursos posible

#	IDEA	CONSECUENCIA PARA LA JUNTA
5	La relación se monetiza más que la transacción	El programa de cuidado anual y el mantenimiento son la palanca de valor a largo plazo, no un extra comercial

Parte



La posición

Dónde estamos parados y por qué ahí

Toda estrategia empieza por una afirmación sobre el mercado que puede resultar falsa. Aquí está la nuestra, el mapa de quién ocupa cada posición en Ourense y la única pregunta que importa: qué tendría que hacer un competidor para quitarnos el sitio, y cuánto tiempo tardaría.

02

LA APUESTA DEL PROYECTO

Por qué este centro y no otro

Ourense tiene densidad alta de oferta generalista y competencia creciente en precio. Diferenciarse por tecnología es insuficiente: la reivindican todos. La oportunidad está en tres segmentos que casi nadie atiende y que comparten una característica: no compran precio, compran solución.

SEGMENTO	POR QUÉ ESTÁ DESATENDIDO	BARRERA DE ENTRADA PARA UN COMPETIDOR
Casos de alta complejidad Pérdida ósea significativa, tratamiento desestimado en otro centro	Exige competencia clínica específica y flujo digital completo; es más cómodo decir que no	No se resuelve comprando equipamiento: requiere criterio y sistema
Ansiedad dental severa Necesidad acumulada durante años, evitación por temor	Casi ninguna clínica lo comunica explícitamente	Circuito de sedación con habilitación, equipamiento y protocolo. Barrera regulatoria alta
Mantenimiento implantológico Portadores de implantes sin seguimiento estructurado	Poco atractivo a corto plazo; no produce caja inmediata	Requiere sistema y constancia, no inversión. Decisivo a largo plazo

La promesa, completa

«Le devolvemos su sonrisa completa, en el menor tiempo posible, y le cuidamos para siempre.»

La primera mitad es el resultado y la fija el posicionamiento «No medias sonrisas»: ningún tratamiento se deja a medias. La segunda es la relación, y su instrumento concreto es el programa de cuidado anual, que convierte «le cuidamos» en revisiones reales.

LOS INDICADORES QUE ACREDITAN LIDERAZGO

La facturación de un trimestre no acredita liderazgo de mercado. Estos cinco sí, y ninguno se compra:

- **Proporción de captación por recomendación** — la única métrica reputacional no adquirible · 18-36 meses
- **Pacientes en mantenimiento activo** — independencia respecto a la inversión publicitaria · 24 meses
- **Producto pendiente en mínimos** — capacidad real de entregar lo comprometido · 6-12 meses
- **Rotación de equipo residual** — atractivo como empleador · 12-24 meses
- **Reputación digital sostenida** — no sujeta a picos de campaña · 12-18 meses

03 EL MAPA COMPETITIVO

Cuatro formas de vender implantes en Ourense, y la que dejamos libre

El mercado de la implantología en una ciudad media no se segmenta por precio, sino por **quién asume el riesgo del resultado**. Esa es la variable que ordena el mapa y la que explica por qué el hueco que ocupamos existe.

La lectura habitual del sector —cadena barata frente a clínica cara— es una simplificación que induce a error estratégico. Lo que un paciente compara no son dos precios: compara dos promesas de a quién puede llamar cuando algo salga mal dentro de tres años. Situar el centro en ese eje, y no en el del precio, cambia por completo qué hay que construir.

Posición A · Volumen

La cadena de precio

Compite por captación masiva y financiación. El profesional rota, el protocolo lo fija la central y el riesgo del resultado a largo plazo queda difuso. Gana en primera visita por precio y pierde en la segunda intervención, cuando el paciente ya no encuentra a quien le operó.

Posición B · Generalista

La clínica de barrio con implantes

Buen vínculo personal, agenda mixta, casuística de implantología baja. Resuelve el caso sencillo con solvencia y deriva —o no deriva y debería— el complejo. Su límite no es la voluntad: es el número de casos al año que ve.

Posición C · Especialista aislado

El cirujano de referencia

Excelencia técnica real concentrada en una persona. Es la competencia más seria en resultado clínico y la más frágil en continuidad: cuando esa persona no está, no hay sistema debajo que sostenga el estándar. Su reputación no es transferible ni vendible.

Posición D · La nuestra

Excelencia con sistema y con contrato

Casuística de especialista, estándar escrito y verificable que no depende de quién esté de guardia, y un compromiso formal de seguimiento —Alma Te Cuida— que pone por escrito quién responde y durante cuánto tiempo. No es «lo mismo pero mejor»: es una categoría distinta de promesa.

Las posiciones A, B y C compiten por vender el acto. Nosotros vendemos el hecho de que alguien siga respondiendo cuando el acto ya se cobró.

La diferencia que justifica el precio

Por qué la posición D está estructuralmente poco ocupada

No por falta de intención: por coste de construcción. Ocupar la D exige simultáneamente casuística alta (que solo da el volumen), sistema documentado (que solo da el tiempo y la disciplina) y un compromiso de seguimiento con coste real asumido por adelantado (que solo da la convicción de que el paciente recurrente vale más que el captado). Las tres a la vez son caras. Una sola no diferencia.

La cadena no puede asumir el compromiso porque su modelo se apoya en la rotación. El generalista no alcanza la casuística. El especialista aislado no puede documentar un sistema que, por definición, es él. La posición está libre porque es la única que no se ocupa comprando nada.

Naturaleza · modelo

Este mapa es una lectura estratégica del sector, no un estudio de mercado con trabajo de campo. Encargar ese estudio en Ourense es una de las tareas del primer trimestre (apartado 16).

Consecuencia operativa

Si la posición se define por quién responde después, entonces el indicador que la mide no es la facturación: es la tasa de pacientes que vuelven a revisión sin que haya que perseguirlos.

04

EL FOSO

Lo que un competidor no puede comprar aunque tenga el dinero

La pregunta de Junta no es «¿somos buenos?». Es «**si mañana un fondo abre enfrente con el doble de presupuesto, qué tarda en igualarnos y qué no podría igualar nunca**». Esta sección responde exactamente eso.

ACTIVO	¿SE COMPRA?	TIEMPO DE RÉPLICA	QUÉ LO PROTEGE
Equipamiento (CBCT, escáner, cirugía guiada)	Sí, con una llamada	2–3 meses	Nada. Es una condición de entrada, no una ventaja.
Instalaciones y ubicación	Sí	6–12 meses	Poco. Retrasa a un competidor, no lo detiene.
Un cirujano de prestigio	Sí, fichándolo	3–9 meses	Poco, y además juega en contra: si nuestra ventaja fuese una persona, sería comprable.
Protocolo escrito y verificable (322 puntos, 12 fases)	No se compra: se escribe	18–36 meses	Requiere haber cometido y documentado los errores. No hay atajo posible.
Equipo que ejecuta el protocolo sin supervisión	No	24–48 meses	Es un cambio de hábito colectivo. El dinero lo acelera poco.
Base de pacientes en seguimiento contratado (ATC)	No	36–60 meses	Se acumula paciente a paciente. Un competidor nuevo empieza en cero por definición.
Reputación verificada por casos propios a 5 años	No	60 meses+	El tiempo es el único proveedor, y no admite pedidos urgentes.

Naturaleza: modelo. Los plazos son estimaciones de dirección, no medidas observadas.

La conclusión estratégica

Los tres primeros activos de la tabla son los que cuestan dinero. Los cuatro últimos son los que dan ventaja. Estamos invirtiendo, deliberadamente, en la mitad de abajo.

Esto explica por qué el gasto en sistema, formación y programa de seguimiento no debe leerse como estructura o como coste indirecto: es la única partida del presupuesto que compra tiempo de ventaja frente a un competidor con más capital. Un euro en equipamiento nos iguala con cualquiera; un euro en sistema nos separa durante años.

Réplica del equipamiento

≈ 3 meses

Lo que tarda un competidor bien financiado en tener nuestra misma tecnología.

Réplica del sistema

≈ 3 años

Lo que tarda en tener un protocolo equivalente ejecutado sin supervisión.

Réplica de la base en seguimiento

5 años+

Y solo si empieza hoy y no comete ningún error de continuidad.

Dónde se rompe el foso

Un foso construido sobre hábito colectivo se degrada por abandono, no por ataque. Se pierde el día en que un estándar deja de verificarse porque «ya lo hacemos siempre», o el día en que una salida no prevista se lleva el conocimiento que nunca se escribió. Por eso la verificación periódica y la documentación de puestos no son burocracia: son el mantenimiento del activo principal.

Parte



El sistema

El activo se llama **sistema operativo**, no clínica

Una clínica es un local con pacientes. Un sistema operativo es un conjunto de decisiones ya tomadas que hacen que el resultado no dependa de quién esté ese martes. Lo primero se vende al peso; lo segundo se vende por múltiplo. Esta parte describe qué tenemos construido y qué estamos construyendo a continuación.

05

EL SISTEMA OPERATIVO

■ HECHO

Qué se ha construido

No es documentación descriptiva: es normativa interna con criterios de salida, registros obligatorios e indicadores por fase. Está escrita para ejecutarse y para auditarse.

Recorrido del paciente 14 Fases, de la primera llamada al mantenimiento a largo plazo	Puestos normalizados 6 Con misión, límites, checklists, derivaciones y reporte diario	Puntos de verificación 322 Recorrido físico, documental, de sistemas y de procesos
Fichas de innovación 18 Con protocolo, guion, contingencia e indicador	Documentos vigentes 17 Tres troncales y catorce de apoyo	Decisiones registradas 20 Más once verificaciones externas obligatorias

Los tres documentos troncales

Documento 1

Manual Maestro de Operaciones

La norma. Las catorce fases del recorrido, los manuales de puesto, las funciones de vanguardia, la matriz de responsabilidad, los indicadores, los incentivos y la puesta en marcha.

Abrir

Documento 2

Protocolo de Primera Visita

El detalle minuto a minuto de la visita que decide la conversión: doce fases con guiones, criterios de salida, registros e indicador propio de cada una.

Abrir

Documento 3

Otros documentos del sistema

Los catorce documentos que rodean a los anteriores: verificación, auditoría, programa de 100 días, protocolos por perfil, innovación, marca, posicionamiento y programa de cuidado.

Abrir

Qué garantiza tener esto por escrito

Que la calidad no dependa de quién esté de turno; que un profesional nuevo sea productivo en semanas y no en meses; que una inspección encuentre trazabilidad y no explicaciones; y que la Dirección pueda delegar sin perder control, porque cada fase tiene criterio de salida y registro. Es, en términos de Junta, la diferencia entre un negocio dependiente de personas y un negocio con activos transferibles.

06 CARTERA DE INNOVACIÓN

Tres horizontes, tres criterios de decisión distintos

Innovar sin cartera es hacer lo que llega. La disciplina que se propone a la Junta es clasificar cada iniciativa por horizonte y **juzgar cada horizonte con el criterio que le corresponde**: el H1 por retorno, el H2 por aprendizaje, el H3 por opción.

El error clásico de un centro que crece es exigir retorno inmediato a las iniciativas de horizonte largo y matarlas antes de que puedan demostrar nada; y su reverso, mantener con vida indefinida proyectos de horizonte corto que ya han demostrado que no funcionan. Separar los tres horizontes y asignarles reglas distintas es lo que evita las dos cosas.

H1

0–12 meses · Explotar

- Cirugía guiada como estándar, no como excepción
- Flujo digital completo en prótesis: escáner intraoral y diseño
- Consentimiento y presupuesto con firma digital trazable
- Recordatorio automatizado de revisiones y mantenimiento
- Panel semanal de indicadores del cuadro de mando (apartado 13)
- Alma Te Cuida ofrecido en el 100 % de los cierres

Criterio: retorno medible en el ejercicio · ~70 % del esfuerzo

H2

12–36 meses · Construir

- Unidad de casos complejos: atrofia severa y rehabilitación total
- Programa formal de derivación con clínicas generalistas de la provincia
- Registro propio de resultados clínicos a 3 y 5 años
- Segunda unidad asistencial preparada para replicar el sistema (apartado 10)
- Formación estructurada interna con itinerario por puesto

Criterio: hitos de aprendizaje, no beneficio · ~20 %

H3

36 meses+ · Explorar

- Docencia y publicación de casuística propia
- Diagnóstico asistido por imagen sobre la serie histórica propia
- Licencia del sistema operativo a terceros centros
- Red de dos a cuatro unidades bajo un mismo estándar

Criterio: mantener la opción abierta a coste bajo · ~10 %

Regla de cartera que se somete a aprobación

Ninguna iniciativa de H2 o H3 puede financiarse con recursos comprometidos en H1, y ninguna iniciativa de H1 puede aplazarse por atender a H2. El reparto orientativo 70/20/10 se revisa una vez al año, no caso a caso. Se recoge como decisión **D9**.

Un centro que solo hace H1 es rentable hasta que el mercado cambia. Uno que solo hace H3 es fascinante hasta que se queda sin caja.

Por qué el reparto se fija por escrito y no por instinto

Parte



La economía

De dónde sale el dinero y **qué lo destruye**

Tres preguntas y tres respuestas cuantificadas: cuánto vale cada primera visita según cómo la trabajemos, qué le pasa a la facturación si movemos las dos únicas palancas que la gobiernan, y por qué el valor de un paciente en seguimiento es más del doble que el de un paciente atendido.

07

LÍNEA BASE ECONÓMICA ■ PENDIENTE

Los cinco números que aún no tenemos

La dirección de un centro se sostiene sobre cinco cifras. Ninguna está cerrada todavía, y esa es la primera tarea del trimestre: sin ellas, cualquier objetivo comercial es una opinión.

#	NÚMERO	CÓMO SE OBTIENE	ESTADO	FECHA OBJETIVO
1	Costes fijos mensuales	Suma real de alquiler, nóminas y Seguridad Social, leasing, seguros, software, suministros, servicios, mantenimiento y marketing fijo	■ PENDIENTE	Día 15
2	Punto de equilibrio mensual	Costes fijos dividido entre el margen bruto medio	■ PENDIENTE	Día 15
3	Primeras visitas necesarias al día	Del punto de equilibrio, vía ticket medio y tasa de conversión	■ PENDIENTE	Día 30
4	Producto pendiente heredado	Cruce de presupuestos aceptados, cobros, financiación externa, laboratorio y agenda	■ PENDIENTE	Día 15
5	Meses de colchón de tesorería	Saldo actual dividido entre costes fijos mensuales	■ PENDIENTE	Día 21

Las seis preguntas incómodas sobre lo adquirido

La información económica de una transmisión se presenta, por naturaleza, en su configuración más favorable. No se presume mala fe: se aplica diligencia debida posterior.

¿La facturación presentada incorpora anticipos de tratamientos no ejecutados? ¿Hay estacionalidad no comunicada? ¿Los costes fijos comunicados son exhaustivos? ¿Hay saldos de cobro incobrables? ¿Hay pasivos con proveedores no comunicados? ¿Descendió la captación en los meses previos a la venta —es decir, se transmitió un negocio o una tendencia—?

Cuánta actividad exige el equilibrio ■ MODELO

Mientras llegan los datos propios, el orden de magnitud se razona con los supuestos del apartado 18. La conclusión que importa no es el número exacto, sino la **sensibilidad**: cada diez puntos de conversión ganados reducen en torno a una primera visita diaria la actividad necesaria para llegar al equilibrio. Es la palanca más barata que existe, porque no requiere captar a nadie más.

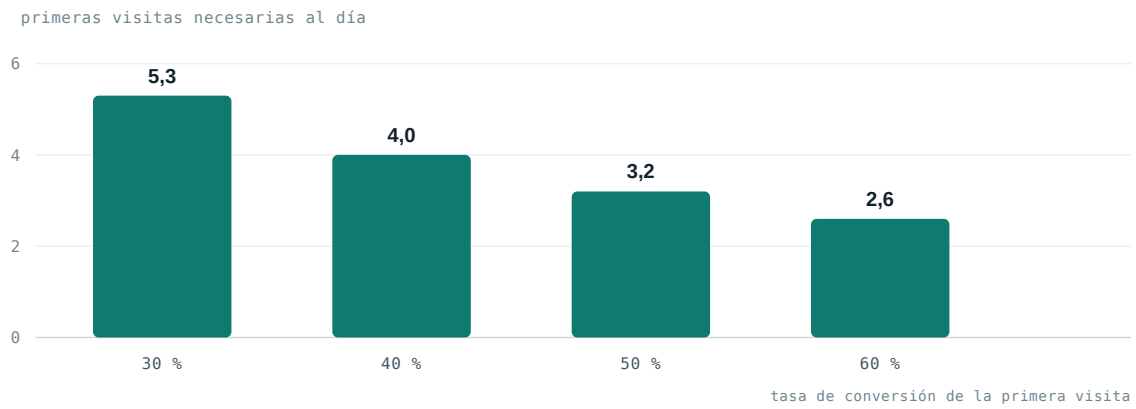


Figura 1 · Primeras visitas necesarias al día según la tasa de conversión. Modelo construido sobre un punto de equilibrio de 60.000 € al mes, un ticket medio aceptado de 1.800 € y 21 días laborables. Los tres valores son supuestos de trabajo no verificados, recogidos en el apartado 18; se sustituyen por los datos reales en cuanto estén disponibles.

Cómo dejan de faltar

Con el libro «Los números del centro · 2026» que acompaña a este documento. Su hoja *Los cinco números* pide siete entradas —costes fijos, margen de contribución, ticket medio, conversión, días laborables, tesorería y producto pendiente heredado— y devuelve los cinco resultados calculados, incluida la cifra que más incomoda: cuántas primeras visitas diarias hacen falta para llegar al equilibrio con la conversión actual. Mientras falte una entrada, el resultado dice *pendiente* en lugar de dar un número: **un número inventado es peor que un hueco declarado.**

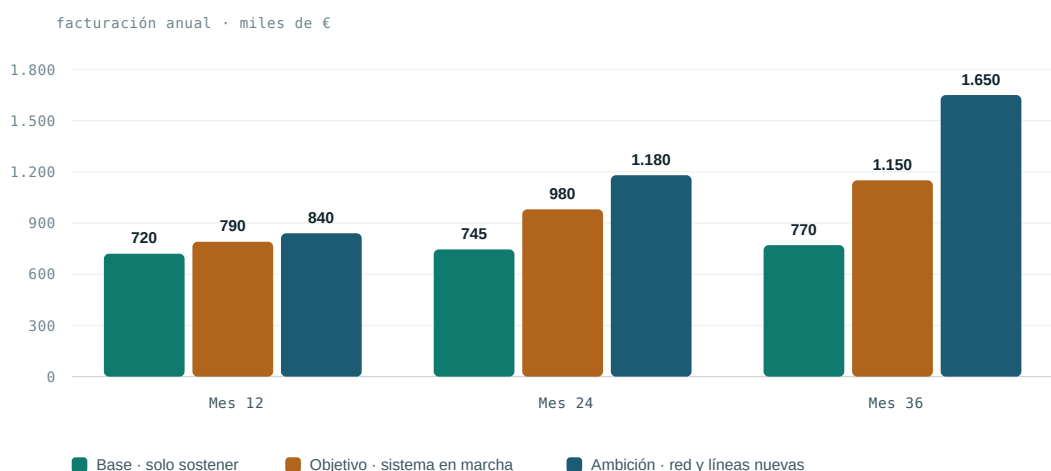
08 ECONOMÍA UNITARIA Y ESCENARIOS

Dos variables gobiernan el resultado; el resto son consecuencias

Con la capacidad instalada fija, la facturación de implantología depende de la **tasa de conversión de la primera visita** y del **ticket medio del caso aceptado**. Todo lo demás —captación, marketing, horarios— actúa sobre una de esas dos o no actúa sobre nada.

Figura 2 · Tres trayectorias a 36 meses

Escenario base: el centro sostiene lo heredado sin cambio de sistema. Objetivo: el sistema operativo en marcha con las palancas de apartado 14 activas. Ambición: además, segunda unidad y líneas nuevas del H2. Naturaleza: **modelo** de dirección construido sobre supuestos declarados en el apartado 18, no proyección auditada.



Qué separa realmente los tres escenarios

No es el esfuerzo comercial, ni la inversión en captación. Es si el protocolo de primera visita se ejecuta completo o a medias. Un centro con la misma agenda, el mismo equipo y el mismo equipamiento produce el escenario base o el escenario objetivo según una sola cosa: si el paciente sale de la primera visita habiendo entendido su caso o habiendo recibido un presupuesto.

Por eso la matriz siguiente es la diapositiva más importante del documento: muestra que mover la conversión diez puntos vale más que cualquier campaña, y que ambas palancas se multiplican entre sí en lugar de sumarse.

Advertencia de honestidad

Ninguna de estas cifras es una medición del centro. Son rangos de trabajo del sector, marcados como tales, para poder razonar sobre órdenes de magnitud mientras se levanta la línea base real (apartado 7).

Qué la haría real

Tres meses de registro sistemático de primeras visitas, aceptaciones y ticket. Es la primera tarea de los 100 días.

Figura 3 · Sensibilidad: conversión × ticket medio

Facturación anual estimada de implantología con capacidad fija de cuatro primeras visitas al día.
Cada casilla combina una tasa de conversión con un ticket medio de caso aceptado. Naturaleza: modelo.

		tasa de conversión de la primera visita			
		30 %	40 %	50 %	60 %
ticket medio	1.400 €	423 k€	564 k€	706 k€	847 k€
	1.800 €	544 k€	726 k€	907 k€	1.089 k€
	2.200 €	665 k€	887 k€	1.109 k€	1.331 k€

Capacidad fija: 4 primeras visitas al día · 21 días · 12 meses

Leído de izquierda a derecha se ve el efecto del protocolo; de arriba abajo, el de la composición de casos. La esquina inferior derecha no se alcanza con precios más altos: se alcanza tratando casos más complejos mejor explicados.

Comprobación en directo

La matriz anterior fija cuatro tasas y tres tickets. Este bloque permite mover los tres supuestos a voluntad durante la sesión, para responder a la pregunta que siempre llega: «¿y si la conversión se queda en el 35 %?». En la versión impresa aparece la matriz fija; esta comprobación solo existe en pantalla.

La lectura de gerencia

Pasar del 30 % al 50 % de conversión, sin tocar el precio ni la agenda, multiplica la facturación por 1,67. Subir el ticket de 1.400 € a 2.200 € sin tocar la conversión la multiplica por 1,57. Hacer las dos cosas la multiplica por 2,6.

Es la razón por la que el Protocolo de Primera Visita no es un documento de calidad asistencial: es el documento económico central del centro. Cada punto de conversión perdido en la fase 10 cuesta más que cualquier partida discutible del presupuesto.

09 EL ACTIVO

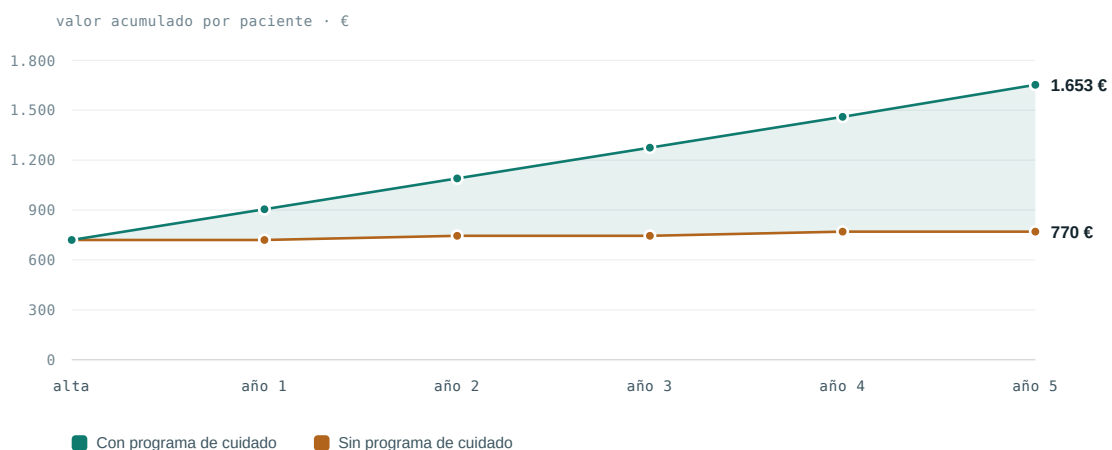
Por qué esto vale más que la suma de sus sillones

Un centro se valora por su beneficio recurrente y por el riesgo de que ese beneficio desaparezca cuando cambie el propietario. Las dos mitades de esa frase se gobiernan con las mismas decisiones que ya están sobre la mesa.

Cuando un comprador —un fondo, un grupo, un socio— valora una clínica, hace tres preguntas: cuánto gana, cuánto de lo que gana seguirá ganando sin el dueño actual, y qué parte de sus ingresos es previsible. La primera depende de la operación. Las dos siguientes dependen exclusivamente de si existe un sistema documentado y una base de pacientes ligada por contrato. Son, exactamente, los dos activos de la mitad de abajo del foso.

Figura 4 · Valor acumulado por paciente a cinco años

Comparación entre un paciente atendido sin programa de seguimiento y un paciente incorporado a Alma Te Cuida, sumando mantenimiento, revisiones y tratamiento derivado. Naturaleza: **modelo** sobre rangos del sector.



El área sombreada es el valor que hoy se deja sobre la mesa: no se pierde por competencia, se pierde por no volver a llamar.

NIVEL 1

Beneficio

Lo que el centro gana este año. Es lo único que existe si no hay sistema.

NIVEL 2

Beneficio sin dependencia del titular

La parte del beneficio que sobrevive a que el fundador se aparte. La produce el protocolo escrito, no el talento.

NIVEL 3

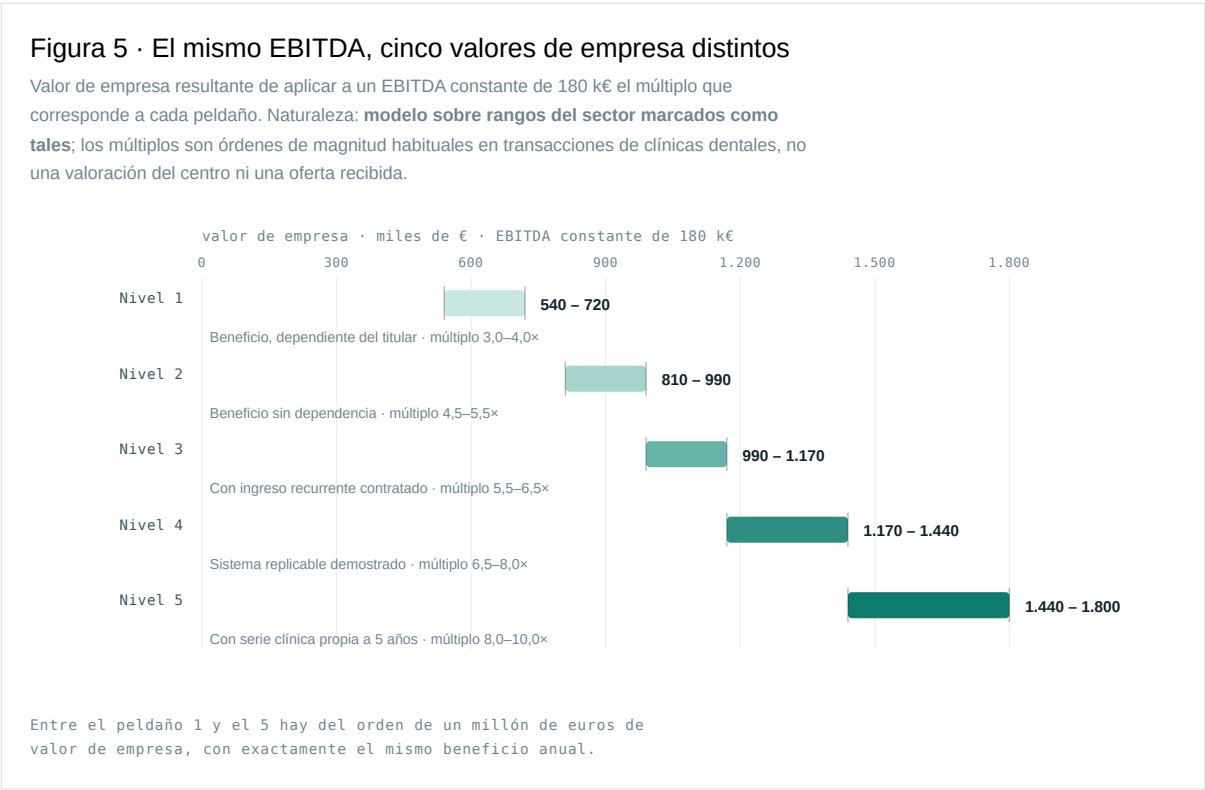
Ingreso recurrente contratado

La parte previsible: cuotas y mantenimientos de la base en seguimiento. Se valora con múltiplo superior al ingreso por acto.

NIVEL 4 Sistema replicable La capacidad demostrada de abrir una segunda unidad y obtener el mismo resultado. Convierte un centro en una plataforma.	
NIVEL 5 Serie clínica propia Resultados documentados a cinco años. Es el activo que ningún competidor puede acelerar con dinero.	

La aritmética: qué múltiplo compra cada peldaño

La escalera anterior es cualitativa y por sí sola no decide nada. Un comprador —un grupo, un fondo, un socio— no razona en peldaños: razona en múltiplo sobre resultado. Esta es la traducción, y es la que convierte «el sistema aporta valor» en una cifra que la Junta puede contrastar.



Por qué el múltiplo sube si el beneficio no cambia

Porque el múltiplo no paga el beneficio: paga **la probabilidad de que ese beneficio siga existiendo dentro de cinco años sin las personas que lo produjeron**. Cada peldaño elimina una fuente de incertidumbre —la dependencia del titular, la volatilidad del ingreso por acto, la imposibilidad de replicar, la falta de evidencia de resultados— y cada fuente eliminada vale medio punto o un punto de múltiplo.

De ahí se sigue la consecuencia práctica, y es incómoda: **una inversión que no mueve el beneficio de este año puede ser la más rentable del presupuesto**, si mueve el peldaño. Es literalmente el caso de la prioridad 2 de apartado 15.

Cómo leerlo en junta

No como una tasación. Como el orden de magnitud de lo que está en juego al decidir si el gasto en sistema es coste o inversión.

Qué lo haría real

Un EBITDA normalizado auditado y, si alguna vez interesa, una valoración independiente.
Ninguna de las dos cosas existe hoy.

PELDAÑO	QUÉ ELIMINA DE INCERTIDUMBRE	MÚLTIPLO ORIENTATIVO	DECISIÓN QUE LO DESBLOQUEA
1 · Beneficio	Nada: el comprador asume todo el riesgo de continuidad	3,0–4,0×	—
2 · Sin dependencia del titular	Que el resultado se vaya con el fundador	4,5–5,5×	D12 · inversión sostenida en el sistema
3 · Ingreso recurrente contratado	La volatilidad del ingreso por acto	5,5–6,5×	D5 y D14 · programa de cuidado
4 · Sistema replicable	Que el modelo no funcione en otra plaza	6,5–8,0×	D11 · condición de apertura
5 · Serie clínica propia	La duda sobre la calidad real del resultado a largo plazo	8,0–10,0×	D9 · horizonte H2 del registro de resultados

Rangos del sector, marcados como tales. No proceden de ninguna transacción del centro ni de una tasación encargada.

Lo que esto implica para esta Junta

Cada decisión de las que siguen puede leerse dos veces: por su efecto en la cuenta de este año y por su efecto en el nivel de la escalera al que llega el centro. La segunda lectura es la que decide cuánto vale la empresa dentro de cinco años, y es la que rara vez aparece en un consejo de administración de una clínica.

10

LA APUESTA DE ESCALADO

De un centro a una red: la condición que no se puede saltar

La pregunta no es si se puede abrir un segundo centro. Es **qué prueba tenemos de que el resultado del segundo no dependerá de que el fundador esté en él**. Sin esa prueba, abrir es multiplicar el riesgo, no el negocio.

La secuencia, y por qué el orden es innegociable

Los centros que fracasan al escalar casi nunca fallan por falta de demanda en la segunda plaza. Fallan porque replicaron una operación que nunca había funcionado sin su fundador delante. Se lleva a la segunda unidad un sistema que en realidad era una persona, y el estándar se desploma en el mes cuatro.

PASO 1 Estándar escrito Hecho. Protocolo de 12 fases, 322 puntos de verificación, manual por puesto.	
PASO 2 Estándar verificado En curso. Auditoría periódica con resultado registrado, no autoevaluación.	
PASO 3 Estándar sostenido sin el titular Pendiente. Prueba: un trimestre completo con el indicador dentro de umbral sin intervención de Dirección.	
PASO 4 Formador formado Pendiente. Alguien distinto del fundador capaz de incorporar a un profesional nuevo al estándar.	
PASO 5 Segunda unidad Solo después de 3 y 4. Antes, no.	

El semáforo de apertura

Se propone que la Junta no autorice la búsqueda de segunda plaza hasta que los pasos 3 y 4 estén acreditados con evidencia documental. Es la decisión **D11**.

Coste de saltarse el orden

Una segunda apertura fallida no cuesta solo su inversión: consume la atención de dirección que sostenía el estándar del primer centro. El daño es doble.

No abrimos un segundo centro cuando tengamos dinero para hacerlo. Lo abrimos cuando podemos demostrar que el primero funciona sin nosotros.

Condición de escalado

Parte

IV

El riesgo

Cómo fracasa esto, contado **antes** de que ocurra

Un registro de riesgos enumera lo que puede salir mal. Un pre-mortem hace algo distinto y más incómodo: se sitúa tres años en el futuro, da por hecho el fracaso y pide explicar la causa. Cambia la pregunta de «¿qué podría pasar?» a «¿qué pasó?», y con ella el nivel de honestidad de las respuestas.

11 RIESGOS

Lo que puede salir mal, con dueño y con fecha

Cinco riesgos críticos y siete de segundo orden, y debajo el registro que puntúa diez: esos cinco críticos más los cinco que salen del pre-mortem de apartado 12. Cada uno tiene mitigación definida y un propietario nominal: un riesgo sin dueño es un riesgo sin gestionar.

#	RIESGO	IMPACTO SI SE MATERIALIZA	MITIGACIÓN	PROPIETARIO
R1	Cobertura aseguradora insuficiente para tratamientos iniciados antes de la adquisición	EXPOSICIÓN PATRIMONIAL ILIMITADA	Verificación documental de la póliza completa antes de abrir. Sin confirmación, no hay actividad clínica	Gerencia
R2	Producto pendiente heredado sin cuantificar	OBLIGACIÓN NO PROVISIONADA Y RECLAMACIONES	Inventario completo en los tres primeros días y plan de ejecución priorizado	Dirección
R3	Pérdida de un profesional clave	FUGA DE CONOCIMIENTO Y DE LA CARTERA ASOCIADA	Entrevistas tempranas, mapa de riesgo individual y formación cruzada	Gerencia
R4	Incumplimiento regulatorio latente	EXPEDIENTE SANCIONADOR O SUSPENSIÓN	Auditoría de las once verificaciones externas, con expediente accesible en el centro	Gerencia
R5	Deterioro de la percepción del paciente durante la transición	PÉRDIDA DE CARTERA Y DAÑO REPUTACIONAL PERSISTENTE	Contacto proactivo de casos críticos, guiones de continuidad y escalado único a Dirección	Dirección

RIESGOS DE SEGUNDO ORDEN

- Pasivos laborales heredados, con responsabilidad solidaria
- Pérdida de activos digitales, en especial las reseñas acumuladas
- Deterioro de tesorería sin previsión a noventa días
- Descenso de captación previo a la transmisión no detectado
- Resistencia interna al nuevo estándar de trabajo
- Equipamiento crítico próximo al fin de su vida útil
- Dependencia excesiva de un proveedor crítico

Registro puntuado, con residual y fecha de revisión

La descripción anterior dice qué puede pasar. Un registro dice además cuánto pesa, cuánto pesará después de mitigarlo, quién responde y cuándo se vuelve a mirar. La exposición es probabilidad × impacto, ambas de 1 a 5. El residual es la exposición estimada una vez ejecutada la mitigación: si un riesgo no baja al mitigarlo, la mitigación es decorativa.

#	RIESGO	P	I	EXP.	RESIDUAL	PROPIETARIO	REVISIÓN	DISPARADOR
R6	Degradación del sistema por abandono de la verificación Causa 1 del pre-mortem	4	5	20	8	Dirección	Mensual	Dos auditorías aplazadas

#	RIESGO	P	I	EXP.	RESIDUAL	PROPIETARIO	REVISIÓN	DISPARADOR
R2	Producto pendiente heredado sin cuantificar	4	4	■ 16	6	Dirección	Semanal hasta cierre	Inventario no cerrado el día 3
R1	Cobertura aseguradora insuficiente para tratamientos previos	3	5	■ 15	4	Gerencia	Antes de abrir	Verificación no positiva
R3	Pérdida de un profesional clave	3	5	■ 15	9	Gerencia	Mensual	Salida no prevista en puesto clave
R4	Incumplimiento regulatorio latente	3	5	■ 15	5	Gerencia	Trimestral	V1–V11 con alguna abierta
R5	Deterioro de la percepción del paciente heredado	3	4	■ 12	6	Dirección	Mensual	Cualquier reclamación formal
R7	El programa de cuidado no llega a venderse Causa 4 del pre-mortem	4	3	■ 12	5	Dirección	Mensual	Ofrecimiento bajo el 90 % dos meses
R8	Apertura prematura de la segunda unidad Causa 5 del pre-mortem	2	5	■ 10	3	Junta	Ante cualquier oportunidad	Apertura planteada sin pasos 3 y 4
R9	Erosión del precio por descuento no reglado Causa 3 del pre-mortem	3	3	■ 9	3	Gerencia	Mensual	Descuento fuera de tipología
R10	Dirección sin datos: se decide por impresión Causa 6 del pre-mortem	3	4	■ 12	4	Dirección	Mensual	Comité sin cuadro de mando presentado

Lo que dice esta tabla y no decía la anterior

El riesgo de mayor exposición del proyecto **no es clínico ni regulatorio: es la erosión silenciosa del propio sistema** (R6, exposición 20). Es también el que menos se parece a una emergencia y el que ningún seguro cubre. Y R3 es el que peor residual conserva —9 sobre 15— porque la formación cruzada reduce el impacto pero no la probabilidad: nadie puede impedir que alguien se marche.

Puntuaciones de dirección, no actuariales. Naturaleza: modelo. Se revisan con la periodicidad de la columna y en cualquier caso en cada Junta ordinaria.

La única regla que detiene la clínica

Sin verificación positiva de la cobertura aseguradora no se realiza actividad clínica.
La actividad administrativa puede mantenerse. Es la única condición de todo el sistema que paraliza la atención, y está así por diseño: es el riesgo cuyo coste no tiene techo.

12

PRE-MORTEM

Estamos en agosto de 2029 y el proyecto ha fracasado. ¿Qué pasó?

Seis explicaciones plausibles, cada una con su señal temprana y su antídoto.

Ninguna es un accidente externo: **las seis son decisiones que tomamos nosotros o dejamos de tomar.**

Causa 1 · La más probable

El sistema se convirtió en papel

Los documentos existían, eran excelentes y nadie los usaba. La verificación se fue espaciando, primero por una urgencia, luego por costumbre. En el mes 18 el protocolo era una carpeta y el estándar real volvía a ser lo que cada uno considerase razonable.

Señal temprana: una auditoría aplazada dos veces seguidas. Un punto de verificación que lleva un trimestre marcándose «no aplica».

Antídoto

La auditoría tiene fecha en calendario y propietario nominal, y su resultado se presenta en Junta aunque sea bueno. Se convoca revisión extraordinaria si dos auditorías consecutivas se aplazan.

Causa 2

Se perdió al equipo en los primeros cien días

La integración se gestionó como un cambio de procedimientos y no como un cambio de vida laboral. Las dos personas que sostenían la relación con los pacientes heredados se marcharon, y con ellas se fue una parte de la base que ninguna campaña recuperó.

Señal temprana: una sola conversación de salida no mantenida a tiempo. Silencio en las reuniones de puesto.

Antídoto

Entrevista individual documentada con cada persona en las dos primeras semanas y de nuevo en el día 90. La permanencia del equipo es uno de los tres resultados que miden el año (cierre).

Causa 3

Se compró crecimiento con descuento

Ante un trimestre flojo se autorizaron rebajas tácticas. Funcionaron: subió el número de casos. También bajó el margen, y el precio de referencia quedó fijado a la baja en la cabeza del mercado. Recuperarlo resultó imposible sin perder los pacientes captados por precio.

Señal temprana: el primer descuento autorizado fuera de la tipología cerrada de D1.

Antídoto

Tipología de descuentos cerrada, tope de acumulación y autorización nominal por tramo. Cada descuento concedido se registra con su coste en beneficio, no en facturación.

Causa 4

El programa de cuidado nunca llegó a venderse

Estaba escrito, tenía cartelería y contrato, y sin embargo se ofrecía «cuando encajaba». Al no ser parte obligatoria del cierre, dependió del ánimo de cada profesional. A los tres años la base en seguimiento era anecdótica y el valor recurrente del apartado 9 no se materializó.

Señal temprana: tasa de ofrecimiento por debajo del 90 % en cualquier mes.

Antídoto

Ofrecerlo es un punto verificable del cierre, no una opción comercial. Se mide el ofrecimiento —no solo la contratación— y se revisa en el cuadro de mando semanal.

Causa 5**Se abrió la segunda unidad demasiado pronto**

La demanda acompañaba y la oportunidad de local parecía irrepetible. Se abrió sin haber demostrado el paso 3 del apartado 10. El estándar del centro nuevo no cuajó, y la atención de dirección que sostenía el primero se fue a apagar el fuego del segundo. Se deterioraron los dos.

Señal temprana: la frase «esta oportunidad no se va a repetir» usada como criterio de decisión.

Antídoto

D11: la Junta no autoriza búsqueda de plaza sin evidencia documental de los pasos 3 y 4.

Una oportunidad inmobiliaria no es una razón para saltarse una condición operativa.

Causa 6 · La más silenciosa**Nunca se supo si iba bien**

La línea base no llegó a levantarse. Se siguió trabajando con impresiones en lugar de con indicadores, y las decisiones se tomaron sobre la sensación del último mes. Cuando el problema fue visible en la caja, llevaba dos años ocurriendo.

Señal temprana: el primer comité en el que se discute sin un número delante.

Antídoto

El cuadro de mando de apartado 13 se presenta completo o se declara qué falta y por qué.

Un indicador sin dato es un indicador en rojo, no un indicador ausente.

Los cinco disparadores que obligan a convocar Junta extraordinaria

Dos auditorías aplazadas · una salida no prevista en un puesto clave · un descuento fuera de tipología autorizado · tasa de ofrecimiento del programa de cuidado por debajo del 90 % dos meses seguidos · cualquier decisión de apertura planteada sin los pasos 3 y 4 acreditados.

Se someten a aprobación como decisión **D13**. Un disparador escrito convierte una intuición incómoda en una obligación de agenda, que es exactamente lo que falta cuando las cosas empiezan a torcerse despacio.

13 CUADRO DE MANDO

Con qué se dirige, mes a mes

Diez indicadores nucleares. Los cuatro primeros son de integridad —miden si el sistema se está cumpliendo—, los cuatro siguientes son de resultado y los dos últimos los exigen las decisiones D13 y D14. Ninguno tiene aún serie histórica propia: la primera lectura se toma este trimestre.

#	INDICADOR	OBJETIVO	FRECUENCIA	PROPIETARIO	ESTADO
1	Verificaciones regulatorias cerradas	11 de 11	Semanal	Gerencia	SIN DATO
2	Bajas voluntarias del equipo	0	Continua	Gerencia	SIN DATO
3	Reclamaciones de pacientes heredados	0	Continua	Dirección	SIN DATO
4	Documentación digitalizada el mismo día	100 %	Diaria	Dirección	SIN DATO
5	Producto pendiente	Descendente	Semanal	RAC	SIN DATO
6	Tasa de conversión de la primera visita	Línea base y mejora	Mensual	Dirección	SIN DATO
7	Pacientes en mantenimiento activo	Creciente	Mensual	Higienista	SIN DATO
8	Captación por recomendación	Creciente	Mensual	Dirección	SIN DATO

Un cuadro de mando con ocho casillas vacías no es una debilidad del documento: es el diagnóstico honesto de dónde estamos. La Junta debe exigir que en la revisión trimestral las ocho tengan valor y tendencia.

Diccionario de indicadores

Un indicador sin definición operativa no se puede medir dos meses seguidos de la misma manera, y una serie que cambia de definición no es una serie. Esta tabla fija, para cada indicador, qué se cuenta arriba, qué se cuenta abajo, de dónde sale el dato y qué queda fuera. **Es la condición previa de la línea base de apartado 7:** mientras no esté acordada, cualquier cifra que se reporte es incomparable con la del mes siguiente.

#	INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	FUENTE	QUÉ QUEDA FUERA
1	Verificaciones regulatorias cerradas	Verificaciones V1–V11 con evidencia documental archivada y fechada	11	Expediente de verificaciones externas	Nada. Una verificación «en trámite» cuenta como no cerrada
2	Bajas voluntarias del equipo	Ceses a instancia de la persona trabajadora en el periodo	Plantilla media del periodo	Registro laboral	Fin de contrato temporal ya previsto e incapacidades temporales
3	Reclamaciones de pacientes heredados	Reclamaciones formales: escrito, hoja oficial, comunicación a colegio o consumo, o reseña pública negativa	— Recuento absoluto	Registro de incidencias	Quejas verbales resueltas en el acto y registradas como incidencia de nivel 1
4	Documentación digitalizada el mismo día	Actos clínicos con historia, consentimiento e imágenes cargados antes del cierre de la jornada	Actos clínicos del día	Gestor de clínica	Nada
5	Producto pendiente	Importe cobrado o comprometido de tratamientos aceptados y no terminados a fecha de corte	— Importe en euros	Informe de tratamientos abiertos	Presupuestos presentados y no aceptados

#	INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	FUENTE	QUÉ QUEDA FUERA
6	Tasa de conversión de la primera visita	Primeras visitas del mes M con plan principal aceptado y primer pago o financiación aprobada dentro de 60 días naturales	Primeras visitas del mes M	Agenda y presupuestos, cruzados	Urgencias, segundas opiniones sin intención de tratarse aquí y derivaciones a otro centro por criterio clínico
7	Pacientes en mantenimiento activo	Pacientes con revisión o higiene realizada en los últimos 12 meses y próxima cita agendada	Pacientes con implantes colocados por el centro	Gestor de clínica	Pacientes con cita agendada pero sin ninguna asistencia en 12 meses
8	Captación por recomendación	Primeras visitas cuyo origen declarado es la recomendación de un paciente o familiar	Primeras visitas del mes	Campo obligatorio de origen en la ficha	Nada: el origen «no consta» permanece en el denominador
9	Ofrecimiento del programa de cuidado Nuevo · exigido por D14	Cierres de tratamiento con el ofrecimiento registrado en la ficha	Cierres de tratamiento del mes	Punto de verificación del cierre	Nada. Se mide el ofrecimiento, no la contratación
10	Auditorías ejecutadas en fecha Nuevo · exigido por D13	Auditorías realizadas dentro de su ventana con resultado registrado	Auditorías programadas en el periodo	Calendario de auditoría	Nada. Una auditoría realizada sin registro cuenta como no realizada

La regla de reporte

Un indicador sin dato se reporta en rojo. No se omite, no se deja en blanco y no se sustituye por una impresión.

El indicador 6 es el único con **cohorte cerrada**: el dato de un mes no es definitivo hasta sesenta días después. Se reporta provisional y se consolida en la revisión siguiente. Confundir el provisional con el definitivo es la forma más habitual de creerse una mejora que no existe.

El instrumento que acompaña a esta tabla

La definición sola no levanta una serie. Junto a este documento se entrega «**Los números del centro · 2026**», un libro de cálculo con una hoja por mes, los diez indicadores ya definidos, umbrales editables en un solo sitio, semáforo automático y resumen anual con tendencia. Solo se teclean las casillas amarillas. Un indicador sin dato aparece como *SIN DATO* y cuenta como rojo, que es exactamente la regla de reporte de arriba.

Lo que cuesta un descuento ■ MODELO

La política de precios es una de las decisiones que se someten hoy a la Junta, y conviene verla en su magnitud real. Con un margen del 40 %, los costes del caso no bajan cuando baja el precio: el descuento sale íntegramente del beneficio.

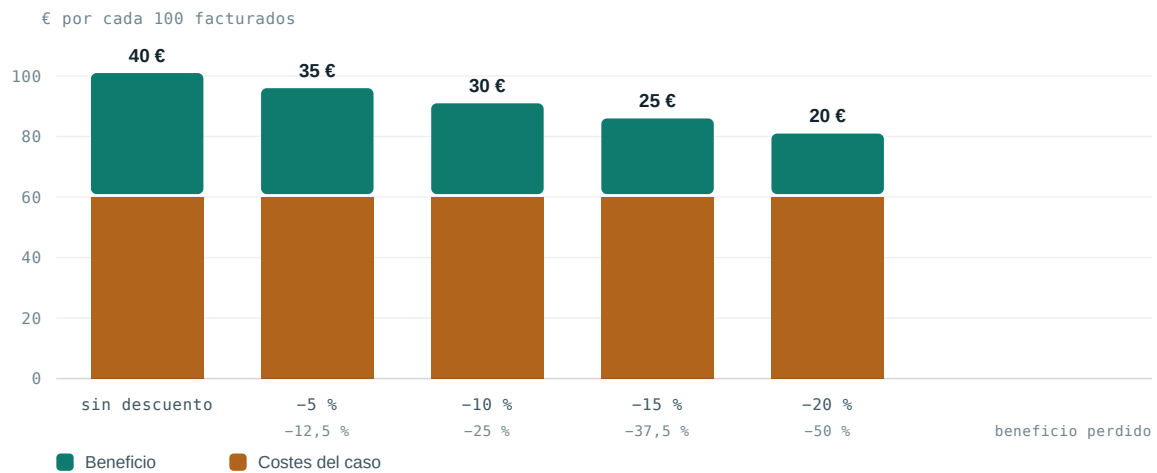


Figura 6 · Reparto de cada 100 € facturados según el descuento aplicado. Un descuento del 10 % no cuesta el 10 %: cuesta el 25 % del beneficio del caso. Uno del 20 % cuesta la mitad. Compensar un 10 % de descuento con un margen del 40 % exige vender un 33 % más de volumen. Margen del 40 % como supuesto de trabajo (apartado 18).

Lo que vale una relación frente a una transacción ■ MODELO

El programa de cuidado anual no se justifica por su cuota, que es marginal, sino por lo que arrastra: revisiones que detectan a tiempo, tratamientos que se hacen cuando aún son sencillos y familiares que entran por la puerta.



Figura 7 · Valor estimado de un paciente a cinco años, con y sin programa de cuidado. Supuestos: ticket medio aceptado de 1.800 € con margen del 40 %; cuota anual de 95 € con margen del 60 % durante cinco años; un tratamiento adicional de 900 € detectado en revisión; 0,4 pacientes referidos por titular. Todos son supuestos de trabajo no verificados (apartado 18). La conclusión robusta no es la cifra, sino la proporción: la relación vale del orden del doble que la transacción.

Parte



La decisión

Qué se pide hoy, y qué cuesta no pedirlo

Las palancas de valor, el orden en que se asigna el capital disponible, la hoja de ruta a treinta y seis meses, las quince decisiones que solo puede tomar este órgano y el registro completo de lo que hemos supuesto sin poder demostrarlo todavía.

14 PALANCAS DE VALOR

Por dónde se crece, y en qué orden

Cinco palancas, ordenadas por coste de activación. Las tres primeras no requieren captar un solo paciente nuevo: actúan sobre lo que ya existe.

ORDEN	PALANCA	QUÉ MOVILIZA	COSTE DE ACTIVACIÓN	HORIZONTE
1	Producto pendiente	Convierte en producción una caja ya cobrada y apaga la principal fuente de reclamaciones	Solo gestión	Semanas
2	Conversión de la primera visita	Cada punto de conversión rinde como si se hubiera captado más demanda, sin coste de captación	Formación y disciplina	1-2 trimestres
3	Cartera propia dormida	Reactivación de inactivos y de presupuestos no aceptados recientes	Bajo	1 trimestre
4	Programa de cuidado y mantenimiento	Recurrencia, detección precoz y entrada de familiares; sostiene el valor a largo plazo	Bajo, con encaje legal previo	2-4 trimestres
5	Captación externa	Segmentos desatendidos, posicionamiento en buscadores y respuesta a asistentes conversacionales	Medio-alto	3-6 trimestres

La secuencia, y por qué no se altera

Sostener → recuperar → fidelizar → captar.

Invertir en captación externa con la cartera propia desatendida es la asignación de recursos menos eficiente posible: se paga por atraer desconocidos mientras se dejan de atender clientes que ya confiaron. La Junta debería resistir la tentación de adelantar la palanca 5.

15 ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Un orden de prelación, no una lista de deseos

Todo presupuesto de clínica se parece: equipamiento, obra, marketing, personal. Lo que distingue una asignación estratégica de una contable es el **orden**, y el criterio explícito para saltarse ese orden.

La regla que se propone parte de una idea sencilla: primero se protege lo que ya genera caja, después se compra ventaja de la que no se puede comprar, y solo al final se compra capacidad. Invertir en capacidad antes de haber asegurado el estándar es multiplicar por más volumen un problema que todavía no está resuelto.

PRIORIDAD 1 Continuidad Nóminas, obligaciones, mantenimiento de lo que ya funciona y colchón de tesorería. No se discute y no se aplaza.	
PRIORIDAD 2 El foso Formación, verificación, documentación y el programa de seguimiento. Es la partida que compra años de ventaja (apartado 4) y la primera que se recorta en cualquier centro con prisa.	
PRIORIDAD 3 Conversión Todo lo que mejora la primera visita: tiempo de consulta, diagnóstico, soporte de explicación al paciente. Retorno más alto y más rápido que cualquier captación (apartado 8).	
PRIORIDAD 4 Captación Marca y adquisición de primeras visitas. Solo tiene sentido cuando la conversión ya está en umbral: captar más para convertir igual es pagar por desperdicio.	
PRIORIDAD 5 Capacidad Sillones, equipos, personal adicional, segunda unidad. Se financia con lo que las prioridades anteriores hayan producido, no con deuda contra una previsión.	

La regla de excepción

Saltarse el orden es legítimo exactamente en un caso: cuando una prioridad inferior es condición técnica de una superior —un equipo cuya avería impide ejecutar el estándar, por ejemplo—. En ese supuesto la excepción se documenta con el formato de registro de decisión y se presenta en la Junta siguiente. Fuera de eso, el orden se respeta aunque la oportunidad parezca buena.

Esta disciplina es la que impide el patrón más común de deterioro en centros que crecen: financiar capacidad con optimismo, descubrir que la conversión no acompaña y recortar entonces la prioridad 2, que era la única que sostenía la diferencia.

Se somete como D10

Aprobar este orden de prelación y la regla de excepción, con revisión anual.

Relación con el foso

La prioridad 2 es, en términos de valoración, la única partida que sube el nivel de la escalera del apartado 9. Todas las demás mantienen el nivel actual.

16

HOJA DE RUTA

Tres horizontes y tres puertas

El programa no avanza por calendario, sino por criterios de salida verificados.

Ninguna fase se adelanta: cada una se apoya en la anterior.

Horizonte 1 · 100 días Estabilización. Riesgo neutralizado, equipo retenido, continuidad asegurada y línea base establecida.	Horizonte 2 · 12 meses Consolidación. Protocolo implantado, producto pendiente residual, primera línea avanzada operativa, marca reposicionada e indicadores con serie propia.	Horizonte 3 · 36 meses Liderazgo. Referencia reconocida en implantología compleja en el área, con captación mayoritariamente por recomendación y base amplia en mantenimiento activo.
---	---	--

Las tres puertas de paso

PUERTA	DÍA	NO SE PASA SIN...
1	30	Tres verificaciones críticas cerradas · entrevistas completadas · cero bajas voluntarias · cero reclamaciones heredadas · producto pendiente inventariado · casos críticos asignados · devolución al equipo realizada
2	60	Once verificaciones regulatorias cerradas · seis decisiones de marco comunicadas · línea base económica establecida · sistema de reportes operativo · formación por perfil completada · producto pendiente descendente
3	100	Protocolo ejecutado sin supervisión constante · responsables funcionales reportando · programa de mantenimiento en marcha · presencia digital reestructurada · indicadores con serie propia · plan de líneas avanzadas autorizado

El paso de fase exige autorización expresa del Comité de Transición previa verificación de los criterios. La Junta recibe el estado de las puertas en cada revisión trimestral.

17 DECISIONES QUE SE SOMETEN A LA JUNTA

Quince acuerdos

Cada decisión lleva su código para el acta, quién la propone, qué se pide exactamente, qué pasa si no se resuelve hoy y de qué depende. Las ocho primeras resuelven la operación; las siete últimas fijan las reglas con las que se decidirá lo que aún no está sobre la mesa, incluida la cifra a la que se dirige todo. Ninguna requiere información adicional a la contenida en este documento.

CÓDIGO	MATERIA	QUÉ SE PIDE	IMPACTO DE NO DECIDIR	PLAZO
D1	Política de precios y tabla de descuentos	Aprobar la tipología cerrada de descuentos, sus porcentajes máximos por tipo, el tope de acumulación y quién autoriza cada tramo	Precios inconsistentes según quién atienda, y margen erosionado sin control	■ INMEDIATO
D2	Garantías publicadas	Fijar los plazos de garantía por tipo de tratamiento que el centro asume por escrito ante el paciente	Compromisos verbales dispares y riesgo de reclamación sobre expectativas no pactadas	■ INMEDIATO
D3	Arquitectura de marca y naming	Aprobar la arquitectura por verticales y ordenar la verificación legal de marca y dominios antes de cualquier adopción	Dilución del mensaje y riesgo de adoptar un nombre no registrable	■ PRIMER TRIMESTRE
D4	Presupuesto anual de captación	Autorizar el porcentaje de facturación destinado a marca y captación, y el modelo de ejecución: interno, agencia o mixto	Marketing sin marco, sin responsable y sin medición de retorno	■ PRIMER TRIMESTRE
D5	Programa de cuidado anual	Cerrar precio, catálogo de servicios y límites, y ordenar la validación jurídica del contrato de adhesión antes de comercializarlo	No puede lanzarse: sin encaje legal y sin catálogo cerrado no se puede firmar con ningún paciente	■ INMEDIATO
D6	Línea de sedación consciente	Autorizar —o posponer— la línea, condicionada a la verificación del alcance competencial con asesoría y colegio profesional	Bloquea el acceso a uno de los tres segmentos nucleares de la apuesta	■ PRIMER TRIMESTRE
D7	Inversión en flujo digital	Aprobar el marco de inversión tecnológica y el criterio de retorno exigible a cada partida	Decisiones de compra caso a caso, sin criterio común ni periodo de recuperación exigido	■ SEGUNDO TRIMESTRE
D8	Gobernanza y responsables funcionales	Designar con nombre al responsable de marca y reseñas, y confirmar la composición y periodicidad del Comité de Transición	Áreas sin dueño: lo que no tiene responsable nominal no se ejecuta	■ INMEDIATO

Las tres que bloquean lo demás

D1, D5 y D8.

Sin política de precios el equipo improvisa en cada cierre; sin catálogo y encaje legal el programa de cuidado no puede ofrecerse pese a estar íntegramente documentado; y sin responsables nominales las áreas quedan huérfanas. Las otras cinco admiten un trimestre; estas tres, no.

LO QUE LA JUNTA NO NECESITA DECIDIR HOY

- El contenido del sistema operativo: está construido y es competencia de Dirección
- El criterio clínico, que corresponde en exclusiva al responsable clínico y no es delegable ni revisable por gestión
- Los objetivos comerciales del primer trimestre: el mes 1 es línea base, no objetivo
- La secuencia de implantación, que ya está fijada por puertas de paso verificables

Las seis decisiones de la capa estratégica

Las ocho anteriores resuelven la operación. Estas seis nacen de las partes I a V y resuelven algo distinto: fijan las reglas con las que la Junta tomará las decisiones que todavía no sabe que va a tener que tomar. Se presentan en ficha, no en tabla, porque cada una lleva una alternativa descartada que conviene que conste en acta.

D9 · Regla de cartera de innovación	06 · PLAZO: ESTA SESIÓN
Qué se pide Aprobar el reparto orientativo 70/20/10 entre horizontes H1, H2 y H3, y la regla de que ningún horizonte se financie con recursos comprometidos en otro. Alternativa descartada Decidir caso a caso según mérito. Suena razonable y produce sistemáticamente el mismo resultado: todo el esfuerzo acaba en H1, porque es el único horizonte que enseña resultados dentro del ejercicio. Si no se decide Las iniciativas de horizonte largo mueren por asfixia presupuestaria sin que nadie llegue a decidir matarlas. Cómo se verifica Revisión anual del reparto real ejecutado frente al aprobado, presentada en Junta. Recomendación de Dirección Aprobar. El coste de la regla es nulo y evita el modo de fallo más común en centros que crecen rápido.	
D10 · Orden de prelación del capital	15 · PLAZO: ESTA SESIÓN
Qué se pide Aprobar las cinco prioridades —continuidad, foso, conversión, captación, capacidad— y la regla de excepción documentada. Alternativa descartada Presupuesto por partidas contables sin orden. Es lo habitual y hace invisible el hecho de que la partida que da ventaja competitiva es siempre la primera candidata al recorte. Si no se decide Cada inversión se discute por su mérito aislado y gana la más urgente, que casi nunca es la más importante. Cómo se verifica Toda excepción al orden consta en el registro de decisiones con su fundamento. Recomendación de Dirección Aprobar. Es la decisión que protege la prioridad 2 cuando llegue el primer trimestre malo, y llegará.	

D11 · Condición de apertura de segunda unidad

10 · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se pide

Establecer que no se autoriza búsqueda de plaza ni compromiso inmobiliario mientras no estén acreditados con evidencia documental el paso 3 —un trimestre en umbral sin intervención de Dirección— y el paso 4 —formador formado distinto del fundador—.

Alternativa descartada

Decidir por oportunidad de mercado. Es la causa 5 del pre-mortem, y la que más veces ha convertido un centro rentable en dos centros mediocres.

Si no se decide

La primera buena oportunidad inmobiliaria se convierte en argumento suficiente, y el orden se rompe justo cuando más caro cuesta romperlo.

Cómo se verifica

Expediente de acreditación de los pasos 3 y 4 presentado a la Junta antes de cualquier gasto de prospección.

Recomendación de Dirección

Aprobar. Y hacerlo hoy, mientras no hay ninguna oportunidad concreta sobre la mesa: es el único momento en que esta decisión es barata.

D12 · Inversión sostenida en el foso

04 · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se pide

Fijar un suelo anual de inversión en formación, verificación y documentación del sistema, expresado como porcentaje de facturación, que no pueda reducirse sin acuerdo expreso de la Junta.

Alternativa descartada

Tratarlo como gasto variable ajustable al resultado. Convierte la única ventaja no comprable del centro en la primera variable de ajuste.

Si no se decide

El foso se degrada por abandono —no por ataque— y nadie identifica el momento en que empezó, porque no hay una fecha concreta en la que se decidiera dejarlo caer.

Cómo se verifica

Ejecución de la partida reportada trimestralmente junto al cuadro de mando.

Recomendación de Dirección

Aprobar el principio en esta sesión y fijar el porcentaje concreto cuando exista línea base real (apartado 7), en la revisión del primer trimestre.

D13 · Disparadores de Junta extraordinaria

12 · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se pide

Aprobar los cinco disparadores del pre-mortem como obligación automática de convocatoria, sin valoración previa de gravedad.

Alternativa descartada

Convocar cuando Dirección lo considere necesario. El problema es que los cinco modos de fallo descritos son lentos y cómodos: nunca parecen suficientemente graves el día en que aún son baratos de corregir.

Si no se decide

El deterioro silencioso —causa 6— sigue su curso hasta ser visible en la caja, dos años tarde.

Cómo se verifica

Cada disparador tiene un indicador asociado en el cuadro de mando de apartado 13.

Recomendación de Dirección

Aprobar. Un disparador automático protege a la Junta de la propia Dirección en el momento exacto en que la Dirección estaría tentada de minimizar el problema.

D14 · Obligatoriedad del programa de cuidado en el cierre

09 · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se pide

Establecer que ofrecer Alma Te Cuida es un punto verificable obligatorio del cierre de todo tratamiento, y que se mide la tasa de *ofrecimiento* además de la de contratación.

Alternativa descartada

Dejarlo a criterio comercial del profesional. Es la causa 4 del pre-mortem: el programa existe, está bien construido y no llega a venderse nunca.

Si no se decide

No se materializa el ingreso recurrente del apartado 9 —el activo que sube el nivel de la escalera de valor— y la diferencia entre las dos curvas de la figura queda como potencial teórico.

Cómo se verifica

Tasa de ofrecimiento mensual, con umbral del 90 %, en el cuadro de mando.

Recomendación de Dirección

Aprobar, condicionada a D5: no puede ofrecerse de forma obligatoria un contrato cuya validación jurídica y cuyo catálogo no estén cerrados. D5 primero, D14 acto seguido.

D15 · El objetivo de facturación y su horizonte

20 A 23 · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se pide

Fijar la cifra —1,2 M€ de facturación anual— y el ejercicio en que se exige. Dirección propone el **tercero**, con 890 k€ en el primero y 1.060 k€ en el segundo, y la cartera de nueve campañas del apartado 21 como contenido de D4.

Alternativa descartada

Fijar 1,2 M€ para el primer ejercicio. No se descarta por prudencia sino por aritmética: con cuatro primeras visitas al día haría falta un rendimiento de 1.190 € por visita, un 47 % por encima del actual, y las campañas que lo sostienen no maduran en doce meses.

Si no se decide

Cada área trabaja contra una cifra distinta. El objetivo de un año exigido en otro no acelera nada: solo hace que en diciembre parezca un fracaso lo que iba conforme al plan.

Cómo se verifica

El puente del apartado 20 se revisa cada trimestre bloque a bloque, no en total: así se ve cuál de los nueve está fallando antes de que lo esté el conjunto.

Recomendación de Dirección

Aprobar 1,2 M€ en el ejercicio tercero. Si la Junta prefiere dieciocho meses, que conste en el acta que se anticipa la prioridad 5 del apartado 15 y se asume ampliar capacidad antes de tener el estándar consolidado: es legítimo, pero no es gratis y no puede quedar sin decir.

El coste de no decidir

Cada ficha dice, en cualitativo, qué pasa si el acuerdo no se toma. Cuatro de las catorce admiten además una cifra, y conviene tenerla delante: **un consejo aplaza sin esfuerzo lo que no tiene precio, y deja de aplazar lo que lo tiene**. Los importes son de modelo, contruidos sobre los supuestos de apartado 18.

DECISIÓN	QUÉ SE PIERDE CADA TRIMESTRE SIN ELLA	CÓMO SALE LA CIFRA	ORDEN DE MAGNITUD
D1 Precios y descuentos	Descuento no reglado que sale íntegro del beneficio	Si el 35 % de los casos lleva un descuento medio del 10 % sobre una facturación anual de 720 k€, y el coste del caso no baja con el precio	≈ 6,3 k€/trimestre ≈ 25 k€ al año, en torno a un tercio del

DECISIÓN	QUÉ SE PIERDE CADA TRIMESTRE SIN ELLA	CÓMO SALE LA CIFRA	ORDEN DE MAGNITUD
D5 Programa de cuidado	Pacientes que terminan tratamiento y no se incorporan al seguimiento	75 tratamientos terminados por trimestre × 883 € de diferencial de valor a cinco años entre paciente con programa y sin él (apartado 9)	≈ 66 k€/trimestre De valor a cinco años que deja de originar
D8 Responsables funcionales	Decisiones que suben a Dirección por no tener dueño nominal	Cuatro áreas sin propietario × entre dos y tres horas semanales de Dirección consumidas en resolver lo que debería resolverse abajo	≈ 120 h/trimestre De la agenda más cara del centro, y la ú
D2 Garantías publicadas	Exposición, no coste recurrente	No es un goteo: es el coste de una sola reclamación resuelta sobre una expectativa que nunca se pactó por escrito	Cola larga Baja probabilidad, importe sin techo def

La lectura conjunta

Aplazar un trimestre las cuatro decisiones inmediatas cuesta del orden de setenta mil euros de valor y ciento veinte horas de dirección. Ninguna de las cuatro exige información que no esté en este documento.

Es la razón por la que están marcadas como inmediatas y no como «primer trimestre»: no es urgencia retórica, es que el retraso tiene factura.

Formato de registro del acuerdo

REGISTRO DE DECISIÓN – Nº _____

Fecha: _____

Órgano: Junta Directiva

Código de la memoria: D__

Nivel de autoridad: N2 / N3

MATERIA:

ALTERNATIVAS EVALUADAS: A. B. C.

CRITERIO DE DECISIÓN:

RESOLUCIÓN ADOPTADA:

FUNDAMENTO:

CONSULTA PREVIA REALIZADA: _____

Fecha: _____

ENTRADA EN OURENSER: _____ DOCUMENTOS AFECTADOS:

COMUNICACIÓN: destinatarios / canal / fecha

REVISIÓN PREVISTA:

Toda decisión de nivel N2 o superior se documenta en este formato. Sin registro, en tres meses nadie recuerda por qué se decidió así ni qué alternativas se descartaron; y una decisión que no se comunica con fecha de entrada en vigor no llega al equipo.

18

REGISTRO DE SUPUESTOS

Sobre qué se ha razonado

Todos los valores empleados en los modelos de esta memoria, con su origen. Ninguno procede de la explotación del centro: son **supuestos de trabajo no verificados**, elegidos como órdenes de magnitud plausibles para poder razonar mientras llegan los datos reales. Se sustituyen en cuanto exista línea base.

#	SUPUESTO	VALOR EMPLEADO	DÓNDE SE USA	ORIGEN
S1	Margen bruto medio por caso	40 %	Figura 6 · coste del descuento; figura 7 · valor del paciente	■ SUPUESTO DE TRABAJO
S2	Punto de equilibrio mensual	60.000 €	Figura 1 · primeras visitas necesarias	■ SUPUESTO DE TRABAJO
S3	Ticket medio aceptado	1.800 €	Figuras 1 y 3	■ SUPUESTO DE TRABAJO
S4	Días laborables al mes	21	Figura 1	■ SUPUESTO DE TRABAJO
S5	Cuota anual del programa de cuidado	95 €, con margen del 60 %	Figura 7	Documentación del programa · ■ PENDIENTE DE CIERRE POR DIRECCIÓN
S6	Tratamiento adicional detectado en revisión	900 € en cinco años	Figura 7	■ SUPUESTO DE TRABAJO
S7	Pacientes referidos por titular del programa	0,4	Figura 7	■ SUPUESTO DE TRABAJO

Cómo debe leerse un modelo

La cifra concreta de un modelo no es una previsión: es la consecuencia aritmética de los supuestos de esta tabla. Lo que sí es robusto —y lo único que conviene llevarse— es la **dirección y el orden de magnitud**: que el descuento sale del beneficio y no del coste; que la conversión es la palanca más barata; y que la relación continuada vale del orden del doble que la transacción aislada. Si cambian los supuestos, cambian las cifras, pero no esas tres conclusiones.

Qué falta por resolver, además de las quince decisiones

PUNTO ABIERTO	DE QUIÉN DEPENDE	CÓMO SE OPERA MIENTRAS TANTO
Alcance competencial del higienista	Titulación y normativa	El protocolo organiza la función; no amplía competencias
Sustitutos formados de cada puesto	Dirección	Solo cubre una fase quien esté certificado; si no hay nadie, se reprograma
Marcas de implante y tasas de éxito comunicables	Dirección y responsable clínico	Solo se mencionan las que consten en la ficha de datos verificables; ninguna cifra se improvisa
Contenido del kit de bienvenida	Dirección	Mínimo: guía del tratamiento, kit de higiene y tarjeta de contacto directo
Software de planificación de ortodoncia	Dirección	Se usa la herramienta con la que se planificó cada caso y se anota cuál

S8 · Los supuestos de la cartera de campañas

La Parte VI no añade supuestos nuevos sobre la clínica: reparte los que ya están en S1 a S7 entre nueve campañas. Lo que sí declara es cuánta agenda ocupa cada una y con qué rendimiento, y eso es lo que va aquí. **Ninguno procede de una medición del**

centro. Todos viven en modelo -campanas .py, que se puede ejecutar y modificar; el guion de coherencia comprueba que este documento no diga nada distinto de lo que ese modelo calcula.

CÓD.	CAMPAÑA	QUÉ SE SUPONE	POR QUÉ ESE RENDIMIENTO	COSTE
C1	Alma Te Cuida	460 adheridos × 190 € de cuota, menos el 30 % que sustituye higienes ya facturables. · 460 adheridos × 16 % que necesita tratamiento nuevo al año × 1.500 € de ticket medio.	No ocupa agenda de primera visita	6 k€
C2	«Su caso no es imposible»	80 primeras visitas al año · 50 % de conversión · 3.400 € de ticket	Convierte la mitad porque llega decidido, y el plan es de rehabilitación	14 k€
C3	«Volvemos a llamarle»	130 primeras visitas al año · 48 % de conversión · 1.900 € de ticket	Confían, así que convierten bien, pero el caso suele ser ordinario	3 k€
C4	Red de derivación	70 primeras visitas al año · 60 % de conversión · 2.400 € de ticket	La conversión más alta de la cartera: llegan enviados y con el caso acotado	11 k€
C5	«Sin miedo»	55 primeras visitas al año · 45 % de conversión · 2.800 € de ticket	Cuando por fin deciden, el plan acumulado es amplio	9 k€
C6	«La revisión que evita la cirugía»	1.050 revisiones al año × 95 €, entre base propia y portadores de otros centros. · 1.050 revisiones × 6 % con hallazgo tratable × 1.150 € de ticket medio.	No ocupa agenda de primera visita	5 k€
C7	«Segunda opinión, sin compromiso»	70 primeras visitas al año · 42 % de conversión · 2.600 € de ticket	Convierte menos porque compara, pero el diagnóstico completo eleva el plan	4 k€
C8	Prescripción de pacientes	120 primeras visitas al año · 55 % de conversión · 2.000 € de ticket	La mayor confianza previa de todas: la conversión más alta del embudo abierto	1 k€
C9	Presencia digital y reseñas	83 primeras visitas al año · 40 % de conversión · 1.900 € de ticket	Búsqueda fría: la calidad media más baja de la cartera	34 k€

Valor de referencia con el que se compara toda campaña: 810 € por primera visita (45 % × 1.800 €, supuestos S2 y S3). Margen de contribución del 40 %, supuesto S4.

El supuesto más frágil de los nueve

Los 130 pacientes al año que C3 supone recuperables de la cartera dormida. Es el único que no se apoya en ningún dato del sector ni en la experiencia del equipo: se apoya en que exista una cartera que nadie ha contado. Dos días de trabajo administrativo lo convertirían en un hecho, y hasta que eso ocurra conviene leer el puente sabiendo que este tramo puede no existir.

19TRAZABILIDAD DE LOS ACUERDOS

Dónde aterriza cada decisión y cómo se comprueba seis meses después

La pregunta que cierra cualquier consejo serio es la misma: «de acuerdo, lo aprobamos; ¿cómo sé dentro de seis meses que se hizo?». Esta matriz la responde para las catorce. Cada acuerdo tiene un documento donde se escribe, un punto donde se verifica y un indicador donde se ve.

CÓD.	DÓNDE SE ESCRIBE	CÓMO SE VERIFICA	DÓNDE SE VE
D1	Manual Maestro, Parte VI · política comercial · y Protocolo, Fase 10	Tipología de descuentos publicada y registro de autorizaciones por tramo	Producto pendiente y margen por caso
D2	Otros documentos, 12 · continuidad legal · y cartelería de sala	Texto de garantía por tipo de tratamiento visible y entregado con el presupuesto	Reclamaciones formales (ind. 3)
D3	Otros documentos, 9 · marca y captación	Certificado de búsqueda registral y disponibilidad de dominios	Captación por recomendación (ind. 8)
D4	Otros documentos, 9 · economía unitaria del embudo	Presupuesto aprobado con responsable nominal y modelo de ejecución	Coste por primera visita captada
D5	Otros documentos, 14 · ATC · y Protocolo, Fases 10 a 12	Catálogo cerrado y dictamen jurídico del contrato de adhesión archivado	Pacientes en mantenimiento activo (ind. 7)
D6	Manual Maestro, Parte V · funciones de vanguardia	Informe de alcance competencial de asesoría y colegio profesional	Casos atendidos del segmento de ansiedad severa
D7	Manual Maestro, Parte VI · compras e inversión	Criterio de retorno exigible aplicado a cada partida de compra	Documentación digitalizada el mismo día (ind. 4)
D8	Manual Maestro, Parte III · RACI · y Anexo de gobernanza	Acta con nombres y periodicidad del Comité de Transición	Bajas voluntarias (ind. 2)
D9	Otros documentos, 8 · innovación · apartado 6 de este documento	Reparto real ejecutado por horizonte, frente al aprobado	Revisión anual de cartera
D10	apartado 15 de este documento y presupuesto anual	Toda excepción al orden consta en el registro de decisiones con su fundamento	Ejecución por prioridad, trimestral
D11	apartado 10 de este documento	Expediente de acreditación de los pasos 3 y 4, previo a cualquier gasto de prospección	Un trimestre en umbral sin intervención de Dirección
D12	Presupuesto anual, partida de sistema y formación	Suelo anual ejecutado, reportado con el cuadro de mando	Auditorías en fecha (ind. 10)
D13	Anexo de gobernanza del Manual Maestro	Cada disparador tiene indicador asociado y convocatoria automática	Indicadores 2, 3, 9 y 10
D14	Protocolo, Fase 12 · cierre · y Otros documentos, 14	Punto de verificación obligatorio del cierre de tratamiento	Ofrecimiento del programa (ind. 9)
D15	apartados 20 a 23 de este documento y presupuesto anual	Puente revisado por bloques cada trimestre, no en total	Facturación anual frente a la senda de apartado 22

La comprobación de coherencia

Los diez indicadores del diccionario de apartado 13 aparecen todos en la columna de la derecha, y las quince decisiones aparecen todas en la de la izquierda. Un acuerdo que no cupiera en esta matriz sería un acuerdo sin forma de comprobarse; un indicador que no apareciera sería un indicador que no sirve para gobernar nada.

Parte

VI

La cifra

Cómo se llega a 1,2 M€

Ninguna cifra de esta parte está escrita a mano. Todas salen de un modelo que vive en el repositorio, declara sus supuestos y se puede ejecutar: cada campaña dice cuánta agenda ocupa, a qué tasa convierte y con qué ticket, y de ahí se deriva lo que aporta. Cambie un supuesto y cambian el puente, las figuras y esta página.

20 EL PUENTE

De 720 k€ a 1,2 M€, bloque a bloque

Un objetivo sin puente es un deseo. Este es el recorrido completo, y cada tramo tiene detrás una operación aritmética, no una intuición.

La regla que gobierna todo el cálculo

Con la agenda llena, **una campaña no vale lo que factura: vale la diferencia entre el paciente que trae y el paciente al que desplaza**. Es una distinción incómoda y es la que separa un plan creíble de una suma de deseos. Si una campaña trae pacientes que convierten al 40 % con ticket de 1.900 €, y la visita que ocupa habría rendido 810 €, esa campaña no aporta lo que factura: aporta la diferencia, y puede ser negativa.

Agenda instalada

1.008

Primeras visitas al año: 4 al día × 21 días × 12 meses.

Valor de una visita hoy

810 €

45 % de conversión × 1.800 € de ticket. Es la vara con la que se mide toda campaña.

Ocupación heredada

3,5/día

889 visitas al año. Hay holgura, pero menos de la que parece.

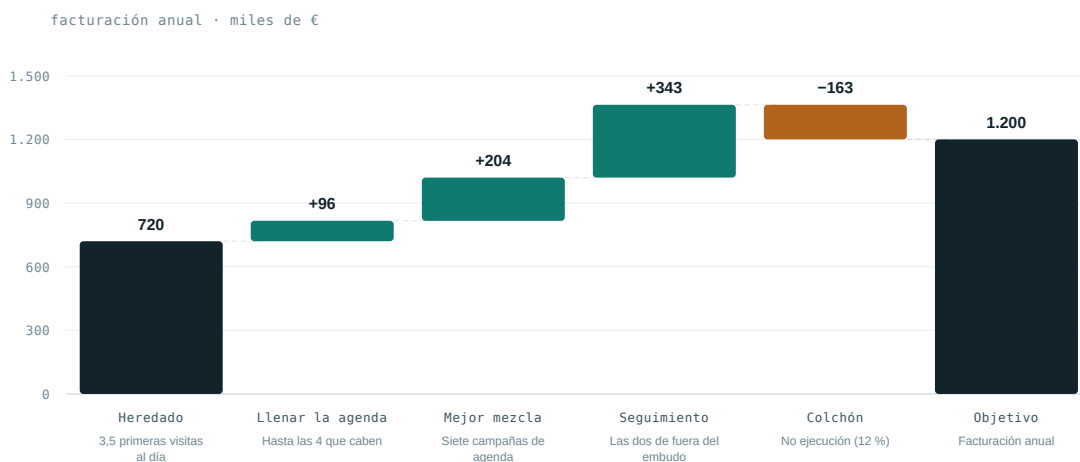
Agenda que piden las nueve

608

Quedan 400 visitas libres. **La cartera cabe**, y esa comprobación es parte del modelo.

Figura 8 · El puente hasta el objetivo

Los cuatro tramos y el colchón. Naturaleza: **modelo** ejecutable, con los supuestos declarados en el apartado 18 y en el propio archivo del modelo.



Se planifican 1.363 k€ para comprometer 1.200. Un plan que suma exactamente el objetivo es un plan que lo falla.

TRAMO	DE DÓNDE SALE	APORTA
Base heredada	889 primeras visitas al año a 810 € cada una	720 k€
Llenar la agenda	Pasar de 3,5 a 4 visitas al día: 1.008 – 889 visitas más, al valor de hoy	+96 k€
Mejorar la mezcla	Las siete campañas que ocupan agenda, cada una valorada por su diferencia con 810 €	+204 k€
Seguimiento y recurrente	Las dos campañas que producen fuera del embudo: cuotas, revisiones y el tratamiento que detectan	+343 k€
Planificado	La suma de lo anterior, si las nueve salen	1.363 k€
Colchón de no ejecución	El 12 % que se descuenta de antemano	-163 k€
Objetivo	Lo que se compromete ante la Junta	1.200 k€

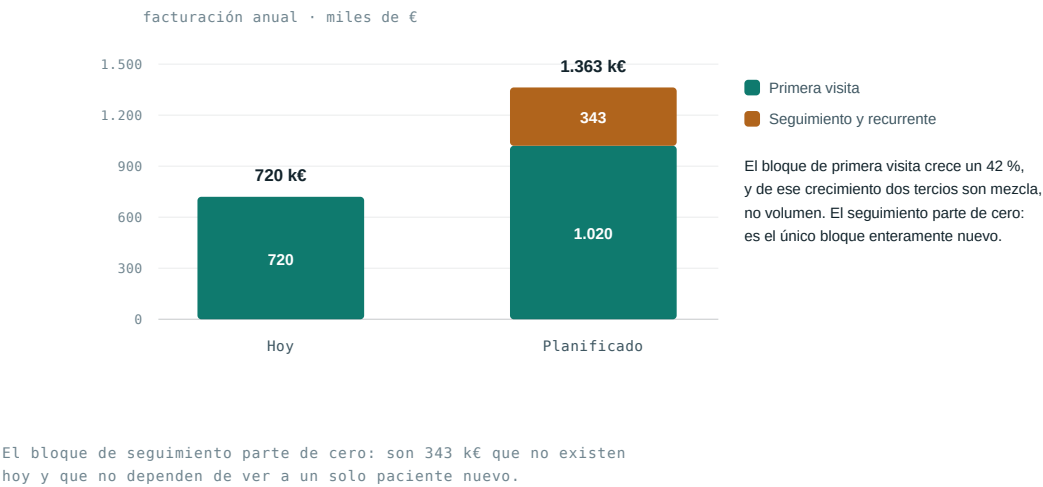
Por qué el colchón es del 12 % y no de cero

Porque de nueve campañas, dos no arrancarán a tiempo, una dependerá de una decisión que se retrase y otra rendirá la mitad de lo previsto. Eso no es pesimismo: es la tasa normal.

Planificar 1.200 para conseguir 1.200 obliga a que las nueve salgan perfectas, y entonces la primera que falle se lleva por delante el objetivo entero. **El colchón no es holgura: es lo que hace que la cifra sea creíble.**

Figura 9 · De qué está hecho el plan

La facturación de hoy —toda de primera visita— frente a la composición del plan antes del colchón.
Naturaleza: **modelo**.



El objetivo no se alcanza captando más pacientes. La agenda no los admite. Se alcanza cambiando quién ocupa las visitas que ya tenemos y cobrando por seguir cuidando a quien ya tratamos.

La apuesta del apartado 20, derivada del modelo

21

LA CARTERA DE CAMPAÑAS

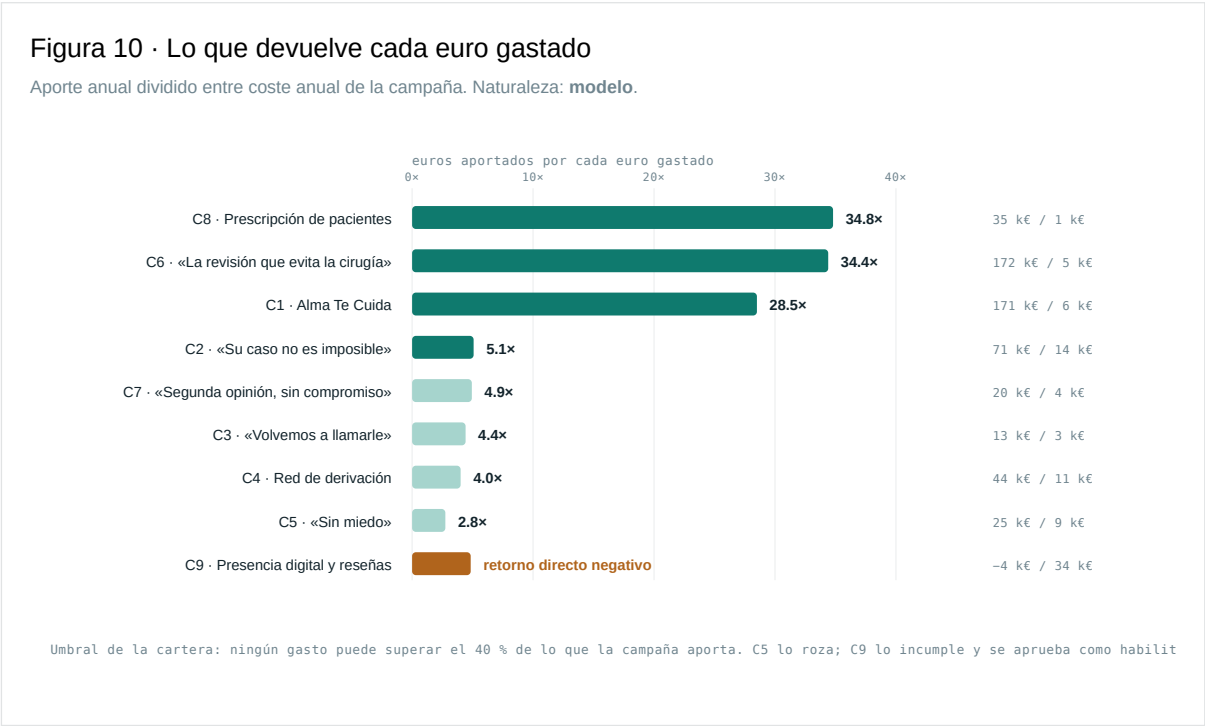
Nueve campañas, cada una con su cuenta echada

Alma Te Cuida es una de las nueve. Cada fila de esta tabla es una multiplicación que se puede rehacer: visitas que ocupa × conversión × ticket, menos lo que habría rendido esa misma visita sin la campaña.

CÓD.	CAMPAÑA	A QUIÉN	VISITAS	CONV.	TICKET	APORTA	COSTE	RETORNO	DEPENDE DE
C1	Alma Te Cuida No ocupa agenda de primera visita	Todo paciente que termina tratamiento	—	—	—	171 k€	6 k€	28.5×	D5 · D14
C2	«Su caso no es imposible» Convierte la mitad porque llega decidido, y el plan es de rehabilitación	Atrofia severa, rehabilitación completa, casos rechazados en otros centros	80	50 %	3.400 €	71 k€	14 k€	5.1×	—
C3	«Volvemos a llamarle» Confían, así que convierten bien, pero el caso suele ser ordinario	Pacientes del centro sin visita en más de dieciocho meses	130	48 %	1.900 €	13 k€	3 k€	4.4×	Inventario de cartera
C4	Red de derivación La conversión más alta de la cartera: llegan enviados y con el caso acotado	Clínicas generalistas de la provincia que no hacen implantología compleja	70	60 %	2.400 €	44 k€	11 k€	4.0×	—
C5	«Sin miedo» Cuando por fin deciden, el plan acumulado es amplio	Ansiedad dental severa: años sin sentarse en un sillón	55	45 %	2.800 €	25 k€	9 k€	2.8×	D6
C6	«La revisión que evita la cirugía» No ocupa agenda de primera visita	Portadores de implantes, propios y de otros centros	—	—	—	172 k€	5 k€	34.4×	—
C7	«Segunda opinión, sin compromiso» Convierte menos porque compara, pero el diagnóstico completo eleva el plan	Quien tiene un presupuesto de otro centro y dudas	70	42 %	2.600 €	20 k€	4 k€	4.9×	D1
C8	Prescripción de pacientes La mayor confianza previa de todas: la conversión más alta del embudo abierto	La base propia, en tratamiento y terminada	120	55 %	2.000 €	35 k€	1 k€	34.8×	—
C9	Presencia digital y reseñas Búsqueda fría: la calidad media más baja de la cartera	Quien busca activamente en Ourense y su provincia	83	40 %	1.900 €	−4 k€	34 k€	NEGATIVO	D3 · D4

Aporte = visitas × (conversión × ticket − 810 €) para las siete de agenda; para C1 y C6, ingreso directo fuera del embudo. Coste total de la cartera: 87 k€, un 7,2 % del objetivo. Naturaleza: modelo.

Tres resultados que el modelo devuelve y que conviene mirar de frente



Uno · Las dos campañas más rentables son las dos más baratas, y ninguna capta pacientes

C6 devuelve 34 € por cada euro y C1 devuelve 28. Las dos trabajan sobre pacientes que ya son del centro. La campaña más cara de la cartera —C9, con -4 k€ de aporte y treinta y cuatro mil de gasto— es la única con retorno directo negativo. **Esto no es una opinión sobre el marketing digital: es lo que sale de multiplicar.**

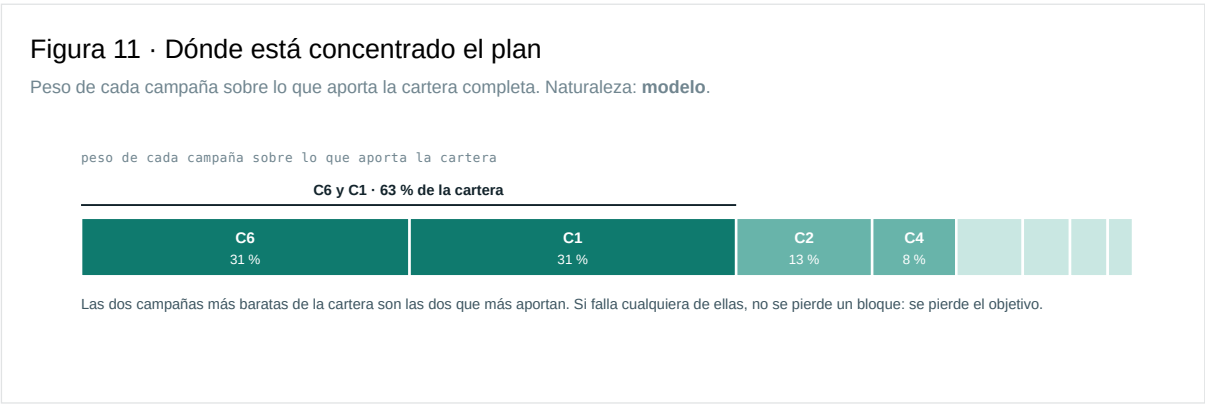
Y sin embargo C9 se aprueba. No como campaña de retorno, sino como **habilitador**: sin presencia digital, C2, C4, C5 y C7 no encuentran a nadie, y esas cuatro suman 71 + 44 + 25 + 20 k€. Apagar C9 para ahorrar treinta y cuatro mil euros pondría en riesgo diez veces esa cifra. Que conste así en el acta, porque la tentación de recortarla llegará.

La regla de gasto

Ninguna campaña puede costar más del 40 % de lo que aporta —el margen de contribución del apartado 18—. C5 lo roza. C9 lo incumple y por eso necesita justificación aparte.

Lo que esto no dice

Que la captación digital no sirva. Dice que con la agenda llena no paga por sí sola, y que su papel es otro.



Dos · El plan está peligrosamente concentrado

C6 y C1 aportan el **63 %** de la cartera. Si cualquiera de las dos falla, no se pierde un bloque: se pierde el objetivo, porque el colchón del 12 % no cubre una caída de esa magnitud. Las dos dependen de lo mismo —que el seguimiento se ofrezca y se registre en el cierre de cada tratamiento— y las dos están sometidas a la misma decisión: D14. **D14 no es una decisión menor sobre un programa: es la mitad del objetivo.**

Tres · La cartera dormida vale mucho más en el año uno que en el tres

C3 aporta solo 13 k€ en régimen, y a primera vista parece la peor campaña de la lista. No lo es: es la mejor mientras la agenda tenga huecos. Con 3,5 visitas al día hay sitio libre, y ahí una llamada a un paciente propio no desplaza a nadie —factura 810 € limpios en vez de la diferencia—. Cuando la agenda se llene, su valor cae al diferencial.

De ahí que arranque en febrero del primer año y no más tarde: **es la campaña que hay que hacer antes de que deje de valer la pena.** Es también la más barata de todas y la que ningún centro hace.

Los dos regímenes

Con hueco, una campaña suma lo que factura. Con la agenda llena, suma solo su diferencia. El modelo calcula siempre el segundo, que es el conservador.

Las cuatro reglas de la cartera

Una: nunca más de dos campañas arrancando a la vez. **Dos:** ninguna se lanza sin guion escrito y ensayado. **Tres:** toda campaña tiene umbral de parada a los sesenta días. **Cuatro:** ninguna puede costar más del 40 % de lo que aporta, y la excepción —C9— se aprueba nombrándola como excepción.

22

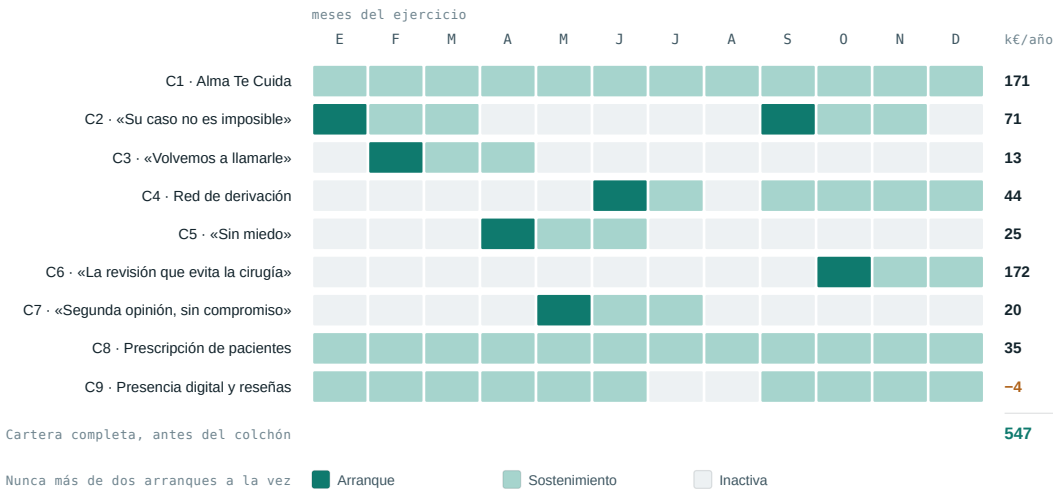
CALENDARIO Y CAPACIDAD

Cuándo se enciende cada una, y por qué en ese mes

La demanda dental no es plana. Enero y septiembre son los meses en que la gente decide; agosto y diciembre, en los que aplaza. Encender una campaña cara en julio es tirar el dinero, y encender dos a la vez en enero es no atender bien ninguna.

Figura 12 · Las nueve campañas a lo largo del ejercicio

En oscuro el arranque, en claro el sostenimiento. C1 y C8 no tienen arranque porque son permanentes: viven dentro del protocolo, no fuera. Naturaleza: modelo.



En ningún mes hay más de dos arranques. Es la regla, y el calendario está construido para cumplirla.

La senda: el objetivo es de año tres, no de año uno

Las campañas necesitan arrancar, madurar y acumular base. C1 y C6 —el 63 % del plan— solo alcanzan su régimen cuando la base adherida lleva tres años acumulándose: en el primer ejercicio hay una tercera parte de los pacientes que habrá en el tercero, y la aritmética no admite atajos.

EJERCICIO	QUÉ ESTÁ EN MARCHA	FACTURACIÓN	QUÉ HAY QUE HABER DEMOSTRADO AL CERRARLO
Año 1	C1, C3, C8 y C9. Protocolo ejecutado completo y línea base levantada	890 k€	Los diez indicadores con serie propia y la conversión por encima del 45 %
Año 2	Se añaden C2, C6 y C7. El ticket sube por composición de casos	1.060 k€	Base en seguimiento contratado por encima de 300 pacientes
Año 3	Cartera completa: entran C4 y C5	1.200 k€	El objetivo, con la capacidad actual y sin abrir una segunda unidad

Coincide con el escenario «objetivo» del apartado 8, que situaba 1.150 k€ en el mes 36. La diferencia son los 50 k€ que aporta afinar la cartera. Naturaleza: modelo.

La comprobación que evita el error caro

Antes de encender cualquier campaña, una sola pregunta: **¿hay hueco en la agenda para atender lo que va a traer?** El modelo la responde en el agregado —las nueve piden 608 visitas de las 1.008 que hay—, pero mes a mes la responde el responsable de la campaña. Generar demanda que no se puede atender es la forma más cara de hacer marketing: se paga el coste de la campaña y el daño de la espera.

23 QUÉ TIENE QUE SER CIERTO

Las cinco condiciones, y el riesgo que ninguna campaña puede permitirse

El puente del apartado 20 se sostiene sobre cinco cosas. Ninguna es una campaña: son condiciones. **Si alguna no se cumple, el objetivo no baja un poco: se cae el bloque entero que dependía de ella.**

Condición 1 · La que más pesa

Que el seguimiento se ofrezca y se registre siempre

C1 y C6 son el 63 % de la cartera y las dos dependen de un solo gesto repetido: que en el cierre de cada tratamiento se ofrezca el programa y quede constancia. No es una campaña de marketing, es un punto de verificación. Si se ofrece «cuando encaja», se van 171 + 172 k€.

Cómo se comprueba

Indicador 9, tasa de ofrecimiento, umbral del 90 %. Y la decisión D14, que lo hace obligatorio.

Condición 2

Que el protocolo se ejecute completo, no a medias

Todo el puente supone una conversión base del 45 %. Hoy es un supuesto de trabajo, no una medición. Si la real fuese del 35 %, el valor de la visita cae de 810 a 630 € y con él todos los diferenciales de la tabla del apartado 21.

Cómo se comprueba

Indicador 6, con cohorte cerrada a 60 días. Primera lectura fiable: tercer mes.

Condición 3

Que exista una cartera propia que reactivar

C3 supone 130 visitas al año traídas de la base dormida. Nadie ha contado todavía cuántos pacientes son, cuántos siguen localizables y cuántos volverían. Es el supuesto más barato de comprobar de toda la Parte VI y está sin comprobar.

Cómo se comprueba

Inventario de cartera en las dos primeras semanas. Dos días de trabajo administrativo.

Condición 4

Que el ticket suba por complejidad y no por tarifa

La tabla del apartado 21 asigna a C2 un ticket de 3.400 € y a C5 de 2.800. Si eso se intenta subiendo precios en lugar de tratando casos más complejos, la conversión cae y el diferencial se vuelve negativo: la campaña destruiría valor exactamente igual que C9.

Cómo se comprueba

Ticket y conversión se leen siempre juntos. Si uno sube y el otro baja, la palanca está mal accionada.

Condición 5

Que el equipo aguante

Nueve campañas, un protocolo nuevo y una línea base que levantar es mucha carga sobre las mismas personas. La condición más silenciosa y la que más veces rompe los planes: no falla la demanda, falla quien tiene que atenderla.

Cómo se comprueba

Indicador 2, bajas voluntarias, y la regla de no más de dos arranques simultáneos.

El riesgo que ninguna campaña puede permitirse: la publicidad sanitaria

Tres de las nueve tocan materia regulada. La publicidad sanitaria en España no admite prometer resultados, comparar con otros profesionales ni presentar casos como resultado esperable, y la competencia es autonómica. Es la verificación **V11** del sistema, y aquí deja de ser una casilla para convertirse en una condición de arranque: **ninguna campaña marcada en rojo se enciende sin pasar por ella.**

CÓD.	CAMPAÑA	RIESGO	QUÉ EXIGE V11
C1	Alma Te Cuida	Bajo	Contrato de adhesión: es materia de consumo, no de publicidad sanitaria.
C2	«Su caso no es imposible»	Alto	Prohibido sugerir resultados garantizados o comparar con otros profesionales. Los casos publicados exigen consentimiento expreso y no pueden presentarse como resultado esperable.
C3	«Volvemos a llamarle»	Bajo	Comunicación a pacientes propios, no publicidad.
C4	Red de derivación	Medio	Comunicación entre profesionales; el acuerdo no puede incluir contraprestación económica por derivación.
C5	«Sin miedo»	Alto	No puede prometerse ausencia de dolor ni presentarse la sedación como servicio general sin la habilitación de D6.
C6	«La revisión que evita la cirugía»	Bajo	Recordatorio asistencial a pacientes con tratamiento previo.
C7	«Segunda opinión, sin compromiso»	Medio	No puede formularse como comparación desfavorable con otro profesional ni como oferta de precio.
C8	Prescripción de pacientes	Bajo	No puede incentivarse económicamente la recomendación.
C9	Presencia digital y reseñas	Alto	Toda pieza pasa por V11 antes de publicarse: es el canal con más superficie de exposición.

Valoración de dirección, no dictamen jurídico. Las tres marcadas en alto requieren revisión por asesoría antes de publicar la primera pieza.

Y si la Junta quiere 1,2 M€ en dieciocho meses

Es una decisión legítima y tiene precio. Comprimir tres años en año y medio no se consigue acelerando las campañas —C1 y C6, que son el 63 % del plan, maduran al ritmo al que se acumula la base adherida— sino ampliando capacidad: **un segundo gabinete en uso efectivo y un día más de quirófano a la semana.** Eso significa invertir en la prioridad 5 del apartado 15 antes de haber consolidado la 2 y la 3, que es justo el orden que el apartado 15 pide no romper.

Se puede hacer. Pero entonces hay que decirlo así en el acta: *«la Junta acuerda anticipar la prioridad 5, asumiendo que se hace antes de que el estándar esté consolidado»*. Lo que no se puede es fijar el plazo de dieciocho meses y mantener a la vez el orden de prelación intacto, porque una de las dos cosas no será verdad.

Se somete como D15

Fijar el objetivo y su horizonte. Es la decisión que ordena todo lo demás de esta parte.

El modelo es auditable

Está en modelo -campanas-.py. Cualquiera puede ejecutarlo, cambiar un supuesto y ver qué le pasa al puente.

Lo que esta parte pide a la Junta

Fijar la cifra y el horizonte —1.200 k€ en el ejercicio tercero—, aprobar la cartera de nueve campañas como contenido de D4, y entender que **D14 no es un detalle del programa de cuidado: es el 63 % del objetivo**.

Y una cosa más, que no cuesta dinero: aceptar que el primer año no se parece al tercero. Un objetivo de año tres exigido en el año uno no acelera nada; solo garantiza que en diciembre parezca un fracaso lo que iba conforme al plan.

ANEXO A · CUADERNILLO DE ACUERDOS

Quince hojas para salir de la sesión con el acta hecha

Una hoja por decisión, con las alternativas ya redactadas y espacio para la resolución, el fundamento, la fecha de entrada en vigor y las firmas. Se imprimen a una cara, se rellenan durante la sesión y se archivan. **Sin este cuadernillo, la Junta sale con quince acuerdos y un acta por redactar**; con él, sale con quince documentos firmados y con fecha.

Cómo se usa

Marque la alternativa adoptada, escriba el fundamento en dos líneas —basta con dos— y fije la fecha de entrada en vigor. Un acuerdo sin fecha de entrada en vigor no llega al equipo, y un acuerdo cuyo fundamento no se anotó es un acuerdo que dentro de tres meses nadie sabrá por qué se tomó así. La opción D existe porque una Junta no está obligada a elegir entre las alternativas que le presentan.

D1

Política de precios y tabla de descuentos

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: INMEDIATO

Qué se somete a acuerdo. Aprobar la tipología cerrada de descuentos, sus porcentajes máximos por tipo, el tope de acumulación y quién autoriza cada tramo.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Tipología cerrada con tope de acumulación y autorización nominal por tramo

☐

B

Descuento máximo único sin tipología, autorizado siempre por Gerencia

☐

C

Mantener la situación actual y revisar en el primer trimestre

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor	Responsable de ejecución
_____	_____
Próxima revisión	Consulta previa realizada
_____	_____

Documentos afectados

Manual Maestro, Parte VI · Protocolo, Fase 10

Se verificará en

Margen por caso y producto pendiente

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

D2

Garantías publicadas por tipo de tratamiento

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: INMEDIATO

Qué se somete a acuerdo. Fijar los plazos de garantía por tipo de tratamiento que el centro asume por escrito ante el paciente.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Tabla de garantías publicada y entregada con cada presupuesto

☐

B

Garantía única de duración uniforme para todo tratamiento

☐

C

Sin garantía publicada, resolución caso a caso

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Se verificará en

Otros documentos, 12 · cartelería de sala

Reclamaciones formales · indicador 3

Comunicación del acuerdo

Destinatarios

Canal

Fecha

Presidencia

Secretaría

Fecha de la sesión

D3

Arquitectura de marca y naming

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: PRIMER TRIMESTRE

Qué se somete a acuerdo. Aprobar la arquitectura por verticales y ordenar la verificación legal de marca y dominios antes de cualquier adopción.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐ A Arquitectura por verticales, condicionada a verificación registral previa

☐ B Marca única sin verticales

☐ C Aplazar hasta disponer del estudio de mercado

☐ D Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor	Responsable de ejecución
_____	_____
Próxima revisión	Consulta previa realizada
_____	_____

Documentos afectados
Otros documentos, 9 · marca y captación

Se verificará en
Captación por recomendación · indicador 8

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

D4

Presupuesto anual de captación y modelo de ejecución

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: PRIMER TRIMESTRE

Qué se somete a acuerdo. Autorizar el porcentaje de facturación destinado a marca y captación, y el modelo de ejecución: interno, agencia o mixto.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Porcentaje fijo de facturación, ejecución mixta con responsable interno

☐

B

Importe cerrado anual con agencia externa

☐

C

Sin presupuesto propio hasta que la conversión esté en umbral

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Otros documentos, 9 · economía unitaria

Se verificará en

Coste por primera visita captada

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

D5

Programa de cuidado: precio, catálogo y validación jurídica

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: INMEDIATO

Qué se somete a acuerdo. Cerrar precio, catálogo de servicios y límites, y ordenar la validación jurídica del contrato de adhesión antes de comercializarlo.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Cerrar catálogo y precio ahora, comercializar tras dictamen jurídico favorable

☐

B

Lanzar con catálogo provisional y revisar tras los primeros contratos

☐

C

Aplazar el lanzamiento al segundo semestre

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor	Responsable de ejecución
_____	_____
Próxima revisión	Consulta previa realizada
_____	_____

Documentos afectados

Otros documentos, 14 · Protocolo, Fases 10 a 12

Se verificará en

Mantenimiento activo · indicador 7

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

D6

Línea de sedación consciente

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: PRIMER TRIMESTRE

Qué se somete a acuerdo. Autorizar —o posponer— la línea, condicionada a la verificación del alcance competencial con asesoría y colegio profesional.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Autorizar condicionada al informe favorable de alcance competencial

☐

B

Posponer la línea y derivar el segmento a un centro colaborador

☐

C

Descartar la línea en este horizonte

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Se verificará en

Manual Maestro, Parte V

Casos del segmento de ansiedad severa

Comunicación del acuerdo

Destinatarios

Canal

Fecha

Presidencia

Secretaría

Fecha de la sesión

D7

Marco de inversión en flujo digital

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: SEGUNDO TRIMESTRE

Qué se somete a acuerdo.

Aprobar el marco de inversión tecnológica y el criterio de retorno exigible a cada partida.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐ A

Marco con periodo de recuperación máximo exigible por partida

☐ B

Aprobación caso a caso por la Junta sin marco previo

☐ C

Congelar la inversión tecnológica hasta disponer de línea base

☐ D

Otra:

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Manual Maestro, Parte VI · compras

Se verificará en

Documentación en el día · indicador 4

Comunicación del acuerdo

Destinatarios

Canal

Fecha

Presidencia

Secretaría

Fecha de la sesión

D8

Responsables funcionales y Comité de Transición

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: INMEDIATO

Qué se somete a acuerdo. Designar con nombre al responsable de marca y reseñas, y confirmar la composición y periodicidad del Comité de Transición.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Designación nominal de las cuatro áreas y comité quincenal

☐

B

Designación nominal parcial, resto asumido por Dirección

☐

C

Mantener todas las áreas bajo Dirección

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor	Responsable de ejecución
_____	_____
Próxima revisión	Consulta previa realizada
_____	_____

Documentos afectados

Manual Maestro, Parte III · RACI

Se verificará en

Bajas voluntarias · indicador 2

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

D9

Regla de cartera de innovación 70/20/10

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se somete a acuerdo. Aprobar el reparto orientativo entre horizontes H1, H2 y H3 y la regla de que ningún horizonte se financie con recursos comprometidos en otro.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Reparto 70/20/10 con revisión anual

☐

B

Decidir caso a caso según mérito de cada iniciativa

☐

C

Concentrar todo el esfuerzo en H1 durante el primer año

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor	Responsable de ejecución
_____	_____
Próxima revisión	Consulta previa realizada
_____	_____

Documentos afectados

Otros documentos, 8 · apartado 6 del Plan de Dirección

Se verificará en

Reparto ejecutado frente al aprobado

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

D10

Orden de prelación del capital

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se somete a acuerdo. Aprobar las cinco prioridades —continuidad, foso, conversión, captación, capacidad— y la regla de excepción documentada.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Orden de prelación con excepción documentada y presentada en Junta

☐

B

Presupuesto por partidas contables sin orden de prelación

☐

C

Orden de prelación sin regla de excepción

☐

D

Otra:

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

apartado 15 del Plan de Dirección · presupuesto anual

Se verificará en

Ejecución por prioridad, trimestral

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión

D11

Condición de apertura de segunda unidad

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se somete a acuerdo. Establecer que no se autoriza búsqueda de plaza ni compromiso inmobiliario sin acreditar los pasos 3 y 4 del apartado 10.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Condición estricta: sin pasos 3 y 4 acreditados, no hay prospección

☐

B

Condición orientativa, con posibilidad de dispensa de la Junta

☐

C

Sin condición: decidir por oportunidad de mercado

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Se verificará en

apartado 10 del Plan de Dirección

Un trimestre en umbral sin intervención de Dirección

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

D12

Suelo anual de inversión en el sistema

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se somete a acuerdo. Fijar un suelo anual de inversión en formación, verificación y documentación, expresado como porcentaje de facturación, irreducible sin acuerdo expreso.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Suelo porcentual irreducible sin acuerdo expreso de la Junta

☐

B

Partida anual revisable trimestralmente según resultado

☐

C

Sin suelo: gasto variable ajustable a la marcha del ejercicio

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Presupuesto anual, partida de sistema

Se verificará en

Auditorías en fecha · indicador 10

Comunicación del acuerdo

Destinatarios

Canal

Fecha

Presidencia

Secretaría

Fecha de la sesión

D13

Disparadores de Junta extraordinaria

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se somete a acuerdo. Aprobar los cinco disparadores del pre-mortem como obligación automática de convocatoria, sin valoración previa de gravedad.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Los cinco disparadores, con convocatoria automática

☐

B

Los cinco disparadores, con convocatoria a criterio de Dirección

☐

C

Sin disparadores: convocatoria ordinaria trimestral

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Se verificará en

Anexo de gobernanza del Manual Maestro

Indicadores 2, 3, 9 y 10

Comunicación del acuerdo

Destinatarios

Canal

Fecha

Presidencia

Secretaría

Fecha de la sesión

D15

Objetivo de facturación y horizonte

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: ESTA SESIÓN

Qué se somete a acuerdo. Fijar la cifra de facturación anual y el ejercicio en que se exige, y aprobar la cartera de nueve campañas del apartado 21 como contenido de D4.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

1,2 M€ en el ejercicio tercero, con la senda 890 · 1.060 · 1.200

☐

B

1,2 M€ en dieciocho meses, anticipando la prioridad 5 del apartado 15 y ampliando capacidad

☐

C

Aplazar la fijación del objetivo hasta disponer de línea base real

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor

Responsable de ejecución

Próxima revisión

Consulta previa realizada

Documentos afectados

Se verificará en

apartados 20 a 23 del Plan de Dirección · presupuesto anual

Facturación anual frente a la senda de apartado 22

Comunicación del acuerdo

Destinatarios

Canal

Fecha

Presidencia

Secretaría

Fecha de la sesión

D14

Programa de cuidado obligatorio en el cierre

REGISTRO DE DECISIÓN N° _____ · PLAZO: TRAS D5

Qué se somete a acuerdo. Establecer que ofrecer el programa es punto verificable obligatorio del cierre de todo tratamiento, y medir la tasa de ofrecimiento además de la de contratación.

Alternativas evaluadas · márquese la adoptada

☐

A

Obligatorio y medido, con umbral del 90 % de ofrecimiento

☐

B

Recomendado, medido pero sin umbral exigible

☐

C

A criterio comercial del profesional

☐

D

Otra: _____

Fundamento de la resolución

Entrada en vigor	Responsable de ejecución
_____	_____
Próxima revisión	Consulta previa realizada
_____	_____

Documentos afectados

Protocolo, Fase 12 · Otros documentos, 14

Se verificará en

Ofrecimiento del programa · indicador 9

Comunicación del acuerdo

Destinatarios	Canal	Fecha
_____	_____	_____
Presidencia	Secretaría	Fecha de la sesión
_____	_____	_____

ANEXO B · FICHAS DE CAMPAÑA

Nueve hojas para poner en marcha, no para leer

Una por campaña, con la promesa, a quién va dirigida, qué se le ofrece, cómo se abre la conversación, quién responde y —lo que casi nunca se escribe— **en qué momento se para**. Se imprimen, se reparten al responsable de cada una y se revisan a los sesenta días.

Cómo se usa una ficha

La contribución exigida no es una previsión: es el compromiso que asume quien la firma. El umbral de parada no es pesimismo: es lo que impide que una campaña que no funciona siga consumiendo presupuesto y atención durante un año entero porque a nadie le apetece admitirlo. **Una campaña sin umbral de parada no se cancela nunca.**

Su tratamiento no termina cuando se coloca: empieza otra cosa

A quién	Dónde está
Todo paciente que termina un tratamiento, sin excepción ni criterio comercial.	No hay que encontrarlo: ya está sentado delante. La campaña vive dentro del cierre de la Fase 12.
Qué se le ofrece	Canal y ritmo
El programa de cuidado anual: revisiones, mantenimiento y prioridad de agenda, por una cuota.	Punto de verificación obligatorio del cierre. Permanente, los doce meses.

De dónde sale la cifra

Cuotas netas de sustitución · 61 k€ 460 adheridos × 190 € de cuota, menos el 30 % que sustituye higienes ya facturables.
Tratamiento detectado en la base adherida · 110 k€ 460 adheridos × 16 % que necesita tratamiento nuevo al año × 1.500 € de ticket medio.
Total: 171 k€

Cómo se abre la conversación

«Antes de que se vaya, quiero explicarle cómo vamos a cuidar esto a partir de ahora. No es una venta: es cómo trabajamos.»
--

Contribución exigida	Coste y retorno
171 k€ al año , en régimen	6 k€ al año · 28.5 € por cada euro gastado
Responsable	Depende de
Dirección	D5 · catálogo y validación jurídica · D14 · obligatoriedad en el cierre
Cómo se mide	Umbral de parada
Indicador 9 · ofrecimiento por encima del 90 %	Si el ofrecimiento baja del 90 % dos meses seguidos, se para todo lo demás y se corrige esto.

Fecha de arranque acordada	Primera revisión (60 días)	Resultado a la revisión

C2

«Su caso no es imposible»

ARRANQUE: ENERO Y SEPTIEMBRE · APORTA 71 K€/AÑO

Le dijeron que no se podía. Vamos a mirarlo otra vez

A quién

Atrofia severa, rehabilitación completa, fracasos previos, casos rechazados en otros centros.

Qué se le ofrece

Un diagnóstico completo con CBCT y una respuesta honesta, incluida la de que no se puede.

Dónde está

No busca precio: busca a alguien que se atreva. Llega por contenido, por prescripción y por segunda opinión.

Canal y ritmo

Casos propios documentados, colaboración con prescriptores, presencia en búsqueda. Arranque fuerte en enero y septiembre.

De dónde sale la cifra

80 visitas × (50 % × 3.400 € – 810 €) = 71 k€

Cómo se abre la conversación

«Tráigame lo que le dijeron. Vamos a ver el caso entero, no solo la zona que le duele, y le voy a decir la verdad.»

Contribución exigida

71 k€ al año, en régimen

Responsable

Dirección clínica

Coste y retorno

14 k€ al año · 5.1 € por cada euro gastado

Depende de

Nada externo: casuística y CBCT ya están

Cómo se mide

Ticket medio de los casos aceptados y número de casos complejos al mes

Umbral de parada

Si a los 60 días no hay al menos tres casos complejos aceptados, se revisa el mensaje antes de gastar más.

Fecha de arranque acordada

Primera revisión (60 días)

Resultado a la revisión

Centro de Excelencia Implantológica Alma

Página 72 de 80

C3

«Volvemos a llamarle»

ARRANQUE: FEBRERO · APORTA 13 K€/AÑO

A quién

Pacientes del propio centro sin visita en más de dieciocho meses.

Qué se le ofrece

Una revisión sin coste y, si procede, retomar el tratamiento donde se dejó.

Dónde está

Están en la base de datos. La campaña más barata que existe y la primera que todo centro abandona.

Canal y ritmo

Teléfono, uno a uno, con guion escrito. Nunca correo masivo. Veinte llamadas al día durante ocho semanas.

De dónde sale la cifra

130 visitas × (48 % × 1.900 € – 810 €) = 13 k€

Cómo se abre la conversación

«Le llamo del centro. Veo que la última vez que vino fue hace dos años y quedó pendiente terminar. ¿Cómo está de eso?»

Contribución exigida

13 k€ al año, en régimen

Responsable

Recepción, con seguimiento diario de Gerencia

Cómo se mide

Llamadas hechas, citas conseguidas y tratamientos retomados

Coste y retorno

3 k€ al año · 4.4 € por cada euro gastado

Depende de

Inventario de la cartera dormida, que nadie ha hecho todavía

Umbral de parada

Si de 200 llamadas no salen 20 citas, el problema es el guion, no la cartera: se reescribe.

Fecha de arranque acordada

Primera revisión (60 días)

Resultado a la revisión

C4

Red de derivación

ARRANQUE: JUNIO · APORTA 44 K€/AÑO

Le devolvemos a su paciente, y con el caso resuelto

A quién Clínicas generalistas de Ourense y su provincia que no hacen implantología compleja.	Dónde está No es una campaña de pacientes: es de colegas. Se hace en persona, una a una.
Qué se le ofrece Resolver el caso que ellos no hacen y devolver al paciente para todo lo demás, por escrito.	Canal y ritmo Visita profesional del director clínico. Dos clínicas por semana. Acuerdo escrito de devolución.

De dónde sale la cifra

$70 \text{ visitas} \times (60 \% \times 2.400 \text{ €} - 810 \text{ €}) = 44 \text{ k€}$

Cómo se abre la conversación

«No queremos su paciente. Queremos el caso que usted no va a hacer, y devolvérselo terminado con el informe.»

Contribución exigida 44 k€ al año, en régimen	Coste y retorno 11 k€ al año · 4.0 € por cada euro gastado
Responsable Dirección clínica	Depende de Protocolo de derivación y compromiso de devolución por escrito
Cómo se mide Clínicas con acuerdo firmado y pacientes derivados al trimestre	Umbral de parada Si tras veinte visitas no hay cinco acuerdos, el problema es la propuesta, no el mercado.

Fecha de arranque acordada	Primera revisión (60 días)	Resultado a la revisión
---	---	--

C5

«Sin miedo»

ARRANQUE: ABRIL · APORTA 25 K€/AÑO

Lleva años sin ir al dentista. No le vamos a reñir

A quién

Ansiedad dental severa: personas que llevan años evitando el sillón.

Qué se le ofrece

Una primera visita sin instrumental, un circuito propio y sedación consciente si hace falta.

Dónde está

Es el segmento que menos se comunica y más lo agradece. Llega por mensaje explícito, casi nunca preguntando.

Canal y ritmo

Mensaje explícito en todos los canales, circuito diferenciado en el centro. Arranque en abril.

De dónde sale la cifra

55 visitas × (45 % × 2.800 € – 810 €) = 25 k€

Cómo se abre la conversación

«La primera vez no le vamos a tocar nada. Solo vamos a hablar y a mirar. Usted dice cuándo paramos.»

Contribución exigida

25 k€ al año, en régimen

Responsable

Dirección clínica

Coste y retorno

9 k€ al año · 2.8 € por cada euro gastado

Depende de

D6 · autorización de la línea de sedación consciente

Cómo se mide

Pacientes atendidos del segmento y tasa de abandono entre primera visita y tratamiento

Umbral de parada

Si la habilitación de sedación no está resuelta, la campaña no arranca: no se promete lo que no se puede dar.

Fecha de arranque acordada

Primera revisión (60 días)

Resultado a la revisión

Centro de Excelencia Implantológica Alma

Página 75 de 80

Un implante también se cuida, y cuesta mucho menos que rehacerlo

A quién	Dónde está
Portadores de implantes, propios y de otros centros.	Un segmento enorme y desatendido: casi nadie les llama, porque no produce caja inmediata.
Qué se le ofrece	Canal y ritmo
Revisión de mantenimiento con informe, y entrada natural al programa de cuidado.	Agenda de recuerdo del higienista e informe escrito al paciente. Arranque en octubre.

De dónde sale la cifra

Revisiones facturadas · 100 k€ 1.050 revisiones al año × 95 €, entre base propia y portadores de otros centros.
Tratamiento detectado a tiempo · 72 k€ 1.050 revisiones × 6 % con hallazgo tratable × 1.150 € de ticket medio.
Total: 172 k€

Cómo se abre la conversación

«¿Cuándo le revisaron los implantes por última vez? Le explico qué pasa cuando no se revisan.»
--

Contribución exigida	Coste y retorno
172 k€ al año , en régimen	5 k€ al año · 34.4 € por cada euro gastado
Responsable	Depende de
Higienista, con supervisión de Dirección	Indicador 7 definido y en captura
Cómo se mide	Umbral de parada
Indicador 7 · pacientes en mantenimiento activo	Si el mantenimiento activo no crece dos trimestres seguidos, se revisa el circuito de recuerdo.

Fecha de arranque acordada	Primera revisión (60 días)	Resultado a la revisión

C7

«Segunda opinión, sin compromiso»

ARRANQUE: MAYO · APORTA 20 K€/AÑO

Traiga el presupuesto que le han dado. Lo miramos juntos

A quién Quien ya tiene un plan de tratamiento de otro centro y no está seguro.	Dónde está Llega con la decisión medio tomada y con toda la información encima de la mesa. Convierte más que ningún otro.
Qué se le ofrece Diagnóstico completo propio y explicación de las diferencias, sin presión de cierre.	Canal y ritmo Oferta explícita en el mensaje y en recepción. Arranque en mayo.

De dónde sale la cifra

70 visitas × (42 % × 2.600 € – 810 €) = **20 k€**

Cómo se abre la conversación

«No vengo a criticar a nadie. Vamos a mirar su caso desde cero y luego usted compara.»

Contribución exigida 20 k€ al año, en régimen	Coste y retorno 4 k€ al año · 4.9 € por cada euro gastado
Responsable Dirección	Depende de D1 · política de precios y tabla de descuentos
Cómo se mide Conversión específica del segmento frente a la conversión general	Umbral de parada Si acaba convirtiéndose en una negociación de precio, se suspende: destruye la política de D1.

Fecha de arranque acordada	Primera revisión (60 días)	Resultado a la revisión

C8

Prescripción de pacientes

ARRANQUE: PERMANENTE · APORTA 35 K€/AÑO

Si le hemos tratado bien, dígaselo a quien lo necesite

A quién La base propia, en tratamiento y terminada.	Dónde está El canal más barato, el de mayor conversión y el único que nadie puede copiar.
Qué se le ofrece Nada material. Se pide, sencillamente, en el momento adecuado del recorrido.	Canal y ritmo Petición formal integrada en el protocolo, en el momento de mayor satisfacción. Permanente.

De dónde sale la cifra

120 visitas × (55 % × 2.000 € – 810 €) = 35 k€

Cómo se abre la conversación

«Si ha estado a gusto, lo que más nos ayuda es que se lo cuente a alguien que lo esté pasando como usted lo pasaba.»

Contribución exigida 35 k€ al año, en régimen	Coste y retorno 1 k€ al año · 34.8 € por cada euro gastado
Responsable Todo el equipo, con Dirección como responsable	Depende de Indicador 8 definido y campo de origen obligatorio
Cómo se mide Indicador 8 · captación por recomendación	Umbral de parada Si la recomendación no crece con la base, es que la experiencia no está a la altura: se mira eso, no la campaña.

Fecha de arranque acordada	Primera revisión (60 días)	Resultado a la revisión
---	---	--

C9

Presencia digital y reseñas

ARRANQUE: ENERO · APORTA -4 K€/AÑO

Que quien nos busque nos encuentre, y que al encontrarnos confíe

A quién

Quien busca activamente en Ourense y su provincia.

Dónde está

Búsqueda, ficha de negocio y reseñas. Es el escaparate, no el vendedor.

Qué se le ofrece

Información honesta, casos reales y respuesta a las preguntas que la gente hace de verdad.

Canal y ritmo

Ficha de negocio, reseñas pedidas sistemáticamente, contenido de casos. Todo el año salvo verano.

De dónde sale la cifra

83 visitas × (40 % × 1.900 € - 810 €) = -4 k€

Cómo se abre la conversación

«No hay guion: hay contenido. La pregunta que responde cada pieza es una que un paciente hizo en consulta.»

Contribución exigida

-4 k€ al año, en régimen

Coste y retorno

34 k€ al año · negativo en régimen · se aprueba como habilitador, no como campaña

Responsable

Responsable de marca, designado en D8

Depende de

D3 · arquitectura de marca · D4 · presupuesto de captación

Cómo se mide

Coste por primera visita captada y volumen de reseñas nuevas

Umbral de parada

Si el coste por primera visita supera el margen de contribución del caso medio, se apaga.

Fecha de arranque acordada

Primera revisión (60 días)

Resultado a la revisión

CIERRE

Qué mide el éxito de este año

Los tres resultados verificables

Que el equipo permanezca. Que los pacientes heredados no perciban discontinuidad. Que la organización acepte un estándar de trabajo superior al preexistente.

Los objetivos de crecimiento, diferenciación y liderazgo dependen íntegramente de esos tres. No son una fase previa al proyecto: son su fundamento. Un programa de integración no se evalúa por la sofisticación de su planificación, sino por si al cierre del periodo esas tres cosas han ocurrido.

La Junta dispone de un sistema operativo construido y verificable, de un mapa honesto de lo que aún no se sabe y de quince decisiones que solo ella puede tomar. Lo que se pide hoy no es respaldo genérico: es resolver esas quince y fijar la fecha de la próxima revisión.



Centro de Excelencia Implantológica Alma

Plan de Dirección para la Junta Directiva

Documento de uso interno y confidencial. Contiene información económica, laboral y estratégica. No se difunde fuera del órgano de gobierno sin autorización expresa de la Dirección General.

Versión

v32.0 · Septiembre 2026
Revisión trimestral

Documentos de referencia

Manual Maestro v32.0
Protocolo de Primera Visita v32.0
Otros documentos del sistema v32.0
Los números del centro v32.0

Manual Maestro

Protocolo de Primera Visita

Otros documentos

JUNTA DIRECTIVA · SEPTIEMBRE 2026 · USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

No medias sonrisas. Ni medias decisiones.

Centro de Excelencia Implantológica Alma · Plan de Dirección
v32.0 · Seis partes, veintitrés apartados y quince decisiones que
solo puede tomar este órgano.

EL PLANTEAMIENTO

Un plan, no un informe

PREGUNTA 1

¿Qué?

Qué creemos que es cierto sobre este mercado y por qué la posición que ocupamos está libre

PREGUNTA 2

¿Cuánto?

Qué vale cada palanca, en euros y con los supuestos declarados sobre la mesa

PREGUNTA 3

¿Y si no?

Bajo qué condiciones estaríamos equivocados, y qué señal lo avisaría a tiempo

Un informe cuenta lo que ha pasado. Un plan afirma, apuesta y se expone a ser refutada. Cada cifra de esta presentación lleva marcada su naturaleza: **hecho**, **modelo** o **pendiente**.



Dónde estamos parados y por qué ahí

La apuesta del proyecto, los segmentos desatendidos, el mapa competitivo de Ourense y el foso: qué tendría que hacer un competidor para quitarnos el sitio y cuánto tardaría.

Un centro que resuelve lo que otros rechazan y no termina la relación cuando cobra

«Le devolvemos su sonrisa completa, en el menor tiempo posible, y le cuidamos para siempre.»

La primera mitad es el resultado: ningún tratamiento se deja a medias. La segunda es la relación, y tiene instrumento propio: el programa de cuidado anual. La ventaja competitiva no es el equipamiento —lo reivindican todos— sino la ejecución sistemática.

Tres segmentos que casi nadie atiende

SEGMENTO	POR QUÉ ESTÁ DESATENDIDO	BARRERA DE ENTRADA
Casos de alta complejidad	Es más cómodo decir que no	Criterio y sistema, no equipamiento
Ansiedad dental severa	Casi nadie lo comunica explícitamente	Circuito de sedación con habilitación
Mantenimiento implantológico	No produce caja inmediata	Constancia y sistema; decisivo a largo plazo

Ninguno compra precio: los tres compran solución. Es el terreno donde la competencia en tarifa no llega.

Cuatro formas de vender implantes en Ourense, y la que dejamos libre

POSICIÓN	CÓMO COMPITE	DÓNDE SE ROMPE
A	Cadena de precio — captación masiva y financiación	El profesional rota: en la segunda intervención el paciente no encuentra a quien le operó
B	Generalista con implantes — vínculo personal, agenda mixta	Casuística baja: su límite no es la voluntad, es el número de casos al año
C	Especialista aislado — excelencia técnica real	No hay sistema debajo: su reputación no es transferible ni vendible
D	La nuestra — casuística de especialista, estándar verificable y seguimiento contratado	Solo se rompe por abandono propio

El mercado no se segmenta por precio, sino por **quién asume el riesgo del resultado**. A, B y C compiten por vender el acto; nosotros vendemos que alguien siga respondiendo cuando el acto ya se cobró.

MODELO

Lo que un competidor no puede comprar

ACTIVO	¿SE COMPRA?	RÉPLICA
Equipamiento: CBCT, escáner, cirugía guiada	Sí, con una llamada	2-3 meses
Instalaciones y ubicación	Sí	6-12 meses
Un cirujano de prestigio	Sí, fichándolo	3-9 meses
Protocolo escrito y verificable	No: se escribe	18-36 meses
Equipo que lo ejecuta sin supervisión	No	24-48 meses
Base de pacientes en seguimiento contratado	No	36-60 meses
Serie clínica propia a cinco años	No	60 meses+

Los tres primeros cuestan dinero. Los cuatro últimos dan ventaja.
Estamos invirtiendo, deliberadamente, en la mitad de abajo. **MODELO**

Un euro en equipamiento nos igual a con cualquiera.

Un euro en sistema nos separa durante años.

Por eso el gasto en formación, verificación y programa de seguimiento no es estructura ni coste indirecto: es la única partida del presupuesto que compra tiempo de ventaja frente a un competidor con más capital. Y es siempre la primera candidata al recorte.



El activo se llama **sistema operativo**, no clínica

Una clínica es un local con pacientes. Un sistema operativo es un conjunto de decisiones ya tomadas que hacen que el resultado no dependa de quién esté ese martes. Lo primero se vende al peso; lo segundo, por múltiplo.

Un sistema operativo, no un plan

RECORRIDO DEL PACIENTE

14

Fases, de la primera llamada al mantenimiento

PUESTOS NORMALIZADOS

6

Con límites, checklists, derivaciones y reporte

PUNTOS DE VERIFICACIÓN

322

Físicos, documentales, de sistemas y de proceso

DOCUMENTOS VIGENTES

17

Tres troncales y catorce de apoyo

Normativa interna con criterios de salida, registros obligatorios e indicador por fase. Escrita para ejecutarse y para auditarse.

Qué garantiza tenerlo por escrito

- **Manual Maestro de Operaciones** — la norma: catorce fases, manuales de puesto, responsabilidades, indicadores e incentivos
- **Protocolo de Primera Visita** — el detalle minuto a minuto de la visita que decide la conversión
- **Otros documentos del sistema** — verificación, auditoría, 100 días, innovación, marca, posicionamiento y programa de cuidado

Que la calidad no dependa de quién esté de turno; que un profesional nuevo sea productivo en semanas; que una inspección encuentre trazabilidad y no explicaciones; y que la Dirección pueda delegar sin perder control. En términos de Junta: la diferencia entre un negocio dependiente de personas y un negocio con activos transferibles.

Tres horizontes, tres criterios distintos

H1

0-12 MESES · EXPLOTAR · ~70 %

- Cirugía guiada como estándar
- Flujo digital completo en prótesis
- Recordatorio automatizado de revisiones
- Panel semanal de indicadores
- Programa de cuidado en el 100 % de los cierres

H2

12-36 MESES · CONSTRUIR · ~20 %

- Unidad de casos complejos
- Programa formal de derivación
- Registro propio de resultados a 3 y 5 años
- Segunda unidad preparada
- Itinerario formativo por puesto

H3

36 MESES+ · EXPLORAR · ~10 %

- Docencia y publicación de casuística
- Diagnóstico asistido sobre serie propia
- Licencia del sistema a terceros
- Red de dos a cuatro unidades

El H1 se juzga por retorno, el H2 por hitos de aprendizaje y el H3 por mantener abierta la opción a coste bajo. Confundir los criterios mata el horizonte largo sin que nadie decida matarlo. **Decisión D9.**



De dónde sale el dinero y qué lo destruye

Cuánto vale cada primera visita según cómo la trabajemos, qué le pasa a la facturación si movemos las dos únicas palancas que la gobiernan, y por qué un paciente en seguimiento vale más del doble que un paciente atendido.

Los cinco números que aún no tenemos

- **Costes fijos mensuales** — día 15
- **Punto de equilibrio mensual** — día 15
- **Primeras visitas necesarias al día** — día 30
- **Producto pendiente heredado** — día 15
- **Meses de colchón de tesorería** — día 21

Sin estas cinco cifras, cualquier objetivo comercial es una opinión. Esta memoria no contiene ni un solo dato real de explotación: donde hace falta un orden de magnitud, se usa un supuesto de trabajo declarado.

Tres trayectorias a treinta y seis meses



Base: el centro sostiene lo heredado sin cambio de sistema. Objetivo: el sistema operativo en marcha con las palancas activas. Ambición: además, segunda unidad y líneas nuevas del H2. La distancia entre base y objetivo —del orden de 380 k€ anuales en el mes 36— es lo que está en

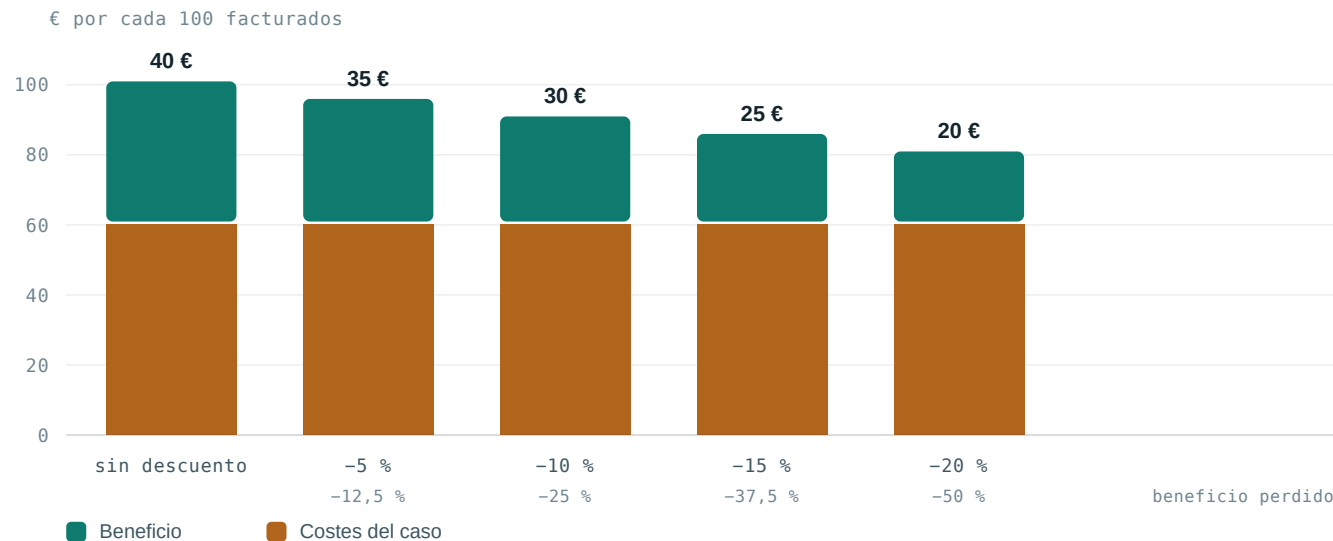
Dos variables gobiernan el resultado; el resto son consecuencias

		tasa de conversión de la primera visita			
		30 %	40 %	50 %	60 %
ticket medio	1.400 €	423 k€	564 k€	706 k€	847 k€
	1.800 €	544 k€	726 k€	907 k€	1.089 k€
	2.200 €	665 k€	887 k€	1.109 k€	1.331 k€

Capacidad fija: 4 primeras visitas al día · 21 días · 12 meses

Ecturación anual con capacidad fija de cuatro primeras visitas al día. Pasar del 30 % al 50 % de

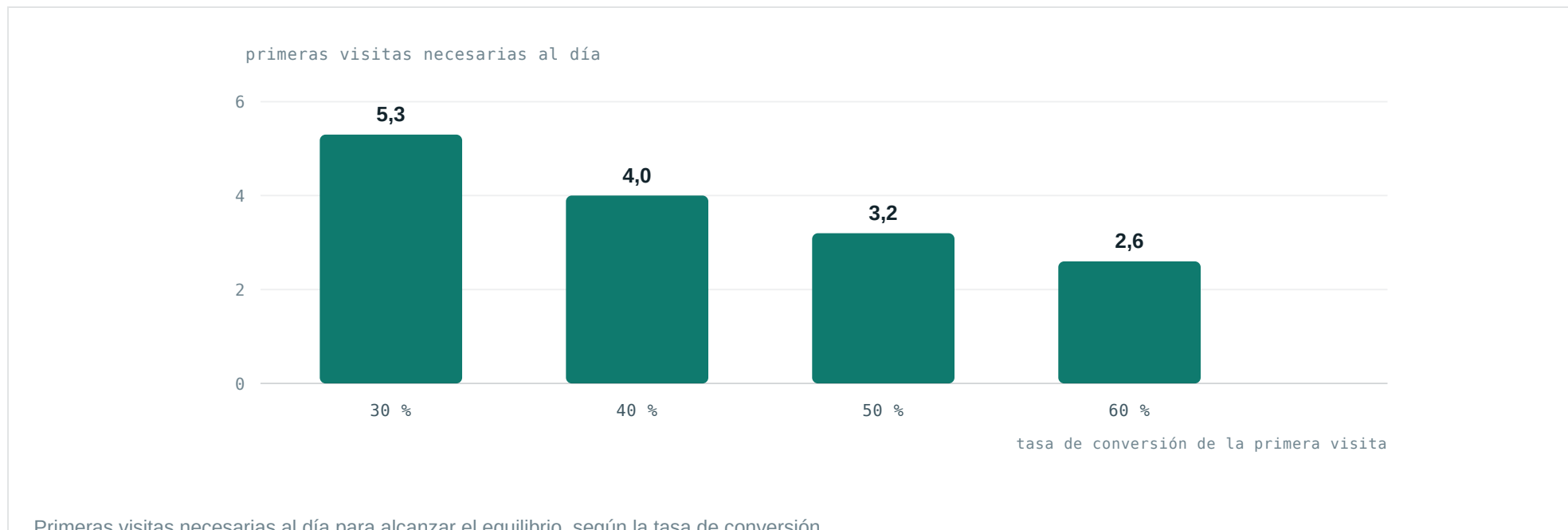
Lo que cuesta de verdad un descuento



Los costes del caso no bajan cuando baja el precio: el descuento sale íntegramente del beneficio.

Un 10 % de descuento cuesta el 25 % del beneficio del caso; compensarlo exige vender un 33 % más. Margen del 40 % como supuesto de trabajo.

Cada diez puntos de conversión valen una visita diaria

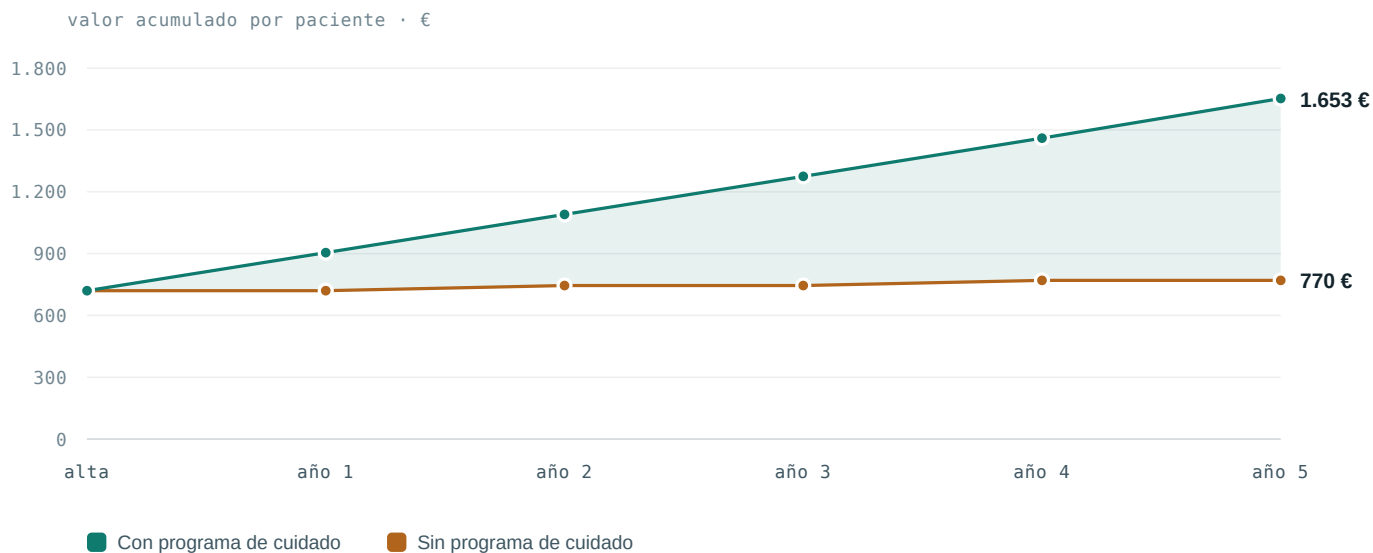


La relación vale del orden del doble



Valor estimado de un paciente a cinco años. El programa de cuidado no se justifica por su cuota, que es marginal, sino por lo que arrastra: revisiones que detectan a tiempo, tratamientos que se hacen cuando aún son sencillos y familiares que entran por la puerta.

Lo que hoy se deja sobre la mesa



Valor acumulado por paciente a cinco años, con y sin programa de seguimiento. El área sombreada no se pierde por competencia: se pierde por no volver a llamar. Es también la parte del ingreso que un comprador valora con múltiplo superior, porque es previsible.

Por qué esto vale más que la suma de sus sillones

- 1 **Beneficio** — lo que el centro gana este año. Es lo único que existe si no hay sistema.
- 2 **Beneficio sin dependencia del titular** — la parte que sobrevive a que el fundador se aparte. La produce el protocolo escrito, no el talento.
- 3 **Ingreso recurrente contratado** — cuotas y mantenimientos de la base en seguimiento. Se valora con múltiplo superior al ingreso por acto.
- 4 **Sistema replicable** — capacidad demostrada de abrir una segunda unidad con el mismo resultado. Convierte un centro en una plataforma.
- 5 **Serie clínica propia** — resultados documentados a cinco años. El único activo que no se acelera con dinero.

Cada decisión de hoy puede leerse dos veces: por su efecto en la cuenta de este año y por el nivel de esta escalera al que lleva al centro. La segunda lectura rara vez aparece en el consejo de una clínica.

De un centro a una red: el orden es innegociable

- 1 **Estándar escrito** **HECHO** — 12 fases, 322 puntos, manual por puesto
- 2 **Estándar verificado** **EN CURSO** — auditoría con resultado registrado, no autoevaluación
- 3 **Estándar sostenido sin el titular** **PENDIENTE** — un trimestre en umbral sin intervención de Dirección
- 4 **Formador formado** **PENDIENTE** — alguien distinto del fundador capaz de incorporar a un profesional al estándar
- 5 **Segunda unidad** — solo después de 3 y 4. Antes, no.

Los centros que fracasan al escalar casi nunca fallan por falta de demanda en la segunda plaza: replicaron una operación que nunca había funcionado sin su fundador delante. **Decisión D11.**

IV

Cómo fracasa esto, contado **antes** de que ocurra

Un registro de riesgos enumera lo que puede salir mal. Un pre-mortem se sitúa tres años en el futuro, da por hecho el fracaso y pide explicar la causa. Cambia la pregunta, y con ella el nivel de honestidad de las respuestas.

Cinco riesgos críticos, con dueño

#	RIESGO	MITIGACIÓN	PROPIETARIO
R1	Cobertura aseguradora insuficiente para tratamientos previos	Verificación documental antes de abrir	Gerencia
R2	Producto pendiente heredado sin cuantificar	Inventario en los tres primeros días	Dirección
R3	Pérdida de un profesional clave	Entrevistas tempranas y formación cruzada	Gerencia
R4	Incumplimiento regulatorio latente	Auditoría de las once verificaciones	Gerencia
R5	Deterioro de la percepción del paciente	Contacto proactivo y escalado único	Dirección

La única regla que detiene la clínica: sin verificación positiva de la cobertura aseguradora no se realiza actividad clínica. Es el riesgo cuyo coste no tiene techo.

Agosto de 2029: el proyecto ha fracasado. ¿Qué pasó?

CAUSA

- 1 · El sistema se convirtió en papel.** La verificación se espació, primero por una urgencia y luego por costumbre
- 2 · Se perdió al equipo en los primeros cien días.** Se gestionó como un cambio de procedimientos, no de vida laboral
- 3 · Se compró crecimiento con descuento.** Subieron los casos, bajó el margen y el precio de referencia quedó fijado a la baja
- 4 · El programa de cuidado nunca llegó a venderse.** Se ofrecía «cuando encajaba»
- 5 · Se abrió la segunda unidad demasiado pronto.** Se deterioraron las dos
- 6 · Nunca se supo si iba bien.** Se decidió sobre la sensación del último mes

SEÑAL TEMPRANA

- Una auditoría aplazada dos veces seguidas
- Una conversación de salida no mantenida a tiempo
- El primer descuento fuera de la tipología cerrada
- Tasa de ofrecimiento por debajo del 90 %
- «Esta oportunidad no se va a repetir» como criterio
- El primer comité en que se discute sin un número delante

Ninguna es un accidente externo: las seis son decisiones que tomamos nosotros o dejamos de tomar.

Cinco disparadores que obligan a convocar sin valorar la gravedad

- Dos auditorías aplazadas
- Una salida no prevista en un puesto clave
- Un descuento fuera de tipología autorizado
- Ofrecimiento del programa de cuidado bajo el 90 % dos meses seguidos
- Una apertura planteada sin los pasos 3 y 4 acreditados

Los seis modos de fallo son lentos y cómodos: nunca parecen suficientemente graves el día en que aún son baratos de corregir. Un disparador automático protege a la Junta de la propia Dirección en ese momento exacto.

Diez indicadores, ninguno con serie propia todavía

INTEGRIDAD DEL SISTEMA

4

Verificaciones cerradas · bajas voluntarias ·
reclamaciones heredadas · documentación
en el día

RESULTADO

4

Producto pendiente · conversión ·
mantenimiento activo · captación por
recomendación

EXIGIDOS POR D13 Y D14

2

Ofrecimiento del programa de cuidado ·
auditorías ejecutadas en fecha

CON DATO HOY

0 / 10

PRIMERA LECTURA ESTE TRIMESTRE

Diez casillas vacías no son una debilidad del documento: son el diagnóstico honesto de dónde estamos. La Junta debe exigir que en la revisión trimestral las diez tengan valor y tendencia.



Qué se pide hoy, y qué cuesta no pedirlo

Las palancas de valor, el orden en que se asigna el capital, la hoja de ruta a treinta y seis meses y las quince decisiones que solo puede tomar este órgano.

Por dónde se crece, y en qué orden

ORDEN	PALANCA	COSTE DE ACTIVACIÓN	HORIZONTE
1	Producto pendiente: caja ya cobrada que se convierte en producción	Solo gestión	Semanas
2	Conversión de la primera visita	Formación y disciplina	1-2 trimestres
3	Cartera propia dormida	Bajo	1 trimestre
4	Programa de cuidado y mantenimiento	Bajo, con encaje legal previo	2-4 trimestres
5	Captación externa	Medio-alto	3-6 trimestres

Sostener → **recuperar** → **fidelizar** → **captar**. Invertir en captación con la cartera propia desatendida es la asignación de recursos menos eficiente posible.

Un orden de prelación, no una lista de deseos

- 1 **Continuidad** — nóminas, obligaciones, mantenimiento y colchón de tesorería. No se discute.
- 2 **El foso** — formación, verificación, documentación y programa de seguimiento. Compra años de ventaja y es lo primero que se recorta en cualquier centro con prisa.
- 3 **Conversión** — todo lo que mejora la primera visita. Retorno más alto y más rápido que cualquier captación.
- 4 **Captación** — solo cuando la conversión ya está en umbral: captar más para convertir igual es pagar por desperdicio.
- 5 **Capacidad** — sillones, equipos, segunda unidad. Se financia con lo producido, no con deuda contra una previsión.

Excepción legítima, una sola: cuando una prioridad inferior es condición técnica de una superior. Se documenta y se presenta en la Junta siguiente. **Decisión D10.**

Tres horizontes, tres puertas

HORIZONTE 1 · 100 DÍAS

Estabilizar

Riesgo neutralizado, equipo retenido,
continuidad asegurada, línea base
establecida

HORIZONTE 2 · 12 MESES

Consolidar

Protocolo implantado, producto pendiente
residual, marca reposicionada, indicadores
con serie propia

HORIZONTE 3 · 36 MESES

Liderar

Referencia en implantología compleja,
captación mayoritariamente por
recomendación

El programa no avanza por calendario, sino por criterios de salida
verificados en los días 30, 60 y 100. Ninguna fase se adelanta.

Las ocho de la operación

CÓD.	MATERIA	PLAZO
D1	Política de precios y tabla de descuentos	INMEDIATO
D2	Garantías publicadas por tipo de tratamiento	INMEDIATO
D5	Programa de cuidado: precio, catálogo y validación jurídica	INMEDIATO
D8	Responsables funcionales y Comité de Transición	INMEDIATO
D3	Arquitectura de marca y verificación legal del naming	TRIMESTRE
D4	Presupuesto anual de captación y modelo de ejecución	TRIMESTRE
D6	Línea de sedación consciente	TRIMESTRE
D7	Marco de inversión en flujo digital	2.º TRIMESTRE

Las siete de la estrategia

CÓD.	MATERIA	ALTERNATIVA DESCARTADA	PLAZO
D9	Regla de cartera de innovación 70/20/10	Decidir caso a caso: todo acaba en H1	HOY
D10	Orden de prelación del capital	Presupuesto por partidas sin orden	HOY
D11	Condición de apertura de segunda unidad	Decidir por oportunidad de mercado	HOY
D12	Suelo anual de inversión en el foso	Tratarlo como gasto variable ajustable	HOY
D13	Disparadores de Junta extraordinaria	Convocar cuando Dirección lo considere	HOY
D14	Programa de cuidado obligatorio en el cierre	Dejarlo a criterio comercial	TRAS D5
D15	Objetivo de facturación y horizonte: 1,2 M€ en el ejercicio tercero	Exigirlo en el primero: con 4 visitas al día no da la aritmética	HOY

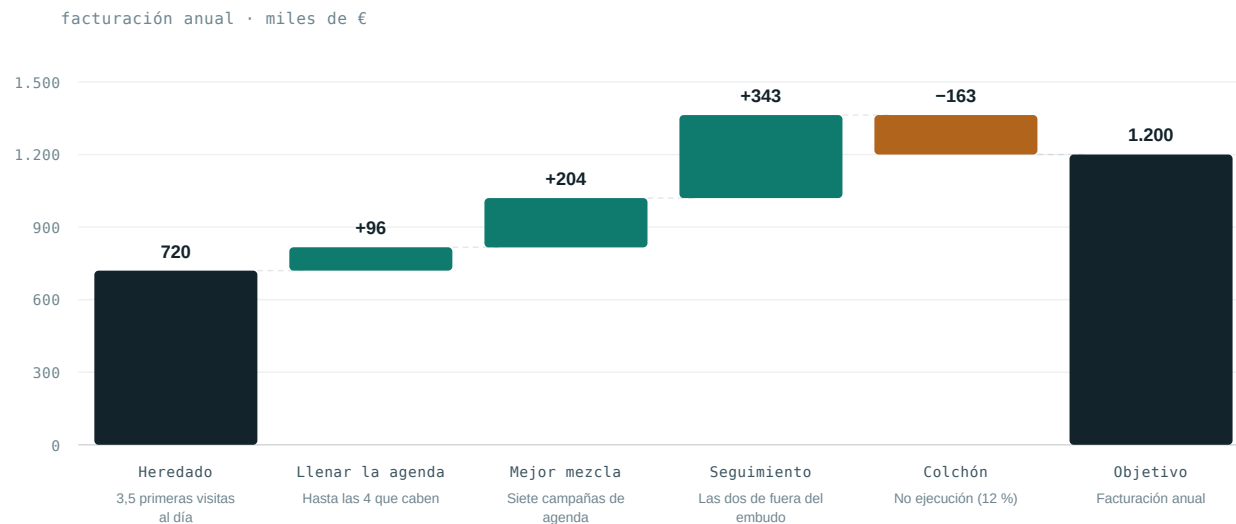
Las ocho anteriores resuelven la operación. Estas siete fijan las reglas con las que la Junta decidirá lo que todavía no está sobre la mesa. Es la diferencia entre gobernar y reaccionar.

VI

Cómo se llega a 1,2 M€

El objetivo, descompuesto hasta el último euro: de dónde sale cada bloque, si cabe en la agenda que tenemos y qué nueve campañas lo sostienen.

De 720 k€ a 1,2 M€, bloque a bloque



Se planifican 1.440 k€ para comprometer 1.200. Un plan que suma exactamente el objetivo es un plan que lo falla: de nueve campañas, dos no arrancarán a tiempo y una rendirá la mitad. El colchón no es holgura, es lo que hace creíble la cifra.

¿Cabe 1,2 M€ en la agenda que tenemos?

CAPACIDAD INSTALADA

1.008

Primeras visitas al año: 4 al día × 21 días × 12 meses

VALOR DE UNA VISITA HOY

810 €

45 % × 1.800 €. Es la vara con la que se mide toda campaña

AGENDA QUE PIDEN LAS NUEVE

608

De las 1.008 que hay. La cartera cabe, y el modelo lo comprueba

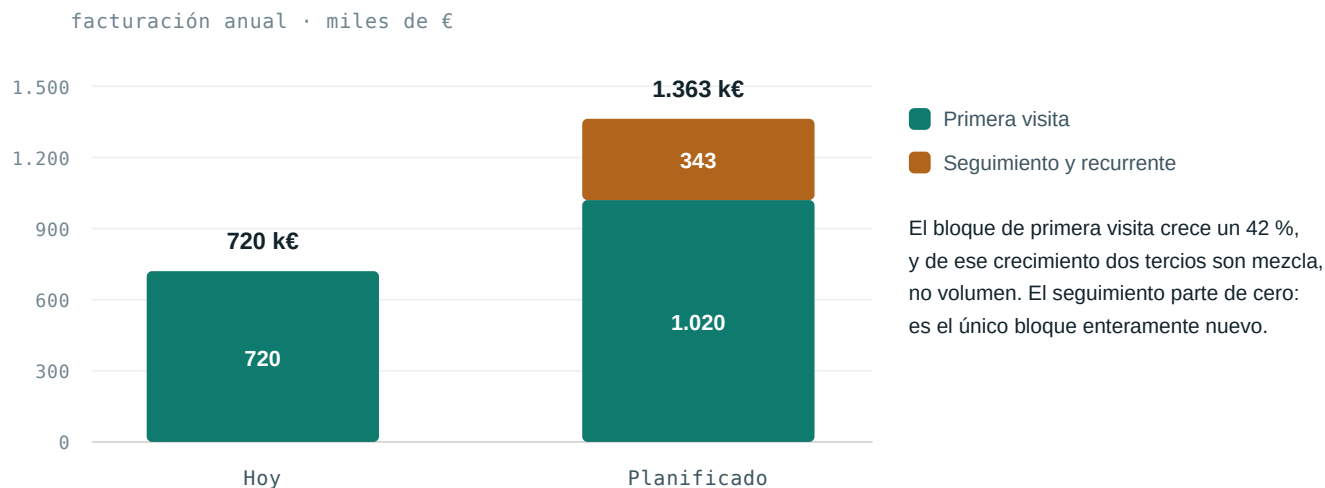
SI FUERA SOLO CAPTACIÓN

5,9/día

Las visitas diarias que harían falta al ticket de hoy. La agenda da cuatro

La agenda no admite más volumen. El objetivo no se alcanza captando más pacientes: se alcanza sacando un 10 % más de los que ya vienen y construyendo 300 k€ de ingreso que hoy no existe.

Dos tercios del salto no son implantes



El bloque de primera visita crece un 42 %. El de seguimiento parte de cero: son 343 k€ que no existen hoy y que no dependen de ver a un solo paciente nuevo.

Nueve campañas, ordenadas por lo que aportan

CÓD.	CAMPAÑA	VISITAS	APORTA	RETORNO
C6	«La revisión que evita la cirugía»	—	172 k€	34.4×
C1	Alma Te Cuida	—	171 k€	28.5×
C2	«Su caso no es imposible»	80	71 k€	5.1×
C4	Red de derivación	70	44 k€	4.0×
C8	Prescripción de pacientes	120	35 k€	34.8×
C5	«Sin miedo»	55	25 k€	2.8×
C7	«Segunda opinión, sin compromiso»	70	20 k€	4.9×
C3	«Volvemos a llamarle»	130	13 k€	4.4×
C9	Presencia digital y reseñas	83	-4 k€	negativo

Las dos que más aportan son las dos más baratas, y ninguna capta **pacientes**: trabajan sobre los que ya son del centro. La única con gasto externo relevante es la única con retorno negativo, y aun así se

aprueba: sin presencia digital, cuatro de las otras no encuentran a nadie.

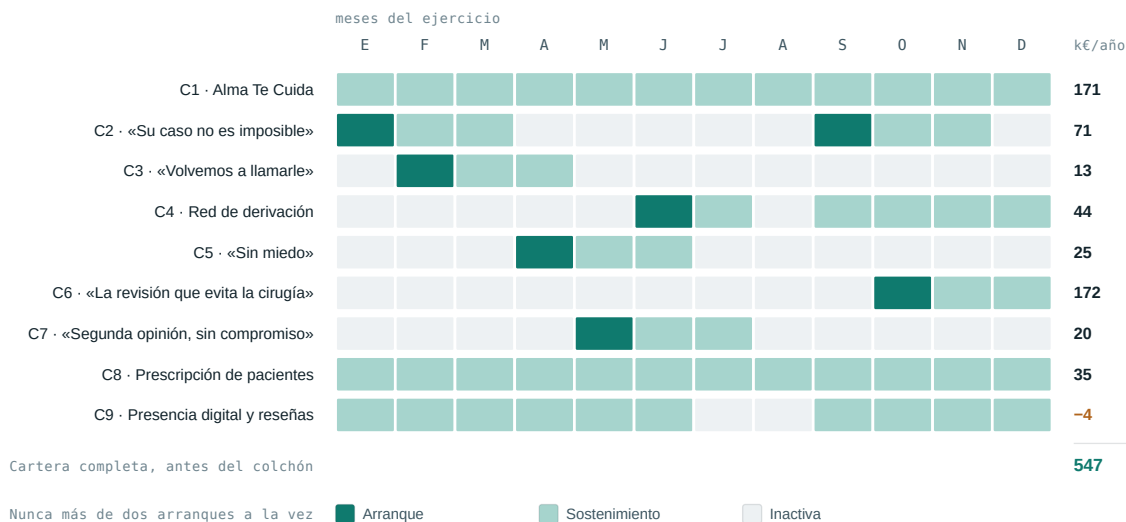
21 · LO QUE DEVUELVE EL MODELO

D14 no es un detalle del programa de cuidado. Es el 63 % del objetivo.

- el 63 % de todo lo que aportan las nueve campañas
- Las dos dependen del mismo gesto repetido:
- El colchón del 12 % no cubre que falle ninguna de las dos: si cae una, cae el objetivo

Un plan concentrado no es un plan malo, pero hay que saber dónde está concentrado. Aquí no está en la campaña más cara: está en la más barata y en la más fácil de dejar de hacer un martes con prisa.

Cuándo se enciende cada una



En oscuro el arranque, en claro el sostenimiento. Nunca más de dos arranques a la vez: el equipo no sostiene más, y una campaña mal atendida hace más daño que ninguna. Enero y septiembre son los meses en que la gente decide; en julio y agosto no se enciende nada caro.

1,2 M€ es un objetivo de **año tres**

- C1, C3, C8 y C9. Protocolo completo y línea base levantada
- entran C2, C6 y C7. El ticket sube por composición de casos
- cartera completa con C4 y C5, sin abrir una segunda unidad

Comprimirlo a dieciocho meses no se consigue acelerando campañas —maduran a su ritmo— sino ampliando capacidad, y eso anticipa la prioridad 5 del apartado 15. Es legítimo, tiene precio, y debe constar en el acta. Es la decisión **D15**.

Qué tiene que ser cierto

CONDICIÓN	QUÉ SE CAE SI FALLA	CÓMO SE COMPRUEBA
1 · Que el protocolo se ejecute completo	Con 35 % de conversión en vez de 45 %, el bloque de primera visita cae de 900 a 700 k€	Indicador 6, cohorte a 60 días
2 · Que exista cartera propia que reactivar	Si es la mitad de lo supuesto, se van 116 k€ de los 232	Inventario, dos primeras semanas
3 · Que las decisiones se resuelvan a tiempo	274 k€ esperan a D1, D3, D4, D5, D6 y D14	Acta de esta sesión
4 · Que el ticket suba por complejidad, no por precio	Si sube por tarifa, la conversión cae y el efecto neto es negativo	Ticket y conversión, leídos juntos
5 · Que el equipo aguante	La más silenciosa: no falla la demanda, falla quien tiene que atenderla	Indicador 2 y la regla de dos arranques

Ninguna de las cinco es una campaña. Son condiciones: si alguna no se cumple, el objetivo no baja un poco, se cae el bloque entero que dependía de ella.

CIERRE

Qué mide el éxito de este año

- **Que el equipo permanezca.** El conocimiento operativo reside en las personas y su reposición exige plazos que ningún plan comprime
- **Que los pacientes heredados no perciban discontinuidad.** Son la base de ingresos inmediata y el primer canal de prescripción
- **Que la organización acepte un estándar superior al preexistente.** La ventana para establecerlo se cierra en el primer trimestre

Lo que se pide hoy no es respaldo genérico: es resolver las quince decisiones y fijar la fecha de la próxima revisión.

Plan maestro · Uso interno · Confidencial · Junta Directiva

No se capta a un paciente. Se le merece.

Plan Maestro de Marketing

Centro de Excelencia Implantológica Alma · Calle Progreso 2 · Ourense
v32.0 · Septiembre 2026 · Documento de dirección
Setenta y seis acciones sobre doce estados del paciente

00 Ficha de control

Qué es	El catálogo completo de lo que este centro puede hacer para que un paciente lo elija, lo entienda y se quede. No es un plan de campañas: las campañas son un subconjunto suyo
Qué no es	Un plan de captación. La captación es uno de los siete grupos, y no el que más aporta
De dónde sale	Del posicionamiento «no medias sonrisas», del recorrido de 14 fases del Manual Maestro y de la aritmética de la Parte VI del Plan de Dirección
Qué decide	Nada por sí solo. Propone; la Junta aprueba en el registro de acuerdos del Plan de Dirección
Propietario	Dirección General, con Gerencia como responsable de ejecución y presupuesto
Revisión	Trimestral, con la misma cadencia que el cuadro de mando del apartado 13 del Plan de Dirección
Versión	v32.0 · Septiembre 2026

Marcas de naturaleza

Se usan las mismas que en el Plan de Dirección, y por el mismo motivo: ■ HECHO es algo verificado; ■ MODELO es un cálculo sobre supuestos declarados; ■ PENDIENTE es algo que hay que cerrar antes de comprometerlo. **Ninguna cifra de este plan es un dato de explotación del centro**, porque el centro todavía no tiene serie propia: los cinco números del apartado 7 del Plan de Dirección siguen abiertos.

Parte



La doctrina

Qué creemos, y qué nos prohibimos en consecuencia

Casi todo lo que este sector hace para captar pacientes funciona porque el paciente no sabe algo. Esta parte fija qué creemos sobre cómo se elige de verdad un dentista, cuál es la única regla de admisión del catálogo, las ocho cosas que no haremos nunca y el marco legal que gobierna a las setenta y seis.

01

Por qué este plan no se parece a un plan de marketing

Un plan de marketing dental normal se organiza por canales y se mide por captación. Este se organiza por **el estado de la relación de una persona con su propia boca**, y se mide por si esa persona obtuvo lo que necesitaba —incluso cuando lo que necesitaba de nosotros era nada.

La diferencia no es retórica y tiene consecuencias caras. Un plan por canales pregunta «¿cuánto invertimos en búsqueda de pago?». Un plan por estados pregunta «¿qué le pasa por la cabeza a alguien que lleva doce años sin sentarse en un sillón, y qué es lo primero que necesita que no sea una oferta?». Las dos preguntas se responden con dinero, pero no con el mismo dinero, y no producen el mismo centro al cabo de tres años.

La única ventaja competitiva que no se compra es la reputación de decir que no cuando toca decir que no.

La aritmética de la Parte VI del Plan de Dirección ya había señalado algo incómodo antes de que existiera este plan: las dos campañas más rentables de la cartera —34× y 28× de retorno— **no captan a nadie**. Trabajan sobre pacientes que ya son del centro. Entre las dos suman el 63 % de lo que aporta la cartera entera. Y la única campaña con gasto externo relevante es la única con retorno directo negativo.

Ese resultado no se buscó: salió del modelo. Y obliga a una conclusión que ordena todo lo que viene después: **en un centro con la agenda casi llena, el marketing que más produce no es el que trae gente nueva, sino el que impide que se vaya la que ya está**. Este plan está construido sobre esa frase.

Las tres consecuencias de organizarlo así

1. **La primera visita es un soporte publicitario, y es el único que ya está pagado.** Doce de las setenta y seis acciones ocurren dentro de la clínica, con el paciente delante, y no cuestan un euro adicional.
2. **El paciente que se apaga no se ha ido.** Sigue siendo nuestro hasta que decide lo contrario, y recuperarlo cuesta una fracción de lo que cuesta encontrar a otro igual.
3. **Lo que hacemos con quien no va a comprar nada define lo que somos.** La segunda opinión que termina en «no necesita tratamiento» es el activo de marca más barato que este centro puede fabricar.

02

La regla de la ficha

La única regla de admisión de este plan

Una acción entra en el catálogo si —y solo si— puede decir en una línea qué gana el paciente. No qué ganamos nosotros: qué gana él, aunque no compre nada. Si esa línea no se puede escribir, la acción no existe.

Parece una declaración de intenciones y no lo es: es un filtro ejecutable. En el archivo `catalogo-acciones.py` cada acción lleva un campo `gana`, y el generador se niega a producir este documento si alguno está vacío o es demasiado corto para decir algo. Una regla que no puede comprobarse en una lista es una intención, y este sistema documental lleva desde su primera versión sosteniendo lo contrario.

El efecto práctico es que la regla expulsa por sí sola a casi todo el repertorio habitual del sector. «Sorteo de una limpieza» no pasa el filtro: lo que gana el paciente es una lotería. «Primera visita gratis» tampoco, porque el paciente no gana una visita —la visita siempre fue gratis en la práctica—: gana la falsa impresión de que le regalan algo. «Financiación al 0 %» solo pasa si el coste total es visible y nadie cobra comisión por colocarla. La regla no obliga a ser generosos: obliga a ser exactos.

PASA EL FILTRO	NO LO PASA	
«Se lleva un informe escrito, diga lo que diga»	«Segunda opinión gratuita» a secas: no dice qué se lleva	
«Sabe el orden de magnitud antes de sentarse»	«Presupuesto sin compromiso»: el compromiso nunca existió	
«Le llama quien le operó, no un número desconocido»	«Seguimiento postoperatorio»: describe nuestra tarea, no su beneficio	
«Puede parar la intervención con una señal, y se respeta»	«Trato cercano y humano»: no es comprobable	

03

Las ocho que no haremos nunca

Un plan que solo enumera lo que va a hacer no compromete a nada. Estas ocho fijan el borde, y son las que hay que sostener el día que un trimestre venga flojo.

-
- 01 **Ningún antes-y-después que no sea del mismo caso, con la misma luz y el mismo encuadre, y con consentimiento expreso y revocable.** Una foto favorecida es una promesa de resultado, y una promesa de resultado en sanidad no es publicidad agresiva: es publicidad prohibida.

 - 02 **Ninguna urgencia inventada.** Ni descuento que caduca hoy, ni «solo quedan dos huecos», ni precio de campaña que en realidad es el precio. Si esperar tiene un coste, será un coste clínico y estará explicado.

 - 03 **Nada se cierra en la silla el día del miedo.** Quien llega asustado no está en condiciones de firmar, y aprovecharlo es exactamente el motivo por el que la gente desconfía de este sector.

 - 04 **Ninguna reseña incentivada, comprada, filtrada ni redactada por nosotros.** Se piden todas, se publican todas y se contestan todas, empezando por las malas.

 - 05 **Ninguna comisión por colocar financiación.** Quien la ofrece no puede ganar nada porque el paciente la acepte.

 - 06 **Ningún «gratis» que no sea gratis.** Si algo está incluido en el precio de otra cosa, se dice que está incluido.

 - 07 **Ningún diagnóstico por fotografía, por teléfono ni por mensajería.** Se puede orientar; no se puede diagnosticar. La diferencia se le explica al paciente cada vez.

 - 08 **Ningún tratamiento que no haga falta.** Es la primera y la última: todas las demás son casos particulares de esta.

No son un código ético colgado en la pared: son el activo. Un centro que las cumple durante cinco años tiene algo que un competidor con más presupuesto no puede comprar en menos de cinco años.

04

El marco de la publicidad sanitaria

La publicidad de un centro sanitario no se rige por las reglas de la publicidad comercial, y esa es una **buena noticia para nosotros**: el marco prohíbe exactamente lo que hace la competencia agresiva —prometer resultado, exhibir testimonios que sugieran eficacia, cerrar por precio— y no prohíbe nada de lo que este plan propone hacer. Conviene saberlo con precisión de todas formas. La sanción no es lo peor: lo peor es retirar una campaña a mitad de ejercicio con el presupuesto ya gastado.

La ventaja de conocer el borde
Un centro que sabe exactamente dónde está la línea trabaja pegado a ella con tranquilidad. El que no lo sabe se queda a diez metros por miedo, y desde ahí no se comunica nada. **Este marco no es un freno: es el mapa que permite ser agresivo sin ser temerario.**

QUÉ REGULA	NORMA DE REFERENCIA	QUÉ IMPLICA PARA ESTE PLAN
Publicidad en general	Ley 34/1988, General de Publicidad	Prohíbe la publicidad engañosa y desleal. Aquí muerde sobre todo en los precios: un precio anunciado que no es el precio final es engañoso aunque lleve asterisco
Publicidad sanitaria	Ley 14/1986, General de Sanidad, y RD 1907/1996	No se puede prometer curación ni resultado, ni sugerirlo con testimonios. Es la norma que gobierna los antes-y-después y los vídeos de pacientes
Información y consentimiento	Ley 41/2002, de autonomía del paciente	El presupuesto y el plan de tratamiento son información clínica, no material comercial. De ahí la entrega por escrito el mismo día
Datos e imagen	RGPD y LO 3/2018	La imagen clínica es dato de salud. Consentimiento expreso, específico, informado y revocable para cada uso, y el uso publicitario es un uso distinto del clínico
Profesión y deontología	Ley 44/2003 y código deontológico del Consejo General de Dentistas	Identificación del profesional responsable, prohibición de inducir a tratamientos innecesarios y límites a la publicidad basada en precio
Registro autonómico	Régimen gallego de autorización de centros sanitarios	El número de registro del centro consta en todo soporte publicado. Es una línea de texto en el pie: se pone una vez y se olvida

Cómo se traduce a semáforo
■ VERDE · no toca el régimen de publicidad sanitaria. Se ejecuta y punto: **36 de las 76 acciones** están aquí, y entre ellas están las que más aportan. ■ AMARILLO · el texto se revisa antes de publicar, porque una frase de más lo convierte en promesa de resultado. Revisión de veinte minutos, no de veinte días. ■ NARANJA · exige consentimiento expreso del paciente, criterio jurídico, o ambos. Once acciones.
El reparto completo está en el Anexo A, y la regla de gobierno cabe en una línea: **una acción naranja se activa cuando conste por escrito quién la revisó y cuándo**. No antes, y no más tarde de lo que tarde esa firma.

Parte



El paciente

Doce estados, seis personas y siete minutos que lo deciden todo

Dónde está, qué le pasa y en qué momentos se decide todo. Nada de esto es un segmento de mercado: son personas de esta ría.

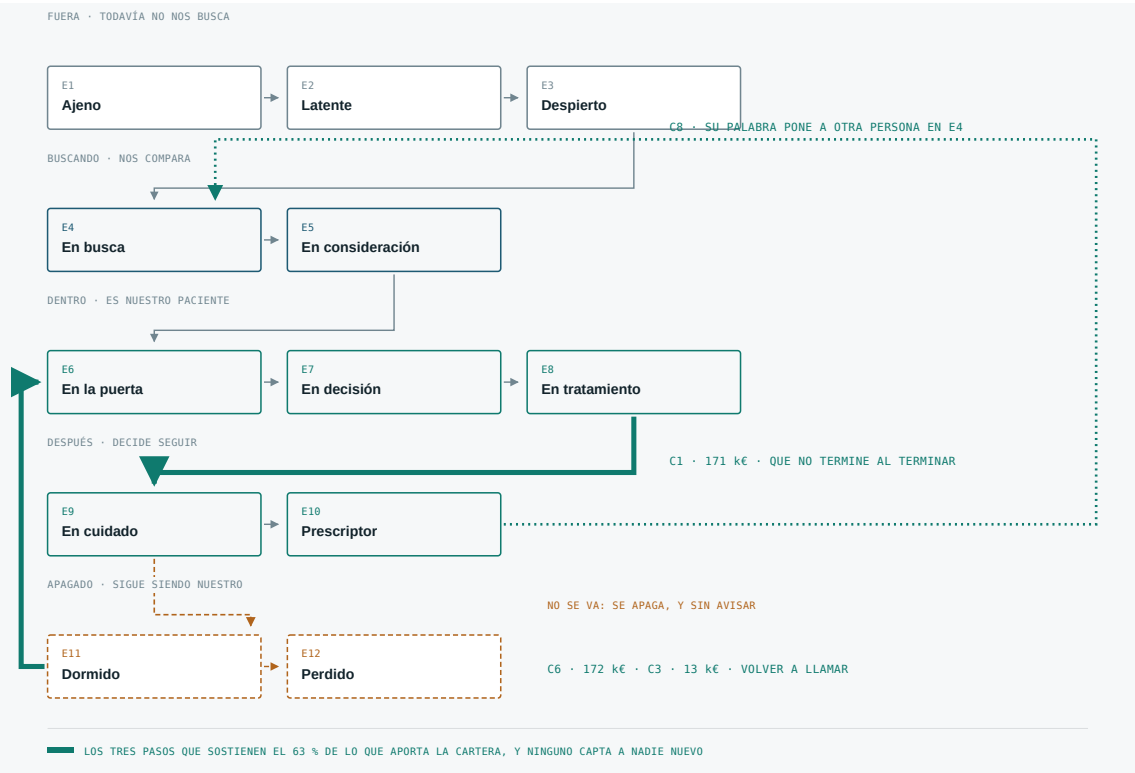
05

Los doce estados

Un embudo va en un sentido y termina en la venta. Una persona va y viene, se apaga, vuelve, recomienda y a veces se pierde. Sustituir el embudo por **doce estados** con tránsitos en los dos sentidos no es un capricho de diseño: cambia qué acciones parecen importantes.

Figura 1 · El mapa de los doce estados

Los trazos gruesos son los tres pasos que el modelo de la Parte VI señala como los que sostienen el 63 % de lo que aporta la cartera. Ninguno de los tres consiste en captar a nadie nuevo. Naturaleza: **modelo**, con las cifras traídas de modelo - campanas . py.



Lo que el mapa hace evidente es dónde no está el dinero: el tramo de E1 a E5 –todo lo que un plan convencional llamaría «captación»– aporta este ejercicio menos que el tramo de E8 a E11, que no aparece en ningún plan de marketing dental al uso.

ESTADO	CÓMO SE LLAMA	QUÉ LE ESTÁ PASANDO
E1	Ajeno	No sabe que existimos y no tiene un problema con nombre.
E2	Latente	Algo le pasa en la boca y todavía no lo ha llamado por su nombre.
E3	Despierto	Ya lo ha nombrado. Aún no busca: lo aplaza.
E4	En busca	Busca activamente, casi siempre solo y casi siempre mal informado.
E5	En consideración	Nos tiene en una lista corta y compara.
E6	En la puerta	Ha pedido cita. Es nuestro durante una hora.

ESTADO	CÓMO SE LLAMA	QUÉ LE ESTÁ PASANDO
E7	En decisión	Tiene un presupuesto encima de la mesa y una conversación pendiente en casa.
E8	En tratamiento	Ha dicho que sí y ahora tiene miedo de haber acertado.
E9	En cuidado	Ha terminado y sigue con nosotros por decisión propia.
E10	Prescriptor	Habla de nosotros sin que se lo pidamos.
E11	Dormido	Fue paciente y se apagó. No se fue: dejó de venir.
E12	Perdido	Se fue, con motivo o sin él, y lo sabemos o deberíamos saberlo.

Los tres tránsitos que importan

- **E8 → E9 · que no termine al terminar.** El paciente acaba el tratamiento y decide seguir con nosotros. Es la campaña C1 de la cartera: 171 k€, con un retorno de 28×, y ocurre en los últimos cinco minutos de la última cita.
- **E11 → E6 · volver a llamar.** El paciente dormido vuelve. Son las campañas C6 y C3: 185 k€ entre las dos. No requiere que nadie nos descubra: requiere que alguien coja el teléfono.
- **E10 → E4 de otra persona · su palabra.** El prescriptor no vuelve a buscarnos: pone a otro en el estado E4. Es C8, con retorno de 35×, el más alto de toda la cartera.

06

Los seis de la provincia

No son segmentos demográficos ni perfiles de manual. Son seis situaciones vitales reconocibles en Ourense y su provincia, cada una con una barrera distinta y una puerta distinta. Quien trabaja en recepción los reconoce a los treinta segundos de teléfono.

Arquetipo 1

El que lleva años sin ir

Qué le pasa. Diez, quince, veinte años sin sentarse en un sillón. No es dejadez: es una mezcla de miedo, vergüenza por el estado en que sabe que tiene la boca, y la certeza de que le van a reñir.

Qué le frena. No el precio. El primer minuto.

La puerta. Una visita en la que *por norma* no se le propone tratamiento: **A27**, la Consulta del Miedo. Y la garantía de que nadie va a comentar cuánto tiempo ha pasado.

Es el grupo más grande y el peor atendido del mercado.

Arquetipo 2

El que se lo quitó todo

Qué le pasa. Lleva una prótesis que se mueve, o ninguna. Ha dejado de comer en público, de reírse en las fotos y a veces de hablar de cerca. Le han dicho en dos sitios que su caso no tiene solución.

Qué le frena. Creer que ya se lo han dicho todo.

La puerta. «Su caso no es imposible» —la campaña C2— y casos reales contados por el clínico que los trató, **A30**, sin promesa de resultado.

Es el paciente de mayor ticket y el de mayor cambio de vida.

Arquetipo 3

El que vuelve

Qué le pasa. Vive fuera y vuelve dos o tres semanas en agosto y en Navidad. Su calendario no lo decide él: lo decide el billete de vuelta, el convenio de su empresa o el curso escolar de sus hijos. Aquí tiene la casa, la familia y muchas veces a la persona mayor a la que cuida desde la distancia.

Qué le frena. No tener tres semanas seguidas aquí, y no querer empezar algo que tenga que terminar a mil kilómetros.

La puerta. Tratamiento planificado dentro de su estancia real, a dos veranos si hace falta:

A69 a A72, la Campaña del Retorno del apartado 13.

Es el arquetipo que nadie de este sector atiende en una provincia que vive con media familia fuera.

Arquetipo 4**El que acompaña**

Qué le pasa. No es el paciente. Es la hija que trae al padre, el cónyuge que empuja la silla, el cuidador de una persona dependiente. Escucha todo y decide la mitad.

Qué le frena. Que nadie le hable a él, y salir sin entender lo que se ha dicho.

La puerta. Silla, nombre y copia del plan también para él: **A37**. Cuesta cero euros.

Es el mayor prescriptor no reconocido que tiene una clínica dental.

Arquetipo 5**El que ya se lo hizo fuera**

Qué le pasa. Se trató a bajo coste, aquí o a mil kilómetros, y algo ha fallado. Vuelve avergonzado y a la defensiva, esperando un sermón.

Qué le frena. Temer que le cobremos el error de otro con intereses.

La puerta. Segunda opinión con informe escrito que se lleva, diga lo que diga: **A25**. Y la comparativa honesta de **A32**, con el coste total de revisión y garantía incluido.

Nunca se critica al colega. Se describe lo que hay.

Arquetipo 6**El que no tiene hueco**

Qué le pasa. Sabe lo que necesita y tiene con qué pagarlo. Lo que no tiene es una mañana libre. Lleva dos años posponiendo una cita que dura cuarenta minutos.

Qué le frena. El horario, y tener que llamar en horario de oficina para pedir cita.

La puerta. Cita en línea con hueco real a las once de la noche —**A19**—, y el acuerdo con su empresa: **A75**.

Es el paciente que se pierde por logística, no por convicción.

07

Los siete momentos de verdad

Hay siete instantes en los que una relación se gana o se pierde entera. Ninguno dura más de tres minutos y ninguno cuesta dinero. Cinco ocurren dentro de la clínica y dos, al teléfono.

MOMENTO	LO QUE EL PACIENTE ESTÁ MIDIENDO	LO QUE LO RESUELVE
1 · La primera búsqueda	Si somos reales o somos un anuncio	Ficha completa con fotos propias y horarios verdaderos · A13
2 · La primera llamada	Cuánto tardamos y si contesta una persona	Teléfono con persona y recuperación de perdidas en dos horas · A21, A22
3 · Los primeros noventa segundos	Si es un turno o le esperaban	Acogida por su nombre, sin mostrador de por medio · A36
4 · Cuando se dice el precio	Si le están vendiendo o informando	Explicación de qué se paga y presupuesto sin prisa · A29, A28
5 · Cuando se le dice que no hace falta	Todo. Este momento vale más que los otros seis juntos	Que ocurra de verdad, se documente y se cuente · A25, A26
6 · El día después de la cirugía	Si le importamos cuando ya hemos cobrado	Llamada del clínico que operó, a las 24 horas · A47
7 · El día que algo va mal	Si hay alguien con nombre al otro lado	Vía directa con nombre, número y plazo · A48

El quinto momento es el único que un competidor no puede copiar comprándolo. Los otros seis se compran con organización; ese se compra renunciando a facturar.

Merece la pena detenerse en él. Cuando un paciente llega con un presupuesto de otra clínica y le decimos que la mitad de lo que le han propuesto no hace falta, perdemos ese ingreso. Lo que ganamos es una persona que va a contar esa conversación durante años, y un dato que se puede publicar: **el índice anual de segundas opiniones que terminan en «no necesita tratamiento»**, la acción **A26**. Es la única métrica de este plan que nuestros competidores no van a querer publicar, y por eso es la que hay que publicar.

08

Lo que él no sabe y nosotros sí

Toda la desconfianza del sector nace de una asimetría real: el paciente no puede evaluar lo que le proponemos. No sabe si necesita ese implante, si ese precio es alto, ni si el fallo de dentro de seis años será culpa del material, de la técnica o suya. Un plan de marketing honesto es, básicamente, una lista de maneras de reducir esa asimetría.

LA ASIMETRÍA	CÓMO LA EXPLOTA EL SECTOR	CÓMO LA REDUCIMOS
No sabe si lo necesita	Se le trata de más	Segunda opinión con informe e índice publicado · A25, A26
No sabe cuánto cuesta hasta que está sentado	Se le da el precio en el peor momento	Precio de partida publicado por tratamiento · A15
No sabe qué está pagando	Se le da un total y un descuento	Desglose de material, tiempo, laboratorio, garantía y revisión · A29
No sabe qué pasa si falla	Se le promete de palabra	Tabla de garantías publicada y entregada con cada presupuesto · A34
No sabe qué pasa si espera	Se le mete prisa con un descuento	Consecuencia clínica de esperar 6, 12 y 24 meses, escrita · A28
No es dueño de su propia historia	Se le retiene por la vía del archivo	El Archivo de tu Boca: se lo lleva aunque se marche · A50

La apuesta que hay detrás de todo el plan

Reducir la asimetría reduce el margen a corto plazo: un paciente que entiende el precio negocia mejor, y uno al que le decimos que no necesita tratamiento no factura. **La apuesta es que a treinta y seis meses el efecto se invierte**, porque la conversión sube cuando nadie se siente vendido, la tasa de abandono cae y la prescripción —la campaña con más retorno de la cartera, 35×— solo la produce alguien que se fue sintiendo bien tratado.

Es una apuesta, no un hecho, y está declarada como tal. Si a los cuatro trimestres la conversión no ha mejorado y la prescripción no ha crecido, esta doctrina estaba equivocada y hay que decirlo en Junta. El apartado 19 fija cómo se comprueba.

Parte



El catálogo

Todo lo que se puede hacer, contado una vez y con dueño

El inventario completo de lo posible, del que después se elige: setenta y seis acciones repartidas en siete grupos, cada una con código estable, dueño, banda de coste, plazo, el número que mueve y su semáforo legal. Ninguna entra sin decir en una línea qué gana el paciente.

09

Las setenta y seis acciones

Este es el inventario completo. No es una selección ni una recomendación: es el mapa de lo posible, del que después se elige. Cada acción lleva código estable —se cita en acta y en calendario—, dueño, banda de coste, plazo, el número que mueve y su semáforo legal.

Acciones catalogadas 76 En 7 grupos, uno por tramo del mapa de estados.	Sin coste directo 32 El 42 % del catálogo no cuesta dinero: cuesta atención y disciplina.
Ejecutables ya 32 No dependen de presupuesto, de obra ni de contratar a nadie.	Techo de gasto anual 201.000 € Si se activara el catálogo entero, que no es lo que se propone.

Cómo se lee la tabla

Coste · 0 sin coste directo · € hasta 1 k€ · €€ de 1 a 5 k€ · €€€ de 5 a 15 k€ · €€€€ más de 15 k€ al año.

Plazo · cuánto tarda en estar en marcha, no en dar resultado.

Efecto · de 1 a 5, efecto esperado sobre el objetivo de este ejercicio. Es un juicio de Dirección, no un cálculo. ■ **MODELO**

Campaña · a qué campaña de la cartera de la Parte VI pertenece la acción, si pertenece a alguna. 46 de las 76 no están en ninguna: son el fondo del que salen las campañas de los ejercicios siguientes.

G1 · Presencia y educación ■ 12 ACCIONES

E1 · E2 · E3 — Actuar sobre quien todavía no nos busca. Es la parte del plan que no produce facturación este ejercicio y sin la cual no hay ninguno de los siguientes.

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A01	Aula da Boca: charla mensual en asociaciones vecinales, centros culturales y clubes de la ciudad Entiende lo que le pasa en la boca sin que nadie le venda nada esa tarde	Dirección de Centros	€	Un trimestre	2	Asistentes y primeras visitas con origen «charla»	■ SIN TRÁMITE	—
A02	Programa en residencias de mayores: revisión anual en el propio centro, con informe a la familia Alguien mira la boca de un mayor que ya no puede pedir cita solo	Doctor	€€	Un trimestre	3	Residencias con convenio y revisiones hechas	■ REVISAR CONTENIDO	—
A03	Convenio con colegios: salud bucodental infantil, sin ninguna captación comercial dentro del aula Un niño aprende a cepillarse antes de necesitar un implante a los cincuenta	Higienista	€	Un año	1	Centros con convenio activo	■ REVISIÓN PREVIA	—

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A04	Ciclo abierto «lo que nadie le cuenta de los implantes», en el propio centro, con turno de preguntas Pregunta lo que no se atreve a preguntar en una consulta con el reloj corriendo	Doctor	€	Un trimestre	2	Asistentes y conversión a primera visita a 90 días	REVISAR CONTENIDO	—
A05	Material informativo en farmacias de barrio, sin promesa de resultado ni oferta Recibe información útil de alguien en quien ya confía	RAC	€	Un trimestre	1	Farmacias con material y origen declarado en la PV	REVISAR CONTENIDO	—
A06	Contenido que responde a las preguntas que la gente hace de verdad, no a las que nos gustaría que hiciera Encuentra una respuesta honesta escrita por un clínico y no por un redactor	Dirección General	€	Un año	3	Preguntas respondidas y tráfico de intención informativa	REVISAR CONTENIDO	C9 · Presencia digital y reseñas
A07	Recorrido en vídeo por la clínica, sin pacientes y sin música de anuncio Ve dónde va a meterse antes de meterse	Dirección General	€	Un trimestre	2	Reproducciones completas y menciones en la acogida	SIN TRÁMITE	C9 · Presencia digital y reseñas
A08	Prótesis a la vista: jornada de puertas abiertas al laboratorio y al flujo digital Ve con sus ojos por qué una pieza cuesta lo que cuesta	Dirección de Centros	€	Un año	2	Asistentes y efecto sobre la objeción de precio	SIN TRÁMITE	—
A09	Presencia en medios locales como fuente experta, no como anunciante Lee sobre salud bucodental en su periódico y no un publisreportaje	Dirección General	0	Un año	1	Apariciones no pagadas	REVISAR CONTENIDO	—
A10	Patrocinio deportivo de base con contrapartida sanitaria: revisión al equipo, no logotipo en la camiseta Su hijo tiene la boca revisada porque su club juega con nosotros	Dirección de Centros	€€	Un año	2	Clubes con revisión hecha	SIN TRÁMITE	—
A11	Programa de salud bucodental para empresas del polígono, del termalismo y de la administración Le revisan la boca en horario de trabajo, que es el único que tiene	Gerencia	€€	Un año	3	Empresas con acuerdo y trabajadores revisados	REVISAR CONTENIDO	—
A12	Señalética y fachada legibles desde la calle, con el número de registro sanitario visible Sabe qué hay dentro antes de entrar y quién responde de ello	Gerencia	€€	Ya	1	Entradas espontáneas registradas	SIN TRÁMITE	—

G2 · Encontrabilidad y respuesta 12 ACCIONES

E4 — Que quien nos busque nos encuentre, y que al encontrarnos le conteste alguien. La segunda mitad de esa frase es donde se pierde el dinero.

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A13	Ficha de negocio completa: horarios reales, fotos propias, servicios y accesibilidad No se planta en la puerta un día que está cerrado	Recepción	0	Ya	3	Impresiones, llamadas y cómo-llegar	SIN TRÁMITE	C9 · Presencia digital y reseñas

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A14	Web construida sobre preguntas reales, con la respuesta firmada por quien la sostiene Sabe quién le está hablando y puede pedirle cuentas	Dirección General	€€	Un trimestre	3	Páginas vistas de intención alta	■ REVISAR CONTENIDO	C9 · Presencia digital y reseñas
A15	Página por tratamiento con precio de partida publicado y qué incluye Sabe el orden de magnitud antes de sentarse, y no le sorprenden en el peor momento	Gerencia	0	Un trimestre	3	Conversión de página a cita	■ REVISAR CONTENIDO	C9 · Presencia digital y reseñas
A16	Página por localidad de la provincia con el tiempo real de desplazamiento y dónde aparcar Sabe si le compensa venir desde Verín, O Carballiño o Xinzo antes de llamar	Dirección General	€	Un trimestre	2	Primeras visitas por localidad de origen	■ SIN TRÁMITE	C9 · Presencia digital y reseñas
A17	Búsqueda de pago acotada a intención alta y a radio corto, con tope mensual duro Encuentra una clínica que existe de verdad a veinte minutos de su casa	Gerencia	€€€€	Ya	3	Coste por primera visita y su tendencia	■ REVISAR CONTENIDO	C9 · Presencia digital y reseñas
A18	Respuesta en menos de quince minutos en horario; fuera de él, respuesta automática que dice la verdad sobre cuándo se le contestará No se queda esperando sin saber si alguien le ha leído	Recepción	0	Ya	4	Tiempo hasta primera respuesta, mediana y p90	■ SIN TRÁMITE	—
A19	Cita en línea con hueco real, no formulario de contacto Cierra su cita a las once de la noche, que es cuando se acuerda	Recepción	€€	Un trimestre	3	Citas cerradas fuera de horario	■ SIN TRÁMITE	—
A20	WhatsApp de centro con norma publicada: aquí no se diagnostica por foto No recibe un diagnóstico falso por una foto mal hecha	Recepción	0	Ya	2	Consultas resueltas y derivadas a visita	■ REVISIÓN PREVIA	—
A21	Teléfono contestado por persona durante todo el horario, con registro de llamadas perdidas Le contesta alguien, no un menú	Recepción	€€	Ya	4	Llamadas perdidas sobre recibidas	■ SIN TRÁMITE	—
A22	Recuperación de toda llamada perdida antes de dos horas, sin excepción Le devuelven la llamada aunque él ya se haya rendido	Recepción	0	Ya	4	Llamadas perdidas recuperadas	■ SIN TRÁMITE	—
A23	Solicitud sistemática de reseña a todo paciente al alta, nunca incentivada y nunca filtrada Lee opiniones que no están compradas	RAC	0	Ya	3	Reseñas nuevas al mes y nota media	■ REVISIÓN PREVIA	C9 · Presencia digital y reseñas
A24	Respuesta pública a toda reseña, y en veinticuatro horas a la negativa Ve cómo tratamos a quien se queja, que es el único dato fiable	Dirección General	0	Ya	3	Reseñas negativas con respuesta y su plazo	■ REVISIÓN PREVIA	C9 · Presencia digital y reseñas

G3 · La duda ■ 10 ACCIONES

E5 — El territorio propio del centro. Casi toda la ventaja competitiva de «no medias sonrisas» se cobra aquí.

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A25	Segunda Opinión Honesta: informe escrito que el paciente se lleva, diga lo que diga Se lleva un documento suyo, aunque decida tratarse en otro sitio	Doctor	€€	Ya	4	Segundas opiniones emitidas y su conversión	REVISAR CONTENIDO	C7 · «Segunda opinión, sin compromiso»
A26	Publicación anual del índice de «no necesita tratamiento» sobre las segundas opiniones Puede comprobar con un número cuántas veces decimos que no hace falta	Dirección General	0	Un año	3	Índice publicado y su evolución	REVISAR CONTENIDO	C7 · «Segunda opinión, sin compromiso»
A27	Consulta del Miedo: primera visita para quien lleva más de diez años sin ir, sin propuesta de tratamiento ese día Entra sin que nadie le proponga nada. Solo a contar y a que le escuchen	Doctor	€€	Un trimestre	4	Consultas del miedo y su conversión a 90 días	REVISAR CONTENIDO	C5 · «Sin miedo»
A28	Presupuesto sin prisa: sin caducidad comercial, con la consecuencia clínica de esperar seis, doce y veinticuatro meses Decide con información en vez de con urgencia inventada	Doctor	0	Ya	5	Tasa de aceptación y días hasta aceptar	REVISAR CONTENIDO	—
A29	Explicación de qué se paga: material, tiempo clínico, laboratorio, garantía y revisión Entiende el precio en vez de sospechar de él	Gerencia	0	Un trimestre	3	Objeciones de precio registradas en la Fase 10	SIN TRÁMITE	—
A30	Casos reales contados por el clínico, con consentimiento expreso y sin promesa de resultado Ve un caso parecido al suyo contado por quien lo trató	Doctor	€	Un trimestre	3	Casos publicados y menciones espontáneas	REVISIÓN PREVIA	C2 · «Su caso no es imposible»
A31	Visita previa de cinco minutos para ver la clínica y conocer al equipo, sin sillón Conoce el sitio sin comprometerse a nada	Recepción	0	Ya	2	Visitas previas y su conversión	SIN TRÁMITE	C5 · «Sin miedo»
A32	Comparativa honesta con tratarse fuera: coste total incluyendo revisiones, garantía y quién responde si falla Compara peras con peras antes de coger un avión	Doctor	0	Un trimestre	3	Pacientes con tratamiento previo fuera atendidos	REVISAR CONTENIDO	C7 · «Segunda opinión, sin compromiso»
A33	Financiación con coste total visible y sin comisión para quien la ofrece Nadie gana nada por empujarle a financiar	Gerencia	0	Ya	3	Financiaciones y tasa de impago	REVISIÓN PREVIA	—
A34	Tabla de garantías publicada por tipo de tratamiento, entregada con cada presupuesto Sabe por escrito qué pasa si algo falla dentro de cinco años	Dirección General	0	Ya	4	Presupuestos entregados con tabla adjunta	REVISAR CONTENIDO	—

G4 · La visita como medio 12 ACCIONES

E6 — La primera visita es el mejor soporte publicitario que tenemos y el único que ya está pagado.

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A35	Recordatorio de cita que cuenta lo que va a pasar, cuánto dura y qué traer Llega sabiendo a qué viene y no en ayunas por si acaso	Recepción	0	Ya	2	Ausencias sin avisar	SIN TRÁMITE	—

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A36	Acogida en noventa segundos, por su nombre y sin mostrador de por medio Le reciben como a una persona esperada, no como a un turno	Recepción	0	Ya	3	Cumplimiento observado de la Fase 1	 SIN TRÁMITE	—
A37	El Acompañante: silla, nombre, y copia del plan también para él Quien viene con él entiende lo mismo y puede ayudarle a decidir en casa	Recepción	0	Ya	4	Planes entregados por duplicado	 REVISAR CONTENIDO	C8 · Prescripción de pacientes
A38	Sala de espera sin televisión comercial ni publicidad de tratamiento Espera sin que le vendan mientras está nervioso	Gerencia	€	Ya	2	Verificación trimestral de sala	 SIN TRÁMITE	—
A39	Explicación con el modelo y la imagen en la mano, no con folleto Ve su propia boca en vez de la de un catálogo	Doctor	€€	Un trimestre	3	Comprensión verificada al cierre de la visita	 SIN TRÁMITE	—
A40	Entrega del plan por escrito el mismo día, siempre, también cuando el plan es no hacer nada Sale con papel. Siempre	Doctor	0	Ya	4	Planes entregados el mismo día sobre visitas	 SIN TRÁMITE	—
A41	Nada se cierra el día del miedo: por norma se le invita a pensarlo Nadie le arranca un sí el día que llegó asustado	Dirección General	0	Ya	4	Aceptaciones diferidas sobre el total	 SIN TRÁMITE	C5 · «Sin miedo»
A42	Registro literal de lo que dijo que le preocupaba, en su ficha y en sus palabras La próxima vez alguien se acuerda de lo que le importaba	RAC	0	Ya	3	Fichas con preocupación registrada	 SIN TRÁMITE	—
A43	Encuesta de una sola pregunta al salir, contestada de pie y en diez segundos Le preguntan cuando aún se acuerda	Recepción	0	Ya	2	Respuestas y su serie mensual	 SIN TRÁMITE	—
A44	Huevo útil: la cancelación se ofrece por orden clínico a quien espera, no por orden de importe Entra antes porque su caso corre más prisa, no porque pague más	Recepción	0	Un trimestre	3	Huecos reasignados sobre cancelaciones	 SIN TRÁMITE	—
A45	Información real de aparcamiento, bus y accesibilidad, publicada y comprobada Sabe dónde dejar el coche y si entra con silla de ruedas	Recepción	0	Ya	2	Incidencias de acceso registradas	 SIN TRÁMITE	—
A46	Atención en gallego y apoyo de traducción para quien lo necesite Le atienden en la lengua en la que piensa	Dirección de Centros	€	Un trimestre	2	Visitas atendidas con apoyo idiomático	 SIN TRÁMITE	—

G5 · La decisión y el tratamiento 10 ACCIONES

E7 · E8 — Nadie decide en la silla el día del miedo. Lo que se hace aquí decide la conversión de verdad, no el anuncio.

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A47	Llamada del propio clínico veinticuatro horas después de cualquier cirugía Le llama quien le operó, no un número desconocido	Doctor	0	Ya	4	Llamadas hechas sobre cirugías	 SIN TRÁMITE	C1 · Alma Te Cuida

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A48	Vía directa para cuando algo va mal, con nombre, número y plazo de respuesta comprometido Sabe a quién llamar a las diez de la noche de un sábado	Dirección de Centros	€	Ya	4	Incidencias atendidas dentro de plazo	 SIN TRÁMITE	—
A49	Informe de progreso a mitad de tratamiento, con lo hecho y lo que queda Sabe por dónde va sin tener que preguntar	Doctor	0	Un trimestre	2	Informes entregados sobre tratamientos largos	 SIN TRÁMITE	—
A50	El Archivo de tu Boca: su historia clínica, imágenes y plan, en formato que se lleva aunque se marche Es dueño de su propia historia y puede llevársela a cualquier sitio	Dirección de Centros	€€€	Un año	4	Archivos entregados sobre altas	 REVISIÓN PREVIA	C1 · Alma Te Cuida
A51	Fotografía clínica normalizada para el archivo del paciente, no para el escaparate Sus imágenes existen para tratarle, no para anunciarnos	Higienista	€€	Un trimestre	2	Casos con serie fotográfica completa	 REVISIÓN PREVIA	—
A52	Acompañamiento pactado paso a paso para el paciente con miedo, con señal de parada acordada Puede parar la intervención con una señal, y se respeta	Doctor	0	Ya	3	Pacientes en circuito de miedo y abandonos	 SIN TRÁMITE	C5 · «Sin miedo»
A53	Aviso antes de ejecutar cualquier cambio de coste sobre el plan aprobado Nunca le llega una factura que no esperaba	Gerencia	0	Ya	4	Desviaciones comunicadas antes de ejecutar	 SIN TRÁMITE	—
A54	Documento de alta con lo conseguido y lo que toca a partir de ahora Sabe qué pasa el año que viene y el siguiente	Doctor	0	Ya	3	Altas con documento entregado	 SIN TRÁMITE	C1 · Alma Te Cuida
A55	Encuesta de experiencia al alta con una pregunta abierta que alguien lee Su queja llega a una persona con capacidad de cambiar algo	RAC	0	Un trimestre	2	Respuestas y acciones abiertas a partir de ellas	 SIN TRÁMITE	—
A56	Política de devolución en supuestos tasados, resuelta sin discusión y sin abogado Sabe de antemano cuándo se le devuelve el dinero	Dirección General	€€	Un trimestre	3	Devoluciones y días hasta resolver	 REVISAR CONTENIDO	—

G6 · El cuidado, el sueño y la pérdida 10 ACCIONES

E9 · E11 · E12 — Donde está el dinero, según la aritmética de la propia Plan de Dirección: dos de estas campañas son el 63 % de lo que aporta la cartera.

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A57	Alma Te Cuida: programa anual de mantenimiento, revisión y prioridad de agenda Su tratamiento se vigila en vez de olvidarse	Dirección de Centros	€€	Ya	5	Altas incorporadas al programa	 REVISAR CONTENIDO	C1 · Alma Te Cuida
A58	La Carta del Tercer Año: se escribe para confirmar que aquello sigue funcionando, no para vender nada Recibe una carta que no le pide dinero	Dirección General	€	Un año	3	Cartas enviadas y respuestas espontáneas	 SIN TRÁMITE	C1 · Alma Te Cuida

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A59	Revisión sistemática que evita la cirugía: se llama por criterio clínico, no por calendario comercial Le llaman antes de que el problema cueste una cirugía	Higienista	€€	Ya	5	Revisiones hechas y hallazgos precoces	REVISAR CONTENIDO	C6 · «La revisión que evita la cirugía»
A60	El Día de los que no Volvieron: una jornada al año para reabrir planes abandonados, sin presión y sin oferta Puede volver sin dar explicaciones ni sentirse juzgado	RAC	€	Un año	3	Planes reabiertos y aceptados	REVISAR CONTENIDO	C3 · «Volvemos a llamarle»
A61	Rescate del paciente dormido por antigüedad y por riesgo clínico, en ese orden Le llaman porque su caso lo pide, no porque toque campaña	RAC	€	Un trimestre	4	Dormidos contactados y reactivados	REVISAR CONTENIDO	C3 · «Volvemos a llamarle»
A62	Entrevista de salida al paciente que se va, sin ningún intento de retenerle Se le pregunta por qué se va y no se le retiene a la fuerza	Gerencia	0	Un trimestre	2	Entrevistas hechas sobre bajas	SIN TRÁMITE	—
A63	Aviso de mantenimiento por tipo de prótesis y fecha de colocación Le avisan cuando toca, aunque él lo haya olvidado	Higienista	€	Un trimestre	3	Avisos enviados y citas generadas	REVISAR CONTENIDO	C6 · «La revisión que evita la cirugía»
A64	Cadencia de higiene profesional según riesgo individual, no según calendario comercial Viene las veces que necesita, ni una más	Higienista	0	Un trimestre	3	Pacientes con cadencia asignada por riesgo	SIN TRÁMITE	C6 · «La revisión que evita la cirugía»
A65	Recuperación del producto pendiente heredado: caja ya cobrada que hay que convertir en producción Recibe el tratamiento que ya pagó a la titularidad anterior	Gerencia	€	Ya	5	Producto pendiente convertido	REVISAR CONTENIDO	—
A66	Contacto anual con el paciente sin tratamiento activo, con algo útil y sin oferta Sabe que seguimos aquí sin que le persigan	RAC	€	Un año	2	Contactos hechos y bajas de lista	REVISAR CONTENIDO	—

G7 · Prescripción y alianzas 10 ACCIONES

E10 — Lo que otro dice de nosotros vale más que lo que digamos nosotros, y cuesta menos. También es lo más lento de construir.

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A67	Prescripción de pacientes: se pide de frente, se agradece siempre y no se paga nunca Recomienda sin cobrar, que es la única forma de que su palabra valga	RAC	€	Ya	4	Primeras visitas con origen «prescripción»	REVISAR CONTENIDO	C8 · Prescripción de pacientes
A68	Red de derivación con médicos de familia, odontólogos generalistas y protésicos Su médico le manda a un sitio concreto y no a buscar en internet	Dirección General	€€€	Un trimestre	4	Derivadores activos y visitas derivadas	REVISIÓN PREVIA	C4 · Red de derivación

CÓD.	ACCIÓN · Y QUÉ GANA EL PACIENTE	DUEÑO	COSTE	PLAZO	EF.	INDICADOR	LEGAL	CAMPAÑA
A69	Acuerdo con asociaciones de emigrantes y concellos: diagnóstico y plan en la primera estancia No vuelve a marcharse con un problema que va a estallar a mil kilómetros de quien le conoce	Gerencia	€€	Un trimestre	4	Planes abiertos en estancia	■ REVISAR CONTENIDO	—
A70	Campaña del Retorno: ventana de tratamiento ajustada al calendario real de las estancias Se trata en las semanas en que está aquí, sin gastar la estancia en salas de espera	Gerencia	€€€	Un año	4	Tratamientos completados dentro de ventana	■ REVISAR CONTENIDO	—
A71	Informe clínico para continuar fuera, dirigido al propio paciente Se marcha con un papel que dice cómo tiene la boca y qué falta	Doctor	€	Un año	3	Informes emitidos	■ REVISIÓN PREVIA	—
A72	Protocolo de urgencia a distancia y qué llevarse al volver a marchar Sabe qué hacer si le duele una muela lejos de aquí	Doctor	€	Un año	2	Consultas a distancia atendidas	■ REVISIÓN PREVIA	—
A73	Convenio con residencias y servicios de ayuda en el hogar Alguien lleva la boca de un dependiente que no puede ir solo	Dirección de Centros	€€	Un año	3	Convenios activos y pacientes atendidos	■ REVISAR CONTENIDO	—
A74	Alianza con clubes deportivos: férulas de protección y revisión de temporada Su hijo juega con la boca protegida	Higienista	€€	Un año	2	Férulas hechas y equipos revisados	■ SIN TRÁMITE	—
A75	Acuerdo con empresas: revisión anual como retribución en especie para la plantilla Le revisan la boca sin pedir un día libre	Gerencia	€€	Un año	3	Empresas con acuerdo y trabajadores atendidos	■ REVISAR CONTENIDO	—
A76	Presencia como docente en colegio profesional y formación de posgrado Le trata quien enseña a otros a hacerlo	Doctor	€€	Estructural	2	Horas de docencia impartidas	■ SIN TRÁMITE	—

Parte

IV

Las diez piezas

Lo que nadie está haciendo en esta ciudad

De las setenta y seis, diez son distintas. Todas nacen de la misma idea —que al paciente se le debe algo aunque no compre— y todas llevan una casilla incómoda: por qué nadie lo hace.

10

Las diez piezas, una a una

Cada una lleva una casilla incómoda —«por qué nadie lo hace»— porque si una idea es buena, barata y evidente, y aun así nadie la aplica, hay un motivo. Casi siempre es que cuesta facturación a corto plazo, y ese es exactamente el precio de entrada.

P1 · La Segunda Opinión Honesta

A25 · A26 · CAMPAÑA C7

Qué es

Una consulta específica para quien ya tiene un plan de tratamiento de otro centro. Se revisa, se explica y **se entrega un informe escrito que el paciente se lleva**, diga lo que diga el informe. Sin coste y sin condición de tratarse aquí.

Qué gana el paciente

Sale con un documento suyo, redactado por un clínico, que puede llevar a donde quiera. Deja de estar solo delante de una decisión de varios miles de euros.

Cómo se hace

Cita de 30 minutos con el Doctor, plantilla de informe normalizada, entrega el mismo día. Nunca se critica al colega: se describe lo que hay y lo que cambiaría, con su fundamento.

Qué cuesta

Tiempo de agenda, que es el recurso escaso. En régimen de agenda llena cada segunda opinión desplaza una primera visita, y el modelo lo contabiliza así: C7 aporta 20 k€ ya neto de ese desplazamiento.

Por qué nadie lo hace

Porque el informe escrito se puede usar para negociar con la clínica de al lado. Es justo lo que lo hace creíble: entregarlo es la prueba de que no dependemos de retener al paciente por la vía de la información.

P2 · El índice de «no necesita tratamiento»

A26 · PUBLICACIÓN ANUAL

Qué es

La cifra, publicada una vez al año, de cuántas de nuestras segundas opiniones terminaron en «lo que le han propuesto no hace falta, o no hace falta todavía». Con el numerador, el denominador y el periodo.

Qué gana el paciente

Puede comprobar con un número —y no con un eslogan— cuántas veces este centro renuncia a facturar. Es la única forma de hacer verificable la frase «no le vamos a vender lo que no necesita».

Cómo se hace

Se registra el desenlace de cada segunda opinión en la ficha, se agrega al cierre del ejercicio y se publica junto al cuadro de mando del apartado 13 del Plan de Dirección. Definición operativa cerrada por escrito *antes* de empezar a medir, para que nadie pueda ajustarla después.

Qué cuesta

Nada de dinero. Cuesta la incomodidad de publicar un número que puede salir bajo.

Por qué nadie lo hace

Porque obliga a sostenerlo el año que sale mal. Un competidor puede copiar la idea en una tarde; lo que no puede copiar es una serie de cinco años.

P3 · La Consulta del Miedo

A27 · A52 · CAMPAÑA C5

Qué es

Una primera visita distinta, para quien lleva más de diez años sin ir al dentista. **Por norma no se propone tratamiento ese día.** Se escucha, se explora si el paciente quiere, se explica qué hay, y se le cita otro día si él lo pide.

Qué gana el paciente

Entra sabiendo que nadie le va a proponer nada ni le va a reñir. Para el arquetipo 1 —el grupo más grande y peor atendido del mercado— es la diferencia entre venir y no venir.

Cómo se hace

Se nombra, se publica y se puede pedir por su nombre al teléfono. Guion propio, sin bata en los primeros minutos si el paciente lo prefiere, y señal de parada pactada para cualquier exploración: **A52.**

Qué cuesta

Una visita que no convierte ese día. C5 lo modela con conversión del 45 % diferida y ticket alto: 25 k€ de aporte neto.

Por qué nadie lo hace

Porque renunciar a cerrar el mismo día es renunciar al 100 % de los cierres por impulso. Ese es el punto: quien cierra por impulso el día del miedo se arrepiente, no vuelve y no recomienda.

P4 · El Presupuesto sin Prisa

A28 · A34 · NORMA DE CENTRO

Qué es

Un presupuesto **sin caducidad comercial**. En su lugar lleva escrito qué cambia clínicamente si se espera seis, doce o veinticuatro meses: qué se puede perder, qué encarece y qué da igual.

Qué gana el paciente

Decide con información en lugar de con urgencia inventada. Y si espera, sabe exactamente a qué se expone.

Cómo se hace

Tres líneas normalizadas por tipo de tratamiento, redactadas por Dirección Clínica, que se rellenan con el caso concreto. Va grapado a la tabla de garantías de **A34.**

Qué cuesta

Cero. Sustituye un texto por otro texto.

Por qué nadie lo hace

Porque la caducidad del presupuesto cierra casos esta semana. Convierte una presión comercial en una advertencia clínica, y la advertencia clínica es, además, la única que es cierta.

P5 · El Archivo de tu Boca

A50 · A51 · CAMPAÑA C1

Qué es

La historia de la boca de cada paciente —imágenes, radiografías, plan, materiales colocados con su referencia y lote, garantías— en un formato que **se lleva cuando quiera, incluso si se marcha a otra clínica**.

Qué gana el paciente

Es dueño de su propia historia. Si se muda a Madrid, si cambia de dentista o si tiene una urgencia en otro país, lleva consigo lo que hicimos y con qué.

Cómo se hace

Serie fotográfica normalizada, registro de material con lote, exportación en formato abierto, entrega al alta. Requiere revisión de protección de datos: es dato de salud y el consentimiento tiene que ser específico.

Qué cuesta

Banda €€€: sistema, tiempo de higienista y almacenamiento. Es la pieza más cara de las diez.

Por qué nadie lo hace

Porque el archivo retiene: el paciente que no puede llevarse su historia vuelve por inercia. Renunciar a esa retención es la manera más clara de decir que solo queremos a quien quiere estar.

P6 · La Campaña del Retorno

A69 · A70 · A71 · A72 · FUERA DE CARTERA

Qué es

Un programa dental construido sobre el calendario de quien vive fuera y no sobre el nuestro: diagnóstico y plan en la primera estancia, tratamiento planificado dentro de la ventana real, informe clínico para continuar fuera si hace falta y protocolo de urgencia a distancia.

Qué gana el paciente

No vuelve a marcharse con un problema que va a estallar a mil kilómetros del dentista que le conoce, y se trata en las semanas en que está aquí, sin gastar la estancia entera en salas de espera.

Cómo se hace

Acuerdo con asociaciones de emigrantes, centros gallegos en el exterior y concellos. Agenda con reserva de huecos en agosto y en Navidad. Informe dirigido al propio paciente, que decide con quién lo comparte.

Qué cuesta

Banda €€€ el primer año, casi todo en tiempo comercial de Gerencia. Las ventanas del calendario se contrastan con dos asociaciones en T2; hasta entonces no se compromete agenda.

Por qué nadie lo hace

Porque exige adaptar la agenda a un calendario ajeno en vez de exigir al paciente que se adapte al nuestro. En una provincia que vive con media familia fuera, es la pieza con más recorrido y la que nadie ha tocado.

P7 · El Día de los que no Volvieron

A60 · A61 · CAMPAÑA C3

Qué es

Una jornada al año dedicada exclusivamente a reabrir planes de tratamiento abandonados. Sin oferta, sin descuento y sin presión: se llama para preguntar cómo está aquello y se le ofrece retomarlo donde se quedó.

Qué gana el paciente

Puede volver sin dar explicaciones. Casi nadie abandona un tratamiento por convicción: lo abandona por dinero, por miedo o por vergüenza, y las tres cosas empeoran con el tiempo si nadie llama.

Cómo se hace

Lista ordenada por criterio clínico —riesgo primero, antigüedad después— y guion que empieza por «no le llamo para venderle nada». Se registra el desenlace de todas, incluidas las que dicen que no.

Qué cuesta

Banda €, sobre todo tiempo de RAC. C3 lo modela en 13 k€ de aporte con 4,4× de retorno.

Por qué nadie lo hace

Porque llamar a quien abandonó se siente como perseguir. Lo que convierte la llamada en servicio y no en acoso es el orden de la lista: primero el riesgo clínico, nunca el importe pendiente.

P8 · La Carta del Tercer Año

A58 · CAMPAÑA C1

Qué es

Una carta que se envía cuando un implante cumple tres años, con un único propósito: confirmar que sigue funcionando. **No pide nada, no ofrece nada y no lleva promoción.**

Qué gana el paciente

Recibe una carta de su clínica que no le pide dinero. Estadísticamente, es la primera de su vida.

Cómo se hace

Disparador automático desde la fecha de colocación. Texto firmado por el clínico que trató el caso, con su nombre. Si el paciente responde que algo va mal, entra por la vía directa de **A48**, no por la agenda general.

Qué cuesta

Banda €: papel, franqueo y quince minutos al mes.

Por qué nadie lo hace

Porque no tiene retorno atribuible. Es exactamente lo que la hace funcionar: en cuanto lleve una oferta al pie deja de ser una carta y pasa a ser publicidad, y el paciente lo nota en la primera línea.

P9 · Prótesis a la Vista

A08 · A39 · JORNADA ABIERTA

Qué es

Abrir el laboratorio y el flujo digital al público una o dos veces al año. Se ve el escaneado, el diseño, la fresadora y el acabado a mano de una pieza real.

Qué gana el paciente

Ve con sus ojos por qué una pieza cuesta lo que cuesta. Es la respuesta a la objeción de precio que no se puede dar con palabras, porque con palabras suena a excusa.

Cómo se hace

Grupos pequeños, sin sesión comercial al final. El mismo material sirve para **A39**: explicar con el modelo en la mano dentro de la consulta, que es donde de verdad se usa a diario.

Qué cuesta

Banda €: una tarde de laboratorio y de clínica.

Por qué nadie lo hace

Porque enseñar el proceso enseña también dónde están los márgenes. Un centro que compite por excelencia y no por precio no tiene ese problema: es su mejor argumento.

P10 · El Acompañante

A37 · A42 · CAMPAÑA C8

Qué es

Reconocer formalmente a quien viene con el paciente: silla, nombre, y **copia del plan de tratamiento también para él** cuando el paciente lo autoriza. Deja de ser un bulto en la sala de espera.

Qué gana el paciente

Quien le acompaña entiende lo mismo que él y puede ayudarlo a decidir en casa, que es donde se decide de verdad. Para el arquetipo 4 —la hija que trae al padre— cambia la conversación entera.

Cómo se hace

Dos líneas en el protocolo de acogida y un ejemplar más de impresora. Se registra en la ficha quién acompañó y qué preocupaba a cada uno: **A42**.

Qué cuesta

Cero euros. Es la acción con mejor relación entre efecto y coste de todo el catálogo.

Por qué nadie lo hace

Porque el acompañante no figura en ninguna ficha, así que oficialmente no existe. Es el mayor prescriptor no reconocido de una clínica dental, y C8 —35× de retorno, el más alto de la cartera— se alimenta en buena parte de él.

Lo que tienen en común las diez

Ninguna es una idea de comunicación: las diez son **cambios en cómo se trabaja** que después se pueden contar. Esa es la diferencia entre una campaña y un plan maestro. Una campaña se apaga cuando se acaba el presupuesto; esto no se puede apagar, porque para apagarlo habría que volver a tratar peor a la gente.

Y ninguna de las diez es cara. Ocho están en banda 0, € o €€. La más cara —el Archivo— es la única que exige sistema. Lo que cuestan las diez juntas es más difícil de conseguir que el dinero: exigen renunciar a facturación de este trimestre a cambio de facturación del tercero.

Parte



El territorio

La provincia, el canal y el calendario del retorno

Dónde estamos, a quién alcanzamos y por qué el canal va después del territorio y no al revés.

11

La presencia digital, al servicio de lo demás

La campaña C9 —presencia digital y reseñas— es la única de la cartera con gasto externo relevante y la única con retorno directo negativo: **-4 k€**. No es un error del modelo: con la agenda casi llena, la visita que trae desplaza a otra de más valor. Se aprueba igual, y conviene entender por qué.

Por qué se aprueba una campaña con retorno negativo

Porque no es una campaña de captación: es un **habilitador**. Cuatro campañas de la cartera dependen de que exista. La segunda opinión —C7— no funciona si quien la busca no nos encuentra. «Su caso no es imposible» —C2— vive de que alguien lea un caso parecido al suyo. La prescripción —C8— acaba en una búsqueda del nombre que le han dado. Y la red de derivación —C4— se comprueba mirando la ficha del centro.

Se aprueba, por tanto, **como infraestructura y no como campaña de retorno**, y así consta en su ficha del Anexo B del Plan de Dirección. Su presupuesto no se justifica por lo que trae, sino por lo que sostiene. Si algún día se la juzga por retorno directo, saldrá siempre la última.

De esa naturaleza salen tres reglas que gobiernan las doce acciones del grupo G2:

REGLA	QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA	ACCIONES
Encontrable antes que visible	Primero que quien nos busca por nombre o por necesidad nos encuentre con datos verdaderos. La notoriedad es un problema posterior y más caro	A13 · A14 · A15 · A16
La respuesta es la mitad del canal	De nada sirve que llame si nadie contesta. La segunda mitad de «encontrabilidad y respuesta» es donde se pierde el dinero, y no cuesta un euro arreglarla	A18 · A19 · A21 · A22
La reseña no se gestiona: se merece y se contesta	Se piden todas al alta, no se filtra ninguna y se responde a la negativa en veinticuatro horas. Cómo tratamos a quien se queja es el único dato fiable que un desconocido tiene sobre nosotros	A23 · A24

El tope duro

La búsqueda de pago —A17— lleva **tope mensual cerrado y radio corto**. Es la única acción del catálogo cuyo gasto puede crecer sin límite si nadie lo vigila, y la única cuyo coste por primera visita sube justo cuando más se necesita. Se revisa mensualmente en el cuadro de mando; si el coste por primera visita supera el valor de una primera visita, se para sin esperar al comité.

12

El mapa de la provincia

El área de influencia de un centro dental no se mide en kilómetros: se mide en **minutos de puerta a sillón**, y en esta provincia los minutos no son los que dice el mapa. La autovía acerca comarcas enteras del sur y del Ribeiro, mientras que una parroquia a treinta kilómetros por carretera de montaña puede estar más lejos en tiempo que un pueblo que está al doble de distancia.

De ahí la acción **A16**: una página por localidad con el tiempo real de desplazamiento y dónde aparcar al llegar. No es una técnica de posicionamiento: es información que el paciente necesita para decidir si le compensa venir, y que hoy no tiene.

CORONA	LOCALIDADES	QUÉ LA CARACTERIZA	QUÉ LA ABRE
1 · La ciudad	Ourense: O Couto, A Ponte, Mariñamansa, O Vinteún, A Carballeira, Casco Vello	Mercado maduro y saturado de oferta. La decisión no se toma por cercanía, sino por confianza	Reputación, prescripción y las diez piezas del apartado 10
2 · El área urbana	Barbadás, San Cibrao das Viñas, O Pereiro de Aguiar, Coles, Toén	Ya viene a la ciudad a diario, a trabajar o a comprar. El desplazamiento no es la barrera	Cita en franja compatible con la jornada, y dónde aparcar al llegar
3 · Las comarcas	Verín, Xinzo de Limia, Allariz, Celanova, O Carballiño, Ribadavia	Población con capacidad adquisitiva y sin centro de excelencia implantológica propio. Kilómetros que no son minutos	Tiempo real de trayecto dicho explícitamente, y agenda que agrupe las citas para no hacer el viaje dos veces
4 · El retorno	La emigración que vuelve en agosto y en Navidad, dentro y fuera de España	Concentra decisiones en semanas concretas del año. En esta provincia no es una corona más: es la primera	Agenda con reserva en agosto y en Navidad, y plan de tratamiento planificado dentro de la estancia real

■ **MODELO** El reparto en coronas, y muy especialmente el peso que se le da al retorno, es un supuesto de trabajo de Dirección escrito al trasladar el centro a Ourense. Se sustituye por la distribución real de códigos postales de primera visita en cuanto la hoja de captura tenga cuatro meses de serie: es una de las cosas que el instrumento del apartado 7 del Plan de Dirección está esperando medir.

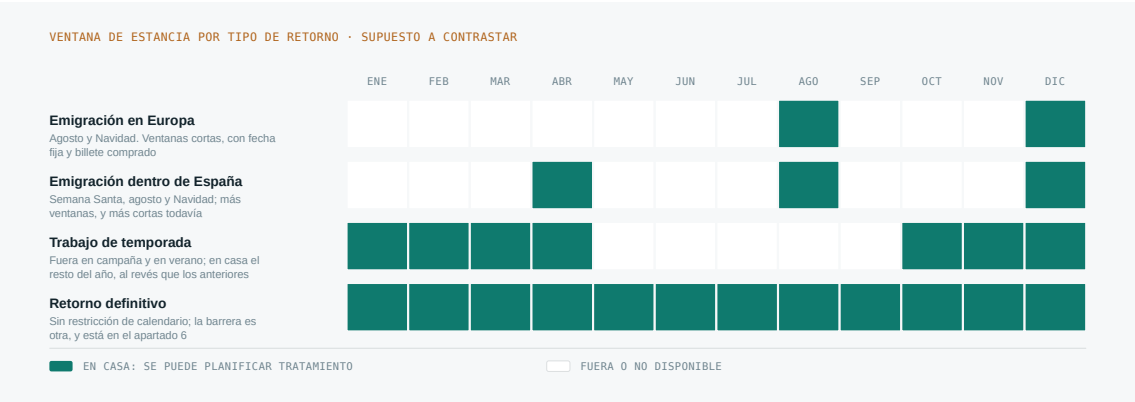
13

La Campaña del Retorno

Ourense vive con media familia fuera y ninguna clínica dental de la ciudad organiza su agenda alrededor de esa realidad. Quien vuelve no elige cuándo tiene tres semanas seguidas aquí —lo decide el billete de vuelta, el convenio de su empresa o el calendario escolar de sus hijos—, y un tratamiento implantológico exige varias citas separadas en el tiempo. El resultado es que **un colectivo entero queda fuera del sistema por un problema de calendario, no de dinero ni de voluntad.**

Figura 2 · La ventana de estancia por tipo de retorno

Cuándo se puede planificar tratamiento con cada colectivo. Naturaleza: **modelo** · las ventanas se contrastan con dos asociaciones de emigrantes y con los concellos en el segundo trimestre, y la figura se sustituye por el calendario real de estancias en cuanto la hoja de captura registre la procedencia de la primera visita. Hasta entonces son supuestos de trabajo y no se citan como dato.



La consecuencia operativa es de agenda, no de comunicación: si el plan se aprueba, hay que reservar huecos en agosto y en Navidad con meses de antelación, y esos huecos compiten con el resto de la cartera justo en las semanas de mayor demanda local.

ACCIÓN	QUÉ SE HACE	CON QUIÉN	SEMÁFORO
A69	Diagnóstico y plan en la primera estancia, con las fechas de la siguiente ya puestas	Asociaciones de emigrantes, centros gallegos en el exterior y concellos	■ CONTENIDO A REVISAR
A70	Ventana de tratamiento en la estancia: agenda reservada y citas agrupadas en las semanas disponibles	El propio paciente	■ CONTENIDO A REVISAR
A71	Informe clínico para continuar fuera si hace falta, dirigido al paciente	El paciente, que decide con quién lo comparte	■ CONSENTIMIENTO Y VERIFICACIÓN JURÍDICA
A72	Protocolo de urgencia a distancia y qué llevarse al volver a marchar	El paciente, con criterio clínico nuestro	■ ALCANCE A DELIMITAR

La línea que no se cruza

El calendario del paciente no manda sobre el calendario clínico. La tentación de esta campaña es evidente: si alguien se va el día 30, comprimir en tres semanas lo que necesita tres meses. Eso no se hace aquí. Si el tratamiento no cabe en la ventana, no se mete en la ventana: se planifica a dos estancias, se deja por escrito qué se hace en cada una y se dice claramente lo que no se va a terminar este verano. Un centro que se llama «no medias sonrisas» no puede entregar media boca porque el billete de vuelta tenga fecha.

Por qué está fuera de la cartera aprobada

Porque la cartera está cerrada en nueve campañas con un colchón del 12 %, y meter una décima sin datos propios sería el tipo exacto de optimismo que este sistema documental existe para impedir. La Campaña del Retorno no espera por eso: **arranca en T2 como prueba acotada** —dos asociaciones, una ventana de agosto, demanda medida— y en el cierre del ejercicio se presenta a Junta como C10 con su aritmética hecha, igual que las otras nueve. Es la única pieza de este plan con recorrido para cambiar de tamaño la cartera del año que viene.

Parte

VI

La prioridad

Qué va primero, y con qué dinero

Setenta y seis acciones no se hacen a la vez. Qué va primero, con qué dinero y por qué en ese orden.

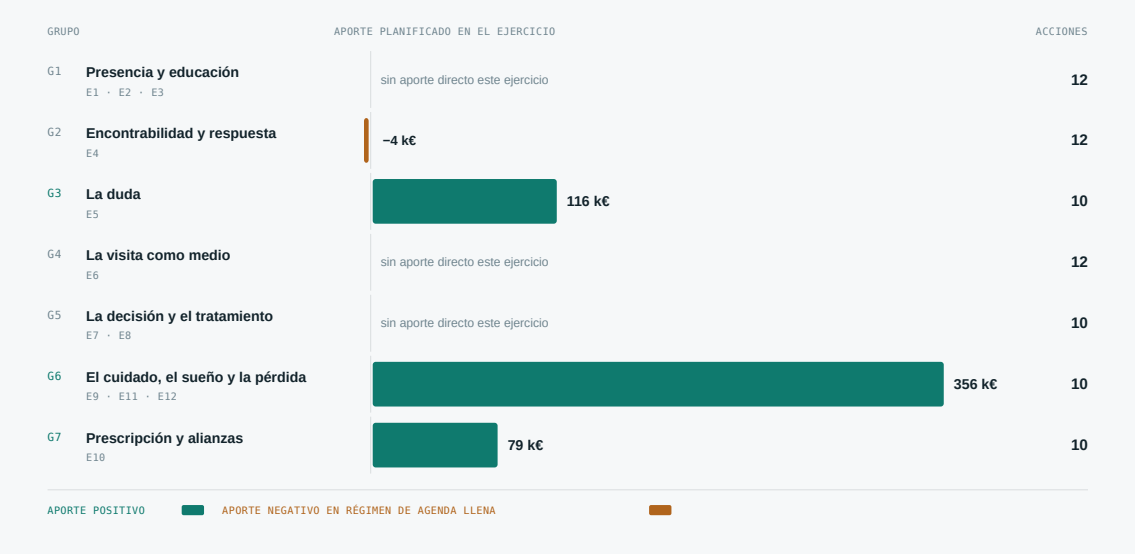
14

Lo que aporta cada grupo

La regla que gobierna toda la aritmética de este plan es la misma que la de la Parte VI del Plan de Dirección, y es deliberadamente conservadora: **con la agenda llena, una acción no vale lo que factura, sino la diferencia entre el paciente que trae y el paciente al que desplaza.**

Figura 3 · Aporte planificado por grupo, frente al número de acciones

El aporte de cada campaña de la cartera, asignado al grupo del catálogo donde viven sus acciones. Naturaleza: **modelo**, derivado de `modelo-campanas.py`; el recuento de acciones sale de `catalogo-acciones.py`.



Tres grupos —G1, G4 y G5— suman treinta y cuatro acciones y aportan cero euros este ejercicio. No sobran: su plazo no es este año.

Las tres lecturas de esta figura

- El grupo que más aporta es el que menos se parece a marketing.** G6 —el cuidado, el sueño y la pérdida— aporta 356 k€ con diez acciones, y todas consisten en atender bien a alguien que ya es paciente.
- Los grupos sin aporte son la mitad del catálogo.** G1, G4 y G5 no producen euros atribuibles este año, y sin ellos los otros cuatro no funcionan: una campaña de segunda opinión sin la acogida de G4 detrás es un anuncio que se desmiente en la primera visita.
- Medir por atribución destruye el plan.** Si a cada acción se le exige retorno propio, se apagan treinta y cuatro y con ellas el suelo sobre el que las demás producen. Por eso el apartado 17 mide grupos y comportamientos, no acciones sueltas.

15

Qué va primero

Figura 4 · Las setenta y seis acciones por plazo y por coste

Cuántas acciones caen en cada casilla. Naturaleza: **hecho** · es un recuento del catálogo, no una estimación.



La casilla más poblada es la más barata y la más rápida. Veintidós acciones no cuestan dinero y se pueden empezar esta semana.

El orden de activación no se decide por efecto esperado, sino por una regla que evita la trampa habitual de los planes de marketing —empezar por lo caro y lo visible—:

☐

Primero lo que no cuesta y ya se puede hacer.

Las 22 acciones de coste cero y plazo inmediato. Cambian cómo se trabaja, no cuánto se gasta, y son las que hacen creíble todo lo demás.

☐

Después lo que sostiene a las campañas aprobadas.

Las 30 acciones que pertenecen a una de las nueve campañas de la cartera: son las que responden del objetivo de este ejercicio.

☐

Luego lo que reduce la asimetría del apartado 8.

Precio publicado, garantías, desglose, archivo. Es lo que produce el efecto a treinta y seis meses sobre el que apuesta este plan.

☐

Al final,
lo que
cuesta
dinero
externo.

Búsqueda de pago, patrocinios, sistema del Archivo. Con tope, con dueño y con regla de parada escrita antes de empezar.

☐

Nunca,
lo que
no
pasa
la
regla
de la
ficha.

No hay quinto escalón: si no dice qué gana el paciente, no está en el catálogo.

La regla de las dos a la vez

La misma que rige la cartera en el apartado 22 del Plan de Dirección: **no más de dos acciones nuevas de banda €€ o superior arrancando al mismo tiempo**. No es prudencia financiera: es que una acción nueva consume atención de las mismas personas que atienden la consulta, y una acogida deteriorada cuesta más de lo que aporta cualquier campaña.

16

Presupuesto y techo

Si se activara el catálogo entero, el techo de gasto anual sería de **201.000 €**. No es lo que se propone: es el límite superior de lo posible, y sirve para saber que este plan nunca va a pedir una cifra que la clínica no pueda sostener.

Coste de la cartera aprobada 87 k€ Las nueve campañas de la Parte VI, ya aprobadas y presupuestadas.	Sobre el objetivo 7,2 % Del objetivo de 1,2 M€. Es la referencia que la Junta ya conoce.
Acciones sin coste 32 El 42 % del catálogo. Su límite no es el dinero: es la atención.	Techo si se activara todo 201.000 € Límite superior teórico, no propuesta.

Lo que este plan pide de verdad

Cero euros adicionales sobre lo ya aprobado en la Parte VI del Plan de Dirección. Las 32 acciones sin coste directo no necesitan presupuesto; las que sí lo necesitan y pertenecen a la cartera ya están dentro de los 87 k€ aprobados. Lo único que este plan pide que no esté ya aprobado son dos cosas, y las dos son decisiones, no partidas:

- **La norma de no cerrar el día del miedo** —P3 y P4—, que cuesta cierres de este trimestre y no cuesta dinero.
- **La prueba acotada de la Campaña del Retorno**, para poder presentarla como C10 el ejercicio que viene con su aritmética hecha.

Parte

VII

El gobierno

Cómo se mide, y con qué regla se para

Ocho medidas que no se pueden mejorar tratando peor a alguien, cuatro puertas de paso que son puertas de verdad, y una regla de parada que cualquiera del centro puede invocar. Sin esto, un catálogo de setenta y seis acciones es una lista de deseos.

17

Las ocho medidas del plan

Los **diez indicadores** nucleares del apartado 13 del Plan de Dirección siguen siendo los del centro y no se tocan. Lo que sigue son **ocho medidas** propias de este plan —M1 a M8—, y se llaman medidas y no indicadores a propósito: para que nadie las confunda con los diez del cuadro de mando cuando se citen en Junta. Se eligieron con un criterio: **ninguna se puede mejorar tratando peor a alguien**. Es el filtro que descarta casi todas las métricas de marketing al uso.

MEDIDA	NUMERADOR / DENOMINADOR	QUÉ VIGILA	CADENCIA
M1 · Tiempo hasta primera respuesta	Mediana y percentil 90 de minutos entre contacto y respuesta humana	El segundo momento de verdad. El indicador más barato de mejorar del sistema	Semanal
M2 · Llamadas perdidas recuperadas	Recuperadas antes de 2 h / perdidas totales	Que nadie se quede sin respuesta porque llamó a la hora mala	Semanal
M3 · Planes entregados el mismo día	Visitas con plan por escrito entregado / visitas con plan	Que nadie salga sin papel, incluido cuando el plan es no hacer nada	Mensual
M4 · Índice de «no necesita tratamiento»	Segundas opiniones sin indicación / segundas opiniones emitidas	El quinto momento de verdad. Se publica una vez al año	Trimestral
M5 · Aceptación diferida	Aceptaciones fuera del día de la visita / aceptaciones totales	Que no estemos cerrando por presión. Un valor bajo es una alarma, no un logro	Mensual
M6 · Altas incorporadas al programa de cuidado	Altas que entran en ATC / altas totales	El tránsito E8 → E9, que sostiene 171 k€ de la cartera	Mensual
M7 · Dormidos reactivados	Pacientes que vuelven / pacientes dormidos contactados	El tránsito E11 → E6, que sostiene otros 185 k€	Trimestral
M8 · Primeras visitas por prescripción	Visitas con origen «prescripción» / visitas totales	La campaña con más retorno de la cartera, y la única que no se puede comprar	Mensual

Los cuatro que no se van a medir, y por qué

Y cuatro que se quedan fuera. **Seguidores**. No compran, no vuelven y no recomiendan. **Impresiones**. Miden lo que gastamos, no lo que conseguimos. **Nota media de reseñas aislada**. Sube filtrando; solo significa algo junto al volumen y al porcentaje de negativas contestadas. **Coste por lead**. Baja empeorando la calidad del lead, y en un centro con la agenda llena un lead barato es un lead que desplaza a uno mejor.

Los cuatro se pueden mejorar tratando peor a alguien. Por eso no están.

18

El calendario del ejercicio

El calendario de las nueve campañas está en el apartado 22 del Plan de Dirección y no se repite aquí. Lo que sigue es el calendario del *plan*: cuándo se activa cada tramo del catálogo y qué tiene que estar hecho antes de pasar al siguiente.

TRAMO	QUÉ SE ACTIVA	PUERTA DE PASO
T1 · Primer trimestre	Las 22 acciones de coste cero y plazo inmediato, más las ocho normas del apartado 3 puestas por escrito y firmadas por los seis puestos	M1, M2 y M3 midiéndose de verdad. Sin serie, no se pasa a T2
T2 · Segundo trimestre	Las piezas P1, P3, P4 y P10 —segunda opinión, consulta del miedo, presupuesto sin prisa y acompañante— y las acciones de la cartera con plazo trimestral	M4 y M5 con al menos un trimestre de serie. Prueba acotada de Mar iniciada
T3 · Tercer trimestre	P5 —el Archivo— y las alianzas del G7: derivación, residencias, empresas y clubes	M6 y M7 en la senda prevista. Si no, se revisa la doctrina antes de gastar más
T4 · Cuarto trimestre	P2 —publicación del índice anual—, P7 —el Día de los que no Volvieron— y el cierre del ejercicio	Presentación a Junta con las ocho medidas y la propuesta de C10

Las puertas de paso son puertas de verdad: si al final de T1 los tres primeros indicadores no se están midiendo, T2 no arranca. Un plan que avanza sin medir es un plan que a los doce meses no puede decir si funcionó.

19

Reglas de parada

Toda acción con coste lleva escrita, antes de empezar, la condición con la que se para. Sin ella, una acción que no funciona sobrevive por inercia hasta que alguien se acuerda de mirarla, y eso suele ser al cierre del ejercicio.

ACCIÓN O GRUPO	SE PARA SI...	QUIÉN LO DECIDE
Búsqueda de pago · A17	El coste por primera visita supera el valor de una primera visita durante dos meses seguidos	Gerencia, sin esperar al comité
Cualquier acción de banda €€€ o €€€ €	No mueve su indicador declarado en dos trimestres	Comité de Transición
Alianzas y patrocinios · A10, A74, A75	No producen ni una revisión efectiva en dos trimestres	Gerencia
Campaña del Retorno · A69 a A72	Las ventanas contrastadas no coinciden con el supuesto, o dos asociaciones de emigrantes dicen que no	Dirección General
Cualquier acción, en cualquier momento	Se descubre que solo funciona porque el paciente no tiene toda la información	Cualquiera de los seis puestos. Sin discusión

La regla que detiene el plan entero

La última fila no es retórica y no tiene contrapeso económico. **Cualquier persona del centro puede detener cualquier acción de este plan si descubre que funciona porque el paciente no sabe algo que debería saber.** No hay que justificarlo ante nadie, no hay que esperar al comité y no hay coste que lo compense. Es la traducción operativa de «no medias sonrisas», y es la única línea de este documento que no admite excepción.

Cómo se revisa

Trimestral, en el Comité de Transición, con la misma cadencia y en la misma sesión que el cuadro de mando del apartado 13 del Plan de Dirección. Tres preguntas, en este orden: qué se activó y qué no; qué dicen las ocho medidas M1 a M8; y qué acción hay que parar. La tercera pregunta se hace siempre, aunque la respuesta sea «ninguna», porque una revisión en la que nunca se para nada no es una revisión.

Parte

VIII

El programa

Alma Te Cuida

Todo lo anterior sirve para que un paciente llegue, entienda y decida. Esto es lo que hace que se quede: el programa que convierte un tratamiento cerrado en una relación que dura, con su speech, sus objeciones, su campaña sobre la base de datos y su panel de control.

20

ATC · Alma Te Cuida

La otra mitad de la promesa. «No medias sonrisas» dice qué se resuelve; **Alma Te Cuida** dice cómo se acompaña después. No es un extra ni un añadido comercial: es la parte del tratamiento que garantiza que lo que hoy se hace bien, dure bien. Por eso se ofrece a todos los pacientes, siempre, y forma parte del cierre de cualquier tratamiento.

La mentalidad correcta

Ofrecer ATC no es vender un producto: es invitar al paciente a estar mejor cuidado, a él y a su familia, durante todo el año.

Quien lo vive así, lo transmite; quien lo vive como «colocar una tarjeta», falla. La convicción se nota, y el primer convencido tiene que ser quien lo ofrece.

Qué es, en una tarjeta

ALMA TE CUIDA · ATC

Cuidamos su sonrisa y la de toda su familia, todo el año.

95 € al año · hasta 4 personas · más de 50 servicios incluidos

- ✓ Revisiones y limpieza del año incluidas
- ✓ Urgencias sin cita y prioridad de agenda
- ✓ Toda la familia con una sola tarjeta
- ✓ Descuentos en todos los tratamientos

Solo con la limpieza y las revisiones, la tarjeta ya se paga sola.

Precio, límites y descuentos los cierra Dirección antes de comercializarlo, y deben coincidir exactamente con lo que figure en el catálogo de servicios del contrato.

PUNTO ABIERTO

Por qué se ofrece a todos

POR QUÉ LE CONVIENE AL PACIENTE

- **Ahorra dinero de verdad.** Solo la limpieza y las revisiones incluidas ya cubren el precio; todo lo demás es ventaja neta
- **Cuida su salud, no solo sus dientes.** Las revisiones periódicas detectan a tiempo, cuando todo es más sencillo y barato de resolver
- **Protege a su familia.** Una sola tarjeta cuida hasta a cuatro personas
- **Le da tranquilidad.** Urgencias sin cita, prioridad de agenda y un centro que le conoce
- **Protege su inversión.** Incluye el seguimiento y la garantía que mantienen el tratamiento en el tiempo

POR QUÉ LE CONVIENE A LA CLÍNICA

BENEFICIO	POR QUÉ IMPORTA
Fidelización	El paciente con ATC vuelve, porque quiere aprovechar lo que pagó
Recurrencia	Las revisiones incluidas lo traen varias veces al año

BENEFICIO	POR QUÉ IMPORTA
Detección precoz	Más visitas es más problemas detectados a tiempo: más salud y más producción
Captación familiar	Entran hasta tres familiares que no eran pacientes
Diferenciación	Hace tangible el «Alma Te Cuida»: cuidado real, no eslogan

La regla de oro

ATC se ofrece a **todos** los pacientes, siempre, sin prejuzgar quién lo querrá. No decidimos por el paciente: el que parece que no puede, a veces es el que más lo valora. Ofrecer es un acto de cuidado; no ofrecer es privarle de una oportunidad. Y alinea los dos intereses: al paciente le conviene cuidarse más y a la clínica le conviene que se cuide. Por eso se ofrece con la conciencia tranquila.

Los cuatro argumentos

ARGUMENTO	PARA QUIÉN	CÓMO SE EXPLICA
El ahorro · el más potente	Casi todos	«Fíjese: solo con la limpieza y las revisiones del año ya recupera lo que cuesta la tarjeta. Todo lo demás —urgencias, descuentos, y para toda su familia— es un extra que no paga aparte»
La familia	Con pareja, hijos o padres	«Y lo mejor: esta tarjeta no es solo para usted. Cubre hasta cuatro personas de su familia. Su pareja, sus hijos, sus padres... todos con las revisiones y la limpieza incluidas»
El cuidado continuo	Quien valora la tranquilidad más que el precio	«No es un descuento: es pertenecer a un centro que se ocupa de su salud bucal todo el año. No tiene que acordarse usted de nada: nosotros le avisamos. Usted se despreocupa; nosotros le cuidamos. De ahí el nombre»
La protección de la inversión	Quien acaba de aceptar un tratamiento	«Acaba de hacer una inversión importante en su salud. ATC la protege: incluye las revisiones de seguimiento, el mantenimiento y la garantía. Cuidar lo que se ha hecho es tan importante como hacerlo bien»

El cálculo del ahorro se prepara con los precios reales de la clínica —limpieza anual, dos revisiones con radiografía, una urgencia con valoración y el estudio diagnóstico— y se compara con los 95 €. Dicho con números concretos, ese cálculo cierra la mayoría de los ofrecimientos.

El speech, situación por situación

No hay que memorizarlos palabra por palabra: lo que se retiene es la estructura, que es siempre la misma en cinco pasos —se introduce con naturalidad, se dice qué incluye, se traduce a ahorro concreto, se menciona a la familia y se cierra con una pregunta suave—.

Primera visita · al cerrar la visita

«[Nombre], antes de que se vaya, quiero contarle algo que tenemos para nuestros pacientes y que le va a interesar. Se llama Alma Te Cuida, ATC. Es una tarjeta con la que, por 95 € al año, tiene incluidas sus revisiones, su limpieza dental, las urgencias sin cita y más de cincuenta servicios. Y no solo para usted: cubre hasta cuatro personas de su familia. Fíjese en una cosa: solo con la limpieza y las revisiones del año ya recupera lo que cuesta. Todo lo demás es un extra. Es nuestra forma de cuidarle durante todo el año, no solo cuando viene con una molestia. ¿Quiere que se la active hoy mismo y así ya empieza a disfrutarla?»

Al aceptar un tratamiento · el momento de mayor sentido

«Me alegro mucho de que vayamos a resolver esto, [nombre]. Y precisamente por eso quiero contarle lo de la tarjeta Alma Te Cuida. Ya que va a hacer este tratamiento, con ATC protege su inversión: incluye las revisiones de seguimiento, el mantenimiento y la garantía. Es lo que hace que lo que hoy hacemos bien, dure bien. Son 95 € al año, cubre a cuatro personas de su familia, e incluye la limpieza, las revisiones y las urgencias de todos. Además le da descuento en cualquier otro tratamiento que necesite. ¿Se la añado y así ya se queda todo el seguimiento cubierto?»

En una limpieza o revisión

«[Nombre], ya que viene a cuidarse, déjeme que le cuente algo que le va a compensar mucho. Con la tarjeta Alma Te Cuida, esta limpieza y las revisiones del año le saldrían incluidas. Por 95 € al año tiene la limpieza, las revisiones, las urgencias y más de cincuenta servicios, y además lo puede compartir con hasta tres personas más de su familia. Prácticamente se paga sola solo con lo que ya viene a hacerse. ¿Le explico lo que lleva y se la activamos?»

Recordatorio breve · ya se mencionó antes

«¿Recuerda la tarjeta Alma Te Cuida que le comenté? Por 95 € al año, revisiones, limpieza y urgencias incluidas para usted y su familia. ¿Se la activo?»

Manejo de objeciones

El principio

Una objeción no es un rechazo: es una duda sin resolver.

Se entiende qué hay detrás, se resuelve con información y nunca se presiona. Si tras resolver la duda el paciente sigue diciendo que no, se acepta con una sonrisa y se le vuelve a ofrecer en la siguiente visita.

OBJECCIÓN	QUÉ HAY DETRÁS	CÓMO SE RESPONDE
«Me lo tengo que pensar»	No ha visto el valor con claridad, o es una respuesta automática	«La tarjeta prácticamente se paga sola con la limpieza y las revisiones que de todas formas necesita al año. Y cubre a su familia. No hay permanencia ni letra pequeña. Si quiere, se la activo hoy y la disfruta desde ya; y si en algún momento no le compensa, no la renueva»
«Es caro / ahora no puedo»	Mira los 95 € como gasto, no como ahorro	«Mírelo al revés: no es un gasto, es un ahorro. Solo la limpieza y las revisiones del año ya cuestan más de lo que paga por ella. Con ATC gasta menos de lo que gastaría sin ella. ¿Quiere que le haga el número exacto con lo que usted necesita este año?»
«Yo casi no vengo al dentista»	No percibe que vaya a usar los servicios	«Precisamente por eso le viene bien: incluye las revisiones y nosotros le avisamos cuando toca, así no tiene que acordarse. Venir una o dos veces al año es lo que evita los problemas grandes y caros. Además, la puede aprovechar su familia aunque usted venga poco»
«Ya tengo seguro dental»	Cree que es lo mismo o que se solapa	«No tiene nada que ver: ATC no es un seguro, es su tarjeta de cuidado aquí, en el centro donde le tratamos. Muchos pacientes tienen las dos cosas y las combinan. ¿Le explico qué le aporta ATC que su seguro no le da?»

OBJECCIÓN	QUÉ HAY DETRÁS	CÓMO SE RESPONDE
«Me lo pienso y os digo»	Aplazamiento cortés; probablemente no vuelva sobre el tema solo	«Le dejo la información por escrito para que la vea con calma, y la próxima vez que venga se lo recuerdo. Si quiere, se la puedo dejar ya activada sin compromiso»
«¿Y si no la uso?»	Miedo a comprometerse	La renovación es libre y no hay permanencia; solo con la limpieza ya sale a cuenta

Registro obligatorio
A quien dice «me lo pienso» se le registra en el sistema como **ATC pendiente**, para volver a ofrecérselo en la siguiente visita. Sin registro, la oportunidad se pierde.

Quién lo ofrece y cuándo

PUNTO DE CONTACTO	QUIÉN OFRECE	MOMENTO
Primera visita	Director o Recepción	Al cerrar la visita
Aceptación de tratamiento	Director	Justo tras el sí
Limpieza o revisión	Higienista	Durante o al terminar
Salida y caja	Recepción	Como red de seguridad, si nadie lo hizo antes

Meta operativa: **a ningún paciente se le despide sin haberle ofrecido ATC al menos una vez**. Recepción es la última barrera.

Campaña sobre la base de datos

ATC se ofrece por dos vías complementarias: a cada paciente que pisa la clínica —la principal— y a toda la cartera que ahora mismo no viene, segmentando el mensaje.

SEGMENTO	ÁNGULO DEL MENSAJE
Activos sin ATC	Ya se cuida aquí; con ATC ahorra y suma a su familia
Inactivos	Un motivo para volver: revisiones y limpieza incluidas
Portadores de implantes	Incluye el seguimiento que sus implantes necesitan
Familias	Una tarjeta, cuatro personas cuidadas
Presupuestos no aceptados	Empiece por cuidarse; da descuento si luego se trata

WhatsApp a pacientes activos
«Hola [nombre], en el Centro Alma hemos creado la tarjeta Alma Te Cuida: por 95 €/año, revisiones, limpieza y urgencias incluidas para usted y hasta 3 familiares, más descuentos en todo. Como ya se cuida con nosotros, le sale a cuenta desde la primera limpieza. ¿Le contamos? (Baja: responda BAJA.)»

WhatsApp a pacientes inactivos

«Hola [nombre], le echamos de menos en el Centro Alma. Le presentamos Alma Te Cuida: revisiones y limpieza del año incluidas, urgencias y descuentos, para usted y su familia, por 95 €/año. Un buen motivo para volver a cuidarse. ¿Le buscamos hueco? (Baja: responda BAJA.)»

CUÁNDO	ACCIÓN
Continuo	Ofrecimiento presencial a todos los que vienen
Lanzamiento	Comunicación a toda la base activa, una vez
Mensual	Oleada a un segmento distinto de la cartera
En renovación	Aviso y renovación de los titulares que vencen

Herramientas, formación y medición

MATERIAL DE APOYO

- ☐ Tarjeta física o folleto de una cara para entregar
- ☐ Cartel en recepción y en salas
- ☐ Cálculo de ahorro impreso, con los precios reales
- ☐ Ficha de alta rápida para activar en el momento
- ☐ Chuleta con el speech y las objeciones, visible para el equipo

FORMACIÓN PREVIA AL LANZAMIENTO

- Sesión de presentación: qué es y por qué es bueno para el paciente
- Role-play del speech y de las objeciones, persona a persona
- Responsable operativo asignado, normalmente Recepción
- Objetivo común y seguimiento semanal las primeras semanas

INDICADORES

INDICADOR	OBJETIVO
% de pacientes a los que se ofreció	100 %
Altas al mes	Creciente
Tasa de conversión del ofrecimiento	Creciente
Penetración en pacientes activos	La mayoría
Tasa de renovación	≥ 80 %

El indicador que manda

El porcentaje de pacientes a los que se **ofreció** ATC, no el de los que la aceptaron. Si se ofrece a todos, las altas llegan solas: lo que se controla es el comportamiento del equipo, no el resultado del paciente.

Si Dirección liga ATC al plan de incentivos, conviene que premie *ofrecerlo a todos* —comportamiento— y no solo cerrarlo —resultado—, para no forzar la venta.

Panel de control del programa

El seguimiento vive en una hoja de control con cuatro pestañas. Se actualiza en el momento del alta, no a final de mes.

HOJA	QUÉ CONTIENE
Panel	Titulares activos, personas cubiertas, altas del último mes, ingresos anuales por tarjetas, tasa de renovación y penetración en pacientes activos
Titulares	Una fila por titular: fecha de alta, vencimiento, personas cubiertas, estado (activa, vencida o baja), importe, teléfono y notas
Seguimiento	Mes a mes: altas, renovaciones, bajas, activas a fin de mes, vencimientos e ingresos
Cálculo de valor	Precios reales de cada servicio incluido frente a los 95 €, para obtener el ahorro real del paciente

El marco legal

Antes de comercializarlo

El contrato de adhesión es una plantilla base, no un contrato definitivo: debe revisarlo y validarlo un asesor jurídico.

Ha de verificarse su adecuación a la normativa de protección de datos, defensa de consumidores y usuarios, condiciones generales de la contratación y normativa sanitaria. Los importes, límites y coberturas deben coincidir exactamente con lo que la clínica decida ofrecer.

PUNTO ABIERTO

CLÁUSULA	QUÉ ESTABLECE
Objeto	Programa de fidelización y cuidado de la salud bucodental. No es un seguro : son servicios y ventajas prestados directamente por la clínica
Beneficiarios	El titular y hasta tres personas más designadas por él, hasta un total de cuatro. El titular es el único responsable del pago y el interlocutor
Precio y pago	95 € anuales por unidad familiar, impuestos incluidos, por adelantado en el momento del alta
Duración y renovación	Doce meses. La renovación no es automática : la clínica avisa antes del vencimiento y el titular decide. Sin permanencia ni penalización
Servicios y límites	Los del catálogo, personales, prestados solo en las instalaciones de la clínica, no canjeables por dinero ni transferibles
Exclusiones	Los tratamientos no listados, que se benefician del descuento correspondiente, y los servicios de terceros ajenos a la clínica
Desistimiento	Catorce días naturales desde el alta, sin justificación, descontando el valor de los servicios ya disfrutados según tarifa
Modificación	Solo para futuras renovaciones y con antelación suficiente: las condiciones del periodo en curso no se ven afectadas

El expediente se compone de **tres piezas**: el contrato de adhesión que firma el titular, la cláusula de protección de datos con sus consentimientos —gestión del programa, comunicaciones comerciales y declaración de contar con el consentimiento de los beneficiarios designados— y la **información precontractual** que se entrega antes de firmar, de la que se conserva constancia. Recepción verifica que el paciente ha podido leerla y resolver sus dudas antes de contratar.

Checklist de arranque

☐ Precio, límites y descuentos cerrados por Dirección

- ☐ Encaje legal resuelto: contrato de adhesión, RGPD e información precontractual
- ☐ Material de apoyo listo: folleto, cartel, ficha de alta y cálculo de ahorro
- ☐ Equipo formado y con el speech practicado
- ☐ Responsable operativo asignado
- ☐ Objetivo y sistema de medición definidos
- ☐ Mensajes a la cartera preparados y segmentados

Dónde encaja en el sistema

ATC es el instrumento que hace verdad la segunda mitad de la promesa: «le cuidamos para siempre».

El **posicionamiento** fija el resultado —la sonrisa completa—; ATC sostiene la relación. Se ofrece en la **Fase 10** al cerrar el tratamiento, se activa en la **Fase 11** con su contrato, y se vive en la **Fase 14**, donde el programa de mantenimiento lo convierte en visitas reales.

Anexos

Lo que hay que tener a mano

Tres listas de trabajo: qué puede publicarse y con qué trámite, qué acción sostiene qué campaña, y qué se activa este trimestre.

ANEXO A

Semáforo legal por acción

El reparto completo del catálogo según el marco del apartado 4. La regla de gobierno es una sola: **ninguna acción naranja se activa sin que conste por escrito quién la revisó y cuándo.**

REVISIÓN PREVIA 11 acciones

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ HAY QUE RESOLVER ANTES
A03	Convenio con colegios: salud bucodental infantil, sin ninguna captación comercial dentro del aula	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A20	WhatsApp de centro con norma publicada: aquí no se diagnostica por foto	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A23	Solicitud sistemática de reseña a todo paciente al alta, nunca incentivada y nunca filtrada	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A24	Respuesta pública a toda reseña, y en veinticuatro horas a la negativa	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A30	Casos reales contados por el clínico, con consentimiento expreso y sin promesa de resultado	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A33	Financiación con coste total visible y sin comisión para quien la ofrece	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A50	El Archivo de tu Boca: su historia clínica, imágenes y plan, en formato que se lleva aunque se marche	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A51	Fotografía clínica normalizada para el archivo del paciente, no para el escaparate	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A68	Red de derivación con médicos de familia, odontólogos generalistas y protésicos	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A71	Informe clínico para continuar fuera, dirigido al propio paciente	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo
A72	Protocolo de urgencia a distancia y qué llevarse al volver a marchar	Consentimiento expreso o verificación jurídica previa, con constancia escrita de quién revisó y cuándo

REVISAR CONTENIDO 29 acciones

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ HAY QUE RESOLVER ANTES
A02	Programa en residencias de mayores: revisión anual en el propio centro, con informe a la familia	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A04	Ciclo abierto «lo que nadie le cuenta de los implantes», en el propio centro, con turno de preguntas	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A05	Material informativo en farmacias de barrio, sin promesa de resultado ni oferta	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A06	Contenido que responde a las preguntas que la gente hace de verdad, no a las que nos gustaría que hiciera	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ HAY QUE RESOLVER ANTES
A09	Presencia en medios locales como fuente experta, no como anunciante	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A11	Programa de salud bucodental para empresas del polígono, del termalismo y de la administración	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A14	Web construida sobre preguntas reales, con la respuesta firmada por quien la sostiene	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A15	Página por tratamiento con precio de partida publicado y qué incluye	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A17	Búsqueda de pago acotada a intención alta y a radio corto, con tope mensual duro	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A25	Segunda Opinión Honesta: informe escrito que el paciente se lleva, diga lo que diga	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A26	Publicación anual del índice de «no necesita tratamiento» sobre las segundas opiniones	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A27	Consulta del Miedo: primera visita para quien lleva más de diez años sin ir, sin propuesta de tratamiento ese día	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A28	Presupuesto sin prisa: sin caducidad comercial, con la consecuencia clínica de esperar seis, doce y veinticuatro meses	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A32	Comparativa honesta con tratarse fuera: coste total incluyendo revisiones, garantía y quién responde si falla	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A34	Tabla de garantías publicada por tipo de tratamiento, entregada con cada presupuesto	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A37	El Acompañante: silla, nombre, y copia del plan también para él	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A56	Política de devolución en supuestos tasados, resuelta sin discusión y sin abogado	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A57	Alma Te Cuida: programa anual de mantenimiento, revisión y prioridad de agenda	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A59	Revisión sistemática que evita la cirugía: se llama por criterio clínico, no por calendario comercial	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A60	El Día de los que no Volvieron: una jornada al año para reabrir planes abandonados, sin presión y sin oferta	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A61	Rescate del paciente dormido por antigüedad y por riesgo clínico, en ese orden	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A63	Aviso de mantenimiento por tipo de prótesis y fecha de colocación	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A65	Recuperación del producto pendiente heredado: caja ya cobrada que hay que convertir en producción	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A66	Contacto anual con el paciente sin tratamiento activo, con algo útil y sin oferta	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A67	Prescripción de pacientes: se pide de frente, se agradece siempre y no se paga nunca	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A69	Acuerdo con asociaciones de emigrantes y concellos: diagnóstico y plan en la primera estancia	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ HAY QUE RESOLVER ANTES
A70	Campaña del Retorno: ventana de tratamiento ajustada al calendario real de las estancias	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A73	Convenio con residencias y servicios de ayuda en el hogar	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado
A75	Acuerdo con empresas: revisión anual como retribución en especie para la plantilla	Revisión del contenido: una frase de más lo convierte en promesa de resultado

SIN TRÁMITE

36 acciones

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ HAY QUE RESOLVER ANTES
A01	Aula da Boca: charla mensual en asociaciones vecinales, centros culturales y clubes de la ciudad	Nada. Se ejecuta sin trámite
A07	Recorrido en vídeo por la clínica, sin pacientes y sin música de anuncio	Nada. Se ejecuta sin trámite
A08	Prótesis a la vista: jornada de puertas abiertas al laboratorio y al flujo digital	Nada. Se ejecuta sin trámite
A10	Patrocinio deportivo de base con contrapartida sanitaria: revisión al equipo, no logotipo en la camiseta	Nada. Se ejecuta sin trámite
A12	Señalética y fachada legibles desde la calle, con el número de registro sanitario visible	Nada. Se ejecuta sin trámite
A13	Ficha de negocio completa: horarios reales, fotos propias, servicios y accesibilidad	Nada. Se ejecuta sin trámite
A16	Página por localidad de la provincia con el tiempo real de desplazamiento y dónde aparcar	Nada. Se ejecuta sin trámite
A18	Respuesta en menos de quince minutos en horario; fuera de él, respuesta automática que dice la verdad sobre cuándo se le contestará	Nada. Se ejecuta sin trámite
A19	Cita en línea con hueco real, no formulario de contacto	Nada. Se ejecuta sin trámite
A21	Teléfono contestado por persona durante todo el horario, con registro de llamadas perdidas	Nada. Se ejecuta sin trámite
A22	Recuperación de toda llamada perdida antes de dos horas, sin excepción	Nada. Se ejecuta sin trámite
A29	Explicación de qué se paga: material, tiempo clínico, laboratorio, garantía y revisión	Nada. Se ejecuta sin trámite
A31	Visita previa de cinco minutos para ver la clínica y conocer al equipo, sin sillón	Nada. Se ejecuta sin trámite
A35	Recordatorio de cita que cuenta lo que va a pasar, cuánto dura y qué traer	Nada. Se ejecuta sin trámite
A36	Acogida en noventa segundos, por su nombre y sin mostrador de por medio	Nada. Se ejecuta sin trámite
A38	Sala de espera sin televisión comercial ni publicidad de tratamiento	Nada. Se ejecuta sin trámite
A39	Explicación con el modelo y la imagen en la mano, no con folleto	Nada. Se ejecuta sin trámite
A40	Entrega del plan por escrito el mismo día, siempre, también cuando el plan es no hacer nada	Nada. Se ejecuta sin trámite
A41	Nada se cierra el día del miedo: por norma se le invita a pensarlo	Nada. Se ejecuta sin trámite
A42	Registro literal de lo que dijo que le preocupaba, en su ficha y en sus palabras	Nada. Se ejecuta sin trámite
A43	Encuesta de una sola pregunta al salir, contestada de pie y en diez segundos	Nada. Se ejecuta sin trámite
A44	Hueco útil: la cancelación se ofrece por orden clínico a quien espera, no por orden de importe	Nada. Se ejecuta sin trámite
A45	Información real de aparcamiento, bus y accesibilidad, publicada y comprobada	Nada. Se ejecuta sin trámite
A46	Atención en gallego y apoyo de traducción para quien lo necesite	Nada. Se ejecuta sin trámite
A47	Llamada del propio clínico veinticuatro horas después de cualquier cirugía	Nada. Se ejecuta sin trámite

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ HAY QUE RESOLVER ANTES
A48	Vía directa para cuando algo va mal, con nombre, número y plazo de respuesta comprometido	Nada. Se ejecuta sin trámite
A49	Informe de progreso a mitad de tratamiento, con lo hecho y lo que queda	Nada. Se ejecuta sin trámite
A52	Acompañamiento pactado paso a paso para el paciente con miedo, con señal de parada acordada	Nada. Se ejecuta sin trámite
A53	Aviso antes de ejecutar cualquier cambio de coste sobre el plan aprobado	Nada. Se ejecuta sin trámite
A54	Documento de alta con lo conseguido y lo que toca a partir de ahora	Nada. Se ejecuta sin trámite
A55	Encuesta de experiencia al alta con una pregunta abierta que alguien lee	Nada. Se ejecuta sin trámite
A58	La Carta del Tercer Año: se escribe para confirmar que aquello sigue funcionando, no para vender nada	Nada. Se ejecuta sin trámite
A62	Entrevista de salida al paciente que se va, sin ningún intento de retenerle	Nada. Se ejecuta sin trámite
A64	Cadencia de higiene profesional según riesgo individual, no según calendario comercial	Nada. Se ejecuta sin trámite
A74	Alianza con clubes deportivos: férulas de protección y revisión de temporada	Nada. Se ejecuta sin trámite
A76	Presencia como docente en colegio profesional y formación de posgrado	Nada. Se ejecuta sin trámite

Lo que dice el reparto

Casi la mitad del catálogo se ejecuta sin ningún trámite, y ahí están las acciones que más aportan: el tránsito al programa de cuidado, la revisión que evita la cirugía, la respuesta al teléfono, la acogida, el plan por escrito el mismo día. El bloque que exige revisión previa son once acciones —las que tocan imagen clínica, datos de salud o informes a terceros—, y ninguna de ellas está en el camino crítico del ejercicio.

Dicho de otro modo: **el marco legal no es lo que frena este plan**. Lo que lo frena, si algo lo frena, es la disciplina de sostener las ocho normas del apartado 3 el trimestre que venga flojo.

ANEXO B

Correspondencia con la cartera de campañas

Qué acciones de este catálogo sostienen cada una de las nueve campañas de la Parte VI del Plan de Dirección. Sirve para lo contrario de lo que parece: para ver **qué campaña se queda sin suelo** si una acción no se ejecuta.

CÓD.	CAMPAÑA	APORTE	ACCIONES QUE LA SOSTIENEN	Nº
C1	Alma Te Cuida	171 k€	A47 · A50 · A54 · A57 · A58	5
C2	«Su caso no es imposible»	71 k€	A30	1
C3	«Volvemos a llamarle»	13 k€	A60 · A61	2
C4	Red de derivación	44 k€	A68	1
C5	«Sin miedo»	25 k€	A27 · A31 · A41 · A52	4
C6	«La revisión que evita la cirugía»	172 k€	A59 · A63 · A64	3
C7	«Segunda opinión, sin compromiso»	20 k€	A25 · A26 · A32	3
C8	Prescripción de pacientes	35 k€	A37 · A67	2
C9	Presencia digital y reseñas	−4 k€	A06 · A07 · A13 · A14 · A15 · A16 · A17 · A23 · A24	9
—	Fuera de la cartera El fondo del que salen las campañas de los ejercicios siguientes, incluida la Campaña del Retorno	sin aporte declarado	46 acciones	46

Lo que esta tabla hace visible

Una campaña no es una idea publicitaria: es un conjunto de acciones concretas con dueño. Si las acciones de una fila no se ejecutan, la cifra de aporte de esa campaña — que la Junta ya ha aprobado— deja de tener respaldo. **La concentración vuelve a aparecer aquí:** C1 y C6 son el 63 % de lo que aporta la cartera y se apoyan en muy pocas acciones, casi todas de banda cero. Son baratas de hacer y baratas de dejar de hacer, y eso segundo es el riesgo.

ANEXO C

Lo que se activa este trimestre

Las acciones de coste cero y plazo inmediato, que son las que arrancan en T1. No necesitan presupuesto, ni obra, ni contratar a nadie: necesitan que alguien firme que a partir del lunes se trabaja así.

Dirección General ■ 3

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ GANA EL PACIENTE	INDICADOR
A24	Respuesta pública a toda reseña, y en veinticuatro horas a la negativa	Ve cómo tratamos a quien se queja, que es el único dato fiable	Reseñas negativas con respuesta y su plazo
A34	Tabla de garantías publicada por tipo de tratamiento, entregada con cada presupuesto	Sabe por escrito qué pasa si algo falla dentro de cinco años	Presupuestos entregados con tabla adjunta
A41	Nada se cierra el día del miedo: por norma se le invita a pensarlo	Nadie le arranca un sí el día que llegó asustado	Aceptaciones diferidas sobre el total

Gerencia ■ 2

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ GANA EL PACIENTE	INDICADOR
A33	Financiación con coste total visible y sin comisión para quien la ofrece	Nadie gana nada por empujarle a financiar	Financiaciones y tasa de impago
A53	Aviso antes de ejecutar cualquier cambio de coste sobre el plan aprobado	Nunca le llega una factura que no esperaba	Desviaciones comunicadas antes de ejecutar

Recepción ■ 10

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ GANA EL PACIENTE	INDICADOR
A13	Ficha de negocio completa: horarios reales, fotos propias, servicios y accesibilidad	No se planta en la puerta un día que está cerrado	Impresiones, llamadas y cómo llegar
A18	Respuesta en menos de quince minutos en horario; fuera de él, respuesta automática que dice la verdad sobre cuándo se le contestará	No se queda esperando sin saber si alguien le ha leído	Tiempo hasta primera respuesta, mediana y p90
A20	WhatsApp de centro con norma publicada: aquí no se diagnostica por foto	No recibe un diagnóstico falso por una foto mal hecha	Consultas resueltas y derivadas a visita
A22	Recuperación de toda llamada perdida antes de dos horas, sin excepción	Le devuelven la llamada aunque él ya se haya rendido	Llamadas perdidas recuperadas
A31	Visita previa de cinco minutos para ver la clínica y conocer al equipo, sin sillón	Conoce el sitio sin comprometerse a nada	Visitas previas y su conversión
A35	Recordatorio de cita que cuenta lo que va a pasar, cuánto dura y qué traer	Llega sabiendo a qué viene y no en ayunas por si acaso	Ausencias sin avisar
A36	Acogida en noventa segundos, por su nombre y sin mostrador de por medio	Le reciben como a una persona esperada, no como a un turno	Cumplimiento observado de la Fase 1
A37	El Acompañante: silla, nombre, y copia del plan también para él	Quien viene con él entiende lo mismo y puede ayudarlo a decidir en casa	Planes entregados por duplicado
A43	Encuesta de una sola pregunta al salir, contestada de pie y en diez segundos	Le preguntan cuando aún se acuerda	Respuestas y su serie mensual

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ GANA EL PACIENTE	INDICADOR
A45	Información real de aparcamiento, bus y accesibilidad, publicada y comprobada	Sabe dónde dejar el coche y si entra con silla de ruedas	Incidencias de acceso registradas

RAC ■ 2

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ GANA EL PACIENTE	INDICADOR
A23	Solicitud sistemática de reseña a todo paciente al alta, nunca incentivada y nunca filtrada	Lee opiniones que no están compradas	Reseñas nuevas al mes y nota media
A42	Registro literal de lo que dijo que le preocupaba, en su ficha y en sus palabras	La próxima vez alguien se acuerda de lo que le importaba	Fichas con preocupación registrada

Doctor ■ 5

CÓD.	ACCIÓN	QUÉ GANA EL PACIENTE	INDICADOR
A28	Presupuesto sin prisa: sin caducidad comercial, con la consecuencia clínica de esperar seis, doce y veinticuatro meses	Decide con información en vez de con urgencia inventada	Tasa de aceptación y días hasta aceptar
A40	Entrega del plan por escrito el mismo día, siempre, también cuando el plan es no hacer nada	Sale con papel. Siempre	Planes entregados el mismo día sobre visitas
A47	Llamada del propio clínico veinticuatro horas después de cualquier cirugía	Le llama quien le operó, no un número desconocido	Llamadas hechas sobre cirugías
A52	Acompañamiento pactado paso a paso para el paciente con miedo, con señal de parada acordada	Puede parar la intervención con una señal, y se respeta	Pacientes en circuito de miedo y abandonos
A54	Documento de alta con lo conseguido y lo que toca a partir de ahora	Sabe qué pasa el año que viene y el siguiente	Altas con documento entregado

Cómo se pone en marcha

Cada puesto recibe la lista de las acciones de las que es dueño, con su indicador al lado, y la firma. No es burocracia: es la diferencia entre una norma que existe y una norma que se cumple. Es el mismo mecanismo con el que el Manual Maestro pone en marcha sus catorce fases, y funciona por el mismo motivo — **un estándar que no puede comprobarse en una lista es una intención.**

CIERRE

Qué se pide con este plan

Tres cosas, y ninguna es dinero

Una. Aprobar las ocho normas del apartado 3 como norma de centro, con la consecuencia de que se sostienen el trimestre que venga flojo. **Dos.** Aprobar la norma de no cerrar el día del miedo, sabiendo que cuesta cierres de este trimestre. **Tres.** Autorizar la prueba acotada de la Campaña del Retorno, para poder presentarla como C10 el ejercicio que viene con su aritmética hecha.

Este plan no pide un euro que no esté ya aprobado en la Parte VI del Plan de Dirección. Lo que pide es más difícil de conceder que un presupuesto: pide aceptar que durante los dos primeros trimestres algunos números van a empeorar —la aceptación en el día de la visita, desde luego— porque estamos dejando de cerrar casos que no deberíamos haber cerrado nunca.

La apuesta está declarada en el apartado 8 y es comprobable: si a los cuatro trimestres la conversión no ha mejorado y la prescripción no ha crecido, la doctrina de este documento estaba equivocada y hay que decirlo en Junta con las ocho medidas encima de la mesa. Un plan que no puede fallar tampoco puede acertar.

No medias sonrisas. Tampoco medias verdades sobre lo que una sonrisa cuesta, cuánto dura y qué pasa si falla.

Centro de Excelencia Implantológica Alma

Plan Maestro de Marketing

Documento de uso interno y confidencial. Contiene información económica y estratégica. No se difunde fuera del órgano de gobierno sin autorización expresa de la Dirección General.

Versión

v32.0 · Septiembre 2026
Revisión trimestral

Documentos de referencia

Plan de Dirección v32.0
Manual Maestro v32.0
Protocolo de Primera Visita v32.0
Otros documentos del sistema v32.0

Plan de Dirección

Manual Maestro

Protocolo de Primera Visita

Otros documentos

Documento único troncal · Uso interno · Confidencial

Manual Maestro de Operaciones

Centro de Excelencia Implantológica Alma. El recorrido del paciente, los manuales de puesto, las funciones de vanguardia, los indicadores y la puesta en marcha, en un solo cuerpo.

Ourense · Versión 32.0 · Edición integrada · Agosto 2026.
Versión única de todo el sistema documental: los ocho documentos comparten número y fecha, para que ninguno pueda quedar desfasado respecto de otro sin que se note.
Es la referencia única para **formación, operación y auditoría**.

Fases del recorrido 14 De la primera llamada al mantenimiento a largo plazo	Primera visita 115–120' Suma real de las fases 2 a 11; varía según el caso
Puestos 6 Recepción · Doctor · Higienista · Auxiliar · RAC · Dirección	Partes 8 Más estándares transversales y anexos
Procedimientos 26 Numerados por puesto (PR-XX)	Anexos 13 Plantillas, checklists, reportes, auditoría, escalado y glosario

PRESENTACIÓN

Un documento, tres usos

Este Manual Maestro reúne en un solo cuerpo todo el sistema operativo del centro: el recorrido completo del paciente, los manuales de cada puesto, la matriz de responsabilidades y el protocolo de puesta en marcha.

Uso 01

Material de formación

Quien se incorpora entiende no solo qué hace, sino por qué lo hace y qué palabras exactas emplear.

Uso 02

Manual de operación

Cada procedimiento, paso a paso, con sus checklists y sus reglas innegociables.

Uso 03

Herramienta de auditoría

Fija los indicadores con los que se mide cada fase y cada puesto, de modo que la calidad no dependa de quién esté de turno.

Cómo está organizado

- **Marco de vanguardia.** El principio que gobierna todos los protocolos: la antelación sistematizada.
- **Parte I — Fundamentos.** Ficha de control, principios rectores, glosario de roles, sistemas y puntos abiertos.
- **Parte II — El recorrido del paciente.** Las catorce fases, desde la primera llamada hasta el mantenimiento a largo plazo, con guiones, KPI, errores y checklists.
- **Parte III — Matriz RACI.** Quién es responsable, quién rinde cuentas, quién es consultado y quién informado en cada fase.
- **Parte IV — Manuales por puesto.** Recepción, Doctor, Higienista, Auxiliar, RAC y Dirección, cada uno con misión, jornada, procedimientos, guiones e indicadores.
- **Parte V — Funciones de vanguardia por perfil.** El detalle operativo de cada función: circuito, reglas innegociables, límites e indicadores.
- **Parte VI — Interdependencias e indicadores.** Compras y proveedores, matriz de interdependencias y cuadro maestro de indicadores.

- **Parte VII — Plan de incentivos.** Cómo se convierten los indicadores en retribución variable.
- **Parte VIII — Puesta en marcha.** Las 72 horas previas y la mañana del día 1 en un centro recién adquirido.
- **Anexos.** Plantillas de reporte, checklists imprimibles y calendario de implantación.

Cómo leerlo

Nadie necesita leerlo entero de una vez. Cada persona empieza por su manual de puesto (Parte IV) y por las fases del recorrido en las que interviene (Parte II). La Dirección lo usa completo. Todo el equipo comparte el marco de vanguardia y los principios rectores: son el suelo común sobre el que se apoya todo lo demás.

Qué contiene

Cronología minuto a minuto y qué percibe el paciente en cada fase, guiones contrastados de qué decir y qué evitar, casos especiales y contingencias, checklists operativos marcables, campos exactos de registro en Clinic Cloud, contingencias y plan de incorporación de treinta días para cada puesto, los estándares transversales —comunicación, seguridad clínica, emergencias, protección de datos y continuidad del centro—, seis diagramas de los circuitos, los anexos y un apartado de puntos abiertos con lo que Dirección tiene todavía que resolver.

ÍNDICE

Dónde está cada cosa

Cada persona empieza por su manual de puesto y por las fases en las que interviene. La Dirección lo usa completo.

BLOQUE	CONTENIDO	A QUIÉN LE CORRESPONDE
Marco de vanguardia	Antelación sistematizada, tres horizontes y cinco pilares	Todo el equipo
I · Fundamentos	Ficha de control, nueve principios, glosario, sistemas y puntos abiertos	Todo el equipo
I bis · Estándares transversales	Comunicación, seguridad clínica, emergencias, datos y continuidad	Todo el equipo
II · Recorrido	Las catorce fases, de la llamada al mantenimiento	Según la fase
III · Matriz RACI	Quién ejecuta, quién responde, a quién se consulta y a quién se informa	Dirección y responsables
IV · Manuales por puesto	Misión, jornada, procedimientos, contingencias e incorporación	Cada perfil, el suyo
V · Funciones de vanguardia	Circuitos, reglas innegociables, límites e indicadores	Cada perfil, el suyo
VI · Interdependencias	Compras, matriz de interdependencias y cuadro maestro de indicadores	Dirección
VII · Plan de incentivos	Arquitectura, escala, pesos, fórmula y gobernanza	Todo el equipo
VIII · Puesta en marcha	Las 72 horas previas y la mañana del día 1	Gerencia y Dirección
Anexos	Plantillas, checklists imprimibles y consolidados, mapa de documentos, auditoría, sistema de reportes y glosario	Todo el equipo
Otros documentos del sistema	Índice de los catorce documentos que rodean a este manual, desarrollados en documento propio : compendio, verificación de 322 puntos, auditoría, decisiones de gerencia, programa de 100 días, dossier de 30 días, protocolos por perfil, innovación y plan de marca	Dirección y Gerencia
Puntos abiertos	Lo que todavía no está cerrado y cómo se opera mientras tanto	Dirección

MARCO DE VANGUARDIA

El principio que gobierna todos los protocolos

Principio rector

La vanguardia es antelación sistematizada. Ninguna función se ejecuta en el momento en que se necesita: todas se preparan con antelación calculada.

Un centro reacciona o dirige según cuándo hace las cosas. El que prepara el día anterior, verifica antes de agendar y anticipa el material de una cirugía con una semana de margen, trabaja sin sobresaltos. El que resuelve todo en el último momento vive en la urgencia permanente y comete errores caros. Todo este manual está construido sobre esa diferencia.

Los tres horizontes

Todo perfil trabaja simultáneamente en tres marcos temporales. Un profesional que solo trabaja en el «hoy» reacciona; uno que trabaja en los tres, dirige su función.

HORIZONTE	QUÉ SE HACE EN ÉL	CÓMO SE COMPRUEBA	AMPLIACIÓN
HOY	Ejecución de lo que se preparó ayer.	Al abrir, todo lo del día está ya verificado: agenda, casos, material y equipos	
MAÑANA	Preparación de la jornada siguiente.	Al cerrar, nadie se va sin dejar preparado el día siguiente de su función	
7–21 DÍAS	Anticipación de necesidades futuras (material, casos complejos, campañas).	Revisión semanal de stock y de casos contra la agenda de las próximas tres semanas	

Los cinco pilares transversales

Cinco principios se aplican en todos los perfiles, sin excepción. Son el estándar de calidad común del centro.

PILAR	APLICACIÓN EN TODOS LOS PERFILES	SEÑAL DE QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO	AMPLIACIÓN
Anticipación	Nada se resuelve en el último momento.	Llamadas urgentes a proveedores; casos que se estudian con el paciente sentado	
Trazabilidad	Todo se registra en el momento, no al final del día.	Documentación pendiente de subir al cerrar; registros escritos de memoria	

PILAR	APLICACIÓN EN TODOS LOS PERFILES	SEÑAL DE QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO	AMPLIACIÓN
Verificación cruzada	Ninguna decisión crítica depende de una sola persona.	Cirugías agendadas sin confirmar material; presupuestos sin solicitud firmada	
Estandarización	El resultado no depende de quién esté de turno.	Dos profesionales del mismo puesto dan experiencias distintas al paciente	
Medición	Cada función tiene indicador y se reporta.	Reuniones basadas en impresiones y no en datos del sistema	

Estructura común de los manuales de puesto

Para que sean fáciles de consultar, todos los manuales de la Parte IV siguen el mismo orden: misión y ámbito; cronograma de jornada; procedimientos numerados (PR-XX); guiones literales; checklists operativos; protocolos de contingencia; criterios de calidad; indicadores y reportes; y errores documentados. Quien conoce la estructura de un puesto sabe dónde buscar en cualquier otro.



Fundamentos

Ficha de control, principios rectores, glosario, sistemas y puntos abiertos.

1 · Ficha de control del documento

CAMPO	DETALLE
Versión	v32.0 · Agosto 2026
Denominación comercial	Centro de Excelencia Implantológica Alma (uso abreviado: Alma)
Software de gestión clínica	Clinic Cloud (agenda, fichas, historia clínica, presupuestos, documentación, portal del paciente)
Software complementario	Smartee (Smartee Doctor) y/o Spark Approver — planificación e informes de ortodoncia. WeDiagnostix — prediagnóstico IA opcional sobre OPG.
Sustituye a	Protocolo v32.0, manuales de puesto sueltos y manual de puesta en marcha por separado
Propietario del documento	Dirección de Centros / Dirección Comercial
Difusión obligatoria	Recepción, Dirección de Clínica, Odontólogos, Higienistas, Auxiliares, RAC
Revisión	Semestral, o ante cualquier incidencia grave de trazabilidad o RGPD
Duración del recorrido	115–120 minutos (Fases 2–11) para la primera visita, según la complejidad del caso a valorar; Fase 1 previa, Fase 12 seguimiento, Fase 13 producción, Fase 14 mantenimiento

2 · Principios rectores del protocolo

Nueve principios rigen todas las decisiones del recorrido. Cuando una situación no está prevista, se resuelve preguntándose cuál de estos principios aplica.

#	PRINCIPIO	QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA	CÓMO SE COMPRUEBA	AMPLIACIÓN
1	Excelencia técnica visible	La tecnología se muestra, no se menciona.	Todo paciente ha visto la sala de imagen antes de la Fase 5	
2	Transparencia informada	Todo consentimiento se obtiene con comprensión real, no como mero trámite firmado.	En la historia consta que la comprensión fue verificada	
3	Personalización	Cada fase construye sobre la información recogida en la anterior; nada se repite ni se improvisa.	Ninguna pregunta se hace dos veces al paciente	
4	Trazabilidad documental total	Si no está en Clinic Cloud y escaneado, no ha ocurrido.	Cero documentos pendientes de subir al cierre	
5	Ética comercial	Se guía hacia la decisión, no se presiona; toda objeción se resuelve con información, no con urgencia artificial.	Ninguna oferta con caducidad inventada; motivo real de no conversión registrado	
6	Continuidad de confort	El paciente regresa a la Sala VIP entre pruebas y análisis; nunca espera sin explicación.	Ningún paciente espera en sala general durante la PV	

#	PRINCIPIO	QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA	CÓMO SE COMPRUEBA	AMPLIACIÓN
7	Lo vendido se entrega rápido	El circuito de producción (Fase 13, RAC) evita que un presupuesto aceptado tarde en ejecutarse.	Producto pendiente con tendencia descendente	
8	Ninguna tarea de back-office bloquea al paciente	El alta en Clinic Cloud (Fase 3) se completa en paralelo mientras el paciente avanza.	El alta está terminada antes de la Fase 9	
9	Corrección inmediata	Cualquier dato incorrecto se corrige en el momento con el paciente presente, nunca después de memoria.	Sin correcciones «pendientes» en la ficha al cierre	

3 · Glosario de roles

ROL	ABREV.	FUNCIÓN
Recepción	REC	Primer y último contacto; alta en Clinic Cloud; custodia documental y agenda
Director de Clínica	DC	Anamnesis inicial, RGPD, briefing, presentación, cierre económico
Odontólogo / Doctor	DR	Autoridad clínica única; diagnóstico, consentimiento, IAC
Higienista	HIG	Mantenimiento, prevención, seguimiento periimplantario
Auxiliar	AUX	Pruebas diagnósticas, carga de imágenes, esterilización, material
Director de Centros	DdC	Supervisión multi-clínica, KPIs agregados, escalado
RAC	RAC	Ejecución real de tratamientos: pago, material, producto pendiente (Fase 13)

4 · Sistemas y herramientas

El centro opera sobre un núcleo de herramientas que hay que conocer:

Clinic Cloud Sistema central: agenda, ficha del paciente, historia clínica, presupuestos, documentación escaneada y portal del paciente. La regla es absoluta: si algo no está aquí, no ha ocurrido.
Smartee Doctor / Spark Approver Planificación e informes de ortodoncia, que se adjuntan al IAC cuando el caso lo requiere.
WeDiagnostix Prediagnóstico asistido por IA sobre la OPG. Es apoyo opcional al criterio clínico, nunca sustituto del diagnóstico profesional.

4 ante · El posicionamiento del centro: «No medias sonrisas»

POSICIONAMIENTO

El criterio que está por encima de este manual

«No medias sonrisas.» Si algo deja al paciente a medias, no es la manera Alma de hacer las cosas.

Una media sonrisa es un tratamiento a medias, una solución provisional que se eterniza, un paciente al que se le resuelve solo una parte del problema. La promesa es la contraria: rehabilitación integral, definitiva y mínimamente invasiva, en el menor tiempo posible —idealmente en un solo día—. Cuando un paciente sale de aquí, sale con la boca resuelta, no con una etapa cumplida.

El objetivo del centro es ser **referencia mundial en implantología y rehabilitación compleja mínimamente invasiva resuelta en un día**. Eso ordena cada inversión, cada contratación, cada protocolo y cada campaña: todo lo que se hace se pregunta si acerca o aparta de esa referencia. La filosofía se inspira en «*No Half Smiles*», del Dr. Miguel Stanley (White Clinic, Lisboa), cuyo origen se reconoce expresamente.

PILAR	LA PROMESA	LA PRUEBA TANGIBLE
Un solo día	Rehabilitación fija en veinticuatro horas	Cirugía guiada y carga inmediata como estándar
Mínima invasión	La menor agresión posible	Planificación digital, guía quirúrgica, menos cirugía
Diagnóstico total	Ver lo que otros no ven	CBCT 3D, escáner y planificación protésicamente guiada
Predecibilidad	El resultado se planifica antes de operar	Simulación digital del resultado final
Cuidado de por vida	La relación no termina con la cirugía	El programa de mantenimiento de la Fase 14

La distinción que hay que tener clara al presentar un plan

El **fraccionamiento económico** —pagar por fases— es legítimo y bueno. Lo que el posicionamiento prohíbe es el **fraccionamiento del alcance**: dejar el caso clínicamente a medias. Se puede pagar por partes; no se puede quedar a medias. Por eso el producto pendiente que persigue el **círculo de producción** no es solo un problema de caja: son medias sonrisas sin cerrar.

Desarrollo completo —manifiesto, origen, los cinco pilares, qué significa para cada puesto y en cada fase, y cómo se comunica dentro y fuera— en **Otros · «No medias sonrisas»**.

4 ante bis · ATC · Alma Te Cuida, la otra mitad de la promesa

ALMA TE CUIDA

La promesa completa

«Le devolvemos su sonrisa completa, en el menor tiempo posible, y le cuidamos para siempre.»

La primera mitad es el **resultado** y la fija «No medias sonrisas». La segunda es la **relación**, y su instrumento concreto es **ATC · Alma Te Cuida**: la tarjeta de cuidado anual que convierte el «le cuidamos» en revisiones reales, urgencias atendidas y seguimiento del tratamiento.

Por eso ATC no es un producto que se vende aparte: es **parte del cierre de cualquier tratamiento**. Un tratamiento aceptado sin seguimiento es media promesa, y un implante sin mantenimiento es exactamente lo que el posicionamiento no acepta. Se ofrece a todos los pacientes, siempre, sin prejuzgar quién lo querrá, y su indicador principal no es cuántas tarjetas se activan, sino **a cuántos pacientes se les ofreció**.

MOMENTO	QUIÉN LO OFRECE	CON QUÉ ARGUMENTO
Al cerrar la primera visita	Director o Recepción	El ahorro: solo la limpieza y las revisiones del año ya cubren el precio
Justo tras aceptar un tratamiento	Director	La protección de la inversión: incluye seguimiento, mantenimiento y garantía
En una limpieza o revisión	Higienista	Lo que viene a hacerse hoy ya iría incluido
En la salida y en caja	Recepción	Red de seguridad: nadie se va sin que se le haya ofrecido al menos una vez

Programa completo —qué incluye, los cuatro argumentos, el speech por situación, el manejo de objeciones, la campaña sobre la cartera, la medición y el marco legal— en **Otros · ATC · Alma Te Cuida**. Precio, límites, descuentos y validación jurídica del contrato son decisión de Gerencia y están pendientes de cerrar.

4 bis · La filosofía que gobierna todo: el tratamiento integral

PROTOCOLOS POR PERFIL

Qué significa

Diagnosticamos la boca completa. Proponemos el plan completo. Ejecutamos con el orden clínico correcto y sin dejar nada a medias.

Y su reverso, igual de importante: tratamiento integral *no* significa vender siempre el plan más grande. La indicación es clínica, no comercial.

Hacemos

- Diagnóstico completo, siempre
- Plan integral presentado, siempre
- Secuencia clínica correcta
- Resultado funcional y estético completo
- Seguimiento de por vida

No hacemos

- Mirar solo el diente que duele
- Presentar solo lo urgente y callar el resto
- Restaurar sobre un periodonto enfermo
- Dejar una rehabilitación a medio terminar
- Cobrar y desaparecer

PRINCIPIO	CÓMO SE APLICA
La indicación es clínica, no comercial	Se propone lo que el paciente necesita, no lo que más factura
El paciente decide	Se informa del plan completo y de las alternativas reales
Por fases es legítimo	Un plan integral ejecutado en etapas sigue siendo integral
Nunca se oculta información	El paciente conoce el cuadro completo aunque decida hacer solo una parte
Nunca se presiona	Se explica la consecuencia de no tratar, sin dramatizar

«No half smiles»

Ningún tratamiento estético o rehabilitador se deja a medias. Si se inicia una rehabilitación, se termina; si hay compromiso estético, el resultado es coherente en el conjunto; no se entregan resultados parciales como si fueran finales; y si el paciente interrumpe, queda documentado que el plan no está completo.

#	LA REGLA QUE SOSTIENE EL SISTEMA	RESPONSABLE
1	Todo paciente entra al circuito completo	Recepción
2	Se documenta la boca completa	Auxiliar
3	Se diagnostica integralmente, siempre	Doctor
4	Se presenta el plan completo, siempre	Director
5	Se ejecuta entero, no a medias	RAC

#	LA REGLA QUE SOSTIENE EL SISTEMA	RESPONSABLE
6	Se mantiene el resultado de por vida	Higienista

Un tratamiento integral no lo hace un profesional: lo hacen seis perfiles ejecutando cada uno su parte sin saltarse ninguna. Si uno solo emparcha, el sistema entero emparcha. Desarrollo completo en [Otros · Protocolos Operativos por Perfil](#).

5 · Puntos abiertos pendientes de confirmar

Cuestiones que la Dirección debe cerrar y que, hasta entonces, se operan según la última instrucción vigente.

#	PUNTO ABIERTO	ESTADO	QUÉ HACER MIENTRAS TANTO	AMPLIACIÓN
1	¿Spark Approver sigue en uso junto a, o en sustitución de, Smartee?	 PENDIENTE	Usar la herramienta con la que se planificó cada caso y anotarlo en el IAC	
2	Recordatorio pre-cita: ¿WhatsApp 48 h o SMS 24 h?	 RESUELTO	Dos recordatorios por WhatsApp: a 48 h y a 24 h de la cita	
3	Contenido definitivo del Kit de Bienvenida	 PENDIENTE DE DEFINIR	Entregar como mínimo guía del tratamiento, kit de higiene y tarjeta de contacto	
4	Reparto REC/DC en Fase 3	 RESUELTO	DC = anamnesis y RGPD · REC = alta en Clinic Cloud	
5	Definición y alcance de RAC	 RESUELTO	Ver Fase 13 y manual de RAC	



Estándares transversales AMPLIACIÓN

Lo que se cumple en las catorce fases y en los seis puestos. No pertenece a ninguna fase concreta porque rige en todas.

1 · Comunicación y trato

Lenguaje preferido

- «Su tratamiento», «su plan», «su informe»
- «Vamos a...», que incluye al paciente en la decisión
- «Lo que le proponemos», en lugar de «lo que hay que hacer»
- «¿Me he explicado bien?», en lugar de «¿lo ha entendido?»
- Nombre propio del paciente, y de usted salvo que él proponga otra cosa
- Cifras exactas: «doce semanas», «cuatro citas», «tres años de garantía»

Lenguaje que se evita

- «El caso», «la boca de las dos y media», «el implante de la 3»
- «Esto es carísimo, ya lo sé»: nadie desactiva su propio presupuesto
- «No se preocupe», sin explicar por qué no debe preocuparse
- «Le voy a ser sincero», que sugiere que antes no lo era
- Diminutivos clínicos: «una limpiécita», «un empastito»
- Jerga sin traducir: «vamos a ferulizar la 46 por distal»

- **Comunicación no verbal:** sentarse a la altura del paciente, mirarle al hablar y no a la pantalla, mascarilla retirada en las conversaciones de despacho
- **Confidencialidad:** ningún nombre, diagnóstico ni importe se pronuncia en recepción, pasillos ni sala de espera
- **Coherencia del equipo:** nadie contradice en público a un compañero; las discrepancias se resuelven fuera de la vista del paciente
- **Puntualidad informada:** todo retraso se comunica antes de que el paciente lo pregunte
- **Idioma:** se atiende en la lengua que el paciente elija entre las disponibles, y se registra cuál es
- **Una sola versión:** lo que se dice en la Fase 9 debe coincidir con el IAC, con el presupuesto y con lo que diga cualquier otro miembro del equipo

2 · Seguridad clínica

ÁMBITO	ESTÁNDAR DEL CENTRO	RESPONSABLE
Identificación del paciente	Verificación con dos datos antes de cualquier prueba, registro o intervención	Quien ejecuta
Alergias y alertas	Marcadas de forma visible en Clinic Cloud y revisadas al inicio de cada cita	Doctor
Esterilización	Circuito unidireccional, control de ciclos con registro y trazabilidad por paciente	Auxiliar

ÁMBITO	ESTÁNDAR DEL CENTRO	RESPONSABLE
Protección radiológica	Justificación de cada prueba, dosis mínima razonablemente alcanzable y consentimiento previo	Doctor
Checklist quirúrgico	Completo y firmado; sin él, la cirugía no se marca como iniciada	Doctor · Auxiliar
Trazabilidad de implantes	Lote, referencia y posición, sin excepción	Doctor
Residuos	Segregación conforme a normativa y retirada por gestor autorizado	Auxiliar
Mantenimiento de equipos	Calendario de revisiones y registro de incidencias por equipo	Auxiliar · Dirección

3 · Emergencias médicas en la clínica

Principio

Ante cualquier emergencia: detener el procedimiento, pedir ayuda en voz alta y activar el aviso a emergencias si hay compromiso vital.

Nadie atiende una emergencia en solitario si hay alguien más en el centro. La formación en soporte vital básico es requisito del equipo asistencial.

PREPARACIÓN	ESTÁNDAR	COMPROBACIÓN
Botiquín de emergencia	Contenido definido por Dirección Médica, accesible desde cualquier gabinete	Revisión mensual con registro de caducidades
Oxígeno	Disponible y con carga suficiente	Comprobación en la apertura semanal
Protocolo visible	Número de emergencias y dirección exacta del centro en cada gabinete	Verificación trimestral
Formación del equipo	Soporte vital básico vigente en el personal asistencial	Registro de formación por persona
Simulacro	Al menos uno al año, con reparto de papeles	Acta del simulacro
Registro del episodio	Toda emergencia se documenta en la historia y se analiza con causa raíz	Revisión en comité

Este apartado fija la organización del centro ante una emergencia. El manejo clínico concreto de cada cuadro corresponde al criterio del profesional y a la formación acreditada de cada persona.

4 · Protección de datos en el día a día

- Pantallas bloqueadas al levantarse; ninguna ficha abierta a la vista de otro paciente
- Monitores de recepción orientados de forma que no sean legibles desde el mostrador

- El papel con datos personales no se queda en superficies comunes ni en el escáner
- Comunicaciones por WhatsApp solo desde el número corporativo y sin contenido clínico sensible
- Las imágenes clínicas no salen del sistema del centro ni se envían desde dispositivos personales
- Cada persona accede con su propio usuario: las credenciales no se comparten
- Cualquier pérdida, envío erróneo o acceso indebido se comunica a Dirección el mismo día para valorar si constituye una brecha notificable
- Las bajas de personal implican revocación inmediata de accesos

5 · Plan de continuidad del centro

INCIDENCIA	RESPUESTA INMEDIATA	QUIÉN DECIDE
Caída de Clinic Cloud	Juego documental impreso, hoja de contingencia y volcado íntegro antes del cierre	Dirección
Corte de suministro eléctrico	Suspensión de procedimientos en curso con seguridad, aviso a pacientes del día y reprogramación	Dirección
Avería del autoclave	Retirada de servicio; se reorganiza la agenda quirúrgica y se avisa a los pacientes afectados	Dirección · Auxiliar
Avería de CBCT u OPG	Se completa el resto de la batería y se cita para la prueba pendiente sin coste	Auxiliar · Dirección
Ausencia imprevista de un profesional	Sustituto certificado o reprogramación con aviso antes de que el paciente salga de casa	Dirección
Incidencia grave de RGPD	Documentación el mismo día y traslado a Gerencia para valorar notificación	Gerencia
Retirada de un lote de material	Bloqueo del lote, identificación de pacientes afectados por trazabilidad y comunicación	Dirección Médica

Regla común a todas las contingencias

Ninguna incidencia se resuelve degradando en silencio el protocolo.

Se informa al paciente, se documenta lo ocurrido y se registra qué se hizo en lugar de lo previsto.

6 · Orden de prioridades del centro

Prioridad 01**Seguridad del paciente**

Ninguna consideración de agenda, comercial o económica se antepone a ella.

Prioridad 02**Calidad del diagnóstico**

Antes que la rapidez y antes que el cierre: sin diagnóstico completo no hay propuesta.

Prioridad 03**Experiencia del paciente**

Confort, información y trato, en cada una de las catorce fases.

Prioridad 04**Entrega de lo vendido**

Un tratamiento aceptado que no se ejecuta es un riesgo, no un logro.

Prioridad 05**Conversión**

Consecuencia de las cuatro anteriores, nunca sustituto de ninguna.

Cómo se usa**Ante lo no previsto**

Se aplica este orden. Cualquier decisión que lo altere se consulta con Dirección antes de tomarla.



El recorrido del paciente

Las catorce fases, de la primera llamada al mantenimiento a largo plazo.

El recorrido del paciente se divide en catorce fases encadenadas. Cada una construye sobre la anterior: la información recogida en la llamada personaliza la recepción, la anamnesis alimenta la presentación, y el cierre abre el circuito de producción. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, por eso ninguna fase se salta «por falta de tiempo».

Las fases 2 a 11 componen la primera visita, con una duración real de 115 a 120 minutos según la complejidad del caso a valorar. La Fase 1 es previa (la llamada); la 12 es el seguimiento; la 13, el circuito de producción que ejecuta lo vendido; y la 14, el mantenimiento que sostiene el resultado en el tiempo y da coherencia al nombre del centro.

Dónde se gana y se pierde

Las fases 9 (presentación) y 10 (cierre) concentran la conversión: son las dos donde se gana o se pierde al paciente. Pero fallan más a menudo por causas que vienen de atrás — una Fase 7 sin material emocional, un briefing saltado, una Fase 1 que trajo al paciente equivocado—. Cuando la producción baje, se auditan primero esas dos, pero se revisa toda la cadena.

Las catorce fases de un vistazo

Filtra por puesto para ver solo las fases en las que intervienes.

FASE	TÍTULO	TIEMPO	RESPONSABLE	QUÉ PRODUCE
01	Preparación previa (la llamada)	Pre-visita	REC	Cita agendada con motivo, triaje y origen
02	Recepción, Sala VIP y tour	5´	REC · DC	Primera impresión de nivel
03	Anamnesis, RGPD y alta	15´	DC · REC	Vínculo, RGPD firmado y ficha completa
04	Historial médico y consentimiento radiológico	10´	DR	Anamnesis y consentimiento válidos
05	Pruebas diagnósticas y fotografía	15´	AUX	Evidencia objetiva cargada
06	Briefing odontólogo–director	5´	DR · DC	Plan único acordado
07	Expectativas y exploración	15´	DR	Material clínico y emocional
08	IAC, solicitud de presupuesto e informe	10´	DC · DR	IAC y solicitud firmados
09	Presentación del diagnóstico y plan	15´	DR · DC	Diagnóstico comprendido
10	Propuesta económica y cierre	20´	DC	Decisión y registro de conversión

FASE	TÍTULO	TIEMPO	RESPONSABLE	QUÉ PRODUCE
11	Cierre administrativo y escaneo	5–10´	REC · DC	Documentación subida y aviso a RAC
12	Despedida y seguimiento	Post-visita	DC · REC	Recuperación y fidelización
13	Circuito de producción	Post-aceptación	RAC	Lo vendido, ejecutado
14	Mantenimiento y seguimiento	Recurrente	HIG	Resultado sostenido en el tiempo

FASE 01 / 14

01

Tiempo

Pre-visita

Responsable

Recepción

Ubicación

Recepción de clínica

Preparación previa · la llamada

La primera llamada no es «coger una cita»: es el primer momento de verdad del centro. En unos 90 segundos el paciente decide, de forma inconsciente, si el sitio le transmite confianza, y se recoge la información que hará personalizado —o genérico— todo el recorrido posterior.

ACCIONES CLAVE

- **Recolección de datos esenciales.** Nombre completo, teléfono y email; urgencia percibida y motivo detallado de la consulta.
- **Filtrado por especialidad.** ¿Ausencia de piezas (implantología, el eje de Alma) o malposición (ortodoncia)? Determina el especialista, no solo el hueco.
- **«Cómo nos conoció».** Origen del paciente (redes, recomendación, Google, publicidad). Dato de marketing imprescindible.
- **Registro en la Agenda de PV.** Toda la información inicial y el motivo se registran en Clinic Cloud, verificando que el paciente no exista ya (duplicados).
- **Triage telefónico.** Urgencia (dolor agudo, trauma) → hueco más próximo; preferente (estético/funcional con ansiedad); estándar (el resto). La urgencia condiciona el hueco, nunca el orden interno del protocolo.
- **Speech de valor.** Se comunica el diferenciador de la primera visita gratuita con todas las pruebas avanzadas.
- **Cierre y confirmación.** Cita agendada y confirmada por el canal establecido.

Guion · speech de valor

«En el Centro de Excelencia Implantológica Alma su primera visita es completamente gratuita e incluye todas las pruebas diagnósticas avanzadas: tomografía 3D (CBCT), radiografía panorámica digital (OPG), estudio fotográfico profesional y escaneado intraoral 3D. Le garantizamos el diagnóstico más completo y preciso, sin ningún coste.»

INDICACIONES DE EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN

01 Descolgar antes del tercer tono e identificarse

Centro y nombre propio. Si no es posible atender en ese momento, se pide permiso para devolver la llamada en un plazo concreto y se cumple.

02 Escuchar el motivo sin interrumpir y anotarlo literal

Las palabras del paciente son el material con el que la Fase 9 conectará. «Se me mueve el puente de abajo y no puedo comer» vale mucho más que «prótesis».

03 Clasificar antes de agendar

Motivo, especialidad, triaje, origen y disponibilidad. Solo con los cinco ejes claros se elige hueco, profesional y duración.

04 Verificar duplicado en Clinic Cloud

Búsqueda por teléfono, email y apellidos antes de crear ficha. Un duplicado parte el historial y descuadra los indicadores de marketing.

05 Comunicar el valor antes de proponer hueco

Primero qué incluye la visita, después el día. Al revés, el paciente compara solo agendas.

06 Cerrar con dos opciones concretas

Dos huecos, no «¿cuándo le viene bien?». Y confirmar dirección, parking y qué traer (informes o radiografías previas).

07 Enviar el cuestionario previo

Permite al Doctor preparar el caso la tarde anterior (Función 2.1). Se explica en una frase por qué merece la pena rellenarlo.

CHECKLIST OPERATIVO DE LA LLAMADA

AMPLIACIÓN

☐ **Nombre y apellidos** correctamente escritos

☐ **Teléfono** repetido en voz alta y confirmado

☐ **Email** deletreado

- ☐ **Motivo detallado** en palabras del paciente
- ☐ **Especialidad** asignada (implantología / ortodoncia / general)
- ☐ **Nivel de triaje** (urgencia / preferente / estándar)
- ☐ **Origen** con canal y campaña concretos
- ☐ **Duplicado** verificado antes de crear ficha
- ☐ **Cuestionario previo** enviado
- ☐ **Recordatorios por WhatsApp** programados a 48 h y a 24 h

INDICADORES

Llamadas con «cómo nos conoció» registrado	≥ 98 %
Tiempo medio de conversión llamada → cita agendada	Se mide
Duplicados generados	AMPLIACIÓN 0

ERRORES A EVITAR

- Agendar sin verificar duplicado
- Omitir el motivo detallado, lo que deja a Recepción ciega en la Fase 2
- No registrar el origen por prisa
- Asignar especialista sin preguntar por ausencias o malposiciones

CRONOLOGÍA DE LA LLAMADA

AMPLIACIÓN

0:00 – 0:20 Descolgar antes del tercer tono. Centro y nombre propio.	0:20 – 2:00 Motivo, sin interrumpir. Se anota literal.	2:00 – 3:30 Los cinco ejes de cualificación y el triaje.	3:30 – 5:00 Speech de valor de la primera visita.
5:00 – 6:30 Dos huecos concretos y cierre de cita.		6:30 – 7:30 Confirmación de datos, envío del cuestionario y del recordatorio.	

Entre cinco y ocho minutos es lo normal. Por debajo de tres suele faltar información; por encima de doce, casi siempre se ha intentado diagnosticar por teléfono.

QUÉ PERCIBE EL PACIENTE

AMPLIACIÓN

- Que le cogen el teléfono rápido y quien contesta se identifica
- Que le escuchan y anotan, en lugar de recitar un guion

- Que la primera visita incluye mucho más de lo que esperaba, y sin coste
- Que le orientan al especialista adecuado a lo que le pasa
- Que cuelga con día, hora, dirección y qué llevar

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

AMPLIACIÓN

Diga

- «Cuénteme qué le ocurre, con sus palabras.»
- «¿Le faltan piezas o lo que le molesta es la posición de los dientes?»
- «La primera visita incluye tomografía 3D, panorámica, escaneado y estudio fotográfico, sin coste.»
- «Tengo martes a las 11:00 o jueves a las 18:30. ¿Cuál le viene mejor?»
- «¿Cómo nos ha conocido? Nos ayuda mucho saberlo.»

Evite

- «Es gratis», sin explicar qué incluye: abarata la percepción de valor.
- Dar precios de tratamientos por teléfono sin diagnóstico.
- Opinar sobre lo que le pasa: «eso suena a una infección...».
- «¿Cuándo le viene bien?», que alarga la llamada sin cerrar nada.
- Prometer profesional concreto, plazos o resultados.

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Dolor agudo o traumatismo

Triage de urgencia: hueco reservado del día. Si hay avulsión dentaria o inflamación facial, se pasa al Doctor en el momento de la llamada.

Solo pregunta precio

No se dan tarifas sueltas. El precio depende del diagnóstico, y la visita que lo determina no cuesta nada.

Segunda opinión

Se acepta sin criticar al centro anterior y se pide que traiga informes y radiografías previas.

Recomendado por un paciente

Se registra quién recomienda: activa el agradecimiento y el programa de referidos.

Menor de edad

La cita se confirma con el tutor, que debe acudir con su documentación.

Paciente internacional

Verificar idioma, documentación y fechas de estancia antes de planificar cualquier tratamiento.

CONTINGENCIAS

AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
Clinic Cloud no responde	Se anota en la hoja de contingencia impresa y se vuelca en cuanto el sistema vuelve, antes de cerrar la jornada
Entran dos llamadas a la vez	Se atiende, se pide permiso para devolver la llamada en diez minutos y se cumple
El paciente no sabe cómo nos conoció	Se ofrecen opciones concretas: «¿nos vio en Google, en redes, le habló alguien de nosotros?»
Pide cita con un profesional que no está	Se ofrece la primera fecha real, nunca una tentativa que luego haya que cambiar
Llamada agresiva o reclamación	Escucha sin interrumpir, registro y traslado a Dirección el mismo día

Objetivo de la fase

Captar la atención, generar expectativa, demostrar desde el primer contacto el valor diferencial de Alma, y dirigir al paciente hacia el especialista adecuado a su necesidad.

CHECKLIST DE SALIDA

- ☐ **Agenda de PV** completa
- ☐ **Ficha Clinic Cloud** preliminar sin duplicar
- ☐ **Nivel de triaje** asignado
- ☐ **Especialista** asignado según motivo

FASE 02 / 14

02

Tiempo

5 minutos

Responsable

Recepción / Director

Ubicación

Recepción → Sala VIP → Instalaciones

Recepción, Sala VIP y tour

Esta fase construye la percepción de nivel. El paciente ha decidido dar una oportunidad al centro; en los primeros cinco minutos confirma o revisa esa decisión. Un centro de excelencia se demuestra, no se dice: el tour por la tecnología es la primera prueba tangible de que el nombre significa algo.

ACCIONES CLAVE

- **Acogida y reconocimiento.** Recepción, tras consultar Clinic Cloud, saluda por el nombre. Transición inmediata, sin demoras.
- **Acompañamiento a Sala VIP.** Nunca a la sala general. Ofrecimiento de bebida. El paciente se siente valorado desde el primer momento.
- **Tour por la tecnología (Director).** Esterilización (confianza sanitaria) y sala de imagen 3D (diferenciación tecnológica), conectando siempre con el motivo de consulta ya conocido.

Guion · en sala de imagen 3D

«Esta tecnología nos permite ver lo que otros no ven, planificar con exactitud milimétrica y garantizar resultados predecibles a largo plazo. En un rato le haremos estas pruebas, sin ningún coste.»

INDICACIONES DE EJECUCIÓN**AMPLIACIÓN****01 Preparar la llegada quince minutos antes**

Recepción revisa quién viene, por qué y quién le atenderá. El reconocimiento por el nombre solo funciona si se ha mirado la ficha antes.

02 Recibir de pie y sin mostrador de por medio

El mostrador es una barrera. Se sale, se saluda y se acompaña.

03 Instalar en Sala VIP y ofrecer bebida

Nunca se deja al paciente sin saber qué pasa a continuación ni durante cuánto tiempo.

04 Conectar cada parada del tour con su motivo

A quien viene por ausencias se le enseña el CBCT hablando de hueso disponible; a quien viene por estética, el escáner y la simulación. El mismo tour genérico para todos no diferencia.

05 Cerrar el tour anunciando el siguiente paso

«Ahora pasamos al despacho quince minutos y después el Doctor le explorará.» El paciente siempre sabe dónde está del recorrido.

CHECKLIST DEL ENTORNO, ANTES DE QUE
LLEGUE

AMPLIACIÓN

☐ **Sala VIP** ordenada, sin documentación de otros pacientes a la vista

☐ **Bebidas y material de acogida** repuestos

☐ **Sala de imagen** presentable, sin restos del paciente anterior

☐ **Esterilización** en condiciones de ser mostrada

☐ **Equipo** uniformado e identificado

☐ **Retrasos previsibles** detectados y con mensaje acordado

INDICADORES

Tiempo de espera real antes de ser recibido **0 min en sala general**

Tours completados sin interrupciones **AMPLIACIÓN** **100 %**

ERRORES A EVITAR

- Dejar al paciente en sala general
- Tour genérico que no conecta la tecnología con el motivo de consulta

CRONOLOGÍA DE LA ACOGIDA

AMPLIACIÓN

-15 min Recepción revisa quién viene, por qué y quién le atiende.	0:00 Llegada. Saludo por su nombre, de pie, sin mostrador de por medio.	0:30 – 1:30 Acompañamiento a Sala VIP y ofrecimiento de bebida.	1:30 – 2:00 Aviso al Director de que el paciente ha llegado.
2:00 – 5:00 Tour: esterilización y sala de imagen 3D.			

PREPARACIÓN DEL ENTORNO · ANTES DE QUE LLEGUE

AMPLIACIÓN

- ☐ **Sala VIP** ordenada, sin documentación de otros pacientes a la vista
- ☐ **Bebidas y material de acogida** repuestos
- ☐ **Temperatura y ventilación** comprobadas
- ☐ **Sala de imagen** presentable, sin restos del paciente anterior
- ☐ **Esterilización** en condiciones de ser mostrada
- ☐ **Equipo** uniformado e identificado con nombre y función
- ☐ **Retrasos previsibles** detectados, con el mensaje ya acordado

CÓMO SE CONECTA EL TOUR CON EL MOTIVO

AMPLIACIÓN

MOTIVO DEL PACIENTE	QUÉ SE ENSEÑA Y CON QUÉ FRASE
Le faltan piezas	CBCT: «aquí medimos su hueso en milímetros, y por eso podemos decirle con certeza qué se puede colocar y qué no»
Prótesis que se mueve	Escáner intraoral: «esto sustituye a las pastas de impresión y nos da un ajuste que antes no era posible»
Estética	Escáner y simulación: «podemos enseñarle el resultado antes de empezar»
Miedo o mala experiencia	Esterilización y sala de imagen: «todo lo que entra en su boca tiene su ciclo registrado; aquí no se improvisa nada»
Ortodoncia	Escaneado y planificación digital: «su tratamiento se diseña en ordenador antes de ponerle nada»

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

AMPLIACIÓN

Diga

- «Buenos días, [Nombre]. Le estábamos esperando.»
- «Acompáñeme, le llevo a nuestra sala; ¿le apetece un café o un agua?»
- «Antes de empezar quiero enseñarle cómo trabajamos.»
- «Ahora pasamos quince minutos al despacho y después le explora el Doctor.»

Evite

- «¿Su nombre?», cuando la cita está en agenda.
- Dejar al paciente de pie mientras se busca su ficha.
- Un tour largo y técnico: cinco minutos, dos paradas.
- Comentarios entre compañeros delante del paciente.
- Justificar retrasos culpando a otro paciente o a un compañero.

GESTIÓN DE LA ESPERA Y DE LOS RETRASOS

AMPLIACIÓN

—

SITUACIÓN	ACCIÓN INMEDIATA	RESPONSABLE
Retraso de hasta 10 minutos	Informar al llegar, sin excusas largas, y ofrecer bebida	Recepción
Retraso de 10 a 25 minutos	Informar, disculparse una vez y adelantar la Fase 3 en el despacho	Director
Más de 25 minutos	Ofrecer reprogramar sin coste y con hueco preferente; si se queda, el Director acompaña la espera	Director
El paciente llega tarde	Valorar si cabe el circuito completo; si no, reprogramar sin reproche	Recepción
No se presenta	Llamada el mismo día, sin tono de reclamación, y nuevo hueco	Recepción

Una PV que empieza con más de 25 minutos de retraso rara vez recupera la percepción de excelencia: es preferible reprogramar bien que ejecutar mal.

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

—

Viene acompañado El acompañante entra en todo el circuito salvo que el paciente diga lo contrario. Suele influir en la decisión: se le trata como a un segundo paciente.
Movilidad reducida Ruta accesible, tour abreviado o sustituido por vídeo en la Sala VIP.
Con niños Espacio y entretenimiento; si hace falta, alguien del equipo acompaña al menor durante la presentación.
Paciente con prisa

Se explica el circuito y se propone completar hoy lo clínico y la presentación en una segunda cita cercana.

Ansiedad manifiesta

Tour más pausado, sin entrar en gabinete, y aviso al Doctor antes de la Fase 4.

Conocido del equipo

El protocolo no se relaja: la confianza previa no sustituye a la documentación ni al circuito.

Objetivo de la fase

Crear la primera impresión de profesionalidad y diferenciación tecnológica. El paciente debe sentirse en un entorno premium desde el primer minuto.

CHECKLIST DE SALIDA

☐ **Paciente ubicado** en Sala VIP

☐ **Tour completado** sin interrupciones

FASE 03 / 14

03

Tiempo

15 minutos

Responsable

Director (anamnesis y RGPD) + Recepción (alta)

Ubicación

Sala VIP / Despacho

Anamnesis inicial, RGPD y alta en Clinic Cloud

Dos capas en paralelo. La humana: el Director crea el vínculo, conoce a la persona y recoge sus expectativas iniciales. La administrativa y legal: se cumple el RGPD, se dan de alta los datos y se garantiza la trazabilidad. El error de fondo es convertir la fase en un puro trámite de papeles: el paciente que solo rellena formularios no conecta.

ACCIONES CLAVE

- **Ambiente de confianza.** Romper el hielo con conversación genuina: trabajo, familia, intereses. Vínculo antes de la parte clínica.
- **Documentación administrativa.** Hoja de datos personales y política RGPD, explicando los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) antes de firmar.
- **Anamnesis inicial de expectativas.** «¿Qué espera conseguir con su tratamiento?» y las preguntas de la hoja.
- **Verificación de email.** Letra por letra. Se informa de que recibirá una encuesta de satisfacción tras la visita.
- **Entrega a Recepción y alta.** El Director entrega la hoja y la anamnesis; Recepción completa el alta en Clinic Cloud en paralelo a la Fase 4, sin hacer esperar al paciente.

INDICACIONES DE EJECUCIÓN**AMPLIACIÓN**

01

Empezar por la persona, no por el formulario

Tres minutos de conversación abierta antes de sacar ningún papel. Lo que se aprenda aquí se anota: en la Fase 10 vale más que cualquier técnica de cierre.

02 Explicar el RGPD en voz alta, en un minuto

Quién trata los datos, para qué, cuánto se conservan, con quién se comparten y qué derechos tiene. Una firma sin explicación es un consentimiento débil.

03 Separar los consentimientos

Asistencial, comunicaciones comerciales y uso de imágenes son tres decisiones distintas. Nunca se marcan por defecto.

04 Verificar email y móvil en voz alta

Es el canal del informe, la encuesta y los recordatorios. Un carácter mal escrito rompe toda la comunicación posterior.

05 Entregar a Recepción sin retrasar al paciente

El alta corre en paralelo a la Fase 4. El principio es que ninguna tarea de back-office bloquee el recorrido.

CHECKLIST DE ALTA EN CLINIC CLOUD

AMPLIACIÓN

☐ **Identificación:** nombre, apellidos, documento, fecha de nacimiento

☐ **Contacto:** móvil, email y teléfono alternativo, verificados

☐ **Domicilio y datos de facturación**

☐ **Origen de marketing,** coherente con la Fase 1

☐ **Consentimientos** firmados y fechados, uno a uno

☐ **Terceros autorizados** a recibir información

☐ **Notas de contexto** de la conversación de apertura

INDICADORES

Fichas Clinic Cloud completas a las 24 h	100 %
Altas completadas antes de que termine la Fase 4	Se mide

ERRORES A EVITAR

- Firmar el RGPD sin explicar los derechos ARCO
- Dar de alta con email no verificado
- Que Recepción reciba la anamnesis tarde y retrase el alta más allá de la Fase 9

CRONOLOGÍA DEL DESPACHO

AMPLIACIÓN

0:00 – 3:00	3:00 – 7:00	7:00 – 10:00	10:00 – 12:00
-------------	-------------	--------------	---------------

Conversación de apertura: quién es, a qué se dedica, qué le trae.	Hoja de datos personales y anamnesis inicial de expectativas.	RGPD explicado y firmado, con consentimientos diferenciados.	Verificación de email y aviso de la encuesta de satisfacción.
12:00 – 15:00 Entrega a Recepción y presentación del Doctor.			

El alta en Clinic Cloud corre en paralelo a la Fase 4: el paciente nunca espera a que Recepción termine de teclear.

CONVERSACIÓN DE APERTURA · PREGUNTAS QUE ABREN

[AMPLIACIÓN](#)

- «¿De qué zona viene? ¿Le ha costado aparcar?» — rompe el hielo sin invadir
- «¿A qué se dedica?» — informa sobre disponibilidad horaria sin preguntar por dinero
- «¿Quién le ha hablado de nosotros?» — confirma el origen registrado en la Fase 1
- «¿Ha estado antes en otra clínica por este tema?» — anticipa comparaciones
- «¿Hay algo que le preocupe de la visita de hoy?» — detecta miedos antes de que aparezcan

Todo lo relevante se anota en Clinic Cloud. En la Fase 10, recordar que su hija se casa en septiembre vale más que cualquier técnica de cierre.

QUÉ SE EXPLICA DEL RGPD, LITERALMENTE

[AMPLIACIÓN](#)

Responsable del tratamiento: Centro de Excelencia Implantológica Alma.
Finalidad: asistencia sanitaria, gestión administrativa y facturación; y –solo si lo autoriza– comunicaciones informativas y uso docente o promocional de imágenes.
Base legal: ejecución del contrato asistencial y obligación legal sanitaria;
el consentimiento para lo comercial y para las imágenes.
Conservación: la historia clínica, durante el plazo legalmente exigible; los datos comerciales, hasta que retire su consentimiento.
Destinatarios: laboratorio y profesionales colaboradores cuando el tratamiento lo requiera; entidad financiera si contrata financiación; administraciones si la ley obliga.
Derechos ARCO y ampliados: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición. Puede reclamar ante la autoridad de control.

☐ **Consentimiento asistencial firmado**

- ☐ **Consentimiento de comunicaciones comerciales**, marcado de forma expresa y nunca premarcado
- ☐ **Consentimiento de uso de imágenes**, independiente y revocable
- ☐ **Terceros autorizados** a recibir información del paciente
- ☐ **Representante legal** identificado, si procede

CAMPOS OBLIGATORIOS DEL ALTA EN CLINIC CLOUD

AMPLIACIÓN

BLOQUE	CAMPOS	VERIFICACIÓN
Identificación	Nombre, apellidos, DNI/NIE/pasaporte, fecha de nacimiento	Contra documento original
Contacto	Móvil, email, teléfono alternativo	Repetición en voz alta
Domicilio	Dirección completa, código postal, localidad	Necesario para facturación
Facturación	Titular, NIF, empresa o aseguradora si aplica	Antes del primer cobro
Marketing	Cómo nos conoció, campaña, paciente que recomienda	Coherente con la Fase 1
Consentimientos	RGPD, comercial, imágenes, terceros	Fecha y firma
Contexto	Profesión, disponibilidad, notas personales relevantes	Útil en Fases 7 y 10

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

AMPLIACIÓN

Diga

- «Dedicamos diez minutos al papeleo aquí, cómodos, y después no volvemos a hablar de formularios.»
- «Le explico qué hacemos con sus datos; si algo no le encaja, no lo firme.»
- «¿Me confirma su email letra por letra? Ahí le llegará su informe y la encuesta.»
- «El siguiente paso es el Doctor; le acompaño yo y le presento.»

Evite

- «Firme aquí y aquí», sin explicar qué se firma.
- Rellenar el formulario mientras el paciente espera en silencio.
- Preguntar directamente por ingresos o capacidad de pago.
- Dejar campos vacíos «para completarlos luego».

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Menor de edad

Firma el tutor, cuya identificación se registra. En custodia compartida se documenta quién autoriza.

Representante legal

Se archiva copia de la resolución o poder que acredita la representación.

Sin documento español

Se admite pasaporte; se registran número y nacionalidad para facturación y garantías.

Se niega a dar email

Se explica que por ahí viajan el informe y la encuesta. Si mantiene la negativa, se registra el motivo y se acuerda entrega en papel.

Paga una empresa o aseguradora

Datos fiscales del pagador, autorización expresa y condiciones de cobertura antes del presupuesto.

Revoca un consentimiento

Se atiende de inmediato, se registra la fecha y se excluye de los envíos correspondientes.

Objetivo de la fase

Completar el registro administrativo, cumplir el RGPD y crear un vínculo de confianza antes de la parte clínica, con toda la información en el sistema antes de que avance el proceso comercial.

CHECKLIST DE SALIDA

- ☐ **RGPD** firmado y explicado
- ☐ **Email verificado** y paciente informado de la encuesta
- ☐ **Anamnesis** entregada a Recepción
- ☐ **Alta completa** y documentación subida

FASE 04 / 14

04

Tiempo

10 minutos

Responsable

Doctor

Ubicación

Despacho del Doctor

Criticidad

Máxima · riesgo clínico-legal

Historial médico y consentimiento radiológico

Primera fase puramente clínica y la de mayor riesgo clínico-legal de toda la visita. Una anamnesis incompleta puede derivar en una complicación grave: una alergia no detectada, una interacción medicamentosa, una contraindicación ignorada.

ACCIONES CLAVE

- **Transición de autoridad clínica.** El Director presenta al Doctor como máxima autoridad, en continuidad premium.
- **Anamnesis médica general.** Enfermedades, alergias, medicación, cirugías, problemas cardiovasculares/diabetes/hipertensión, coagulación, embarazo/lactancia. Sin omitir ninguna.
- **Anamnesis dental.** Tratamientos previos, experiencias, higiene, bruxismo, sensibilidad, miedos.
- **Consentimiento radiológico explicado.** Baja dosis (comparable a un vuelo transatlántico), necesidad diagnóstica, comprensión verificada y firma.
- **Registro del Doctor.** Datos médicos, confirmación de la firma y observaciones, en Clinic Cloud el mismo día.

Base legal

El consentimiento debe cumplir el estándar de la Ley 41/2002: información suficiente, comprensible y específica, no una autorización genérica.

Una firma sin comprensión verificable equivale, a efectos prácticos, a no tener consentimiento válido.

Guión · apertura de la anamnesis

«[Nombre], antes de cualquier exploración necesito conocer bien su historial de salud. Algunas preguntas le parecerán no tener que ver con los dientes, pero son importantes para tratarle con total seguridad.»

BLOQUE MÉDICO · PREGUNTAS OBLIGATORIAS

- ¿Padece alguna enfermedad actual o pasada relevante?
- ¿Tiene alguna alergia: medicamentos, látex, materiales?
- ¿Toma alguna medicación de forma habitual?
- ¿Le han operado alguna vez?
- ¿Problemas cardiovasculares, diabetes o hipertensión?
- ¿Algún problema de coagulación?
- (Si aplica) ¿Está embarazada o en periodo de lactancia?

ALERTAS QUE CAMBIAN EL PLAN**AMPLIACIÓN**

HALLAZGO	IMPLICACIÓN	ACTUACIÓN
Anticoagulantes / antiagregantes	Riesgo de sangrado quirúrgico	Registrar pauta y coordinar con el médico prescriptor antes de cirugía
Bifosfonatos y otros antirresortivos	Riesgo de osteonecrosis maxilar	Vía, duración e inicio; consentimiento específico y valoración de alternativas
Diabetes	Cicatrización comprometida	Preguntar por control glucémico reciente; condiciona el calendario quirúrgico
Cardiopatía o prótesis valvular	Posible profilaxis antibiótica	Verificar informe del cardiólogo antes de procedimientos con sangrado
Inmunosupresión / oncológico	Riesgo infeccioso	Coordinación con el especialista responsable
Alergia a látex o anestésicos	Riesgo de reacción	Alerta visible en Clinic Cloud y material alternativo preparado
Embarazo o lactancia	Prudencia radiológica y farmacológica	Diferir lo no urgente y documentar la decisión
Tabaquismo y bruxismo	Peor pronóstico implantario y protésico	Reflejar en el IAC y en las condiciones de garantía

Esta tabla ordena el criterio del centro; no sustituye al juicio clínico del Doctor ni a la valoración del médico responsable del paciente.

INDICADORES

Historiales con alergias, medicación y cirugías completos	100 %
Consentimientos con comprensión verificada registrada	100 %

ERRORES A EVITAR

- Anamnesis superficial que obliga a repetir preguntas en la Fase 7
- Consentimiento radiológico «de trámite» sin verificar comprensión

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA CLÍNICA

AMPLIACIÓN

0:00 – 1:00 Presentación por el Director y recapitulación del motivo.	1:00 – 5:00 Anamnesis médica general, revisión sistemática.	5:00 – 7:30 Anamnesis dental y experiencias previas.	7:30 – 10:00 Consentimiento radiológico: explicación, verificación de comprensión y firma.
--	--	---	---

QUÉ PERCIBE EL PACIENTE

AMPLIACIÓN

- Que quien le atiende ya sabe por qué ha venido: nadie le hace repetir lo contado
- Que le preguntan por su salud general, no solo por los dientes
- Que la firma no es un trámite: alguien se ha asegurado de que entiende qué firma
- Que el Doctor es la autoridad clínica, y que el equipo se lo ha presentado como tal

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

AMPLIACIÓN

Diga

- «¿Toma alguna medicación, aunque le parezca que no tiene relación con los dientes?»
- «¿Ha tenido alguna reacción a un anestésico o a un antibiótico?»
- «La dosis de esta tomografía es muy baja, comparable a la radiación natural de un vuelo largo.»
- «¿Me puede decir con sus palabras qué le vamos a hacer y por qué?»

Evite

- Pasar la anamnesis como un cuestionario de sí o no, sin repreguntar.
- «Esto no es nada, firme aquí.»
- Minimizar la radiación con datos inventados.
- Comentar en voz alta lo que hizo mal el centro anterior.
- Empezar a diagnosticar antes de tener las pruebas.

**CONTENIDO MÍNIMO DEL CONSENTIMIENTO
RADIOLÓGICO**

AMPLIACIÓN

- ☐ **Identificación** del paciente y del centro
- ☐ **Pruebas concretas:** CBCT, OPG y, si procede, periapicales
- ☐ **Justificación diagnóstica** de cada una
- ☐ **Información de dosis** y comparación comprensible
- ☐ **Riesgos y alternativas**, incluida la de no realizar la prueba
- ☐ **Declaración sobre embarazo** en pacientes en edad fértil
- ☐ **Firma del paciente** o representante, con fecha
- ☐ **Firma del profesional** que informa y nota de comprensión verificada

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Embarazo

Se difiere lo no urgente. Si hay urgencia, se documenta la justificación y se extremen las medidas de protección.

Paciente pediátrico

Anamnesis con el tutor presente, lenguaje adaptado y criterio radiológico más restrictivo.

Claustrofobia o ansiedad

Explicación previa del equipo, acompañamiento en sala y prueba en dos tiempos si hace falta.

Barrera idiomática

Consentimiento en idioma comprensible; si no es posible, intérprete identificado en la historia.

Deterioro cognitivo

Información y firma del representante legal, con el paciente presente y participando en lo posible.

Trae pruebas recientes

Se valoran; si son válidas y suficientes, se evita repetir exposición y se deja constancia del motivo.

REGISTRO EN CLINIC CLOUD · CAMPOS DE
ESTA FASE

AMPLIACIÓN

- ☐ **Enfermedades** actuales y pasadas relevantes
- ☐ **Alergias**, marcadas como alerta visible en la ficha
- ☐ **Medicación habitual**, con dosis si el paciente la conoce
- ☐ **Cirugías previas** y complicaciones
- ☐ **Factores de riesgo**: tabaco, bruxismo, diabetes, coagulación
- ☐ **Miedos declarados**, trasladados al resto del equipo
- ☐ **Consentimiento radiológico**: firmado, con nota de comprensión verificada

Objetivo de la fase

Obtener toda la información médica para un diagnóstico seguro, cumplir los requisitos legales y establecer la relación médico-paciente basada en la confianza profesional.

CHECKLIST DE SALIDA

- ☐ **Anamnesis completa** en Clinic Cloud
- ☐ **Consentimiento radiológico** firmado y explicado
- ☐ **Alergias y medicación** destacadas para el equipo de imagen

FASE 05 / 14

05

Tiempo

15 minutos

Responsable

Auxiliar

Ubicación

Sala de Imagen 3D / Gabinete

Pruebas diagnósticas y documentación fotográfica

Aquí se genera la evidencia objetiva sobre la que se sostienen el diagnóstico y la presentación. Una prueba mal hecha o mal cargada arruina la Fase 9 y reduce la conversión. Además es un momento de experiencia: el paciente vive la tecnología prometida.

ACCIONES CLAVE

- **CBCT 3D.** Posicionamiento, explicación, captura de la estructura ósea y dental.
- **OPG.** Panorámica de ambos maxilares.
- **Escaneado intraoral 3D.** Modelo digital de alta precisión de las arcadas.
- **Serie fotográfica.** Extraoral (frontal reposo/sonriendo, perfiles, tres cuartos) e intraoral (frontal, laterales, oclusales, detalles).
- **Prediagnóstico IA (opcional).** WeDiagnostix sobre la OPG, como apoyo; nunca sustituye el diagnóstico profesional.
- **Carga en tiempo real.** Todas las imágenes se cargan de inmediato en Clinic Cloud, etiquetadas, enderezadas y con calidad verificada, asociadas al historial.

SECUENCIA DE LA BATERÍA

AMPLIACIÓN

1 · CBCT Retirada de metales, posicionamiento verificado, explicación previa del ruido y la duración.	2 · OPG Mordida en posición, lengua en el paladar, hombros relajados.	3 · Escaneado Campo seco, secuencia oclusal-lingual-vestibular, registro de oclusión.	4 · Fotografía Serie extraoral e intraoral completa, con espejos calentados y retractores.
5 · Control de calidad		6 · Carga y aviso	

Nitidez, encuadre y enderezado antes de subir nada.

Etiquetado correcto, verificación de apertura y notificación al Doctor.

Regla nuclear

Verificas y enderezas cada imagen antes de subirla. No se avanza sin confirmar la carga.

Si una imagen genera duda, se repite en el momento. Nunca se deja «a ver si vale».

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR PRUEBA

AMPLIACIÓN

PRUEBA	SE ACEPTA SI...	MOTIVO HABITUAL DE REPETICIÓN
CBCT	Volumen completo del área de interés, sin movimiento	Movimiento del paciente durante la adquisición
OPG	Simetría de ramas, cóndilos visibles, sin sombra de lengua	Lengua separada del paladar o posición adelantada
Escaneado	Arcadas completas sin huecos y oclusión coincidente	Saliva, sangrado o secuencia interrumpida
Fotografía extraoral	Encuadre reproducible y enfoque en el tercio medio	Inclinación de cabeza distinta entre tomas
Fotografía intraoral	Sin vaho, sin dedos ni retractores en cuadro	Espejo empañado o saliva en la superficie dental

INDICADORES

Tiempo medio de la batería completa	≤ 15 min
Tasa de repetición por mala calidad	< 5 %

ERRORES A EVITAR

- Pasar al Doctor imágenes sin verificar nitidez o encuadre
- Etiquetado incorrecto que impide localizar la imagen en la Fase 9

QUÉ PERCIBE EL PACIENTE

AMPLIACIÓN

- Que le explican cada prueba antes de hacerla: cuánto dura, qué va a oír y qué va a notar
- Que puede levantar la mano y parar en cualquier momento
- Que ve su propio modelo 3D en pantalla, aunque solo sean treinta segundos

- Que sale de la sala arreglado, con enjuague y espejo si lo necesita
- Que la tecnología prometida en el tour existe y funciona

CONFORT DURANTE LAS PRUEBAS

AMPLIACIÓN

- Anunciar cada prueba antes de empezarla y avisar de los ruidos antes de que suenen
- Retirar objetos metálicos con tiempo, no con el paciente ya posicionado
- Espejos calentados y retractores lubricados: la mayoría de las molestias vienen de ahí
- Pausas a demanda, con una señal acordada de antemano
- Enjuague y espejo al terminar; nadie vuelve al despacho despeinado o con restos
- Anunciar que verá sus imágenes en pantalla en unos minutos: convierte la prueba en expectativa

ETIQUETADO Y NOMENCLATURA

AMPLIACIÓN

Formato: AAAAMMDD_Apellido-Nombre_TIPO_detalle

20260318_Perez-Ana_CBCT_maxilar-completo
 20260318_Perez-Ana_OPG
 20260318_Perez-Ana_IOS_arcada-superior
 20260318_Perez-Ana_FOT0-E0_frontal-sonrisa
 20260318_Perez-Ana_FOT0-IO_lateral-derecho
 20260318_Perez-Ana_CAM-IO_16-fisura

- ☐ **Tipo de prueba** elegido del desplegable, no escrito a mano
- ☐ **Fecha real** de adquisición
- ☐ **Observaciones:** incidencias, repeticiones, limitaciones
- ☐ **Identidad verificada** con dos datos antes de asociar a la ficha
- ☐ **Apertura comprobada** desde el equipo de presentación

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Reflejo nauseoso intenso

Escaneado por sectores con pausas, respiración nasal y, si es necesario, posponer la arcada superior.

Movilidad reducida

Posicionamiento sentado cuando el equipo lo permita; si no, se documenta la limitación y se busca alternativa diagnóstica.

Restauraciones metálicas extensas

Advertir de los artefactos en el CBCT y complementar con periapicales dirigidas.

Paciente pediátrico

Criterio radiológico restrictivo, protección adicional y acompañamiento del tutor.

Prótesis removible

Se escanea con y sin prótesis cuando el plan lo requiera, y se anota así en observaciones.

Prueba fallida

Se repite solo si es imprescindible, se justifica en la historia y se informa al paciente sin dramatizar.

CONTINGENCIAS

AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
El CBCT no arranca o falla la calibración	Se avisa a Dirección antes del primer paciente; si ocurre en visita, se completa el resto de pruebas y se cita para el CBCT sin coste
El escáner pierde la conexión	Se reinicia el flujo por sectores; si persiste, se registra la incidencia y se toma impresión convencional solo si el plan lo exige
Las imágenes no suben al sistema	No se avanza a la Fase 6. Se guarda copia en el equipo autorizado y se sube en cuanto se restablezca, antes del cierre
La calidad es dudosa	Se repite en el momento, con el paciente todavía posicionado
El paciente no tolera una prueba	Se detiene, se registra y el Doctor decide si el diagnóstico puede completarse por otra vía

Objetivo de la fase

Obtener toda la información diagnóstica objetiva necesaria, con la tecnología más avanzada disponible y en el máximo confort del paciente.

CHECKLIST DE SALIDA

☐ Las 4 pruebas cargadas, etiquetadas, enderezadas y verificadas

☐ **Doctor notificado** de disponibilidad

☐ **Paciente acompañado** de vuelta a Sala VIP

FASE 06 / 14

06

Tiempo

5 minutos

Responsable

Odontólogo + Director

Ubicación

Gabinete / Sala de presentación

Visibilidad

Fase invisible para el paciente

Briefing odontólogo–director

Fase invisible para el paciente y decisiva para la conversión. Doctor y Director se alinean para presentar una propuesta única, coherente y sólida. Sin briefing, el paciente percibe dudas, contradicciones o improvisación, y no compra. El principio: el paciente nunca debe ver improvisación; todo lo que verá en las Fases 7, 9 y 10 se cocina aquí.

ACCIONES CLAVE

- **Análisis interdisciplinar.** Revisión conjunta de las pruebas 3D, el perfil del paciente (expectativas, capacidad, urgencia) y la información recopilada.
- **Consenso clínico.** El Doctor fija de forma inequívoca el plan óptimo que se comunicará: diagnóstico principal y secundarios, plan por fases, alternativas, tiempos y resultados esperados.
- **Estrategia de cierre.** Argumentos de valor (Doctor), enfoque financiero (Director) y anticipación de objeciones probables de este paciente concreto.

AGENDA CRONOMETRADA

AMPLIACIÓN

0:00 – 1:30 Lectura del CBCT y de la OPG por el Doctor.	1:30 – 2:30 Perfil del paciente: expectativas, contexto, miedos, urgencia.	2:30 – 4:00 Plan óptimo y alternativas razonables.	4:00 – 5:00 Reparto: quién dice qué en las Fases 9 y 10.
--	---	---	---

FICHA DE ACUERDO DEL BRIEFING

AMPLIACIÓN

Diagnóstico principal:

.....

Secundarios:

.....

Plan óptimo F1 urgencias: F2 principal: F3 estética:

.....

Alternativa razonable:

.....

Duración estimada: N.º de citas:

Rango económico previsto: Vía de pago probable:

Objeción esperada:

.....

Reparto: diagnóstico plan presupuesto

INDICADORES

Briefings realizados antes de que el paciente vuelva a ver al Doctor

100 %

ERRORES A EVITAR

- Que Doctor y Director presenten planes distintos
- Saltarse el briefing por falta de tiempo

REGLAS DEL BRIEFING

AMPLIACIÓN

- Se hace siempre, aunque el caso parezca sencillo: los casos simples también se pierden por descoordinación
- Se hace fuera del alcance auditivo del paciente y de la sala de espera
- La decisión clínica es del Doctor; la estrategia de comunicación se acuerda entre ambos
- Si el caso excede la cartera del centro, aquí se decide la derivación y quién la explica
- Si el Doctor necesita más tiempo de estudio, se ofrece una segunda cita de presentación en 24–48 h, sin improvisar
- El acuerdo se registra: sin registro, nadie puede auditar qué se decidió ni por qué

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Discrepancia clínica

Prevalece el criterio del Doctor. Si persiste la duda, se consulta a Dirección Médica antes de presentar nada.

Caso fuera de cartera

Se define la derivación, el profesional receptor y el mensaje al paciente. Derivar bien también fideliza.

Hallazgo grave incidental

Se decide cómo comunicarlo, con qué urgencia y a qué especialista se remite el mismo día.

Presupuesto elevado

Se prepara ya la secuenciación por fases y la simulación de financiación, no en mitad de la Fase 10.

Expectativas irreales

Se acuerda qué se puede prometer y qué no, y quién marca ese límite delante del paciente.

Caso interdisciplinar

Se identifica qué especialistas intervienen y en qué orden, para que el calendario sea creíble.

ERRORES A EVITAR

AMPLIACIÓN

- Cerrar un plan sin haber mirado el CBCT con detenimiento
- Definir el precio antes que el plan clínico
- Comentar el caso en pasillos o zonas comunes
- Salir del briefing sin haber repartido quién dice qué en las Fases 9 y 10

Objetivo de la fase

Asegurar que Doctor y Director estén perfectamente alineados para ofrecer una propuesta coherente, convincente y profesional que maximice la conversión.

CHECKLIST DE SALIDA

☐ **Plan de tratamiento** único y acordado

☐ **Estrategia de objeciones** definida

FASE 07 / 14

07

Tiempo

15 minutos

Responsable

Doctor

Ubicación

Gabinete de diagnóstico

Anamnesis de expectativas y exploración

Fase clínica y emocional a la vez. El Doctor explora físicamente y confirma el diagnóstico, y extrae el material emocional que hará que la presentación conecte. La clave que casi nadie entiende: un paciente no compra un tratamiento por sus características técnicas, sino por lo que significa para su vida. Ese «para qué» se descubre aquí.

LAS CUATRO DIMENSIONES DE EXPECTATIVAS ·
OBLIGATORIAS TODAS

DIMENSIÓN	PREGUNTAS
Funcional	¿Qué le impide comer con normalidad? ¿Tiene dolor o molestias? ¿Qué le gustaría poder hacer que ahora no puede?
Estética	¿Cómo se siente con su sonrisa actual? Si pudiera cambiar algo, ¿qué sería? ¿Hay situaciones en las que evita sonreír?
Emocional	¿Cómo le afecta en su día a día? ¿Qué significaría resolverlo? ¿Qué le preocupa o le da miedo del tratamiento?
Experiencias previas	¿Ha tenido alguna mala experiencia dental? ¿Qué le gustó y qué no de tratamientos anteriores?

EXPLORACIÓN Y CÁMARA INTRAORAL

Exploración extraoral (simetría, perfil, ATM, ganglios) e intraoral completa (encías, placa, cada pieza, caries, restauraciones, oclusión, tejidos blandos). La cámara intraoral captura evidencia visual de las zonas problemáticas: la imagen más potente es la que el paciente entiende.

Guión · con la cámara intraoral

«¿Ve esto? Esto es una caries que está comenzando aquí. La encía debería verse rosa y firme, pero observe cómo está inflamada.»

TÉCNICA DE ENTREVISTA

AMPLIACIÓN

- **Pregunta abierta primero.** «Cuénteme» produce más información que quince preguntas cerradas.
- **Silencio activo.** Tras la respuesta, esperar tres segundos: ahí aparece lo que de verdad preocupa.
- **Reformulación.** «Si le he entendido bien, lo que más le molesta es...», y dejar que corrija.
- **Escala de importancia.** «Del 0 al 10, ¿cuánto le afecta esto?» ordena las prioridades del plan.
- **Registro literal.** Las palabras del paciente se anotan tal cual: son el guion de la Fase 9.
- **Sin juicio.** Nunca se reprocha la higiene, el abandono ni tratamientos anteriores.

REGISTRO ESTRUCTURADO DE EXPECTATIVAS

AMPLIACIÓN

Motivo declarado:

«.....»

Funcional: 0-10:

Estética: 0-10:

Emocional / impacto en su vida:

.....

Criterio de éxito del paciente:

.....

Experiencias previas y miedos:

.....

INDICADORES

Preguntas de expectativas por consulta ≥ 6, cubriendo las 4 dimensiones

Consultas con imágenes de cámara intraoral

AMPLIACIÓN

100 %

ERRORES A EVITAR

- Reducir la anamnesis a una sola pregunta genérica

- No usar la cámara intraoral por prisa

CRONOLOGÍA DE LA EXPLORACIÓN

AMPLIACIÓN

0:00 – 5:00 Las cuatro dimensiones de expectativas.	5:00 – 8:00 Exploración extraoral y ATM.	8:00 – 12:00 Exploración intraoral sistemática y sondaje.	12:00 – 15:00 Cámara intraoral sobre las zonas clave, explicando en pantalla.
--	---	--	--

PROTOCOLO SISTEMÁTICO DE EXPLORACIÓN

AMPLIACIÓN

ORDEN	EXPLORACIÓN	QUÉ SE REGISTRA
1	Extraoral: simetría, perfil, tercios faciales, línea de sonrisa	Descripción y fotografía
2	ATM: apertura, desviación, chasquidos, dolor a la palpación	Milímetros de apertura y hallazgos
3	Musculatura y ganglios cervicofaciales	Normalidad o hallazgo
4	Tejidos blandos: labios, mucosas, lengua, suelo de boca, paladar	Cribado de lesiones
5	Periodontal: sondaje, sangrado, recesiones, movilidad, furcas	Periodontograma o índice
6	Dental por cuadrantes, diente a diente	Odontograma actualizado
7	Restauraciones y prótesis existentes	Estado y pronóstico
8	Oclusión: clase, guías, interferencias, facetas de desgaste	Hallazgos funcionales

Los diez componentes obligatorios del diagnóstico integral (Función 2.2) se cubren con esta secuencia más la lectura radiológica.

QUÉ CAPTURAR CON LA CÁMARA INTRAORAL

AMPLIACIÓN

- ☐ Cada zona que aparecerá en la presentación, sin excepción
- ☐ Una imagen de contraste: zona sana del propio paciente junto a la afectada
- ☐ Márgenes de restauraciones antiguas con filtración o fractura
- ☐ Encía inflamada o con recesión, frente a una zona estable
- ☐ Desgastes y fisuras a alto aumento
- ☐ El detalle estético que el paciente mencionó como preocupación

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

AMPLIACIÓN

Diga

- «¿Qué le gustaría poder hacer que ahora no puede?»
- «Del 0 al 10, ¿cuánto le afecta esto en su día a día?»
- «Voy a enseñárselo en pantalla para que lo vea usted mismo.»
- «Esto de aquí está perfectamente; lo que hay que atender es esta zona.»

Evite

- «¿Cómo ha llegado usted a esta situación?»
- Dictar hallazgos en jerga delante del paciente sin traducirlos.
- Enseñar solo lo malo: sin referencia sana, la imagen no se entiende.
- Adelantar precios o plazos en pleno gabinete.
- Prometer resultados antes de terminar el análisis.

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Dolor agudo

Primero se alivia. La exploración completa puede esperar; el dolor, no. Se documenta la actuación de urgencia.

Expectativa irreal

Se dice con claridad qué no es alcanzable y se ofrece el mejor resultado realista, con evidencia visual.

Solo quiere estética

La salud precede a la estética; se secuencía el plan sin renunciar a su objetivo.

Lesión sospechosa

Prioridad diagnóstica sobre cualquier plan estético; derivación y seguimiento documentados el mismo día.

El paciente se emociona

Pausa, agua, tiempo. No se continúa hasta que el paciente lo indique.

Acompañante que interviene

Se le integra con respeto, pero las preguntas se dirigen siempre al paciente.

Objetivo de la fase

Comprender las necesidades funcionales, estéticas y emocionales del paciente, completar el diagnóstico clínico y capturar evidencia visual para la presentación.

CHECKLIST DE SALIDA

- ☐ **Expectativas** de las 4 dimensiones registradas
- ☐ **Exploración** completa
- ☐ **Imágenes de cámara intraoral** capturadas y cargadas

FASE 08 / 14

08

Tiempo

10 minutos

Responsable

Director redacta · Doctor dicta, valida y firma

Ubicación

Gabinete

IAC, solicitud de presupuesto e informe

Aquí se crea el documento que sostiene legal y clínicamente todo lo demás: el Informe de Análisis Clínico (IAC). El principio de separación: el Doctor decide el contenido clínico (dicta), el Director lo redacta, pero el Doctor valida y firma. Ante una reclamación o inspección, el IAC es la prueba de que el diagnóstico y el plan fueron correctos, completos y documentados. Un tratamiento excelente sin IAC es indefendible.

ACCIONES CLAVE

- **Dictado exhaustivo.** El Doctor dicta hallazgos clínicos (pieza por pieza, patologías, oclusión/ATM), hallazgos radiológicos (nivel óseo, infecciones, anatomía, calidad ósea), diagnóstico (principal, secundarios, pronóstico) y plan por fases.
- **Redacción del IAC.** El Director redacta mientras el Doctor dicta, con datos, fecha y motivo.
- **Revisión y firma.** El Doctor repasa, corrige y firma. Documento con valor legal y clínico.
- **Solicitud de presupuesto.** El Doctor firma la solicitud que autoriza al Director a presupuestar. Sin ella, no se elabora presupuesto.
- **Informe de ortodoncia (si aplica).** Smartee Doctor y/o Spark Approver, adjunto al IAC.
- **Entrega a Recepción.** Inmediata, para escaneo y subida el mismo día.

Regla nuclear

Sin solicitud de presupuesto firmada por el Doctor, no se elabora presupuesto.

Es la separación que protege al paciente y al centro: quien decide qué es clínicamente necesario no es quien lo vende.

ESTRUCTURA DEL IAC

SECCIÓN	CONTENIDO
Datos	Paciente, fecha, motivo de consulta
Hallazgos clínicos	Estado general, pieza por pieza, patologías, oclusión / ATM
Hallazgos radiológicos	CBCT / OPG, nivel óseo, infecciones, anatomía, calidad ósea
Diagnóstico	Principal, secundarios, pronóstico
Plan de tratamiento	Fase 1 (urgencias), Fase 2 (principal), Fase 3 (estética), alternativas

REGLAS DE REDACCIÓN

AMPLIACIÓN

- **Objetivo, no comercial.** Se describe lo que se observa; los adjetivos de venta no entran en un documento clínico.
- **Sin promesas.** «Pronóstico favorable» sí; «resultado garantizado» no.
- **Trazable.** Cada afirmación debe poder señalarse en una imagen o en la exploración.
- **Comprensible.** Término técnico seguido de su equivalente en lenguaje llano.
- **Sin importes.** El IAC es clínico; el presupuesto es otro documento.
- **Versionado.** Si el plan cambia, se emite un IAC nuevo fechado; no se corrige uno firmado.

INDICADORES

Tiempo entre firma y entrega a Recepción	< 10 min
IAC con discrepancias en auditoría	< 2 %

ERRORES A EVITAR

- Que el Director redacte hallazgos no dictados
- Elaborar el presupuesto sin solicitud firmada
- Retrasar la entrega a Recepción

PLANTILLA COMPLETA DEL IAC

AMPLIACIÓN

INFORME DE ANÁLISIS CLÍNICO

Centro de Excelencia Implantológica Alma

Paciente: N.º de historia:
 Fecha de exploración: Doctor:

1. MOTIVO DE CONSULTA

«.....»

2. ANTECEDENTES RELEVANTES Médicos: Dentales:**3. HALLAZGOS CLÍNICOS**

Estado general de salud oral:

.....

Hallazgos por sector / pieza:

.....

Periodontal:

.....

Oclusión y ATM:

.....

4. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

CBCT:

.....

OPG:

.....

Nivel óseo · calidad y cantidad:

.....

5. DIAGNÓSTICO Principal: Secundarios:

Pronóstico: general por pieza

6. PLAN DE TRATAMIENTO PROPUESTO

Fase 1 – urgencias y preparación:

.....

Fase 2 – tratamiento principal:

.....

Fase 3 – estética y mantenimiento:

.....

Alternativas:

.....

Duración estimada: N.º de citas:

7. OBSERVACIONES Y FACTORES QUE CONDICIONAN EL PRONÓSTICO

.....

Firma del Doctor: N.º de colegiado: Fecha:

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

AMPLIACIÓN

SOLICITUD DE PRESUPUESTO (autoriza al Director a presupuestar)

Paciente: Historia:

Basada en el IAC de fecha:

Tratamientos autorizados a presupuestar:

Fase 1:

.....

Fase 2:

.....

Fase 3:

.....

Alternativa a presupuestar (si procede):

.....

Firma del Doctor: Fecha:

Sin este documento firmado no se elabora presupuesto. Es la separación que protege al paciente y al centro: quien decide qué es clínicamente necesario no es quien lo vende.

VALIDEZ, CUSTODIA Y VERSIONADO

AMPLIACIÓN

- ☐ **Original firmado** para el paciente
- ☐ **Copia digitalizada** en Clinic Cloud el mismo día
- ☐ **Versionado:** si el plan cambia, se emite un IAC nuevo fechado, sin destruir el anterior
- ☐ **Correcciones** antes de la firma; nunca tachaduras sobre documento firmado
- ☐ **Conservación** conforme a la normativa de historia clínica aplicable

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Hallazgo incidental grave

Se refleja con su prioridad, se comunica el mismo día y se documenta la derivación y el receptor.

Pide el informe para otra clínica

Se entrega sin retenciones: es su derecho y refuerza la credibilidad del centro.

Requiere estudio adicional

El IAC recoge el diagnóstico provisional y la prueba pendiente; se cita para completarlo.

Plan modificado tras el presupuesto

Nuevo IAC fechado y firmado: el presupuesto siempre cuelga de un informe vigente.

Paciente que no acepta

Recibe igualmente su IAC. Es el documento que le acompañará si vuelve dentro de un año.

Caso de ortodoncia

Informe de Smartee o Spark adjunto al IAC, indicando con qué herramienta se planificó.

Objetivo de la fase

Crear un documento oficial, preciso y completo que refleje el diagnóstico profesional, sirva de base para la propuesta económica y tenga validez legal y clínica.

CHECKLIST DE SALIDA

☐ **IAC y solicitud de presupuesto** firmados

☐ **Informe de ortodoncia** adjunto si aplica

☐ **Entregado físicamente** a Recepción

FASE 09 / 14

09

Tiempo

15 minutos

Responsable

Doctor / Director

Ubicación

Gabinete de explicación

Criticidad

Fase de conversión

Presentación del diagnóstico y plan

Primera de las dos fases donde se gana o se pierde al paciente. Aquí pasa de «me han mirado» a «entiendo lo que tengo y por qué necesito tratarlo». Si falla, no hay cierre posible: nadie compra la solución a un problema que no ha entendido. El principio: no se presenta un tratamiento, se presenta un problema y su solución, en ese orden.

Verificación crítica

Antes de empezar, el Director verifica que TODO el material esté cargado: CBCT, OPG, fotografías extraorales e intraorales, imágenes de cámara intraoral e informe de ortodoncia si aplica.

Descubrir a mitad de presentación que falta una imagen destruye la credibilidad y la conversión.

ACCIONES CLAVE

- **Presentar el problema.** Empezar por la zona problemática, con imagen 3D, zoom y marcado.
- **Demostrar con evidencia.** Comparar con la normalidad usando las imágenes propias del paciente.
- **Mostrar consecuencias.** Qué pasa si no se trata, en términos comprensibles y sin exagerar.
- **Storytelling clínico.** Conectar con las expectativas de la Fase 7; el paciente como protagonista.
- **Presentar el plan (Director).** Por fases, tiempos, diferenciadores y garantías.

- **Resolver dudas clínicas.** Antes de pasar a lo económico.

Guion · storytelling, conexión con la Fase 7

«Usted me comentaba antes que le preocupaba [expectativa concreta que dijo el paciente]. El plan que le proponemos está pensado precisamente para resolver eso.»

CHECKLIST DE MATERIAL · ANTES DE QUE
ENTRE EL PACIENTE

AMPLIACIÓN

- ☐ **CBCT** abierto y navegable
- ☐ **OPG** visible y con calidad de proyección
- ☐ **Fotografías extraorales**, serie completa
- ☐ **Fotografías intraorales**, serie completa
- ☐ **Cámara intraoral**: capturas de la Fase 7
- ☐ **Informe de ortodoncia** si aplica
- ☐ **IAC firmado** disponible
- ☐ **Sala preparada**: pantalla, asientos junto al paciente, sin interrupciones

SECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN

AMPLIACIÓN

- 01 Recapitular con sus palabras**
«Usted vino porque...» — el paciente reconoce que se le escuchó.
- 02 Empezar por lo que está sano**
Delimita el alcance y da credibilidad: no todo es problema.
- 03 Mostrar el hallazgo con referencia**
Zona normal del propio paciente frente a la zona afectada, en la misma pantalla.
- 04 Explicar la causa y el síntoma**
Unir lo que se ve con lo que el paciente nota.
- 05 Proyectar la evolución sin tratar**
Realista, nunca alarmista: la exageración se detecta y arruina la confianza.
- 06 Presentar el plan por fases**
Tiempos, número de citas, diferenciadores y garantías por escrito.
- 07 Comprobar comprensión**
«¿Me lo puede resumir usted?» Si no puede, la presentación no ha terminado.

INDICADORES

Presentaciones con checklist de material completo	100 %
¿El paciente puede repetir el diagnóstico con sus palabras?	Sí, verificado

ERRORES A EVITAR

- Empezar sin verificar material
- Jerga médica excesiva
- Presentar el tratamiento antes que el problema
- No conectar con las expectativas
- Pasar a lo económico con dudas clínicas abiertas

CRONOLOGÍA DE LA PRESENTACIÓN

AMPLIACIÓN

-5 min El Director verifica material y sala.	0:00 – 2:00 Recapitulación con las palabras del paciente.	2:00 – 7:00 Evidencia: de lo general a lo concreto.	7:00 – 11:00 Plan por fases, tiempos y número de citas.
11:00 – 15:00 Preguntas y comprobación de comprensión.			

GUIÓN DE LA PRESENTACIÓN

AMPLIACIÓN

1. RECAPITULAR

«Usted vino porque [motivo con sus palabras] y me dijo que lo que más le afecta es [prioridad]. Vamos a ver qué hemos encontrado.»

2. EMPEZAR POR LO SANÓ

«Antes de nada: esto de aquí está bien, y esto también. No hay que tocarlo.»

3. MOSTRAR EL PROBLEMA

«Mire esta imagen. Aquí debería verse [referencia normal] y en su caso vemos [hallazgo]. Se lo enseño también en la foto de su boca.»

4. EXPLICAR LA CAUSA

«Esto ocurre porque [mecanismo], y por eso usted nota [síntoma].»

5. PROYECTAR SIN TRATAMIENTO

«Si no hacemos nada, lo previsible es [evolución realista].»

6. PRESENTAR LA SOLUCIÓN

«El plan tiene tres fases: [1], [2] y [3]. En total, [tiempo] y [n.º] citas.»

7. CERRAR EL CÍRCULO

«Volviendo a lo que me dijo al principio: esto le devuelve [criterio de éxito].»

8. COMPROBAR

«¿Me lo puede resumir usted, para asegurarme de que lo he explicado bien?»

PUESTA EN ESCENA**AMPLIACIÓN**

- Paciente y acompañante frente a la pantalla, nunca de lado
- El profesional se sienta junto al paciente: se mira juntos la imagen, no se le interroga
- Puntero o marcado en pantalla; señalar con el dedo sobre el monitor distrae y ensucia
- Una imagen por idea: navegar sin rumbo entre cortes agota la atención
- Ritmo lento y pausas: el silencio después de una evidencia hace más que un argumento
- Móviles en silencio, puerta cerrada, sin interrupciones salvo urgencia real

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR**AMPLIACIÓN**

Diga

- «Se lo enseño y me dice si lo ve tan claro como yo.»
- «Esto hay que tratarlo sí o sí; esto otro es opcional y puede esperar.»
- «Hay una alternativa más sencilla; le explico qué gana y qué pierde con ella.»
- «¿Qué duda le queda? Prefiero resolverla ahora que dentro de un mes.»

Evite

- «Si no se trata ya, va a perder todos los dientes.»
- Acumular hallazgos sin jerarquía hasta abrumar.
- Hablar diez minutos seguidos sin preguntar nada.
- Desacreditar el trabajo de otros profesionales.
- Mezclar el precio con el diagnóstico: cada cosa en su fase.

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

El paciente se bloquea

Se para, se resume en tres frases y se le ofrece continuar otro día con la documentación en la mano.

Discute el diagnóstico

Se agradece la pregunta y se vuelve a la imagen. La evidencia no se defiende: se enseña otra vez.

Plan muy extenso

Se presenta por fases y se acuerda empezar por lo urgente, sin exigir decisión sobre el conjunto.

Acompañante escéptico

Se le implica y se le muestran las mismas imágenes: será quien opine en el coche de vuelta.

Trae otro presupuesto

Se compara alcance y contenido, nunca cifras sueltas: qué incluye cada plan, con qué materiales y qué garantía.

Barrera idiomática

Presentación más visual, frases cortas y comprobación frecuente de comprensión.

Objetivo de la fase

Que el paciente comprenda plenamente su problema y valore la solución, llegando predispuesto a la fase económica.

CHECKLIST DE SALIDA

- ☐ **Material verificado** al 100 %
- ☐ **Diagnóstico comprendido** por el paciente
- ☐ **Dudas clínicas resueltas** antes del precio

FASE 10 / 14

10

Tiempo

20 minutos

Responsable

Director

Ubicación

Despacho

Criticidad

Fase de conversión

Propuesta económica y cierre

La segunda fase donde se gana o se pierde al paciente, y la más delicada. Aquí un diagnóstico aceptado se transforma en una decisión de tratamiento. El principio ético: se guía hacia la decisión, no se presiona. La regla de oro: el precio se justifica con valor, nunca con comparación ni con rebaja improvisada.

ACCIONES CLAVE

- **Justificar la inversión.** Antes del número, el valor: diagnóstico, tecnología, garantías.
- **Desglose línea por línea.** Transparencia total, cada partida explicada.
- **Presentar la financiación.** Opciones adaptadas, cálculo de la mensualidad, bonificación por pronto pago, plan por fases.
- **Cierre.** Por alternativa o por asunción, según el paciente.
- **Manejo de objeciones.** Con información, nunca con presión.
- **Registro de conversión.** Estado en Clinic Cloud, con la razón real de no conversión si aplica.

LA ESTRUCTURA DEL CIERRE

PARTE V · 6.2

- 01 Justificar el valor antes del número**
Diagnóstico, tecnología, materiales y garantías.
- 02 Presentar el plan completo**
El paciente ve el conjunto antes de ver el precio.
- 03 Desglose línea por línea**
Cada partida con su porqué.

04 Tres escenarios

Completo, por fases y sin tratamiento, con sus consecuencias.

05 Opciones de pago con cálculo en directo

Cuota, plazos y coste total dichos en voz alta.

06 Cierre

Por alternativa o por asunción, según la lectura del paciente.

MANEJO DE LAS OBJECIONES MÁS FRECUENTES

La regla común: nunca bajar el precio como primera reacción; siempre entender qué hay detrás.

«Es muy caro»

«Le entiendo, es una decisión importante. Pero no es un gasto puntual: es una inversión en su salud para las próximas décadas. Con las garantías que le comento, no solo resolvemos el problema de hoy, evitamos que vuelva. Para hacerlo manejable, ¿le ayudaría ver cómo queda la cuota a [X] meses?»

«Necesito pensarlo»

«Por supuesto. Para ayudarle mejor, ¿qué es concretamente lo que necesita pensar? ¿El precio, el tiempo, alguna duda clínica? Si es algo puntual, se lo resuelvo ahora mismo.»

«Voy a comparar precios»

«Me parece bien que se informe. Solo le pido que, al comparar, no mire solo el precio final: mire la tecnología con la que se diagnostica y planifica, los materiales y las garantías. Ahí está la diferencia real a largo plazo.»

Miedo al tratamiento

«Es muy comprensible, y me alegra que me lo diga. Trabajamos con sedación consciente para que no pase mal rato, y puede venir acompañado. ¿Le ayudaría que le explicara el proceso paso a paso?»

SECUENCIA OBLIGATORIA ANTE UNA
OBJECCIÓN DE PRECIOPARTE V ·
6.2**01 Valor**

Reencuadrar como inversión.

02 Facilidades

Financiación y cuota mensual.

03 Fases

Plan integral ejecutado por etapas.

04 Y solo entonces, si procede y con autorización: descuento

Dentro de tabla y con registro. Nunca como primera respuesta ni fuera de política.

SEÑALES DE DECISIÓN

AMPLIACIÓN

Quiere avanzar

- Pregunta por fechas, duración o baja laboral
- Pregunta por cuidados posteriores
- Busca confirmación en el acompañante
- Repite en voz alta la cuota mensual

Aún no

- Vuelve al importe total sin escuchar la respuesta
- Responde con monosílabos tras haber conversado
- Pide documentación «para llevársela» sin preguntas
- Menciona por primera vez a alguien ausente

Ante señales de que aún no, el objetivo deja de ser cerrar hoy y pasa a ser cerrar bien: acordar el siguiente paso, con fecha, y registrarlo.

INDICADORES

Tasa de conversión	Creciente
Ticket medio aceptado vs. presentado	Se mide
Razones de no conversión registradas	100 %

ERRORES A EVITAR

- Bajar el precio como primera respuesta
- Presión con urgencia falsa
- Aceptar «me lo pienso» sin explorar

- No registrar la razón de no conversión
- Prometer descuentos fuera de política

CRONOLOGÍA DEL CIERRE

AMPLIACIÓN

0:00 – 3:00 Recapitulación del plan y del criterio de éxito del paciente.	3:00 – 8:00 Presupuesto línea a línea, con justificación de cada partida.	8:00 – 13:00 Tres escenarios y simulación de pago en directo.	13:00 – 18:00 Objeciones y ajuste de la propuesta.
18:00 – 20:00 Decisión, firma o acuerdo de seguimiento, y registro.			

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

AMPLIACIÓN

PRESUPUESTO DE TRATAMIENTO N.º Fecha:
 Paciente: Historia:
 Basado en el IAC de fecha y en la solicitud firmada por Dr./Dra.

FASE 1 – Urgencias y preparación

Concepto Piezas Uds Importe

FASE 2 – Tratamiento principal

Concepto Piezas Uds Importe

FASE 3 – Estética y mantenimiento

Concepto Piezas Uds Importe

Subtotal Bonificación por pago anticipado TOTAL

INCLUYE: planificación digital, materiales, laboratorio, revisiones del plan

y seguimiento durante el tratamiento.

NO INCLUYE: tratamientos no descritos, complicaciones ajenas al plan y mantenimientos posteriores al alta.

GARANTÍA: según condiciones vigentes entregadas por escrito.

VALIDEZ: días.

Firma de aceptación del paciente Fecha

Un presupuesto sin apartado de exclusiones genera conflictos más adelante: lo que no está escrito, el paciente lo da por incluido, y con razón.

LOS TRES ESCENARIOS

AMPLIACIÓN

ESCENARIO	QUÉ SE EXPLICA	CUÁNDO ENCAJA
Plan completo	Todas las fases, tiempo total y resultado final; la vía más eficiente en coste y en número de citas	Paciente decidido y con capacidad de asumirlo
Por fases	Qué se resuelve en cada etapa, qué queda estable al terminar cada una y qué se pospone	Limitación económica o de tiempo, con el plan íntegro documentado
Sin tratamiento	Evolución previsible, con qué velocidad y qué coste tendría resolverlo más tarde	Siempre: es el término de comparación honesto

FINANCIACIÓN · OPERATIVA

AMPLIACIÓN

PASO	QUÉ SE HACE	DOCUMENTACIÓN
1	Simulación delante del paciente, con importe total y número de plazos	Impresión o pantalla de la simulación
2	Información precontractual: importe financiado, plazos, intereses y coste total	Documento de la entidad
3	Solicitud con los datos del titular	Documento de identidad y justificantes según entidad
4	Respuesta de la entidad	Aprobación o denegación registrada en Clinic Cloud
5	Firma del contrato y calendario de pagos	Copia al paciente y copia digitalizada
6	Vinculación del calendario de pagos al calendario clínico	Aviso a RAC con la fecha realista

- El coste total y el número de cuotas se dicen en voz alta, aunque el paciente solo pregunte por la mensualidad
- Ninguna condición se promete antes de la respuesta de la entidad
- Si se deniega, se ofrece alternativa el mismo día: plan por fases, otra entidad o aplazamiento acordado
- La firma de financiación nunca se plantea como requisito para recibir el diagnóstico

OBJECIONES · QUÉ SIGNIFICAN REALMENTE

AMPLIACIÓN

LO QUE DICE	LO QUE SUELE SIGNIFICAR	RESPUESTA	ERROR A EVITAR
«Es muy caro»	No ve la relación entre lo que cuesta y lo que recibe	Volver al desglose y al alcance; ofrecer fases o financiación	Bajar el precio de inmediato

LO QUE DICE	LO QUE SUELE SIGNIFICAR	RESPUESTA	ERROR A EVITAR
«Necesito pensarlo»	Queda una duda concreta sin resolver	«¿Qué parte concretamente quiere pensar?» y resolver esa	Aceptar la frase sin explorarla
«Tengo que consultarlo»	La decisión es compartida	Ofrecer llamada conjunta o segunda cita con esa persona	Presionar sin quien decide
«Voy a comparar»	No sabe en qué se diferencian los presupuestos	Dar criterios por escrito: alcance, materiales, garantía, pruebas incluidas	Criticar a la competencia
«Más adelante»	No percibe urgencia o teme el tratamiento	Explicar qué se agrava con el tiempo y qué no; acordar revisión	Inventar una urgencia
«¿No hay algo más sencillo?»	Busca una entrada más asumible	Presentar la alternativa real con sus límites, por escrito	Improvisar un plan B no validado por el Doctor
«Me da miedo»	Experiencia previa o anticipación del dolor	Sedación consciente, citas cortas, acompañamiento, testimonios	Restar importancia al miedo
Silencio	Está calculando o abrumado	Callar y esperar; luego preguntar qué le ronda	Llenar el silencio con más argumentos

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Financiación denegada

Se comunica con discreción y sin juicio, y se ofrece alternativa el mismo día.

Seguro dental

Se comprueba cobertura real y se presenta el presupuesto completo, indicando qué cubre la póliza.

Paga un tercero

El titular del pago firma; el paciente sigue siendo el titular de la información clínica.

Quiere empezar por lo urgente

Se acepta y se documenta el plan completo, con revisión de las fases pendientes en fecha acordada.

Regatea

No se negocian tarifas; se negocia alcance, secuencia y forma de pago, dentro de política.

Acepta y se arrepiente

Se respeta el desistimiento, se documenta y se mantiene la relación abierta sin reproches.

REGISTRO DE CONVERSIÓN EN CLINIC CLOUD

AMPLIACIÓN

CAMPO	OBLIGATORIO	DETALLE
Estado de la PV	Sí	Convertida / No convertida / Pendiente de decisión
Presupuesto presentado	Sí	Importe total propuesto
Presupuesto aceptado	Sí	Importe efectivamente aceptado
Método de pago	Sí	Contado / Financiación / Por fases
Fecha prevista de inicio	Si aplica	Sujeta a la doble verificación de RAC
Razón de no conversión	Si aplica	Precio · pensarlo · consulta familiar · segunda opinión · miedo · timing
Observaciones	Recomendado	Contexto útil para el seguimiento de la Fase 12

GARANTÍA HABITUAL DEL CENTRO

Es la garantía que se comunica al paciente y la que aparece en el presupuesto.
Se entrega siempre por escrito junto con el presupuesto, nunca solo de palabra.

TRATAMIENTO	GARANTÍA	QUÉ CUBRE
Implante · fijación de titanio	10 años	Sustitución de la fijación por fracaso de osteointegración o fractura del implante
Prótesis fija sobre implantes	5 años	Corona, puente y componentes protésicos frente a fractura o descementado no atribuible a mal uso
Prótesis fija sobre diente	5 años	Corona y puente en las mismas condiciones

TRATAMIENTO	GARANTÍA	QUÉ CUBRE
Prótesis removable	2 años	Fractura de base o dientes protésicos; no cubre los rebases por reabsorción fisiológica
Restauraciones de composite	2 años	Fractura o pérdida de la restauración
Endodoncia	2 años	Retratamiento si fracasa el tratamiento inicial
Ortodoncia	Durante el plan	Cobertura mientras dure el tratamiento activo; la estabilidad posterior depende del uso de la retención indicada

Condiciones de la garantía

La garantía se mantiene si el paciente acude a las revisiones de mantenimiento con la periodicidad indicada por el Doctor.

Además: higiene adecuada acreditada en esas revisiones; uso de férula de descarga cuando esté indicada por bruxismo; y comunicación de cualquier incidencia en cuanto aparezca. Quedan fuera los traumatismos, el mal uso, las modificaciones hechas en otro centro y las complicaciones derivadas de patologías o hábitos comunicados y reflejados en el IAC, como el tabaquismo en implantología.

Regla de veracidad

Estos son los plazos habituales del centro y son los únicos que se comunican. Prevalece siempre el **documento de condiciones de garantía** firmado y entregado al paciente. Marcas de implante, tasas de éxito y cualquier cifra distinta a esta tabla solo se mencionan si constan en la ficha de datos verificables que mantiene Dirección. Dirección revisa esta tabla una vez al año.

TABLA DE DESCUENTOS AUTORIZADOS

DECISIÓN 7

El descuento es la última herramienta, nunca la primera. Existe una tabla precisamente para que nadie tenga que negociar precios bajo presión: lo que está en la tabla se aplica; lo que no está, se consulta.

La matemática que casi nadie hace

Un descuento no reduce la facturación en el porcentaje que se aplica: reduce el beneficio en mucho más. Sobre un tratamiento de 3.000 € con un margen del 40 %:

DESCUENTO	PRECIO FINAL	COSTES	BENEFICIO	BENEFICIO PERDIDO
0 %	3.000 €	1.800 €	1.200 €	—
5 % (150 €)	2.850 €	1.800 €	1.050 €	12,5 %

DESCUENTO	PRECIO FINAL	COSTES	BENEFICIO	BENEFICIO PERDIDO
10 % (300 €)	2.700 €	1.800 €	900 €	25 %
15 % (450 €)	2.550 €	1.800 €	750 €	37,5 %
20 % (600 €)	2.400 €	1.800 €	600 €	50 %

La regla de compensación

Un descuento del 10 % no cuesta el 10 %: cuesta la cuarta parte de lo que se gana con ese paciente.

Volumen adicional necesario = descuento ÷ (margen – descuento). Con un margen del 40 %, bajar los precios un 10 % obliga a vender un 33 % más solo para quedarse igual.

Estructura autorizada

CONCEPTO	% MÁXIMO SUGERIDO	AUTORIZA	ACUMULABLE
Pronto pago o anticipado	5–8 %	Director	Sí, con familiar
Familiar	5–10 %	Director	Sí, con pronto pago
Tratamiento combinado	5–10 %	Director	No
Paciente referido	Importe fijo o %	Director	No
Casos sociales	Caso por caso	Gerencia	—
Personal y familiares directos	A definir	Gerencia	—

Límite de acumulación recomendado: no superar el 15 %. Los porcentajes concretos los fija Dirección a partir del margen real del centro, calculando antes qué beneficio queda con cada uno. Revisión semestral con datos de margen real.

Reglas de aplicación

- ☐ Todo descuento se **registra en el sistema con su motivo**
- ☐ Todo descuento **consta en el presupuesto firmado**
- ☐ Todo descuento tiene **autorización identificable**
- ☐ Ningún descuento se comunica **antes de haber presentado el valor**
- ☐ Ningún descuento se ofrece como **primera respuesta** a una objeción de precio
- ☐ Fuera de tabla, **siempre Gerencia**

El descuento encubierto

La financiación al 0 % tiene un coste que asume la clínica y que rara vez se contabiliza como lo que es: un descuento. Se decide hasta cuántos meses se ofrece y con qué coste asumido, y se registra igual que cualquier otro.

ERROR FRECUENTE	CONSECUENCIA
No calcular el impacto real en margen	Descuentos que destruyen la rentabilidad
Descuento como primera respuesta	Devalúa el tratamiento y confirma que el precio estaba inflado
Descuentos verbales	Imposibles de controlar; generan agravios
No contabilizar el coste del 0 %	Margen que desaparece sin explicación
Permitir acumulación sin límite	Casos vendidos por debajo de coste
Tabla demasiado generosa	Se convierte en el precio real

Objetivo de la fase

Transformar el diagnóstico aceptado en decisión de tratamiento, con un paciente convencido que además recomienda.

CHECKLIST DE SALIDA _____

- ☐ **Estado de conversión** registrado
- _____
- ☐ **Razón de no conversión** anotada si aplica
- _____
- ☐ **Financiación** planteada
- _____

FASE 11 / 14

11

Tiempo

5–10 minutos

Responsable

Recepción / Director

Ubicación

Recepción

Cierre administrativo y escaneo

Aquí se formaliza y se blinda todo. La experiencia termina con la misma pulcritud con la que empezó, y la trazabilidad documental queda garantizada. Es administrativa, pero con consecuencias legales directas.

SI EL PACIENTE ACEPTA

- Firma de aceptación (Director) y aceptación en el sistema.
- Escaneo y subida de toda la documentación (Recepción).
- **Aviso a RAC**, que abre el circuito de producción.
- Agenda de la siguiente cita y entrega de carpeta (Libro Alma, presupuesto, OPG, fotos, Tarjeta Personal).

SI NO ACEPTA

- Agradecimiento, puerta abierta, entrega de documentación y fecha de seguimiento programada.

DOCUMENTACIÓN A ESCANEAR EL MISMO DÍA☐ **Hoja de datos**☐ **RGPD**☐ **Consentimiento de uso de imágenes**, si se firmó☐ **Anamnesis**☐ **Consentimiento radiológico**☐ **IAC**

☐ **Solicitud de presupuesto**

☐ **Presupuesto aceptado** (si aplica)

☐ **Financiación** (si aplica)

Estos son los documentos que genera la primera visita. El **consentimiento quirúrgico**, el **checklist quirúrgico** y el **registro de trazabilidad de implantes** pertenecen a la Fase 13 y se digitalizan en ella. La lista completa, con quién produce cada documento y quién lo firma, está en el [Anexo 7 · Mapa maestro de documentos](#).

Regla nuclear

Ningún día se cierra con documentación sin subir.

Y ninguna aceptación se cierra sin avisar a RAC: sin ese aviso, el circuito de producción no arranca y el caso se convierte en producto pendiente invisible.

QUÉ SE ENTREGA EN LA CARPETA

AMPLIACIÓN

☐ **Libro Alma**

☐ **Presupuesto** con validez y exclusiones

☐ **Impresión de la OPG**

☐ **Fotografías clínicas** seleccionadas

☐ **Tarjeta Personal** con contacto directo

☐ **Copia del IAC** firmado

☐ **Instrucciones previas** si ya hay cita de tratamiento

INDICADORES

Documentación subida el mismo día	100 %
Aceptaciones con aviso a RAC	100 %

ERRORES A EVITAR

- Dejar el escaneo para el día siguiente
- No avisar a RAC
- Entregar carpeta incompleta
- No agendar seguimiento del no convertido

CRONOLOGÍA DEL CIERRE ADMINISTRATIVO

AMPLIACIÓN

0:00 – 2:00 Firma de aceptación y aceptación en el sistema.	2:00 – 4:00 Aviso a RAC con los datos completos del caso.	4:00 – 6:00 Agenda de la siguiente cita e instrucciones previas.	6:00 – 8:00 Entrega de la carpeta y repaso de su contenido.
8:00 – 10:00 Escaneo y subida de toda la documentación firmada.			

QUÉ INCLUYE EL AVISO A RAC

AMPLIACIÓN

- ☐ **Paciente y tratamiento** aceptado, por fases
- ☐ **Importe aceptado** y estado del pago
- ☐ **Ficha de material** de la planificación, si el Doctor ya la generó
- ☐ **Preferencias de fecha** del paciente
- ☐ **Condicionantes médicos** relevantes para programar
- ☐ **Financiación:** aprobada, en trámite o no aplica

Sin este aviso el circuito de producción no arranca y el caso se convierte en producto pendiente invisible.

INSTRUCCIONES PREVIAS SEGÚN EL TRATAMIENTO

AMPLIACIÓN

TIPO DE CITA	QUÉ SE INDICA	AVISO ADICIONAL
Cirugía o implantes	Comer antes salvo indicación contraria, medicación pautada, acudir acompañado, ropa cómoda	Prever reposo el resto del día
Sedación consciente	Ayuno según pauta, acompañante obligatorio, no conducir	Confirmación telefónica 24 h antes
Endodoncia	Prever una a dos horas de sillón, analgesia previa si hay dolor	Posible sensibilidad posterior
Periodoncia	Higiene reforzada los días previos	Sensibilidad transitoria tras el raspado
Prótesis y estética	Traer fotografías de referencia si las tiene	Prever pruebas intermedias
Ortodoncia	Higiene y registros previos	Calendario de revisiones

DIGITALIZACIÓN · NOMENCLATURA Y CONTROL

AMPLIACIÓN

Formato: AAAAMMDD_Apellido-Nombre_DOCUMENTO

20260318_Perez-Ana_DATOS-PERSONALES
 20260318_Perez-Ana_RGPD
 20260318_Perez-Ana_ANAMNESIS
 20260318_Perez-Ana_CONS-RADIOLOGICO
 20260318_Perez-Ana_IAC
 20260318_Perez-Ana_SOLICITUD-PRESUPUESTO
 20260318_Perez-Ana_PRESUPUESTO-ACEPTADO
 20260318_Perez-Ana_FINANCIACION

- Escaneo en color, legible, sin páginas giradas ni recortadas
- Todas las páginas, incluidas las que solo llevan firma
- Comprobación de que el archivo abre antes de archivar el papel
- Original al archivo físico según el circuito del centro
- Cierre de jornada: repaso de las PV del día contra la lista maestra de documentos

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Se marcha sin firmar

Se entrega igualmente la carpeta y se registra como pendiente de decisión, con fecha de seguimiento.

Financiación en trámite

Se programa de forma provisional y se documenta la condición; el contrato se sube al recibirlo.

Documento olvidado

Se digitaliza lo firmado, se anota lo pendiente y se acuerda cómo se completará.

Cita urgente el mismo día

Prioridad clínica; la digitalización se completa igualmente antes del cierre.

Escáner averiado

Captura con dispositivo autorizado del centro y subida inmediata; nunca desde un móvil personal.

Pide todo en digital

Se envía por el canal verificado en la Fase 3 y se registra el envío.

Objetivo de la fase

Formalizar la decisión, garantizar la trazabilidad documental y arrancar el circuito de producción o el de seguimiento según corresponda.

CHECKLIST DE SALIDA

- ☐ **Documentación 100 % subida**
- ☐ **RAC avisado** si hay aceptación
- ☐ **Carpeta entregada** completa
- ☐ **Siguiente cita o seguimiento** agendado

FASE 12 / 14

12

Tiempo

Post-visita

Responsable

Director / Recepción

Ubicación

Teléfono / Clinic Cloud

Despedida y seguimiento

La relación no termina en la puerta. Esta fase decide si un no convertido se recupera y si un convertido se fideliza. Es la más descuidada y una de las más rentables.

NO CONVERTIDOS · NURTURING SEGÚN LA OBJECCIÓN REGISTRADA

MOMENTO	ACCIÓN	CONTENIDO SEGÚN OBJECCIÓN	AMPLIACIÓN
Día 1-2	Llamada de cortesía	Sin venta: comprobar que quedó todo claro	
Día 7	Seguimiento según la objeción real	Económica → financiación · «pensarlo» → caso similar · miedo → sedación y testimonios	
Día 15	Propuesta ajustada	Plan por fases o condiciones revisadas	
Día 30	Contenido de valor	Material educativo sobre su tratamiento	
Día 60	Oferta especial	Condiciones vigentes, nunca inventadas	
Día 90	Check-in	Cortesía, sin propuesta	
Día 180	Reactivación	Revisión sin coste; diagnóstico previo en ficha	

Cada objeción, su contenido: económica → financiación; «pensarlo» → caso similar; miedo → sedación y testimonios; segunda opinión → seguimiento suave.

CONVERTIDOS · FIDELIZACIÓN

Email de bienvenida → recordatorio pre-cita → kit de bienvenida → seguimiento durante el tratamiento → programa de referidos → seguimiento post-tratamiento y revisiones.

Guion · Llamada de cortesía (convertido)

«Buenos días [nombre], le llamo del Centro Alma para saber qué tal está tras su visita. Le confirmo su cita del [día]. ¿Le ha surgido alguna duda sobre el plan?»

REGLAS DE CONTACTO**AMPLIACIÓN**

- Máximo dos intentos por acción programada, separados por al menos un día
- Tras un intento fallido, mensaje breve identificándose
- Si el paciente pide no ser contactado, se registra y se detiene la cadencia en todos los canales
- Cada contacto se registra con fecha, canal, resultado y siguiente paso
- El seguimiento lo hace quien conoció el caso; delegarlo en quien no estuvo destruye su valor

INDICADORES

No convertidos con tarea de re-contacto activa	100 %
Tasa de recuperación a 90 días	Se mide
Llamadas de cortesía realizadas	Se mide

ERRORES A EVITAR

- No programar el re-contacto
- Mismo guion para todos
- No registrar las respuestas

PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN**AMPLIACIÓN**

EMAIL DE BIENVENIDA – día 1, paciente convertido

Asunto: Su plan de tratamiento en el Centro Alma

Estimado/a [Nombre]:

Gracias por su confianza. Le resumimos lo acordado:

- Plan: [fases principales]
- Primera cita: [fecha y hora]
- Instrucciones previas: [detalle]

Adjuntamos su informe de análisis clínico y el presupuesto aceptado.

Para cualquier duda: [teléfono] · [WhatsApp].

WHATSAPP – 48 h antes de la cita

Hola [Nombre], le recordamos su cita el [día] a las [hora] en el Centro Alma. [Instrucción previa]. Si necesita cambiarla, respóndanos aquí.

WHATSAPP – 24 h antes de la cita

Hola [Nombre], le esperamos mañana [día] a las [hora]. [Instrucción previa].

Si le surge cualquier imprevisto, avísenos por aquí y le buscamos otro hueco.

EMAIL – no convertido, objeción económica, día 7

Asunto: Opciones para su tratamiento

Tras su visita hemos revisado su caso y podemos ofrecerle [opción concreta].

Le adjuntamos la simulación. Si le parece bien, le llamamos [día] a las [hora].

MENSAJE – reactivación, día 180

Hola [Nombre], soy [Nombre] del Centro Alma. Hace unos meses estudiamos su caso. ¿Le gustaría que revisáramos cómo está la situación? La revisión no tiene coste y su diagnóstico previo sigue en su ficha.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y RESEÑAS

AMPLIACIÓN

- **Pregunta principal:** «Del 0 al 10, ¿qué probabilidad hay de que nos recomiende a un amigo o familiar?»
- **Pregunta abierta:** «¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado de su visita?»
- **Momento:** tras la PV para el circuito, y al alta para el tratamiento
- **De 0 a 6:** llamada del Director en 48 h para entender qué falló
- **De 9 a 10:** invitación a dejar reseña pública y al programa de referidos
- **Regla ética:** se invita a todos por igual y nunca se ofrece contraprestación por una reseña positiva

PROGRAMA DE REFERIDOS

AMPLIACIÓN

PASO	ACCIÓN	RESPONSABLE
1	Invitación en el momento de mayor satisfacción: alta o resultado visible	Director
2	Entrega de material con el código del paciente	Recepción
3	Registro del referido en la ficha de quien recomienda	Recepción
4	Agradecimiento en cuanto el referido acude	Director
5	Aplicación del incentivo según condiciones vigentes	Dirección
6	Medición: referidos por paciente y conversión de referidos	Dirección

El referido es el paciente con mayor tasa de conversión y menor coste de captación de todo el sistema. Merece un circuito tan cuidado como una campaña.

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

No coge el teléfono

Dos intentos, mensaje identificándose y cambio de canal antes de dar por perdido el contacto.

Responde con enfado

Escucha sin defenderse, registro del motivo y traslado al Director; nunca se responde por escrito en caliente.

Pide no ser contactado

Baja inmediata de la cadencia en todos los canales, registrada con fecha.

Se fue a otro centro

Se agradece la sinceridad, se pregunta qué pesó en la decisión y se cierra el caso con esa información.

Vuelve meses después

Se revisa la vigencia del diagnóstico; pasados seis meses se repiten las pruebas que corresponda.

Reseña negativa pública

Respuesta institucional, breve y sin datos clínicos, ofreciendo resolverlo por teléfono. La responde Dirección.

Objetivo de la fase

Recuperar a los no convertidos y fidelizar a los convertidos, alimentando la captación del siguiente paciente.

CHECKLIST DE SALIDA

☐ **Re-contacto** programado según objeción☐ **Convertido** con bienvenida y recordatorio☐ **Respuestas registradas** en Clinic Cloud

FASE 13 / 14

13

Tiempo

Post-aceptación

Responsable

RAC

Ubicación

Coordinación interna

Indicador rector

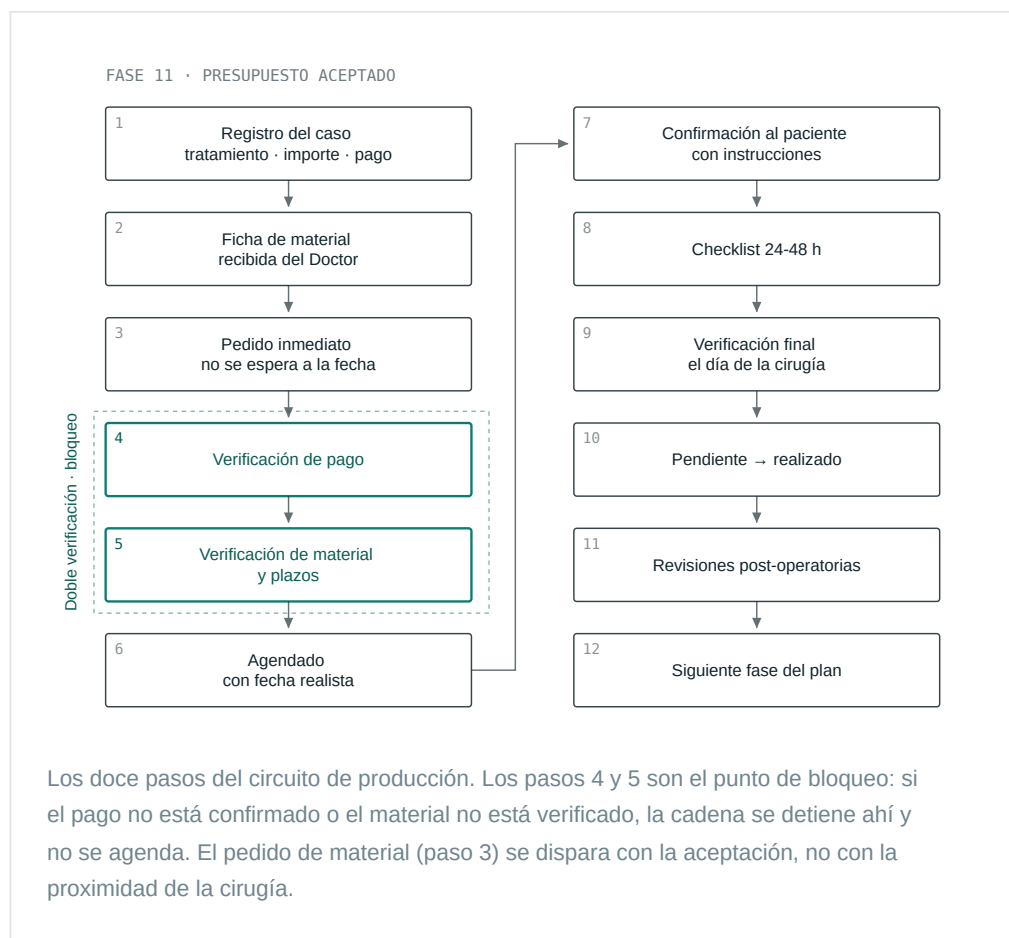
Producto pendiente

Circuito de producción

Aquí se cierra el círculo: lo vendido se convierte en lo ejecutado. Una venta no es un éxito hasta que el tratamiento se ha realizado. Un presupuesto aceptado que no se ejecuta es un riesgo, no un logro. El indicador que gobierna la fase es el producto pendiente: cuanto más bajo, más sana la clínica.

ACCIONES CLAVE

- **Apertura del caso.** Al recibir el aviso de la Fase 11, se registra el caso.
- **Verificación de pago.** Nunca se agenda sin confirmar.
- **Verificación de material.** Con el Auxiliar; si hay que pedirlo, se ajusta la fecha.
- **Confirmación al paciente.** Con instrucciones pre-quirúrgicas.
- **Checklist 24-48 h.** Pago, material, consentimiento quirúrgico, quirófano y equipo.
- **Día de la cirugía.** Verificación final de que nada ha cambiado.
- **Tras la cirugía.** Producto pendiente → realizado; revisiones post-operatorias.
- **Seguimiento del panel.** Actualización continua del producto pendiente.



La doble verificación · regla de oro

Ninguna cirugía se agenda sin (1) pago confirmado y (2) material disponible. Las dos, siempre.

Es el único puesto con poder de bloqueo, y ninguna presión comercial lo anula.

CHECKLIST 24-48 H ANTES DE UNA CIRUGÍA

AMPLIACIÓN

- ☐ **Pago** confirmado
- ☐ **Material** físicamente disponible
- ☐ **Guía quirúrgica** recibida y probada, si aplica
- ☐ **Consentimiento quirúrgico** firmado
- ☐ **Quirófano** reservado con margen
- ☐ **Doctor y Auxiliar** confirmados
- ☐ **Anestesiólogo** confirmado si aplica
- ☐ **Paciente confirmado** con instrucciones pre-quirúrgicas

Si algo falla, se resuelve o se reprograma. Nunca se llega al día con una casilla sin marcar.

INDICADORES

Producto pendiente total	Tendencia descendente
Tiempo medio aceptación → ejecución	Mínimo
Casos con más de 6 meses	0

ERRORES A EVITAR

- Agendar sin verificar pago
- No verificar material a tiempo
- No actualizar el producto pendiente
- No priorizar casos antiguos

REGLAS DE BLOQUEO POR LÍNEA DE TRATAMIENTO

AMPLIACIÓN

LÍNEA	NO SE AGENDA SI...
Implantología estándar	Falta pago confirmado o material verificado
Cirugía guiada	La férula no está recibida y probada
Carga inmediata	El laboratorio no ha confirmado disponibilidad por escrito
Sedación	Falta valoración previa, consentimiento específico, acompañante confirmado, profesional competente o equipo de emergencia verificado
Ortodoncia	Los alineadores no han llegado

PANEL DE PRODUCTO PENDIENTE

AMPLIACIÓN

Paciente	Tratamiento	Importe	Cobrado	F. aceptación	Días	
Estado	Bloqueo					

ANTIGÜEDAD	RIESGO	ACTUACIÓN
> 6 meses	■ CRÍTICO	Contacto del Director en 72 h

ANTIGÜEDAD	RIESGO	ACTUACIÓN
3-6 meses	ALTO	Contacto en la semana
1-3 meses	MEDIO	Seguimiento estándar
< 1 mes	NORMAL	Circuito

SEGUIMIENTO POST-QUIRÚRGICO

AMPLIACIÓN

MOMENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE
Mismo día	Instrucciones postoperatorias entregadas por escrito y explicadas	Doctor · Auxiliar
Día 1	Llamada de control: dolor, sangrado, inflamación, medicación	RAC · Recepción
Día 3	Fotografía y cuestionario breve si el protocolo remoto aplica	Higienista
Día 7-10	Revisión presencial y retirada de sutura si procede	Doctor
Según plan	Siguiente fase agendada antes de que el paciente salga	RAC

Toda complicación, incluso leve, se registra con causa raíz y medida correctora (Función 2.6).

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Material que no llega a tiempo Se reprograma con el paciente informado antes de que se desplace. Nunca se improvisa con una referencia distinta sin criterio del Doctor.
El paciente pide adelantar Solo si la doble verificación está cerrada. La presión del paciente tampoco anula el bloqueo.
Pago parcial Se agenda solo la fase cubierta, con el resto documentado como pendiente.
Baja médica sobrevenida Se reprograma y se mantiene el caso vivo en el panel, con motivo registrado.
Caso heredado sin trazabilidad Se reconstruye con Dirección antes de agendar nada: pago, tratamiento pactado y estado real.

Cancelación el mismo día

Se registra el motivo, se recoloca el hueco (Función 1.2) y se reprograma de inmediato.

Objetivo de la fase

Garantizar que todo tratamiento aceptado y pagado se ejecute realmente, en el menor tiempo posible y sin incidencias.

CHECKLIST DE SALIDA

- ☐ **Pago y material** verificados
- ☐ **Paciente confirmado** con instrucciones
- ☐ **Panel de producto pendiente** actualizado

FASE 14 / 14

14

Tiempo

Recurrente

Responsable

Higienista

Ubicación

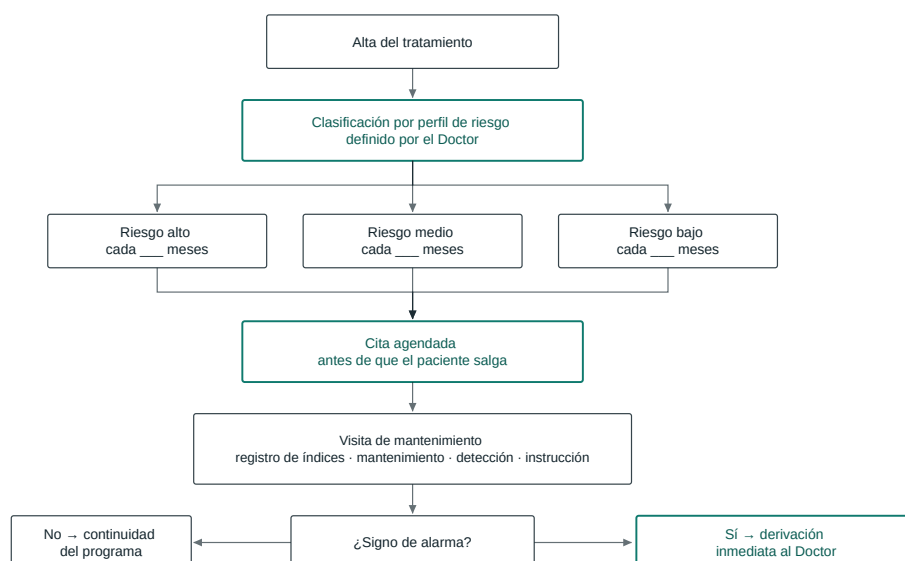
Gabinete de higiene

Mantenimiento y seguimiento a largo plazo

El recorrido no termina con la cirugía: continúa en el mantenimiento, que sostiene el resultado en el tiempo y da coherencia al nombre del centro. Es, además, una de las principales fuentes de fidelización y de producción recurrente. Un centro de excelencia implantológica se demuestra en el seguimiento de sus implantes.

ACCIONES CLAVE

- **Alta en el programa.** Todo portador de implantes entra en el programa de mantenimiento con calendario de revisiones.
- **Mantenimiento periimplantario.** Higiene y control según indicación del Doctor y competencia del higienista.
- **Detección precoz.** Signos de alarma periimplantaria, con derivación inmediata al Doctor.
- **Educación continua.** Refuerzo de la higiene del paciente en cada visita.
- **Reactivación.** Coordinación con Recepción para recuperar a los pacientes que se descuelgan del programa.



Arquitectura del programa de mantenimiento. Los dos pasos marcados son los que determinan su éxito: la clasificación por perfil de riesgo, que fija la periodicidad, y la cita agendada antes de que el paciente abandone la clínica.

La regla que determina el éxito

La próxima cita se agenda antes de que el paciente abandone la clínica. Sin excepción.

Es la variable que más determina la adherencia de todo el programa.

Delimitación competencial

El alcance concreto de las actuaciones clínicas del higienista lo determina su titulación y la normativa vigente. Este protocolo organiza la función; no amplía competencias.

REGISTRO OBLIGATORIO EN CADA VISITA

ELEMENTO	REGISTRO
Índices periodontales	Numérico, comparable
Estado periimplantario	Según protocolo
Estado de restauraciones	Observación
Higiene del paciente	Valoración
Hallazgos nuevos	Descripción

ELEMENTO	REGISTRO
Fotografía de control	Si procede

INDICADORES

Pacientes con implantes en seguimiento activo	Creciente
Adherencia al programa	≥ 80 %
Próxima cita agendada antes de salir	100 %

ERRORES A EVITAR

- No dar de alta al portador en el programa
- No derivar un signo de alarma de inmediato
- Registrar los índices de memoria al final del día

CONTENIDO DE LA VISITA DE MANTENIMIENTO

AMPLIACIÓN

Apertura Revisión del historial y de la última visita antes de que entre el paciente.	Registro Índices periodontales y estado periimplantario, anotados en el momento.	Mantenimiento Actuación según indicación del Doctor y competencia del higienista.	Detección Cribado de signos de alarma y de hallazgos nuevos.
Educación Instrucción de higiene adaptada a lo observado hoy.		Cierre Próxima cita agendada antes de que el paciente salga.	

SIGNOS DE ALARMA Y RESPUESTA

AMPLIACIÓN

SITUACIÓN	URGENCIA	ACTUACIÓN
Signo de alarma periimplantaria	■ INMEDIATA	Doctor en la misma visita
Dolor o inflamación	■ INMEDIATA	Doctor en la misma visita
Movilidad de implante o prótesis	■ INMEDIATA	Doctor en la misma visita
Caries o deterioro detectado	■ MISMA VISITA	Doctor
Progresión periodontal	■ MISMA VISITA	Doctor
Interés en tratamiento estético	■ MISMO DÍA	Dirección

SITUACIÓN	URGENCIA	ACTUACIÓN
Abandono del programa	■ SEMANAL	Dirección y Recepción

ATC · EL PROGRAMA QUE SOSTIENE EL MANTENIMIENTO

ALMA TE
CUIDA

El mantenimiento deja de depender de la buena voluntad del paciente cuando está pagado por adelantado y avisado por la clínica. Eso es **Alma Te Cuida**: revisiones y limpieza del año incluidas, urgencias sin cita y prioridad de agenda, para el titular y hasta tres personas más de su familia.

LO QUE CAMBIA	SIN ATC	CON ATC
Quién recuerda la revisión	El paciente	La clínica, que avisa cuando toca
Coste de cada visita	Se decide cada vez	Ya resuelto: no hay decisión que tomar
Adherencia al programa	Depende de la disciplina individual	Sostenida por lo ya pagado
Alcance	Individual	Familiar: hasta cuatro personas
Urgencias	Se busca hueco	Sin cita y con prioridad

Guion · Higienista, durante la visita de mantenimiento

«[Nombre], ya que viene a cuidarse, déjeme que le cuente algo que le va a compensar mucho. Con la tarjeta Alma Te Cuida, esta limpieza y las revisiones del año le saldrían incluidas. Y además lo puede compartir con hasta tres personas más de su familia. Prácticamente se paga sola solo con lo que ya viene a hacerse.»

- La renovación no es automática: la clínica avisa antes del vencimiento y el paciente decide libremente
- La tasa de renovación —objetivo, por encima del 80 %— es la medida real de si el mantenimiento aporta valor percibido
- El titular con tarjeta vencida y sin renovar entra en la cadencia de reactivación como cualquier otro paciente descolgado

REACTIVACIÓN DE QUIEN SE DESCUELGA

AMPLIACIÓN

- Listado semanal de portadores de implantes sin cita futura
- Primer contacto por el canal habitual del paciente, con mensaje de salud, no comercial
- Segundo intento a los siete días, cambiando de canal

- Si no responde, se marca para la campaña de reactivación y se registra el motivo si se conoce
- Al recuperarlo, se revisa si el diagnóstico previo sigue vigente antes de retomar el programa

CASOS ESPECIALES

AMPLIACIÓN

Portador tratado en otro centro

Se documenta qué sistema de implante lleva antes de intervenir sobre él; si no consta, se consulta al Doctor.

Higiene deficiente mantenida

Se acorta la periodicidad y se registra; nunca se reprocha.

Paciente que solo quiere «la limpieza»

Se hace lo indicado y se explica qué más se ha observado, sin convertir la visita en una venta.

Embarazo

Se prioriza el control gingival y se difiere lo no indicado.

Cambio de perfil de riesgo

Lo revalida el Doctor: la periodicidad no se cambia por criterio propio.

Paciente que se muda

Se le entrega su historial de mantenimiento y el perfil Alma para continuidad en otro centro.

DISEÑO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DECISIÓN 8

Delimitación

La periodicidad clínica la determina el responsable clínico según el perfil de riesgo de cada paciente y la evidencia. Lo que sigue es el marco de organización y de decisión de gestión.

Por qué es más estratégica de lo que parece

DIMENSIÓN	IMPACTO
Clínico	Detección precoz de complicaciones periimplantarias

DIMENSIÓN	IMPACTO
Coherencia de marca	Un centro de excelencia implantológica que no sigue sus implantes es una contradicción
Ingresos recurrentes	Es la única fuente de facturación predecible del centro
Fidelización	El paciente en mantenimiento no se va a otra clínica
Detección de tratamientos	Cada revisión es una oportunidad clínica legítima
Prescripción	El paciente que vuelve cada seis meses recomienda más

El dato de gestión que casi nadie ve: una base de 500 pacientes en mantenimiento semestral son 1.000 citas al año de facturación predecible, sin coste de captación.

Estratificación por riesgo

Una periodicidad única es cómoda pero ineficiente: satura la agenda con pacientes de bajo riesgo y deja cortos a los de alto.

NIVEL	PERFIL ORIENTATIVO	PERIODICIDAD
 ALTO RIESGO	Antecedentes periodontales, factores de riesgo relevantes, rehabilitaciones complejas	Más frecuente
 RIESGO MEDIO	Portador de implantes sin factores añadidos	Intermedia
 BAJO RIESGO	Buena higiene, sin antecedentes, casos simples	Menos frecuente

La asignación de nivel y la periodicidad concreta de cada uno las define el responsable clínico. La decisión de gestión es adoptar el modelo estratificado y dotarlo de agenda.

¿Incluido o facturado?

OPCIÓN	A FAVOR	EN CONTRA
A · Facturado siempre	Ingreso directo por cada visita	Barrera de entrada y menor adherencia; el paciente puede percibirlo como cobrar por revisar lo ya pagado
B · Incluido el primer año	Argumento de venta potente en la Fase 10, alta adherencia inicial y genera el hábito de volver	Coste asumido el primer año; exige reconvertir al paciente al año
C · Incluido siempre en tratamientos de alto importe	Diferencial competitivo fuerte y máxima fidelización	Coste recurrente permanente; debe estar en el precio desde el inicio

Recomendación

Opción B: mantenimiento incluido el primer año en el precio del tratamiento implantológico y facturado a partir del segundo, con tarifa preferente para pacientes del centro.

Es un argumento de cierre real sin bajar precio —se añade valor en lugar de restar importe—, genera el hábito de volver, que es lo difícil, y al segundo año el paciente ya está fidelizado.

Guion · la conversación de reconversión al año

«[Nombre], este año cumple el primer año desde su tratamiento y todo está funcionando bien, que es lo importante. Como sabe, el seguimiento del primer año estaba incluido. A partir de ahora, las revisiones de mantenimiento tienen un coste de [importe], que para pacientes nuestros es [tarifa preferente]. Le recomiendo mantener la periodicidad de [X meses] porque es lo que nos permite detectar cualquier cosa a tiempo. Un implante bien cuidado dura décadas; sin seguimiento, no lo podemos garantizar igual. ¿Le agendo la próxima?»

Es el momento crítico del programa: si se hace mal, se pierde al paciente. Nunca una factura sorpresa; siempre una conversación estructurada.

Organización operativa

ELEMENTO	DECISIÓN
Quién ejecuta	Higienista, con supervisión del Doctor
Franja de agenda	Preferentemente de baja demanda externa (13:30–16:00)
Convocatoria	Automática desde Clinic Cloud, con llamada si no responde
Antelación	2 a 3 semanas antes de la fecha objetivo
Si no acude	Reintento a 15 días, después a 3 meses y después a la campaña de reactivación

Pacientes que agendan antes de salir	100 %
Tasa de asistencia a mantenimientos	Establecer línea base
Tasa de reconversión al segundo año	Establecer línea base
Complicaciones detectadas en mantenimiento	Registrar todas

Objetivo de la fase

Sostener el resultado del tratamiento en el tiempo, detectar precozmente cualquier complicación y fidelizar al paciente en una relación a largo plazo.

CHECKLIST DE SALIDA

☐ **Portador dado de alta** en el programa

☐ **Revisión registrada** en el momento

☐ **Signos de alarma** derivados al Doctor

Con el mantenimiento se cierra el ciclo y comienza la relación a largo plazo con el paciente.



Matriz RACI

Quién es responsable, quién rinde cuentas, quién es consultado y quién informado.

La matriz RACI reparte, para cada fase, cuatro papeles. Evita el doble problema de que una tarea no tenga dueño o de que varias personas creen que es suya. Se lee así:

- **R (Responsable).** Ejecuta el trabajo.
- **A (Accountable).** Rinde cuentas del resultado; hay uno solo por fase.
- **C (Consultado).** Se le pide criterio antes de actuar.
- **I (Informado).** Se le comunica el resultado.

FASE	REC	DC	DR	AUX	DDC	RAC
1. Preparación previa	R/A	I	—	—	I	—
2. Recepción y tour	R	R/A	—	—	—	—
3. Anamnesis/RGPD y alta	R/A	R/A	—	—	—	—
4. Historial y consentimiento	—	I	R/A	—	—	—
5. Pruebas diagnósticas	—	I	C	R/A	—	—
6. Briefing	—	R/A	R/A	I	I	—
7. Anamnesis de expectativas	—	I	R/A	C	—	—
8. IAC / solicitud / informe	I	R	A	—	—	—
9. Presentación	—	R	R/A	I	—	—
10. Propuesta y cierre	I	R/A	C	—	I	—
11. Cierre administrativo	R/A	A	—	—	—	I
12. Seguimiento	R	R/A	—	—	A	—
13. Circuito de producción	I	C	C	C	I	R/A
14. Mantenimiento	C	I	C	—	I	—

El higienista (HIG) es R/A en la Fase 14 y consultado en el mantenimiento periimplantario; se integra en la matriz junto al resto de perfiles clínicos.

Cómo se usa esta matriz

AMPLIACIÓN

Ante una incidencia, se busca primero la **A** de la fase: esa persona responde del resultado, aunque no lo haya ejecutado. Ante una duda de criterio, se consulta a la **C** antes de decidir, no después. Y ninguna fase puede quedarse sin **A** por ausencias: si quien rinde cuentas no está, Dirección designa sustituto ese mismo día.

IV

Manuales por puesto

Misión, jornada, procedimientos, guiones e indicadores de cada perfil.

ANTES DE LAS FICHAS

Qué pasa exactamente cuando un puesto no cumple

MATRIZ DE OBLIGACIONES

Cada manual de puesto termina con sus indicadores. Esta tabla dice lo contrario: qué se rompe aguas abajo cuando algo no se hace. Casi ningún fallo se queda en el puesto que lo comete.

PUESTO	SI NO SE HACE...	LO QUE SE ROMPE
Recepción	No verificar duplicados antes de agendar	Historial fragmentado: el paciente acaba con dos fichas y ninguna completa
	Retrasar el alta en el sistema	El presupuesto se elabora con datos incompletos
	No escanear el mismo día	Pérdida de trazabilidad legal: lo firmado, a efectos prácticos, no existe
	No avisar a RAC tras una aceptación	El circuito de producción no arranca y el caso se queda en el limbo
Director	Retrasar la entrega de la anamnesis a Recepción	Alta atrasada y presentación con la ficha a medias
	Aviso incompleto a RAC	RAC no puede verificar el pago y la cirugía no se agenda
Doctor	Anamnesis superficial	Riesgo clínico directo: es el ítem de mayor exposición de toda la visita
	No firmar la solicitud de presupuesto	Bloquea al Director, que no debe elaborar presupuesto sin ella, y a RAC después
Auxiliar	Subir una imagen de baja calidad	Repetición de la prueba en plena presentación, delante del paciente
	Responder sobre material sin comprobarlo	Cirugía agendada sin material real, y cancelación el mismo día
RAC	Agendar sin pago confirmado	Riesgo de tratamiento ejecutado y no cobrado
	No verificar el material con antelación	Cancelación el mismo día, con el paciente ya preparado
	No actualizar el producto pendiente	Dirección pierde la visibilidad real de lo vendido y no entregado
Dirección de Centros	No seguir el producto pendiente	Dinero cobrado sin visibilidad de entrega, que es el origen de la mayoría de las reclamaciones

PUESTO · REC

Recepción

R.1 · Misión y ámbito

Ser el sistema nervioso del centro: todo entra y sale por aquí, y nada se pierde.

Recepción es el primer y el último contacto del paciente, y el guardián de la trazabilidad documental. Su ámbito abarca la gestión de la demanda (todos los canales de entrada), la arquitectura de la agenda (diseño, ocupación y recuperación), la custodia documental, la gestión económica de mostrador y el seguimiento (confirmaciones, cortesía, recuperación).

R.2 · Jornada minuto a minuto

APERTURA · 30 MINUTOS ANTES

- ☐ **Sistemas encendidos** y Clinic Cloud operativo
- ☐ **Agenda del día** revisada, con los casos rojos identificados
- ☐ **Sala VIP** presentable y material de acogida repuesto
- ☐ **Documentación pendiente** del día anterior: debe ser cero

CIERRE · 25 MINUTOS

- ☐ **Arqueo de caja** y registro de descuadres
- ☐ **Documentación del día** verificada como subida
- ☐ **Agenda de mañana** revisada, con rojos identificados
- ☐ **Reporte diario** enviado a Dirección

Durante la jornada, el trabajo se organiza en bloques: atención al paciente presente, gestión telefónica, confirmaciones del día siguiente y digitalización documental. Entre paciente y paciente, se sube al momento lo firmado. Al mediodía, punto de control de cinco minutos: ausencias, huecos por cubrir, documentación pendiente y confirmaciones en marcha.

R.3 · Procedimientos

PR-01 Atención telefónica de primer contacto

Críticidad alta

Objetivo: convertir el contacto en cita agendada con información completa.

Cinco ejes de clasificación obligatorios: motivo detallado, especialidad (implantología/ortodoncia), urgencia (triaje), origen («cómo nos conoció») y verificación de duplicado antes de agendar.

Fichas con origen registrado	≥ 98 %
Duplicados generados	0

PR-02 Triage de urgencia telefónica

Criticidad máxima

Objetivo: clasificar correctamente sin diagnosticar.

Regla nuclear

Ante cualquier duda sobre la gravedad, se pasa al Doctor. Nunca se diagnostica por teléfono.

AMPLIACIÓN

Señales que elevan el triaje de inmediato: dolor que impide dormir, inflamación facial, fiebre, traumatismo con movilidad o avulsión dentaria, sangrado que no cede, y cualquier complicación en paciente operado recientemente.

PR-03 Acogida presencial

Fase 2

Objetivo: que el paciente sienta que se le esperaba.

Saludo por el nombre tras consultar la ficha, acompañamiento a Sala VIP y aviso de cualquier demora antes de que el paciente espere, nunca cuando ya lleva esperando.

PR-04 Alta en sistema

Fase 3 · en paralelo

Objetivo: ficha completa antes de que el paciente llegue a la Fase 9.

El alta se completa en paralelo a la Fase 4 y está terminada antes de la Fase 9.
Campos obligatorios: datos personales completos, contacto verificado y origen de marketing.

PR-05 Gestión de agenda

Diaria

Objetivo: diseñar la agenda, no rellenarla.

La agenda se construye con estructura: primeras visitas en las franjas de mayor conversión, huecos de urgencia reservados, duraciones tipo por procedimiento y bloques de producción protegidos.

PR-06 Gestión de huecos y cancelaciones

Continúa

Ante cancelación: registrar el motivo, activar la lista de recuperación y ofrecer el hueco al siguiente paciente compatible. Un hueco no cubierto es facturación perdida que no vuelve.

PR-07 Confirmación de citas

Diaria

Calendario de confirmación por adelantado, con tono humano (el mensaje robótico reduce la confirmación a la mitad). Se confirma fecha, hora y ubicación, nunca el motivo clínico.

PR-08 Custodia y digitalización documental

Crítica máxima

Regla nuclear

Ningún día se cierra con documentación sin subir.

AMPLIACIÓN

Se escanea en color, con todas las páginas, se comprueba que el archivo abre y que corresponde a la ficha correcta antes de archivar el papel.

PR-09 Gestión de caja

Diaria

Protocolo de cobro con justificante, límite de efectivo de 1.000 € cuando interviene un profesional (no fraccionable) y arqueado diario. Ante un descuadre, se comunica siempre: comunicar elimina cualquier sospecha sobre la persona.

PR-10 Llamada de cortesía

24-48 h post-visita

Guion · paciente convertido

«Buenos días [nombre], le llamo del Centro Alma para saber qué tal está tras su visita y confirmarle su cita del [día]. ¿Le ha surgido alguna duda?»

PR-11 Gestión de ausencias

Mismo día

Llamada sin reproche: muchos pacientes que faltan no vuelven por vergüenza; una llamada amable recupera la relación.

Guion · ausencia

«Hola [nombre], le llamamos porque hoy no ha podido venir. ¿Está todo bien? ¿Le busco otro hueco?»

PR-12 Reactivación

Por campañas

Segmentos por prioridad, con depuración previa obligatoria: nunca se llama sin depurar (se eliminan fallecidos, bajas expresas y duplicados). Protocolo de intentos escalonado.

PR-13 Atención a reclamaciones

Criticidad alta

Escucha sin interrumpir, registro, escalado a Dirección y entrega de la hoja de reclamaciones siempre que se solicite, sin condiciones y sin intentar disuadir.

PR-14 Reporte diario

Al cierre

Consolida caja, agenda del día siguiente, ausencias y documentación al Director al cierre.

R.5 · Contingencias AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
Cae Clinic Cloud	Hoja de contingencia impresa, juego documental en papel y volcado íntegro antes del cierre de la jornada
Se acumulan pacientes en recepción	Se prioriza a quien tiene cita, se informa del tiempo real y se avisa al Director
Falta personal en el mostrador	Dirección designa sustituto certificado; ninguna PV se atiende sin acogida
Un paciente aparece sin cita en el sistema	Se le atiende igual y se investiga después: nunca se le hace responsable del fallo
Descuadre de caja	Se comunica el mismo día, se registra y nunca se compensa de bolsillo
Reclamación en mostrador	Se escucha sin interrumpir, se traslada a un espacio privado y se avisa a Dirección

R.5 · Criterios de calidad AMPLIACIÓN

- Ningún paciente espera en sala general durante una primera visita
- Ningún día se cierra con documentación sin subir
- Ninguna ficha se crea sin verificar duplicado
- Ninguna cita se confirma con mensaje robótico
- Ningún dato de contacto se registra sin verificación en voz alta
- Ninguna ausencia se queda sin llamada el mismo día

R.5 · Primeros 30 días en el puesto AMPLIACIÓN

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 1-3	Recorrido del centro, glosario de roles, marco de vanguardia y lectura del manual del puesto
Días 4-7	Clinic Cloud: alta, agenda, documentación y tareas. Alta de un caso de prueba sin errores
Días 8-12	Observación de cuatro llamadas de PV y cuatro acogidas, con ficha de observación
Días 13-18	Role-play de la llamada de primer contacto, del triaje y de una ausencia
Días 19-25	Atención acompañada, con revisión diaria de sus registros
Días 26-30	Evaluación: cinco ejes, digitalización el mismo día y arqueo. Certificación del puesto

R.3 bis · Su papel comercial real PROTOCOLOS POR PERFIL

Recepción no vende tratamientos, pero determina si el paciente llega o no. Cada momento del puesto tiene una consecuencia comercial concreta que conviene tener explícita.

MOMENTO	IMPACTO COMERCIAL
La llamada	Decide si el paciente agenda o cuelga
El motivo detallado	Determina si el resto del circuito puede personalizarse
El origen registrado	Sin ese dato, todo el marketing es a ciegas
La acogida	Confirma o desmiente la expectativa creada
La confirmación de cita	Reduce ausencias, que son capacidad recuperada
La despedida	Última impresión y base de la recomendación

El principio integral en la llamada

Nunca se minimiza el motivo de consulta.

Un paciente que llama por una limpieza puede necesitar tratamiento integral: si se le agenda solo la higiene, nunca se le diagnostica. Los guiones y las objeciones telefónicas están en la **Fase 1 del Protocolo de Primera Visita**.

REPORTE DIARIO – RECEPCIÓN

Fecha:

AGENDA

Citas previstas: ____ Atendidas: ____

Ausencias sin aviso: ____ Cancelaciones <24h: ____ Huecos cubiertos: ____

CAPTACIÓN

Llamadas recibidas: ____ Primeras visitas agendadas: ____

Origen registrado en todas: ☐

DOCUMENTACIÓN

100 % subida hoy: ☐ Si no, qué falta:

CAJA

Cuadrada: ☐ Incidencia:

INCIDENCIAS DEL DÍA:

MAÑANA – casos delicados / cirugías:

R.4 · Indicadores del puesto

Fichas sin duplicados	100 %
Documentación subida el mismo día	100 %
Tiempo de espera del paciente	0 en sala general
Citas confirmadas	Se mide
Descuadres de caja	0

PUESTO · DR

Doctor

D.1 · Misión y ámbito

Diagnosticar el futuro, no solo el presente. Y dejarlo documentado con precisión legal.

El Doctor es la autoridad clínica única del centro. Su criterio clínico no es revisable por gestión; y, a la inversa, ese criterio no exime del cumplimiento documental, que es obligatorio. Su ámbito: diagnóstico y plan, consentimiento informado, ejecución de tratamientos, trazabilidad clínica y de implantes.

D.2 · Cronograma de jornada

Preparación del día anterior — 25 minutos. La función que más distingue a un profesional de vanguardia: ningún caso se conoce a la vez que el paciente.

- ☐ **Historial, cuestionario y pruebas previas** revisados, paciente por paciente
- ☐ **Factores de riesgo** identificados
- ☐ **Necesidades especiales** anticipadas
- ☐ **Casos que requieren más tiempo** marcados
- ☐ **Material de casos quirúrgicos** verificado con RAC
- ☐ **Preguntas específicas** preparadas

Clasificación previa de casos

CATEGORÍA	PREPARACIÓN NECESARIA
COMPLEJO	Revisión profunda; posible consulta a comité
QUIRÚRGICO	Verificación de material y planificación
EN TRATAMIENTO	Revisión de la fase actual y del plan restante
PRIMERA VISITA	Revisión del cuestionario previo

D.3 · Procedimientos

PR-D01 Preparación anticipada del caso	Diaria · tarde anterior · criticidad máxima

Regla nuclear

Ningún caso se conoce a la vez que el paciente.

Si un caso tiene información insuficiente, se comunica a Dirección la tarde anterior, no cuando el paciente ya está esperando. En un traspaso de caso, se demuestra dominio con datos concretos: es lo único que reconstruye la confianza cuando el paciente cambia de profesional.

Pacientes con historial revisado antes de su cita

100 %

PR-D02 Anamnesis médica y dental

Fase 4 · 10 min · criticidad máxima

Bloque médico — preguntas obligatorias: enfermedades actuales o pasadas; alergias a medicamentos, látex o materiales; medicación habitual; cirugías previas; problemas cardiovasculares, diabetes o hipertensión; problemas de coagulación; y embarazo o lactancia si aplica.

Guion · apertura

«[Nombre], antes de cualquier exploración necesito conocer bien su historial de salud. Algunas preguntas le parecerán no tener que ver con los dientes, pero son importantes para tratarle con total seguridad.»

Historiales con campos de riesgo completos

100 %

PR-D03 Consentimiento informado

Fases 4 y 13 · criticidad máxima

Regla nuclear

Una firma sin comprensión verificada no es consentimiento.

Seis contenidos obligatorios: en qué consiste el procedimiento, beneficios esperados, riesgos y complicaciones, alternativas reales (incluida la de no tratar), consecuencias de no tratar y qué esperar durante y después. La secuencia: explicar con soporte visual, verificar («¿me lo puede repetir con sus palabras?»), aclarar, firmar y registrar que la comprensión fue verificada.

Guion · verificación

«Antes de firmar quiero asegurarme de que le ha quedado todo claro. No es un trámite: si algo no se entiende, prefiero explicarlo otra vez. ¿Me puede decir con sus palabras qué le vamos a hacer y por qué?»

Consentimientos con verificación registrada

100 %

PR-D04 Anamnesis de expectativas

Fase 7

Las cuatro dimensiones son obligatorias: funcional, estética, emocional y experiencias previas. El registro del perfil de riesgo y de las expectativas es el argumento más potente de la presentación posterior.

PR-D05 IAC y trazabilidad de implantes

Fases 8 y 13 · criticidad máxima

El Doctor dicta, revisa y firma el IAC; registra el lote y la referencia de cada implante sin excepción. La trazabilidad es la defensa ante cualquier incidencia.

D.4 · Errores documentados

ERROR	CONSECUENCIA
Conocer el caso a la vez que el paciente	Pérdida de confianza irreversible
Anamnesis superficial	Riesgo clínico real
Consentimiento sin verificar comprensión	Consentimiento inválido
Diagnosticar solo la zona del motivo	Se pierde el tratamiento integral
No registrar la trazabilidad de implantes	Incumplimiento e indefensión
Registrar al final del día	Pérdida de detalle clínico

D.6 · Contingencias AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
Un caso llega sin información suficiente	Se comunica a Dirección la tarde anterior, no con el paciente esperando
Falta material verificado para una cirugía	No se interviene. Se reprograma con RAC y se informa al paciente antes de que se desplace
El paciente no comprende el consentimiento	Se explica otra vez con otro soporte; si no hay comprensión, no se firma ni se interviene
Hallazgo grave incidental	Se comunica el mismo día, se documenta y se deriva con informe
Complicación intraoperatoria	Se estabiliza, se registra con causa raíz y medida correctora, y se informa al paciente y a Dirección
Discrepancia con el prediagnóstico asistido	Prevalece el criterio del Doctor; la discrepancia se registra siempre

D.6 · Criterios de calidad AMPLIACIÓN

- Ningún caso se conoce a la vez que el paciente
- Ningún diagnóstico se limita a la zona del motivo de consulta
- Ningún consentimiento se firma sin verificación de comprensión registrada
- Ningún implante se coloca sin registrar lote, referencia y posición
- Ningún acto clínico se registra al final del día
- Ninguna promesa de resultado se hace fuera de lo que el IAC sostiene

D.6 · Primeros 30 días en el puesto AMPLIACIÓN

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 1-3	Marco de vanguardia, protocolo de las 14 fases y su papel en las Fases 4, 6, 7, 8 y 9
Días 4-7	Clinic Cloud clínico: historia, odontograma, imágenes, IAC y trazabilidad de implantes
Días 8-12	Observación de cuatro PV completas y de dos briefings
Días 13-18	Role-play de anamnesis, consentimiento verificado y presentación con evidencia
Días 19-25	Ejecución acompañada, con revisión de sus IAC y de sus perfiles de riesgo
Días 26-30	Evaluación: historial revisado antes de cada cita, consentimientos verificados y trazabilidad al 100 %

D.4 bis · Secuencia clínica del plan integral PROTOCOLOS POR PERFIL

El plan integral no es una lista de tratamientos: es una secuencia con orden clínico. Un paciente que viene por un diente y sale con el diagnóstico de un diente no ha sido diagnosticado.

Fase 0 Urgencia. Lo que no puede esperar: dolor, infección.	Fase 1 Estabilización. Base sana: periodoncia, control de caries, extracciones.	Fase 2 Rehabilitación. Implantes, prótesis y restauración funcional.	Fase 3 Finalización. Estética, ajuste oclusal y detalles.	Fase 4 Mantenimiento. Programa de seguimiento de por vida.
--	--	---	--	---

Regla clínica innegociable: no se rehabilita sobre una base no estabilizada. La secuencia no se altera por conveniencia comercial ni por prisa del paciente.

D.4 ter · Su papel comercial y sus límites

El Doctor no negocia precios, pero es quien genera la convicción: la conversión no se decide en el momento del precio, sino en el momento en que el paciente entiende su problema.

CÓMO SE GENERA CONCIENCIA SIN PRESIONAR

TÉCNICA	EJEMPLO
Mostrar, no contar	«¿Ve esto en la pantalla? Esto es lo que le comentaba»
Comparar con lo normal	«Compare esta zona con esta otra, que es como debería estar»
Explicar la evolución	«Si esto no se trata, lo esperable es que...»
Conectar con su vida	«Usted me decía que le costaba comer. Esto es por qué»
Ser honesto con lo bueno	«Esta zona está perfecta, no hay que tocarla»

La última es la que más credibilidad da: quien dice «aquí no hace falta nada» es creído cuando dice que en otro sitio sí.

LO QUE NUNCA HACE

- Indicar tratamientos por rentabilidad
- Exagerar la gravedad
- Negociar precios
- Prometer resultados garantizados
- Presentar un plan distinto al acordado en el briefing
- Criticar trabajos previos delante del paciente

REPORTE DIARIO – DOCTOR Fecha:
 ACTIVIDAD
 Pacientes: ____ PV: ____ Tratamientos: ____ Cirugías: ____
 DIAGNÓSTICOS
 Planes integrales: ____ IAC firmados: ____
 CALIDAD
 Registros completos hoy: ☐
 Trazabilidad de implantes: ☐
 Complicaciones registradas: ____
 DERIVACIONES / CASOS PARA COMITÉ:
 MATERIAL Y CASOS DE MAÑANA:

D.5 · Indicadores del Doctor

Historiales completos (alergias, medicación, cirugías)	100 %
Consentimientos con verificación registrada	100 %
Trazabilidad de implantes registrada	100 %
Casos documentados el mismo día	100 %
Coherencia con el plan acordado en briefing	Se audita

PUESTO · HIG

Higienista

H.1 · Misión y ámbito

Sostener el resultado en el tiempo y detectar lo que aparece antes de que sea un problema.

El higienista es el responsable directo del programa de mantenimiento (Fase 14) y el pilar de la prevención del centro. Su ámbito: mantenimiento periimplantario (núcleo de su función), higiene y prevención según competencia, detección precoz y derivación, educación continua del paciente y elaboración del perfil Alma anual.

Delimitación competencial

El alcance concreto de las actuaciones clínicas lo determina su titulación y la normativa vigente. Este protocolo organiza la función; no amplía competencias.

H.2 · Por qué este puesto es estratégico

El centro se llama de excelencia implantológica. El seguimiento y mantenimiento de los implantes es la prueba de que el nombre significa algo, y el higienista es quien lo sostiene en el día a día. La reactivación del segmento de mantenimiento descansa en gran parte en este puesto, que es a la vez una de las principales fuentes de fidelización y de producción recurrente.

H.3 · Procedimientos

PR-H01 Programa de mantenimiento periimplantario

Recurrente · criticidad alta

Mantener el listado de portadores de implantes, gestionar el calendario de revisiones, ejecutar los mantenimientos según indicación y coordinar con Recepción la reactivación de quienes se descuelgan.

Pacientes con implantes en seguimiento activo

Creciente

Adherencia al programa

≥ 80 %

PR-H02 Detección precoz y derivación

Criticidad máxima

Regla nuclear

Ante cualquier signo de alarma periimplantaria, se deriva al Doctor de inmediato.

PR-H03 Educación del paciente

En cada visita

La instrucción en higiene oral es parte del trabajo, no un extra. Un paciente educado mantiene el resultado y reduce complicaciones.

PR-H04 Registro

En el momento

Regla nuclear

Cada actuación se registra en el momento. Los índices se anotan, no se recuerdan.

H.5 · Contingencias

AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
Signo de alarma y el Doctor no está disponible	El paciente no se marcha sin valoración: se localiza a otro Doctor o se agenda en 24 h con aviso a Dirección
El paciente no acude a su revisión	Se contacta en la semana y se registra el motivo; si se repite, pasa a la lista de reactivación
El gabinete no está disponible	Se reprograma la franja completa con Recepción, nunca se acorta el protocolo de la visita
Índices peores que en la visita anterior	Se registra, se acorta la periodicidad y se consulta al Doctor la revisión del perfil de riesgo
Portador de implante sin sistema identificado	No se instrumenta sobre él hasta confirmarlo con el Doctor

H.5 · Criterios de calidad

AMPLIACIÓN

- Ningún portador de implantes sale del alta sin entrar en el programa
- Ninguna visita termina sin la próxima cita agendada
- Ningún índice se anota de memoria al final del día
- Ninguna duda razonable se resuelve sin derivar
- Ninguna periodicidad se cambia sin criterio del Doctor

H.5 · Primeros 30 días en el puesto AMPLIACIÓN

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 1-3	Marco de vanguardia, Fase 14 y delimitación competencial del puesto
Días 4-7	Clinic Cloud: registro de índices, programa de mantenimiento y agenda
Días 8-12	Observación de mantenimientos y de derivaciones reales
Días 13-18	Role-play de educación del paciente y de comunicación de un signo de alarma
Días 19-25	Ejecución acompañada, con revisión de registros
Días 26-30	Evaluación: adherencia, registro completo y próxima cita agendada al 100 %

H.3 bis · Detección, derivación y papel comercial PROTOCOLOS POR PERFIL

Derivar no es un fallo

Ante cualquier duda, se deriva. Derivar es hacer bien el trabajo.

Se registra lo observado, se avisa al Doctor en el momento y el paciente no se marcha sin valoración si el signo es relevante.

DETECTA	COMUNICA	DERIVA A	URGENCIA
Signo de alarma periimplantario, dolor, inflamación o movilidad	Registro y aviso en el momento	Doctor	■ INMEDIATA
Caries, deterioro de restauración o periodontal en progresión	«Voy a comentárselo al doctor»	Doctor	■ MISMA VISITA
Interés estético expresado	«Se lo comento al director»	Director	■ MISMO DÍA
Paciente que no cumple el mantenimiento	Registro para reactivación	Director	■ SEMANAL
Familiar interesado	«Puede pedir cita, la primera visita es sin coste»	Recepción	■ MISMO DÍA

Nunca vende ni presupuesta: detecta, registra y deriva. Es, además, el perfil con más contacto recurrente, y por eso el mejor situado para pedir reseña —paciente satisfecho y sin tratamiento pendiente— y para activar el programa de referidos.

Guion · el mantenimiento como última fase del tratamiento

«Su tratamiento no termina cuando colocamos el implante. Termina cuando ese implante lleva veinte años funcionando bien. Para eso está el mantenimiento.»

H.4 · Indicadores del higienista

Higienes y mantenimientos realizados	Se mide
Pacientes con implantes en seguimiento activo	Creciente
Detección precoz de problemas periimplantarios	Se registra
Adherencia al programa de mantenimiento	≥ 80 %
Registro completo de cada actuación	100 %

PUESTO · AUX

Auxiliar

X.1 · Misión y ámbito

Garantizar que la actividad clínica se desarrolle con seguridad, higiene y fluidez, y ser la fuente de verdad sobre el material disponible.

El auxiliar ejecuta las pruebas diagnósticas, asiste al Doctor en gabinete y quirófano, mantiene la esterilización y controla el material. Cuatro áreas: diagnóstica, apoyo clínico, bioseguridad (responsabilidad crítica) y material.

X.2 · Procedimientos

PR-A01 Batería diagnóstica y carga de imágenes

Fase 5

CBCT, OPG, escaneado intraoral y serie fotográfica, con verificación de calidad, enderezado y etiquetado. Carga en tiempo real en Clinic Cloud, asociada al historial.

Regla nuclear

Verificas y enderezas cada imagen antes de subirla. No se avanza sin confirmar la carga.

Tiempo medio de la batería	≤ 15 min
----------------------------	----------

Repetición por calidad	< 5 %
------------------------	-------

PR-A02 Circuito de esterilización

Diario · criticidad crítica

Regla nuclear

Ningún ciclo de esterilización sin registro. La trazabilidad es tu defensa.

Circuito completo sucio → limpio, registro de ciclos y controles (biológico, químico, físico), desinfección de superficies y gestión de residuos según protocolo.

PR-A03 Control de material

Diario

Control de existencias, verificación de disponibilidad para cirugías (informa a RAC), retirada de caducados y propuesta de pedidos al responsable de compras.

Regla nuclear

Sobre material, siempre compruebas físicamente. Nunca «creo que sí».

PR-A04 Comprobación de equipos

Apertura

Antes del primer paciente, se encienden y comprueban los equipos. No se asume que funcionan: se verifica.

X.4 · Contingencias

AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
Un control de esterilización falla	El material del ciclo no se usa, se reprocesa, se comunica al responsable clínico y se registra la incidencia
El autoclave se avería	Se retira de servicio, se avisa a Dirección y se reorganiza la agenda quirúrgica del día
Un equipo de imagen no arranca	Se comunica antes del primer paciente y se ofrece alternativa o nueva cita sin coste
Falta material para una cirugía de mañana	Se informa a RAC en el momento; nunca se confirma disponibilidad sin comprobar físicamente
Rotura de stock crítico	Se activa el proveedor alternativo identificado y se avisa a Dirección
Material caducado detectado	Retirada inmediata, registro y revisión del resto del lote

X.4 · Criterios de calidad

AMPLIACIÓN

- Ningún ciclo de esterilización sin registro completo
- Ningún instrumental con duda de esterilidad se utiliza
- Ninguna imagen se sube sin verificar nitidez, encuadre y enderezado
- Ninguna confirmación de material a RAC sin comprobación física
- Ningún equipo se da por operativo sin encenderlo y comprobarlo
- Ningún residuo se almacena en zona de paciente o de paso

X.4 · Primeros 30 días en el puesto AMPLIACIÓN

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 1-3	Marco de vanguardia, bioseguridad y circuito unidireccional de esterilización
Días 4-7	Equipos: arranque, calibración y comprobación diaria. Clinic Cloud: carga y etiquetado
Días 8-12	Observación de baterías diagnósticas completas y de asistencia quirúrgica
Días 13-18	Ejecución acompañada de la batería, con control de calidad revisado imagen a imagen
Días 19-25	Gestión de stock: revisión semanal contra agenda de 21 días y verificación para RAC
Días 26-30	Evaluación: registros de ciclo al 100 %, repetición por calidad por debajo del objetivo. Certificación

X.2 bis · Documentar la boca completa y explicar cada prueba PROTOCOLOS POR PERFIL

Sin registro completo no hay diagnóstico integral posible, ni comparación futura, ni material de presentación. El Auxiliar no vende, pero construye o destruye la experiencia: la calidad de sus imágenes es el material con el que se cierra en la Fase 9, y durante las pruebas el paciente cuenta cosas que no le dice al Doctor.

PRUEBA	ALCANCE OBLIGATORIO
CBCT	Según indicación del Doctor
OPG	Panorámica completa
Escaneado intraoral	Ambas arcadas completas
Fotografía extraoral	Frontal en reposo, frontal en sonrisa, perfiles y tres cuartos
Fotografía intraoral	Frontal en oclusión, laterales, oclusales superior e inferior y detalles

Guion · antes del CBCT

«[Nombre], le voy a hacer una tomografía 3D. Es totalmente indolora: solo tiene que quedarse quieto unos segundos mientras el aparato gira. Esta prueba es la que nos permite ver el hueso en tres dimensiones, y es la base de todo el diagnóstico.»

Guion · al fotografiar

«Y ahora unas fotografías, de fuera y de dentro. Nos sirven para el diagnóstico completo y también para que usted pueda ver la diferencia cuando terminemos.»

Lo que detecta y deriva: ansiedad significativa al Doctor y al Director; un problema no consultado que el paciente menciona, al Doctor; interés en otro tratamiento o una queja, al Director. Una imagen de calidad dudosa no se deriva: se repite.

X.3 · Indicadores del auxiliar

Tiempo medio de la batería diagnóstica	≤ 15 min
Tasa de repetición de pruebas por calidad	< 5 %
Cumplimiento del protocolo de esterilización	100 %
Registros de ciclo completos	100 %
Exactitud en la información de material a RAC	100 %

PUESTO · RAC

RAC · Responsable de Producción

C.1 · Misión y ámbito

Garantizar que todo tratamiento aceptado y pagado se ejecute realmente, en el menor tiempo posible y sin incidencias. Es el dueño del indicador de producto pendiente.

C.2 · Poder de bloqueo

Regla nuclear

Ninguna cirugía se agenda sin pago confirmado y material disponible.

Es el único puesto con poder de bloqueo, y ninguna presión comercial lo anula: si el Director quiere agendar sin verificación, se escala a Gerencia.

C.3 · Procedimientos

PR-R01 Doble verificación

Antes de cada agendado · criticidad máxima

Verificar pago y verificar material con el Auxiliar antes de agendar cualquier cirugía. Si falta cualquiera de los dos, se bloquea el agendado.

PR-R02 Programación y priorización

Continua

Agendar con fecha realista según material y priorizar el producto pendiente antiguo. Los casos más antiguos son los más urgentes.

PR-R03 Confirmación y checklist 24-48 h

Antes de cada cirugía

Guion · confirmación

«Buenos días [nombre], le llamo del Centro Alma para confirmar su cirugía del [día] a las [hora]. Le recuerdo [ayuno, medicación, acompañante]. ¿Alguna duda antes del día?»

PR-R04 Panel de producto pendiente

Actualización continua

Regla nuclear

El panel se actualiza en cada cambio de estado, no a fin de mes.

Tu primera tarea al llegar es sacar a la luz el producto pendiente heredado.

C.5 · Contingencias

AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
Dirección pide agendar sin verificación	Se mantiene el bloqueo y se escala a Gerencia; queda registrado
El material no llega en plazo	Se reprograma antes de que el paciente se desplace y se busca alternativa con el Doctor
El laboratorio incumple una fecha	Se registra la incidencia, se informa a Dirección y se activa la alternativa prevista
Un pago no se confirma	El caso permanece bloqueado y visible en el panel, con motivo escrito
Caso heredado sin documentación	Se reconstruye con Dirección antes de agendar: pago, tratamiento pactado y estado real
Cancelación quirúrgica de última hora	Se recoloca el hueco con Recepción y se reprograma en el acto

C.5 · Criterios de calidad

AMPLIACIÓN

- Ninguna cirugía se agenda sin pago y material verificados
- Ningún caso aceptado queda sin registrar en el panel el mismo día
- Ningún plan por fases se da por terminado con fases sin agendar
- Ningún cambio de estado se anota a fin de mes
- Ningún caso de más de seis meses queda sin contacto del Director

C.5 · Primeros 30 días en el puesto

AMPLIACIÓN

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 1-3	Marco de vanguardia, Fase 13 y significado del producto pendiente
Días 4-7	Clinic Cloud: presupuestos, estados, tareas y panel de producción
Días 8-12	Observación del circuito completo de dos casos, de la aceptación a la cirugía
Días 13-18	Role-play de la doble verificación y de la confirmación al paciente

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 19-25	Gestión acompañada del panel, priorizando el pendiente antiguo
Días 26-30	Evaluación: doble verificación al 100 % y panel actualizado en cada cambio de estado

C.3 bis · El guardián del plan completo

PROTOCOLOS POR PERFIL

Seguimiento del plan integral

Un plan de tres fases aceptado y con solo la primera ejecutada es un plan incompleto, no un plan terminado.

Control semanal de: casos con fases pendientes, casos con una fase ejecutada y sin la siguiente agendada, casos parados sin motivo registrado y casos con demasiados meses sin avanzar, que escalan a Dirección.

RAC no vende, pero recupera facturación que se estaba perdiendo: ejecutar producto pendiente convierte caja parada en producción, reactivar planes parados recupera fases no ejecutadas, confirmar cirugías reduce cancelaciones de alto valor y contactar casos antiguos recupera pacientes en el limbo.

Guion · recuperación de un plan parado

«[Nombre], le llamo porque estaba revisando su tratamiento. Usted tiene pendiente [fase], que era el siguiente paso del plan que acordamos. ¿Ha habido algún motivo para pararlo, o simplemente se fue quedando? Si le parece, le busco fecha y lo retomamos. Cuanto antes lo completemos, mejor resultado tendrá el conjunto.»

Guion · caso heredado con espera larga

«[Nombre], le llamo porque tenemos ya cerrada la fecha para su [tratamiento]: el [fecha]. Sé que llevaba tiempo pendiente y quería confirmárselo personalmente.»

Si el pago no consta pero el paciente afirma haber pagado, nunca se le cuestiona: se deriva a Dirección. Una cirugía cancelada por falta de material es una incidencia grave y se reporta como tal.

C.4 · Indicadores del RAC

Producto pendiente total

Tendencia descendente

Tiempo medio aceptación → ejecución	Mínimo
Cirugías sin incidencias de pago o material	100 %
Casos con más de 6 meses	0

PUESTO · DC

Dirección de Clínica

G.1 · Misión y ámbito

Dirigir la operativa diaria y el proceso comercial completo, garantizando que se cumplan los protocolos, se alcancen los objetivos y el equipo funcione coordinado.

Es el puente entre Gerencia y el equipo, y el responsable último de que lo que se vende se entregue.

G.2 · Autoridad y sus límites

DECIDE

- Lo comercial, dentro de la política aprobada
- Lo operativo del día a día
- La organización del equipo

NO DECIDE SIN GERENCIA

- Precios de tarifa, devoluciones y gratuidades
- Contrataciones y despidos
- Inversiones y acuerdos con terceros
- Respuestas públicas a reseñas graves y atención a medios

G.3 · Procedimientos

PR-G01 Conducción del proceso comercial

Fases 3, 6, 9, 10

Anamnesis inicial, briefing con el Doctor, presentación del plan y cierre económico, aplicando descuentos solo dentro de la política aprobada.

PR-G02 Dirección de la operativa diaria

Diaria

Vuelta de comprobación al abrir, organización de la agenda y del reparto, resolución de incidencias ordinarias y verificación al cierre de que la documentación está completa.

PR-G03 Dirección del equipo y reuniones

Diaria · semanal · mensual

Reuniones diarias, semanales y mensuales; asignación de tareas y responsables funcionales; canalización de incidencias del equipo.

PR-G04 Consolidación de reportes

Diaria · semanal · mensual

Recibe los reportes de todos los puestos, los consolida y eleva a Gerencia el cierre diario, el panel semanal y el informe mensual.

G.5 · Contingencias

AMPLIACIÓN

SI OCURRE...	SE HACE
Falta un profesional clave el mismo día	Se reorganiza la agenda, se avisa a los pacientes afectados antes de que salgan de casa y se designa sustituto certificado
Cae el sistema	Se activa el juego documental en papel y se garantiza el volcado antes del cierre
Incidencia grave de trazabilidad o RGPD	Se documenta el mismo día y se comunica a Gerencia para valorar si es notificable
Reclamación formal	Se entrega la hoja sin condiciones, se registra y se responde por escrito dentro del plazo legal
Conflicto entre dos miembros del equipo	Se aborda en privado el mismo día; nunca delante del paciente ni del resto del equipo
Indicador por debajo de umbral dos meses seguidos	Se abre plan de refuerzo con acciones, responsable y fecha de revisión

G.5 · Criterios de calidad

AMPLIACIÓN

- Ninguna presentación sin briefing previo
- Ningún presupuesto sin solicitud firmada por el Doctor
- Ninguna aceptación sin aviso a RAC
- Ningún día se cierra sin panel diario revisado
- Ningún descuento fuera de la política aprobada
- Ninguna decisión reservada a Gerencia se toma sin consultarla

G.5 · Primeros 30 días en el puesto

AMPLIACIÓN

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 1-3	Manual completo, indicadores del centro y estado real del producto pendiente heredado
Días 4-7	Clinic Cloud de gestión: presupuestos, conversión, reportes y auditoría

PERIODO	QUÉ DEBE DOMINAR AL TERMINARLO
Días 8-12	Observación del circuito completo y de los seis puestos en funcionamiento
Días 13-18	Conducción acompañada de briefings, presentaciones y cierres
Días 19-25	Dirección de la operativa diaria con revisión de Gerencia
Días 26-30	Evaluación: briefings al 100 %, documentación el mismo día y panel semanal completo

G.3 bis · Estructura de la presentación económica

PROTOSCOLS POR PERFIL

Se presenta el plan completo. Siempre. Aunque se ejecute por fases. Se adapta la ejecución, nunca el diagnóstico.

1 · Valor Justificar antes del número: diagnóstico completo, tecnología, materiales, garantías y seguimiento.	2 · Plan Presentar el plan completo por fases, con tiempo total y número de citas.	3 · Desglose Línea por línea, cada partida explicada.	4 · Ejecución Opciones: completo o por fases.	5 · Pago Anticipado con bonificación, financiación con cuota calculada o fases.	6 · Cierre Por alternativa o por asunción.
--	---	--	--	--	---

Guion · plan integral por fases

«[Nombre], le explico el plan completo y luego vemos cómo organizarlo. Lo que necesita su caso es [plan completo]. Eso es lo ideal y es a donde queremos llegar. Esto se puede hacer de dos formas: todo seguido, que es lo más eficiente; o por fases, empezando por [fase clínicamente prioritaria]. Lo que no le recomiendo es hacer solo una parte y olvidarnos del resto, porque [consecuencia clínica real]. Si vamos por fases, vamos por fases con un plan, no a salto de mata.»

LO QUE NUNCA SE HACE COMERCIALMENTE

- Descuento como primera respuesta
- Urgencia artificial: «solo hoy»
- Prometer resultados garantizados
- Presentar un plan reducido para que salga más barato
- Cerrar sin que el paciente haya entendido su diagnóstico
- Descalificar a otras clínicas

REPORTE DIARIO – DIRECCIÓN Fecha:

ACTIVIDAD

Pacientes: ____ PV: ____ Convertidas: ____ Tasa: ____%

Presentado: ____ € Aceptado: ____ € Ticket: ____ €

PLANES

Integrales presentados: ____ Completos: ____ Por fases: ____

Razones de no conversión registradas: ☐

VERIFICACIONES

Documentación 100%: ☐ Caja cuadrada: ☐

Cirugías de mañana verificadas: ☐

INCIDENCIAS / COMPROMISOS CON PACIENTES:

SEMÁFORO DEL DÍA: verde / ámbar / rojo

G.4 · Indicadores de Dirección

Tasa de conversión de primeras visitas	Creciente
Ticket medio	Creciente
Producto pendiente	Tendencia descendente
Documentación subida el mismo día	100 %
Clima y estabilidad del equipo	Se valora
Cumplimiento de protocolos	Se audita

FUNCIÓN TRANSVERSAL

Compras y material

K.1 · Misión. Compras no es un puesto, sino una responsabilidad transversal (habitualmente del Auxiliar) que garantiza que nunca falte material crítico y que no se inmovilice capital en stock caducado. Propone; el Director autoriza; Gerencia autoriza las compras relevantes.

K.2 · Funciones

- Mantener el control de stock actualizado y detectar necesidades con antelación (stock mínimo).
- Proponer pedidos y verificar la recepción contra albarán.
- Controlar caducidades y rotación.
- Gestionar la relación operativa con proveedores bajo coordinación del Director.

Reporte semanal

Stock de material crítico, pedidos realizados y pendientes, incidencias con proveedores y caducidades próximas.

V

Funciones de vanguardia por perfil

Cada perfil con sus funciones delimitadas, sus flujos, sus límites e indicadores.

La Parte IV describe cada puesto en su estructura de manual (misión, jornada, procedimientos). Esta Parte V desarrolla, para los mismos perfiles, sus funciones de vanguardia: el detalle operativo de cada función —su circuito, sus reglas innegociables, sus límites y sus indicadores— bajo el principio que gobierna todo el centro, la antelación sistematizada. Ambas partes se complementan: la IV dice *qué hace* cada puesto; la V, *cómo lo ejecuta* un profesional de vanguardia.

MARCO DE IMPLANTACIÓN

Cómo entra una función nueva sin romper lo que funciona

INNOVACIÓN

Las funciones de vanguardia de esta parte no se activan todas a la vez. El sistema documentado para incorporarlas —dieciocho fichas con protocolo, guion, contingencia e indicador— está en

Otros · Innovación aplicada al protocolo . Estas son sus reglas, que se aplican a cualquier cambio de este manual.

Principio rector y regla de ritmo

Ninguna innovación entra si no mejora la seguridad del paciente, la precisión del diagnóstico, la comprensión del paciente o el tiempo hasta el resultado.

Una innovación por trimestre, consolidada antes de la siguiente. Activar varias a la vez garantiza que ninguna quede bien implantada y que el equipo pierda la confianza en el sistema.

LOS CINCO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ☐ Funciona técnicamente: **dos semanas sin incidencias**
- ☐ El equipo la usa **sin supervisión**, verificado por observación
- ☐ Existe **protocolo de contingencia** documentado y probado
- ☐ Se **mide su impacto** con un indicador definido y con datos
- ☐ El paciente la percibe como **mejora**

Si falta cualquiera de los cinco, la innovación está «en pruebas», no implantada. Y no se activa la siguiente.

EL VALLE DE ADOPCIÓN

Durante las semanas 2 a 5 toda innovación ralentiza en lugar de acelerar. Si el equipo no lo sabe de antemano, concluye que no funciona y la abandona.

Antes Advertir explícitamente del valle.	Semana 1 Acompañamiento constante.	Semanas 2-3 Recoger fricciones sin corregir en público.	Semana 4 Ajustes sobre lo detectado.	Semana 6 Evaluación de los cinco criterios.
---	---------------------------------------	--	---	--

Regla general de contingencia

Ninguna innovación puede convertirse en un requisito para atender a un paciente. Si el sistema falla, la clínica funciona igual, aunque con más trabajo manual: el cuestionario se rellena en consulta, la firma se hace en papel, el diagnóstico se hace igual sin prediagnóstico y la presentación se hace con imágenes estáticas.

Secuencia de formación · nadie usa una innovación con un paciente antes del paso 5

1 · Explicar Qué es, por qué y qué mejora · 15 min.	2 · Demostrar Uso real delante del equipo · 15 min.	3 · Practicar Casos ficticios · 30 min.	4 · Acompañar Primeros usos reales supervisados · 1 semana.	5 · Certificar Verificación de autonomía.
---	---	---	---	---

PERFIL 1

Recepción · funciones de vanguardia

Misión: ser el sistema nervioso del centro. Todo entra y sale por aquí, y nada se pierde.

Función 1.1 · Gestión de la demanda

No es «coger el teléfono». Es cualificar, clasificar y asignar cada contacto que llega por cualquier canal.

CANAL	GESTIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA
Teléfono	Directa	3 tonos
WhatsApp	Directa	< 15 min en horario
Web / formulario	Directa	< 2 horas
Asistente conversacional (fuera de horario)	Revisión y recuperación	Primera hora del día siguiente
Presencial	Directa	Inmediata

Regla de vanguardia

Ningún contacto queda sin respuesta el mismo día. Ninguno.

Protocolo de cualificación · cinco ejes

1. MOTIVO	implantología / ortodoncia / general / mantenimiento / urgencia
2. URGENCIA	vital / urgente / preferente / estándar
3. PERFIL	caso complejo / ansiedad / infantil / estándar
4. ORIGEN	canal exacto (dato de marketing)
5. DISPONIBILIDAD	mañanas / tardes / indiferente
↓	
ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA: profesional + franja + duración	

Reglas de asignación inteligente

PERFIL DETECTADO	FRANJA	PROFESIONAL	DURACIÓN
Caso complejo implantológico	Mañana	Implantólogo	Ampliada
Ansiedad manifiesta	Primera hora	Con margen	Ampliada

PERFIL DETECTADO	FRANJA	PROFESIONAL	DURACIÓN
Infantil	Tarde / no lectivo	Ortodoncista	Estándar
Ortodoncia adulto	18-20 h	Ortodoncista	Estándar
Mantenimiento	13:30-16:00	Higienista	Reducida
Urgencia	Hueco reservado diario	Según motivo	Variable

Guion · envío del cuestionario previo

«Perfecto, [nombre], le espero el [día] a las [hora]. Le envió un cuestionario breve —tres minutos— para que el doctor pueda revisar su caso antes de que venga.»

Contactos con 5 ejes clasificados	100 %
Contactos respondidos el mismo día	100 %
Origen registrado	≥ 98 %
Cuestionarios cumplimentados	≥ 60 %

Función 1.2 · Arquitectura de agenda

Por qué importa

Esta es la función menos valorada y la que más producción libera. La agenda no se rellena: se diseña.

Cada franja tiene un propósito y una rentabilidad distinta.

FRANJA	USO PREFERENTE	POR QUÉ
09:00 - 11:00	Cirugías y tratamientos complejos	Equipo fresco, día por delante para seguimiento
11:00 - 13:30	Primeras visitas	Paciente descansado, tiempo amplio
13:30 - 16:00	Mantenimientos e higienes	Franja de menor demanda externa
16:00 - 18:00	Tratamientos ordinarios	Franja mixta
18:00 - 20:00	Primeras visitas y ortodoncia	Franja de oro: cuando puede venir quien trabaja

Las cinco reglas de agenda

#	REGLA	FUNDAMENTO
1	La franja 18-20 h se reserva a primeras visitas	Es cuando puede tu paciente objetivo
2	Las cirugías no van a última hora	Sin margen para complicaciones
3	Hueco diario reservado para urgencias	Nunca se llena preventivamente
4	Bloques de cirugía agrupados	Reduce cambios de montaje
5	Ningún hueco sin criterio asignado	Se diseña, no se rellena



Gestión dinámica de huecos. Un hueco no cubierto es facturación perdida que no vuelve, por eso la cancelación dispara un aviso inmediato y, si no hay respuesta en dos horas, un orden de prioridad que empieza por el producto pendiente.

Ocupación de agenda clínica	Medir y optimizar
Ocupación de la franja 18-20 h con PV	≥ 70 %
Huecos recuperados tras cancelación	≥ 50 %
Ausencias sin aviso	Descendente

Función 1.3 · Custodia documental

El principio

Lo que no está en el sistema, no ha ocurrido.

CIRCUITO DE VANGUARDIA
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
↓
ARCHIVADO AUTOMÁTICO en la ficha del paciente
↓
COPIA INMEDIATA AL PACIENTE
↓
VERIFICACIÓN DIARIA por Recepción
↓
AUDITORÍA SEMANAL por Dirección

Documentación obligatoria por paciente

DOCUMENTO	MOMENTO	DIGITAL
Datos personales	Fase 3	✓
Consentimiento RGPD	Fase 3	✓
Anamnesis médica	Fase 4	✓
Consentimiento radiológico	Fase 4	✓
IAC firmado	Fase 8	✓
Solicitud de presupuesto	Fase 8	✓
Presupuesto aceptado	Fase 11	✓
Financiación	Fase 11	Según entidad
Consentimiento quirúrgico	Fase 13	✓

Contingencia

Juego impreso completo siempre disponible. Si falla el sistema, se firma en papel y se digitaliza el mismo día.

Documentación completa y archivada el mismo día

100 %

Función 1.4 · Gestión económica de mostrador

PROTOCOLO DE COBRO

1. VERIFICAR importe contra presupuesto aceptado
2. COBRAR por el medio elegido
3. REGISTRAR en el sistema EN EL MOMENTO
4. ENTREGAR justificante
5. ACTUALIZAR estado del tratamiento

ARQUEO DIARIO · PASO	ACCIÓN
1	Recuento físico del efectivo
2	Cuadre contra registros del sistema
3	Cuadre de operaciones de TPV
4	Registro y firma
5	Custodia según protocolo

Norma que protege a quien maneja caja

Ante un descuadre del importe que sea, se comunica el mismo día. Nunca se compensa de bolsillo.

Descuadres	0
Cobros registrados en el momento	100 %
Arqueos firmados	100 %

Función 1.5 · Seguimiento y recuperación

FLUJO	MOMENTO	CANAL
Confirmación de cita	48 h antes	WhatsApp
Recordatorio de cita	24 h antes	WhatsApp
Llamada de cortesía	24-48 h post-visita	Teléfono
Ausencia sin aviso	Mismo día	Teléfono
Nurturing de no convertido	Según objeción	Escalonado

Protocolo de ausencia · nunca con reproche

Muchos pacientes que faltan no vuelven por vergüenza. «Hola [nombre], le llamamos porque hoy no ha podido venir. ¿Está todo bien? ¿Le busco otro hueco?»

Tasa de confirmación	≥ 80 %
Ausencias contactadas el mismo día	100 %
No convertidos con tarea de seguimiento	100 %

Jornada tipo de Recepción

MOMENTO	FUNCIÓN
Antes de abrir	Sistema · agenda del día · contactos del asistente nocturno · casos delicados identificados
Mañana	Acogida · teléfono · altas en paralelo · documentación según llega
Mediodía	Verificación de documentación de la mañana · confirmaciones de mañana
Tarde	Acogida · seguimiento · llamadas de cortesía · reactivación
Cierre	Documentación 100 % · arqueo · agenda de mañana revisada · reporte

PERFIL 2

Doctor · funciones de vanguardia

Misión: diagnosticar el futuro, no solo el presente. Y dejarlo documentado con precisión defendible.

Función 2.1 · Preparación anticipada del caso

El principio · la función que más distingue a un profesional de vanguardia

Ningún caso se conoce a la vez que el paciente.

TARDE DEL DÍA ANTERIOR (20-30 min) · para cada paciente del día siguiente

- Revisar historial completo
- Revisar cuestionario previo si lo cumplimentó
- Revisar pruebas previas si las hay
- Identificar factores de riesgo médico
- Anticipar necesidades especiales
- Marcar casos que requieren más tiempo
- Verificar material de casos quirúrgicos con RAC

CATEGORÍA	PREPARACIÓN
■ COMPLEJO	Revisión profunda · posible consulta a comité
■ QUIRÚRGICO	Verificación de material y planificación
■ EN TRATAMIENTO	Revisión de la fase actual
■ PRIMERA VISITA	Revisión del cuestionario previo

Pacientes con historial revisado antes de su cita

100 %

Función 2.2 · Diagnóstico integral y predictivo

DIAGNÓSTICO CONVENCIONAL	DIAGNÓSTICO DE VANGUARDIA
Qué tiene el paciente	Qué tiene y hacia dónde va
Zona del motivo de consulta	Boca completa, siempre
Estado presente	Perfil de riesgo con proyección

DIAGNÓSTICO CONVENCIONAL	DIAGNÓSTICO DE VANGUARDIA
Lectura del profesional	Lectura + segunda lectura asistida

Los diez componentes obligatorios

#	COMPONENTE	#	COMPONENTE
1	Estado periodontal completo	6	Ausencias y repercusión
2	Estado de cada pieza	7	Estado óseo
3	Oclusión y función	8	Tejidos blandos
4	ATM	9	Componente estético
5	Restauraciones previas	10	Hábitos y factores de riesgo

El perfil de riesgo · registro obligatorio

PERFIL DE RIESGO – [Paciente]

Periodontal: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo Factores: _____
 Caries: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo Factores: _____
 Biomecánico: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo Factores: _____
 Periimplantario: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo Factores: _____

PERFIL GLOBAL: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo

PERIODICIDAD INDICADA: cada _____ meses

PROYECCIÓN A 5 AÑOS SIN INTERVENCIÓN: _____

Uso del prediagnóstico asistido

Orden obligatorio: el Doctor lee primero, contrasta después.

(1) Lectura propia · (2) contraste con el prediagnóstico · (3) registro de concordancias y discrepancias · (4) diagnóstico final, siempre del Doctor.

Diagnósticos integrales (no parciales)	100 %
Perfiles de riesgo registrados	100 %
Discrepancias con IA registradas	Todas

Función 2.3 · Planificación digital de tratamientos



El flujo de planificación digital. Se planifica desde el resultado protésico hacia atrás, y el paso marcado —la definición exacta del material— sale del gabinete hacia RAC en ese mismo momento: es el cambio operativo que elimina las cancelaciones por falta de material.

Principio nuclear

Se planifica desde el resultado protésico hacia atrás, no desde el hueso hacia adelante.

Definición de material en el momento de planificar

Este es el cambio operativo más importante de todo el manual.

CONVENCIONAL	VANGUARDIA
El material se pide cuando se acerca la cirugía	Se define al planificar y se pide al aceptar
Se descubre la falta días antes	Se anticipa semanas antes
Cancelaciones por material	Cero

Ficha de material que el Doctor genera al planificar

CASO: _____ FECHA PLANIFICACIÓN: _____

IMPLANTES

Referencia: _____ Diámetro: _____ Longitud: _____ Uds: _____

Alternativa si no disponible: _____

COMPONENTES PROTÉSICOS: _____

MATERIAL DE REGENERACIÓN (si aplica): _____

GUÍA QUIRÚRGICA: ☐ Necesaria ☐ No Fabric.: ☐ Interna ☐ Externa Plazo: _____

INSTRUMENTAL ESPECÍFICO: _____

TIEMPO ESTIMADO DE QUIRÓFANO: _____ min PERSONAL: _____

Cuándo se envía

Esta ficha va a RAC en el momento de la planificación, no cuando se acerca la fecha.

Función 2.4 · Consentimiento informado real**El estándar**

Una firma sin comprensión verificada no es consentimiento.

PROTOCOLO

1. EXPLICAR con soporte visual (modelo 3D, imágenes)
2. Cubrir los seis contenidos obligatorios
3. VERIFICAR: «¿me lo puede repetir con sus palabras?»
4. ACLARAR lo que no haya quedado claro
5. FIRMAR
6. REGISTRAR que la comprensión fue verificada

#	CONTENIDO OBLIGATORIO
1	En qué consiste el procedimiento
2	Beneficios esperados
3	Riesgos y complicaciones posibles
4	Alternativas reales, incluida la de no tratar
5	Consecuencias de no tratar
6	Qué esperar durante y después

El registro que protege

«Consentimiento explicado con apoyo de modelo 3D. Se verifica comprensión mediante repetición por el paciente. Dudas resueltas sobre [tema]. Firma.»

Consentimientos con verificación registrada

100 %

Función 2.5 · Ejecución clínica

Checklist quirúrgico de seguridad, digital y firmado.

ANTES DE EMPEZAR

- ☐ **Identidad del paciente** confirmada
- ☐ **Procedimiento y zona** confirmados
- ☐ **Consentimiento** verificado
- ☐ **Alergias** revisadas
- ☐ **Material completo** verificado
- ☐ **Planificación** disponible
- ☐ **Guía quirúrgica** probada
- ☐ **Equipo completo** presente
- ☐ **Material de emergencia** disponible

ANTES DE LA FASE CRÍTICA Y AL FINALIZAR

- ☐ **Confirmación verbal** del equipo
- ☐ **Aspectos críticos** comunicados
- ☐ **Procedimiento** registrado
- ☐ **Trazabilidad de implantes:** lote, referencia, posición
- ☐ **Recuento de material**
- ☐ **Instrucciones postoperatorias** entregadas
- ☐ **Seguimiento** agendado
- ☐ **Checklist firmado**

Bloqueo del sistema

Sin checklist completo, el sistema no permite marcar la cirugía como iniciada.

Función 2.6 · Registro y trazabilidad

ELEMENTO	REQUISITO
Registro del acto	Mismo día, sin excepción
Trazabilidad de implante	Lote + referencia + posición
Imágenes	Vinculadas al acto
Complicaciones	Todas, incluso leves
Desviaciones de la planificación	Registradas y analizadas

COMPLICACIÓN – [Caso] · [Fecha]

Tipo: _____

Descripción objetiva: _____

Actuación realizada: _____

Resultado: _____

CAUSA RAÍZ: _____

MEDIDA CORRECTORA: _____

Para qué sirve este registro

No es una lista de culpables: es la herramienta con la que un centro mejora. Y la que protege ante una reclamación.

Jornada tipo del Doctor

MOMENTO	FUNCIÓN
Antes de abrir	Historiales del día revisados · casos complejos identificados · material quirúrgico verificado
Mañana	Cirugías (franja de mayor rendimiento) · casos complejos
Entre pacientes	Registro inmediato
Briefing	Con Dirección, antes de cada presentación
Tarde	Tratamientos · primeras visitas · presentaciones
Última media hora	Preparación del día siguiente · planificaciones digitales

MOMENTO	FUNCIÓN
Cierre	Verificación de que todo está registrado

PERFIL 3

Higienista · funciones de vanguardia

Misión: sostener el resultado en el tiempo y detectar lo que aparece antes de que sea un problema.

Función 3.1 · Programa de mantenimiento

El principio

El paciente no termina: pasa a mantenimiento.

La arquitectura del programa está representada en el diagrama de la **Fase 14**: alta del tratamiento, clasificación por perfil de riesgo definido por el Doctor, cita agendada antes de salir, visita de mantenimiento con registro e instrucción, y derivación inmediata ante cualquier signo de alarma.

ELEMENTO	REGISTRO
Índices periodontales	N Numérico, comparable
Estado periimplantario	N Según protocolo
Estado de restauraciones	N Observación
Higiene del paciente	N Valoración
Hallazgos nuevos	N Descripción
Fotografía de control	N Si procede

Pacientes con implantes en programa activo	Creciente
Próxima cita agendada antes de salir	100 %
Adherencia al programa	≥ 80 %
Registros de índices completos	100 %

Función 3.2 · Detección precoz y derivación

El principio

Ante la duda, se deriva. Derivar no es un fallo: es hacer bien el trabajo.

SITUACIÓN	URGENCIA	ACTUACIÓN
Signo de alarma periimplantaria	■ INMEDIATA	Doctor en la misma visita
Dolor o inflamación	■ INMEDIATA	Doctor en la misma visita
Movilidad de implante o prótesis	■ INMEDIATA	Doctor en la misma visita
Caries o deterioro detectado	■ MISMA VISITA	Doctor
Progresión periodontal	■ MISMA VISITA	Doctor
Interés en tratamiento estético	■ MISMO DÍA	Dirección
Paciente que abandona el programa	■ SEMANAL	Dirección

- CÓMO SE DERIVA
- 1. Se registra lo observado
 - 2. Se avisa al Doctor EN EL MOMENTO
 - 3. El paciente no se marcha sin valoración si el signo es relevante

Función 3.3 · Monitorización remota

APLICACIÓN	PROTOCOLO
Ortodoncia	Fotografía periódica → valoración → convocatoria solo si procede
Post-quirúrgico	Seguimiento fotográfico días 3 y 7
Mantenimiento	Control intermedio entre visitas presenciales

- PROTOCOLO POST-QUIRÚRGICO
- DÍA 1 Contacto telefónico
- DÍA 3 Solicitud de fotografía + cuestionario breve
- DÍA 7 Valoración de evolución
- ↓
- ¿EVOLUCIÓN NORMAL? SÍ → seguimiento estándar
- NO → convocatoria presencial inmediata

NUNCA	MOTIVO
Diagnosticar a distancia	Requiere exploración
Sustituir una revisión indicada	Complementa, no reemplaza
Resolver una urgencia por fotografía	Se convoca siempre

Función 3.4 · El perfil Alma anual

Qué es

El informe predictivo que se entrega a cada miembro del programa. El producto que ningún competidor tiene.

PASO	RESPONSABLE
Recopilación de datos del año	Higienista
Comparativa de índices y fotografías	Higienista
Proyección de riesgo	Doctor (valida)
Plan del año siguiente	Higienista + Doctor
Entrega y explicación	Higienista

Momento de entrega

Presencial, antes de la renovación. Nunca por correo sin explicación.

Jornada tipo del Higienista

MOMENTO	FUNCIÓN
Antes de abrir	Agenda de mantenimientos · historiales revisados · gabinete preparado
Mañana	Higienes y mantenimientos · apoyo clínico
13:30-16:00	Franja principal de programa de mantenimiento
Entre pacientes	Registro de índices inmediato
Tarde	Continuación · monitorización remota · elaboración de perfiles
Cierre	Registros completos · derivaciones comunicadas · agenda de mañana
Semanal	Revisión de adherencia · pacientes que no acudieron

PERFIL 4

Auxiliar · funciones de vanguardia

Misión: garantizar que la actividad clínica se desarrolla con seguridad absoluta y que el diagnóstico dispone de material impecable.

Función 4.1 · Gestión de equipos

COMPROBACIÓN DIARIA (15 min antes de abrir)

- ❑ Equipos informáticos y acceso al sistema
- ❑ CBCT: arranque y calibración
- ❑ OPG: arranque
- ❑ Escáner intraoral: conexión y calibración
- ❑ Compresor: presión y purga de condensados
- ❑ Aspiración: potencia
- ❑ Purga de líneas de agua de cada gabinete
- ❑ Autoclave: test de funcionamiento
- ❑ Sillones: movimientos, luz, agua
- ❑ Cámara intraoral
- ❑ Equipo de emergencia (si aplica)

Regla

Se enciende y se comprueba. No se asume que funciona.
Cualquier anomalía se comunica antes de la llegada del primer paciente.

EQUIPO	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE
Autoclave	Según fabricante	Externo + registro interno
CBCT / OPG	Según fabricante + control de calidad	Externo
Compresor	Purga diaria + revisión periódica	Interno + externo
Escáner	Calibración según fabricante	Interno
Sillones	Revisión periódica	Externo

Función 4.2 · Batería diagnóstica

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. CBCT | posicionamiento verificado |
| 2. OPG | panorámica completa |
| 3. ESCANEADO INTRAORAL | ambas arcadas completas |
| 4. SERIE FOTOGRÁFICA | extraoral e intraoral completa |
| ↓ | |
| 5. CONTROL DE CALIDAD | nitidez · encuadre · enderezado |
| 6. FUSIÓN DE ARCHIVOS | verificada |
| 7. CARGA EN SISTEMA | etiquetada correctamente |
| 8. MOSTRAR AL PACIENTE | su modelo 3D (30 segundos) |
| 9. NOTIFICAR AL DOCTOR | disponibilidad confirmada |

SERIE EXTRAORAL	SERIE INTRAORAL
Frontal en reposo	Frontal en oclusión
Frontal sonriendo	Lateral derecho
Perfil derecho	Lateral izquierdo
Perfil izquierdo	Oclusal superior
Tres cuartos	Oclusal inferior
—	Detalles de zonas específicas

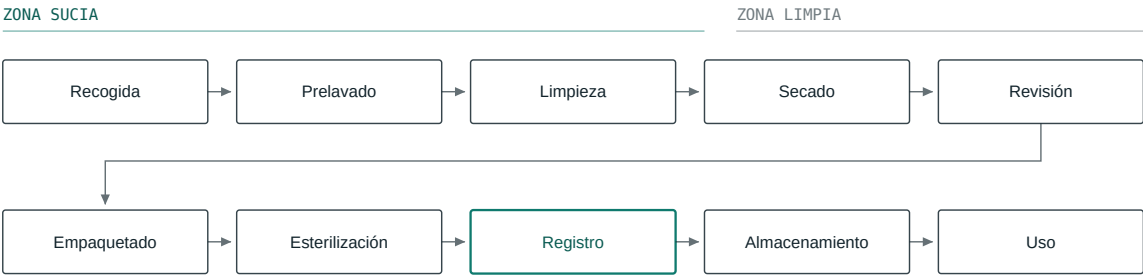
Regla

Si una imagen genera duda, se repite en el momento. Nunca se deja «a ver si vale».

Tiempo de batería completa	≤ 15 min
Tiempo con fusión	≤ 20 min
Repetición por calidad	< 5 %
Fusiones correctas	≥ 95 %

Función 4.3 · Esterilización y bioseguridad

La función que más determina la calidad real de una clínica.



Circuito unidireccional: no se cruzan materiales ni se retrocede.

El circuito unidireccional de esterilización. La frontera entre zona sucia y zona limpia se cruza una sola vez y en un solo sentido; el registro del ciclo es el paso que convierte el proceso en trazable y, ante una incidencia, en defendible.

Regla del circuito

Zona sucia y zona limpia físicamente diferenciadas. No se cruzan materiales ni se retrocede.

Registro por ciclo · todos obligatorios

- ☐ Fecha y hora
- ☐ Número de ciclo
- ☐ Programa utilizado
- ☐ Contenido del ciclo
- ☐ Resultado de controles
- ☐ Responsable

CONTROL	FRECUENCIA
Físico (parámetros del ciclo)	Cada ciclo
Químico	Según protocolo validado
Biológico	Según protocolo · se conserva
Test de funcionamiento	Según fabricante

ANTE CONTROL FALLIDO

1. EL MATERIAL DE ESE CICLO NO SE UTILIZA
2. Se reprocesa
3. Se comunica al responsable clínico de inmediato
4. Se registra la incidencia
5. Si se repite → equipo retirado de servicio

Prohibiciones absolutas

- Usar instrumental con duda de esterilidad
- Reencapuchar agujas
- Reutilizar material de un solo uso
- Usar envase dañado o caducado
- Omitir el registro de ciclo
- Acelerar o interrumpir un ciclo por prisa de agenda

Función 4.4 · Gestión de material y stock**El principio de vanguardia**

El stock no se controla cuando falta. Se controla contra la agenda de las próximas tres semanas.

REVISIÓN SEMANAL DE STOCK

↓

CRUCE CON AGENDA DE 21 DÍAS

↓

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

↓

PROPUESTA DE PEDIDO A DIRECCIÓN

CATEGORÍA	CONTROL	FRECUENCIA
Implantes y componentes	Por referencia y medida	Semanal + antes de cada cirugía
Material quirúrgico	Por kit	Semanal
Material de regeneración	Por referencia y caducidad	Semanal
Fungible clínico	Por nivel de stock mínimo	Semanal
Material de esterilización	Por nivel	Semanal

CATEGORÍA	CONTROL	FRECUENCIA
Productos de higiene	Por nivel	Quincenal

VERIFICACIÓN PARA CIRUGÍAS

RAC SOLICITA VERIFICACIÓN

↓

AUXILIAR COMPRUEBA FÍSICAMENTE (nunca «creo que sí»)

↓

CONFIRMA: disponible / hay que pedir / plazo estimado

↓

RAC AGENDA EN CONSECUENCIA

Caducidades

La pérdida por caducidad es 100 % evitable. Se mide como indicador de gestión: revisión mensual de caducidades a 60 días, rotación continua (lo que caduca antes, delante) y retirada inmediata al detectar.

Roturas de stock	0
Cirugías canceladas por material	0
Material caducado (valor)	Mínimo, medido
Exactitud en verificación a RAC	100 %

Función 4.5 · Gestión de residuos

CATEGORÍA	CONTENEDOR	NORMA
Asimilables a urbanos	Circuito general	—
Biosanitarios específicos	Contenedor específico	Gestor autorizado
Cortopunzante	Contenedor rígido	Nunca sobrepasar la marca
Químicos	Contenedor específico	Gestor específico
Amalgama	Separador + contenedor	Gestor específico

- Nunca se introduce la mano en un contenedor de cortopunzante.
- Se cierran definitivamente al alcanzar el límite, con fecha.
- No se almacenan en zonas de paciente ni de paso.
- Documentación de retirada conservada.

Jornada tipo del Auxiliar

MOMENTO	FUNCIÓN
Antes de abrir	Comprobación de equipos · purga · autoclave · gabinetes · material de cirugías del día
Mañana	Asistencia quirúrgica · baterías diagnósticas
Continuo	Esterilización · preparación entre pacientes
A demanda	Verificación de material para RAC
Tarde	Baterías · asistencia · esterilización
Cierre	Instrumental pendiente · residuos · apagado de equipos · material de mañana verificado
Semanal	Revisión de stock contra agenda de 21 días
Mensual	Control de caducidades

PERFIL 5

RAC · funciones de vanguardia

Misión: garantizar que todo lo vendido se entrega completo, en el menor tiempo posible y sin una sola incidencia evitable.

Función 5.1 · Circuito de producción

FASE 11 · PRESUPUESTO ACEPTADO

1. REGISTRO DEL CASO (tratamiento · importe · pago · plan)
2. RECEPCIÓN DE FICHA DE MATERIAL (del Doctor)
3. PEDIDO INMEDIATO de material específico ★ no se espera a la fecha
4. VERIFICACIÓN DE PAGO
5. VERIFICACIÓN DE MATERIAL Y PLAZOS
6. AGENDADO con fecha realista
7. CONFIRMACIÓN AL PACIENTE con instrucciones
8. CHECKLIST 24-48 h
9. VERIFICACIÓN FINAL el día de la cirugía
10. ACTUALIZACIÓN: pendiente → realizado
11. AGENDADO DE REVISIONES POST-OPERATORIAS
12. PROGRAMACIÓN DE LA SIGUIENTE FASE DEL PLAN

El cambio de vanguardia

El pedido de material se dispara con la aceptación del presupuesto, no con la proximidad de la cirugía.

Esto elimina de raíz la causa más frecuente de cancelación quirúrgica.

Función 5.2 · Doble verificación y poder de bloqueo

La regla innegociable

Ninguna cirugía se agenda sin verificar pago y material. Las dos. Siempre.

RAC es el único puesto con capacidad de detener un agendado. Ninguna presión comercial anula esta facultad. Si Dirección quiere agendar sin verificación, se escala a Gerencia.

LÍNEA	NO SE AGENDA SI...
Implantología estándar	Falta pago confirmado o material verificado
Cirugía guiada	La férula no está recibida y probada

LÍNEA	NO SE AGENDA SI...
Carga inmediata	El laboratorio no ha confirmado disponibilidad por escrito
Sedación	Falta valoración previa · consentimiento específico · acompañante confirmado · profesional competente · equipo de emergencia verificado
Ortodoncia	Los alineadores no han llegado

Función 5.3 · Planificación quirúrgica

ELEMENTO	VERIFICACIÓN
Quirófano disponible	Reservado
Doctor confirmado	Agenda bloqueada
Auxiliar confirmado	Asignado
Anestesiólogo (si aplica)	Confirmado
Material completo	Verificado físicamente
Guía quirúrgica	Recibida y probada
Componentes protésicos	Disponibles
Consentimiento quirúrgico	Firmado
Instrucciones al paciente	Entregadas
Tiempo estimado	Bloqueado con margen

Checklist 24-48 h antes

Pago confirmado · material físicamente disponible · guía probada · consentimiento firmado · quirófano reservado · Doctor y Auxiliar confirmados · paciente confirmado con instrucciones. Si algo falla, se resuelve o se reprograma. Nunca se llega al día con una casilla sin marcar.

Función 5.4 · Control de producto pendiente

El producto pendiente es el valor de todo lo aceptado y pagado que aún no se ha ejecutado. Es el indicador que gobierna todo el puesto.

PANEL DE CONTROL							
Paciente	Tratamiento	Importe	Cobrado	F. aceptación	Días	Estado	Bloqueo

ANTIGÜEDAD	RIESGO	ACTUACIÓN
> 6 meses	■ CRÍTICO	Contacto del Director en 72 h
3-6 meses	■ ALTO	Contacto en la semana
1-3 meses	■ MEDIO	Seguimiento estándar
< 1 mes	■ NORMAL	Circuito

Planes incompletos

Un plan de tres fases con solo la primera ejecutada no es un plan terminado: es un plan incompleto. Se controla semanalmente: fases pendientes sin agendar, casos parados sin motivo y casos con más de 60 días sin avanzar (estos, a Dirección).

Producto pendiente total	Tendencia descendente
Casos > 6 meses	0
Tiempo medio aceptación → ejecución	Mínimo
Cirugías canceladas por material o pago	0
Planes con fases pendientes sin agendar	0

Jornada tipo de RAC

MOMENTO	FUNCIÓN
Antes de abrir	Cirugías del día verificadas · nada ha cambiado
Mañana	Registro de casos nuevos · pedidos inmediatos · verificaciones
Continuo	Confirmaciones a pacientes · coordinación con Auxiliar
Tarde	Checklist 24-48 h de cirugías próximas · seguimiento de plazos de material
Cierre	Cirugías de mañana verificadas · reporte
Semanal	Panel de producto pendiente · casos parados · reporte a Dirección

PERFIL 6

Dirección clínica · funciones de vanguardia

Misión: coordinar el sistema, conducir el proceso comercial y garantizar que nada de lo prometido se queda sin entregar.

Función 6.1 · Coordinación operativa

INSTRUMENTO	FRECUENCIA	DURACIÓN
Briefing de apertura	Diario	5 min
Punto de control de mediodía	Diario	5 min
Cierre de jornada	Diario	10 min
Coordinación semanal	Semanal	15 min
Revisión de producción con RAC	Semanal	15 min
Comité de casos complejos	Semanal / quincenal	Según volumen
Resultados mensuales	Mensual	45 min

- BRIEFING DE APERTURA – CONTENIDO FIJO
- 1. Pacientes complejos o delicados del día
 - 2. Cirugías y necesidades especiales
 - 3. Ausencias o cambios en el equipo
 - 4. Incidencias pendientes del día anterior
 - 5. «¿Alguien necesita algo?»

Función 6.2 · Proceso comercial

FASE	FUNCIÓN DE DIRECCIÓN
2	Tour activo con demostración
3	Anamnesis de expectativas · RGPD
6	Briefing con el Doctor — sin excepción
8	Redacción del IAC al dictado
9	Operación de pantalla · narrativa comercial

FASE	FUNCIÓN DE DIRECCIÓN
10	Presentación de tres escenarios · cierre
11	Aceptación · aviso a RAC
12	Seguimiento de no convertidos

LA ESTRUCTURA DEL CIERRE
1. JUSTIFICAR EL VALOR antes del número
2. PRESENTAR EL PLAN COMPLETO
3. DESGLOSE línea por línea
4. TRES ESCENARIOS: completo / fases / sin tratamiento
5. OPCIONES DE PAGO con cálculo en directo
6. CIERRE

MANEJO DE OBJECIONES – SECUENCIA OBLIGATORIA
1. VALOR Reencuadrar como inversión
2. FACILIDADES Financiación, cuota mensual
3. FASES Plan integral en etapas
y solo entonces, si procede y con autorización:
4. DESCUENTO Dentro de tabla, con registro

Función 6.3 · Control de gestión

PANEL DIARIO

☐ Documentación 100 % subida
☐ Caja cuadrada
☐ Cirugías de mañana verificadas
☐ Casos delicados de mañana asignados
☐ Incidencias registradas

PANEL SEMANAL · INDICADOR	FUENTE
Producción realizada	Sistema
Primeras visitas y conversión	Sistema
Ticket medio	Sistema
Producto pendiente	RAC

PANEL SEMANAL · INDICADOR	FUENTE
Ocupación de agenda	Recepción
Ausencias	Recepción
Stock crítico	Auxiliar
Adherencia a programa	Higienista

AUDITORÍA PERIÓDICA · QUÉ	FRECUENCIA
Documentación del mismo día	Diaria
Cumplimiento de checklists	Semanal
Historias clínicas (muestra)	Trimestral
Trazabilidad de implantes	Trimestral
Consentimientos	Trimestral
Registros de esterilización	Mensual
Complicaciones y resultados	Semestral

VI

Interdependencias e indicadores

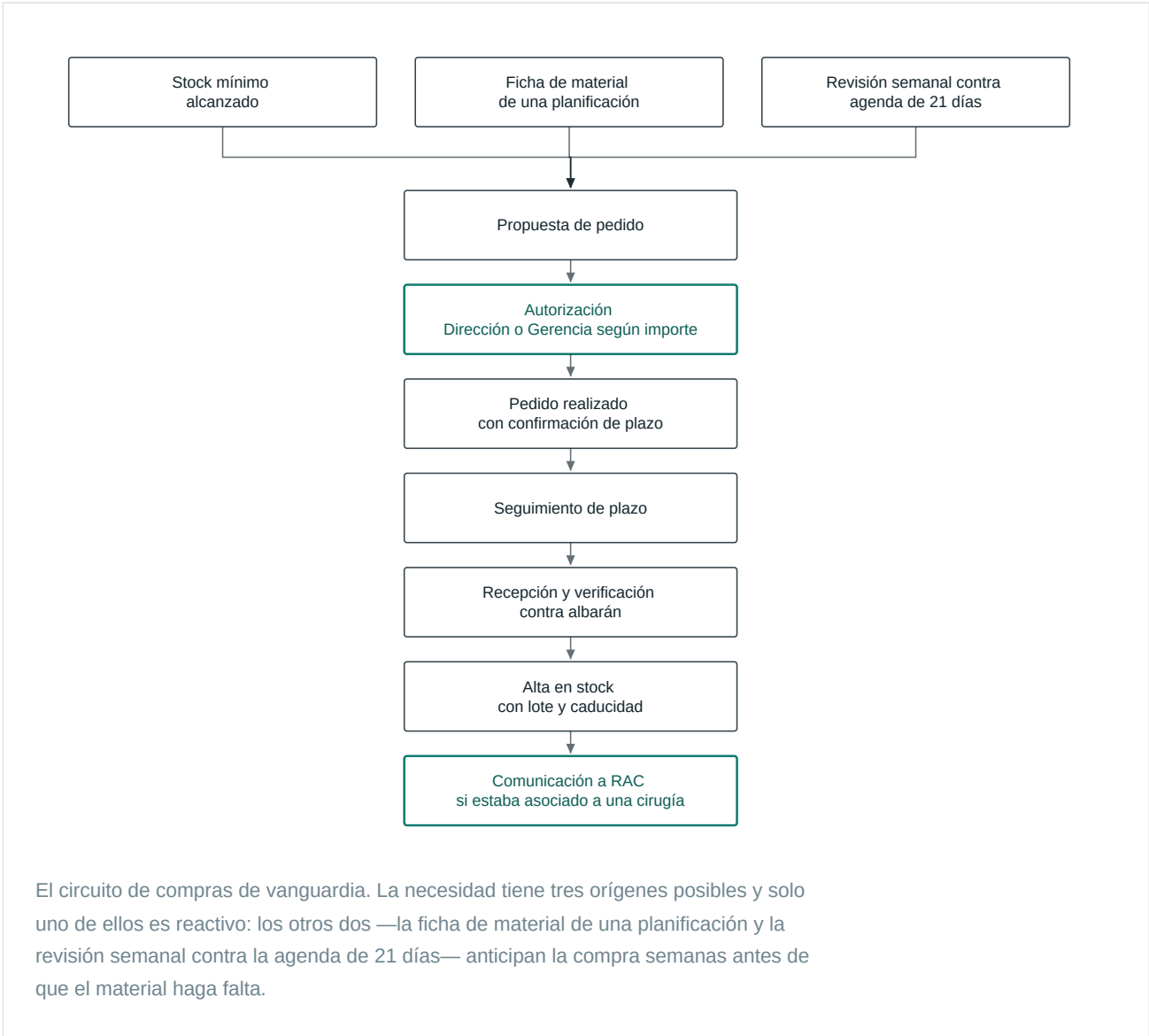
Función transversal de compras, matriz de interdependencias y cuadro maestro de indicadores.

PERFIL FX · FUNCIÓN TRANSVERSAL

Compras y proveedores

Asignada a un perfil, habitualmente el Auxiliar, con autorización de Dirección.

III.1 · El circuito de vanguardia



III.2 · Niveles de autorización

IMPORTE / TIPO	AUTORIZA
Reposición ordinaria dentro de stock mínimo	Automático
Pedido no ordinario	Dirección
Compra relevante	Gerencia

IMPORTE / TIPO	AUTORIZA
Cambio de proveedor	Gerencia
Nuevo producto o marca	Gerencia + criterio clínico

III.3 · Gestión de proveedores

ELEMENTO	CONTROL
Contrato o condiciones vigentes	Documentado
Plazos comprometidos	Verificados
Incidencias	Registradas
Revisión de condiciones	Anual
Alternativa disponible	Para cada material crítico

Regla de dependencia

Todo material crítico debe tener un proveedor alternativo identificado.

III.4 · Gestión del laboratorio protésico

La relación con más impacto en el producto pendiente.

CONTROL	FRECUENCIA
Trabajos en curso	Semanal
Plazos comprometidos vs. reales	Semanal
Tasa de repeticiones	Mensual
Incidencias de calidad	Continuo
Trabajos sin reclamar	Semanal

Lectura de las repeticiones

Las repeticiones de laboratorio son un indicador de calidad disfrazado de coste. Si suben, el problema puede ser propio, no del laboratorio.

Roturas de stock

0

Cirugías afectadas por falta de material	0
Pérdida por caducidad	Mínima, medida
Plazos de proveedor cumplidos	≥ 95 %
Repeticiones de laboratorio	Descendente

IV · INTERDEPENDENCIAS

Qué necesita cada perfil de los demás

Cada fila es un punto de fallo potencial: si algo se rompe en la clínica, casi siempre es una de estas conexiones.

PERFIL	NECESITA DE	QUÉ EXACTAMENTE	CUÁNDO
Doctor	Auxiliar	Batería diagnóstica completa y fusionada	Antes de la Fase 6
	RAC	Confirmación de material	Antes de agendar cirugía
	Dirección	Briefing realizado	Antes de cada presentación
Dirección	Doctor	IAC y solicitud firmados	Antes de presupuestar
	Doctor	Plan único acordado	Antes de la presentación
	Recepción	Alta completa en sistema	Antes de la Fase 9
RAC	Doctor	Ficha de material de la planificación	Al planificar
	Auxiliar	Verificación física de material	Antes de agendar
	Dirección	Aviso de aceptación con datos completos	Fase 11
Auxiliar	Doctor	Indicación de pruebas necesarias	Antes de Fase 5
	RAC	Previsión de cirugías	Semanal
Higienista	Doctor	Perfil de riesgo y periodicidad	Al alta
	Recepción	Agenda de mantenimientos	Continuo
Recepción	Todos	Documentación firmada	El mismo día
	Dirección	Aviso de aceptación para agendar	Fase 11

V · CUADRO MAESTRO

Indicadores por perfil

PERFIL	INDICADOR NUCLEAR	OBJETIVO
Recepción	Documentación el mismo día	100 %
	Ocupación franja 18-20 h con PV	≥ 70 %
Doctor	Perfiles de riesgo registrados	100 %
	Trazabilidad de implantes	100 %
Higienista	Próxima cita agendada antes de salir	100 %
	Adherencia al programa	≥ 80 %
Auxiliar	Cirugías canceladas por material	0
	Registros de esterilización	100 %
RAC	Producto pendiente	↓ sostenido
	Casos > 6 meses	0
Dirección	Tasa de conversión	Creciente
	Briefings realizados	100 %

Los cinco indicadores que definen una clínica de vanguardia

Indicador 01

Historiales revisados antes de la cita

Nadie improvisa.

Indicador 02

Perfiles de riesgo registrados

Se diagnostica el futuro.

Indicador 03**Cirugías canceladas por material**

La anticipación funciona.

Indicador 04**Producto pendiente descendente**

Lo vendido se entrega.

Indicador 05**Documentación el mismo día**

La trazabilidad es real.

Lectura conjunta**Se leen juntos**

Un indicador aislado se puede maquillar; los cinco a la vez describen si el sistema se está cumpliendo de verdad.

VI · Lo que define la vanguardia

Cinco comportamientos que ninguna tecnología sustituye:

- Nadie conoce un caso a la vez que el paciente.
- El material se pide al planificar, no al necesitarlo.
- Ninguna cirugía se agenda sin doble verificación.
- La próxima cita se agenda antes de que el paciente salga.
- Todo se registra en el momento, no al final del día.

El resumen del manual

Una clínica con CBCT, escáner, prediagnóstico por IA e impresión 3D, donde un paciente lleva seis meses esperando su prótesis y el doctor abre su historial cuando ya está sentado, no es una clínica de vanguardia.

Es una clínica con buen equipamiento y mala organización. Y esa diferencia el paciente la percibe antes que cualquier tecnología.

Indicadores del programa ATC

ALMA TE CUIDA

Se revisan con la misma cadencia que los demás. El primero es el que manda: mide el comportamiento del equipo, no la decisión del paciente.

INDICADOR	OBJETIVO	QUÉ REVELA
% de pacientes a los que se ofreció	100 %	Si el ofrecimiento está realmente instalado en el circuito, o depende de quién atienda
Altas al mes	Creciente	Ritmo real de adopción
Tasa de conversión del ofrecimiento	Creciente	Calidad del speech y del manejo de objeciones
Penetración en pacientes activos	La mayoría	Hasta qué punto tener ATC es lo normal para un paciente del centro
Tasa de renovación	≥ 80 %	Valor percibido: si no renuevan, el programa no se está usando

El seguimiento operativo vive en el panel del programa: titulares con su fecha de alta y de vencimiento, movimiento mensual de altas, renovaciones y bajas, y el cálculo del ahorro real con los precios de la clínica. Detalle en [Otros · ATC](#).

Indicadores consolidados del centro

COMPENDIO MAESTRO

ECONÓMICOS

- Producción realizada y cobros
- Producto pendiente
- Ticket medio y margen por tratamiento
- Punto de equilibrio
- Tesorería a 60 días
- Coste de material sobre producción

DE MARKETING

- Contactos y citas por canal
- Tasa de asistencia y conversión por canal
- Coste de captación y valor del paciente a largo plazo
- Retorno por canal
- Porcentaje de pacientes por recomendación
- Reseñas nuevas y valoración media

DE EQUIPO

- Rotación y absentismo
- Formación completada
- Reportes entregados a tiempo

- Incidencias internas

LOS CINCO INDICADORES DEL LIDERAZGO REAL

- Porcentaje de pacientes que llegan por recomendación
- Pacientes en mantenimiento activo
- Producto pendiente mínimo
- Rotación de equipo cercana a cero
- Reputación online sostenida

Estos cinco no aparecen en ningún cuadro de mando al uso, y son los que describen si el centro está bien dirigido. Ninguno se puede maquillar en un trimestre.

VII

Plan de incentivos

Cómo se convierten los indicadores en retribución variable.

VII.1 · Filosofía del plan

Principio

Se incentiva lo que se puede medir y lo que la persona controla.

El incentivo premia el comportamiento de vanguardia, no solo el resultado económico: si se recompensa únicamente la facturación, se erosiona la calidad; si se recompensa el sistema, la facturación llega sola y se sostiene.

- **Se incentiva lo controlable.** Cada perfil solo responde por indicadores que dependen de su trabajo, no de terceros.
- **Calidad como llave (gate).** Ningún incentivo económico se cobra si no se superan primero los umbrales de calidad y seguridad. La trazabilidad y la esterilización no son negociables por dinero.
- **Individual + equipo.** Una parte premia el desempeño propio y otra el resultado del centro, para que nadie optimice su casilla a costa del conjunto.
- **Transparencia.** Cada persona conoce de antemano sus indicadores, sus umbrales y su fórmula. Nadie se evalúa por objetivos que no conocía.
- **Trimestral con revisión anual.** Se liquida por trimestre y se recalibran los umbrales una vez al año.

VII.2 · Arquitectura de la retribución variable

BLOQUE	QUÉ MIDE	NATURALEZA
A · Calidad y seguridad (gate)	Trazabilidad, esterilización, consentimientos, documentación	Umbral de acceso: si no se cumple, no hay bonus
B · Desempeño individual	Indicadores nucleares del propio puesto	Escalable según cumplimiento
C · Resultado de equipo	Producción del centro y producto pendiente	Común a todo el equipo

Cómo funciona el gate

El bloque A no suma dinero: lo desbloquea.

Si los indicadores de calidad del trimestre están por debajo del umbral, el bonus de ese trimestre es cero por muy buenos que sean B y C. Es la garantía de que la vanguardia nunca se sacrifica por producción.

VII.3 · Escala de cumplimiento

NIVEL DE LOGRO	DENOMINACIÓN	% DEL OBJETIVO DEL INDICADOR
< umbral mínimo	No alcanzado	0 %
Umbral mínimo	Cumple	60 %
Objetivo	Cumple bien	100 %
Objetivo superado	Excelente	120 %
Excelencia sostenida (2+ trimestres)	Vanguardia	130 % (tope)

El tope del 130 % evita que un indicador dispare el coste y protege el equilibrio del plan. La «excelencia sostenida» premia la constancia, no el pico puntual.

VII.4 · Pesos por perfil

PERFIL	A · CALIDAD (GATE)	B · INDIVIDUAL	C · EQUIPO
Recepción	Gate	70 %	30 %
Doctor	Gate	65 %	35 %
Higienista	Gate	70 %	30 %
Auxiliar	Gate	75 %	25 %
RAC	Gate	65 %	35 %
Dirección	Gate	50 %	50 %

Dirección tiene el mayor peso de equipo (50 %) porque su función es que el conjunto funcione. El Auxiliar tiene el mayor peso individual (75 %) porque su trabajo es muy medible y directo. En todos, la calidad es gate, no porcentaje.

VII.5 · Indicadores incentivados por perfil

PERFIL	BLOQUE	INDICADOR	UMBRAL	OBJETIVO
Recepción	A · gate	Documentación subida el mismo día	98 %	100 %
	B	Ocupación franja 18-20 h con PV	60 %	≥ 70 %
	B	Huecos recuperados tras cancelación	40 %	≥ 50 %
	B	Origen registrado (calidad del dato de marketing)	95 %	≥ 98 %

PERFIL	BLOQUE	INDICADOR	UMBRAL	OBJETIVO
Doctor	A · gate	Trazabilidad de implantes + consentimientos verificados	100 %	100 %
	B	Perfiles de riesgo registrados	90 %	100 %
	B	Historiales revisados antes de la cita	95 %	100 %
	B	Casos documentados el mismo día	95 %	100 %
Higienista	A · gate	Registros de índices completos + derivaciones a tiempo	95 %	100 %
	B	Próxima cita agendada antes de salir	90 %	100 %
	B	Adherencia al programa de mantenimiento	70 %	≥ 80 %
	B	Pacientes con implantes en programa activo	Estable	Creciente
Auxiliar	A · gate	Registros de esterilización completos	100 %	100 %
	B	Cirugías canceladas por material	≤ 1/trim	0
	B	Repetición de pruebas por calidad	< 8 %	< 5 %
	B	Exactitud en verificación de material a RAC	95 %	100 %
RAC	A · gate	Doble verificación aplicada (pago + material)	100 %	100 %
	B	Producto pendiente total	Estable	↓ sostenido
	B	Casos > 6 meses	≤ 2	0
	B	Tiempo medio aceptación → ejecución	Estable	Descendente
Dirección	A · gate	Cumplimiento de auditorías y briefings	95 %	100 %
	B	Tasa de conversión de primeras visitas	Estable	Creciente
	B	Ticket medio	Estable	Creciente

VII.6 · El componente de equipo

INDICADOR DE EQUIPO	UMBRAL	OBJETIVO	PESO DENTRO DE C
Producción del centro (trimestral)	Presupuesto	≥ objetivo	50 %
Producto pendiente (tendencia)	Estable	Descendente	30 %
Reseñas / satisfacción (valoración media)	≥ 4,5	≥ 4,8	20 %

El producto pendiente entra en el bonus de equipo a propósito: obliga a que Recepción, RAC, Auxiliar y Doctor colaboren para que los casos aceptados se ejecuten. Es el antídoto contra vender mucho y entregar poco.

VII.7 · Fórmula de liquidación

BONUS DEL TRIMESTRE

SI (indicadores de calidad $\geq$ umbral) → continúa

SI NO → BONUS = 0

$$\text{BONUS} = \text{Bonus_objetivo} \times [(\text{peso_B} \times \text{logro_medio_B}) + (\text{peso_C} \times \text{logro_medio_C})]$$

donde logro_medio se calcula con la escala de VII.3
y el resultado por indicador se topa al 130 %.

Ejemplo · Auxiliar

Bonus objetivo trimestral: 600 €. Gate de esterilización: cumplido (100 %), luego se cobra. Bloque B (peso 75 %): cero cancelaciones por material (120 %), repetición 4 % (100 %), exactitud 100 % (100 %) → logro medio B $\approx$ 107 %. Bloque C (peso 25 %): producción en objetivo (100 %), pendiente descendente (120 %), satisfacción 4,7 (100 %) → logro medio C $\approx$ 106 %.

$$\text{Bonus} = 600 \text{ €} \times [(0,75 \times 1,07) + (0,25 \times 1,06)] = 600 \text{ €} \times (0,80 + 0,265) \approx 639 \text{ €}.$$

VII.8 · Incentivos no económicos

- **Reconocimiento del trimestre.** A la persona o al perfil con mejor cumplimiento sostenido de su gate de calidad.
- **Presupuesto de formación.** Quien mantiene excelencia dos trimestres accede a formación avanzada financiada.
- **Días de libre disposición.** Ligados a hitos de equipo, como cerrar un trimestre con cero casos de producto pendiente > 6 meses.
- **Participación en decisiones.** Los perfiles con mejor desempeño participan en la revisión anual de protocolos.

VII.9 · Gobernanza del plan

ASPECTO	REGLA
Cálculo	Automático desde los indicadores del sistema; sin valoración subjetiva
Liquidación	Trimestral, en la nómina del mes siguiente al cierre del trimestre

ASPECTO	REGLA
Comunicación	Cada persona recibe su hoja de cumplimiento con el detalle por indicador
Revisión de umbrales	Anual, en la evaluación de resultados; nunca a mitad de trimestre
Cláusula de integridad	Falsear un registro para cobrar incentivo anula el bonus del año y es falta grave

Principio final

El plan de incentivos no sustituye al salario justo: lo complementa.

Su objetivo no es que la gente trabaje más, sino que trabaje según el sistema de vanguardia, porque cuando el sistema se cumple, la producción y la calidad crecen juntas.

VIII

Puesta en marcha

Las 72 horas previas y la mañana del día 1 en un centro recién adquirido.

Contexto

Esta parte aplica a la puesta en marcha del centro tras la adquisición de Arclimedent. En esta clínica, el rol de Asesor Comercial lo asume el Director de Clínica. El objetivo de los primeros días es doble: que ningún paciente note el cambio y que ninguna persona del equipo se vaya. La continuidad es la credibilidad de partida.

A.1 · Las cinco verificaciones que haces en persona

Cinco comprobaciones no se delegan: se hacen en persona y con el documento delante, no fiándose de lo que cuenten.

Autorización sanitaria de funcionamiento

Ver la resolución del cambio de titularidad, no que la asesoría diga que «está en trámite». Si no saben responder con claridad, es señal de alarma.

Seguro de responsabilidad civil

Pedir la póliza y comprobar cuatro puntos: cobertura vigente, importe, retroactividad (que cubra actos anteriores a la compra) y titular. Ante una duda razonable de cobertura, no se realiza ninguna actuación clínica de riesgo.

Situación laboral de cada persona

Primera prioridad humana. Verificar que existe comunicación formal escrita a cada trabajador, y distinguir con claridad sucesión de empresa (art. 44 ET) de nueva contratación.

Acceso real a los historiales

Abrir tú mismo, esa misma tarde, varias historias en el sistema. Si no puedes acceder a alguna, localizar dónde está físicamente. Nunca se elimina, sobrescribe ni da de baja ningún dato.

Exposición financiera real

El dinero que pacientes ya han pagado y cuyo tratamiento falta por ejecutar (producto pendiente heredado). Repasar la lista uno a uno, distinguiendo lo pagado-no-ejecutado de lo facturado-cobrado.

Cómo se registra

AMPLIACIÓN

Cada verificación se cierra con la fecha, el documento visto y quién lo mostró. Lo que no tenga documento a la vista se anota como pendiente con responsable y plazo.

A.2 · Los cuatro documentos que preparas

No tienen que estar perfectos. Tienen que existir.

- ☐ **Inventario de pacientes en tratamiento activo** — nombre, tratamiento, fase, profesional, próxima cita y clasificación de riesgo

☐ **Conciliación financiera** — quién ha pagado qué y qué falta por ejecutar

☐ **Agenda impresa de los próximos 5 días** — respaldo en papel por si el sistema falla en la hora cero

☐ **Listado de personal** — con rol asignado para mañana y situación laboral confirmada

A.3 · Clasificación de riesgo de pacientes

COLOR	CRITERIO	EJEMPLO
■ ROJO	Fase quirúrgica abierta, post-operatorio reciente, o cualquier caso donde un retraso o error tenga consecuencia clínica.	Implante colocado hace 10 días pendiente de revisión; provisional que debe sustituirse en fecha.
■ AMARILLO	Tratamiento en curso sin urgencia clínica inmediata.	Ortodoncia en seguimiento mensual; fase protésica en espera de laboratorio.
■ VERDE	Mantenimiento, revisión de rutina, higiene periódica.	Higiene semestral programada.

Regla operativa

Todos los rojos se contactan proactivamente antes de su próxima cita.

Ninguno puede llegar el día 1 sin que sepas quién le atiende y en qué punto está.

A.4 · Qué preparas físicamente en la clínica

- **Cartelería de continuidad en recepción.** Breve y visible. El paciente no debe descubrir el cambio de marca por sorpresa.
- **Archivo localizado y accesible.** Que Recepción sepa exactamente dónde está y llegue a él en menos de un minuto.
- **Sistema operativo comprobado.** Enciende y entra en Clinic Cloud hoy, no mañana a las nueve menos cinco.

A.5 · Dónde encaja esto en el programa de 100 días

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN

La puesta en marcha de este manual es la fase 1 de un programa con tres puertas de paso. Ninguna fase se adelanta: el paso de una a otra exige autorización expresa del Comité de Transición previa verificación de los criterios de salida. El programa completo, con sus seis flujos de trabajo y su registro de riesgos, está en

Otros · Programa de 100 días

PUERTA	DÍA	NO SE PASA SIN...
1 · Estabilización	30	Tres verificaciones críticas cerradas · entrevistas completadas · cero bajas voluntarias · cero reclamaciones de pacientes heredados · producto pendiente inventariado · casos rojos con profesional asignado · devolución al equipo
2 · Consolidación	60	Once verificaciones regulatorias cerradas · seis decisiones de marco adoptadas y comunicadas · línea base económica · sistema de reportes operativo · formación por perfil completada · producto pendiente descendente
3 · Proyección	100	Protocolo ejecutado sin supervisión constante · responsables funcionales reportando · programa de mantenimiento en marcha · presencia digital reestructurada · indicadores con serie propia · plan de líneas avanzadas autorizado

La regla del primer mes

No lanzar nada nuevo hasta saber exactamente qué hay.

Durante los primeros treinta días no se lanzan líneas avanzadas, ni campañas de pago, ni cambios de precios, ni reorganizaciones del equipo, ni cambios de protocolo: no se conocen aún los márgenes, ni las personas, ni por qué las cosas están como están. El detalle semana a semana está en [Otros · Dossier de los primeros 30 días](#).

B.1 · Tu llegada

Llega el primero. Antes de que aparezca nadie del equipo, haz una vuelta en solitario por todo el centro: lo que se ve cuando no hay nadie es la verdad del sitio. Comprueba instalaciones, esterilización, sistema y agenda del día.

B.2 · La reunión de equipo · guion en siete bloques

- 01 **Apertura · 2 min**
Directo a lo que todos tienen en la cabeza: hay un cambio de titularidad y vas a explicarlo.
- 02 **Situación laboral, persona por persona · 5-8 min**
Nadie escucha nada más hasta saber si conserva su trabajo. Si alguien plantea una duda que no puedes resolver, la anotas y te comprometes a resolverla; nunca dejas a nadie empezar la jornada con esa duda.
- 03 **El mensaje al paciente · 3 min**
«Para el paciente no cambia nada: mismos profesionales, misma atención.»
- 04 **Reparto de roles del día · 5 min**
Cada uno hace hoy lo que hacía ayer.
- 05 **El foco único de hoy · 5 min**
Hoy solo continuidad. Ningún cambio, ninguna métrica nueva.
- 06 **Casos críticos del día · 3 min**
Los rojos: quién los atiende y en qué punto están.

07

Cierre · 2 min

«Voy a mirar y preguntar mucho; no es control. Si algo no funciona, decídmelo: el problema es que lo descubra dentro de tres meses.»

B.3 · Instrucciones que das a cada perfil**A Recepción**

Todo lo firmado hoy se escanea hoy; ninguna información económica de casos heredados (se pasa al Director); y un paciente con cita que no aparece en el sistema se atiende igual y se investiga después. Se le entrega el listado impreso de citas de los próximos días.

A cada Doctor

El historial se revisa antes de cada paciente; ningún consentimiento sin explicar y verificar; y el lote de cada implante se registra sin excepción.

Al Auxiliar

Comprobar los equipos antes del primer paciente; y sobre material, comprobar siempre físicamente, nunca «creo que sí».

B.4 · Durante la jornada

PUESTA EN MARCHA

Tu posición el día 1

No te encierres en el despacho. Tu sitio es donde se pueda escalar cualquier cosa en diez segundos: disponible, visible y accesible.

Cada hora, una comprobación mental de treinta segundos: ¿hay algún paciente esperando más de lo normal?, ¿alguien del equipo tiene cara de estar atascado?, ¿ha entrado algún caso rojo y cómo ha ido?

SITUACIÓN	POR QUÉ INTERVIENES TÚ PERSONALMENTE
Un paciente pregunta por dinero ya pagado	Es la conversación de mayor riesgo del día; no debe gestionarla nadie que no tenga los datos completos
Un paciente muestra desconfianza por el cambio	Requiere autoridad de Dirección para transmitir seguridad real
Un paciente pide devolución	Nunca se decide en caliente ni por otra persona
Un trabajador plantea una duda laboral durante la jornada	Se resuelve al momento y fuera de la vista de pacientes
Un proveedor llama exigiendo aclaraciones	No lo gestiona Recepción: es tuyo

SITUACIÓN	POR QUÉ INTERVIENES TÚ PERSONALMENTE
Cualquier caso rojo con incidencia	Riesgo clínico: escalado inmediato

Los guiones literales de esas conversaciones —dinero pagado, desconfianza en el nuevo profesional, petición de devolución, dudas sobre el futuro de la clínica, subida de precios y espera larga de una cirugía— están en **Otros · Cuaderno de Campo del Día 1**. Cada incidencia se registra en el momento: sin ese registro, el día 5 no se podrá distinguir un problema estructural de una anécdota.

B.5 · Cierre de jornada y primeras 72 horas

PUESTA EN MARCHA

Reunión de cierre del día 1 · 10-15 minutos

«Antes de irnos, tres cosas rápidas. Primero: ¿qué ha pasado hoy que no esperábamos? Sin filtro, quiero saberlo todo, aunque parezca una tontería. [...] Segundo: mañana tenemos estos casos que requieren atención: [casos rojos del día siguiente]. [Doctor], ¿los tienes revisados? Tercero: gracias. Hoy ha ido [valoración honesta]. Mañana seguimos.»

Se escucha y se anota. No se juzga ni se corrige en ese momento.

LO QUE REVISAS TÚ AL CERRAR

- ☐ Todos los pacientes rojos del día atendidos sin incidencia
- ☐ Ninguna documentación sin escanear
- ☐ Ninguna duda laboral sin respuesta
- ☐ Promesas hechas a pacientes, anotadas con fecha de cumplimiento
- ☐ Casos rojos de mañana identificados y con profesional asignado

CHECKLIST DE LAS PRIMERAS 72 HORAS

- ☐ Todos los pacientes rojos contactados o atendidos sin incidencia
- ☐ Primer barrido de conciliación financiera real frente a la prevista
- ☐ Todas las dudas laborales resueltas por escrito
- ☐ Comunicación de cambio enviada a los pacientes
- ☐ Cartas a proveedores y financieras enviadas
- ☐ Ninguna incidencia del registro del día 1 sin respuesta

Días 2 y 3 · qué cambia

Día 2: empieza la formación en el protocolo. Cada perfil lee y practica en voz alta su propia ficha, no en grupo genérico. **Día 3:** formación práctica en software con casos ficticios, nunca con datos reales de pacientes. Ambos días se mantienen la reunión breve de cierre y la posición de Dirección como punto único de escalado.

B.6 · Los siete errores que hunden una transición PUESTA EN MARCHA

Ninguno es técnico, y son los que de verdad cuestan pacientes y equipo.

#	ERROR	POR QUÉ CUESTA TAN CARO
1	Comunicar el cambio de marca antes de resolver la situación laboral	El equipo se entera del rebranding antes de saber si tiene trabajo: la forma más rápida de perder a las personas que se necesitan
2	Improvisar delante del paciente	Un Doctor que abre el historial con el paciente sentado enfrente, o un «no sé cómo queda su caso». Cada frase de esas cuesta un paciente
3	Tratar el día 1 como un día de formación	Se satura al equipo con protocolo nuevo mientras intenta sostener la continuidad, y se hacen mal las dos cosas
4	Delegar las verificaciones críticas	Fiarse de que «alguien lo miró». El día que un paciente reclame, la pregunta será qué comprobaste tú
5	Prometer para salir del paso	Cada promesa incumplida en la primera semana vale por diez cumplidas después
6	Dejar el escaneo «para cuando haya menos lío»	Es exactamente el día en que más importa que todo quede registrado
7	No registrar las incidencias del primer día	Sin ese registro, el día 5 no se distingue un problema estructural de una anécdota

A.5 · Las once verificaciones externas DECISIONES DE GERENCIA

Las cinco verificaciones que se hacen en persona conviven con once comprobaciones que dependen de terceros. No se resuelven técnicamente desde Dirección: se exigen, se verifican y se archivan en la carpeta legal accesible en el centro. El detalle de cada una, con la pregunta exacta que hay que hacer y el documento que hay que exigir, está en Otros · Decisiones de Gerencia.

#	VERIFICACIÓN	PRIORIDAD	SI NO ESTÁ EN REGLA
V1	Autorización sanitaria y cambio de titularidad	■ ANTES DE ABRIR	Sin cambios visibles de titularidad; continuidad según indique la asesoría
V2	Póliza de responsabilidad civil	■ ANTES DE ABRIR	Ninguna actuación clínica; solo actividad administrativa
V3	Situación laboral del personal	■ ANTES DE ABRIR	Se resuelve antes de que nadie atienda pacientes
V4	Protección de datos	■ PRIMER MES	Riesgo sancionador real; prioridad alta

#	VERIFICACIÓN	PRIORIDAD	SI NO ESTÁ EN REGLA
V5	Protocolo de esterilización	PRIMER MES	Se exige por escrito y firmado por el responsable clínico
V6	Gestión de residuos	PRIMER MES	Contrato con gestor autorizado antes de generar residuo
V7	Protección radiológica	PRIMER MES	Sin documentación no se opera el equipo
V8	Plan de prevención de riesgos laborales	PRIMER MES	Se concierta servicio de prevención
V9	Régimen disciplinario	PRIMER TRIMESTRE	Sin marco no hay corrección exigible
V10	Alcance competencial de la sedación	ANTES DE LA LÍNEA	Bloqueante: no se lanza la línea
V11	Publicidad sanitaria	ANTES DE CAMPAÑAS	No se publica campaña sin criterio

C · Calendario integral de implantación

COMPENDIO MAESTRO

TRAMO	FOCO	HITOS QUE QUEDAN CERRADOS
Día 0	Preparar	Verificaciones V1, V2 y V3 · inventario de pacientes en tratamiento · conciliación financiera · agenda de cinco días impresa · situación laboral comunicada por escrito · reunión de equipo preparada
Día 1	Continuidad	Llegada 45 minutos antes con vuelta de comprobación · reunión de equipo en siete bloques · reparto de fichas individuales · jornada con foco único · reunión de cierre y reporte
Semana 1	Estabilizar	Día 2 formación del protocolo por perfil · día 3 formación en el sistema · día 4 simulacro completo de las catorce fases · día 5 revisión de incidencias · fin de semana primeros indicadores. Además: conversación individual con cada persona y decisiones urgentes 1 a 6
Mes 1	Ordenar	Decisiones urgentes cerradas · verificaciones V4 a V8 iniciadas · producto pendiente inventariado y priorizado · casos de más de seis meses contactados · perfil de Google renombrado · reactivación de los dos primeros segmentos · primeras delegaciones · rúbricas de competencia
Mes 2	Delegar	Decisiones importantes cerradas · responsables funcionales con nombre · acuerdos de delegación firmados · sistema de reportes funcionando · uno a uno con cada persona · programa de mantenimiento en marcha · primeras métricas fiables
Mes 3	Exigir y medir	Decisiones estratégicas cerradas · protocolo cumpliéndose sin recordatorios · delegación en niveles superiores · primera auditoría trimestral completa

Regla de secuencia

Primero estabilizar, después ordenar, después delegar y solo entonces exigir.

Exigir antes de haber formado y delegado produce el efecto contrario: el equipo se cierra y deja de contar lo que pasa.

A

Anexos

Plantillas de reporte, checklists imprimibles y calendario de implantación.

Anexo 1 · Plantilla de cierre diario del Director

CIERRE DIARIO

Fecha: ____ / ____ / ____

Pacientes atendidos: _____

Primeras visitas / convertidas: _____ / _____

Producción del día (€): _____

Cobros del día (€): _____

Caja cuadrada: ☐ Sí ☐ No (incidencia)

Documentación 100 % subida: ☐ Sí ☐ No

Cirugías de mañana verificadas: ☐ Sí ☐ No

Incidencias: _____

Semáforo del día: ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo

Anexo 2 · Cadencia de reportes

CUÁNDO	QUÉ	QUIÉN
Cada día, al cierre	Caja, agenda de mañana, ausencias, cirugías verificadas → cierre del Director	Todos → Director → Gerencia
Lunes	Consolidación semanal: producción, conversión, producto pendiente, stock, laboratorio, mantenimiento, reseñas	Director
Primer lunes de mes	Informe mensual de resultados, evolución de producto pendiente, origen de pacientes, equipo, reactivación	Director → Gerencia

Anexo 3 · Checklist de implantación para Gerencia

- ☐ Cerrar las **cinco verificaciones** de las 72 horas previas
- ☐ Preparar los **cuatro documentos** de arranque
- ☐ Clasificar y contactar a todos los **pacientes rojos**
- ☐ Nombrar los **sustitutos** de cada puesto
- ☐ Asignar los **responsables funcionales** transversales
- ☐ Ajustar el **alcance del higienista** a su titulación y normativa
- ☐ Confirmar los **puntos abiertos** (Smartee/Spark, recordatorios, kit de bienvenida)
- ☐ Comunicar a cada persona su **manual de puesto** y recabar acuse de recibo
- ☐ Aprobar el **sistema de reportes** y las plantillas

☐ Fijar la **frecuencia de las evaluaciones** formales

Anexo 4 · Checklist imprimible de la Primera Visita AMPLIACIÓN

Una hoja por visita. Si queda una casilla sin marcar, la PV no está cerrada.

FASES 1 A 7

- ☐ **F1** · Cinco ejes clasificados y duplicado verificado

- ☐ **F1** · Cuestionario previo enviado

- ☐ **F2** · Paciente en Sala VIP y tour completado

- ☐ **F3** · RGPD explicado y firmado

- ☐ **F3** · Email verificado letra por letra

- ☐ **F3** · Alta en Clinic Cloud completa

- ☐ **F4** · Anamnesis médica y dental completas

- ☐ **F4** · Consentimiento radiológico con comprensión verificada

- ☐ **F5** · Cuatro pruebas cargadas, etiquetadas y verificadas

- ☐ **F6** · Briefing realizado y plan único acordado

- ☐ **F7** · Cuatro dimensiones de expectativas registradas

- ☐ **F7** · Capturas de cámara intraoral cargadas

FASES 8 A 12

- ☐ **F8** · IAC dictado, revisado y firmado

- ☐ **F8** · Solicitud de presupuesto firmada

- ☐ **F8** · Entregado a Recepción en menos de 10 min

- ☐ **F9** · Checklist de material verificado al 100 %

- ☐ **F9** · Paciente capaz de repetir su diagnóstico

- ☐ **F10** · Presupuesto desglosado y tres escenarios presentados

- ☐ **F10** · Estado de conversión y razón registrados

- ☐ **F11** · Ocho documentos escaneados el mismo día

- ☐ **F11** · RAC avisado si hay aceptación

- ☐ **F11** · Carpeta entregada completa
- ☐ **F12** · Llamada de cortesía programada
- ☐ **F12** · Tarea de re-contacto según objeción

Anexo 5 · Checklists de apertura y cierre por puesto AMPLIACIÓN

APERTURA

- ☐ **REC** · sistemas, agenda del día, casos rojos, sala VIP, documentación del día anterior a cero
- ☐ **AUX** · equipos, purga de líneas, autoclave, gabinetes, material de las cirugías del día
- ☐ **DR** · historiales revisados la tarde anterior, casos complejos marcados
- ☐ **RAC** · cirugías del día verificadas, nada ha cambiado
- ☐ **HIG** · agenda de mantenimientos, historiales, gabinete
- ☐ **DC** · briefing de apertura de 5 minutos con el equipo

CIERRE

- ☐ **REC** · arqueo, documentación 100 %, agenda de mañana, reporte
- ☐ **AUX** · instrumental, residuos, apagado, material de mañana verificado
- ☐ **DR** · todo registrado, planificaciones digitales, preparación del día siguiente
- ☐ **RAC** · cirugías de mañana verificadas, panel actualizado, reporte
- ☐ **HIG** · registros completos, derivaciones comunicadas
- ☐ **DC** · panel diario cerrado y elevado a Gerencia

Anexo 6 · Calendario de implantación AMPLIACIÓN

MOMENTO	HITO	RESPONSABLE
Semana 0	Entrega del manual a cada persona y acuse de recibo	Dirección
Semana 1	Formación por puesto: manual de la Parte IV y fases propias de la Parte II	Dirección + responsables
Semana 2	Arranque de checklists de apertura y cierre; documentación el mismo día	Todos
Semana 3	Puesta en marcha del panel de producto pendiente y de la doble verificación	RAC

MOMENTO	HITO	RESPONSABLE
Semana 4	Primer panel semanal completo con todos los indicadores	Dirección
Mes 2	Programa de mantenimiento activo y perfiles de riesgo registrados	Higienista + Doctor
Mes 3	Primera auditoría trimestral y primera liquidación del plan de incentivos	Dirección + Gerencia
Mes 6	Revisión semestral del manual y cierre de puntos abiertos	Dirección de Centros

Anexo 7 · Mapa maestro de documentos

AMPLIACIÓN

Lista única de la documentación que genera un paciente, con quién la produce, quién la firma y cuándo se digitaliza. Unifica lo que la Fase 11 y la Función 1.3 enumeran por separado.

DOCUMENTO	FASE	LO PRODUCE	LO FIRMA	DIGITALIZACIÓN
Hoja de datos personales	3	Director	Paciente	Mismo día
Consentimiento RGPD	3	Director	Paciente	Mismo día
Consentimiento de imágenes	3	Director	Paciente	Mismo día
Anamnesis médica y dental	4	Doctor	Doctor y paciente	Mismo día
Consentimiento radiológico	4	Doctor	Paciente	Mismo día
Informe de Análisis Clínico	8	Director redacta	Doctor	Mismo día
Solicitud de presupuesto	8	Doctor	Doctor	Mismo día
Informe de ortodoncia	8	Doctor	Doctor	Si aplica
Presupuesto	10	Director	Paciente al aceptar	Mismo día
Documentación de financiación	11	Entidad	Paciente	Según entidad
Consentimiento quirúrgico	13	Doctor	Paciente	Antes de la cirugía
Checklist quirúrgico	13	Doctor y Auxiliar	Equipo	Mismo día
Registro de trazabilidad de implantes	13	Doctor	Doctor	Mismo día
Instrucciones postoperatorias	13	Doctor	Entregadas al paciente	Copia en ficha
Registro de mantenimiento	14	Higienista	—	En el momento
Perfil Alma anual	14	Higienista y Doctor	Doctor valida	Al entregarlo

Anexo 8 · Ficha de auditoría trimestral AMPLIACIÓN

Cien puntos. Por debajo de 80 se abre plan de refuerzo con el equipo del centro.

Es también la evidencia del bloque A (gate de calidad) del plan de incentivos.

CRITERIO	QUÉ SE COMPRUEBA	PESO
Documentación	Lista maestra completa y subida el mismo día	20
Consentimientos	Verificación de comprensión registrada en cada uno	15
Trazabilidad de implantes	Lote, referencia y posición en todos los casos	15
Esterilización	Registros de ciclo y controles completos	15
Diagnóstico	Perfiles de riesgo registrados y diagnósticos integrales	10
Producción	Panel de producto pendiente actualizado y sin casos > 6 meses	10
Conversión	Estado, importes y razón de no conversión en todas las PV	10
Experiencia	Briefings, tours y llamadas de cortesía registrados	5

Interpretación

- 90 – 100 Ejecución de referencia; sirve como material de formación
- 80 – 89 Correcta, con observaciones puntuales
- 60 – 79 Plan de refuerzo y nueva auditoría en treinta días
- < 60 Revisión del circuito con Dirección de Centros

Cómo se audita

- Muestra mínima: cinco PV y cinco casos quirúrgicos por trimestre
- Se audita la ficha, no la memoria de quien atendió
- Los hallazgos se comparten con el equipo completo, sin señalar personas
- Un hallazgo repetido dos trimestres genera acción formativa obligatoria

Anexo 9 · Guion de las reuniones AMPLIACIÓN

BRIEFING DE APERTURA · 5 min · diario

1. Pacientes complejos o delicados del día
2. Cirugías y necesidades especiales
3. Ausencias o cambios en el equipo
4. Incidencias pendientes del día anterior
5. «¿Alguien necesita algo?»

PUNTO DE CONTROL DE MEDIODÍA · 5 min · diario

Ausencias · huecos por cubrir · documentación pendiente · confirmaciones en marcha

CIERRE DE JORNADA · 10 min · diario

Documentación 100 % · caja · cirugías de mañana verificadas · incidencias

COORDINACIÓN SEMANAL · 15 min

Producción · conversión · producto pendiente · stock · laboratorio · adherencia

COMITÉ MENSUAL · 45 min

Indicadores de ejecución primero, de resultado después · auditoría de fichas · origen de pacientes y coste por paciente convertido · decisiones, que se versionan

Anexo 10 · Glosario de términos AMPLIACIÓN

PV

Primera Visita: el circuito de las fases 2 a 11, con una duración real de 115 a 120 minutos según el caso.

IAC

Informe de Análisis Clínico: documento firmado por el Doctor con hallazgos, diagnóstico y plan.

Solicitud de presupuesto

Documento firmado por el Doctor que autoriza a presupuestar. Sin él no hay presupuesto.

Producto pendiente

Valor de todo lo aceptado y pagado que aún no se ha ejecutado. Indicador rector de RAC.

Doble verificación

Comprobación de pago y de material antes de agendar una cirugía. Otorga poder de bloqueo a RAC.

Gate de calidad

Umbral del bloque A del plan de incentivos: si no se cumple, no hay bonus ese trimestre.

CBCT Tomografía computarizada de haz cónico: estudio tridimensional con dosis reducida.
OPG Ortopantomografía: radiografía panorámica digital de ambos maxilares.
IOS Escaneado intraoral: modelo digital de las arcadas y de la oclusión.
Guía quirúrgica Férula diseñada sobre la planificación digital que traslada la posición prevista a la cirugía.
Carga inmediata Colocación de la prótesis provisional en el mismo acto quirúrgico, cuando el caso lo permite.
Perfil de riesgo Clasificación periodontal, de caries, biomecánica y periimplantaria que fija la periodicidad del mantenimiento.
Perfil Alma anual Informe predictivo que se entrega presencialmente a cada miembro del programa de mantenimiento.
RACI Reparto de papeles por fase: responsable, accountable, consultado e informado.
Triage Clasificación telefónica por urgencia. Condiciona el hueco, nunca el orden interno del protocolo.
Clinic Cloud Sistema central del centro. Si algo no está aquí, no ha ocurrido.

Anexo 11 · Checklists consolidados del sistema

COMPENDIO MAESTRO

Los nueve checklists del sistema, reunidos. Los cinco primeros ya están desarrollados en sus fases y puestos; los cuatro últimos se incorporan aquí.

APERTURA DIARIA · AUXILIAR Y RECEPCIÓN

☐ **Alarma** desconectada e incidencias visibles revisadas

☐ **Iluminación y climatización**

- ☐ **Equipos informáticos** y acceso al sistema
- ☐ **Equipos clínicos:** CBCT, OPG, escáner, sillones
- ☐ **Compresor y aspiración**, con purga de condensados
- ☐ **Purga de líneas de agua** de cada gabinete
- ☐ **Autoclave** y test de funcionamiento
- ☐ **Agenda revisada** con los casos delicados identificados
- ☐ **Orden de zonas** y material de consumo repuesto

CIERRE DIARIO · RECEPCIÓN Y DIRECTOR

- ☐ **Documentación 100 % subida**
- ☐ **Agenda de mañana** revisada
- ☐ **Caja arqueada**
- ☐ **Desinfección de superficies**
- ☐ **Instrumental gestionado** y residuos retirados
- ☐ **Equipos apagados**
- ☐ **Sin material ni documentación a la vista**
- ☐ **Climatización y accesos** cerrados
- ☐ **Alarma conectada**

RIESGO TRIMESTRAL · DIRECTOR

- ☐ **Autorización sanitaria** vigente
- ☐ **Director técnico** designado
- ☐ **Seguro de responsabilidad civil** al día
- ☐ **Titulaciones** archivadas
- ☐ **Contratos y registro horario**
- ☐ **Documentación RGPD**
- ☐ **Contrato de residuos**
- ☐ **Mantenimientos** de equipos al día

- ☐ **Protección radiológica**
- ☐ **Formación en prevención**
- ☐ **Hojas de reclamaciones** disponibles
- ☐ **Registros de esterilización** completos

LANZAMIENTO DE LÍNEA AVANZADA · GERENCIA

- ☐ **Verificación regulatoria** cerrada
- ☐ **Seguro específico** de la línea
- ☐ **Competencia acreditada** del profesional
- ☐ **Equipamiento verificado**
- ☐ **Protocolo clínico** firmado
- ☐ **Consentimiento específico**
- ☐ **Protocolo de emergencia** y simulacro documentado
- ☐ **Equipo formado** y checklists creados
- ☐ **Circuito y plan de mantenimiento** definidos
- ☐ **Indicadores, proveedores y viabilidad** económica
- ☐ **Precios aprobados** y comunicación revisada
- ☐ **Autorización expresa de Gerencia**

REBRANDING · DIRECTOR

- ☐ **Google Business renombrado**, nunca creado de nuevo: se perderían todas las reseñas
- ☐ **Dominio anterior redirigido**
- ☐ **Redes renombradas** conservando el histórico
- ☐ **Cartelería** del centro
- ☐ **Documentación y facturas** con la nueva denominación
- ☐ **Firmas de email** y directorios actualizados

Anexo 12 · Sistema de reportes consolidado

COMPENDIO MAESTRO

CUÁNDO	REPORTE	RESPONSABLE	DESTINATARIO	TIEMPO
Diario	Cierre de caja	Recepción	Director	3 min
	Agenda del día siguiente	Recepción	Director	2 min
	Ausencias del día	Recepción	Director	1 min
	Cirugías de mañana verificadas	RAC	Director	3 min
	Estado de material	Auxiliar	Director y compras	2 min
	Cierre del Director	Director	Gerencia	5 min
Semanal	Producción y conversión · producto pendiente · agenda y ocupación	Director, RAC y Recepción	Gerencia	—
	Stock · laboratorio · mantenimientos · reseñas	Auxiliar, responsable de laboratorio, Higienista y responsable de redes	Director	—
Mensual	Informe de resultados · producto pendiente · origen de pacientes	Director y RAC	Gerencia	—
	Estado de equipo · reactivación · calidad y reputación · programa de implantes · compras	Director, Recepción, Higienista y compras	Gerencia	—

Anexo 13 · Cuadro de escalado de incidencias

MATRIZ DE OBLIGACIONES

Quién detecta cada incidencia, a quién se escala y qué acción correctiva corresponde.
Sin este cuadro, las incidencias se comentan de pasillo y no corrigen nada.

INCIDENCIA	DETECTADA POR	ESCALA A	ACCIÓN CORRECTIVA
Documentación no subida el mismo día	Auditoría o Dirección de Clínica	Dirección de Centros	Revisión de causa raíz
Alta en el sistema no completada antes de la presentación	Auditoría o Dirección de Clínica	Dirección de Clínica	Revisar la entrega de la anamnesis a Recepción
IAC con discrepancias clínicas	Auditoría	Dirección de Centros y Doctor	Corrección formal del informe
Presupuesto elaborado sin solicitud firmada	Auditoría	Dirección de Centros	Recordatorio del circuito a Dirección de Clínica
RAC no avisada tras una aceptación	Auditoría o RAC	Dirección de Clínica	Aviso inmediato y revisión del traspaso
Cirugía agendada sin pago confirmado	Auditoría o RAC	Dirección de Centros	Revisión inmediata del caso

INCIDENCIA	DETECTADA POR	ESCALA A	ACCIÓN CORRECTIVA
Cirugía cancelada por falta de material	Auditoría, RAC o Auxiliar	Dirección de Centros	Revisión del circuito de verificación de material
Producto pendiente creciendo	Panel de producto pendiente	Dirección de Centros	Auditoría del circuito de producción



Otros documentos del sistema

Los catorce documentos que rodean a este manual, desde el posicionamiento que lo ordena todo hasta el programa de cuidado ATC. Se desarrollan en su [propio documento](#), del mismo rango que este; aquí queda el índice y lo que cada uno aporta.

Dónde está ahora este apartado

Los catorce documentos que rodean a este manual se desarrollan en un documento propio, con el mismo rango que este y que el Protocolo de Primera Visita:

Otros documentos del sistema . Nada se ha eliminado; al contrario, allí cada documento está desarrollado por extenso. Aquí queda el índice y los enlaces directos a cada uno.

#	DOCUMENTO	QUÉ APORTA	CUÁNDO SE USA
1	Compendio Maestro del Sistema de Gestión	Ordena y conecta toda la documentación en cuatro niveles, con seis consolidados: decisiones, checklists, indicadores, reportes, calendario y resúmenes	Al empezar y para localizar cualquier cosa
2	Protocolo Maestro de Verificación · 322 puntos	Recorrido físico por doce zonas más verificación documental, de sistemas, de procesos, económica y de reputación	Inspección del centro
3	Auditoría Integral de la Clínica Adquirida	El día 1 hora a hora y once áreas de auditoría, una por semana	Día 1 y primeros 30 días
4	Decisiones de Gerencia y verificaciones externas	Las veinte decisiones con su plazo y las once verificaciones V1–V11	Semana 1, primer mes y primer trimestre
5	Programa de Integración · Plan Director de 100 días	Gobernanza, seis flujos de trabajo, tres puertas de paso, registro de riesgos y cuadro de mando del programa	Del día 1 al día 100
6	Dossier de Ejecución · primeros 30 días	Cuatro semanas con guiones de llamada, plantillas de decisión, los cinco números y el panel del día 30	Impreso, semana a semana
7	Protocolos Operativos por Perfil	Parte asistencial y parte comercial de los seis puestos, con checklists, derivaciones y reportes diarios	Formación y trabajo diario
8	Innovación Aplicada al Protocolo · 18 fichas	Fichas de implantación con protocolo, guion, contingencia e indicador, curva de adopción y calendario trimestral	Una innovación por trimestre
9	Plan Director de Marca y Captación	Naming y arquitectura de marca, siete segmentos con sus embudos, AEO, automatización y economía unitaria	A partir del día 30
10	Cuaderno de Campo · Día 1	Página de emergencia, cronograma hora a hora, siete guiones de conversaciones difíciles, hojas de registro y semáforo del día	El día 1, impreso
11	Puesta en marcha · operativa por perfil	Qué hace cada puesto durante la transición, con la casuística del día 1 y la tabla de decisión rápida	Día 1 y primera semana
12	Continuidad legal, financiera y de sistemas	Qué se transmite y qué no, huecos de cobertura, producto pendiente heredado, comunicación institucional y plan de cuatro semanas	Del día 1 al primer mes
13	«No medias sonrisas» · posicionamiento y objetivo	El manifiesto, el objetivo de referencia mundial, los cinco pilares, qué significa para cada puesto y en cada fase, y cómo se comunica	Siempre: ordena todo lo demás

#	DOCUMENTO	QUÉ APORTA	CUÁNDO SE USA
14	ATC · Alma Te Cuida	El programa de cuidado anual: qué incluye, los cuatro argumentos, el speech por situación, objeciones, campaña, medición y marco legal	En cada visita, como parte del cierre

Qué de todo eso está ya dentro de este manual

Lo que completaba una parte de este manual se incorporó a esa parte, con la etiqueta de su documento de origen.

La tabla de descuentos en la [Fase 10](#), el diseño del programa de mantenimiento en la [Fase 14](#), las once verificaciones externas y el calendario integral en la [Parte VIII](#), los checklists consolidados y el sistema de reportes en los [Anexos](#), y los indicadores del centro en la [Parte VI](#).

PUNTOS ABIERTOS

Lo que todavía no está cerrado

Lo que este manual no puede resolver por sí solo, con quién depende de ello y cómo se opera mientras tanto. **Un punto abierto declarado es una decisión pendiente; un punto abierto callado es un error esperando.**

Puntos que siguen abiertos

PUNTO	ESTADO	CÓMO SE OPERA MIENTRAS TANTO
Software de ortodoncia: Smartee o Spark Approver DECISIÓN 13	 PENDIENTE	Se usa la herramienta con la que se planificó cada caso y se anota cuál en el IAC
Contenido del Kit de Bienvenida DECISIÓN 10	 PENDIENTE	Se entrega como mínimo guía del tratamiento, kit de higiene y tarjeta de contacto directo
Alcance competencial del Higienista DECISIÓN 9	 PENDIENTE	Lo determina la titulación y la normativa; el protocolo organiza la función y no amplía competencias
Sustitutos de cada puesto DECISIÓN 11	 PENDIENTE	Solo cubre una fase quien esté certificado en ella; si no hay nadie, se reprograma la visita
Responsables funcionales con nombre DECISIÓN 12	 PENDIENTE	Compras, laboratorio, reseñas y reactivación operan por asignación provisional de Dirección
Marcas de implante y tasas de éxito comunicables	 PENDIENTE	Solo se mencionan las que consten en la ficha de datos verificables de Dirección; ninguna cifra se improvisa
Decisiones 1 a 4, 6 y 14 a 20 GERENCIA	 PENDIENTE	Horarios, apertura y cierre, caja, efectivo, urgencias fuera de horario y las siete estratégicas. Ver Otros · Decisiones de Gerencia



Manual Maestro de Operaciones

Centro de Excelencia Implantológica Alma · Calle Progreso 2 · Ourense

Documento único troncal. Uso interno y confidencial. Contiene criterios de actuación clínica y de gestión; no sustituye el juicio profesional del Doctor ante un caso concreto ni amplía las competencias de ningún perfil.

Ver el protocolo de Primera Visita

Versión

v32.0 · Agosto 2026

Revisión semestral

Contenido

8 partes + estándares transversales + otros

14 fases · 6 puestos · 1 función transversal

26 procedimientos · 12 anexos · 6 diagramas

Vista operativa · Uso interno

Qué se espera de cada puesto

Todo lo que el sistema dice de un puesto vivía repartido en cuatro documentos: su manual en el Manual Maestro, su papel en la matriz RACI, sus fases en el Protocolo de Primera Visita y sus protocolos operativos en Otros documentos. Quien llega un lunes a trabajar no debería recorrer cuatro documentos para saber qué se espera de él.

Elija el puesto y aparece en un solo sitio: en qué fases interviene y con qué papel, qué procedimientos tiene escritos, qué funciones de vanguardia le tocan, con qué se le mide y qué se espera de él los primeros treinta días. Cada línea lleva al documento donde está el detalle, que sigue siendo el que manda: **esta página señala, no sustituye**.

LOS SEIS PUESTOS

Elija el suyo

La matriz RACI reparte las catorce fases del recorrido entre seis puestos. R ejecuta, A responde del resultado, C se consulta antes de decidir y I se informa después. Una fase sin A es una fase de la que no responde nadie.

Dirección de Clínica

Dirige la clínica y responde de que el sistema se cumpla. Es la única figura que puede autorizar una excepción, y la que rinde cuentas cuando algo se salta.

9

fases en las que interviene

6

bloques de su manual de puesto

0

funciones de vanguardia

Su papel en las catorce fases del recorrido

Sale de la matriz RACI del Manual Maestro. Las fases 1 a 12 llevan al Protocolo de Primera Visita, donde están contadas minuto a minuto.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
1. Preparación previa	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
2. Recepción y tour	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
3. Anamnesis/RGPD y alta	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
4. Historial y consentimiento	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
5. Pruebas diagnósticas	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
6. Briefing	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
7. Anamnesis de expectativas	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
8. IAC / solicitud / informe	Ejecuta	Hace el trabajo de esa fase.
9. Presentación	Ejecuta	Hace el trabajo de esa fase.
10. Propuesta y cierre	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
11. Cierre administrativo	Responde	Rinde cuentas del resultado, lo haya ejecutado o no.
12. Seguimiento	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
13. Circuito de producción	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.
14. Mantenimiento	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.

Su manual de puesto

[Autoridad y sus límites →](#)

[Procedimientos →](#)

[Indicadores del puesto →](#)

[Contingencias →](#)

[Criterios de calidad →](#)

[Primeros 30 días en el puesto →](#)

Sus funciones de vanguardia

Este puesto no tiene funciones de vanguardia propias: las suyas son de gobierno del sistema y están en su manual.

Dónde está todo lo suyo

[Manual del puesto, completo →](#)

[La matriz RACI de las catorce fases →](#)

[El Protocolo de Primera Visita, fase a fase →](#)

[Protocolos operativos por perfil →](#)

[Puesta en marcha por perfil →](#)

Doctor

Diagnostica, planifica y ejecuta el tratamiento. Responde del criterio clínico y de que el paciente entienda su caso antes de decidir.

9

fases en las que interviene

8

bloques de su manual de puesto

6

funciones de vanguardia

Su papel en las catorce fases del recorrido

Sale de la matriz RACI del Manual Maestro. Las fases 1 a 12 llevan al Protocolo de Primera Visita, donde están contadas minuto a minuto.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
1. Preparación previa	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
2. Recepción y tour	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
3. Anamnesis/RGPD y alta	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
4. Historial y consentimiento	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
5. Pruebas diagnósticas	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.
6. Briefing	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
7. Anamnesis de expectativas	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
8. IAC / solicitud / informe	Responde	Rinde cuentas del resultado, lo haya ejecutado o no.
9. Presentación	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
10. Propuesta y cierre	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.
11. Cierre administrativo	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
12. Seguimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
13. Circuito de producción	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
14. Mantenimiento	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.

Su manual de puesto

Cronograma de jornada →

Procedimientos →

Errores documentados →

Su papel comercial y sus límites →

Indicadores del puesto →

Contingencias →

Criterios de calidad →

Primeros 30 días en el puesto →

Sus funciones de vanguardia

2.1 · Preparación anticipada del caso →

2.2 · Diagnóstico integral y predictivo →

2.3 · Planificación digital del tratamiento →

2.4 · Consentimiento informado real →

2.5 · Ejecución clínica →

2.6 · Registro y trazabilidad →

Dónde está todo lo suyo

Manual del puesto, completo →

La matriz RACI de las catorce fases →

El Protocolo de Primera Visita, fase a fase →

Protocolos operativos por perfil →

Puesta en marcha por perfil →

Recepción

La primera voz y la última. Gestiona la demanda, la agenda, el alta y el cierre administrativo, y es quien recupera al paciente que no vuelve.

6

fases en las que interviene

7

bloques de su manual de puesto

5

funciones de vanguardia

Su papel en las catorce fases del recorrido

Sale de la matriz RACI del Manual Maestro. Las fases 1 a 12 llevan al Protocolo de Primera Visita, donde están contadas minuto a minuto.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
1. Preparación previa	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
2. Recepción y tour	Ejecuta	Hace el trabajo de esa fase.
3. Anamnesis/RGPD y alta	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
4. Historial y consentimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
5. Pruebas diagnósticas	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
6. Briefing	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
7. Anamnesis de expectativas	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
8. IAC / solicitud / informe	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
9. Presentación	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
10. Propuesta y cierre	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
11. Cierre administrativo	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
12. Seguimiento	Ejecuta	Hace el trabajo de esa fase.
13. Circuito de producción	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
14. Mantenimiento	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.

Su manual de puesto

Jornada minuto a minuto →

Procedimientos →

Su papel comercial real →

Indicadores del puesto →

Contingencias →

Criterios de calidad →

Primeros 30 días en el puesto →

Sus funciones de vanguardia

1.1 · Gestión de la demanda →

1.2 · Arquitectura de agenda →

1.3 · Custodia documental →

1.4 · Gestión económica de mostrador →

1.5 · Seguimiento y recuperación →

Dónde está todo lo suyo

Manual del puesto, completo →

La matriz RACI de las catorce fases →

El Protocolo de Primera Visita, fase a fase →

Protocolos operativos por perfil →

Puesta en marcha por perfil →

RAC · Responsable de Producción

Responde del circuito de producción: que lo aceptado se fabrique, se coloque y se cierre. Tiene poder de bloqueo cuando un caso no está listo.

1

fases en las que interviene

6

bloques de su manual de puesto

0

funciones de vanguardia

Su papel en las catorce fases del recorrido

Sale de la matriz RACI del Manual Maestro. Las fases 1 a 12 llevan al Protocolo de Primera Visita, donde están contadas minuto a minuto.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
1. Preparación previa	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
2. Recepción y tour	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
3. Anamnesis/RGPD y alta	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
4. Historial y consentimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
5. Pruebas diagnósticas	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
6. Briefing	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
7. Anamnesis de expectativas	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
8. IAC / solicitud / informe	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
9. Presentación	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
10. Propuesta y cierre	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
11. Cierre administrativo	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
12. Seguimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
13. Circuito de producción	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
14. Mantenimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.

Su manual de puesto

[Poder de bloqueo →](#)

[Procedimientos →](#)

[Indicadores del puesto →](#)

[Contingencias →](#)

[Criterios de calidad →](#)

[Primeros 30 días en el puesto →](#)

Sus funciones de vanguardia

Este puesto no tiene funciones de vanguardia propias: las suyas son de gobierno del sistema y están en su manual.

Dónde está todo lo suyo

[Manual del puesto, completo →](#)

[La matriz RACI de las catorce fases →](#)

[El Protocolo de Primera Visita, fase a fase →](#)

[Protocolos operativos por perfil →](#)

[Puesta en marcha por perfil →](#)

Auxiliar

Sostiene el acto clínico: equipos listos, batería diagnóstica completa y esterilización trazable. Sin esto, la fase 5 no existe.

3

fases en las que interviene

5

bloques de su manual de puesto

3

funciones de vanguardia

Su papel en las catorce fases del recorrido

Sale de la matriz RACI del Manual Maestro. Las fases 1 a 12 llevan al Protocolo de Primera Visita, donde están contadas minuto a minuto.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
1. Preparación previa	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
2. Recepción y tour	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
3. Anamnesis/RGPD y alta	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
4. Historial y consentimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
5. Pruebas diagnósticas	Ejecuta y responde	Hace el trabajo y rinde cuentas de él.
6. Briefing	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
7. Anamnesis de expectativas	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.
8. IAC / solicitud / informe	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
9. Presentación	Se informa	Recibe el resultado; no decide ni ejecuta.
10. Propuesta y cierre	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
11. Cierre administrativo	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
12. Seguimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
13. Circuito de producción	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.
14. Mantenimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.

Su manual de puesto

Procedimientos →

Indicadores del puesto →

Contingencias →

Criterios de calidad →

Primeros 30 días en el puesto →

Sus funciones de vanguardia

4.1 · Gestión de equipos →

4.2 · Batería diagnóstica →

4.3 · Esterilización y bioseguridad →

Dónde está todo lo suyo

Manual del puesto, completo →

La matriz RACI de las catorce fases →

El Protocolo de Primera Visita, fase a fase →

Protocolos operativos por perfil →

Puesta en marcha por perfil →

Higienista

El puesto del largo plazo: mantiene lo tratado, detecta pronto lo que se tuerce y sostiene la relación año tras año.
Es R/A en la fase 14.

1

fases en las que interviene

6

bloques de su manual de puesto

4

funciones de vanguardia

Su papel en las catorce fases del recorrido

Sale de la matriz RACI del Manual Maestro. Las fases 1 a 12 llevan al Protocolo de Primera Visita, donde están contadas minuto a minuto.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
1. Preparación previa	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
2. Recepción y tour	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
3. Anamnesis/RGPD y alta	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
4. Historial y consentimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
5. Pruebas diagnósticas	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
6. Briefing	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
7. Anamnesis de expectativas	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
8. IAC / solicitud / informe	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
9. Presentación	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.

FASE	SU PAPEL	QUÉ SIGNIFICA
10. Propuesta y cierre	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
11. Cierre administrativo	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
12. Seguimiento	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
13. Circuito de producción	No interviene	Esa fase no pasa por sus manos.
14. Mantenimiento	Se consulta	Su criterio se pide antes de decidir, no después.

Su manual de puesto

Por qué este puesto es estratégico →

Procedimientos →

Indicadores del puesto →

Contingencias →

Criterios de calidad →

Primeros 30 días en el puesto →

Sus funciones de vanguardia

3.1 · Programa de mantenimiento →

3.2 · Detección precoz y derivación →

3.3 · Monitorización remota →

3.4 · El perfil Alma anual →

Dónde está todo lo suyo

Manual del puesto, completo →

La matriz RACI de las catorce fases →

El Protocolo de Primera Visita, fase a fase →

Protocolos operativos por perfil →

Puesta en marcha por perfil →

COMÚN A LOS SEIS

Lo que se cumple en todos los puestos

Estándares transversales

Comunicación y trato, seguridad clínica, protección de datos, entorno físico y agenda. Se cumplen en las catorce fases y en los seis puestos.

[Ver los estándares transversales →](#)

Cómo se mide si funciona

Cada puesto tiene sus indicadores, y el centro tiene los diez del cuadro de mando. Sin serie propia, cualquier objetivo es una opinión.

[Indicadores e interdependencias →](#)

[Los números del centro, mes a mes →](#)

Qué pasa si un puesto no cumple

La matriz de obligaciones dice qué se rompe aguas abajo cuando un puesto se salta lo suyo. No es una amenaza: es la razón por la que el orden importa.

[Ver la matriz de obligaciones →](#)

Cómo se aprende y se certifica

Incorporación en los primeros treinta días, certificación por rol y rúbrica de auditoría de una primera visita real.

[Formación y certificación por rol →](#)

[Rúbrica de auditoría de una Primera Visita →](#)



Centro de Excelencia Implantológica Alma

Protocolos por puesto · Uso interno y confidencial

De dónde sale

Manual Maestro · matriz RACI

Protocolo de Primera Visita

Otros documentos del sistema

Versión

Versión única del sistema

v32.0 · Septiembre 2026

DOCUMENTO OPERATIVO INTERNO · VERSIÓN 32.0 · AGOSTO 2026

Protocolo de Experiencia Clínica

Primera Visita

Doce de las catorce fases del recorrido, coreografiadas para que el paciente reciba, en una sola visita, el diagnóstico más preciso que la tecnología permite y la certeza de estar en el sitio correcto.

Este protocolo desarrolla en detalle las fases presenciales de la Primera Visita. El documento troncal del centro es el **Manual Maestro de Operaciones**, que cubre las catorce fases del recorrido, los manuales de puesto, los indicadores y la puesta en marcha.

Este protocolo es el estándar de ejecución de la Primera Visita (PV) en Centro de Excelencia Implantológica Alma. Define **quién** hace cada cosa, **cuándo**, **con qué palabras** y **qué queda registrado** en Clinic Cloud. No es una guía orientativa: es el mínimo exigible. Cualquier desviación debe justificarse en la ficha del paciente.

DURACIÓN REAL 115–120' Fases 2 a 11, según la complejidad del caso a valorar	FASES 12 de 14 Fases 1 a 12 del recorrido; las 13 y 14 van en el Manual Maestro
ROLES IMPLICADOS 4 Recepción · Director · Doctor · Auxiliar	DOCUMENTOS FIRMADOS 9 De la primera visita, digitalizados en Clinic Cloud el mismo día
ESTÁNDARES TRANSVERSALES 5 Comunicación, entorno, seguridad, datos y agenda	ANEXOS 8 Guiones, preguntas frecuentes, checklist, gobernanza y escalado



01 FUNDAMENTOS

Cinco principios que sostienen las doce fases de la primera visita

Si alguna vez el protocolo entra en conflicto con la realidad de una visita concreta, estos principios deciden. Son el criterio al que apelar cuando el guion no cubre la situación.

PRINCIPIO 00 · EL POSICIONAMIENTO QUE ESTÁ POR ENCIMA DE LOS CINCO

POSICIONAMIENTO

«No medias sonrisas.»

Una media sonrisa es un tratamiento a medias, una solución provisional que se eterniza, un paciente al que se le resuelve solo una parte del problema. Si algo deja al paciente a medias, no es la manera Alma de hacer las cosas. En una Primera Visita eso significa: se diagnostica la boca completa aunque venga por una pieza, se presenta el plan definitivo aunque se ejecute por etapas, y no se vende un tratamiento parcial sabiendo que el paciente necesita más sin explicárselo. El desarrollo completo está en Otros · «No medias sonrisas».

PRINCIPIO 01

El diagnóstico manda

Ninguna propuesta económica existe antes que un diagnóstico completo, validado y firmado. La secuencia —pruebas, exploración, informe, presentación, presupuesto— no se altera ni se comprime.

PRINCIPIO 02

Lo que no está en Clinic Cloud, no ha ocurrido

Cada fase termina con un registro. La trazabilidad clínica y legal se construye durante la visita, no al final del día ni la semana siguiente.

PRINCIPIO 03

El paciente entiende lo que ve

La imagen intraoral, el CBCT y la fotografía sustituyen a la explicación abstracta. Mostrar siempre antes que argumentar; la evidencia visual es el lenguaje común.

PRINCIPIO 04

Una sola voz

Doctor y Director acuerdan diagnóstico, plan y enfoque *antes* de sentarse con el paciente. El paciente nunca percibe duda, contradicción ni improvisación entre profesionales.

PRINCIPIO 05

Cierre honesto

Se guía la decisión, no se presiona. Riesgos, alternativas y limitaciones se dicen en voz alta. Un «no» bien atendido hoy es una conversión posible mañana; un «sí» forzado es una reclamación futura.

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Siete capas por fase

Acciones en orden · **cronología** minuto a minuto · **qué percibe el paciente** · **qué decir y qué evitar** · **casos especiales** · **registro obligatorio** en Clinic Cloud · **criterio de salida**, la condición sin la cual no se avanza.

DURACIÓN REAL DE LA VISITA

La suma real de las fases presenciales (2 a 11) es de **115 a 120 minutos**, y esa es la cifra que se publica: la horquilla depende de la complejidad del caso a valorar. Un caso de una sola pieza y otro de rehabilitación completa no ocupan lo mismo en la Fase 7, ni en la 9, ni en la 10.

Al paciente se le comunica esa horquilla —«entre dos horas y dos horas y cuarto»— y nunca una cifra cerrada. La Fase 1 es previa a la visita y la 12 es posterior, así que no computan. La agenda reserva el bloque por el extremo alto, no por el bajo: es preferible terminar antes que hacer esperar al siguiente paciente.

02 MAPA DE LA VISITA

Los 115 a 120 minutos, a escala

Cada bloque es una fase, proporcional a su duración nominal, coloreada por el rol que la lidera. Filtra por rol para leer el protocolo desde tu puesto: verás únicamente las fases en las que tienes responsabilidad directa.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR FASE
La Fase 01 ocurre antes de la visita y se representa fuera de escala. Los 115 a 120´ corresponden a las diez fases presenciales de la primera visita (2 a 11).

Matriz de responsabilidad

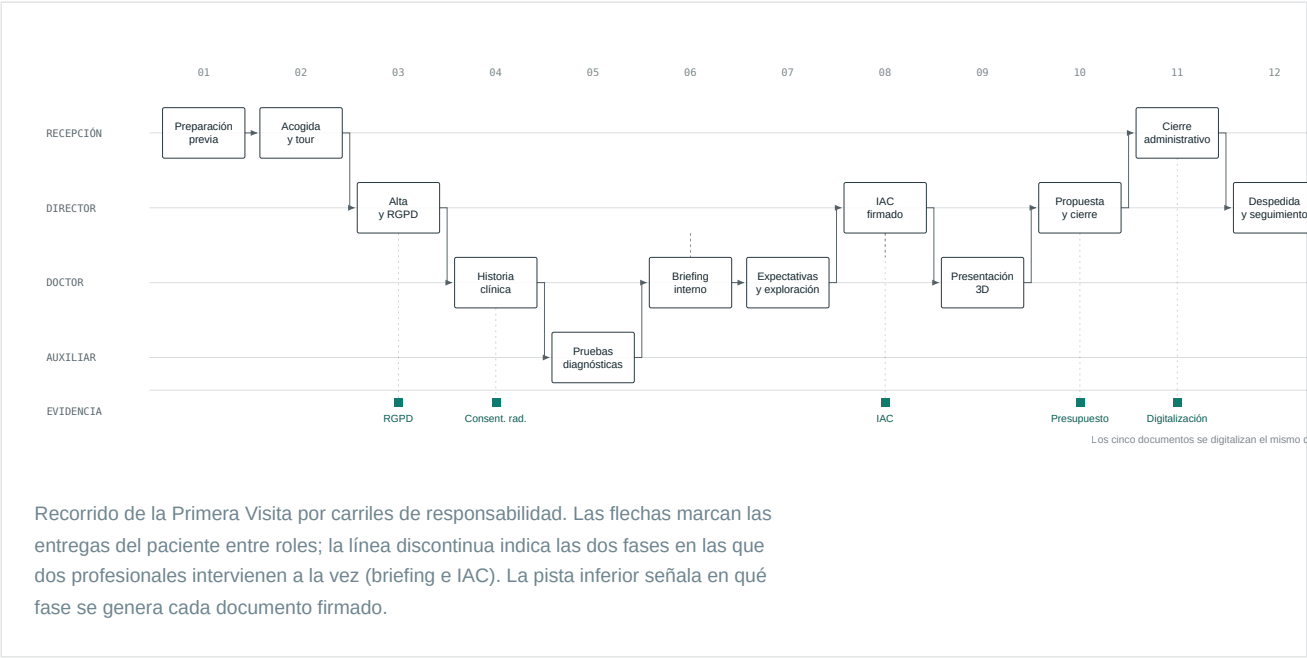
FASE	TÍTULO	LIDERA	APOYA	TIEMPO	REGISTRO QUE CIERRA LA FASE
01	Preparación previa	Recepción	—	Pre-visita	Agenda de PV cumplimentada + verificación de duplicados
02	Acogida, Sala VIP y tour	Recepción	Director	5´	Hora de llegada real en Clinic Cloud
03	Datos personales, RGPD y alta	Director	Recepción	15´	Ficha completa + RGPD firmado + email verificado
04	Historia clínica y consentimiento radiológico	Doctor	—	10´	Anamnesis en historia + consentimiento firmado
05	Pruebas diagnósticas y fotografía	Auxiliar	Doctor	15´	Imágenes cargadas, etiquetadas y verificadas
06	Briefing Doctor–Director	Doctor	Director	5´	Plan de tratamiento óptimo acordado
07	Expectativas y exploración clínica	Doctor	Auxiliar	15´	Expectativas y hallazgos en historia + capturas intraorales
08	Informe de Análisis Clínico (IAC)	Director	Doctor (dicta y firma)	10´	IAC firmado y entregado a Recepción
09	Presentación del diagnóstico 3D	Doctor	Director	15´	Checklist de material verificado antes de proyectar
10	Propuesta económica y cierre	Director	—	20´	Estado de la PV, importes y motivo de no conversión
11	Cierre administrativo y digitalización	Recepción	Director	5–10´	Los 9 documentos escaneados el mismo día
12	Despedida y seguimiento	Director	Recepción · Marketing	2´ + post	Tarea de re-contacto con fecha y responsable
13	Circuito de producción MANUAL MAESTRO	RAC	Doctor · Auxiliar · Dirección	Post-aceptación	Doble verificación de pago y material
14	Mantenimiento y seguimiento MANUAL MAESTRO	Higienista	Doctor · Recepción	Recurrente	Próxima cita agendada antes de salir

Las fases 13 y 14 cierran el recorrido y se desarrollan en el [Manual Maestro de Operaciones](#).

03 FLUJO POR ROLES

Quién tiene al paciente en cada momento

El paciente atraviesa cuatro carriles y cambia de manos siete veces. Cada cambio es un punto de fricción posible: si nadie le presenta, si hay que repetir lo ya contado o si el siguiente profesional no viene informado, la experiencia se rompe justo ahí.



REGLA DE ENTREGA

Nadie se entrega solo

Ningún paciente recorre un pasillo sin acompañante ni entra en una sala sin que le presenten. Quien entrega dice el nombre del paciente, el motivo de consulta y qué se ha hecho ya.

REGLA DE CONTINUIDAD

No se repite ninguna pregunta

Cada rol lee en Clinic Cloud lo que registró el anterior. Preguntar dos veces lo mismo comunica desorganización con más fuerza que cualquier folleto.

REGLA DE EVIDENCIA

Cada tramo deja rastro

Los nueve documentos y las pruebas se generan dentro del circuito, no después. Al salir el paciente, la ficha debe poder leerse como el relato completo de la visita.

04 LAS DOCE FASES

Las doce fases de la primera visita, una por una

Cada fase incluye su propósito, la secuencia de acciones, la cronología interna, lo que percibe el paciente, los guiones sugeridos con su contrapartida de lo que conviene evitar, los casos especiales que obligan a adaptarla, el registro obligatorio en Clinic Cloud, los errores detectados en auditoría y el criterio de salida. Los guiones son una base sobre la que construir con naturalidad, nunca un texto para recitar.

FASE 01 / 14

01

MOMENTO

Pre-visita · llamada o mensaje entrante

RESPONSABLE

Recepción / Atención al Paciente

UBICACIÓN

Recepción

HERRAMIENTA

Clinic Cloud · Agenda de PV

KPI DE LA FASE

Origen del paciente registrado en el 98 % de las llamadas · tiempo medio de llamada a cita agendada

Preparación previa: la visita empieza en la primera llamada

El paciente decide si viene —y con qué expectativa viene— en los primeros tres minutos de conversación. Esta fase persigue dos cosas simultáneas: capturar información limpia para que el equipo trabaje sobre datos reales, y transmitir el valor diferencial de la Primera Visita antes de que el paciente cuelgue.

ACCIONES

01 Recogida de datos esenciales y preguntas de filtrado

Se obtiene la información mínima que permite preparar la visita y priorizar la agenda:

- Nombre y apellidos completos
- Teléfono móvil y correo electrónico
- Urgencia percibida del caso (dolor, inflamación, plazo personal)
- Motivo principal de consulta, con detalle y en las palabras del paciente
- «**Cómo nos conoció**»: redes sociales, recomendación, búsqueda en Google, publicidad, campaña concreta

El dato de origen no es un trámite: es la única métrica que permite saber qué inversión de marketing produce pacientes reales. Se registra con precisión, sin categorías genéricas del tipo «internet».

02 Registro en la Agenda de PV y control de duplicados

Toda la información inicial y el motivo de consulta se vuelcan en la Agenda de Primera Visita en el momento, no después. Antes de crear nada, se comprueba en Clinic Cloud que el paciente no exista ya en el sistema (búsqueda por teléfono, email y apellidos) para evitar fichas duplicadas que fragmentan el historial.

03 Comunicación del diferencial (speech de valor)

Es el momento de explicar, con seguridad y sin prisa, qué incluye la Primera Visita y por qué no es comparable con la de otro centro.

GUION SUGERIDO · RECEPCIÓN

«En el Centro de Excelencia Implantológica Alma su primera visita es completamente gratuita e incluye todas las pruebas diagnósticas avanzadas que habitualmente tienen un coste significativo: tomografía 3D de última generación (CBCT), radiografía panorámica digital, estudio fotográfico profesional completo y escaneado intraoral 3D de alta precisión. Le garantizamos el diagnóstico más preciso y completo posible, sin coste para usted, porque es la única forma honesta de proponerle un tratamiento.»

CRÍTICO · RECEPCIÓN

- Ningún dato inicial se queda «en la cabeza» ni en una nota suelta: todo va a la Agenda de PV.
- Verificar duplicados *antes* de crear cualquier registro nuevo.
- El campo «Cómo nos conoció» es obligatorio y debe ser específico.

CRONOLOGÍA DE LA LLAMADA

0:00 – 0:20 Descolgar antes del tercer tono. Saludo con nombre de la clínica y del recepcionista.	0:20 – 2:00 Escucha del motivo sin interrumpir. Anotar literalmente.	2:00 – 3:30 Preguntas de filtrado y urgencia.	3:30 – 5:00 Speech de valor de la Primera Visita.
5:00 – 6:30 Propuesta de dos huecos concretos y cierre de la cita.	6:30 – 7:00 Confirmación de datos, dirección, parking y envío del recordatorio.		

Una llamada de PV bien llevada dura entre cinco y ocho minutos. Por debajo de tres, casi siempre falta información; por encima de doce, suele haberse intentado diagnosticar por teléfono.

CANALES DE ENTRADA Y TIEMPO DE RESPUESTA

CANAL	COMPROMISO DE RESPUESTA	ACCIÓN
Llamada entrante	3 tonos	Atención directa; si se está ocupado, pedir permiso para llamar en 10 minutos y cumplirlo
Llamada perdida	15 min	Devolución de llamada; si no contesta, WhatsApp identificándose
WhatsApp	30 min en horario	Responder por escrito y proponer llamada breve para cerrar la cita
Formulario web	2 h en horario	Llamada; si no contesta, email + WhatsApp
Redes sociales	2 h en horario	Llevar la conversación a teléfono cuanto antes
Fuera de horario	Primera hora del día siguiente	Priorizar sobre el resto de la agenda de llamadas

La velocidad de respuesta es el factor que más pesa en la conversión de un contacto en visita. Un contacto atendido en menos de una hora convierte muy por encima de uno atendido al día siguiente.

QUÉ PERCIBE EL PACIENTE

- Que le atienden rápido y sin música de espera interminable
- Que quien contesta escucha y anota, en lugar de recitar
- Que la primera visita incluye mucho más de lo que esperaba
- Que no le presionan ni le piden datos de pago
- Que sale de la llamada con día, hora y qué llevar

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

DIGA

- «Cuénteme qué le ocurre, con sus palabras.»
- «La primera visita incluye tomografía 3D, panorámica, escaneado y estudio fotográfico, sin coste.»
- «El Doctor le dará un diagnóstico completo por escrito el mismo día.»
- «Tengo dos huecos: martes a las 10:00 o jueves a las 17:30. ¿Cuál le viene mejor?»
- «¿Cómo nos ha conocido? Nos ayuda mucho saberlo.»

EVITE

- «Es gratis», sin explicar qué incluye: abarata la percepción de valor.
- Dar precios de tratamientos por teléfono sin diagnóstico.
- Opinar sobre lo que le pasa: «eso suena a una infección...».
- «¿Cuándo le vendría bien?», que alarga la llamada sin cerrar nada.
- Prometer plazos, doctores concretos o resultados.

CASOS ESPECIALES

Dolor agudo

Prioridad absoluta en agenda: hueco el mismo día o el siguiente. Se registra como urgencia y se avisa al Doctor de guardia.

Solo pregunta precio

No se dan tarifas sueltas. Se explica que el precio depende del diagnóstico y que la visita que lo determina no cuesta nada.

Segunda opinión

Se acepta sin criticar al centro anterior. Se pide que traiga informes y radiografías previas si las tiene.

Recomendado por un paciente

Registrar quién le recomienda: activa el programa de referidos y se agradece a ambos.

Menor de edad

La cita se confirma con el padre, madre o tutor, que debe acudir a la visita con su documentación.

Paciente internacional

Verificar idioma de atención, documentación de identidad y fechas de estancia antes de planificar cualquier tratamiento.

REGISTRO EN CLINIC CLOUD · CAMPOS DE ESTA FASE

- ☐ Nombre y apellidos completos y correctamente escritos
- ☐ Teléfono móvil verificado repitiéndolo en voz alta
- ☐ Email, deletreado si es necesario
- ☐ Motivo de consulta, en las palabras del paciente
- ☐ Urgencia: con dolor / sin dolor / estética / revisión
- ☐ Cómo nos conoció, con canal y campaña concretos
- ☐ Quién recomienda, si procede
- ☐ Fecha y hora de la PV + recordatorio programado

TRIAJE ESTRUCTURADO DEL CONTACTO

INNOVACIÓN · FICHA 01

Hoy la cualificación del paciente depende de quién coja el teléfono y de su estado de ánimo, y el resultado es información desigual y decisiones de agenda sin criterio. Cada contacto se clasifica en cuatro ejes, siempre preguntando y nunca suponiendo.

1 · Motivo Implantología · ortodoncia · general · mantenimiento.	2 · Urgencia Vital · urgente · preferente · estándar.	3 · Perfil Caso complejo · ansiedad · infantil · estándar.	4 · Origen Canal exacto de captación.
---	--	---	--

De los cuatro ejes sale la asignación de profesional y de franja, que deja de improvisarse:

PERFIL DETECTADO	FRANJA	PROFESIONAL	DURACIÓN
Caso complejo implantológico	Mañana	Implantólogo	Ampliada
Ansiedad manifiesta	Primera hora	Con más tiempo asignado	Ampliada
Infantil	Tarde o día no lectivo	Ortodoncista	Estándar
Ortodoncia adulto	Tarde, 18-20 h	Ortodoncista	Estándar
Estándar	Según disponibilidad	Según motivo	Estándar

Formación: treinta minutos practicando con diez casos ficticios. Indicador: 100 % de contactos con los cuatro ejes clasificados. Error documentado: clasificar por costumbre en lugar de por lo que dice el paciente.

NUNCA SE MINIMIZA EL MOTIVO DE CONSULTA

PROTOSCOLOS POR PERFIL

REDUCE EL CASO

- «¿Solo una limpieza?»
- «Para eso con una revisión rápida vale»
- «¿Le pongo con el higienista directamente?»

ABRE EL CASO

- «Perfecto, en su primera visita hacemos un estudio completo»
- «Le hacemos un diagnóstico completo para ver cómo está todo»
- «Le agendamos primera visita con estudio completo»

Un paciente que llama por una limpieza puede necesitar tratamiento integral. Si se le agenda solo la higiene, nunca se le diagnostica.

Objeciones al teléfono

LO QUE DICE	RESPUESTA
«¿Cuánto cuesta un implante?»	«Depende de cada caso, y por eso la primera visita con estudio completo es gratuita: para poder darle un precio real y no una estimación al aire.»
«Solo quiero una limpieza»	«Perfecto. La primera visita incluye el estudio completo, y así el doctor valora también si necesita algo más. Sin coste.»
«Me lo tengo que pensar»	«Claro. ¿Le apunto y si acaso lo cambiamos? Así le guardo el hueco.»
«¿Es caro?»	«Le paso con el director, que le explica las opciones de pago que tenemos.»
«Me han dicho que no tengo hueso»	«Es de las cosas que más vemos aquí. Le recomiendo pedir una segunda opinión, es sin coste.»

Quince minutos de trámite administrativo en consulta restan tiempo a la conversación que genera confianza. El cuestionario los traslada al momento previo, sin convertirse nunca en un requisito para ser atendido.

Reglas de diseño

- Máximo tres minutos: más de eso reduce la tasa a la mitad
- Optimizado para móvil, que es donde se rellena
- Sin campos innecesarios: cada campo extra pierde respuestas
- Guardado automático y aviso de protección de datos visible

Qué recoge

- Identificación y contacto, con canal preferente
- Historia médica: patologías, medicación, alergias y cirugías
- Historia dental y experiencias previas
- Motivo ampliado: qué le preocupa y desde cuándo
- Recomendados: expectativas y preocupaciones

ENVÍO AL AGENDAR · RECEPCIÓN

«Perfecto, [nombre], le espero el [día] a las [hora]. Le voy a enviar ahora un cuestionario breve por WhatsApp, tres minutos. Si lo rellena antes de venir, el doctor ya habrá revisado su caso cuando llegue y aprovechamos mucho mejor la visita.»

RECORDATORIO A 48 H SI NO ESTÁ CUMPLIMENTADO

«Hola [nombre], le recordamos su cita del [día]. Si puede, rellene este cuestionario antes de venir: [enlace]. Son tres minutos y nos ayuda mucho. Si no le da tiempo, no se preocupe, lo hacemos aquí.»

La última frase es la importante: elimina la sensación de obligación y sube la tasa. Objetivo: ≥ 60 % cumplimentados antes de la cita. Si el paciente llega sin rellenarlo, se hace en consulta como siempre y nunca se le reprocha.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Anotar el motivo como «revisión» cuando el paciente ha descrito algo concreto
- Cerrar la llamada sin haber comunicado el valor de la PV: el paciente compara solo por precio
- Registrar el origen como «internet» o dejarlo vacío
- No enviar recordatorio, con el consiguiente aumento de ausencias
- Crear ficha nueva a un paciente que ya existía, partiendo su historial

CRITERIO DE SALIDA

La cita está en la agenda con motivo de consulta redactado, origen de marketing identificado y verificación de que no existe ficha previa. Si falta el origen, se pregunta antes de cerrar la llamada.

FASE 02 / 14

02

TIEMPO

5 minutos

RESPONSABLE

Recepción · Director

UBICACIÓN

Recepción → Sala VIP → Instalaciones

OBJETIVO

Primera impresión de entorno premium

KPI DE LA FASE

Tiempo de espera real del paciente antes de ser recibido · objetivo: cero

Acogida, Sala VIP y recorrido por la tecnología

Cinco minutos que fijan el marco de todo lo que viene después. El paciente debe percibir, sin que nadie se lo diga, tres cosas: que le esperaban, que el sitio es distinto y que la tecnología que va a ver justifica lo que luego escuchará.

ACCIONES

01 Acogida impecable y reconocimiento

Recepción consulta Clinic Cloud con antelación y saluda al paciente por su nombre. Sin esperas, sin formularios en el mostrador, sin «¿venía usted a qué?». El reconocimiento inmediato es la señal más barata y más eficaz de profesionalidad.

02 Acompañamiento personal a la Sala VIP

No se indica el camino: se acompaña. El paciente se sienta en un espacio cómodo, silencioso y reservado, y se le ofrece bebida. Nunca queda solo más de un par de minutos sin que alguien le informe del siguiente paso.

03 Tour explicativo centrado en la tecnología

El Director guía un recorrido breve y deliberado por dos puntos:

a) Sala de esterilización

- Explicar el circuito de instrumental y los protocolos de higiene
- Mostrar el equipamiento de esterilización y su trazabilidad por ciclos
- Transmitir tranquilidad: la seguridad sanitaria se enseña, no se promete

b) Sala de imagen 3D

- Presentar el CBCT (tomografía computarizada de haz cónico)
- Mostrar el escáner intraoral y explicar que sustituye a las pastas de impresión
- Vincular la inversión tecnológica con la precisión del diagnóstico y la predictibilidad del resultado

MENSAJE CLAVE · DIRECTOR

«Esta tecnología nos permite ver lo que de otro modo no se ve, planificar con exactitud milimétrica y garantizar resultados predecibles a largo plazo. Todo lo que le propongamos hoy saldrá de aquí.»

CRONOLOGÍA DE LA ACOGIDA

-15 min Recepción revisa en Clinic Cloud quién viene, por qué y quién le atenderá.	0:00 Llegada. Saludo por su nombre, de pie, sin mostrador de por medio.	0:30 – 1:30 Acompañamiento a la Sala VIP y ofrecimiento de bebida.	1:30 – 2:00 Aviso al Director de que el paciente ha llegado.
2:00 – 5:00 Tour por esterilización y sala de imagen 3D.			

PREPARACIÓN DEL ENTORNO · ANTES DE QUE LLEGUE

- ☐ Sala VIP ordenada, sin objetos personales del equipo ni documentación de otros pacientes
- ☐ Temperatura agradable y ventilación reciente
- ☐ Agua, café e infusiones disponibles y repuestos
- ☐ Sonido ambiente a volumen bajo; ningún ruido de gabinete audible
- ☐ Material de marca visible: libro Alma, casos, certificados
- ☐ Equipo uniformado e identificado con su nombre y función
- ☐ Sala de imagen encendida y lista para enseñar, sin restos del paciente anterior
- ☐ Agenda al día: si hay retraso previsible, se decide ya cómo se comunicará

GESTIÓN DE LA ESPERA Y DE LOS RETRASOS

SITUACIÓN	ACCIÓN INMEDIATA	RESPONSABLE
Retraso de hasta 10 minutos	Informar al llegar, sin excusas largas, y ofrecer bebida	Recepción
Retraso de 10 a 25 minutos	Informar, disculparse una sola vez y adelantar la Fase 3 en el despacho	Director
Retraso de más de 25 minutos	Ofrecer reprogramar sin coste y con hueco preferente; si se queda, el Director acompaña la espera	Director
El paciente llega tarde	Valorar si cabe el circuito completo; si no, reprogramar sin reproche	Recepción
El paciente no se presenta	Llamada el mismo día, sin tono de reclamación, y nuevo hueco	Recepción

Una PV que empieza con más de 25 minutos de retraso rara vez recupera la percepción de excelencia: es preferible reprogramar bien que ejecutar mal.

QUÉ PERCIBE EL PACIENTE

- Que le esperaban: alguien sabe su nombre y por qué viene
- Que no hay cola, ni papeles que rellenar de pie
- Que el sitio está impecable y huele a limpio, no a clínica
- Que la tecnología existe de verdad, porque la ha visto funcionar
- Que el equipo está orgulloso de enseñar cómo trabaja

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

DIGA

- «Buenos días, [Nombre]. Le estábamos esperando.»
- «Acompáñeme, le llevo a nuestra sala; ¿le apetece un café o un agua?»
- «Antes de empezar quiero enseñarle dónde va a estar y con qué trabajamos.»
- «Esta es la sala de esterilización: aquí es donde se controla todo lo que entra en su boca.»

EVITE

- «¿Su nombre?» cuando la cita está en agenda.
- Dejar al paciente de pie mientras se busca su ficha.
- Un tour largo y técnico: cinco minutos, dos paradas.
- Comentarios entre compañeros delante del paciente.
- Justificar retrasos culpando a otro paciente o a otro profesional.

CASOS ESPECIALES

Viene acompañado

El acompañante entra en todo el circuito salvo que el paciente diga lo contrario. Suele influir en la decisión final: se le trata como a un segundo paciente.

Movilidad reducida

Acceso adaptado, ruta sin escalones, tour abreviado o sustituido por vídeo en la Sala VIP.

Con niños

Ofrecer espacio y entretenimiento; si es necesario, un miembro del equipo acompaña al menor durante la presentación.

Paciente con prisa

Se explica el circuito y se propone completar las fases clínicas hoy y la presentación en una segunda cita cercana.

Odontofobia declarada

Tour más pausado, sin entrar en gabinete, y aviso al Doctor antes de la Fase 4.

Paciente conocido del equipo

El protocolo no se relaja: la confianza previa no sustituye a la documentación ni al circuito.

TOUR ACTIVO: SE DEMUESTRA, NO SE CUENTA

INNOVACIÓN ·
FICHA 04

Un tour narrado es un recital de características que el paciente olvida en cinco minutos. Un tour demostrado deja una imagen concreta que sostiene después toda la conversación sobre el valor.

ANTES

- «Aquí tenemos el CBCT»
- «Trabajamos con planificación digital»
- «Tenemos escáner intraoral»
- Se menciona la esterilización

DESPUÉS

- Se enciende y se muestra una imagen real
- Se abre una planificación en pantalla
- Se muestra un modelo 3D girando
- Se ve el ciclo en marcha y su registro

Requisito previo: tener siempre listo un caso de demostración anonimizado — CBCT, planificación y modelo 3D—, sin datos identificables o con consentimiento expreso para uso demostrativo.

EN LA SALA DE IMAGEN

«Esto es el CBCT. Le enseño una tomografía para que vea lo que nos permite ver —es de un caso de demostración, sin datos de nadie—. Esto blanco es hueso. Esto de aquí es el nervio dentario. Y esta línea es la posición exacta donde iría un implante, calculada al milímetro. Todo esto lo planificamos en el ordenador antes de tocar nada.»

EN ESTERILIZACIÓN

«Aquí está el autoclave. Cada ciclo queda registrado: qué instrumental, qué día, qué controles. Es algo que el paciente normalmente no ve, pero para nosotros es innegociable.»

Error documentado: saltarse el tour por falta de tiempo. Si no hay tiempo para el tour, el problema está en la agenda, no en el tour.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Saltarse el tour «porque vamos justos de tiempo»: se pierde el mayor diferenciador de la clínica
- Enseñar la tecnología sin explicar qué aporta al paciente
- Dejar al paciente solo en la Sala VIP más de cinco minutos sin información

- Hacer el tour con el gabinete o la sala de imagen sin recoger
- No registrar la hora real de llegada, con lo que la puntualidad deja de poder medirse

CRITERIO DE SALIDA

El paciente ha visto esterilización e imagen 3D, ha sido tratado por su nombre y pasa al despacho del Director acompañado. Se registra la hora real de llegada en Clinic Cloud para poder medir la puntualidad del circuito.

FASE 03 / 14

03

TIEMPO

15 minutos

RESPONSABLE

Director / Asesor

UBICACIÓN

Despacho del Director

MARCO LEGAL

RGPD · LOPDGDD

KPI DE LA FASE

100 % de fichas completas y altas cerradas antes de la Fase 9 · email verificado

Datos personales, protección de datos y alta en Clinic Cloud

La parte administrativa se hace en un despacho y no en un mostrador por una razón deliberada: convierte un trámite en una conversación. Mientras se completan los datos, el Director conoce al paciente como persona —a qué se dedica, con quién vive, qué le preocupa— y esa información será decisiva en las fases 7 y 10.

ACCIONES

01 Crear ambiente de confianza

- Gestionar la documentación en un entorno íntimo y poco clínico
- Romper el hielo con conversación genuina, sin interrogatorio
- Escuchar más que hablar: trabajo, familia, intereses, expectativas vitales
- Anotar en Clinic Cloud lo relevante que el paciente cuente de sí mismo

02 Documentación administrativa

a) Hoja de datos personales

- Información completa de contacto y facturación
- Firma del paciente

b) Política de protección de datos (RGPD)

- Informar sobre qué datos se tratan, con qué finalidad y durante cuánto tiempo
- Explicar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
- Recabar consentimiento diferenciado para comunicaciones comerciales y para uso de imágenes clínicas
- Obtener firma y fecha

03 Alta completa en Clinic Cloud

Responsabilidad indelegable del Director. Se completan todos los campos: nombre y apellidos, DNI/NIE, fecha de nacimiento, dirección completa, móvil, email, teléfono alternativo y fuente de contacto («cómo nos conoció»), coherente con lo registrado en la Fase 1.

04 Verificación del correo electrónico

La verificación del email es obligatoria: se comprueba en voz alta, carácter a carácter si hace falta. De ese dato dependen el envío de informes, recetas, documentación, recordatorios y toda la comunicación clínica posterior.

05 Entrega a Recepción

La hoja de datos personales firmada se deja en Recepción para su escaneo y subida a la ficha (Fase 11).

CRÍTICO · DIRECTOR

- Una ficha incompleta bloquea la facturación, la financiación y el envío del IAC. No se avanza con campos vacíos.
- El consentimiento para uso de imágenes con fines docentes o promocionales es **independiente** del consentimiento asistencial y debe marcarse por separado.
- Menores de edad o personas con representante legal: firma del tutor y registro de su identificación.

CRONOLOGÍA DEL DESPACHO

0:00 – 3:00 Conversación de apertura: quién es, a qué se dedica, qué le trae hoy.	3:00 – 8:00 Hoja de datos personales y alta completa en Clinic Cloud.	8:00 – 11:00 Explicación y firma del RGPD, con consentimientos diferenciados.	11:00 – 13:00 Verificación de email y teléfono; explicación del circuito de la visita.
13:00 – 15:00 Transición: presentación del Doctor y entrega de la hoja a Recepción.			

CONVERSACIÓN DE APERTURA · PREGUNTAS QUE ABREN

- «¿De qué zona viene? ¿Le ha costado aparcar?» — rompe el hielo sin invadir
- «¿A qué se dedica?» — informa sobre disponibilidad horaria y capacidad de pago sin preguntarla
- «¿Quién le ha hablado de nosotros?» — confirma el origen registrado en la Fase 1
- «¿Ha estado antes en otra clínica por este tema?» — anticipa comparaciones y experiencias previas
- «¿Hay algo que le preocupe especialmente de la visita de hoy?» — detecta miedos antes de que aparezcan

Todo lo relevante que se aprenda aquí se anota en Clinic Cloud. En la Fase 10, recordar que su hija se casa en septiembre vale más que cualquier técnica de cierre.

QUÉ SE EXPLICA DEL RGPD, LITERALMENTE

Responsable del tratamiento: Centro de Excelencia Implantológica Alma.

Finalidad: prestación de asistencia sanitaria, gestión administrativa, facturación

y –solo si lo autoriza– comunicaciones informativas y comerciales.

Base legal: ejecución del contrato asistencial y obligación legal sanitaria;

el consentimiento para las comunicaciones comerciales y para el uso de imágenes.

Conservación: la historia clínica se conserva durante el plazo legalmente exigible;

los datos comerciales, hasta que usted retire su consentimiento.

Destinatarios: laboratorio y profesionales colaboradores cuando el tratamiento lo requiera;

entidades financieras si contrata financiación; administraciones cuando la ley lo obligue.

Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición,

escribiendo a la dirección de la clínica. Puede reclamar ante la autoridad de control.

- ☐ **Consentimiento asistencial** — firmado
- ☐ **Consentimiento de comunicaciones comerciales** — casilla marcada de forma expresa, nunca premarcada
- ☐ **Consentimiento de uso de imágenes** con fines docentes o promocionales — independiente y revocable
- ☐ **Autorización de terceros:** quién puede recibir información del paciente (pareja, hijos, tutor)

CAMPOS OBLIGATORIOS DEL ALTA EN CLINIC CLOUD

BLOQUE	CAMPOS	VERIFICACIÓN
Identificación	Nombre, apellidos, DNI/NIE/pasaporte, fecha de nacimiento, sexo	Contra documento original
Contacto	Móvil, email, teléfono alternativo	Repetición en voz alta
Domicilio	Dirección completa, código postal, localidad, provincia	Necesario para facturación
Facturación	Titular, NIF, datos de empresa o aseguradora si aplica	Antes del primer cobro
Marketing	Cómo nos conoció, campaña, paciente que recomienda	Coherente con la Fase 1
Consentimientos	RGPD, comercial, imágenes, terceros autorizados	Fecha y firma
Contexto	Profesión, disponibilidad horaria, notas personales relevantes	Útil en Fases 7 y 10

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

DIGA

- «Vamos a dedicar diez minutos al papeleo aquí, cómodos, y después ya no volvemos a hablar de formularios.»
- «Le leo por encima qué hacemos con sus datos; si algo no le encaja, no lo firme.»
- «¿Me confirma su email letra por letra? Le enviaremos ahí su informe.»
- «El siguiente paso es el Doctor; le acompaño yo.»

EVITE

- «Firme aquí y aquí», sin explicar qué se firma.
- Rellenar el formulario mientras el paciente espera en silencio.
- Preguntar directamente por ingresos o capacidad de pago.
- Dejar campos vacíos «para completarlos luego».

CASOS ESPECIALES

Menor de edad

Firma el padre, madre o tutor, cuya identificación se registra. En caso de custodia compartida, se documenta quién autoriza.

Persona con representante legal

Se archiva copia de la resolución o poder que acredita la representación.

Sin documento español

Se admite pasaporte; se registra el número y la nacionalidad para facturación y garantías.

Se niega a dar email

Se explica que el informe y la documentación viajan por ahí. Si mantiene la negativa, se registra el motivo y se acuerda entrega en papel.

Factura a empresa o aseguradora

Datos fiscales del pagador, autorización expresa y condiciones de cobertura antes del presupuesto.

Revoca un consentimiento

Se atiende de inmediato, se registra la fecha y se excluye al paciente de los envíos correspondientes.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Tratar el RGPD como un trámite mudo: sin explicación, el consentimiento es débil
- Marcar por defecto la casilla de comunicaciones comerciales
- Escribir el email de oído, sin deletrearlo: es la causa número uno de informes que no llegan

- No anotar nada de la conversación personal, desaprovechando la única información que el sistema no captura solo
- Delegar el alta en Recepción cuando el protocolo la asigna al Director

CRITERIO DE SALIDA

Ficha de Clinic Cloud completa, RGPD firmado y fechado, email verificado y hoja de datos entregada a Recepción. Solo entonces el paciente pasa al Doctor.

FASE 04 / 14

04

TIEMPO

10 minutos

RESPONSABLE

Doctor / Odontólogo

UBICACIÓN

Despacho del Doctor

SALIDA DOCUMENTAL

Consentimiento radiológico firmado

KPI DE LA FASE

100 % de historiales con alergias, medicación y cirugías previas · el ítem de mayor riesgo clínico-legal

Historia médica y consentimiento radiológico

Aquí cambia la autoridad de la conversación. El Director presenta al Doctor y se retira del primer plano: a partir de este momento, quien decide qué es clínicamente correcto es el Doctor, y el paciente debe percibirlo con nitidez.

ACCIONES

01

Transición de autoridad clínica

El Director acompaña al paciente al despacho del Doctor y hace la presentación explícita, transmitiendo equipo, continuidad y jerarquía clínica. La transición es fluida: el paciente no vuelve a explicar desde cero lo que ya ha contado.

02

Anamnesis médica general

- Enfermedades sistémicas actuales y pasadas
- Alergias: medicamentos, materiales, látex, anestésicos
- Medicación actual, con especial atención a anticoagulantes y bifosfonatos
- Intervenciones quirúrgicas previas y complicaciones
- Patología cardiovascular, diabetes, hipertensión
- Trastornos de la coagulación
- Embarazo o lactancia
- Hábitos relevantes: tabaco, alcohol, bruxismo

03

Anamnesis dental

- Tratamientos dentales previos y su antigüedad
- Experiencias anteriores, positivas y negativas
- Hábitos de higiene oral y frecuencia de revisiones
- Problemas recurrentes, sensibilidad, bruxismo
- Miedos, fobias o antecedentes de mala tolerancia al tratamiento

04

Consentimiento informado para pruebas radiológicas

a) Explicación de la dosis

- Tecnología digital de baja dosis y campo de visión ajustado al área de interés
- Exposición comparable a la radiación natural de un vuelo transcontinental
- Principio ALARA: la dosis mínima razonablemente alcanzable

b) Justificación diagnóstica

- Permite visualizar estructuras óseas y patologías invisibles en la exploración clínica
- Detección temprana de lesiones periapicales, quistes y reabsorciones
- Planificación implantológica con medición real de hueso disponible

c) Firma y custodia

- Firma del paciente en el consentimiento para pruebas radiológicas
- Entrega inmediata a Recepción para escaneo

CRÍTICO · DOCTOR

- Registrar en la historia de Clinic Cloud la anamnesis completa, no un resumen de dos líneas.
- Confirmar en el sistema que el consentimiento radiológico está firmado **antes** de que el paciente entre en la sala de imagen.
- Ante sospecha o confirmación de embarazo, valorar diferir las pruebas y dejarlo documentado.

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA CLÍNICA

0:00 – 1:00 Presentación por parte del Director y recapitulación del motivo de consulta.	1:00 – 5:00 Anamnesis médica general, con revisión sistemática por aparatos.	5:00 – 8:00 Anamnesis dental e historia de experiencias previas.	8:00 – 10:00 Explicación y firma del consentimiento radiológico.
---	---	---	---

ALERTAS MÉDICAS · QUÉ OBLIGA A MODIFICAR EL PLAN

Detectar estas situaciones es el objetivo real de la anamnesis. Cada una condiciona el diagnóstico, la técnica o el calendario, y ninguna puede aparecer por sorpresa el día de la cirugía.

HALLAZGO EN LA ANAMNESIS	IMPLICACIÓN	ACCIÓN DEL DOCTOR
Anticoagulantes o antiagregantes	Riesgo de sangrado en procedimientos invasivos	Registrar fármaco y pauta; coordinar con el médico prescriptor antes de cirugía
Bifosfonatos o antirresortivos	Riesgo de osteonecrosis maxilar	Vía, duración y fecha de inicio; valorar alternativas no quirúrgicas y consentimiento específico
Diabetes	Cicatrización comprometida y mayor riesgo periodontal	Preguntar por control glucémico reciente; condicionar el calendario quirúrgico

HALLAZGO EN LA ANAMNESIS	IMPLICACIÓN	ACCIÓN DEL DOCTOR
Cardiopatía o prótesis valvular	Posible indicación de profilaxis antibiótica	Verificar informe del cardiólogo antes de procedimientos con sangrado
Inmunosupresión o quimioterapia	Riesgo infeccioso y de retraso de cicatrización	Coordinación con el especialista responsable; posponer si procede
Alergias, en especial a látex o anestésicos	Riesgo de reacción durante el tratamiento	Marcar la alerta en Clinic Cloud de forma visible y preparar material alternativo
Embarazo o lactancia	Prudencia radiológica y farmacológica	Diferir pruebas no urgentes; documentar la decisión
Tabaquismo activo	Menor supervivencia implantaria y peor pronóstico periodontal	Informar del impacto en el pronóstico y reflejarlo en el IAC
Bruxismo	Sobrecarga de restauraciones e implantes	Incluir férula de descarga en el plan y advertir sobre garantías
Ansiedad u odontofobia	Abandono del tratamiento y mala experiencia	Valorar sedación consciente y citas más cortas; avisar a todo el equipo

Esta tabla ordena el criterio de actuación del centro; no sustituye al juicio clínico del Doctor ni a la valoración del médico responsable de cada paciente.

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONSENTIMIENTO RADIOLÓGICO

- ☐ **Identificación** del paciente y del centro
- ☐ **Pruebas concretas** que se van a realizar: CBCT, OPG y, si procede, periapicales
- ☐ **Justificación diagnóstica** de cada una
- ☐ **Información sobre la dosis** y su comparación con la exposición natural
- ☐ **Riesgos y alternativas**, incluida la de no realizar la prueba
- ☐ **Declaración sobre embarazo** en pacientes en edad fértil
- ☐ **Firma del paciente** o representante, con fecha
- ☐ **Firma del profesional** que informa

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

DIGA

- «Antes de mirarle la boca necesito conocer su salud general: muchas decisiones dependen de ello.»
- «¿Toma alguna medicación, aunque le parezca que no tiene relación con los dientes?»
- «La dosis de esta tomografía es muy baja, comparable a la radiación natural de un vuelo largo.»
- «Le pido la firma porque toda prueba con radiación exige que usted esté informado.»

EVITE

- Pasar la anamnesis como un cuestionario de sí o no, sin repreguntar.
- «Esto no es nada, firme aquí.»
- Minimizar la radiación con datos inventados.
- Comentar en voz alta lo que hizo mal el centro anterior.
- Empezar a diagnosticar antes de tener las pruebas.

CASOS ESPECIALES

Embarazo

Se difieren las pruebas no urgentes. Si existe urgencia, se documenta la justificación y se extreman las medidas de protección.

Paciente pediátrico

Anamnesis con el tutor presente, lenguaje adaptado y criterio radiológico más restrictivo.

Claustrofobia

Explicación previa del equipo, acompañamiento en sala y prueba en dos tiempos si es necesario.

Barrera idiomática

Consentimiento en un idioma que el paciente comprenda; si no es posible, intérprete identificado en la historia.

Deterioro cognitivo

Información y firma del representante legal, con el paciente presente y participando en lo posible.

Trae pruebas recientes

Se valoran; si son válidas y suficientes, se evita repetir la exposición y se deja constancia del motivo.

CONSENTIMIENTO CON VERIFICACIÓN DE COMPRENSIÓN

INNOVACIÓN · FICHA 06

Una firma sin comprensión no es un consentimiento, y es el punto más débil de la mayoría de las clínicas ante una reclamación. La diferencia entre firmar y consentir cabe en una pregunta y en una línea de registro.

1 Explicar con soporte visual.	2 Preguntar: «¿me puede repetir con sus palabras qué le vamos a hacer y por qué?».	3 Aclarar lo que no haya quedado claro.	4 Firmar.
5 Registrar que la comprensión fue verificada.			

GUIÓN · DOCTOR

«[Nombre], antes de firmar quiero asegurarme de que le ha quedado todo claro. No es un trámite: si algo no se entiende, prefiero explicarlo otra vez. ¿Me puede decir con sus palabras qué le vamos a hacer y por qué?»

EL REGISTRO QUE MARCA LA DIFERENCIA

En la historia clínica: «Consentimiento explicado. Se verifica comprensión mediante repetición por el paciente. Se resuelven dudas sobre [tema]. Firma.» Esa anotación es lo que convierte un consentimiento firmado en un consentimiento válido. Indicador: 100 % de consentimientos con verificación registrada.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Registrar «sin antecedentes de interés» sin haber preguntado por medicación concreta
- No marcar las alergias como alerta visible en Clinic Cloud
- Firmar el consentimiento después de haber hecho las pruebas
- Preguntar por miedos y no trasladárselos al resto del equipo
- Repetir al paciente preguntas que ya respondió por teléfono o en el despacho

CRITERIO DE SALIDA

Historia médica y dental registradas, contraindicaciones identificadas y consentimiento radiológico firmado. Sin firma no hay radiología: la fase 5 no comienza.

FASE 05 / 14

05

TIEMPO

15 minutos

RESPONSABLE

Auxiliar

UBICACIÓN

Sala de imagen 3D · Gabinete

SALIDA

Imágenes en Clinic Cloud, etiquetadas

KPI DE LA FASE

Batería completa en 15 minutos o menos · repetición de pruebas por calidad por debajo del 5 %

Pruebas diagnósticas avanzadas y documentación fotográfica

La batería completa de pruebas es, a la vez, la base del diagnóstico y el argumento más sólido de la clínica. Se ejecuta con precisión técnica y con cuidado del confort: el paciente debe saber en todo momento qué se le va a hacer, cuánto dura y qué va a notar.

PROTOCOLO DE IMAGEN

- 01 **CBCT 3D · Tomografía computarizada de haz cónico**
 - Posicionamiento correcto y estabilización de la cabeza
 - Explicación previa: duración, ruido del equipo, inmovilidad requerida
 - Volumen tridimensional completo de estructura ósea y dental
- 02 **OPG · Ortopantomografía**
 - Visión general de ambos maxilares
 - Detección de patología general y piezas incluidas
 - Evaluación de senos maxilares, cóndilos y nervio dentario
- 03 **Escaneado intraoral 3D**
 - Captura digital de alta precisión de ambas arcadas y de la oclusión
 - Modelo virtual sobre el que se planifican tratamientos estéticos y restauradores
 - Base para simulaciones y para el seguimiento comparativo en el tiempo
- 04 **Serie fotográfica estética y funcional**
 - Extraorales**
 - Frontal en reposo y en sonrisa
 - Perfil derecho e izquierdo
 - Tres cuartos

Intraorales

- Frontal en oclusión
- Laterales derecho e izquierdo
- Oclusales superior e inferior
- Detalles de zonas específicas señaladas por el Doctor

CRÍTICO · AUXILIAR

- Todas las imágenes se cargan en Clinic Cloud **en el momento**, no al final de la jornada.
- Etiquetado correcto: tipo de prueba, fecha y observaciones.
- Verificación de calidad antes de dar la prueba por buena: encuadre, enfoque, ausencia de artefactos y de movimiento.
- Comprobar que el Doctor puede abrir el material desde el equipo de presentación.

CRONOLOGÍA DE LAS PRUEBAS

0:00 – 1:30 Explicación del recorrido de pruebas y retirada de objetos metálicos.	1:30 – 4:00 CBCT: posicionamiento, indicaciones y adquisición.	4:00 – 5:30 OPG.	5:30 – 9:30 Escaneado intraoral de ambas arcadas y registro de oclusión.
9:30 – 13:00 Serie fotográfica extraoral e intraoral.	13:00 – 15:00 Carga, etiquetado y verificación en Clinic Cloud.		

CONTROL DE CALIDAD POR PRUEBA

PRUEBA	PREPARACIÓN	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	MOTIVO HABITUAL DE REPETICIÓN
CBCT	Retirada de pendientes, piercings, prótesis removibles y horquillas; plano oclusal orientado	Volumen completo del área de interés, sin movimiento, cortes nítidos	Movimiento del paciente durante la adquisición
OPG	Mordida en posición, lengua en el paladar, hombros relajados	Simetría de ramas, cóndilos visibles, sin sombra de lengua	Lengua separada del paladar o posición adelantada
Escaneado intraoral	Campo seco, retractores, aspiración; escaneo por secuencia oclusal-lingual-vestibular	Arcadas completas sin huecos, oclusión registrada y coincidente	Saliva, sangrado gingival o secuencia interrumpida
Fotografía extraoral	Fondo neutro, cabeza en plano de Frankfort, iluminación homogénea	Encuadre reproducible, enfoque en el tercio medio facial	Inclinación de cabeza distinta entre tomas

PRUEBA	PREPARACIÓN	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	MOTIVO HABITUAL DE REPETICIÓN
Fotografía intraoral	Retradores, espejos calentados, secado y aspiración	Sin vaho, sin dedos ni retradores en cuadro, plano paralelo	Espejo empañado o saliva en la superficie dental

CONFORT DEL PACIENTE DURANTE LAS PRUEBAS

- Anunciar cada prueba antes de empezarla: qué es, cuánto dura y qué va a notar
- Avisar de los ruidos del equipo antes de que suenen
- Pausas a demanda: el paciente sabe que puede levantar la mano y parar
- Cuidado con la sensibilidad al frío del aire de secado y con los retradores en labios secos
- Ofrecer enjuague y espejo al terminar; nadie vuelve al despacho despeinado o con restos
- Explicar que verá sus imágenes en pantalla en unos minutos: convierte la prueba en expectativa

ETIQUETADO Y NOMENCLATURA EN CLINIC CLOUD

Formato: AAAAMDD_Apellido-Nombre_TIPO_detalle

20260318_Perez-Ana_CBCT_maxilar-completo
 20260318_Perez-Ana_OPG
 20260318_Perez-Ana_IOS_arcada-superior
 20260318_Perez-Ana_FOTO-E0_frontal-sonrisa
 20260318_Perez-Ana_FOTO-I0_lateral-derecho
 20260318_Perez-Ana_CAM-I0_16-fisura

- ☐ **Tipo de prueba** seleccionado en el desplegable, no escrito a mano
- ☐ **Fecha real** de adquisición
- ☐ **Observaciones** del auxiliar: incidencias, repeticiones, limitaciones
- ☐ **Asociación** a la ficha correcta, comprobada con dos datos identificativos
- ☐ **Apertura de prueba** desde el portátil de presentación

CASOS ESPECIALES

Reflejo nauseoso intenso

Escaneado por sectores con pausas, respiración por la nariz, sal en la punta de la lengua y, si es necesario, posponer la arcada superior.

Movilidad reducida

Equipos con posicionamiento sentado; si no es posible, se documenta la limitación y se busca alternativa diagnóstica.

Restauraciones metálicas extensas

Advertir de los artefactos en el CBCT y complementar con periapicales dirigidas.

Paciente pediátrico

Criterio radiológico restrictivo, protección adicional y acompañamiento del tutor.

Prótesis removible

Se escanea con y sin prótesis cuando el plan lo requiera, y se registra así en las observaciones.

Prueba fallida

Se repite solo si es imprescindible, se justifica en la historia y se informa al paciente sin dramatizar.

EL PACIENTE VE SU MODELO 3D

INNOVACIÓN · FICHA 09

Treinta segundos, coste cero: es la innovación con mejor relación entre impacto y coste de todo el sistema. Tras completar el escaneado, antes de que el paciente se levante del sillón.

GUIÓN · AUXILIAR

«[Nombre], mire la pantalla un momento. Esto es su boca en tres dimensiones, ahora mismo. Puede verla desde arriba, desde abajo, por dentro... Esto es exactamente lo que va a ver el doctor para estudiar su caso.»

EFFECTO	POR QUÉ OCURRE
Protagonismo	El paciente pasa de sujeto pasivo a implicado en su caso
Contexto previo	Llega a la presentación de la Fase 9 con familiaridad visual
Percepción tecnológica	Demuestra en lugar de contar
Conversación	Muchos pacientes hacen aquí preguntas que ya no harían después

PREDIAGNÓSTICO ASISTIDO Y FLUJO DIGITAL INTEGRADO

INNOVACIÓN · FICHAS 07 Y 08

REGLA INNEGOCIABLE

El prediagnóstico es una segunda lectura, nunca la primera. El Doctor diagnostica; el sistema señala. Si el Doctor lee antes el informe automático, condiciona su criterio.

1 El Auxiliar carga la imagen.	2 El sistema genera los hallazgos señalados.	3 El Doctor realiza su lectura primero.	4 Después contrasta con el prediagnóstico.
5 Registra concordancias y discrepancias.	6 Decide el diagnóstico final.		

Las discrepancias registradas —la herramienta señala y el Doctor descarta, o el Doctor detecta y la herramienta no señala— son material de calibración: a los seis meses se sabe en qué acierta y en qué falla.

QUÉ SE LE DICE AL PACIENTE

«Además de mi valoración, pasamos todas las radiografías por un sistema de análisis asistido que actúa como una segunda revisión. Sirve para que no se nos escape nada.»

Nunca «el ordenador dice que tiene...»: la autoridad diagnóstica es del profesional. Del flujo digital integrado —CBCT, escaneado y serie fotográfica fusionados en un solo modelo— salen cinco usos con un solo registro: diagnóstico, planificación, guía quirúrgica, simulación y presentación. Si la fusión falla, se trabaja con los archivos por separado y se registra la incidencia: el diagnóstico nunca se pospone.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Dejar la carga de imágenes «para luego», con el consiguiente riesgo de presentación incompleta
- Etiquetar como «foto1, foto2», imposibilitando la comparación en revisiones futuras
- No avisar de los ruidos ni de la duración: el paciente se mueve y hay que repetir
- Fotografías intraorales con vaho o con dedos en cuadro, que restan profesionalidad en la presentación
- Subir imágenes a la ficha equivocada por no verificar identidad

CRITERIO DE SALIDA – BLOQUEANTE

No se avanza a la fase siguiente sin confirmar que todas las pruebas están cargadas, etiquetadas, asociadas a la ficha y visibles desde el portátil de presentación. Una prueba que hay que repetir después destruye la percepción de precisión construida hasta aquí.

FASE 06 / 14

06

TIEMPO

5 minutos

RESPONSABLE

Doctor + Director

UBICACIÓN

Gabinete o sala de presentación

SIN EL PACIENTE

Reunión interna

KPI DE LA FASE

100 % de briefings realizados antes de que el paciente vuelva a ver al Doctor

Briefing entre Doctor y Director

Cinco minutos que determinan la coherencia de los sesenta siguientes. Doctor y Director revisan juntos lo que ya saben y salen de la sala con una única versión del diagnóstico, del plan y del enfoque. Esta reunión ocurre mientras el paciente descansa tras las pruebas.

ACCIONES

01 Análisis interdisciplinar

- Lectura conjunta del CBCT: estructura ósea, patología, anatomía relevante
- Perfil del paciente: expectativas manifestadas, urgencia, contexto personal y económico
- Información acumulada: historia médica, motivaciones, miedos

02 Consenso clínico

El Doctor debe salir del briefing con el Plan de Tratamiento Óptimo definido de forma inequívoca:

- Diagnóstico principal y diagnósticos secundarios
- Plan recomendado, paso a paso y por fases
- Alternativas terapéuticas reales, si existen, con sus pros y contras
- Tiempos estimados y número aproximado de citas
- Resultados esperables y limitaciones honestas

03 Alineación del discurso

a) Argumentos clínicos — Doctor

- Durabilidad de los materiales seleccionados
- Garantías aplicables al caso
- Tecnología empleada en la planificación y la ejecución
- Experiencia del equipo en casos equivalentes

b) Enfoque económico — Director

- Modalidades de financiación aplicables
- Bonificación por pago anticipado, si procede
- Posible secuenciación del plan por fases

c) Objeciones previsibles — Director

- Percepción de precio elevado
- Necesidad de pensarlo o de consultarlo con la familia
- Comparación con otros centros

CRÍTICO

Si Doctor y Director no coinciden en el plan, se resuelve **aquí**. Ninguna discrepancia clínica se ventila delante del paciente: la duda percibida es la primera causa de no conversión y la peor señal de calidad asistencial.

AGENDA DEL BRIEFING · CINCO MINUTOS CRONOMETRADOS —

0:00 – 1:30 Lectura del CBCT y de la OPG por parte del Doctor.	1:30 – 2:30 Perfil del paciente: expectativas, contexto, miedos, urgencia.	2:30 – 4:00 Definición del plan óptimo y de las alternativas.	4:00 – 5:00 Reparto: quién dice qué en las Fases 9 y 10.
---	---	--	---

FICHA DE ACUERDO DEL BRIEFING —

Se cumplimenta en Clinic Cloud durante el propio briefing. Es la garantía de que ambos profesionales salen con la misma versión.

Diagnóstico principal:
.....

Diagnósticos secundarios:
.....

Plan óptimo

Fase 1 (urgencias/preparación):
.....

Fase 2 (tratamiento principal):
.....

Fase 3 (estética/mantenimiento):
.....

Alternativa razonable:
.....

Duración estimada: N.º de citas:

Rango económico previsto: Vía de pago probable:

Riesgo principal del caso:
.....

Objeción esperada:
.....

Reparto: explica el diagnóstico presenta el plan presupuesto

REGLAS DEL BRIEFING —

- Se hace siempre, aunque el caso parezca sencillo: los casos simples también se pierden por descoordinación
- Se hace fuera del alcance auditivo del paciente y de la sala de espera

- La decisión clínica es del Doctor; la estrategia de comunicación se acuerda entre ambos
- Si el caso excede la cartera de servicios del centro, se decide aquí la derivación y quién la explica
- Si el Doctor necesita más tiempo de estudio, se propone al paciente una segunda cita de presentación en 24–48 h, sin improvisar

CASOS ESPECIALES

Discrepancia clínica

Prevalece el criterio del Doctor. Si persiste la duda, se consulta a Dirección Médica antes de presentar nada.

Caso fuera de cartera

Se define la derivación, el profesional receptor y el mensaje al paciente. Derivar bien también fideliza.

Hallazgo grave incidental

Se decide cómo comunicarlo, con qué grado de urgencia y a qué especialista se remite el mismo día.

Presupuesto muy elevado

Se prepara desde ya la secuenciación por fases y la simulación de financiación, no en mitad de la Fase 10.

Paciente con expectativas irreales

Se acuerda qué se puede prometer y qué no, y quién marca ese límite delante del paciente.

Caso interdisciplinar

Se identifica qué especialistas intervienen y en qué orden, para que el plan tenga secuencia y calendario creíbles.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Saltarse el briefing por falta de tiempo, y contradecirse después delante del paciente
- Cerrar un plan sin haber mirado el CBCT con detenimiento
- Definir el precio antes que el plan clínico
- No registrar el acuerdo, con lo que nadie puede auditar qué se decidió y por qué
- Comentar el caso en pasillos o en zonas comunes

CRITERIO DE SALIDA

Existe un plan óptimo único, con fases, tiempos y alternativas, y un reparto claro de quién explica cada parte en las fases 9 y 10.

FASE 07 / 14

07

TIEMPO

15 minutos

RESPONSABLE

Doctor

UBICACIÓN

Gabinete de diagnóstico

HERRAMIENTA

Cámara intraoral

KPI DE LA FASE

Seis o más preguntas de expectativas, cubriendo las cuatro categorías

Anamnesis de expectativas y exploración clínica detallada

Un plan técnicamente impecable que no responde a lo que el paciente quiere resolver es un plan que no se acepta. Esta fase tiene dos mitades inseparables: entender qué espera la persona y explorar exhaustivamente qué ocurre en su boca.

DIÁLOGO DE EXPECTATIVAS

Funcionales

- «¿Qué le impide comer con normalidad?»
- «¿Tiene dolor o molestias habituales?»
- «¿Qué le gustaría poder hacer que ahora no puede?»

Estéticas

- «¿Cómo se siente con su sonrisa actual?»
- «¿Qué cambiaría de su aspecto dental si pudiera?»
- «¿Hay situaciones en las que evita sonreír?»

Emocionales

- «¿Cómo afecta esto a su vida diaria?»
- «¿Qué significaría para usted resolverlo?»
- «¿Qué le preocupa del tratamiento?»

Experiencias previas

- «¿Ha tenido malas experiencias dentales?»
- «¿Qué le gustó y qué no de tratamientos anteriores?»

Las respuestas se registran con las palabras del paciente. Serán el vocabulario exacto con el que se le presente la solución en la Fase 9.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Extraoral

- Simetría facial y perfil estético
- Evaluación de la articulación temporomandibular: apertura, ruidos, desviación
- Palpación de musculatura, ganglios y estructuras cervicofaciales

Intraoral

- Estado gingival: color, inflamación, sangrado al sondaje
- Placa y cálculo; índice de higiene
- Estado diente a diente, con odontograma
- Caries visibles y sospechas radiológicas
- Estado de restauraciones y prótesis previas
- Oclusión, mordida y guías funcionales
- Desgastes, fracturas y fisuras
- Tejidos blandos: lengua, mucosas, paladar, suelo de boca

CÁMARA INTRAORAL · CAPTURA DE EVIDENCIA

La imagen más potente es la que el paciente entiende. La cámara intraoral se usa *en este momento* para documentar las zonas problemáticas y generar conciencia real de la situación, no para impresionar.

TÉCNICA DE EXPLICACIÓN · DOCTOR

«¿Ve esto? Esta sombra oscura es una caries que está empezando aquí. Esta línea es una fisura en el esmalte. Y fíjese en la encía: debería verse rosa y firme, y aquí está inflamada y sangra al tocarla.»

CRONOLOGÍA DE LA EXPLORACIÓN

0:00 – 5:00 Diálogo de expectativas funcionales, estéticas y emocionales.	5:00 – 8:00 Exploración extraoral y de la ATM.	8:00 – 12:00 Exploración intraoral sistemática por cuadrantes y sondaje.	12:00 – 15:00 Cámara intraoral sobre las zonas clave, con explicación en pantalla.
--	---	---	---

TÉCNICA DE ENTREVISTA

- **Pregunta abierta primero:** «Cuénteme» produce más información que quince preguntas cerradas
- **Silencio activo:** tras la respuesta, esperar tres segundos; ahí aparece lo que de verdad preocupa
- **Reformulación:** «Si le he entendido bien, lo que más le molesta es...», y dejar que corrija
- **Escala de importancia:** «Del 0 al 10, ¿cuánto le afecta esto en su día a día?» ordena prioridades del plan
- **Pregunta del deseo:** «Si mañana esto estuviera resuelto, ¿qué haría distinto?» define el criterio de éxito del paciente
- **Sin juicio:** nunca reprochar la higiene, el abandono ni tratamientos anteriores

REGISTRO ESTRUCTURADO DE EXPECTATIVAS

Motivo declarado:
«.....»

Prioridad funcional: Intensidad 0–10:
....

Prioridad estética: Intensidad 0–10:
....

Impacto emocional / social:
.....

Criterio de éxito del paciente:
.....

Experiencias previas relevantes:
.....

Miedos declarados:
.....

Limitaciones: tiempo desplazamientos agenda

Este registro se cita literalmente en la Fase 9. Cuando el paciente escucha su propia frase en boca del profesional, la propuesta deja de ser un catálogo y pasa a ser su solución.

PROTOCOLO SISTEMÁTICO DE EXPLORACIÓN

ORDEN	EXPLORACIÓN	SE REGISTRA
1	Extraoral: simetría, perfil, tercios faciales, línea de sonrisa	Descripción y fotografía
2	ATM: apertura máxima, desviación, chasquidos, dolor a la palpación	Milímetros de apertura y hallazgos
3	Musculatura y ganglios cervicofaciales	Normalidad o hallazgo
4	Tejidos blandos: labios, mucosas, lengua, suelo de boca, paladar, orofaringe	Cribado de lesiones
5	Periodontal: sondaje, sangrado, recesiones, movilidad, furcas	Periodontograma o índice registrado
6	Dental por cuadrantes, diente a diente	Odontograma actualizado
7	Restauraciones y prótesis existentes	Estado y pronóstico
8	Oclusión: clase, guías, interferencias, facetas de desgaste	Hallazgos funcionales

QUÉ CAPTURAR CON LA CÁMARA INTRAORAL

- ☐ Cada zona que aparecerá en la presentación, sin excepción
- ☐ Una imagen de contraste: una zona sana del propio paciente junto a la afectada
- ☐ Márgenes de restauraciones antiguas con filtración o fractura
- ☐ Encía inflamada o con recesión, comparada con una zona estable
- ☐ Desgastes y fisuras visibles a alto aumento
- ☐ Detalle estético que el paciente ha mencionado como preocupación

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

DIGA

- «¿Qué le gustaría poder hacer que ahora no puede?»
- «Voy a enseñárselo en pantalla para que lo vea usted mismo.»
- «Esto de aquí está perfectamente; lo que hay que atender es esta zona.»
- «¿Hay algo que no le haya preguntado y que quiera contarme?»

EVITE

- «¿Cómo ha llegado usted a esta situación?»
- Dictar hallazgos en jerga delante del paciente sin traducirlos después.
- Enseñar solo lo malo: sin referencia sana, la imagen no se entiende.
- Adelantar precios o plazos en pleno gabinete.
- Prometer resultados antes de haber terminado el análisis.

CASOS ESPECIALES

Dolor agudo

Primero se alivia. La exploración completa puede esperar; el dolor, no. Se documenta la actuación de urgencia.

Expectativa irreal

Se dice con claridad y sin rodeos qué no es alcanzable, y se ofrece el mejor resultado realista con evidencia visual.

Solo quiere estética

Se explica que la salud precede a la estética y se secuencia el plan sin renunciar al objetivo del paciente.

Lesión sospechosa

Prioridad diagnóstica sobre cualquier plan estético; derivación y seguimiento documentados el mismo día.

Paciente que se emociona

Pausa, agua, tiempo. No se continúa la exploración hasta que el paciente lo indique.

Acompañante que interviene

Se le integra con respeto, pero las preguntas se dirigen siempre al paciente.

PERFIL DE RIESGO Y PROYECCIÓN A CINCO AÑOS

INNOVACIÓN · FICHA 10

La exploración produce un diagnóstico del presente. No produce una proyección del futuro, que es exactamente lo que el paciente necesita para decidir y lo que da fundamento al mantenimiento. Los criterios clínicos que determinan cada nivel los define el responsable clínico; aquí se fija la estructura del registro.

PERFIL DE RIESGO – [Paciente] · [Fecha]

RIESGO PERIODONTAL Factores: Nivel: alto / medio
/ bajo

RIESGO DE CARIES Factores: Nivel: alto / medio
/ bajo

RIESGO BIOMECÁNICO Factores: Nivel: alto / medio
/ bajo

RIESGO PERIIMPLANTARIO Factores: Nivel: alto / medio
/ bajo

FACTORES SISTÉMICOS Y CONDUCTUALES:

PERFIL GLOBAL: alto / medio / bajo

PERIODICIDAD INDICADA: cada meses

PROYECCIÓN A 5 AÑOS SIN INTERVENCIÓN:

GUIÓN · DOCTOR

«[Nombre], le voy a explicar dos cosas distintas y quiero que distinga bien entre ellas. La primera es lo que tiene hoy: [hallazgos actuales]. Eso lo resolvemos con el tratamiento. La segunda, que es la que más me preocupa, es hacia dónde va. Su perfil de riesgo es alto por [factores concretos]. Si no hacemos nada distinto a lo que ha hecho hasta ahora, lo esperable en cinco años es [proyección realista]. El tratamiento resuelve lo primero. El seguimiento evita lo segundo. Y son dos decisiones diferentes.»

FASE	QUÉ CAMBIA CUANDO EXISTE EL PERFIL DE RIESGO
09	Se presenta riesgo futuro, no solo daño presente
10	El argumento deja de ser el precio y pasa a ser la consecuencia
14	La periodicidad del mantenimiento tiene fundamento individual

Error documentado: registrar el perfil y no usarlo. Si no se comunica al paciente y no determina la periodicidad, es papeleo. Indicador: 100 % de primeras visitas con perfil de riesgo registrado.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Explorar sin haber preguntado antes: se acierta el diagnóstico y se falla la propuesta
- No registrar las palabras del paciente y perder el mejor argumento de la Fase 9
- Capturar imágenes intraorales sin explicarlas: la evidencia sin relato no genera conciencia
- Omitir el cribado de tejidos blandos por centrarse en el motivo de consulta
- Dejar el odontograma incompleto y tener que reconstruirlo de memoria en la Fase 8

CRITERIO DE SALIDA

Expectativas registradas en la historia con literalidad, exploración completa documentada y capturas intraorales de todas las zonas que se mostrarán en la presentación.

FASE 08 / 14

08

TIEMPO

10 minutos

RESPONSABLE

Director redacta · Doctor dicta, valida y firma

UBICACIÓN

Gabinete de diagnóstico

VALOR

Documento clínico y legal

KPI DE LA FASE

Menos de 10 minutos entre firma y entrega · menos del 2 % de IAC con discrepancias en auditoría

Informe de Análisis Clínico: elaboración, firma y entrega

El IAC es la pieza que convierte una exploración en un documento. Sostiene la propuesta económica, acompaña al paciente a casa y tiene valor probatorio. Se redacta a cuatro manos: el Doctor dicta, el Director escribe, el Doctor revisa y firma.

ESTRUCTURA DEL DICTADO

a) Hallazgos clínicos – recuadro propio en el IAC

- Estado general de la salud oral
- Descripción pieza por pieza de los hallazgos relevantes
- Patologías presentes: caries, enfermedad periodontal, lesiones de tejidos blandos
- Estado de restauraciones y prótesis previas
- Alteraciones oclusales o de la ATM

b) Hallazgos radiológicos – recuadro propio en el IAC

- Lectura del CBCT y de la OPG
- Nivel óseo y patrón de reabsorción
- Infecciones, lesiones periapicales, quistes
- Anatomía relevante: seno maxilar, nervio dentario, cortical
- Calidad y cantidad de hueso disponible

c) Diagnóstico definitivo

- Diagnóstico principal
- Diagnósticos secundarios
- Pronóstico por pieza y global

d) Plan de tratamiento propuesto

- Fase 1 — urgencias, control de infección y preparación
- Fase 2 — tratamiento principal
- Fase 3 — rehabilitación estética y funcional, mantenimiento

- Alternativas, cuando existan, con sus implicaciones

REDACCIÓN, VALIDACIÓN Y ENTREGA

01

El Director redacta el IAC en tiempo real

Datos del paciente, fecha de exploración, motivo de consulta, hallazgos clínicos, hallazgos radiológicos, diagnóstico y plan de tratamiento recomendado. Lenguaje preciso, sin adjetivos comerciales.

02

El Doctor revisa y firma

- Verifica la exactitud clínica de cada afirmación
- Corrige errores, imprecisiones o excesos
- Firma, validando oficialmente diagnóstico y plan

03

Entrega inmediata a Recepción

El IAC firmado se entrega en el momento para su escaneo y subida a Clinic Cloud. No espera al final de la visita.

CRÍTICO · DOCTOR

La firma del Doctor no es un trámite administrativo: convierte el documento en un acto clínico con responsabilidad profesional. Nada se firma sin haberlo leído íntegramente, y el contenido del IAC debe ser **idéntico** a lo que después se registre en la historia de Clinic Cloud.

ESTRUCTURA DEL IAC · PLANTILLA

INFORME DE ANÁLISIS CLÍNICO

Centro de Excelencia Implantológica Alma

Paciente: N.º de historia:

.....

Fecha de exploración: Doctor:

.....

1. MOTIVO DE CONSULTA

En palabras del paciente:

«.....»

2. ANTECEDENTES RELEVANTES

Médicos: Dentales:

.....

3. HALLAZGOS CLÍNICOS [recuadro]

Estado general de salud oral:

.....

Hallazgos por sector / pieza:

.....

Periodontal:

.....

Oclusión y ATM:

.....

4. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS [recuadro]

CBCT:

.....

OPG:

.....

Nivel óseo / estructuras:

.....

5. DIAGNÓSTICO

Principal:

.....

Secundarios:

.....

Pronóstico: general por pieza

6. PLAN DE TRATAMIENTO PROPUESTO [recuadro]

Fase 1 – urgencias y preparación:

.....

Fase 2 – tratamiento principal:

.....

Fase 3 – estética y mantenimiento:

.....

Alternativas:

.....

Duración estimada: N.º de citas:

7. OBSERVACIONES Y ADVERTENCIAS

Factores que condicionan el pronóstico:

.....

Firma del Doctor: N.º de colegiado:

Fecha:

REGLAS DE REDACCIÓN

- **Objetivo, no comercial:** se describe lo que se observa; los adjetivos de venta no entran en un documento clínico
- **Sin promesas:** «pronóstico favorable» sí; «resultado garantizado» no
- **Trazable:** cada afirmación debe poder señalarse en una imagen o en la exploración
- **Comprensible:** término técnico seguido de su equivalente en lenguaje llano
- **Completo:** también se recoge lo que está sano, porque delimita el alcance del tratamiento
- **Coherente:** el IAC, la historia de Clinic Cloud y el presupuesto deben decir lo mismo

VALIDEZ, CUSTODIA Y ENTREGA

- ☐ **Original firmado** para el paciente
- ☐ **Copia digitalizada** en la ficha de Clinic Cloud el mismo día
- ☐ **Trazabilidad de versiones:** si el plan cambia, se emite un IAC nuevo fechado, sin destruir el anterior
- ☐ **Correcciones** antes de la firma; nunca tachaduras sobre un documento firmado
- ☐ **Conservación** conforme a la normativa de historia clínica aplicable

CASOS ESPECIALES

Hallazgo incidental grave

Se refleja en el IAC con su prioridad, se comunica el mismo día y se documenta la derivación y el receptor.

El paciente pide el informe para otra clínica

Se entrega sin reticencias: es su derecho y refuerza la credibilidad del centro.

Caso que requiere estudio adicional

El IAC recoge el diagnóstico provisional y la prueba pendiente; se cita para completarlo.

Plan modificado tras el presupuesto

Nuevo IAC fechado y firmado; el presupuesto siempre cuelga de un informe vigente.

Paciente que no acepta

Recibe igualmente su IAC. Es el documento que le acompañará si vuelve dentro de un año.

Menor de edad

El informe se entrega y se explica al tutor, con el menor presente cuando sea adecuado.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Firmar un IAC redactado por otra persona sin haberlo leído entero
- Copiar hallazgos de un caso anterior y dejar datos que no corresponden
- Incluir importes en el IAC: el informe es clínico, el presupuesto es otro documento
- Redactar en jerga cerrada, ilegible para el paciente y para cualquier revisor externo
- Entregarlo a Recepción al final del día, cuando el paciente ya se ha marchado

CRITERIO DE SALIDA

IAC completo, revisado, firmado y en manos de Recepción. La propuesta económica de la Fase 10 se construirá exclusivamente sobre este documento.

FASE 09 / 14

09

TIEMPO

15 minutos

RESPONSABLE

Doctor · Director

UBICACIÓN

Gabinete de explicación

REQUISITO PREVIO

Checklist de material verificado

KPI DE LA FASE

100 % de presentaciones con el checklist de material verificado antes de empezar

Presentación del diagnóstico 3D y del plan de tratamiento

Es el momento en que todo lo anterior se vuelve comprensible para el paciente. El objetivo no es impresionar con imágenes: es que la persona vea su propio caso, entienda qué le pasa, qué ocurrirá si no actúa y cómo se resuelve.

VERIFICACIÓN PREVIA · RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR

Antes de que el paciente entre, el Director comprueba en el equipo de presentación:

- ☐ **CBCT** cargado, abierto y navegable
- ☐ **OPG** visible y con calidad suficiente para proyectar
- ☐ **Fotografías extraorales**, serie completa
- ☐ **Fotografías intraorales**, serie completa
- ☐ **Capturas de cámara intraoral** de las zonas señaladas en la Fase 7
- ☐ **IAC** firmado, disponible en pantalla y en papel

POR QUÉ ESTO ES INNEGOCIABLE

Una presentación incompleta produce pérdida de credibilidad, sensación de improvisación, menor impacto de la evidencia y, en consecuencia, menor conversión. Si falta algo, se carga *antes* de empezar; nunca se improvisa delante del paciente.

PRESENTACIÓN VISUAL · DOCTOR

Empezar por el problema

- «Como puede ver en esta imagen 3D...», señalando la zona concreta
- Uso de zoom, cortes y herramientas de marcado
- Comparación con una referencia de anatomía sana

Demostrar con evidencia

- Apoyarse en las capturas intraorales: el paciente reconoce su propia boca
- Explicar en lenguaje llano, sin jerga innecesaria y sin infantilizar
- Nombrar lo que está bien, no solo lo que está mal: la credibilidad se construye siendo completo

Mostrar la evolución sin tratamiento

- «Si no intervenimos, lo previsible es que esto evolucione a...»
- Consecuencias en salud, función, estética y coste futuro
- Escenarios realistas, nunca alarmismo: la exageración se detecta y arruina la confianza

Relato clínico

- Situación, desarrollo y solución, en ese orden
- El paciente es el protagonista; el equipo, el medio
- Conectar explícitamente con las expectativas expresadas en la Fase 7, usando sus propias palabras

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA · DIRECTOR

Plan paso a paso

- Fase 1: urgencias y preparación
- Fase 2: tratamiento principal
- Fase 3: finalización estética y mantenimiento
- Tiempo total estimado y número aproximado de citas

Diferenciadores, con evidencia

- **Precisión tecnológica:** planificación digital 3D previa, márgenes de trabajo de décimas de milímetro, diseño del caso en ordenador antes de la primera intervención
- **Materiales:** proveedores y referencias concretas, con su documentación técnica disponible
- **Garantías:** años de garantía aplicables, condiciones de mantenimiento y seguimiento incluido

REGLA DE VERACIDAD

Marcas, tasas de éxito, años de garantía y porcentajes se comunican **solo si están respaldados por documentación del fabricante o por las condiciones contractuales vigentes de la clínica**. Dirección mantiene actualizada la ficha de datos verificables; ningún profesional improvisa cifras. Un dato inexacto compromete legalmente a la clínica.

Preguntas y dudas

- Responder con claridad y sin evasivas, también a las preguntas incómodas
- Ser explícito sobre riesgos, limitaciones y lo que el tratamiento no puede conseguir
- Si algo requiere consulta o segunda valoración, decirlo y comprometerse a una fecha

CRONOLOGÍA DE LA PRESENTACIÓN

-5 min Verificación del material y de la sala por parte del Director.	0:00 – 2:00 Recapitulación: lo que el paciente contó, con sus propias palabras.	2:00 – 7:00 Evidencia: CBCT, OPG e imágenes intraorales, de lo general a lo concreto.	7:00 – 11:00 Plan de tratamiento por fases, tiempos y número de citas.
11:00 – 15:00 Preguntas, dudas y comprobación de que se ha entendido.			

GUIÓN DE LA PRESENTACIÓN

1. RECAPITULAR

«Usted vino porque [motivo con sus palabras] y me dijo que lo que más le afecta es [prioridad]. Vamos a ver qué hemos encontrado.»

2. EMPEZAR POR LO SANO

«Antes de nada: esto de aquí está bien, y esto también. No hay que tocarlo.»

3. MOSTRAR EL PROBLEMA

«Mire esta imagen. Aquí debería verse [referencia normal] y en su caso vemos [hallazgo]. Se lo enseño también en la foto de su boca.»

4. EXPLICAR LA CAUSA

«Esto ocurre porque [mecanismo], y por eso usted nota [síntoma].»

5. PROYECTAR SIN TRATAMIENTO

«Si no hacemos nada, lo previsible es [evolución realista], y entonces la solución sería [más compleja y más cara].»

6. PRESENTAR LA SOLUCIÓN

«El plan tiene tres fases: [1], [2] y [3]. En total, [tiempo] y [n.º] citas.»

7. CERRAR EL CÍRCULO

«Volviendo a lo que usted me dijo al principio: esto le devuelve [criterio de éxito del paciente].»

8. COMPROBAR

«¿Me lo puede resumir usted con sus palabras, para asegurarme de que lo he explicado bien?»

PUESTA EN ESCENA

- Paciente y acompañante sentados frente a la pantalla, nunca de lado
- El profesional se sienta junto al paciente, no enfrente: se mira juntos la imagen, no se le interroga
- Puntero o marcado en pantalla; señalar con el dedo sobre el monitor distrae y ensucia
- Una imagen por idea: navegar sin rumbo entre cortes agota la atención
- Ritmo lento y pausas: el silencio después de una evidencia hace más que un argumento

- Móviles en silencio, puerta cerrada, sin interrupciones del equipo salvo urgencia real

QUÉ DECIR Y QUÉ EVITAR

DIGA

- «Se lo enseñó y me dice si lo ve tan claro como yo.»
- «Esto es lo que hay que tratar sí o sí; esto otro es opcional y puede esperar.»
- «Hay una alternativa más sencilla; le explico qué gana y qué pierde con ella.»
- «¿Qué duda le queda? Prefiero resolverla ahora que dentro de un mes.»

EVITE

- «Si no se trata ya, va a perder todos los dientes.»
- Acumular hallazgos sin jerarquía hasta abrumar al paciente.
- Hablar diez minutos seguidos sin preguntar nada.
- Desacreditar el trabajo de otros profesionales.
- Mezclar el precio con el diagnóstico: cada cosa en su fase.

CASOS ESPECIALES

El paciente se bloquea

Se para, se resume en tres frases y se le ofrece continuar otro día con la documentación en la mano.

Discute el diagnóstico

Se agradece la pregunta y se vuelve a la imagen. La evidencia no se defiende: se enseña otra vez.

Plan muy extenso

Se presenta por fases y se acuerda empezar por lo urgente, sin exigir una decisión sobre el conjunto.

Acompañante escéptico

Se le implica de forma explícita y se le muestran las mismas imágenes: será quien opine en el coche de vuelta.

Trae un presupuesto de otro centro

Se compara alcance y contenido, nunca cifras sueltas: qué incluye cada plan, con qué materiales y qué garantía.

Barrera idiomática

Presentación más visual, frases cortas y comprobación frecuente de comprensión.

Las imágenes estáticas no explican: el paciente asiente sin entender. La navegación funciona cuando los papeles están repartidos: **el Doctor narra e indica, el Director opera la pantalla. Nunca los dos a la vez.**

DOCTOR		DIRECTOR
"Vamos a ver su caso"	→	abre el modelo
"Gíralo hacia la derecha"	→	gira
"Amplía esta zona"	→	amplía
"Enséñale el corte"	→	secciona
"Ahora la comparativa"	→	abre lado a lado

GUIÓN · DOCTOR

«[Nombre], esto es su boca en tres dimensiones, la que le hicimos hace un rato. Aquí está el problema principal. Le doy la vuelta para que lo vea mejor. ¿Ve esta zona más oscura? Ahí es donde falta hueso. Y esto amarillo es el nervio: por eso hay que planificarlo con precisión milimétrica. Y ahora compare con esta zona de aquí, que está sana. La diferencia se ve, ¿verdad?»

Requisito: ensayo previo. La primera vez que se usa delante de un paciente no puede ser la primera vez que se usa.

MOstrar LA PROGRESIÓN SIN TRATAMIENTO

INNOVACIÓN · FICHA
13

La consecuencia de no tratar, descrita solo con palabras, no se comprende y el paciente pospone. Métodos disponibles: comparación con casos de referencia en estadio avanzado, proyección sobre su propia imagen, comparativa temporal si hay registros previos y secuencias de casos reales anonimizados.

REGLA ÉTICA INNEGOCIABLE

Se proyecta lo clínicamente esperable, nunca el peor escenario posible para presionar. La exageración se detecta, destruye la confianza y expone al centro.

GUIÓN · DOCTOR

«Le voy a enseñar algo que quiero que entienda bien. Esto es su situación hoy. Y esto de aquí es un caso en un estadio más avanzado del mismo proceso —no es usted, es una referencia—. Con su perfil de riesgo, si no intervenimos, esto es lo esperable en unos años. No se lo digo para asustarle: se lo digo para que tenga toda la información antes de decidir.»

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Empezar por el problema sin recapitular lo que el paciente contó
- Presentar el plan sin haber comprobado que se entendió el diagnóstico
- Usar el CBCT como espectáculo técnico en lugar de como prueba comprensible

- Recurrir al miedo: sube la conversión inmediata y hunde la confianza a medio plazo
- Terminar sin preguntar qué duda queda, y descubrirla en la llamada de seguimiento

CRITERIO DE SALIDA

El paciente puede explicar con sus palabras qué le ocurre y qué se propone hacer. Si no puede, la presentación no ha terminado.

FASE 10 / 14

10

TIEMPO

20 minutos

RESPONSABLE

Director / Asesor

UBICACIÓN

Despacho

SALIDA

Estado de la PV registrado en Clinic Cloud

KPI DE LA FASE

Tasa de conversión de la PV · ticket medio aceptado frente al presentado

Propuesta económica de valor y cierre

El presupuesto no se presenta como un precio, sino como la consecuencia lógica de un diagnóstico que el paciente ya ha entendido y aceptado. Todo lo dicho aquí debe poder rastrearse hasta el IAC firmado en la Fase 8.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

a) Anclaje en el diagnóstico

- «Como ha visto en el análisis del Doctor...»
- «Partiendo de las pruebas 3D que le hemos realizado hoy...»
- «El diagnóstico preciso permite proponerle exactamente lo que necesita, ni más ni menos»

b) Tecnología y medios

- Equipamiento diagnóstico: CBCT, escáner intraoral, fotografía clínica
- Materiales seleccionados por caso, con su trazabilidad
- Software de planificación digital
- Laboratorio de confianza y comunicación directa con el técnico

c) Horizonte largo

- «No resolvemos el problema de hoy: aseguramos su salud dental durante décadas»
- «Las garantías respaldan por escrito la durabilidad del tratamiento»
- Coste de no tratar, en salud y en dinero futuro

d) Desglose

- Presupuesto línea a línea, tratamiento por tratamiento
- Explicación del porqué de cada partida
- Documento timbrado, con validez temporal indicada
- Calculadora a mano para simular escenarios en vivo

FINANCIACIÓN

- **Pago anticipado** — con bonificación aplicable
- **Financiación a interés 0 %** — plazos disponibles según entidad
- **Financiación con interés** — plazos más largos, cuota menor
- **Tratamiento por fases** — último recurso, cuando el plan lo permite clínicamente
- Entidades colaboradoras y condiciones vigentes

CÁLCULO PERSONALIZADO · DIRECTOR

«Si lo financiamos a X meses, su cuota sería de Y euros al mes. Vamos a verlo con números concretos sobre su caso, no en abstracto.»

Toda simulación se hace delante del paciente y por escrito. La TAE, el importe total y el número de cuotas se dicen siempre en voz alta: la transparencia financiera evita bajas y reclamaciones posteriores.

CIERRE PROFESIONAL

- **Cierre por alternativa:** «¿Prefiere comenzar con el plan completo o por fases?»
- **Cierre por disponibilidad:** «Tenemos hueco esta misma semana; cuanto antes empecemos, antes lo resolvemos»
- **Cierre por asunción:** «¿Qué día de la semana le viene mejor para la primera cita?»

Manejo de objeciones

- **«Es muy caro»** — separar precio de valor, desglosar, ofrecer financiación real
- **«Necesito pensarlo»** — preguntar qué exactamente necesita pensar y resolver esa duda concreta
- **«Quiero consultarlo»** — proponer incluir a esa persona en una llamada o en una segunda cita
- **«Voy a comparar»** — invitar a comparar con criterio: qué pruebas incluye, qué materiales, qué garantía por escrito

LÍMITE ÉTICO DEL CIERRE

Se guía la decisión; no se presiona. Nunca se usan urgencias clínicas inexistentes, ofertas que caducan artificialmente ni insistencia tras una negativa clara. El paciente tiene derecho a irse con su IAC, su OPG y sus fotografías, aunque no acepte. Un cierre forzado genera abandono de tratamiento, reclamación y reseña negativa: cuesta más de lo que aporta.

ATC · EL CIERRE NO TERMINA EN EL PRESUPUESTO

ALMA TE
CUIDA

Un tratamiento aceptado sin seguimiento es media promesa. Por eso, **justo después del sí**, el Director ofrece la tarjeta **Alma Te Cuida**: es el instrumento que protege lo que el paciente acaba de decidir, y forma parte del cierre, no de una conversación aparte.

GUIÓN · JUSTO TRAS LA ACEPTACIÓN

«Me alegro mucho de que vayamos a resolver esto, [nombre]. Y precisamente por eso quiero contarle lo de la tarjeta Alma Te Cuida. Ya que va a hacer este tratamiento, con ATC protege su inversión: incluye las revisiones de seguimiento, el mantenimiento y la garantía. Es lo que hace que lo que hoy hacemos bien, dure bien. Son 95 € al año, cubre a cuatro personas de su familia, e incluye la limpieza, las revisiones y las urgencias de todos. ¿Se la añado y así ya se queda todo el seguimiento cubierto?»

Si el paciente **no** ha aceptado el tratamiento, ATC se ofrece igualmente: es la forma de que la relación siga viva y de que vuelva a cuidarse aunque hoy no haya decidido. La estructura del ofrecimiento es siempre la misma: qué incluye, cuánto ahorra, a quién más cubre y una pregunta suave para cerrar.

OBJECCIÓN	CLAVE DE LA RESPUESTA
«Me lo pienso»	Sin permanencia; se activa hoy y se disfruta ya
«Es caro»	Es ahorro, no gasto: la limpieza y las revisiones ya lo cubren
«No vengo casi al dentista»	Por eso: nosotros avisamos cuando toca, y la usa su familia
«Ya tengo seguro dental»	No es un seguro: complementa y no se solapa
«Os digo algo»	Información por escrito, activación sin compromiso y registro como pendiente

Una objeción no es un rechazo: es una duda sin resolver. Si tras resolverla el paciente sigue diciendo que no, se acepta con naturalidad y se le vuelve a ofrecer en la siguiente visita. Nunca se presiona. El programa completo —argumentos, speech por situación, campaña y marco legal— está en **Otros · ATC**.

REGISTRO DE CONVERSIÓN · CLINIC CLOUD

CAMPO	OBLIGATORIO	DETALLE
Estado de la PV	Sí	Convertida / No convertida / Pendiente de decisión
Presupuesto presentado	Sí	Importe total propuesto
Presupuesto aceptado	Sí	Importe efectivamente aceptado
Método de pago	Sí	Contado / Financiación / Por fases
Fecha de inicio	Si aplica	Fecha de la primera cita de tratamiento
Motivo de no conversión	Si aplica	Precio · Necesita pensarlo · Consulta familiar · Segunda opinión · Miedo · Timing
Estado ATC	Sí	Activada · Pendiente (se le vuelve a ofrecer en la siguiente visita) · Rechazada
Observaciones	Recomendado	Contexto útil para el seguimiento posterior

CRONOLOGÍA DEL CIERRE

0:00 – 3:00 Recapitulación del plan aprobado clínicamente y del criterio de éxito del paciente.	3:00 – 8:00 Presupuesto línea a línea, con justificación de cada partida.	8:00 – 13:00 Opciones de pago y simulación de cuotas en vivo.	13:00 – 18:00 Preguntas, objeciones y ajuste de la propuesta.
18:00 – 20:00 Decisión, firma o acuerdo de seguimiento, y registro en Clinic Cloud.			

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE TRATAMIENTO

N.º Fecha:

Paciente: Historia:

Basado en el IAC de fecha firmado por Dr./Dra.

FASE 1 – Urgencias y preparación

Concepto Piezas Uds Importe

FASE 2 – Tratamiento principal

Concepto Piezas Uds Importe

FASE 3 – Estética y mantenimiento

Concepto Piezas Uds Importe

Subtotal Bonificación por pago anticipado TOTAL

INCLUYE: planificación digital, materiales, laboratorio, revisiones del plan y seguimiento durante el tratamiento.

NO INCLUYE: tratamientos no descritos, complicaciones ajenas al plan, mantenimientos posteriores al alta.

GARANTÍA: según condiciones vigentes entregadas por escrito.

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: días.

Firma de aceptación del paciente Fecha

Un presupuesto sin apartado de exclusiones genera conflictos más adelante. Lo que no está escrito, el paciente lo da por incluido, y con razón.

FINANCIACIÓN · OPERATIVA

PASO	QUÉ SE HACE	DOCUMENTACIÓN
1	Simulación de cuota delante del paciente, con importe total y número de plazos	Impresión o pantalla de la simulación
2	Información precontractual: importe financiado, plazos, intereses y coste total	Documento de la entidad
3	Solicitud con los datos del titular	DNI, justificante de ingresos según entidad
4	Respuesta de la entidad	Aprobación o denegación registrada en Clinic Cloud
5	Firma del contrato y calendario de pagos	Copia al paciente y copia digitalizada

PASO	QUÉ SE HACE	DOCUMENTACIÓN
6	Vinculación del calendario de pagos al calendario clínico	Agenda de tratamiento

- El coste total y el número de cuotas se dicen siempre en voz alta, aunque el paciente solo pregunte por la mensualidad
- Ninguna condición financiera se promete antes de la respuesta de la entidad
- Si se deniega, se ofrece alternativa el mismo día: plan por fases, otra entidad o aplazamiento acordado
- La firma de financiación nunca se plantea como requisito para recibir el diagnóstico

OBJECIONES · QUÉ SIGNIFICAN REALMENTE

LO QUE DICE	LO QUE SUELE SIGNIFICAR	RESPUESTA	ERROR A EVITAR
«Es muy caro»	No ve la relación entre lo que cuesta y lo que recibe	Volver al desglose y al alcance; ofrecer fases o financiación	Bajar el precio de inmediato: invalida el valor presentado
«Necesito pensarlo»	Queda una duda concreta sin resolver	«¿Qué parte concretamente quiere pensar?» y resolver esa	Aceptar la frase sin explorarla
«Tengo que consultarlo»	La decisión es compartida	Ofrecer llamada conjunta o segunda cita con esa persona	Presionar para decidir sin quien decide
«Voy a comparar»	No sabe en qué se diferencian los presupuestos	Dar criterios de comparación por escrito: alcance, materiales, garantía, pruebas incluidas	Criticar a la competencia
«Me lo pensaré para más adelante»	No percibe urgencia o teme el tratamiento	Explicar qué se agrava con el tiempo y qué no; acordar revisión	Inventar una urgencia que no existe
«¿No hay algo más sencillo?»	Busca una entrada más asumible	Presentar la alternativa real con sus límites, por escrito	Improvisar un plan B no validado por el Doctor
«Me da miedo»	Experiencia previa o anticipación del dolor	Sedación consciente, citas cortas, acompañamiento, testimonios	Restar importancia al miedo
Silencio	Está calculando o abrumado	Callar y esperar; luego preguntar qué le ronda	Llenar el silencio con más argumentos

SEÑALES DE DECISIÓN

Señales de que quiere avanzar

- Pregunta por fechas, duración o bajas laborales
- Pregunta por cuidados posteriores o por comer
- Se dirige al acompañante buscando confirmación
- Repite en voz alta la cuota mensual
- Pregunta quién realizará el tratamiento

Señales de que aún no

- Vuelve una y otra vez al importe total sin escuchar la respuesta
- Consulta el móvil de forma reiterada
- Responde con monosílabos tras haber conversado con soltura
- Pide documentación «para llevársela» sin más preguntas
- Menciona a alguien ausente por primera vez

Ante señales de que aún no, el objetivo deja de ser cerrar hoy y pasa a ser cerrar bien: acordar el siguiente paso con fecha y dejarlo registrado.

CASOS ESPECIALES

Financiación denegada

Se comunica con discreción y sin juicio, y se ofrece alternativa el mismo día.

Seguro dental

Se comprueba cobertura real y se presenta el presupuesto completo, indicando qué parte cubre la póliza.

Paga un tercero

El titular del pago firma; el paciente sigue siendo el titular de la información clínica.

Quiere empezar por lo urgente

Se acepta y se documenta el plan completo, con revisión de las fases pendientes en fecha acordada.

Regatea el precio

No se negocian tarifas; se negocia alcance, secuencia y forma de pago.

Acepta y luego se arrepiente

Se respeta el desistimiento, se documenta y se mantiene la relación abierta sin reproches.

FRACCIONAR EL PAGO NO ES
FRACCIONAR EL ALCANCE

POSICIONAMIENTO

Cuando el importe aprieta, la salida es siempre la misma: se ajusta **cómo se paga** y **en qué orden se ejecuta**, nunca *qué* se va a resolver. El plan que se presenta es el completo, aunque se acuerde hacerlo en etapas.

LEGÍTIMO Y RECOMENDABLE

- Pagar por fases, con el plan completo presentado y aceptado
- Empezar por la fase clínicamente prioritaria y continuar cuando el paciente decida
- Financiar el tratamiento para hacerlo asumible
- Dejar por escrito qué fases quedan pendientes y en qué orden

LO QUE EL POSICIONAMIENTO PROHÍBE

- Reducir el plan «para que entre» y callar el resto del diagnóstico
- Vender un tratamiento parcial sabiendo que necesita más, sin explicárselo
- Alargar por fases lo que puede resolverse en menos tiempo
- Dejar el caso clínicamente a medias, sin fecha ni seguimiento

Un plan aceptado con fases pendientes que nadie persigue es producto pendiente, y el producto pendiente es una media sonrisa sin cerrar. Por eso toda fase no ejecutada sale de esta visita con fecha o con tarea asignada.

POLÍTICA DE DESCUENTOS

DECISIÓN 7

El descuento es la última herramienta del cierre, nunca la primera. Antes de aplicarlo hay que entender lo que cuesta de verdad: un descuento no reduce la facturación en el porcentaje que se aplica, reduce el beneficio en mucho más.

DESCUENTO	PRECIO FINAL	COSTES	BENEFICIO	BENEFICIO PERDIDO
Sin descuento	100	60	40	—
5 %	95	60	35	12,5 %
10 %	90	60	30	25 %
15 %	85	60	25	37,5 %
20 %	80	60	20	50 %

Ejemplo sobre un caso de 100 con un margen del 40 %. Un descuento del 10 % no cuesta el 10 %: cuesta la cuarta parte del beneficio de ese paciente. Para compensarlo hay que vender más volumen, y la cuenta es exacta: **volumen adicional necesario = Descuento / (Margen – Descuento)**. Con margen del 40 % y descuento del 10 %, hace falta un 33 % más de casos para ganar lo mismo.

La secuencia correcta ante «es muy caro»

1 · Valor Reencuadrar el tratamiento como inversión en salud, no como gasto: volver al diagnóstico, al alcance y a lo que incluye el presupuesto.	2 · Facilidades Financiación y cuota mensual, simuladas delante del paciente y por escrito.	3 · Fases Plantear el tratamiento por etapas, siempre que el plan lo permita clínicamente.	4 · Descuento Solo entonces, si procede: dentro de tabla, con autorización identificable y registrado en el presupuesto firmado.
---	---	--	--

El descuento nunca es el paso 1. Si lo es, se le acaba de confirmar al paciente que el precio estaba inflado.

Tipología cerrada de descuentos

TIPO	RANGO ORIENTATIVO	QUÉ PIDE A CAMBIO	AUTORIZA	ACUMULABLE
Pronto pago / pago anticipado	5–8 %	Cobro íntegro por adelantado: mejora la tesorería y elimina el riesgo de impago	Director	Sí, con el familiar
Familiar	5–10 %	Varios miembros de la misma unidad familiar en tratamiento	Director	Sí, con el de pronto pago
Tratamiento combinado	5–10 %	Aceptación del plan completo, no de una fase suelta	Director	No
Paciente referido	Importe fijo o %	Trae un paciente nuevo: es el descuento más rentable que existe, porque sustituye coste de captación	Director	No
Casos sociales	Caso por caso	Situación acreditada y valorada individualmente	Gerencia	—
Personal y familiares directos	Según condiciones internas	Vínculo laboral acreditado	Gerencia	—

Los porcentajes definitivos los fija Gerencia sobre los márgenes reales del centro, usando la tabla anterior antes de decidir. Límite absoluto de acumulación recomendado: 15 %. Fuera de tabla, siempre Gerencia. PUNTO ABIERTO

Reglas de aplicación

- Todo descuento se registra en Clinic Cloud con su motivo
- Todo descuento consta en el presupuesto firmado
- Todo descuento tiene una autorización identificable
- Ningún descuento se comunica antes de haber presentado el valor
- Ningún descuento es la primera respuesta a una objeción de precio
- Lo que está en la tabla se aplica; lo que no está, se consulta

Descuentos que no existen

- **Por negociación** — enseña al paciente que el precio es negociable
- **Por «cerrar hoy»** — presión comercial de bajo nivel
- **Por igualar a la competencia** — compite en el terreno equivocado
- **Verbal y sin registro** — imposible de controlar y de auditar
- **Acumulable sin límite** — descontrola el margen del caso
- **Decidido por quien no tiene autoridad** — rompe el sistema entero

EL DESCUENTO ENCUBIERTO: LA FINANCIACIÓN AL 0 %

La financiación sin intereses para el paciente no es gratis para el centro: la entidad cobra una comisión que asume la clínica, y eso es un descuento aunque no se llame así. Se contabiliza como una partida más de la tabla y se ofrece únicamente hasta el plazo en el que ese coste siga siendo inferior al descuento máximo autorizado. No contabilizarlo es la forma más habitual de ver desaparecer el margen sin explicación.

Esta política protege también al equipo: nadie tiene que negociar precios bajo presión, porque hay una tabla con porcentajes y motivos concretos. El desarrollo completo, con la plantilla de decisión de Gerencia, está en Otros documentos del sistema.

Ver la Decisión 7

LOS TRES ESCENARIOS
COMPARADOS

INNOVACIÓN · FICHA
14

Presentado como cifra única, el presupuesto se compara con cero, y cero siempre gana. Con tres escenarios el paciente compara entre opciones reales, incluida la de no tratarse.

ESCENARIO	QUÉ SE LE ENTREGA
A · Plan completo	Tratamiento integral, tiempo total, importe y cuota
B · Por fases	Secuencia, tiempos, importes parciales y cuotas
C · Sin tratamiento	Evolución esperable y coste futuro estimado

GUIÓN · DIRECTOR

«Le presento tres escenarios para que decida con toda la información. El primero es el plan completo: [detalle]. Son [importe], o [cuota] al mes a [X] meses. El segundo es por fases: empezamos por [fase prioritaria], que son [importe], y las siguientes cuando usted decida. Y el tercero es no hacer nada, que también es una opción legítima. Lo que pasa es que con su perfil, en unos años lo esperable es [proyección], y entonces el tratamiento sería más complejo. No le estoy presionando: le estoy dando la información completa para que decida usted.»

El escenario C es el que casi nadie muestra y el que más convierte, siempre que se presente como información y nunca como amenaza. Se apoya en el perfil de riesgo registrado en la Fase 7.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Presentar el importe total sin haber recapitulado el plan clínico
- Entregar el presupuesto en papel y callarse mientras el paciente lo lee solo
- Ofrecer descuento antes de que exista objeción de precio
- Prometer condiciones de financiación sin aprobación de la entidad
- Cerrar la visita sin registrar el motivo real de no conversión

CRITERIO DE SALIDA

El estado de la PV está cerrado en Clinic Cloud con importes y motivo. Un «no convertido» sin motivo registrado es un caso perdido: sin él, la Fase 12 no puede diseñar seguimiento alguno. Y **ninguna visita se cierra sin que se haya ofrecido ATC al menos una vez**, con su estado registrado.

FASE 11 / 14

11

TIEMPO

5–10 minutos

RESPONSABLE

Recepción

UBICACIÓN

Recepción

PLAZO

Mismo día, sin excepción

KPI DE LA FASE

100 % de la documentación escaneada y subida el mismo día

Cierre administrativo, planificación y digitalización documental

La visita termina en Recepción, acepte o no acepte el paciente. Aquí se formaliza el compromiso, se programa lo siguiente y se completa la trazabilidad legal de todo lo firmado durante la visita.

ENTREGA Y AGENDA

Con independencia de que se acepte el presupuesto, **todo paciente sale con la carpeta Alma**: libro de la clínica, presupuesto, OPG y fotografías. Nadie se va con las manos vacías; llevarse su diagnóstico es parte del servicio prometido.

Si el paciente acepta

- Firma de aceptación del presupuesto ante el Director y entrega a Recepción
- Aceptación del presupuesto en Clinic Cloud por parte del Director
- Programación de la siguiente cita, con confirmación de fecha y hora
- Instrucciones previas si proceden: ayuno, medicación, acompañante
- Entrega de la documentación del plan de tratamiento

Si el paciente no acepta

- Agradecer el tiempo y la confianza, sin cambio de trato
- Dejar la puerta abierta de forma explícita
- Programar en el sistema la fecha de seguimiento acordada en la Fase 12

DIGITALIZACIÓN · PASO CRÍTICO FINAL

Recepción escanea y sube a la ficha de Clinic Cloud toda la documentación firmada, garantizando la trazabilidad clínica y legal:

☐ **Hoja de datos personales** — firmada por el paciente

☐ **Consentimiento RGPD** — firmado y fechado

☐ **Consentimiento de uso de imágenes** — si se ha firmado

- ☐ **Anamnesis médica** — completa, con todas las páginas
- ☐ **Consentimiento de pruebas radiológicas** — firmado
- ☐ **IAC** — firmado por el Doctor
- ☐ **Solicitud de presupuesto** — firmada por el Doctor
- ☐ **Presupuesto aceptado** — si aplica, con firma de aceptación
- ☐ **Documentación de financiación o transferencia** — si se ha contratado, según disponibilidad de la entidad

Estos son los nueve documentos que genera la primera visita. El consentimiento quirúrgico, el checklist quirúrgico y el registro de trazabilidad de implantes pertenecen a la Fase 13 y se digitalizan en ella.

CRÍTICO · RECEPCIÓN

Este paso no puede quedar pendiente: la subida se completa **el mismo día**.
Un documento firmado que no está digitalizado equivale, ante una reclamación, a un documento que no existe.

CRONOLOGÍA DEL CIERRE ADMINISTRATIVO

0:00 – 1:30 Entrega de la carpeta Alma y repaso de su contenido.	1:30 – 3:00 Programación de la siguiente cita o de la tarea de seguimiento.	3:00 – 4:00 Instrucciones previas y confirmación de canal de contacto.	4:00 – 5:00 Escaneo y subida de la documentación firmada.
---	--	---	--

CONTENIDO EXACTO DE LA CARPETA ALMA

- ☐ **Libro Alma** — presentación del centro, equipo y tecnología
- ☐ **Copia del IAC** firmado por el Doctor
- ☐ **Presupuesto** detallado, con validez y exclusiones
- ☐ **Impresión de la OPG**
- ☐ **Selección de fotografías** clínicas relevantes
- ☐ **Condiciones de garantía** por escrito
- ☐ **Tarjeta de contacto directo** con teléfono y WhatsApp
- ☐ **Instrucciones previas** si ya hay cita de tratamiento

INSTRUCCIONES PREVIAS SEGÚN EL TRATAMIENTO

TIPO DE CITA	QUÉ SE INDICA AL PACIENTE	AVISO ADICIONAL
Cirugía o implantes	Comer antes salvo indicación contraria, medicación pautada, acudir acompañado, ropa cómoda	Prever reposo el resto del día
Sedación consciente	Ayuno según pauta, acompañante obligatorio, no conducir	Confirmación telefónica 24 h antes

TIPO DE CITA	QUÉ SE INDICA AL PACIENTE	AVISO ADICIONAL
Endodoncia	Prever una a dos horas de sillón, analgesia previa si hay dolor	Posible sensibilidad posterior
Periodoncia	Higiene reforzada los días previos	Sensibilidad transitoria tras el raspado
Prótesis y estética	Traer fotografías de referencia si las tiene	Prever pruebas intermedias
Ortodoncia	Higiene y registros previos	Calendario de revisiones

DIGITALIZACIÓN · NOMENCLATURA Y CONTROL

Formato: AAAAMDD_Apellido-Nombre_DOCUMENTO

20260318_Perez-Ana_DATOS-PERSONALES

20260318_Perez-Ana_RGPD

20260318_Perez-Ana_ANAMNESIS

20260318_Perez-Ana_CONS-RADIOLOGICO

20260318_Perez-Ana_IAC

20260318_Perez-Ana_PRESUPUESTO-ACEPTADO

20260318_Perez-Ana_FINANCIACION

- Escaneo en color, legible, sin páginas giradas ni recortadas
- Todas las páginas del documento, incluidas las que solo llevan firma
- Comprobación de que el archivo abre correctamente antes de archivar el papel
- Original en papel al archivo físico según el circuito del centro
- Cierre de jornada: repaso de las PV del día contra la tabla de trazabilidad

CASOS ESPECIALES

Se marcha sin firmar Se entrega igualmente la carpeta y se registra el estado como pendiente de decisión, con fecha de seguimiento.
Financiación en trámite Se programa la cita de forma provisional y se documenta la condición; la subida del contrato se completa al recibirlo.
Documento olvidado por el paciente Se digitaliza lo firmado, se anota lo pendiente y se acuerda cómo se completará.
Cita urgente el mismo día Prioridad clínica; la digitalización se completa igualmente antes del cierre de la jornada.
Escáner averiado

Captura con dispositivo autorizado del centro y subida inmediata; nunca desde un móvil personal.

Paciente que pide todo en digital

Se envía por el canal verificado en la Fase 3 y se registra el envío.

ALTA DE ATC · QUÉ SE FIRMA Y QUÉ SE ENTREGA

ALMA TE
CUIDA

Si el paciente ha dicho que sí a la tarjeta, se activa aquí mismo, sin dejarlo para otro día. La activación tiene tres piezas, y las tres se entregan y se digitalizan como el resto de la documentación.

1 · Información precontractual Se entrega antes de firmar: qué es —un programa de cuidado, no un seguro—, quién lo presta, precio, qué incluye, descuentos, duración, desistimiento y exclusiones. Recepción verifica que ha podido leerla y resolver dudas.	2 · Contrato de adhesión Datos del titular y de los beneficiarios, precio, vigencia de doce meses y renovación voluntaria sin permanencia.	3 · Cláusula RGPD Con sus consentimientos marcados: gestión del programa, comunicaciones comerciales y declaración de contar con el consentimiento de los beneficiarios designados.
--	---	--

- Fecha de alta y fecha de vencimiento anotadas en la ficha y en el panel de control del programa
- Beneficiarios identificados: hasta tres personas además del titular
- Derecho de desistimiento de catorce días explicado en voz alta, no solo escrito
- Si dijo «me lo pienso», se registra como **ATC pendiente** antes de que salga

El contrato es una plantilla pendiente de validación jurídica: no se comercializa hasta que la asesoría lo revise y Dirección cierre precio, límites y descuentos.

PUNTO ABIERTO

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Dejar la digitalización para el día siguiente
- Escanear el IAC sin la firma del Doctor
- Entregar la carpeta incompleta cuando el paciente no ha aceptado
- Programar la cita sin dar instrucciones previas
- No comprobar que el archivo subido corresponde a la ficha correcta

CRITERIO DE SALIDA

Los nueve documentos están en la ficha, la siguiente cita está en agenda (o la tarea de seguimiento creada) y la carpeta Alma está en manos del paciente.

FASE 12 / 14

12

TIEMPO

2 minutos + post-visita

RESPONSABLE

Director · Recepción · Marketing

UBICACIÓN

Salida de clínica · Clinic Cloud

HORIZONTE

180 días

KPI DE LA FASE

100 % de no convertidos con tarea de re-contacto activa · tasa de recuperación a 90 días

Despedida y seguimiento estratégico

La visita acaba en la puerta; la relación, no. Más de la mitad de las conversiones de un centro maduro proceden de pacientes que no aceptaron el primer día y fueron atendidos bien después.

DESPEDIDA

- Acompañamiento personal hasta la salida
- Entrega de detalle de la clínica: kit de higiene, tarjeta de agradecimiento personalizada, material informativo
- Agradecimiento por la confianza
- Recordatorio de la próxima cita, si la hay
- Canal directo disponible para dudas: teléfono y WhatsApp

MENSAJE DE DESPEDIDA

«Ha sido un placer atenderle. Nos alegra mucho poder ayudarle a conseguir la sonrisa que merece. Cualquier duda que le surja, escríbanos o llámenos: estaremos encantados de resolverla.»

LLAMADA DE CORTESÍA · 24-48 H

Pacientes convertidos

- Agradecer de nuevo la confianza
- Confirmar la cita programada
- Resolver dudas surgidas al llegar a casa
- Recordar instrucciones previas
- Reforzar positivamente la decisión

Pacientes no convertidos

- Llamada amable, sin presión ni segunda venta

- Preguntar si quedó alguna duda
- Ofrecer disponibilidad para volver cuando lo necesite
- Detectar la objeción real, que rara vez es la primera que se dijo
- Registrar en Clinic Cloud lo que se descubra

GUIÓN SUGERIDO

«Buenos días, [Nombre]. Le llamamos del Centro Alma para agradecerle su visita y asegurarnos de que todo quedó claro. ¿Le ha surgido alguna duda sobre el plan de tratamiento que le presentamos?»

NURTURING DE NO CONVERTIDOS

Director de Centros y Director de clínica diseñan la estrategia caso a caso, partiendo del motivo real de no conversión.

OBJECCIÓN	QUÉ SE ENVÍA	ACCIÓN DEL DIRECTOR
Económica	Condiciones de financiación ampliada, 0 % a plazos, opción por fases, promoción vigente	Llamada con propuesta concreta y cuota calculada
Necesita pensarlo	Casos antes/después equivalentes, testimonios, vídeo explicativo del tratamiento, literatura sobre la técnica	Envío + llamada al día siguiente
Miedo	Información sobre sedación consciente, vídeo del proceso en clínica, testimonios de pacientes con odontofobia	Ofrecer visita acompañado, sin compromiso
Segunda opinión	Documentación diagnóstica completa para que la lleve consigo	Respetar la decisión, seguimiento suave y disponibilidad
Timing personal	Recordatorio en la fecha que el propio paciente indique	Tarea programada a fecha acordada

CADENCIA DE RE-CONTACTO

MOMENTO	ACCIÓN	CANAL	RESPONSABLE
Día 1-2	Llamada de cortesía	Teléfono	Recepción / Director
Día 7	Primer seguimiento según la objeción registrada	Llamada o WhatsApp	Director
Día 15	Segundo seguimiento con propuesta ajustada	Llamada	Director
Día 30	Contenido de valor personalizado	Email	Marketing
Día 60	Condición especial o nueva propuesta	Llamada	Director
Día 90	Check-in de cortesía	WhatsApp	Recepción
Día 180	Campaña de reactivación	Email + llamada	Marketing + Director

La cadencia se detiene de inmediato si el paciente pide no ser contactado. Esa petición se registra en Clinic Cloud y se respeta en todos los canales, sin excepción.

PROGRAMACIÓN EN CLINIC CLOUD · RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR

Cada tarea de re-contacto incluye

- Responsable asignado
- Fecha concreta
- Canal previsto
- Objetivo del contacto y contenido a enviar

Ejemplos

- **Objeción económica** — «Llamada para propuesta de financiación 0 % a 12 meses» · día 7 · Director
- **Necesita pensarlo** — «Envío de caso equivalente + llamada de seguimiento» · día 3 · Director
- **Revisión de objeciones** — «Nueva propuesta ajustada al feedback» · día 15 · Director
- **Estacional** — «Reactivación de campaña con condiciones mejoradas» · día 60 · Marketing

Cada interacción se registra: respuesta del paciente, estado actualizado y ajuste de la estrategia. Un seguimiento no registrado se repite o se olvida; ambas cosas restan.

FIDELIZACIÓN DE PACIENTES CONVERTIDOS

- **Día 1 — email de bienvenida:** agradecimiento, resumen del plan, confirmación de cita y contactos del equipo
- **48 h antes de cada cita — WhatsApp:** fecha, hora, instrucciones previas y documentación necesaria
- **Primera cita de tratamiento — kit de bienvenida:** guía del tratamiento paso a paso, kit de higiene personalizado, contacto directo del equipo y cuidados posteriores
- **Durante el tratamiento:** llamadas tras citas relevantes, encuestas de satisfacción, fotografías de progreso y resolución inmediata de dudas
- **Programa de referidos:** invitación a «Recomienda Alma», con incentivo y materiales para compartir
- **Al alta:** caja de alta, llamada de satisfacción, solicitud de testimonio o reseña, revisiones incluidas y recordatorios anuales de mantenimiento

REGLAS DE CONTACTO

- Horario de llamadas: laborables, entre las 9:00 y las 20:00; nunca en fin de semana salvo urgencia clínica
- Máximo dos intentos por acción programada, separados por al menos un día
- Tras un intento fallido, mensaje breve identificándose y ofreciendo devolver la llamada
- Si el paciente pide no ser contactado, se registra y se detiene toda la cadencia, en todos los canales

- Cada contacto se registra con fecha, canal, resultado y siguiente paso
- El seguimiento es del Director; delegarlo en quien no conoce el caso destruye su valor

PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN

EMAIL DE BIENVENIDA – día 1, paciente convertido

Asunto: Su plan de tratamiento en el Centro Alma

Estimado/a [Nombre]:

Gracias por su confianza. Le resumimos lo acordado:

- Plan: [fases principales]
- Primera cita: [fecha y hora]
- Instrucciones previas: [detalle]

Adjuntamos su informe de análisis clínico y el presupuesto aceptado.

Para cualquier duda: [teléfono] · [WhatsApp].

Un cordial saludo. Equipo del Centro de Excelencia Implantológica Alma.

WHATSAPP – 48 h antes de la cita

Hola [Nombre], le recordamos su cita el [día] a las [hora] en el Centro Alma. [Instrucción previa]. Si necesita cambiarla, respóndanos a este mensaje. ¡Le esperamos!

WHATSAPP – 24 h antes de la cita

Hola [Nombre], le esperamos mañana [día] a las [hora]. [Instrucción previa].

Si le surge cualquier imprevisto, avísenos por aquí y le buscamos otro hueco.

EMAIL – no convertido, objeción económica, día 7

Asunto: Opciones para su tratamiento

Estimado/a [Nombre]:

Tras su visita hemos revisado su caso y podemos ofrecerle [opción concreta:

financiación a X meses / plan por fases]. Le adjuntamos la simulación.

Si le parece bien, le llamamos [día] a las [hora] para comentarlo.

Quedamos a su disposición.

SMS/WHATSAPP – reactivación, día 180

Hola [Nombre], soy [Nombre] del Centro Alma. Hace unos meses estudiamos su caso. ¿Le gustaría que revisáramos cómo está la situación? La revisión no tiene coste y su diagnóstico previo sigue en su ficha.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y RESEÑAS

- **Pregunta principal:** «Del 0 al 10, ¿qué probabilidad hay de que nos recomiende a un amigo o familiar?»
- **Pregunta abierta:** «¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado de su visita?»
- **Momento:** tras la PV para el circuito, y al alta para el tratamiento
- **Puntuaciones de 0 a 6:** llamada del Director en 48 h para entender qué falló
- **Puntuaciones de 9 a 10:** invitación a dejar reseña pública y al programa de referidos

- **Regla ética:** se invita a todos los pacientes por igual y nunca se ofrece contraprestación por una reseña positiva

PROGRAMA «RECOMIENDA ALMA»

PASO	ACCIÓN	RESPONSABLE
1	Invitación al programa en el momento de mayor satisfacción: alta o resultado visible	Director
2	Entrega de material para compartir con el código del paciente	Recepción
3	Registro del referido en la ficha de quien recomienda	Recepción
4	Agradecimiento a quien recomienda en cuanto el referido acude	Director
5	Aplicación del incentivo según las condiciones vigentes	Dirección
6	Medición: referidos por paciente y conversión de referidos	Dirección

El referido es el paciente con mayor tasa de conversión y menor coste de captación de todo el sistema. Merece un circuito tan cuidado como una campaña.

CASOS ESPECIALES

No coge el teléfono Dos intentos, mensaje identificándose y cambio de canal antes de dar por perdido el contacto.
Responde con enfado Escucha sin defenderse, se registra el motivo y lo asume el Director; nunca se responde por escrito en caliente.
Pide no ser contactado Baja inmediata de la cadencia en todos los canales, registrada con fecha.
Se fue a otro centro Se agradece la sinceridad, se pregunta qué pesó en la decisión y se cierra el caso con esa información.
Vuelve meses después Se revisa la vigencia del diagnóstico; si han pasado más de seis meses, se repiten las pruebas que corresponda.
Reseña negativa pública Respuesta institucional, breve y sin datos clínicos, ofreciendo resolverlo por teléfono. La responde Dirección.

Las ausencias son capacidad pagada y perdida. La diferencia entre una confirmación del 40 % y una del 80 % no está en la tecnología: está en el tono del mensaje.

CONFIRMACIÓN DEL 40-50 %
• «Cita confirmada 23/04 10:00»
CONFIRMACIÓN DEL 80-90 %
• «Hola Marta, te recordamos tu cita mañana a las 10:00 con el Dr. Pérez. ¿Confirmas?»

- Nombre del paciente y nombre del profesional: personalización y vínculo humano
- Día y hora en lenguaje natural: «mañana a las 10» mejor que «23/04 10:00»
- Pregunta directa de confirmación, que facilita la respuesta
- Nunca datos clínicos en el mensaje
- Llamada personal el día antes en cirugías y primeras visitas

Lista de espera automática

Cuando entra una cancelación, el aviso sale en ese momento —no cuando alguien encuentra un rato para llamar— y la cita se la queda quien responde primero.

TRATAMIENTO	¿ SIRVE ?
Revisiones, mantenimientos y controles de ortodoncia	Muy alta
Higienes	Alta
Primeras visitas	Media
Cirugías	No: requieren preparación previa

Condiciones de eficacia: lista depurada cada semana y pacientes que puedan venir con poca antelación. Si el sistema falla, se llama a mano a los primeros de la lista: ninguna automatización puede convertirse en requisito para atender.

ATC EN LA DESPEDIDA Y EN EL SEGUIMIENTO

ALMA TE CUIDA

Recepción es la última barrera: si nadie le ofreció la tarjeta durante la visita, se la ofrece ella al salir. A ningún paciente se le despide sin habérsela ofrecido al menos una vez, haya convertido o no.

RECORDATORIO BREVE EN LA SALIDA

«¿Recuerda la tarjeta Alma Te Cuida que le comenté? Por 95 € al año, revisiones, limpieza y urgencias incluidas para usted y su familia. ¿Se la activo?»

En la cadencia de seguimiento, ATC es además un ángulo propio según el motivo de no conversión: para quien aplazó por precio, la tarjeta es la forma de empezar a cuidarse hoy con descuento si más adelante se trata; para quien ya tiene implantes, es el seguimiento que necesitan; y para el paciente inactivo, es el motivo para volver.

ERRORES FRECUENTES EN ESTA FASE

- Llamar solo a los convertidos: el mayor recorrido de conversión está en los demás
- Repetir el mismo mensaje cada quince días hasta agotar al paciente
- Enviar contenido genérico que no responde a la objeción registrada
- No registrar el resultado de cada contacto, con lo que el siguiente empieza de cero
- Dejar la cadencia en manos de quien no participó en la visita

CRITERIO DE SALIDA

Todo paciente sale del circuito con una tarea futura asignada en Clinic Cloud: cita de tratamiento si aceptó, o re-contacto con fecha y responsable si no. Ninguna PV queda sin siguiente paso.

05 ESTÁNDARES TRANSVERSALES

Lo que se cumple en las doce fases de la primera visita

Reglas que no pertenecen a ninguna fase concreta porque rigen en todas.
Un fallo aquí no arruina un paso: arruina la percepción completa del centro.

Comunicación

LENGUAJE PREFERIDO

- «Su tratamiento», «su plan», «su informe»
- «Vamos a...», que incluye al paciente en la decisión
- «Lo que le proponemos» en lugar de «lo que hay que hacer»
- «¿Me he explicado bien?» en lugar de «¿lo ha entendido?»
- Nombre propio del paciente, y de usted salvo que él proponga otra cosa
- Cifras exactas: «doce semanas», «cuatro citas», «tres años de garantía»

LENGUAJE QUE SE EVITA

- «El caso», «la boca de las dos y media», «el implante de la 3»
- «Esto es carísimo, ya lo sé»: nadie desactiva su propio presupuesto
- «No se preocupe» sin explicar por qué no debe preocuparse
- «Le voy a ser sincero», que sugiere que antes no lo era
- Diminutivos clínicos: «una limpiecita», «un empastito»
- Jerga sin traducir: «vamos a ferulizar la 46 por distal»

- **Comunicación no verbal:** sentarse a la altura del paciente, mirarle al hablar y no a la pantalla, mascarilla retirada en las conversaciones de despacho
- **Confidencialidad:** ningún nombre, diagnóstico ni importe se pronuncia en recepción, pasillos ni sala de espera
- **Coherencia del equipo:** nadie contradice en público a un compañero; las discrepancias se resuelven fuera de la vista del paciente
- **Puntualidad informada:** todo retraso se comunica antes de que el paciente lo pregunte
- **Idioma:** se atiende en la lengua que el paciente elija entre las disponibles, y se registra cuál es

Entorno físico

APERTURA DE LA CLÍNICA

- ☐ **Recepción** despejada, sin documentación visible del día anterior
- ☐ **Sala VIP** ordenada y repuesta
- ☐ **Gabinets** montados y con material estéril disponible
- ☐ **Equipos de imagen** encendidos y comprobados
- ☐ **Portátil de presentación** cargado y con las sesiones del día abiertas
- ☐ **Agenda del día** revisada en equipo: quién viene, por qué y quién le atiende

CIERRE DE LA CLÍNICA

- ☐ **Todas las PV del día** cerradas en Clinic Cloud con su estado
- ☐ **Documentación firmada** escaneada y subida
- ☐ **Tareas de seguimiento** creadas con fecha y responsable
- ☐ **Papel con datos personales** archivado o destruido
- ☐ **Pantallas cerradas** y equipos bloqueados
- ☐ **Incidencias del día** anotadas para el comité semanal

Seguridad clínica

ÁMBITO	ESTÁNDAR DEL CENTRO	RESPONSABLE
Esterilización	Circuito sucio-limpio diferenciado, control de ciclos con registro y trazabilidad por paciente	Auxiliar
Protección radiológica	Justificación de cada prueba, dosis mínima razonablemente alcanzable y consentimiento previo firmado	Doctor
Identificación del paciente	Verificación con dos datos antes de cualquier prueba o registro	Quien ejecuta
Alergias y alertas	Marcadas de forma visible en Clinic Cloud y revisadas al inicio de cada cita	Doctor
Emergencias médicas	Botiquín revisado, oxígeno accesible, equipo formado y protocolo de aviso a emergencias visible	Dirección
Residuos	Segregación conforme a normativa y retirada por gestor autorizado	Auxiliar
Mantenimiento de equipos	Calendario de revisiones y registro de incidencias por equipo	Dirección

Protección de datos en el día a día

- Pantallas bloqueadas al levantarse; ninguna ficha abierta a la vista de otro paciente
- Monitores de recepción orientados de forma que no sean legibles desde el mostrador
- El papel con datos personales no se queda en superficies comunes ni en el escáner
- Comunicaciones por WhatsApp solo desde el número corporativo y sin contenido clínico sensible
- Las imágenes clínicas no salen del sistema del centro ni se envían desde dispositivos personales
- Cualquier pérdida, envío erróneo o acceso indebido se comunica a Dirección el mismo día para valorar si constituye una brecha notificable
- Las bajas de personal implican revocación inmediata de accesos

Cartelería y señalización obligatoria

PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN

Se revisa una vez al mes y siempre que cambie una tarifa, un horario o el director técnico. Su ausencia es una infracción administrativa, y en la sala de espera es lo primero que lee un paciente que está solo y nervioso.

- Autorización sanitaria del centro
- Identificación del director técnico
- Existencia de hojas de reclamaciones
- Información de protección de datos
- Información de precios y tarifas
- Horarios de atención actualizados
- Prohibición de fumar

- Información sobre el límite de pago en efectivo
- Cartel de continuidad de marca durante la transición desde Arclimedent

ALARMAS DEL ENTORNO DE RECEPCIÓN

Documentación de pacientes visible sobre el mostrador · pantallas orientadas hacia la zona pública · sesiones abiertas sin vigilancia · efectivo accesible · conversaciones de recepción audibles desde la sala de espera. Cualquiera de las cinco invalida el trabajo de confidencialidad que se hace en el resto del circuito.

Verificación observada del circuito

PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN

Estos veintidós puntos no se comprueban preguntando ni leyendo registros: se comprueban observando una jornada real sin intervenir. Es la auditoría de campo del protocolo y complementa la rúbrica del Anexo G.

#	QUÉ SE OBSERVA	LO CORRECTO	FASE
1	Tiempo de respuesta al teléfono	Máximo tres tonos	01
2	Fórmula de saludo telefónico	Completa y con el nombre de quien atiende	01
3	Registro del origen del paciente en la llamada	Siempre, sin excepción	01
4	Gabinete preparado antes de que entre el paciente	Montado y comprobado	01 · 05
5	Tiempo de espera real del paciente	Cercano a cero	02
6	Saludo por su nombre al entrar	Siempre	02
7	Acompañamiento físico	Se acompaña al paciente, no se le señala el camino	02
8	Explicación de cualquier retraso	Antes de que el paciente empiece a esperar	02
9	Tour de instalaciones en primeras visitas	Se ofrece siempre	02
10	Verificación del email con el paciente	Se lee en voz alta y se confirma	03
11	Consentimientos	Se explican, no solo se firman	03 · 04
12	Carga de las pruebas	En el momento, no al final del día	05
13	Briefing antes de presentar	Se hace siempre, aunque el caso parezca sencillo	06
14	Verificación del material antes de la presentación	Imágenes cargadas, pantalla lista, presupuesto preparado	06
15	Uso de la pantalla con el paciente	Se explica sobre sus propias imágenes	09
16	Registro de la razón de no conversión	Siempre, con el motivo real	10
17	Digitalización de la documentación	El mismo día, sin excepción	11
18	Agendado de la siguiente cita	Antes de que el paciente salga	11
19	Acompañamiento a la salida	Hasta la puerta, con despedida por su nombre	11
20	Llamada de cortesía tras la visita	Se realiza y se registra	12
21	Desinfección entre pacientes	Sistemática y visible	Transversal

Procede del Protocolo Maestro de Verificación de 322 puntos, cuya Parte F audita el circuito asistencial. El protocolo completo, con las nueve partes del recorrido, está en Otros documentos del sistema.

Ver el protocolo de verificación

Agenda y tiempos

REGLA	DETALLE
Reserva de circuito completo	Una PV bloquea gabinete, sala de imagen y despacho; no se solapa con otra PV
Colchón entre visitas	Quince minutos entre PV para reponer sala, cargar imágenes y hacer el briefing
Máximo de PV por franja	Definido por Dirección según equipo disponible; superarlo degrada el protocolo
Confirmación previa	Recordatorio por WhatsApp a 48 h y a 24 h, con confirmación activa del paciente
Huecos de urgencia	Reserva diaria protegida para pacientes con dolor
Ausencias	Llamada el mismo día, registro del motivo y reprogramación inmediata

06 CASOS ESPECIALES

Cuando el circuito estándar no encaja

El protocolo cubre la visita típica. Estas situaciones aparecen cada semana y exigen adaptar el recorrido sin renunciar a ninguna de sus garantías: diagnóstico completo, documentación firmada y registro trazable.

SITUACIÓN	QUÉ CAMBIA EN EL CIRCUITO	QUÉ NO CAMBIA NUNCA
Urgencia con dolor	Se antepone la exploración dirigida y el alivio del dolor; el circuito completo se realiza en la misma visita o en una segunda cita cercana	Consentimiento radiológico, registro clínico e informe
Paciente pediátrico	Tutor presente, lenguaje adaptado, tiempos más cortos y criterio radiológico restrictivo	Historia médica completa y firma del representante legal
Odontofobia severa	Visita en dos tiempos, sin entrar en gabinete el primer día si es necesario; valoración de sedación	Diagnóstico completo antes de cualquier propuesta
Movilidad reducida o discapacidad	Ruta accesible, tour sustituible, apoyos de posicionamiento en las pruebas	Calidad diagnóstica; si una prueba no es viable, se documenta y se busca alternativa
Paciente internacional	Planificación adaptada a fechas de estancia, información en idioma comprensible, previsión de seguimiento a distancia	Documentación firmada y comprendida
Segunda opinión	Se revisan informes previos y se explica el propio diagnóstico sin descalificar al centro anterior	Informe propio, firmado y entregado
Tratamiento en curso en otro centro	Se delimita con precisión qué se asume y qué no, y desde qué momento	Registro escrito del alcance asumido
Paciente oncológico o inmunodeprimido	Coordinación con el especialista responsable antes de planificar; calendario condicionado	Consentimiento informado específico
Embarazo	Se difieren pruebas y tratamientos no urgentes; se prioriza el control de la salud gingival	Justificación documentada de cada decisión
Acude por promoción o campaña	Se cumple exactamente lo prometido en la campaña y se registra cuál era	El diagnóstico manda sobre la oferta: nunca se ajusta el plan a la promoción
Paciente con seguro dental	Se comprueba cobertura antes del presupuesto y se explica qué parte cubre la póliza	Presupuesto completo y transparente
Paciente derivado por un profesional	Se informa al derivante del diagnóstico, con autorización del paciente	Confidencialidad y consentimiento para compartir

CRITERIO GENERAL

Ante una situación no prevista, se aplica el orden de prioridades del centro: **seguridad del paciente**, después **calidad del diagnóstico**, después **experiencia** y solo al final **conversión**. Cualquier decisión que altere ese orden debe consultarse con Dirección antes de tomarla.

FASES 13 Y 14

Dónde continúa el recorrido

Este protocolo desarrolla las fases 1 a 12. El recorrido del paciente tiene catorce, y las dos últimas se desarrollan en el Manual Maestro de Operaciones.

FASE 13 · RAC

Circuito de producción

Lo aceptado en la Fase 11 se convierte en tratamiento ejecutado: registro del caso, pedido inmediato de material, doble verificación de pago y material, agendado, checklist de 24-48 h y control del producto pendiente.

Ver la Fase 13

FASE 14 · HIGIENISTA

Mantenimiento y seguimiento

El resultado se sostiene en el tiempo: alta en el programa de mantenimiento, periodicidad según perfil de riesgo, detección precoz con derivación inmediata y el perfil Alma anual.

Ver la Fase 14

TERCER DOCUMENTO

Otros documentos del sistema

Los nueve documentos que rodean a este protocolo y al manual: compendio maestro, verificación de 322 puntos, auditoría de la clínica adquirida, decisiones de Gerencia y V1–V11, programa de 100 días, dossier de 30 días, protocolos por perfil, dieciocho fichas de innovación y plan de marca y captación.

Ver Otros documentos

07 TRAZABILIDAD

Qué queda registrado, quién responde y cuándo

Resumen operativo de la evidencia que genera una Primera Visita. Sirve como lista de verificación de cierre de jornada: si una PV del día no cumple todas las filas, no está cerrada.

REGISTRO	FASE	RESPONSABLE	PLAZO	CONSECUENCIA SI FALTA
Agenda de PV con motivo y origen	01	Recepción	En la llamada	Marketing sin datos de retorno
Ficha completa en Clinic Cloud	03	Director	Durante la visita	Bloqueo de facturación y financiación
Consentimiento RGPD firmado	03	Director	Durante la visita	Incumplimiento normativo
Anamnesis médica en historia	04	Doctor	Durante la visita	Riesgo clínico y responsabilidad profesional
Consentimiento radiológico firmado	04	Doctor	Antes de las pruebas	Pruebas realizadas sin cobertura legal
Imágenes cargadas y etiquetadas	05	Auxiliar	Inmediato	Presentación incompleta, pérdida de credibilidad
Expectativas y exploración en historia	07	Doctor	Durante la visita	Propuesta desconectada del paciente
IAC firmado y digitalizado	08 · 11	Doctor · Recepción	Mismo día	Presupuesto sin sustento clínico documentado
Estado de la PV e importes	10	Director	Al cierre	Imposible medir conversión
Motivo de no conversión	10	Director	Al cierre	Seguimiento imposible de diseñar
Documentación escaneada (9 documentos)	11	Recepción	Mismo día	Sin defensa ante reclamación
Estado de ATC: activada, pendiente o rechazada	10 · 11	Director · Recepción	Antes de que salga	Se pierde el seguimiento y la oportunidad de la siguiente visita
Tarea de re-contacto o cita programada	12	Director	Mismo día	Paciente perdido por inacción

08 CUADRO DE MANDO

Cómo se mide si el protocolo funciona

Seis indicadores revisados en el comité mensual de dirección. Miden ejecución (¿se cumple el protocolo?) y resultado (¿produce lo que debe?). Los objetivos son propuestas de partida; dirección los ajusta con el histórico real del centro.

INDICADOR	DEFINICIÓN	OBJETIVO DE PARTIDA	FUENTE
Tasa de conversión de PV	PV convertidas / PV realizadas	≥ 60 %	Clinic Cloud · estado de PV
Importe medio aceptado	Suma aceptada / PV convertidas	Tendencia al alza	Clinic Cloud · presupuestos
Ratio de aceptación	Importe aceptado / importe presentado	≥ 75 %	Clinic Cloud · presupuestos
Documentación completa en 24 h	PV con los 9 documentos subidos el mismo día	100 %	Auditoría de fichas
Cumplimiento de la llamada 24–48 h	PV con llamada de cortesía registrada	≥ 95 %	Clinic Cloud · tareas
Conversión diferida	No convertidos que aceptan en 180 días	≥ 20 %	Clinic Cloud · nurturing

Rúbrica de auditoría de una Primera Visita

Dirección audita cada mes una muestra de PV contra esta rúbrica, revisando la ficha en Clinic Cloud y, cuando procede, acompañando la visita. Cien puntos posibles; por debajo de 80 se activa plan de refuerzo con el equipo del centro.

CRITERIO	QUÉ SE COMPRUEBA	PESO
Datos de captación	Motivo de consulta redactado y origen de marketing específico	10
Documentación firmada	Los nueve documentos, completos y digitalizados el mismo día	20
Historia clínica	Anamnesis completa, alergias y alertas marcadas	15
Pruebas diagnósticas	Serie completa, etiquetada y de calidad aceptable	15
IAC	Firmado, coherente con la historia y entregado al paciente	15
Registro de conversión	Estado, importes y motivo de no conversión cumplimentados	10
Seguimiento	Cita o tarea de re-contacto creada con fecha y responsable	10
Experiencia	Tour realizado, tiempos cumplidos y llamada de cortesía registrada	5

Interpretación

- 90 – 100

 Ejecución de referencia; el caso sirve como material de formación
- 80 – 89

 Correcta, con observaciones puntuales
- 60 – 79

 Plan de refuerzo y nueva auditoría en treinta días
- < 60

 Revisión del circuito con Dirección de Centros

Cómo se audita

- Muestra mínima mensual: cinco PV por centro, elegidas al azar
- Se audita la ficha, no la memoria de quien atendió
- Los hallazgos se comparten con el equipo completo, sin señalar a personas
- Cada hallazgo repetido dos meses seguidos genera acción formativa

LECTURA CORRECTA DE LOS INDICADORES

Una conversión alta con documentación incompleta no es un buen mes: es riesgo acumulado. Los indicadores de ejecución se revisan **antes** que los de resultado, porque los primeros explican a los segundos.

09 FORMACIÓN

Cómo se aprende y se certifica este protocolo

Un protocolo que no se entrena se convierte en un documento decorativo.
Nadie participa en una Primera Visita sin haber recorrido este itinerario y sin estar certificado en su rol.

Incorporación · primeros 30 días

PERIODO	CONTENIDO	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Días 1–3	Lectura del protocolo completo, recorrido físico de la clínica y presentación del equipo	Cuestionario de comprensión
Días 4–7	Formación en Clinic Cloud: alta, historia, imágenes, presupuestos y tareas	Alta de un caso de prueba sin errores
Días 8–12	Observación de cuatro PV completas, sin intervenir	Ficha de observación por fase
Días 13–18	Role-play de su rol con un compañero veterano, incluidas objeciones	Dos simulaciones grabadas y comentadas
Días 19–25	Ejecución acompañada: hace su parte con supervisión presente	Rúbrica de auditoría sobre sus visitas
Días 26–30	Evaluación de certificación y plan de mejora individual	Certificación interna del rol

Certificación por rol

Recepción	FASES 1, 2, 11	Domina la llamada de PV, el speech de valor, la agenda, la acogida y la digitalización completa el mismo día.
Director	FASES 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12	Domina el alta, el RGPD, la redacción del IAC, la presentación económica, el manejo de objeciones y la cadencia de seguimiento.
Doctor	FASES 4, 6, 7, 8, 9	Domina la anamnesis, el consentimiento radiológico, la exploración sistemática, la lectura del CBCT y la presentación del diagnóstico.
Auxiliar	FASE 5	Domina el protocolo de imagen completo, los criterios de calidad, el confort del paciente y el etiquetado en Clinic Cloud.
Recertificación		Anual para todos los roles, y siempre que cambie el protocolo, el sistema o el equipamiento.
Suplencias		Solo cubre una fase quien esté certificado en ella. Si no hay nadie certificado, se reprograma la visita.

Entrenamiento continuo

RUTINA SEMANAL · 30 MINUTOS

- Revisión de las PV no convertidas de la semana y de su motivo real

- Un role-play de objeción, rotando quién hace de paciente
- Revisión de una presentación grabada, con permiso del paciente
- Incidencias del circuito y ajustes acordados

COMITÉ MENSUAL DE DIRECCIÓN

- Indicadores de ejecución antes que los de resultado
- Resultados de la auditoría de fichas
- Origen de marketing de las PV y coste por paciente convertido
- Decisiones sobre el protocolo, que se versionan en este documento

REGLA DE CALIBRACIÓN

Dos profesionales del mismo rol deben producir la misma visita. Cuando la auditoría detecta que un paciente recibe una experiencia distinta según quién le atienda, el problema no es de la persona: es de calibración del equipo, y se corrige con entrenamiento conjunto.

10 ANEXOS

Material de apoyo

Siete anexos de consulta: la biblioteca completa de guiones, las respuestas modelo a lo que el paciente siempre pregunta, los errores detectados en auditoría, el checklist imprimible de la visita, el vocabulario común del equipo, la gobernanza del documento y cómo se cambia.

Anexo A · Biblioteca de guiones

Todos los guiones del protocolo, reunidos para consulta rápida y para los role-play semanales. Son estructura, no texto para recitar: cada profesional los dice con sus palabras.

Llamada entrante FASE 1

Apertura: «Centro de Excelencia Implantológica Alma, le atiende [nombre]. ¿En qué puedo ayudarle?»
 Escucha: «Cuénteme qué le ocurre.» (anotar literal, sin interrumpir)
 Filtrado: «¿Tiene dolor ahora mismo?» · «¿Desde cuándo le pasa?»
 «¿Ha estado en tratamiento por esto en otro sitio?»
 Valor: «Su primera visita es completamente gratuita e incluye tomografía 3D, panorámica digital, escaneado intraoral y estudio fotográfico completo. Saldrá con un diagnóstico por escrito, firmado por el Doctor.»
 Cita: «Tengo martes a las 10:00 o jueves a las 17:30. ¿Cuál le viene mejor?»
 Origen: «¿Cómo nos ha conocido? Nos ayuda mucho saberlo.»
 Cierre: «Le confirmo: [día], [hora], en [dirección]. Le envío ahora un recordatorio por WhatsApp. Traiga informes o radiografías previas si tiene.»

Acogida y tour FASE 2

Acogida: «Buenos días, [Nombre]. Le estábamos esperando.»
 Sala VIP: «Acompáñeme, le llevo a nuestra sala. ¿Le apetece un café o un agua?»
 Tour: «Antes de empezar quiero enseñarle cómo trabajamos.»
 Esterilización: «Aquí se controla todo lo que entra en su boca: cada instrumento tiene su ciclo registrado y trazable.»
 Imagen 3D: «Este es el escáner de tomografía. Nos permite ver lo que de otro modo no se ve, planificar con exactitud milimétrica y garantizar resultados predecibles a largo plazo.»

Documentación y RGPD FASE 3

Encuadre: «Vamos a dedicar diez minutos al papeleo aquí, cómodos, y después ya no volvemos a hablar de formularios.»
 RGPD: «Le explico qué hacemos con sus datos; si algo no le encaja, no lo firme.»
 Verificación: «¿Me confirma su email letra por letra? Ahí le enviaremos su informe.»
 Transición: «El siguiente paso es el Doctor. Le acompaño yo y le presento.»

Historia clínica y radiología FASE 4

Encuadre: «Antes de mirarle la boca necesito conocer su salud general: muchas decisiones dependen de ello.»

Medicación: «¿Toma alguna medicación, aunque le parezca que no tiene relación con los dientes?»

Radiología: «La dosis de esta tomografía es muy baja, comparable a la radiación natural de un vuelo largo. Le pido la firma porque toda prueba con radiación exige que usted esté informado.»

Expectativas y exploración FASE 7

Funcional: «¿Qué le impide comer con normalidad?» · «¿Qué le gustaría poder hacer que ahora no puede?»

Estético: «¿Cómo se siente con su sonrisa actual?» · «¿Hay situaciones en las que evita sonreír?»

Emocional: «¿Cómo afecta esto a su vida diaria?» · «¿Qué significaría para usted resolverlo?»

Escala: «Del 0 al 10, ¿cuánto le afecta esto en su día a día?»

Deseo: «Si mañana esto estuviera resuelto, ¿qué haría distinto?»

Cámara: «¿Ve esto? Esta sombra es una caries que empieza aquí. Y fíjese en la encía: debería verse rosa y firme, y aquí está inflamada.»

Presentación del diagnóstico FASE 9

Recapitular: «Usted vino porque [motivo] y me dijo que lo que más le afecta es [prioridad].»

Lo sano: «Antes de nada: esto de aquí está bien y no hay que tocarlo.»

Evidencia: «Mire esta imagen. Aquí debería verse [normal] y en su caso vemos [hallazgo]. Se lo enseño también en la foto de su boca.»

Evolución: «Si no hacemos nada, lo previsible es [evolución realista].»

Solución: «El plan tiene tres fases: [1], [2] y [3]. En total, [tiempo] y [n.º] citas.»

Comprobar: «¿Me lo puede resumir usted, para asegurarme de que lo he explicado bien?»

Propuesta económica y cierre FASE 10

Anclaje: «Como ha visto en el análisis del Doctor, y partiendo de las pruebas 3D que le hemos hecho hoy...»

Desglose: «Se lo detallo línea a línea y le explico por qué cuesta cada parte.»

Financiación: «Si lo financiamos a X meses, su cuota sería de Y euros. El coste total sería Z. Se lo pongo por escrito.»

Cierre por alternativa: «¿Prefiere comenzar con el plan completo o por fases?»

Cierre por asunción: «¿Qué día de la semana le viene mejor para la primera cita?»

Objeción de precio: «Entiendo. ¿Le parece que repasemos qué incluye y veamos la forma de pago que mejor le encaje?»

Necesita pensarlo: «Por supuesto. ¿Qué parte concretamente quiere pensar? Prefiero resolverlo ahora que dejarle con la duda.»

Despedida y seguimiento FASE 12

Despedida: «Ha sido un placer atenderle. Nos alegra poder ayudarle a conseguir la sonrisa que merece. Cualquier duda, escribanos o llámenos.»

Cortesía 24–48 h: «Buenos días, [Nombre]. Le llamamos del Centro Alma para agradecerle su visita y asegurarnos de que todo quedó claro. ¿Le ha surgido alguna duda sobre el plan que le presentamos?»

No convertido, día 7: «Hemos revisado su caso y podemos ofrecerle [opción concreta]. ¿Le viene bien que se lo explique en dos minutos?»

Reactivación, día 180: «Hace unos meses estudiamos su caso. ¿Le gustaría que revisáramos cómo está la situación? Su diagnóstico sigue en su ficha y la revisión no tiene coste.»

Anexo B · Preguntas frecuentes del paciente

Respuestas modelo para las preguntas que aparecen en casi todas las visitas. Se responden igual, las haga quien las haga.

- + ¿Por qué la primera visita no cuesta nada?

- + ¿Me va a doler?

- + ¿Cuánta radiación tienen estas pruebas?

- + ¿Puedo llevarme el informe si quiero otra opinión?

- + ¿Por qué es más caro que en otro sitio?

- + ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

- + ¿Puedo pagarlo a plazos?

- + ¿Qué pasa si no me hago nada?

- + ¿Quién me va a tratar?

- + ¿Qué garantía tengo?

- + ¿Y si empiezo y no puedo continuar?

- + Me lo tengo que pensar. ¿Hay algún problema?

Anexo C · Errores frecuentes y cómo se corrigen

ERROR OBSERVADO	EFFECTO	CORRECCIÓN
Origen de marketing registrado como «internet»	Imposible atribuir la inversión publicitaria	Preguntar por el canal concreto y la campaña

ERROR OBSERVADO	EFFECTO	CORRECCIÓN
Ficha duplicada del mismo paciente	Historial fragmentado, comunicaciones cruzadas	Búsqueda por teléfono y email antes de crear
Imágenes subidas al final del día	Presentación incompleta o repetición de pruebas	Carga y verificación inmediatas en Fase 5
Presupuesto presentado antes del IAC	El precio precede al diagnóstico; cae la conversión	Respetar el orden de fases sin excepción
Discrepancia clínica delante del paciente	Pérdida inmediata de confianza	Resolver en el briefing de la Fase 6
No conversión sin motivo registrado	Nurturing imposible; paciente perdido	Campo obligatorio al cerrar la PV
Cifras de garantía o éxito improvisadas	Riesgo legal y reputacional	Usar solo la ficha de datos verificables de dirección

Anexo D · Checklist imprimible de la Primera Visita

Una hoja para tener en el despacho. Se repasa al cerrar cada PV; si queda una casilla sin marcar, la visita no está cerrada.

ANTES Y DURANTE

- ☐ **F1** · Motivo de consulta y origen de marketing registrados
- ☐ **F1** · Verificado que no existe ficha duplicada
- ☐ **F1** · Recordatorio enviado al paciente
- ☐ **F2** · Saludo por su nombre y hora de llegada registrada
- ☐ **F2** · Tour de esterilización e imagen 3D realizado
- ☐ **F3** · Ficha completa en Clinic Cloud, sin campos vacíos
- ☐ **F3** · RGPD explicado, firmado y fechado
- ☐ **F3** · Email verificado en voz alta
- ☐ **F4** · Anamnesis médica y dental registradas
- ☐ **F4** · Alergias y alertas marcadas de forma visible
- ☐ **F4** · Consentimiento radiológico firmado antes de las pruebas
- ☐ **F5** · CBCT, OPG, escaneado y serie fotográfica completos
- ☐ **F5** · Imágenes cargadas, etiquetadas y verificadas
- ☐ **F6** · Briefing realizado y plan óptimo acordado

CIERRE Y SALIDA

- ☐ **F7** · Expectativas registradas con las palabras del paciente
- ☐ **F7** · Exploración sistemática completa y odontograma actualizado
- ☐ **F7** · Capturas intraorales de las zonas a presentar
- ☐ **F8** · IAC redactado, revisado y firmado por el Doctor
- ☐ **F8** · IAC entregado a Recepción

- ☐ **F9** · Checklist de material verificado antes de proyectar
- ☐ **F9** · Paciente capaz de resumir su diagnóstico
- ☐ **F10** · Presupuesto desglosado y explicado línea a línea
- ☐ **F10** · Estado de la PV, importes y método de pago registrados
- ☐ **F10** · Motivo de no conversión registrado, si procede
- ☐ **F11** · Carpeta Alma entregada
- ☐ **F11** · Nueve documentos escaneados y subidos el mismo día
- ☐ **F11** · Cita programada o tarea de seguimiento creada
- ☐ **F12** · Llamada de cortesía programada a 24–48 h

Anexo E · Glosario

PV Primera Visita Circuito completo de acogida, diagnóstico y propuesta descrito en este protocolo.
IAC Informe de Análisis Clínico Documento firmado por el Doctor con hallazgos, diagnóstico y plan de tratamiento.
CBCT Tomografía de haz cónico Estudio tridimensional del complejo maxilofacial con dosis reducida.
OPG Ortopantomografía Radiografía panorámica digital de ambos maxilares.
CLINIC CLOUD Sistema de gestión Historia clínica, agenda, presupuestos, tareas y trazabilidad documental del centro.
CARPETA ALMA Dossier del paciente Libro de la clínica, presupuesto, OPG y fotografías que todo paciente se lleva.

Anexo F · Gobernanza del documento

ASPECTO	DEFINICIÓN
Propietario	Dirección de Centros · Centro de Excelencia Implantológica Alma
Ámbito	Todas las Primeras Visitas, en todos los centros de la red
Revisión	Semestral, o antes si cambia la normativa, el sistema o la cartera de servicios
Formación	Obligatoria para toda incorporación antes de participar en una PV
Auditoría	Muestreo mensual de fichas frente a la tabla de trazabilidad
Excepciones	Toda desviación se documenta en la ficha del paciente con su justificación

Anexo G · Cómo se cambia este documento

Cómo se propone un cambio

- Cualquier miembro del equipo puede proponerlo, por escrito y con el motivo
- Se debate en el comité mensual y se decide con Dirección de Centros
- Si se aprueba, se versiona el documento y se comunica a todos los centros
- Los cambios que afecten a consentimientos o a documentación se revisan además con asesoría legal

Qué obliga a revisar el protocolo

- Cambios normativos en protección de datos, radiología o consentimiento informado
- Cambios en el sistema de gestión, en el equipamiento o en la cartera de servicios
- Indicadores por debajo del objetivo durante dos meses consecutivos
- Reclamaciones o incidencias que revelen un vacío en el circuito

Anexo H · Cuadro de escalado de incidencias

MATRIZ DE OBLIGACIONES

Cuando algo del circuito falla, esta tabla dice quién lo detecta, a quién se escala y qué corrección corresponde. Una incidencia comentada de pasillo no corrige nada; escalada según este cuadro, sí.

INCIDENCIA	DETECTADA POR	ESCALA A	ACCIÓN CORRECTIVA
Documentación no subida el mismo día	Auditoría o Director	Dirección de Centros	Revisión de causa raíz
Alta en Clinic Cloud no completada antes de la Fase 9	Auditoría o Director	Director de Clínica	Revisar la entrega de la anamnesis a Recepción
IAC con discrepancias clínicas	Auditoría	Dirección de Centros y Doctor	Corrección formal del informe
Presupuesto elaborado sin solicitud firmada	Auditoría	Dirección de Centros	Recordatorio del circuito al Director
RAC no avisada tras la aceptación	Auditoría o RAC	Director de Clínica	Aviso inmediato y revisión del traspaso
Cirugía agendada sin pago confirmado	Auditoría o RAC	Dirección de Centros	Revisión inmediata del caso

INCIDENCIA	DETECTADA POR	ESCALA A	ACCIÓN CORRECTIVA
Cirugía cancelada por falta de material	Auditoría, RAC o Auxiliar	Dirección de Centros	Revisión del circuito de verificación de material
Producto pendiente creciendo	Panel de producto pendiente	Dirección de Centros	Auditoría del circuito de producción



Centro de Excelencia Implantológica Alma

Protocolo de Experiencia Clínica · Primera Visita

Documento interno de uso obligatorio. Contiene datos de proceso y criterios de actuación clínica; no sustituye el juicio profesional del Doctor ante un caso concreto.

VERSIÓN

v32.0 · Agosto 2026

Revisión semestral

CONTENIDO

Fases 1 a 12 de las 14 del recorrido

4 roles · 9 documentos · 6 indicadores

8 anexos · 1 rúbrica de auditoría

Otros documentos del sistema

Centro de Excelencia Implantológica Alma. Los catorce documentos que rodean al Manual Maestro y al Protocolo de Primera Visita: qué contiene cada uno, cuándo se usa y qué aporta al trabajo diario.

Ourense · Versión 32.0 · Agosto 2026.

Este documento tiene el mismo rango que los otros dos: no es un anexo. Los tres se leen juntos y se enlazan entre sí. Nada de lo que aportan estos documentos se ha eliminado: lo que completa una parte del Manual o del Protocolo se ha incorporado allí con la etiqueta de su origen, y aquí queda el documento entero.

DOCUMENTOS 14 Del posicionamiento del centro al programa de cuidado ATC	PUNTOS DE VERIFICACIÓN 322 Recorrido físico, documental, de sistemas y de procesos
DECISIONES DE GERENCIA 20 Más once verificaciones externas	FICHAS DE INNOVACIÓN 18 Con protocolo, guion, contingencia e indicador
PERFILES OPERATIVOS 6 Parte asistencial y parte comercial de cada puesto	HORIZONTE 100 días Programa de integración tras la adquisición



CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Qué es cada cosa y cuándo se abre

Ninguno de estos documentos sustituye al Manual Maestro ni al Protocolo de Primera Visita: los rodean. Unos se usan una sola vez —los de transición—, otros son permanentes y otros se activan por proyecto. Esta página los ordena para que nadie tenga que buscar.

#	DOCUMENTO	CUÁNDO SE USA	QUIÉN LO USA
1	Compendio Maestro del Sistema de Gestión	Al empezar, y cada vez que haya que localizar algo	Dirección
2	Protocolo Maestro de Verificación · 322 puntos	Inspección física y documental del centro	Dirección y Responsable Clínico
3	Auditoría Integral de la Clínica Adquirida	Día 1 y primeros 30 días	Dirección
4	Decisiones de Gerencia y verificaciones externas	Semana 1, primer mes y primer trimestre	Gerencia
5	Programa de Integración y Transformación · 100 días	Del día 1 al día 100, con puertas de paso	Gerencia y Comité de Transición
6	Dossier de Ejecución · primeros 30 días	Semana a semana, impreso y marcado a mano	Dirección
7	Protocolos Operativos por Perfil	Formación y trabajo diario de cada puesto	Los seis perfiles
8	Innovación Aplicada al Protocolo · 18 fichas	Una innovación por trimestre	Dirección y el perfil propietario
9	Plan Director de Marca y Captación	A partir del día 30, tras estabilizar la operación	Gerencia y Dirección
10	Cuaderno de Campo · Día 1	El día 1, impreso y encima	Dirección
11	Manual de Puesta en Marcha · operativa por perfil	Día 1 y primera semana	Recepción · Doctor · Auxiliar · RAC
12	Continuidad legal, financiera y de sistemas	Del día 1 al primer mes	Gerencia y asesorías

#	DOCUMENTO	CUÁNDO SE USA	QUIÉN LO USA
13	«No medias sonrisas» · posicionamiento y objetivo	Siempre: es el criterio que ordena todo lo demás	Todo el equipo
14	ATC · Alma Te Cuida	En cada visita: forma parte del cierre de cualquier tratamiento	Todo el equipo

Control del documento

CAMPO	CONTENIDO
Versión	v32.0 · Agosto 2026 · versión única del sistema
Clasificación	Uso interno · Confidencial
Propietario	Dirección de Centros
Ámbito	Los catorce documentos que rodean al Manual Maestro y al Protocolo de Primera Visita
Difusión	Dirección, Gerencia y los perfiles a los que corresponde cada documento
Revisión	Semestral, o ante cualquier cambio normativo o de decisión de Gerencia
Documentos relacionados	Todos comparten la versión v32.0: Plan de Dirección, Manual Maestro, Protocolo de Primera Visita y hoja de captura de la línea base

LA REGLA DE SECUENCIA

Estos documentos no se activan a la vez ni en cualquier orden. Los tres últimos —cuaderno de campo, operativa por perfil de la transición y continuidad legal— son los del arranque: se usan una vez y se archivan. Primero se neutraliza el riesgo (documentos 2, 3 y 4), después se establece el marco y la línea base (5 y 6), luego se implanta el estándar de trabajo (7 y el Manual Maestro) y solo entonces se innova y se capta (8 y 9). **Sostener** → **recuperar** → **fidelizar** → **captar**. Captar pacientes nuevos con la cartera heredada desatendida es la peor asignación de recursos posible.

CÓMO SE RELACIONA CON LOS OTROS DOS DOCUMENTOS

Ninguno de estos documentos sustituye al Manual Maestro ni al Protocolo de Primera Visita: los rodean. Cuando alguno aporta algo que completa una parte de aquellos, se ha incorporado allí y se indica con la etiqueta de su documento de origen. Nada se ha eliminado: aquí queda además el documento entero.

El sistema en cuatro niveles

El Compendio Maestro organiza toda la documentación del centro en niveles según quién la usa y durante cuánto tiempo.

NIVEL	QUÉ CONTIENE	PARA QUIÉN	VIGENCIA
0 · Transición	Manual de Apertura (dirección, perfiles, continuidad), Cuaderno de Campo del día 1 y fichas individuales	Dirección y cada perfil	Caduca: se archiva pasadas las primeras semanas
1 · Dirección	Manual del Director y Gerente, Manual de Formación y Delegación, Cuadro de Mando del Director	Solo Dirección	Permanente
2 · Operativa	Este Manual Maestro, el Protocolo Ampliado, el Manual de Operaciones y las Descripciones de Puesto	Todo el equipo	Permanente
3 · Crecimiento	Plan de Diferenciación, Plan de Marca y Marketing, Manual de Reactivación y Plan de Líneas Avanzadas	Dirección	Permanente

DOCUMENTO 01

Compendio Maestro del Sistema de Gestión

El libro maestro que organiza todo el sistema. No sustituye a los demás documentos: los ordena, los conecta y consolida en un solo lugar lo que estaba disperso. Es el documento que se abre primero.

PARA QUÉ SIRVE

Te dice qué necesitas y dónde está.

Su apartado más útil es el consolidado de decisiones pendientes: estaban repartidas por seis documentos y aquí aparecen juntas y priorizadas.

Qué consolida

CONSOLIDADO 1

Las 20 decisiones pendientes

Urgentes de la primera semana, importantes del primer mes y estratégicas del primer trimestre, con su documento de origen y el impacto de no decidir las.

CONSOLIDADO 2

Los nueve checklists

Apertura, cierre, documental por paciente, material de presentación, 24-48 h de cirugía, checklist quirúrgico, riesgo trimestral, lanzamiento de línea y rebranding.

CONSOLIDADO 3

Todos los indicadores

Por fase del protocolo, económicos, de marketing, de equipo y los cinco indicadores del liderazgo real.

CONSOLIDADO 4

El sistema de reportes

Qué se reporta a diario, cada semana y cada mes, con responsable, destinatario y tiempo de dedicación.

CONSOLIDADO 5

El calendario de implantación

Del día 0 al mes 3, con el foco de cada semana y los hitos que deben quedar cerrados en cada tramo.

CONSOLIDADO 6

Los resúmenes ejecutivos

Un párrafo por documento, con lo más importante de cada uno, para saber cuál abrir sin leerlos todos.

Índice de documentos del sistema

#	DOCUMENTO	CONTENIDO NUCLEAR	FRECUENCIA DE USO
0.1–0.3	Manual de Apertura (3 bloques)	Dirección, perfiles y continuidad en las primeras semanas	Días 1 a 30
0.4	Cuaderno de Campo Día 1	Guion impreso del primer día	El día 1
0.5	Fichas individuales Día 1	Una por persona, se reparten en la reunión	El día 1
1.1	Manual del Director y Gerente	Rol, responsabilidades, calendario, crisis y errores del director novel	Semanal
1.2	Manual de Formación, Delegación y Dirección	Método de formación, cinco niveles de delegación, diecisiete conversaciones	Continuo
1.3	Cuadro de Mando del Director	Indicadores, umbrales de alarma y árbol de diagnóstico	Diario, semanal y mensual

#	DOCUMENTO	CONTENIDO NUCLEAR	FRECUENCIA DE USO
2.1	Este Manual Maestro	Las 14 fases, RACI, puestos, funciones de vanguardia e incentivos	Todos, permanente
2.2	Protocolo Ampliado	El porqué de cada fase, guiones, errores y qué observar en auditoría	Formación y auditoría
2.3	Manual de Operaciones	31 capítulos: normas internas, seguridad, economía y calidad	Todos
2.4	Descripciones de Puesto	Seis puestos con funciones, límites, reportes y plan de 90 días	Cada persona, la suya
3.1	Plan de Diferenciación y Crecimiento	Posicionamiento, tecnología y diez movimientos	Trimestral
3.2	Plan de Marca y Marketing	Arquitectura de marca, segmentos, economía unitaria	Semanal
3.3	Manual de Reactivación	Siete segmentos de la base heredada con guion propio	Semanal
3.4	Plan de Líneas Avanzadas	Sedación, cirugía guiada, carga inmediata y ortodoncia	Por proyecto

La columna «Lo que NO hace» de las Descripciones de Puesto y el árbol de diagnóstico del Cuadro de Mando son, según el propio compendio, lo más valioso de cada uno.

DOCUMENTO 02

Protocolo Maestro de Verificación

· 322 puntos de control

Todo lo que hay que comprobar en el centro, zona por zona y documento a documento. Está organizado como un recorrido físico real: se imprime, se lleva encima y se rellena a bolígrafo.

LAS TRES REGLAS DE LA INSPECCIÓN

Solo, sin acompañante. Con la clínica vacía. Tocando y abriendo.

Con alguien al lado te explican en lugar de dejarte ver; con pacientes, todo se ordena; y de pie en el centro de la sala no se inspecciona nada. Se abren cajones, se encienden equipos y se mira detrás.

QUÉ LLEVAR

- ☐ El protocolo **impreso** y un bolígrafo
- ☐ **Móvil** para fotografiar hallazgos
- ☐ **Linterna** para zonas técnicas y detrás de los equipos
- ☐ **Guantes** para tocar sin contaminar zonas limpias

CÓMO SE REGISTRA

- ■ CORRECTO · ■ MEJORABLE · ■ PROBLEMA · sin verificar
- Se fotografía todo lo marcado como mejorable o problema
- Las fotos del primer día son la referencia para medir la mejora tres meses después

Las doce zonas del recorrido físico

B.1 · Exterior y acceso

Rótulo, iluminación, visibilidad, placa de centro sanitario, horario y accesibilidad.

B.2 · Sala de espera

Orden, mobiliario, olor, cartelería obligatoria y nivel real de cuidado.

B.3 · Recepción

Datos a la vista, orientación de pantallas y cultura de confidencialidad.

B.4 · Aseos

Estado, dotación y accesibilidad.

B.5 · Gabinetes

Uno por uno: estado, orden, material a la vista y estándar de limpieza.

B.6 · Sala de imagen

Protección radiológica, señalización y documentación del equipo.

B.7 · Esterilización

Separación sucio-limpio, registros de ciclo y controles. El indicador más fiable del centro.

B.8 · Almacén

Caducidades, rotación y trazabilidad de implantes.

B.9 · Residuos

Contenedores, límites de llenado y documentación de retirada.

B.10 · Zona de personal

Condiciones reales del equipo, que anticipan el clima.

B.11 · Instalaciones técnicas

Extintores, botiquín, iluminación de emergencia y cableado.

B.12 · Archivo

Localización, accesibilidad y custodia de la historia en papel.

Las otras siete partes

PARTE	QUÉ VERIFICA
C · Equipamiento	Se enciende y se prueba cada equipo, con su documentación y sus mantenimientos
D · Documental	Autorización sanitaria, director técnico, póliza de RC, contratos, RGPD, residuos y protección radiológica
E · Sistemas	Copias de seguridad verificadas, usuarios activos, contraseñas y accesos de quien ya no trabaja
F · Procesos	Si el protocolo se cumple de verdad, observando el circuito real de un paciente
G · Económica	Caja, cobros pendientes, precios aplicados y coste de material sobre producción
H · Reputación	Perfil de Google, reseñas, web y accesos a redes
I · Recorrido de 3 horas	El orden a seguir si solo se dispone de una mañana

El recorrido de tres horas

TIEMPO	ZONA	POR QUÉ EN ESE ORDEN
0:00 – 0:20	Esterilización	El indicador más fiable de la calidad real
0:20 – 0:35	Sala de imagen y protección radiológica	Riesgo regulatorio
0:35 – 1:05	Gabinetes, diez minutos cada uno	Actividad principal
1:05 – 1:20	Almacén y trazabilidad de implantes	Riesgo y coste
1:20 – 1:30	Residuos	Cumplimiento
1:30 – 1:45	Instalaciones técnicas y emergencia	Seguridad
1:45 – 2:00	Recepción y cartelería obligatoria	Cumplimiento y experiencia
2:00 – 2:15	Sala de espera y aseos	Experiencia del paciente

TIEMPO	ZONA	POR QUÉ EN ESE ORDEN
2:15 – 2:30	Archivo y zona de personal	Trazabilidad y clima
2:30 – 3:00	Encender y probar todos los equipos	Estado real

Qué se hace con los hallazgos

	COSTE BAJO	COSTE ALTO
Riesgo alto	 HACER YA	 PLANIFICAR CON URGENCIA
Riesgo bajo	 VICTORIAS RÁPIDAS	 VALORAR MÁS ADELANTE

POR DÓNDE EMPEZAR

Por el cuadrante de riesgo bajo y coste bajo. Arreglar diez cosas pequeñas en la primera semana genera más credibilidad ante el equipo que un plan estratégico a doce meses.

DOCUMENTO 03

Auditoría Integral de la Clínica Adquirida

Qué hacer el día 1 y cómo auditar los primeros treinta días. Parte de una premisa incómoda: la compra se hizo sobre lo que contó el vendedor, y ahora hay que verificar qué hay realmente. Esa brecha es a la vez el riesgo y la oportunidad.

EL PRINCIPIO QUE GOBIERNA EL DÍA 1

El día 1 no es para cambiar nada. Es para no romper nada y empezar a mirar.

La tentación de llegar demostrando que hay un nuevo mando es el error más caro: el equipo se cierra y se pierde la única ventana en la que la gente habla con franqueza.

Los tres objetivos del día 1

OBJETIVO 01

Que nadie del equipo se vaya

Son el activo más frágil y el más difícil de reponer.

OBJETIVO 02

Que ningún paciente note nada

La continuidad es la credibilidad de partida.

OBJETIVO 03

Empezar a ver la realidad

Lo que se ve el primer día es lo auténtico; después se maquilla.

El día 1, hora a hora

07:30 Llegada en solitario, antes que nadie. Recorrido por entrada, sala de espera, recepción, gabinetes y esterilización: lo que se ve sin gente es la verdad del sitio.	08:15 Llega el equipo y se le recibe en la puerta, uno a uno.	09:00 Apertura. Dirección se mantiene fuera del despacho, observando el circuito real.	Mediodía Primera conversación individual.	Al cierre Media hora a solas para escribir todo lo observado.
---	---	--	---	---

Las once áreas de auditoría · una por semana

ÁREA	QUÉ VERIFICA	SEÑAL DE ALARMA CARACTERÍSTICA
1 · Instalaciones y equipamiento	Inventario completo, estado y contratos	Leasings que no conocías; autoclave sin registros
2 · Sistemas e información	Qué datos hay realmente y si son fiables	Sin copias de seguridad verificadas; accesos compartidos
3 · Cartera de pacientes	Segmentación de la base y su valor real	Portadores de implantes sin ningún seguimiento
4 · Realidad financiera	Facturación, estacionalidad, ticket medio y mix	Costes fijos superiores a lo previsto
5 · Equipo	Ficha individual y mapa de riesgo de personas clave	Función crítica sin suplente
6 · Calidad clínica	Que exista sistema, con el responsable clínico	Consentimientos genéricos; complicaciones no documentadas
7 · Proceso comercial	Primeras visitas, conversión real y ticket medio	Conversión que nadie había medido nunca
8 · Cumplimiento legal	Las once verificaciones externas	Autorización sin actualizar; sin director técnico designado
9 · Reputación	Google Business, web, redes y reseñas	Perfil o dominio a nombre de un tercero

ÁREA	QUÉ VERIFICA	SEÑAL DE ALARMA CARACTERÍSTICA
10 · Proveedores	Contratos, condiciones y dependencia	Trabajos de laboratorio pendientes sin control
11 · Mercado y competencia	Ocho a diez clínicas de Ourense, con sus huecos	Nadie ocupa «casos complejos» ni «miedo al dentista»

La auditoría se hace en paralelo a la operativa, un área por semana. No se para la clínica para auditar, y no se alarga más de treinta días.

Las diez cosas que más preocupan

#	HALLAZGO	POR QUÉ PREOCUPA
1	Pacientes que pagaron y llevan meses esperando	Obligación, reclamación y reputación a la vez
2	Póliza que no cubre tratamientos anteriores	Exposición patrimonial total
3	Ausencia de trazabilidad de implantes	Incumplimiento e indefensión ante una incidencia
4	Un profesional clave con intención de irse	Se lleva conocimiento y pacientes
5	Deudas laborales heredadas	Responsabilidad solidaria
6	No tener control del perfil de Google	Se pierde el activo de reseñas
7	Registros de esterilización incompletos	Riesgo clínico y de inspección
8	Caída de pacientes nuevos antes de la venta	Te vendieron una tendencia, no un negocio
9	Portadores de implantes sin seguimiento	Complicaciones latentes sin detectar
10	Costes fijos mayores de lo previsto	Punto de equilibrio inalcanzable

LA VENTANA QUE SE CIERRA

Durante seis u ocho semanas, quien llega ve todo lo que el equipo ya no ve. A los tres meses se habrá acostumbrado igual que ellos.

Por eso: escribir todo lo que llame la atención desde el primer día, hacer pronto las conversaciones individuales, terminar la auditoría en treinta días y decidir después, porque la información sin decisión no vale nada.

DOCUMENTO 04

Decisiones de Gerencia y verificaciones externas

Veinte decisiones que Dirección debe cerrar, repartidas en tres entregas por urgencia, y once verificaciones que no son decisiones sino comprobaciones que hay que exigir, verificar y archivar.

Las veinte decisiones

#	DECISIÓN	PLAZO	IMPACTO DE NO DECIDIR
1	Horarios del centro	■ ESTA SEMANA	Sin norma de puntualidad exigible
2	Responsables de apertura y cierre	■ ESTA SEMANA	Nadie responde del cierre
3	Personas autorizadas para caja	■ ESTA SEMANA	Riesgo de descontrol económico
4	Límite legal vigente de efectivo	■ ESTA SEMANA	Riesgo de incumplimiento
5	Canal de recordatorio pre-cita	■ RESUELTA	WhatsApp a 48 h y a 24 h
6	Vía de urgencias fuera de horario	■ ESTA SEMANA	Paciente urgente sin respuesta
7	Tabla de descuentos autorizados	■ PRIMER MES	Precios inconsistentes sin criterio
8	Periodicidad del programa de mantenimiento	■ PRIMER MES	Sin periodicidad no hay programa
9	Alcance competencial del Higienista	■ PRIMER MES	Riesgo competencial
10	Contenido del Kit de Bienvenida	■ PRIMER MES	Cada paciente recibe algo distinto
11	Sustitutos de cada puesto	■ PRIMER MES	Sin cobertura ante ausencias
12	Responsables funcionales con nombre	■ PRIMER MES	Áreas sin dueño
13	Software de ortodoncia: Smartee o Spark	■ PRIMER MES	Doble licencia o casos sin software
14	Modelo de sedación consciente	■ PRIMER TRIMESTRE	Bloquea toda la línea

#	DECISIÓN	PLAZO	IMPACTO DE NO DECIDIR
15	Secuencia de lanzamiento de líneas avanzadas	■ PRIMER TRIMESTRE	Lanzamiento simultáneo mal ejecutado
16	Arquitectura de marca	■ PRIMER TRIMESTRE	Dilución del mensaje
17	Titular de la página principal	■ PRIMER TRIMESTRE	Web sin mensaje definido
18	Quién ejecuta el marketing	■ PRIMER TRIMESTRE	Marketing sin responsable
19	Presupuesto anual de marketing	■ PRIMER TRIMESTRE	Inversión sin marco
20	Responsable de marca y reseñas	■ PRIMER TRIMESTRE	Reputación sin dueño

Las decisiones 7 y 8 están desarrolladas en este manual: la [tabla de descuentos](#) en la Fase 10 y la [estratificación del mantenimiento](#) en la Fase 14. La 5 está resuelta.

Las once verificaciones externas

No son decisiones: son comprobaciones. El trabajo de Dirección no es resolverlas técnicamente, sino exigir las, verificarlas y archivarlas donde puedan consultarse ante una inspección.

#	VERIFICACIÓN	CON QUIÉN	PRIORIDAD	QUÉ SE EXIGE
V1	Autorización sanitaria y cambio de titularidad	Asesoría legal sanitaria	■ ANTES DE ABRIR	Resolución de cambio de titularidad o justificante de solicitud, y director técnico designado
V2	Póliza de responsabilidad civil	Corredor de seguros	■ ANTES DE ABRIR	La póliza completa: fecha de efecto, titular, profesionales cubiertos y cobertura de tratamientos previos
V3	Situación laboral del personal	Asesoría laboral	■ ANTES DE ABRIR	Comunicación escrita a cada trabajador e informe sobre deudas pendientes
V4	Protección de datos	Asesoría en protección de datos	■ PRIMER MES	Registro de actividades, contratos de encargado firmados y procedimiento ante brechas

#	VERIFICACIÓN	CON QUIÉN	PRIORIDAD	QUÉ SE EXIGE
V5	Protocolo de esterilización	Responsable clínico	PRIMER MES	Protocolo escrito y firmado, con parámetros, controles y actuación ante control fallido
V6	Gestión de residuos	Gestor autorizado	PRIMER MES	Contrato vigente y documentación de retirada
V7	Protección radiológica	Asesoramiento técnico especializado	PRIMER MES	Documentación de los equipos y controles de calidad
V8	Plan de prevención de riesgos laborales	Servicio de prevención	PRIMER MES	Plan vigente y formación acreditada del equipo
V9	Régimen disciplinario	Asesoría laboral	PRIMER TRIMESTRE	Marco aplicable y procedimiento
V10	Alcance competencial de la sedación	Asesoría especializada y colegio profesional	ANTES DE LA LÍNEA	Quién puede administrarla, con qué titulación y con qué medios
V11	Publicidad sanitaria	Asesoría	ANTES DE CAMPAÑAS	Qué se puede publicar y con qué límites

QUÉ PASA SI ALGUNA NO ESTÁ EN REGLA

V1: no se hacen cambios visibles de titularidad y se opera con continuidad según indique la asesoría. V2: **no se realiza ninguna actuación clínica**, solo actividad administrativa. V3: se resuelve antes de que nadie atienda pacientes, porque una persona con incertidumbre laboral no puede trabajar bien. V10 es bloqueante para la línea de sedación.

Programa de Integración y Transformación · Plan Director de 100 días

El documento de dirección del proyecto. Una adquisición no es una apertura: se hereda a la vez un activo y un pasivo operativo —compromisos con pacientes, prácticas establecidas, riesgos no documentados— y se dispone de una ventana limitada de credibilidad para reconducirlos.

LA VENTANA CRÍTICA

Los primeros 100 días deciden si el equipo permanece, si los pacientes heredados se consolidan y si la organización acepta un estándar nuevo.

Lo que no se establece en este periodo se convierte en costumbre y multiplica por diez su coste de corrección.

La apuesta del proyecto

Ourense tiene una densidad elevada de oferta generalista y una competencia creciente en precio. En ese contexto, diferenciarse por tecnología no basta: la reivindican todos. La oportunidad está en tres segmentos que casi nadie atiende.

SEGMENTO	DESCRIPCIÓN	BARRERA DE ENTRADA PARA UN COMPETIDOR
Casos de alta complejidad	Pacientes con pérdida ósea significativa a los que se ha desestimado el implante	Exige competencia clínica específica y flujo digital completo. No se resuelve comprando equipamiento
Ansiedad dental severa	Población con necesidad acumulada que evita el tratamiento por temor	Exige circuito de sedación con habilitación, equipamiento y protocolo. Barrera regulatoria alta
Mantenimiento implantológico	Portadores de implantes sin programa de seguimiento estructurado	Exige sistema, no inversión. Poco atractivo a corto plazo y decisivo a largo

PROPOSICIÓN DE VALOR

El centro donde se resuelve lo que otros no resuelven, y donde el tratamiento no termina cuando se cobra.

Los cinco objetivos y sus métricas

#	OBJETIVO	MÉTRICA DE ÉXITO A 100 DÍAS
1	Neutralizar el riesgo heredado	Cero verificaciones críticas pendientes
2	Retener el capital humano	Cero bajas voluntarias
3	Asegurar la continuidad asistencial	Cero reclamaciones de pacientes heredados
4	Establecer la línea base económica	Los cinco indicadores nucleares calculados y monitorizados
5	Implantar el nuevo estándar operativo	Protocolo ejecutándose sin supervisión constante

Los cinco riesgos críticos de partida

#	RIESGO	IMPACTO POTENCIAL	PRIORIDAD
1	Cobertura aseguradora insuficiente para tratamientos previos a la adquisición	Exposición patrimonial ilimitada	■ CRÍTICA
2	Producto pendiente heredado sin cuantificar	Obligación no provisionada y riesgo reputacional	■ CRÍTICA
3	Pérdida de un profesional clave	Fuga de conocimiento y de la cartera asociada	■ CRÍTICA
4	Incumplimientos regulatorios latentes	Expediente sancionador y suspensión de actividad	■ ALTA
5	Deterioro de la percepción del paciente durante la transición	Pérdida de cartera y daño reputacional persistente	■ ALTA

Gobernanza del programa

ÓRGANO	COMPOSICIÓN	RESPONSABILIDAD	PERIODICIDAD
Dirección del Programa	Gerencia	Decisión última, asignación de recursos y resolución de escalados	Continua
Comité de Transición	Gerencia · Dirección de Clínica · Responsable Clínico	Seguimiento de flujos, desbloqueo y validación de entregables	Semanal · 45 min
Propietarios de flujo	Designados por flujo	Ejecución y reporte de su flujo	Continua
Equipo asesor externo	Legal, laboral, fiscal, datos y prevención	Validación técnica de los entregables regulatorios	A demanda

RITMO DE SEGUIMIENTO

Diario · 10´ Punto de control de Dirección de Clínica, con reporte a Gerencia.	Semanal · 45´ Comité de Transición, con acta de decisiones y acciones.	Por fase · 90´ Revisión de hitos y autorización de paso de fase.	Quincenal · 30´ Revisión de riesgos y actualización del registro.
---	---	---	--

NIVELES DE AUTORIDAD

NIVEL	ÁMBITO	DECIDE
N1	Operativa ordinaria dentro de política establecida	Dirección de Clínica
N2	Compromisos económicos, organizativos o con pacientes fuera de política	Gerencia
N3	Estrategia, inversión relevante, líneas de servicio y estructura societaria	Gerencia con asesoramiento
NC	Criterio clínico	Responsable Clínico — no delegable ni revisable por gestión

ESCALADO INMEDIATO A GERENCIA

Emergencia médica · accidente laboral · inspección · requerimiento judicial · brecha de datos · amenaza o agresión · sospecha de irregularidad grave. Todo lo demás sigue la vía ordinaria a través de Dirección de Clínica. El criterio clínico nunca escala a gestión: se resuelve con el Responsable Clínico.

Registro formal de decisiones

Toda decisión de nivel N2 o superior se documenta en el mismo formato. Sin registro, en tres meses nadie recuerda por qué se decidió así ni qué alternativas se descartaron.

REGISTRO DE DECISIÓN – Nº _____

Fecha:

Flujo de trabajo:

Nivel de autoridad:

Decisor:

MATERIA:

ALTERNATIVAS EVALUADAS:

A.

B.

C.

CRITERIO DE DECISIÓN:

RESOLUCIÓN ADOPTADA:

FUNDAMENTO:

CONSULTA PREVIA REALIZADA: Fecha:

ENTRADA EN OURENSER:

DOCUMENTOS AFECTADOS:

COMUNICACIÓN: destinatarios / canal / fecha

REVISIÓN PREVISTA:

Metodología de diagnóstico: triangulación**PRINCIPIO METODOLÓGICO**

Ninguna conclusión relevante se sostiene sobre una única fuente: se cruzan documentación, observación y testimonio.

Y una discrepancia entre fuentes no invalida el diagnóstico: la discrepancia es en sí misma un hallazgo y se registra como tal.

Instrumento	Alcance	Duración	Producto
Inspección física estructurada	322 puntos de control en 12 zonas	3 horas	Registro de hallazgos con evidencia fotográfica
Entrevistas de diagnóstico	Todo el equipo interno más agentes externos	45–60 min cada una	Ficha por entrevista y síntesis
Auditoría documental	250 puntos en 8 bloques	4 horas	Cuadro de cumplimiento
Auditoría de sistemas	Base de datos, trazabilidad y seguridad	2 horas	Informe de calidad de la información
Análisis económico	Reconstrucción de 24 meses	6 horas	Línea base económica
Observación de procesos	Recorrido completo del paciente	1 jornada	Mapa del proceso real frente al protocolo

Programa de entrevistas

A QUIÉN Y CUÁNDO

Grupo	Perfiles	Semana
Interno	Recepción, Doctores, Higienista, Auxiliares y personal de limpieza	1
Cadena de valor	Laboratorio protésico y proveedores críticos	2
Transmitente	Anterior titular	2
Pacientes fieles	Antigüedad superior a tres años	3
Pacientes en tratamiento	Con plan en curso	3
Pacientes perdidos	Sin actividad de 12 a 24 meses	4

CONDICIONES DE CONDUCCIÓN

☐ **Confidencialidad** garantizada expresamente y respetada sin excepción

☐ **Entorno neutro**, sin interrupciones y fuera del puesto de trabajo

☐ **45 minutos mínimo**: lo sustantivo emerge a partir del minuto 25

- ☐ El entrevistador **no supera el 20 %** del tiempo de habla
- ☐ **Notas tomadas delante** del entrevistado
- ☐ Compromiso explícito de **devolución** de conclusiones

La batería nuclear de nueve preguntas

#	PREGUNTA	QUÉ ANALIZA
1	¿Cuál es su función real en el día a día?	Divergencia entre función real y nominal
2	¿Qué le complica más la operativa?	Fricciones
3	¿Qué cree que se hace bien?	Fortalezas percibidas
4	¿Qué cree que se hace mal?	Consenso equivale a prioridad de intervención
5	¿Qué cambiaría en primer lugar?	Prioridad individual
6	¿Qué le transmiten los pacientes?	Percepción externa filtrada
7	¿Qué ha tenido que improvisar últimamente?	Ausencia de protocolo
8	¿Qué espera de esta dirección?	Calibración de expectativas
9	¿Qué me contará dentro de tres meses que hoy no me está contando?	Reconocimiento explícito de la reserva

La pregunta 9 se formula al cierre y en tono distendido: reconocer que existe información reservada precipita, en un porcentaje significativo de casos, su comunicación inmediata.

MATRIZ DE CONSENSO

	LO DICE LA MAYORÍA	LO DICE UNO
Impacto alto	 INTERVENCIÓN PRIORITARIA	 VERIFICACIÓN DIRECTA
Impacto bajo	 CORRECCIÓN PROGRAMADA	 OBSERVACIÓN

ANÁLISIS DE OMISIONES

Lo que *nadie* menciona también es un hallazgo, y casi siempre significa que no existe:

- Seguimiento post-tratamiento → no hay programa estructurado
- Protocolos formales → inexistentes o en desuso
- Formación continua → ausencia de inversión
- Objetivos organizativos → ausencia de dirección
- Coordinación interna → no hay sistema de reuniones
- Pacientes que abandonan → no se sigue la cartera

Los seis flujos de trabajo

FLUJO	PROPIETARIO	HORIZONTE	OBJETIVO	INDICADOR DE CIERRE
FT-1 · Cumplimiento y riesgo	Gerencia	Días 1–30 crítico · 1–60 completo	Neutralizar la exposición legal, regulatoria y patrimonial heredada	3/3 verificaciones críticas en el día 3 y 11/11 en el día 60
FT-2 · Personas y organización	Gerencia y Dirección	Días 1–100	Retener el capital humano e implantar delegación y reporte	Cero bajas voluntarias y 100 % de funciones críticas con sustituto formado
FT-3 · Pacientes y continuidad	Dirección de Clínica	Días 1–60	Que ningún paciente en tratamiento sufra discontinuidad ni incertidumbre económica	Cero reclamaciones heredadas y producto pendiente descendente
FT-4 · Económico- financiero	Gerencia	Días 1–60	Establecer la línea base real y verificar la información de la adquisición	Línea base en el día 30 y previsión de tesorería siempre viva
FT-5 · Operaciones y calidad	Dirección y Responsable Clínico	Días 15–100	Implantar el estándar operativo y clínico con trazabilidad completa	Protocolo ejecutado sin supervisión constante

FLUJO	PROPIETARIO	HORIZONTE	OBJETIVO	INDICADOR DE CIERRE
FT-6 · Marca y crecimiento	Gerencia y Dirección	Días 30–100 y siguientes	Preservar los intangibles heredados y reposicionar la marca	Control de activos digitales al 100 % en el día 7

CRITERIO DE BLOQUEO DE FT-1

Sin verificación positiva de la cobertura aseguradora no se realiza actividad clínica.

La actividad administrativa puede mantenerse. Es la única regla del programa que detiene la clínica.

FT-3 · Segmentación de la cartera heredada

SEGMENTO	CRITERIO	PRIORIDAD
Producto pendiente	Tratamiento abonado y no ejecutado	■ CRÍTICA · OBLIGACIÓN EXIGIBLE
Tratamiento interrumpido	Plan iniciado y no completado	■ CRÍTICA · RIESGO CLÍNICO
En tratamiento activo	Plan en curso	■ ALTA · CONTINUIDAD
Portadores de implantes sin seguimiento	Sin revisión registrada	■ ALTA · RIESGO LATENTE Y OPORTUNIDAD
Presupuestos no aceptados recientes	Menos de seis meses	■ MEDIA
Cartera inactiva	Sin actividad más de doce meses	■ PROGRAMADA

TRASPASO DE CASO: EL CRITERIO QUE CONSERVA LA CONFIANZA

Cuando el facultativo que inició el tratamiento no continúa, el entrante revisa el caso **antes** de la cita y, si la clasificación es roja, se contacta al paciente de forma proactiva. Ningún facultativo entra en una consulta conociendo el caso al mismo tiempo que el paciente: la percepción de dominio del caso es el factor determinante durante una transición.

FT-4 · Las seis preguntas incómodas sobre lo comprado

La información económica de una transmisión se presenta, por naturaleza, en su configuración más favorable. No se presume mala fe: se aplica la diligencia debida posterior.

#	CUESTIÓN	POR QUÉ IMPORTA
1	¿La facturación presentada incorpora anticipos de tratamientos no ejecutados?	Determina si parte del «ingreso» es en realidad deuda de servicio
2	¿Existe estacionalidad no comunicada?	Afecta a la previsión de tesorería
3	¿Los costes fijos comunicados son exhaustivos?	Determina el punto de equilibrio real
4	¿Hay saldos de cobro incobrables?	Sobrevaloración del activo
5	¿Hay pasivos con proveedores no comunicados?	Pasivo oculto
6	¿Descendió la captación en los meses previos a la venta?	Indica si se transmitió un negocio o una tendencia

Las tres puertas de paso

El paso de fase exige autorización expresa del Comité de Transición previa verificación de los criterios de salida. No se adelanta ninguna fase: cada una se apoya en la anterior.

PUERTA 1 → DÍA 30

- ☐ Tres verificaciones críticas cerradas
- ☐ Programa de entrevistas completado
- ☐ Cero bajas voluntarias
- ☐ Cero reclamaciones de pacientes heredados
- ☐ Inventario de producto pendiente cuantificado
- ☐ Casos rojos con profesional asignado
- ☐ Devolución al equipo realizada

PUERTA 2 → DÍA 60

- ☐ Once verificaciones regulatorias cerradas
- ☐ Seis decisiones de marco adoptadas y comunicadas
- ☐ Línea base económica establecida
- ☐ Sistema de reportes operativo
- ☐ Formación por perfil completada
- ☐ Producto pendiente en tendencia descendente

PUERTA 3 → DÍA 100 · CIERRE DEL PROGRAMA

- ☐ Protocolo ejecutado sin supervisión constante
- ☐ Responsables funcionales operativos y reportando
- ☐ Programa de mantenimiento en funcionamiento
- ☐ Presencia digital reestructurada
- ☐ Indicadores con serie histórica propia
- ☐ Plan de líneas avanzadas autorizado

Calendario de hitos

DÍA	HITO	FLUJO
1	Verificaciones críticas iniciadas y comunicación laboral individual	FT-1 · FT-2
3	Verificaciones críticas resueltas	FT-1
7	Entrevistas internas completadas · inspección física · control de activos digitales verificado	FT-2 · FT-5 · FT-6
15	Inventario de producto pendiente · línea base económica preliminar · comunicación a la cartera	FT-3 · FT-4 · FT-6
21	Seis decisiones de marco adoptadas · casos de más de seis meses contactados	FT-5 · FT-3
30	Puerta 1 · devolución al equipo	Todos

DÍA	HITO	FLUJO
45	Acuerdos de delegación · simulacro del recorrido asistencial · sistema de reportes operativo	FT-2 · FT-5
60	Verificaciones regulatorias completadas · programa de mantenimiento implantado · Puerta 2	Todos
75	Auditoría de cumplimiento de protocolo · presencia digital reestructurada	FT-5 · FT-6
90	Sistema de recomendación formalizado	FT-6
100	Puerta 3 · cierre del programa	Todos

Registro de riesgos

#	RIESGO	NIVEL	MITIGACIÓN	PROPIETARIO
R1	Cobertura aseguradora insuficiente para tratamientos previos	■ CRÍTICO	Verificación documental el día 1; suspensión de actividad clínica si no se confirma	Gerencia
R2	Producto pendiente superior al previsto	■ CRÍTICO	Cuantificación el día 15 y plan de ejecución priorizado	Dirección
R3	Desvinculación de un profesional clave	■ CRÍTICO	Entrevistas tempranas, riesgo individual identificado y formación cruzada	Gerencia
R4	Incumplimiento regulatorio latente	■ CRÍTICO	Auditoría de las once verificaciones	Gerencia
R5	Reclamación de un paciente heredado	■ CRÍTICO	Contacto proactivo de casos rojos y protocolo de reclamaciones	Dirección
R6	Pasivos laborales heredados	■ ALTO	Verificación con asesoría laboral el día 1	Gerencia
R7	Pérdida de activos digitales	■ ALTO	Verificación de control el día 7. Renombrar, nunca crear de nuevo	Dirección
R8	Deterioro de tesorería	■ CRÍTICO	Previsión a 90 días y colchón mínimo definido	Gerencia

#	RIESGO	NIVEL	MITIGACIÓN	PROPIETARIO
R9	Descenso de captación previo a la transmisión no detectado	ALTO	Análisis de la serie de 24 meses	Gerencia
R10	Resistencia interna al nuevo estándar	ALTO	Entrevistas, devolución e implantación progresiva	Dirección
R11	Equipamiento crítico próximo al fin de su vida útil	ALTO	Inventario con valoración el día 7	Dirección
R12	Dependencia de un proveedor crítico	MEDIO	Diversificación progresiva	Dirección

Planes de contingencia

Cobertura no confirmada

Suspensión de actividad clínica, mantenimiento de la administrativa y escalado a asesoría.

Baja de un facultativo clave

Continuidad asistencial primero, traspaso documentado, comunicación a los pacientes afectados y búsqueda de sustituto.

Reclamación con daño alegado

La gestiona Gerencia con asesoría. Historia clínica inalterada y comunicación a la aseguradora.

Tensión de tesorería

Priorización de pagos, aceleración de cobros y negociación con proveedores *antes* de incumplir.

Inspección

Documentación accesible, aviso a asesoría y ninguna respuesta improvisada.

Producto pendiente muy superior

Plan de ejecución priorizado, provisión económica y comunicación proactiva a los pacientes.

Las siete preguntas antes de cualquier inversión

- ☐ ¿Qué problema resuelve que hoy no se resuelve?
- ☐ ¿Qué volumen de casos la justifica?
- ☐ ¿Quién la va a usar y tiene la competencia para hacerlo?
- ☐ ¿Cuál es el coste total: adquisición, instalación, formación y mantenimiento?
- ☐ ¿Cuál es el periodo de recuperación?
- ☐ ¿Qué pasa si el volumen resulta ser la mitad del previsto?
- ☐ **¿Genera captación nueva o solo redistribuye la demanda existente?**

La última es la determinante y la que menos se formula: una inversión que redistribuye demanda existente no incrementa el ingreso, incrementa el coste.
Criterio de recuperación: menos de 12 meses es favorable; de 12 a 24, aceptable con justificación; de 24 a 36 exige fundamento estratégico; más de 36, solo por razón estratégica determinante.

Comunicación: de dentro hacia fuera

PRINCIPIO RECTOR

Ningún grupo externo conoce el cambio antes que el equipo interno.

Mensaje nuclear: continuidad y refuerzo. En ningún caso ruptura.

ORDEN	DESTINATARIO	MOMENTO	CANAL	MENSAJE
1	Equipo interno	Día 1, antes de abrir	Presencial individual	Situación laboral y continuidad
2	Pacientes en tratamiento y con producto pendiente	Días 1–15	Contacto directo	Continuidad del tratamiento y de las condiciones
3	Cartera general	Día 15	Comunicación escrita	Continuidad y mejora
4	Proveedores y laboratorio	Días 15–30	Comunicación formal	Continuidad de la relación

ORDEN	DESTINATARIO	MOMENTO	CANAL	MENSAJE
5	Entidades financieras	Días 15–30	Comunicación formal	Continuidad del servicio
6	Entorno profesional	Día 30	Presentación institucional	Posicionamiento y derivación
7	Público general	Día 60 en adelante	Digital	Reposicionamiento

QUÉ CAMBIA

- La titularidad y la denominación
- Los recursos, la tecnología y el seguimiento, que mejoran

QUÉ NO CAMBIA

- El tratamiento y sus condiciones
- El equipo asistencial
- Todo compromiso adquirido se mantiene

Cuadro de mando del programa

#	INDICADOR NUCLEAR	OBJETIVO A 100 DÍAS	FRECUENCIA	PROPIETARIO
1	Verificaciones regulatorias cerradas	11/11	Semanal	Gerencia
2	Bajas voluntarias	0	Continua	Gerencia
3	Reclamaciones de pacientes heredados	0	Continua	Dirección
4	Producto pendiente	Tendencia descendente	Semanal	RAC
5	Casos con antigüedad superior a seis meses	0	Semanal	RAC
6	Documentación digitalizada en el día	100 %	Diaria	Dirección

#	INDICADOR NUCLEAR	OBJETIVO A 100 DÍAS	FRECUENCIA	PROPIETARIO
7	Hitos del programa cumplidos en plazo	≥ 90 %	Semanal	Gerencia
8	Riesgos críticos mitigados	5/5	Quincenal	Gerencia

COMITÉ DE TRANSICIÓN – SEMANA ____ Fecha:

ESTADO GENERAL DEL PROGRAMA: verde / ámbar / rojo

FLUJOS DE TRABAJO	Estado	Avance
FT-1 Cumplimiento y riesgo		%
FT-2 Personas		%
FT-3 Pacientes		%
FT-4 Económico-financiero		%
FT-5 Operaciones y calidad		%
FT-6 Marca y crecimiento		%

INDICADORES NUCLEARES

Verificaciones cerradas: ____/11

Bajas voluntarias: ____ Reclamaciones heredadas: ____

Producto pendiente: _____ € (tendencia)

Documentación en el día: ____%

HITOS DE LA SEMANA Cumplidos: _____ Desviados / causa / nueva fecha: _____

RIESGOS Nuevos: _____ Materializados: _____ Mitigados: _____

DECISIONES ADOPTADAS (nº de registro): _____

DECISIONES PENDIENTES: _____

ESCALADOS A GERENCIA: _____

FOCO DE LA SEMANA SIGUIENTE: _____

CÓMO SE EVALÚA ESTE PROGRAMA

No por lo sofisticado del plan, sino por tres resultados verificables: que el equipo permanezca, que los pacientes heredados no perciban discontinuidad y que la organización acepte un estándar de trabajo superior al preexistente.

Los objetivos de crecimiento y liderazgo dependen íntegramente de esos tres. No son una fase previa al proyecto: son su fundamento.

Dossier de Ejecución · los primeros 30 días

La versión ejecutable del programa de 100 días. No añade teoría: convierte el sistema en tareas concretas con guiones, plantillas y casillas. Se imprime, se lleva encima y se va marcando; al final de cada semana se revisa el cuadro de control.

LA REGLA QUE GOBIERNA ESTOS 30 DÍAS

No lanzar nada nuevo hasta saber exactamente qué tengo.

Al cabo del mes hay que tener: los riesgos legales verificados y cerrados, el diagnóstico real de lo que se ha comprado, las seis decisiones que dan marco al equipo, los cinco números económicos y credibilidad ganada con hechos, no con promesas.

LAS CUATRO SEMANAS

Semana 1 Riesgo y escucha. Verificaciones bloqueantes cerradas y todas las entrevistas hechas.	Semana 2 Marco. Las seis decisiones urgentes tomadas y comunicadas.	Semana 3 Números. Los cinco números económicos y el inventario de producto pendiente.	Semana 4 Credibilidad. Victorias rápidas ejecutadas y devolución al equipo.
--	--	--	--

LO QUE NO SE HACE ESTE MES

NO SE HACE	POR QUÉ
Lanzar líneas avanzadas	Aún no se sabe si están los requisitos
Campañas de pago	No se conoce el coste de captación ni la capacidad
Cambiar precios	No se conocen los márgenes reales
Reorganizar el equipo	Todavía no se conoce a las personas
Cambiar protocolos	No se sabe por qué están como están

NO SE HACE	POR QUÉ
Prometer cambios concretos	Aún no se sabe cuáles son posibles

Semana 1 · Riesgo y escucha

Cerrar lo que puede parar la clínica y abrir la única ventana que se cierra sola: la franqueza del equipo. Las tres verificaciones bloqueantes se hacen el lunes, no el jueves. Si alguna falla, todo lo demás es irrelevante.

LLAMADA 1 · ASESORÍA LEGAL SANITARIA

GUIÓN · DIRECCIÓN

«Soy [nombre], director del centro que antes era Arclimedent. Necesito confirmar tres cosas y le pido que me las responda por escrito. Primera: ¿la autorización sanitaria de funcionamiento está ya a nombre de la nueva titularidad o sigue en trámite? Segunda: si está en trámite, ¿puedo operar bajo la marca comercial nueva o debo mantener la anterior en la documentación oficial hasta la resolución? Tercera: ¿está designado y comunicado el director técnico sanitario?»

Documento que hay que exigir: la resolución de cambio de titularidad o el justificante de la solicitud presentada. Si está sin resolver, no se cambia cartelería ni documentación oficial: se opera con continuidad según indique la asesoría.

LLAMADA 2 · CORREDOR DE SEGUROS

GUIÓN · DIRECCIÓN

«Necesito revisar la póliza de responsabilidad civil del centro. Primera: ¿está a nombre de la nueva titularidad y con fecha de efecto sin carencia? Segunda: ¿cubre nominalmente a todos los profesionales que trabajan aquí ahora? Tercera, y es la más importante: ¿cubre reclamaciones que se presenten a partir de ahora por tratamientos iniciados bajo la titularidad anterior? Cuarta: ¿opera por ocurrencia o por reclamación, y hay cobertura retroactiva desde qué fecha?»

Documento que hay que exigir: la póliza completa, no un correo de confirmación. Ante duda razonable no se realiza ninguna actuación clínica hasta confirmarlo; la actividad administrativa sí puede continuar.

LLAMADA 3 · ASESORÍA LABORAL

GUIÓN · DIRECCIÓN

«Necesito confirmar la situación laboral del personal tras la compra. Primera: para cada trabajador que continúa, ¿estamos ante sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o ante nueva contratación? Segunda: ¿está entregada la comunicación escrita individual a cada persona? Tercera: ¿hay deudas salariales, de Seguridad Social o litigios pendientes de la titularidad anterior que puedan afectarnos por responsabilidad solidaria? Cuarta: ¿está operativo el registro horario?»

Si quedan dudas laborales abiertas se resuelven antes de que nadie atienda pacientes: una persona con incertidumbre laboral no trabaja bien.

#	VERIFICACIÓN BLOQUEANTE	CONTACTADO	DOCUMENTO RECIBIDO	ESTADO
V1	Autorización sanitaria	☐	☐	 BLOQUEANTE
V2	Póliza de responsabilidad civil	☐	☐	 BLOQUEANTE
V3	Situación laboral	☐	☐	 BLOQUEANTE

LAS ENTREVISTAS · LO ÚNICO CON FECHA DE CADUCIDAD REAL

APERTURA · MEMORIZADA

«Te he pedido este rato porque necesito entender cómo funciona esto de verdad, y las únicas personas que lo saben sois vosotros. No vengo a evaluarte ni a juzgar cómo se hacían las cosas antes: vengo a aprender. Te voy a hacer bastantes preguntas y voy a tomar notas. Te pido dos cosas: que me digas lo que piensas de verdad, aunque creas que no me va a gustar, y que me pares si algo no lo entiendo bien.»

Las cuatro preguntas que no pueden faltar en ninguna entrevista: **¿qué haces aquí exactamente?** · **¿qué es lo que más te complica el día a día?** · **si pudieras cambiar una sola cosa, ¿cuál sería?** · **¿qué me vas a contar dentro de tres meses que no me estás contando hoy?**

ENTREVISTA: PUESTO:
FECHA: DURACIÓN:

TRES COSAS QUE NO SABÍA:

- 1.
- 2.
- 3.

QUÉ CREE QUE FUNCIONA BIEN:

QUÉ CREE QUE FUNCIONA MAL:

SU PRIORIDAD Nº 1:

RIESGO DE SALIDA: alto / medio / bajo Motivo:

FUNCIONES QUE SOLO ESTA PERSONA HACE:

QUÉ NECESITA DE MÍ:

VERIFICAR PERSONALMENTE:

CIERRE DE CADA ENTREVISTA

«Te agradezco el rato y la franqueza. Lo voy a cruzar con lo que me cuenten los demás y en unas semanas os contaré qué he visto y qué vamos a hacer. Lo que decida, te lo explicaré. Y si en unos días te acuerdas de algo que no me has contado hoy, ven a decírmelo.»

LOS DIEZ PUNTOS QUE NO PUEDEN QUEDAR SIN VERIFICAR —

☐ Registros de esterilización y controles biológicos

☐ Trazabilidad de implantes en los historiales

☐ Copias de seguridad... y que se hayan probado

☐ Extintores con revisión vigente

☐ Botiquín sin material caducado

☐ Delantales plomados sin grietas y colgados

☐ Contenedores de cortopunzantes sin sobrellenar

☐ Hojas de reclamaciones disponibles

☐ Contrato de gestor de residuos vigente

☐ Control del perfil de Google

La inspección física completa —tres horas, en solitario y con la clínica vacía— está desarrollada en el [Protocolo Maestro de Verificación](#).

Semana 2 · El marco

Una tarde de trabajo para dar al equipo un marco claro y que dejen de improvisar. Cada decisión con su consulta previa hecha. Son las decisiones 1 a 6 del registro de Gerencia.

DECISIÓN 1 · HORARIOS Y BLOQUES DE AGENDA

Atención al público: L-V de a

Sábados: no / sí: a

Cierre al mediodía: sí / no

Turnos: T1 personas

T2 personas

BLOQUES DE AGENDA

09:00-11:00 Cirugías y tratamientos complejos

11:00-13:30 Primeras visitas

13:30-16:00 Mantenimientos e higienes

16:00-18:00 Tratamientos ordinarios

18:00-20:00 PRIMERAS VISITAS (franja de oro)

Hueco diario de urgencias:

La regla que más producción libera: la franja de 18 a 20 h se reserva a primeras visitas, que es cuando puede venir el paciente objetivo. No se llena con revisiones de cinco minutos. Consulta previa: asesoría laboral, por turnos y descansos.

DECISIÓN 2 · APERTURA Y CIERRE

APERTURA Titular: Suplente:

CIERRE Titular: Suplente:

LLAVES Custodia:

ALARMA Códigos:

Compensación del tiempo adicional:

Registro de entrega firmado: ☐

DECISIÓN 3 · CAJA

AUTORIZADOS PARA COBRAR: 1. 2. 3.

ARQUEO Y CIERRE: VERIFICACIÓN: Director (diaria)

Fondo de caja: € Máximo acumulable: €

Custodia en: Ingreso en banco: cada

CÓMO SE COMUNICA LA DECISIÓN DE CAJA · PROTEGE A QUIEN LA MANEJA

«Si un día la caja no cuadra, por poco que sea, me lo decís. No pasa nada, los descuadres ocurren. Lo que no puede pasar es que alguien lo tape o lo ponga de su bolsillo. Comunicarlo os protege a vosotros.»

DECISIÓN 4 · PAGO EN EFECTIVO

Marco legal verificado: **límite de 1.000 €** cuando interviene un profesional, sin posibilidad de fraccionar la operación. Sanción del 25 % con responsabilidad solidaria. Límite interno recomendado: 900 €.

GUIÓN · RECEPCIÓN

«Por normativa no podemos aceptar pagos en efectivo de 1.000 € o más cuando interviene un profesional. Tampoco podemos fraccionarlo, porque legalmente sigue siendo la misma operación. Le busco la mejor alternativa: tarjeta, transferencia o financiación.»

DECISIÓN 5 · RECORDATORIO DE CITAS

Canal: WhatsApp / SMS / email
 Antelación: 24 h / 48 h / doble aviso
 Refuerzo telefónico en: cirugías / primeras visitas
 Responsable del envío:
 CONTENIDO: fecha, hora, ubicación, petición de confirmación
 PROHIBIDO: cualquier dato clínico

Recomendación del documento: WhatsApp a 48 h, porque con dos días de margen una cancelación permite cubrir el hueco y con uno ya no. El centro adoptó doble aviso a 48 h y a 24 h. Consulta previa: asesoría de datos.

DECISIÓN 6 · URGENCIAS FUERA DE HORARIO

Modalidad:

- A. Sin atención (deriva a urgencias generales)
- B. Solo pacientes intervenidos ← recomendado
- C. Urgencias generales
- D. Franja presencial

Horario cubierto: Quién atiende:
 Rotación: Compensación:
 Teléfono:

Si se hace cirugía, la opción A no es viable: un paciente operado que llama un sábado necesita respuesta. No es gestión, es responsabilidad profesional.
 Consulta previa: Responsable Clínico y Doctores.

COMUNICACIÓN DE LAS SEIS DECISIONES · REUNIÓN DE 20 MINUTOS

GUIÓN · DIRECCIÓN

«Os comunico seis decisiones que entran en vigor el [fecha]. Os cuento cada una, por qué la he tomado y qué cambia para vosotros. [...] Todas están por escrito y os las paso. Si alguna no se entiende o veis un problema práctico, decídmelo ahora y lo ajustamos. Lo importante es que a partir de ahora ninguno tenga que improvisar en estas cosas.»

Los cuatro elementos que no pueden faltar en cada decisión: **qué se ha decidido**
 · **por qué** · **desde cuándo** · **qué cambia para cada uno**.

Semana 3 · Los números

Saber exactamente qué se ha comprado y si va bien o mal. Si no se pueden responder los cinco de memoria, ese es el trabajo pendiente más urgente.

LOS CINCO NÚMEROS

1. Costes fijos mensuales: €
2. Punto de equilibrio: €/mes
3. Primeras visitas necesarias al día:
4. Producto pendiente: € (tendencia)
5. Meses de colchón de tesorería:

CÁLCULO 2 – PUNTO DE EQUILIBRIO

Costes fijos / margen bruto medio = €/mes
 Días laborables: FACTURACIÓN DIARIA NECESARIA: €

CÁLCULO 3 – PRIMERAS VISITAS NECESARIAS

Punto de equilibrio / ticket medio = tratamientos/mes
 Tratamientos / tasa de conversión = PRIMERAS VISITAS/MES
 PRIMERAS VISITAS/DÍA

El tercero es el número que hay que llevar en la cabeza cada día. No «hay que facturar más», sino «necesitamos X primeras visitas al día».

INVENTARIO DE PRODUCTO PENDIENTE _____

La oportunidad más rápida y el mayor riesgo a la vez. Se construye cruzando cinco fuentes: presupuestos aceptados en el sistema, registros de cobro (caja, TPV, transferencias), contratos de financiación externa, trabajos pendientes en el laboratorio y citas previstas de tratamientos no iniciados.

ANTIGÜEDAD	ACCIÓN
Más de 6 meses	 CONTACTO EN 72 HORAS
De 3 a 6 meses	 PRIMERA SEMANA
De 1 a 3 meses	 DOS SEMANAS
Menos de 1 mes	 CIRCUITO ESTÁNDAR

GUIÓN DE CONTACTO · LO HACE EL DIRECTOR EN PERSONA

«Buenos días [nombre], le llamo personalmente, soy [nombre], el director del centro. He estado revisando su caso y veo que tiene [tratamiento] contratado y abonado que todavía está pendiente de realizar. Quiero decirle dos cosas: que su tratamiento sigue exactamente en las mismas condiciones y no tiene que abonar nada más, y que quiero darle una fecha concreta, no un «ya le llamaremos». ¿Le viene bien que lo veamos el [fecha]?»

SI EL PACIENTE ESTÁ MOLESTO POR LA ESPERA

«Tiene toda la razón y le pido disculpas. Le llamo precisamente porque quiero resolverlo ya.»

Semana 4 · Credibilidad

VICTORIAS RÁPIDAS

Diez cosas pequeñas arregladas en una semana generan más credibilidad que un plan estratégico a doce meses.

La gente cree en lo que ve arreglado, no en lo que oye prometer. Se priorizan las que pidió el equipo en las entrevistas: arreglar algo que alguien mencionó, y decírselo, vale por diez mejoras que nadie pidió. Candidatos típicos: material que faltaba, una zona desordenada, un cartel obligatorio ausente, una herramienta que no funcionaba, un proceso absurdo que nadie había cuestionado.

LA DEVOLUCIÓN AL EQUIPO · OBLIGATORIA

Si se pregunta mucho y luego no pasa nada, se le habrá enseñado al equipo que hablar con la dirección no sirve. Esa lección tarda años en desaprenderse.

GUIÓN · REUNIÓN DE 30 MINUTOS

«He hablado con todos vosotros y también con gente de fuera. Os quiero contar qué he sacado en claro. Lo que me habéis dicho que funciona bien: [3-4 cosas]. Estoy de acuerdo y no lo vamos a tocar. Lo que casi todos me habéis señalado como problema: [2-3 cosas]. Coincidís, así que empezamos por ahí. Lo que ya hemos arreglado esta semana: [victorias rápidas, mencionando quién lo pidió]. Lo que vamos a hacer en los próximos dos meses: [3 acciones con responsable y fecha]. Lo que no voy a poder hacer ahora y por qué: [honestidad]. Gracias por la franqueza. Quiero que sigamos así: si algo no funciona, me lo decís.»

Panel de control del día 30

INDICADOR	OBJETIVO
Verificaciones bloqueantes cerradas	3/3
Entrevistas realizadas	Todo el equipo

INDICADOR	OBJETIVO
Decisiones urgentes tomadas	6/6
Los cinco números calculados	5/5
Producto pendiente inventariado	100 %
Casos de más de 6 meses contactados	100 %
Victorias rápidas ejecutadas	≥ 8
Devolución al equipo	Realizada
Bajas voluntarias del equipo	0
Reclamaciones de pacientes heredados	0
Documentación subida el mismo día	100 %

SEMÁFORO DEL MES	SIGNIFICA
 VERDE	Verificaciones cerradas, equipo estable y sin incidencias con pacientes
 ÁMBAR	Algo pendiente, pero con plan y con fecha
 ROJO	Una verificación bloqueante sin resolver, alguien se ha ido o hay una reclamación abierta

INFORME DE DIAGNÓSTICO – DÍA 30**1. LO QUE HE COMPRADO REALMENTE**

Pacientes activos: En tratamiento:

Producto pendiente: € Equipo: personas

Funciones críticas sin suplente:

2. LO QUE FUNCIONA BIEN (mantener)**3. LO QUE FUNCIONA MAL (corregir)****4. LO QUE NO EXISTE (crear)****5. RIESGOS DETECTADOS**

Legales: Económicos: De personas:

Clínicos: Reputacionales:

6. OPORTUNIDADES INMEDIATAS

Producto pendiente a ejecutar: €

Portadores de implantes sin seguimiento:

Presupuestos no aceptados recientes:

7. LAS TRES PRIORIDADES DE LOS PRÓXIMOS 60 DÍAS**8. INVERSIONES NECESARIAS**

Urgentes: € A 6 meses: € A 12 meses: €

Qué viene después del día 30

PERIODO	FOCO
Mes 2	Decisiones importantes 7 a 13 · verificaciones V4 a V8 · reactivación de los segmentos 1 y 2 · perfil de Google optimizado
Mes 3	Decisiones estratégicas 14 a 20 · línea base de indicadores · web y páginas estratégicas · programa de mantenimiento
Trimestre 2	Primera línea avanzada (cirugía guiada) · contenido y marketing · alianzas de derivación

Solo cuando el panel del día 30 esté en verde. No se adelanta ninguna fase: cada una se apoya en la anterior.

Las diez reglas de estos 30 días

#	REGLA
1	Las tres verificaciones bloqueantes van primero. Todo lo demás espera

#	REGLA
2	Las entrevistas tienen fecha de caducidad. Se hacen esta semana
3	No cambies nada hasta entender por qué está así
4	No prometas lo que no sabes si podrás cumplir
5	Escucha sin defenderte. En cuanto te justificas, se acabó la conversación
6	Documenta todo lo que te llame la atención, aunque no sepas si es un problema
7	Los cinco números antes que cualquier plan
8	Arregla diez cosas pequeñas antes de anunciar una grande
9	Devuelve lo que has escuchado. Si no, no te volverán a contar nada
10	Que ningún paciente heredado se sienta perdido. Es lo único que de verdad importa este mes

LA ÚNICA MÉTRICA QUE IMPORTA ESTE MES

Que ningún paciente que ya venía a esta clínica se sienta perdido en los próximos treinta días.

Esas personas son los primeros prescriptores o las primeras reseñas negativas. Y se decide ahora, no dentro de seis meses. Todo lo demás del dossier existe para que eso ocurra.

Protocolos Operativos por Perfil

Cada puesto tiene dos partes que suelen documentarse por separado y aquí van juntas: la **asistencial** —lo que hace, lo que nunca hace y a quién deriva— y la **comercial** —cómo influye realmente en que el paciente entre, entienda y se quede—. Complementa los manuales de puesto del Manual Maestro sin sustituirlos.

Parte 0 · La filosofía que lo gobierna todo

TRATAMIENTO INTEGRAL

Diagnosticamos la boca completa. Proponemos el plan completo. Ejecutamos con el orden clínico correcto y sin dejar nada a medias.

Y su reverso, igual de importante: tratamiento integral *no* significa vender siempre el plan más grande.

HACEMOS

- Diagnóstico completo, siempre
- Plan integral presentado, siempre
- Secuencia clínica correcta
- Resultado funcional y estético completo
- Seguimiento de por vida

NO HACEMOS

- Mirar solo el diente que duele
- Presentar solo lo urgente y callar el resto
- Restaurar sobre un periodonto enfermo
- Dejar una rehabilitación a medio terminar
- Cobrar y desaparecer

PRINCIPIO

CÓMO SE APLICA

La indicación es clínica, no comercial

Se propone lo que el paciente necesita, no lo que más factura

PRINCIPIO	CÓMO SE APLICA
El paciente decide	Se informa del plan completo y de las alternativas reales
Por fases es legítimo	Un plan integral ejecutado en etapas sigue siendo integral
Nunca se oculta información	El paciente conoce el cuadro completo aunque decida hacer solo una parte
Nunca se presiona	Se explica la consecuencia de no tratar, sin dramatizar

EMPARCHAR

- Se mira solo el problema visible
- Se soluciona lo puntual
- No hay plan global
- El paciente no sabe qué más tiene
- El problema se repite

FASES DE UN PLAN INTEGRAL

- Se diagnostica todo
- Se planifica todo
- Se ejecuta por etapas ordenadas
- El paciente conoce el plan completo
- El objetivo final se mantiene

«NO HALF SMILES»

Ningún tratamiento estético o rehabilitador se deja a medias. Si se inicia una rehabilitación, se termina; si hay compromiso estético, el resultado es coherente en el conjunto; no se entregan resultados parciales como si fueran finales; y si el paciente interrumpe, queda documentado que el plan no está completo.

Cómo se traduce en cada puesto

PERFIL	SU PARTE EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL
Recepción	No minimiza el motivo de consulta. Todo paciente entra al circuito completo

PERFIL	SU PARTE EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL
Auxiliar	Documenta la boca completa, no solo la zona del problema
Doctor	Diagnostica integralmente y propone el plan completo, con alternativas
Director	Presenta el plan completo con opciones de fase y financiación
Higienista	Detecta lo que aparece después y sostiene el resultado
RAC	Garantiza que lo aceptado se ejecute entero, no a medias

Perfil 1 · Recepción

Misión: ser el primer y el último contacto del paciente, garantizar que todo paciente entra al circuito completo y que toda la documentación queda trazable el mismo día.

PARTE ASISTENCIAL

- Acogida y acompañamiento a sala
- Verificación de identidad y de ficha correcta
- Entrega, recogida y digitalización de documentación clínica
- Custodia y acceso controlado de la historia clínica
- Triage inicial de urgencias y derivación al Doctor
- Confidencialidad en mostrador y al teléfono

LO QUE NUNCA HACE

- Dar información clínica de ningún tipo
- Interpretar pruebas o resultados
- Aconsejar sobre medicación
- Valorar por su cuenta la urgencia clínica: deriva
- Confirmar ante terceros que alguien es paciente

TRIAJE TELEFÓNICO DE URGENCIAS

LO QUE DICE EL PACIENTE	NIVEL	ACTUACIÓN
Sangrado que no cede · pérdida de conciencia · dificultad respiratoria	 VITAL	112 y aviso inmediato al Doctor

LO QUE DICE EL PACIENTE	NIVEL	ACTUACIÓN
Dolor intenso · traumatismo · inflamación creciente · fiebre tras cirugía	■ URGENCIA	Pasar al Doctor. Atención el mismo día
Molestia leve · prótesis descementada sin dolor	■ PREFERENTE	Huevo en 24-48 h
Duda sobre medicación o postoperatorio	■ URGENCIA	Pasar al Doctor. Nunca responder
Consulta administrativa	■ ORDINARIA	Resolver

Regla: ante cualquier duda sobre la gravedad se pasa al Doctor. Nunca se decide desde recepción.

SU PAPEL COMERCIAL REAL

Recepción no vende tratamientos, pero determina si el paciente llega o no: la llamada decide si agenda o cuelga; el motivo detallado permite personalizar todo el circuito; el origen registrado es lo que hace medible el marketing; la acogida confirma o desmiente la expectativa; la confirmación de cita recupera capacidad; y la despedida es la base de la recomendación.

REDUCE EL CASO

- «¿Solo una limpieza?»
- «Para eso con una revisión rápida vale»
- «¿Le pongo con el higienista directamente?»

ABRE EL CASO

- «Perfecto, en su primera visita hacemos un estudio completo»
- «Le hacemos un diagnóstico completo para ver cómo está todo»
- «Le agendamos primera visita con estudio completo»

Un paciente que entra por una limpieza puede necesitar tratamiento integral. Si se le agenda solo la higiene, nunca se le diagnostica.

OBJECIONES AL TELÉFONO

OBJECCIÓN	RESPUESTA
«¿Cuánto cuesta un implante?»	«Depende de cada caso, y por eso la primera visita con estudio completo es gratuita: para poder darle un precio real y no una estimación al aire.»
«Solo quiero una limpieza»	«Perfecto. La primera visita incluye el estudio completo, y así el doctor valora también si necesita algo más. Sin coste.»
«Me lo tengo que pensar»	«Claro. ¿Le apunto y si acaso lo cambiamos? Así le guardo el hueco.»
«¿Es caro?»	«Le paso con el director, que le explica las opciones de pago que tenemos.»
«Me han dicho que no tengo hueso»	«Es de las cosas que más vemos aquí. Le recomiendo pedir una segunda opinión, es sin coste.»

CHECKLIST DE JORNADA

- ☐ **Apertura:** sistema abierto, agenda revisada, casos delicados identificados, zona en orden, cartelaría correcta, impresos, datáfono operativo y caja con fondo verificado
- ☐ **Durante:** teléfono en tres tonos, origen registrado, saludo por el nombre, nadie esperando sin explicación, documentación digitalizada según llega, ninguna información clínica o económica dada por cuenta propia y citas del día siguiente confirmadas
- ☐ **Cierre:** 100 % de documentación subida, arqueo firmado, agenda de mañana revisada, casos delicados señalados, ausencias contactadas, mensajes derivados y zona ordenada

INDICADORES

INDICADOR	OBJETIVO
Documentación subida el mismo día	100 %
Origen del paciente registrado	≥ 98 %
Fichas duplicadas creadas	0
Tiempo de espera del paciente	~0 min
Descuadres de caja	0

INDICADOR	OBJETIVO
Ausencias sin contactar el mismo día	0

Perfil 2 · Director de clínica / Asesor

Misión: conducir el proceso comercial completo garantizando que cada paciente recibe el plan integral que necesita, presentado con claridad, con alternativas reales y sin presión.

PARTE ASISTENCIAL

- Anamnesis inicial: expectativas, motivación y contexto
- Explicación de derechos y consentimiento RGPD
- Redacción del IAC al dictado del Doctor
- Briefing y alineación con el Doctor
- Acompañamiento y continuidad de la experiencia

SUS LÍMITES

- No diagnostica ni indica tratamiento
- No interpreta pruebas
- No modifica un plan clínico
- No responde dudas clínicas

Ante cualquier pregunta clínica: «eso se lo explica mejor el doctor, se lo pregunto ahora mismo».

NUNCA

- Presentar solo lo urgente
- Ocultar el resto del diagnóstico
- «Empezamos por esto y ya veremos»
- Adaptar el diagnóstico al presupuesto del paciente

SIEMPRE

- Presentar el plan completo
- Explicar todo lo detectado
- «El plan completo es este; podemos hacerlo en fases así»
- Adaptar la ejecución, nunca el diagnóstico

GUIÓN · PRESENTAR UN PLAN INTEGRAL POR FASES

«[Nombre], le explico el plan completo y luego vemos cómo organizarlo. Lo que necesita su caso es [plan completo]. Eso es lo ideal y es a donde queremos llegar. Ahora bien, esto se puede hacer de dos formas: todo seguido, que es lo más eficiente; o por fases, empezando por [fase clínicamente prioritaria] y continuando cuando a usted le venga bien. Lo que no le recomiendo es hacer solo una parte y olvidarnos del resto, porque [consecuencia clínica real]. Si vamos por fases, vamos por fases con un plan, no a salto de mata. ¿Qué le encaja mejor?»

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA

1 Justificar el valor antes del número: diagnóstico completo, tecnología, materiales, garantías y seguimiento.	2 Presentar el plan completo por fases, con tiempo total y número de citas.	3 Desglose línea por línea, cada partida explicada.	4 Opciones de ejecución: completo o por fases.	5 Opciones de pago: anticipado con bonificación, financiación con cuota calculada o fases.
6 Cierre por alternativa o por asunción.				

SECUENCIA OBLIGATORIA ANTE UNA OBJECCIÓN DE PRECIO

1 · Valor	2 · Facilidades	3 · Fases	4 · Descuento
-----------	-----------------	-----------	---------------

Reencuadrar como inversión.	Financiación y cuota mensual.	Plan integral en etapas.	Solo entonces, si procede, dentro de tabla y con registro.
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

Desarrollada en la **Fase 10 del Protocolo de Primera Visita.**

LO QUE NUNCA SE HACE COMERCIALMENTE

- Descuento como primera respuesta
- Urgencia artificial: «solo hoy»
- Prometer resultados garantizados
- Presentar un plan reducido para que «salga más barato»
- Cerrar sin que el paciente haya entendido su diagnóstico
- Descalificar a otras clínicas

CHECKLIST ANTES DE CADA PRESENTACIÓN

- ☐ CBCT cargado y OPG visible
- ☐ Fotografías extraorales e intraorales
- ☐ Imágenes de cámara intraoral
- ☐ Informe de ortodoncia si aplica
- ☐ Briefing con el Doctor realizado
- ☐ Plan único acordado
- ☐ Objeciones previsibles anticipadas

CHECKLIST DESPUÉS DE CADA CIERRE

- ☐ Estado de la PV registrado
- ☐ Importe presentado y aceptado
- ☐ Método de pago
- ☐ Razón de no conversión si aplica
- ☐ Aviso a RAC si acepta
- ☐ Tarea de seguimiento si no acepta

Perfil 3 · Doctor / Odontólogo

Misión: ser la autoridad clínica: diagnosticar la boca completa, proponer el plan integral que el paciente necesita, ejecutarlo con calidad y dejarlo documentado.

EL PRINCIPIO INTEGRAL EN EL DIAGNÓSTICO

Un paciente que viene por un diente y sale con el diagnóstico de un diente no ha sido diagnosticado.

Siempre se valora: estado periodontal, estado de cada pieza, oclusión y función, ATM, restauraciones previas, ausencias y su repercusión, estado óseo, tejidos blandos, componente estético y hábitos y factores de riesgo.

SECUENCIA CLÍNICA DEL PLAN INTEGRAL

Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Urgencia. Lo que no puede esperar: dolor, infección.	Estabilización. Base sana: periodoncia, control de caries, extracciones.	Rehabilitación. Implantes, prótesis y restauración funcional.	Finalización. Estética, ajuste oclusal y detalles.	Mantenimiento. Programa de seguimiento de por vida.

Regla clínica innegociable: no se rehabilita sobre una base no estabilizada. La secuencia no se altera por conveniencia comercial ni por prisa del paciente.

CÓMO SE GENERA CONCIENCIA SIN PRESIONAR

TÉCNICA	EJEMPLO
Mostrar, no contar	«¿Ve esto en la pantalla? Esto es lo que le comentaba»
Comparar con lo normal	«Compare esta zona con esta otra, que es como debería estar»
Explicar la evolución	«Si esto no se trata, lo esperable es que...»
Conectar con su vida	«Usted me decía que le costaba comer. Esto es por qué»
Ser honesto con lo bueno	«Esta zona está perfecta, no hay que tocarla»

La última es la que más credibilidad da: quien dice «aquí no hace falta nada» es creído cuando dice que en otro sitio sí.

LO QUE NUNCA HACE

- Indicar tratamientos por rentabilidad

- Exagerar la gravedad
- Negociar precios
- Prometer resultados garantizados
- Presentar un plan distinto al acordado en briefing
- Criticar trabajos previos delante del paciente

La conversión no se decide en el momento del precio: se decide en el momento en que el paciente entiende su problema.

CHECKLIST POR CADA PACIENTE NUEVO

- ☐ Anamnesis médica completa: alergias, medicación y cirugías
- ☐ Anamnesis dental completa
- ☐ Consentimiento radiológico explicado y firmado
- ☐ Exploración extraoral e intraoral completa, con cámara intraoral
- ☐ Anamnesis de expectativas en sus cuatro dimensiones
- ☐ Briefing con el Director antes de presentar
- ☐ Diagnóstico integral formulado y plan por fases con secuencia clínica
- ☐ IAC dictado, revisado y firmado, y solicitud de presupuesto firmada
- ☐ Registro en el sistema el mismo día

POR CADA ACTO QUIRÚRGICO

- ☐ Consentimiento específico firmado
- ☐ Checklist quirúrgico antes de empezar y material verificado
- ☐ Trazabilidad de implantes registrada
- ☐ Instrucciones postoperatorias entregadas por escrito
- ☐ Seguimiento agendado y registro completo el mismo día

Perfil 4 · Higienista

Misión: sostener el resultado del tratamiento integral a lo largo del tiempo, ejecutar el programa de mantenimiento y detectar precozmente lo que aparece después. El alcance concreto de sus actuaciones lo determina su titulación y la normativa: este protocolo organiza la función, no amplía competencias.

DERIVAR NO ES UN FALLO

Ante cualquier duda, se deriva. Derivar es hacer bien el trabajo.

Se registra lo observado, se avisa al Doctor en el momento y el paciente no se marcha sin valoración si el signo es relevante.

SU POSICIÓN COMERCIAL ÚNICA

- Es el perfil con más contacto recurrente con el paciente
- La conversación durante el mantenimiento detecta necesidades no expresadas
- Detectar problemas nuevos genera tratamiento legítimo
- Es el mejor momento para pedir reseña: paciente satisfecho y sin tratamiento pendiente
- Es quien más confianza tiene para el programa de referidos

DETECTA, REGISTRA Y DERIVA · NUNCA VENDE

DETECTA	COMUNICA	DERIVA A
Problema clínico nuevo	«Voy a comentárselo al doctor»	Doctor
Deterioro de restauración	Registro y aviso	Doctor
Interés estético expresado	«Se lo comento al director»	Director
Familiar que necesita tratamiento	«Puede pedir cita, la primera visita es sin coste»	Recepción

GUIÓN · EL MANTENIMIENTO COMO ÚLTIMA FASE DEL TRATAMIENTO

«Su tratamiento no termina cuando colocamos el implante. Termina cuando ese implante lleva veinte años funcionando bien. Para eso está el mantenimiento.»

GUIÓN · PETICIÓN DE RESEÑA

«[Nombre], me alegro de que todo esté funcionando tan bien. Le pido un favor: si está contento con nosotros, ¿le importaría dejarnos una reseña en Google? Para nosotros es lo que más ayuda. Le paso el enlace por WhatsApp, es un minuto.»

SITUACIÓN	DERIVA A	URGENCIA
Signo de alarma periimplantario	Doctor	 INMEDIATA
Dolor o inflamación	Doctor	 INMEDIATA
Movilidad de implante o prótesis	Doctor	 INMEDIATA
Caries o deterioro detectado	Doctor	 MISMA VISITA
Problema periodontal en progresión	Doctor	 MISMA VISITA
Interés en tratamiento estético	Director	 MISMO DÍA
Paciente que no cumple el mantenimiento	Director, para reactivación	 SEMANAL
Familiar interesado	Recepción	 MISMO DÍA

Perfil 5 · Auxiliar

Misión: garantizar la seguridad, la higiene y la fluidez de la actividad clínica, y documentar la boca completa para que el diagnóstico integral sea posible.

PRUEBA	ALCANCE OBLIGATORIO
CBCT	Según indicación del Doctor
OPG	Panorámica completa
Escaneado intraoral	Ambas arcadas completas
Fotografía extraoral	Frontal en reposo, frontal en sonrisa, perfiles y tres cuartos
Fotografía intraoral	Frontal en oclusión, laterales, oclusales superior e inferior y detalles

Sin registro completo no hay diagnóstico integral posible, ni comparación futura, ni material de presentación.

ESTERILIZACIÓN · RESPONSABILIDAD CRÍTICA

El circuito no admite atajos ni excepciones: unidireccional, limpieza previa correcta, secado completo antes de empaquetar, etiquetado con fecha y caducidad, registro de cada ciclo, controles según protocolo, almacenamiento en zona limpia y rotación por caducidad.

Ante control fallido: el material no se usa, se reprocesa, se comunica al responsable clínico y se registra la incidencia.

GUIÓN DURANTE LAS PRUEBAS

CBCT

«[Nombre], le voy a hacer una tomografía 3D. Es totalmente indolora: solo tiene que quedarse quieto unos segundos mientras el aparato gira. Esta prueba es la que nos permite ver el hueso en tres dimensiones, y es la base de todo el diagnóstico.»

ESCANEADO

«Con este escáner tomo un modelo digital exacto de su boca, sin las pastas de molde de toda la vida. Es mucho más cómodo.»

FOTOGRAFÍA

«Y ahora unas fotografías, de fuera y de dentro. Nos sirven para el diagnóstico completo y también para que usted pueda ver la diferencia cuando terminemos.»

La última frase anticipa el resultado y crea expectativa: es comercialmente muy potente sin prometer nada.

LO QUE DETECTA Y DERIVA

- Ansiedad significativa → Doctor y Director
- Comentario sobre otro problema no consultado → Doctor
- Interés en otro tratamiento → Director
- Queja o incomodidad → Director
- Imagen de calidad dudosa → se repite, no se deriva

INDICADORES

INDICADOR	OBJETIVO
Tiempo de batería diagnóstica	≤ 15 min
Repetición de pruebas por calidad	< 5 %
Registros de esterilización completos	100 %
Imágenes cargadas en el momento	100 %
Material caducado detectado a tiempo	100 %

Perfil 6 · RAC · Responsable de Atención al Cliente

Misión: garantizar que todo tratamiento aceptado se ejecuta completo, en el menor tiempo posible y sin incidencias de pago ni de material. Es quien impide que un plan integral aceptado se quede a medias.

SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL

Un plan de tres fases aceptado y con solo la primera ejecutada es un plan incompleto, no un plan terminado.

Control semanal de: casos con fases pendientes, casos con fase ejecutada y sin la siguiente agendada, casos parados sin motivo registrado y casos con demasiados meses sin avanzar, que escalan a Dirección.

RECUPERA FACTURACIÓN QUE SE ESTABA PERDIENDO

- Ejecutar producto pendiente convierte caja parada en producción
- Reactivar planes parados recupera fases no ejecutadas
- Confirmar cirugías reduce cancelaciones de alto valor
- Contactar casos antiguos recupera pacientes en el limbo

BLOQUEOS ANTES DE AGENDAR

- ☐ Pago verificado
- ☐ Material verificado con el Auxiliar
- ☐ Si hay que pedir material, plazo real incorporado
- ☐ Doctor disponible
- ☐ Quirófano disponible

GUIÓN · RECUPERACIÓN DE UN PLAN PARADO

«[Nombre], le llamo porque estaba revisando su tratamiento. Usted tiene pendiente [fase], que era el siguiente paso del plan que acordamos. ¿Ha habido algún motivo para pararlo, o simplemente se fue quedando? Si le parece, le busco fecha y lo retomamos. Cuanto antes lo completemos, mejor resultado tendrá el conjunto.»

GUION · CASO HEREDADO CON ESPERA LARGA

«[Nombre], le llamo porque tenemos ya cerrada la fecha para su [tratamiento]: el [fecha]. Sé que llevaba tiempo pendiente y quería confirmárselo personalmente.»

Este gesto recupera confianza de forma muy eficaz en pacientes que llevaban meses esperando. Nunca se cuestiona al paciente que afirma haber pagado: se deriva a Dirección.

INDICADOR	OBJETIVO
Producto pendiente total	Descenso sostenido
Casos de más de seis meses	0
Tiempo medio de aceptación a ejecución	Mínimo
Cirugías sin incidencias de pago o material	100 %
Casos con fases pendientes sin agendar	0

Mapa de derivaciones internas

REGLA	DETALLE
Todo lo clínico va al Doctor	Sin excepción y sin filtro
Todo lo económico va al Director	Ningún otro perfil da cifras
Todo lo excepcional va a Gerencia	Devoluciones, descuentos fuera de tabla y crisis
Ante duda, se deriva	Derivar nunca es un error
La derivación se registra	Queda constancia de qué y a quién
El paciente no espera a la derivación	Se le atiende mientras se resuelve

Sistema de reportes consolidado

Cada perfil entrega un reporte breve al Director al cierre de la jornada; el Director consolida y entrega a Gerencia. Veintiún minutos de reporte diario en total: menos que una sola reunión de coordinación improvisada.

PERFIL	QUÉ REPORTA A DIARIO	TIEMPO	A QUIÉN
Recepción	Agenda, caja, documentación y ausencias	5 min	Director
Doctor	Actividad, calidad y derivaciones	5 min	Director
Higienista	Mantenimientos, derivaciones y detección	3 min	Director
Auxiliar	Diagnóstico, esterilización y material	3 min	Director
RAC	Cirugías, verificaciones y producto pendiente	5 min	Director
Director	Consolidado del día	5 min	Gerencia

REPORTE DIARIO – DIRECCIÓN

Fecha:

ACTIVIDAD

Pacientes atendidos: ____ Primeras visitas: ____

Convertidas: ____ Tasa: ____%

Importe presentado: _____ € Aceptado: _____ € Ticket medio: _____ €

PLANES

Integrales presentados: ____ Aceptados completos: ____

Aceptados por fases: ____ No aceptados: ____

Razones de no conversión registradas: ☐

VERIFICACIONES

Documentación 100%: ☐ Caja cuadrada: ☐

Cirugías de mañana verificadas: ☐

Casos delicados de mañana asignados: ☐

INCIDENCIAS:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON PACIENTES:

SEMÁFORO DEL DÍA: verde / ámbar / rojo

PERFIL	REPORTE SEMANAL
Director	Producción, conversión y planes integrales
RAC	Panel de producto pendiente y planes incompletos

PERFIL	REPORTE SEMANAL
Higienista	Programa de mantenimiento y adherencia
Recepción	Agenda, ocupación y origen de los pacientes
Auxiliar	Stock, esterilización e incidencias de equipos

Las seis reglas que sostienen el sistema

#	REGLA	RESPONSABLE
1	Todo paciente entra al circuito completo	Recepción
2	Se documenta la boca completa	Auxiliar
3	Se diagnostica integralmente, siempre	Doctor
4	Se presenta el plan completo, siempre	Director
5	Se ejecuta entero, no a medias	RAC
6	Se mantiene el resultado de por vida	Higienista

LA CONSECUENCIA

Un tratamiento integral no lo hace un profesional: lo hacen seis perfiles ejecutando cada uno su parte sin saltarse ninguna.

Si uno solo emparcha, el sistema entero emparcha.

DOCUMENTO 08

Innovación Aplicada al Protocolo

· 18 fichas de implantación

No es un catálogo de tecnología: es un manual de implantación. Cada innovación viene con su protocolo, su guion, su formación, su plan B, su indicador y los errores documentados de quienes ya lo intentaron. Toda innovación clínica requiere validación del responsable clínico antes de aplicarse.

PRINCIPIO RECTOR

Ninguna innovación entra si no mejora una de estas cuatro cosas: la seguridad del paciente, la precisión del diagnóstico, la comprensión del paciente o el tiempo hasta el resultado.

Y la regla que evita el fracaso: **una innovación por trimestre, consolidada antes de la siguiente**. Activar varias a la vez garantiza que ninguna quede bien implantada y que el equipo pierda la confianza en el sistema. Es el error documentado con más frecuencia en digitalización de clínicas.

LOS CINCO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

#	CRITERIO	VERIFICACIÓN
1	Funciona técnicamente	Sin incidencias durante dos semanas
2	El equipo la usa sin supervisión	Observación directa
3	Existe protocolo de contingencia	Documentado y probado
4	Se mide su impacto	Indicador definido y con datos
5	El paciente la percibe como mejora	Feedback recogido

Si falta cualquiera de los cinco, la innovación está «en pruebas», no implantada. Y no se activa la siguiente.

LOS TRES NIVELES

NIVEL	REQUIERE	PLAZO	RIESGO
N1	Protocolo y formación. Sin inversión	0–3 meses	BAJO
N2	Software o equipamiento accesible	3–12 meses	MEDIO
N3	Inversión relevante o validación clínica	12–36 meses	ALTO

Las dieciocho fichas

#	INNOVACIÓN	FASE	NIVEL	PROPIETARIO	QUÉ RESUELVE
01	Triaje estructurado de contacto	1	N1	Recepción	La cualificación depende de quién coja el teléfono y de su ánimo
02	Cuestionario previo digital	1	N1-N2	Recepción	Quince minutos de trámite que restan tiempo a la conversación
03	Asistente conversacional de captación	1	N2	Dirección	Los contactos fuera de horario se pierden
04	Tour activo con demostración	2	N1	Dirección	El tour se convierte en un recital que se olvida en cinco minutos
05	Firma digital y documentación automatizada	3 · 4 · 11	N2	Recepción	Escaneo manual de ocho documentos por paciente
06	Consentimiento con verificación de comprensión	4	N1	Doctor	Una firma sin comprensión no es un consentimiento
07	Flujo digital integrado	5	N2	Auxiliar	Las pruebas existen como archivos sueltos
08	Prediagnóstico asistido por IA	5	N2	Doctor	Hallazgos que pasan desapercibidos en jornadas largas
09	El paciente ve su modelo 3D	5	N1	Auxiliar	El paciente vive las pruebas como un trámite pasivo

#	INNOVACIÓN	FASE	NIVEL	PROPIETARIO	QUÉ RESUELVE
10	Modelo de estratificación de riesgo	7	N1	Doctor	Hay diagnóstico del presente, pero no proyección del futuro
11	Generación asistida del IAC	8	N2	Director y Doctor	Diez minutos de redacción por caso y riesgo de omisión
12	Navegación 3D en la presentación	9	N2	Doctor y Director	Las imágenes estáticas no explican; el paciente asiente sin entender
13	Visualización de la progresión sin tratamiento	9	N2	Doctor	La consecuencia de no tratar se describe y no se comprende
14	Escenarios comparados en el cierre	10	N1-N2	Director	El presupuesto se compara con cero
15	Recordatorios con confirmación	12	N2	Recepción	Las ausencias son capacidad pagada y perdida
16	Lista de espera automática	12	N2	Recepción	El hueco de una cancelación se pierde porque nadie puede llamar
17	Monitorización remota	14	N2	Higienista y Doctor	Entre visitas no hay información del paciente
18	Perfil Alma · informe anual predictivo	14	N1	Higienista y Doctor	El mantenimiento parece opcional

Fichas destacadas

FICHA 01 · TRIAJE ESTRUCTURADO DE CONTACTO

Cada contacto se clasifica en cuatro ejes: **motivo** (implantología, ortodoncia, general o mantenimiento), **urgencia** (vital, urgente, preferente o estándar), **perfil** (caso complejo, ansiedad, infantil o estándar) y **origen** (canal exacto de captación). De ahí sale la asignación automática de profesional y franja.

PERFIL DETECTADO	FRANJA	PROFESIONAL	DURACIÓN
Caso complejo implantológico	Mañana	Implantólogo	Ampliada
Ansiedad manifiesta	Primera hora	Con más tiempo asignado	Ampliada
Infantil	Tarde o día no lectivo	Ortodoncista	Estándar
Ortodoncia adulto	Tarde, 18-20 h	Ortodoncista	Estándar
Estándar	Según disponibilidad	Según motivo	Estándar

Formación: 30 minutos practicando con diez casos ficticios. Indicador: 100 % de contactos con los cuatro ejes clasificados. Error documentado: clasificar por costumbre en lugar de preguntar.

FICHA 02 · CUESTIONARIO PREVIO DIGITAL

Contenido obligatorio: identificación, contacto con canal preferente, historia médica (patologías, medicación, alergias, cirugías), historia dental y motivo ampliado. Recomendados: expectativas y preocupaciones.

- Máximo tres minutos: más reduce la tasa a la mitad
- Optimizado para móvil, que es donde se rellena
- Sin campos innecesarios: cada campo extra pierde respuestas
- Guardado automático y aviso de protección de datos visible

GUIÓN DE ENVÍO · RECEPCIÓN

«Perfecto, [nombre], le espero el [día] a las [hora]. Le voy a enviar ahora un cuestionario breve por WhatsApp, tres minutos. Si lo rellena antes de venir, el doctor ya habrá revisado su caso cuando llegue y aprovechamos mucho mejor la visita. Y si le surge cualquier duda antes, escríbanos por aquí mismo.»

RECORDATORIO A 48 H SI NO ESTÁ CUMPLIMENTADO

«Hola [nombre], le recordamos su cita del [día]. Si puede, rellene este cuestionario antes de venir: [enlace]. Son tres minutos y nos ayuda mucho. Si no le da tiempo, no se preocupe, lo hacemos aquí.»

La última frase es la importante: elimina la sensación de obligación y, paradójicamente, sube la tasa. Objetivo: $\geq 60\%$ cumplimentados antes de la cita. Si el paciente llega sin rellenarlo, se hace en consulta como siempre y nunca se le hace sentir mal por ello.

FICHA 03 · ASISTENTE CONVERSACIONAL DE CAPTACIÓN

SÍ HACE

- Responder preguntas frecuentes
- Explicar cómo funciona la primera visita
- Dar rangos orientativos de precio
- Recoger motivo y datos
- Agendar o dejar el contacto preparado
- Derivar a una persona cuando procede

NO HACE

- Dar información clínica ni diagnosticar
- Dar presupuestos cerrados
- Sustituir la llamada en horario
- Gestionar quejas
- Tratar urgencias clínicas

TONO QUE FUNDE LA CONVERSIÓN

- «Te llamamos para hablarte de nuestros precios»
- «Aprovecha nuestra promoción»
- «Déjanos tus datos y te informamos»

TONO QUE CONVIERTE

- «¿Quieres que te llamemos mañana para explicarte cómo funciona la primera visita?»
- «La primera visita incluye el estudio completo sin coste»
- «Si me dices tu nombre y un teléfono, te llamamos cuando abramos»

LA REGLA DEL PRECIO

Se da el rango. Ocultarlo genera desconfianza y reduce la conversión: «El rango de un implante unitario suele estar entre [X] y [Y] euros, dependiendo del caso. El precio exacto depende de lo que veamos en la valoración, que es sin coste. ¿Quieres que te agendemos?»

SITUACIÓN	ESCALADO A PERSONA
Urgencia con síntomas	Derivación inmediata y aviso al teléfono de guardia
Queja o reclamación	A Dirección, sin intentar resolverla
Pregunta clínica específica	«Eso te lo explica mejor el doctor» y se agenda
El paciente insiste en hablar con una persona	Derivación inmediata, sin resistencia
Tres intercambios sin avance	Derivación automática

SI EL PACIENTE PREGUNTA «¿ESO ERA UN ROBOT?»

«Es nuestro asistente automático, que atiende fuera de horario para que nadie se quede sin respuesta. Pero a partir de aquí le atiendo yo.»

FICHA 04 · TOUR ACTIVO CON DEMOSTRACIÓN

ANTES

- «Aquí tenemos el CBCT»
- «Trabajamos con planificación digital»
- «Tenemos escáner intraoral»
- Se menciona la esterilización

DESPUÉS

- Se enciende y se muestra una imagen real
- Se abre una planificación en pantalla
- Se muestra un modelo 3D girando
- Se ve el ciclo en marcha y su registro

Requisito previo: tener preparado un caso de demostración anonimizado — CBCT, planificación y modelo 3D— listo para mostrar en cualquier momento, sin datos identificables o con consentimiento expreso para uso demostrativo.

EN LA SALA DE IMAGEN

«Esto es el CBCT. Le enseño una tomografía para que vea lo que nos permite ver —es de un caso de demostración, sin datos de nadie—. Esto blanco es hueso. Esto de aquí es el nervio dentario. Y esta línea es la posición exacta donde iría un implante, calculada al milímetro. Todo esto lo planificamos en el ordenador antes de tocar nada. Por eso sabemos exactamente qué vamos a encontrar.»

EN ESTERILIZACIÓN

«Aquí está el autoclave. Cada ciclo queda registrado: qué instrumental, qué día, qué controles. Es algo que el paciente normalmente no ve, pero para nosotros es innegociable.»

Error documentado: saltarse el tour por falta de tiempo. Si no hay tiempo para el tour, el problema está en la agenda, no en el tour.

FICHA 06 · CONSENTIMIENTO CON VERIFICACIÓN DE COMPRENSIÓN

1 Explicar con soporte visual.	2 Preguntar: «¿me puede repetir con sus palabras qué le vamos a	3 Aclarar lo que no haya quedado claro.	4 Firmar.	5 Registrar que la comprensión fue verificada.
-----------------------------------	--	--	--------------	---

	hacer y por qué?».			
--	--------------------	--	--	--

EL REGISTRO QUE MARCA LA DIFERENCIA

En la historia clínica: «Consentimiento explicado. Se verifica comprensión mediante repetición por el paciente. Se resuelven dudas sobre [tema]. Firma.»

Esa anotación es lo que convierte un consentimiento firmado en un consentimiento válido, y es el punto más débil de la mayoría de las clínicas ante una reclamación.

FICHA 08 · PREDIAGNÓSTICO ASISTIDO POR IA

REGLA INNEGOCIABLE

El prediagnóstico es una segunda lectura, nunca la primera. El Doctor diagnostica; el sistema señala.

El orden importa: si el Doctor lee primero el informe automático, condiciona su criterio. Auxiliar carga la imagen → el sistema genera hallazgos → **el Doctor realiza su lectura primero** → después contrasta → registra concordancias y discrepancias → decide el diagnóstico final.

Las discrepancias registradas —la IA detecta y el Doctor descarta, o el Doctor detecta y la IA no señala— son material de calibración: a los seis meses se sabe en qué acierta y en qué falla la herramienta.

QUÉ SE LE DICE AL PACIENTE

«Además de mi valoración, pasamos todas las radiografías por un sistema de análisis asistido que actúa como una segunda revisión. Sirve para que no se nos escape nada.»

Nunca «el ordenador dice que tiene...». La autoridad diagnóstica es del profesional.

FICHA 10 · MODELO DE ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO

La innovación de mayor alcance estratégico del sistema, y no cuesta nada. La exploración produce un diagnóstico del presente; no produce la proyección del futuro, que es justo lo que el paciente necesita para decidir y lo que fundamenta el

mantenimiento. Los criterios clínicos que determinan cada nivel los define el responsable clínico: este documento aporta la estructura organizativa, no el criterio.

PERFIL DE RIESGO – [Paciente] · [Fecha]

RIESGO PERIODONTAL Factores: Nivel: alto / medio / bajo

RIESGO DE CARIES Factores: Nivel: alto / medio / bajo

RIESGO BIOMECÁNICO Factores: Nivel: alto / medio / bajo

RIESGO PERIIMPLANTARIO Factores: Nivel: alto / medio / bajo

FACTORES SISTÉMICOS Y CONDUCTUALES:

PERFIL GLOBAL: alto / medio / bajo

PERIODICIDAD INDICADA: cada meses

PROYECCIÓN A 5 AÑOS SIN INTERVENCIÓN:

GUION DEL DOCTOR

«[Nombre], le voy a explicar dos cosas distintas y quiero que distinga bien entre ellas. La primera es lo que tiene hoy: [hallazgos actuales]. Eso lo resolvemos con el tratamiento. La segunda, que es la que más me preocupa, es hacia dónde va. Su perfil de riesgo periodontal es alto por [factores concretos]. Eso significa que si no hacemos nada distinto a lo que ha hecho hasta ahora, lo esperable en cinco años es [proyección realista]. El tratamiento resuelve lo primero. El seguimiento evita lo segundo. Y son dos decisiones diferentes.»

FASE	CÓMO CAMBIA CON EL PERFIL DE RIESGO
9	Se presenta riesgo futuro, no solo daño presente
10	El argumento deja de ser el precio y pasa a ser la consecuencia
14	La periodicidad del mantenimiento tiene fundamento individual

FASE	CÓMO CAMBIA CON EL PERFIL DE RIESGO
Programas	El plan de mantenimiento pasa de «caro» a «el que corresponde a su perfil»

Error documentado: registrar el perfil y no usarlo. Si no se comunica al paciente y no determina la periodicidad, es papeleo.

FICHA 12 · NAVEGACIÓN 3D EN LA PRESENTACIÓN

La coreografía es lo que la hace funcionar: **el Doctor narra e indica, el Director opera la pantalla. Nunca los dos a la vez.**

DOCTOR		DIRECTOR
"Vamos a ver su caso"	→	abre el modelo
"Gíralo hacia la derecha"	→	gira
"Amplía esta zona"	→	amplía
"Enséñale el corte"	→	secciona
"Ahora la comparativa"	→	abre lado a lado

GUION DEL DOCTOR

«[Nombre], esto es su boca en tres dimensiones, la que le hicimos hace un rato. Aquí está el problema principal. Le doy la vuelta para que lo vea mejor. ¿Ve esta zona más oscura? Ahí es donde falta hueso. Y esto amarillo es el nervio: por eso hay que planificarlo con precisión milimétrica. Y ahora compare con esta zona de aquí, que está sana. La diferencia se ve, ¿verdad?»

Requisito: ensayo previo. La primera vez que se usa delante de un paciente no puede ser la primera vez que se usa.

FICHA 13 · VISUALIZACIÓN DE LA PROGRESIÓN SIN TRATAMIENTO

REGLA ÉTICA INNEGOCIABLE

Se proyecta lo clínicamente esperable, nunca el peor escenario posible para presionar.

La exageración se detecta, destruye la confianza y expone al centro.

GUIÓN

«Le voy a enseñar algo que quiero que entienda bien. Esto es su situación hoy. Y esto de aquí es un caso en un estadio más avanzado del mismo proceso —no es usted, es una referencia—. Con su perfil de riesgo, si no intervenimos, esto es lo esperable en unos años. No se lo digo para asustarle: se lo digo para que tenga toda la información antes de decidir.»

FICHA 14 · ESCENARIOS COMPARADOS EN EL CIERRE

El presupuesto se presenta como una cifra única frente a la nada, y el paciente la compara con cero. Con tres escenarios, compara entre opciones reales.

ESCENARIO	CONTENIDO
A · Plan completo	Tratamiento integral, tiempo, importe y cuota
B · Por fases	Secuencia, tiempos, importes parciales y cuotas
C · Sin tratamiento	Evolución esperable y coste futuro estimado

El escenario C es el que casi nadie muestra y el que más convierte. No como amenaza: como información completa. «No hacer nada también es una opción legítima. Lo que pasa es que con su perfil, en unos años lo esperable es [proyección], y entonces el tratamiento sería más complejo. No le estoy presionando: le estoy dando la información completa para que decida usted.»

FICHAS 15 Y 16 · RECORDATORIOS CON CONFIRMACIÓN Y LISTA DE ESPERA

CONFIRMACIÓN DEL 40-50 %

- «Cita confirmada 23/04 10:00»

CONFIRMACIÓN DEL 80-90 %

- «Hola Marta, te recordamos tu cita mañana a las 10:00 con el Dr. Pérez. ¿Confirmas?»

Misma tecnología, distinto tono. Reglas de contenido: nombre del paciente, nombre del profesional, día y hora en lenguaje natural, pregunta directa de confirmación y nunca datos clínicos. Antelación: confirmación con ubicación al agendar, recordatorio con petición de confirmación a 48 h y llamada personal el día antes en cirugías y primeras visitas.

TRATAMIENTO	¿SIRVE PARA LISTA DE ESPERA AUTOMÁTICA?
Revisiones y mantenimientos	MUY ALTA
Controles de ortodoncia	MUY ALTA
Higienes	ALTA
Primeras visitas	MEDIA
Cirugías	NO: REQUIEREN PREPARACIÓN

La clave es la inmediatez: el aviso sale cuando entra la cancelación, no cuando alguien encuentra un rato para llamar. El primero que responde se queda la cita y el aviso se cierra automáticamente para el resto.

FICHA 18 · PERFIL ALMA · INFORME ANUAL PREDICTIVO —

El producto que ningún competidor tiene. Lo elabora el Higienista y lo valida el Doctor; se entrega en visita presencial antes de renovar el programa, nunca por correo sin explicación.

PERFIL ALMA – [Paciente] · [Año]

TU SITUACIÓN HOY [estado actual con imágenes]

TU EVOLUCIÓN ESTE AÑO [comparativa con el año anterior]

LO QUE HEMOS DETECTADO A TIEMPO

[hallazgos resueltos antes de ser problema]

TU PERFIL DE RIESGO

Periodontal  Medio

Caries  Bajo

Biomecánico  Alto

Periimplantario  Medio

QUÉ ESPERAMOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

[proyección clínica realista]

QUÉ VAMOS A HACER PARA EVITARLO

[plan de seguimiento del año]

TU CALENDARIO

[próximas visitas agendadas]

GUIÓN DE ENTREGA

«[Nombre], le he preparado su informe del año. Se lo explico. Aquí está cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Esto de aquí lo detectamos en la revisión de [mes] y lo resolvimos antes de que fuera un problema. Si no hubiera venido, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Y esto es su perfil de riesgo actual. Lo que le propongo para el año que viene es [plan]. Se lo lleva usted para verlo con calma.»

Convierte al paciente en gestor de su riesgo en lugar de comprador de tratamientos, hace evidente la necesidad del mantenimiento y es el instrumento que sostiene la renovación del programa.

Protocolos de contingencia

REGLA GENERAL

Ninguna innovación puede convertirse en un requisito para atender a un paciente.

Si el sistema falla, la clínica funciona igual, aunque con más trabajo manual.

INNOVACIÓN	SI FALLA	RESPONSABLE
Cuestionario previo	Se cumplimenta en consulta	Recepción
Firma digital	Juego impreso siempre disponible	Recepción
Flujo digital y fusión	Se trabaja con los archivos por separado	Auxiliar
Prediagnóstico IA	El Doctor diagnostica igual. Nunca se pospone	Doctor
Navegación 3D	Se presenta con imágenes estáticas	Director
Asistente conversacional	Los contactos van al buzón habitual	Recepción
Recordatorios automáticos	Llamada manual el día anterior	Recepción
Lista de espera	Llamada manual a los primeros	Recepción
Monitorización remota	Convocatoria presencial	Higienista

La curva de adopción: el valle

LO QUE OCURRE SIEMPRE

Durante las semanas 2 a 5 la innovación ralentiza en lugar de acelerar.

Si el equipo no lo sabe de antemano, concluye que no funciona y la abandona. El valle es inevitable; lo evitable es la sorpresa.

CÓMO SE GESTIONA

Antes Advertir explícitamente del valle.	Semana 1 Acompañamiento constante.	Semanas 2-3 Recoger fricciones sin corregir en público.	Semana 4 Ajustes sobre lo detectado.	Semana 6 Evaluación de los cinco criterios de aceptación.
---	---------------------------------------	--	---	--

LOS PERFILES ANTE EL CAMBIO

PERFIL	CÓMO GESTIONARLO
Entusiasta	Canalizar: que forme a otros

PERFIL	CÓMO GESTIONARLO
Pragmático	Mostrarle el beneficio concreto en su trabajo
Escéptico	No presionar. Convencer con datos
Resistente	Escuchar primero. A veces tiene razón

El resistente suele ser quien más información valiosa tiene: su resistencia señala con frecuencia un problema real que nadie más ha visto.

GUIÓN DE LA ADVERTENCIA PREVIA

«Vamos a activar [innovación]. Os aviso de una cosa para que no os sorprenda: las primeras semanas va a ir más lento que ahora. Es normal y es así siempre. A partir de la tercera o cuarta semana empieza a compensar. Si en ese momento seguís viendo que resta más que suma, lo revisamos y lo cambiamos. Lo que os pido es que me contéis cada cosa que os moleste, aunque parezca pequeña. Eso es lo que me permite ajustarlo.»

Formación y certificación

1 · Explicar Qué es, por qué y qué mejora · 15 min.	2 · Demostrar Uso real delante del equipo · 15 min.	3 · Practicar Casos ficticios · 30 min.	4 · Acompañar Primeros usos reales supervisados · 1 semana.	5 · Certificar Verificación de autonomía.
--	--	---	---	---

Nadie usa una innovación con un paciente antes del paso 5.

Calendario de implantación

TRIMESTRE	FOCO	FICHAS
T1	Sin inversión, impacto alto	01 Triaje · 04 Tour activo · 06 Verificación de comprensión · 09 El paciente ve su 3D · 10 Estratificación de riesgo

TRIMESTRE	FOCO	FICHAS
T2	Digitalización	02 Cuestionario previo · 05 Firma digital · 07 Flujo digital · 15 Recordatorios · 16 Lista de espera
T3	Diagnóstico y presentación	08 Prediagnóstico IA · 11 IAC asistido · 12 Navegación 3D · 13 Progresión · 14 Escenarios comparados
T4	Continuidad	03 Asistente conversacional · 17 Monitorización remota · 18 Perfil Alma

Los doce errores documentados

#	ERROR	CONSECUENCIA	PREVENCIÓN
1	Activar varias innovaciones a la vez	Ninguna queda implantada	Una por trimestre
2	Tono robótico en la automatización	La confirmación cae a la mitad	Revisar todos los mensajes
3	Ocultar precios en el asistente	Caída fuerte de la respuesta	Dar rangos siempre
4	No formar a Recepción	No sabe responder al paciente	Formación previa obligatoria
5	No advertir del valle de adopción	El equipo concluye que no funciona	Advertencia explícita previa
6	No tener plan B	Un fallo técnico paraliza la consulta	Contingencia documentada
7	Leer el prediagnóstico antes de explorar	Condiciona el criterio clínico	Doctor primero, siempre
8	Registrar el perfil de riesgo y no usarlo	Se convierte en papeleo	Debe determinar periodicidad y comunicarse
9	Usar el 3D sin ensayar	Improvisación delante del paciente	Ensayo previo obligatorio
10	Exagerar la proyección de riesgo	Se detecta y destruye la confianza	Proyección clínicamente esperable
11	Convertir la innovación en requisito	Si falla, no se puede atender	Nunca imprescindible

#	ERROR	CONSECUENCIA	PREVENCIÓN
12	No medir el impacto	No se sabe si funciona	Indicador definido antes de activar

Lo que no cambia

PRINCIPIO	APLICACIÓN
El criterio clínico es del Doctor	La IA señala; el profesional diagnostica
La comprensión del paciente es el objetivo	Si la tecnología no la mejora, sobra
La trazabilidad es obligatoria	Digital o en papel, pero completa
Nadie espera sin explicación	Ninguna pantalla sustituye eso
Lo prometido se cumple en plazo	Ninguna innovación arregla un incumplimiento
El equipo es lo que sostiene todo	Ninguna herramienta compensa un equipo desmotivado

LA IDEA QUE LO ORDENA TODO

Que el paciente entienda su situación y vea su futuro.

El modelo 3D no impresiona: explica. El perfil de riesgo no es un dato: proyecta. La simulación no es un truco: anticipa. El informe anual no es un parte: demuestra. El prediagnóstico no diagnostica: protege de la omisión. Cuando un paciente entiende de verdad su situación y ve hacia dónde va, la conversación sobre el precio se vuelve secundaria. Esa es la ventaja competitiva: no la tecnología, sino la comprensión que la tecnología permite.

DOCUMENTO 09

Plan Director de Marca y Captación

Naming, arquitectura de marca, embudos por segmento, motor digital y automatización. Es el último documento que se activa: no antes de haber estabilizado la operación y recuperado la cartera propia. Toda la comunicación queda sujeta a la normativa de publicidad sanitaria, con validación previa de la asesoría.

Qué ha cambiado en captación

CAMBIO 01

El buscador ya no es solo Google

Los pacientes preguntan a asistentes conversacionales cuál es la mejor clínica para su caso. Eso obliga a estructurar la web con datos enriquecidos y respuestas naturales para que una IA la identifique como fuente de autoridad.

CAMBIO 02

La promoción masiva dejó de funcionar

Las campañas de precio saturan la agenda de pacientes que solo buscan precio y que rara vez aceptan planes integrales. La promoción de precio no solo daña el margen: atrae al paciente incompatible con el modelo.

CAMBIO 03

La conversación se mudó a la mensajería

La web capta al paciente nuevo; WhatsApp lo retiene y lo acompaña cita tras cita. La web es el escaparate, pero la conversión y la relación ocurren donde el paciente ya vive.

ENFOQUE TRADICIONAL

- Posicionar en Google
- Campañas de precio
- Formulario web
- Captar volumen
- Comunicar tratamientos
- Marketing como gasto

ENFOQUE DE ESTE PLAN

- Ser la respuesta de la IA
- Segmentación por valor
- Conversación en WhatsApp
- Captar el paciente correcto
- Responder preguntas reales
- Marketing como sistema medible

Naming y arquitectura de marca

«Centro de Excelencia Implantológica Alma» declara especialización y autoridad, pero para la madre de un niño de nueve años que busca ortodoncia infantil no comunica «aquí atienden a mi hijo». Diluir el nombre destruiría la ventaja en implantología, que es donde está el margen; mantenerlo sin más excluye mentalmente a tres segmentos con recorrido de décadas. La solución es una arquitectura de marca con una madre y cuatro verticales.

VERTICAL	DENOMINACIÓN	PÚBLICO	FUNDAMENTO
Implantología	Alma Implantes	45-75	Directo, descriptivo y coherente con la marca madre. No requiere explicación
Ortodoncia	Alma Alinea	14-45	Verbo en lugar de sustantivo: transmite acción y proceso, y evita el término técnico, que resulta frío
Infantil	Alma Kids	6-14	Universalmente comprendido por los padres. Cálido sin infantilizar la marca madre
Mantenimiento	Alma Cuida	Todos	Verbo de acompañamiento: comunica permanencia, que es el diferencial del programa

VERIFICACIÓN OBLIGATORIA ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER NOMBRE

Disponibilidad de marca ante la oficina de marcas y disponibilidad de dominios y perfiles sociales. Ningún nombre se adopta sin esa verificación. Los siete criterios de evaluación: claridad, pronunciabilidad, diferenciación, coherencia con la marca madre, adecuación al segmento, escalabilidad y disponibilidad legal y digital.

Programas con nombre propio

Un programa con nombre convierte un servicio en algo tangible, comunicable y buscable.

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	FUNCIÓN
Segunda opinión para casos rechazados	Consulta Sí Se Puede	Captación del segmento nuclear
Atención a pacientes con ansiedad	Unidad Calma	Captación de un segmento desatendido
Mantenimiento de implantes	Implante de por Vida	Fidelización y recurrencia
Recomendación de pacientes	Círculo Alma	Activación del canal más rentable
Simulación de resultado en ortodoncia	Tu Sonrisa en 3D	Herramienta de conversión
Revisión infantil	Primera Sonrisa	Captación familiar

«Consulta Sí Se Puede» es el activo de naming más valioso del plan: convierte el posicionamiento en un servicio con nombre.

PROMESA DE MARCA

Donde sí se puede.

Implantes: «Le dijeron que no tenía hueso. Aquí sí se puede.» · **Alinea:** «Creía que ya era tarde. Aquí sí se puede.» · **Kids:** «Pensaba que había que esperar. Aquí sí se puede, y ahora es el momento.» · **Cuida:** «Su tratamiento no termina. Aquí seguimos cuidándolo.»

VERTICAL	TRATO	TONO	LÉXICO
Implantes	Usted	Seguro, técnico accesible	Precisión, planificación, garantía
Alinea	Tú	Cercano, aspiracional	Discreto, compatible, resultado

VERTICAL	TRATO	TONO	LÉXICO
Kids	Tú, a los padres	Cálido, tranquilizador	Momento, prevención, sin miedo
Cuida	Según relación	De acompañamiento	Cuidar, mantener, siempre

Los siete segmentos

#	SEGMENTO	EDAD	DECISOR	MOTOR DE DECISIÓN	VERTICAL
1	Rehabilitación compleja	55-78	Paciente y pareja	Recuperar función	Implantes
2	Ausencia puntual	40-65	Paciente	Evitar deterioro	Implantes
3	Caso rechazado	50-75	Paciente	Encontrar solución	Sí Se Puede
4	Paciente con fobia	Cualquiera	Paciente	Dejar de posponer	Unidad Calma
5	Ortodoncia adulto	25-45	Paciente	Imagen y autoestima	Alinea
6	Ortodoncia joven	14-24	Padres y paciente	Estética social	Alinea
7	Ortodoncia infantil	6-13	Padres	Hacer lo correcto a tiempo	Kids

LA ESTRATEGIA FAMILIAR COMO HILO CONDUCTOR

Un niño captado a los ocho años puede representar tres generaciones durante treinta años: sus padres entran por ortodoncia de adulto o por ausencias, y sus abuelos por rehabilitación y mantenimiento. Esa es la lógica que convierte «atender a todos los segmentos» de riesgo de dilución en estrategia coherente.

Segmento 3 · Caso rechazado

Paciente al que otro centro desestimó, normalmente por falta de hueso. Frustración y resignación: no compara precios, busca a alguien que pueda. Es el segmento con menor sensibilidad al precio. Mensaje: «¿Le han dicho que no tiene hueso suficiente? Pida una segunda opinión. Sin coste.»

Segmento 4 · Fobia

El segmento invisible: necesidad acumulada durante años y evitación por temor. El elemento diferencial es la primera visita sin tratamiento. Mensaje: «Puede venir solo a conocernos. No le vamos a hacer nada el primer día.» Canal crítico: WhatsApp, porque la llamada genera ansiedad.

Segmentos 5 y 6 · Ortodoncia

La única especialidad donde se puede mostrar el resultado antes de decidir. El momento en que el paciente ve su sonrisa corregida en pantalla es el de mayor conversión del recorrido. Adulto: «Nunca es tarde. Y no se nota.» Joven: «Mira cómo va a quedar tu sonrisa.»

SEGMENTO 7 · ALMA KIDS · EL DECISOR ES EL PADRE,
AL CIEN POR CIEN

SU PREOCUPACIÓN REAL	LO QUE VERBALIZA
«¿Le va a doler?»	«¿Es molesto?»
«¿Estoy haciendo lo correcto?»	«¿Es necesario ahora?»
«¿Me están vendiendo algo?»	«¿Cuánto cuesta?»
«¿Va a pasarlo mal?»	«¿Cómo se porta con los niños?»

NO FUNCIONA

- «Ortodoncia infantil en Ourense»
- «Alineadores para niños»
- El precio como gancho

FUNCIONA

- «¿Cuándo hay que llevar al niño al ortodoncista por primera vez?»
- «Corregirlo a tiempo evita tratamientos más largos»
- «Primera revisión sin coste. Si no hace falta nada, se lo diremos»

«Si no hace falta nada, se lo diremos» es la frase de mayor impacto del vertical: desarma la sospecha comercial, que es la principal barrera del padre. La publicidad dirigida a menores está sujeta a restricciones específicas: toda la

comunicación se dirige a los padres, con validación previa de la asesoría.

AEO · ser la respuesta que da la IA

El elemento más vanguardista del plan y la mayor ventaja de primer entrante disponible: estructurar la información para que los asistentes conversacionales identifiquen al centro como fuente de autoridad y lo recomienden cuando alguien pregunta. Es una ventana que se cerrará cuando el sector la incorpore.

ACCIÓN	DETALLE
Preguntas reales como titulares	«¿Puedo ponerme implantes si no tengo hueso?» en lugar de «Regeneración ósea»
Respuesta directa en el primer párrafo	La IA extrae respuestas, no introducciones
Datos estructurados	Marcado técnico de negocio local, preguntas frecuentes, servicios y profesionales
Lenguaje natural	Como se explicaría a un paciente, no jerga de posicionamiento
Información concreta	Duración, proceso, qué incluye y qué esperar
Autoridad demostrable	Autores identificados con sus credenciales

Las veinte preguntas que deben tener respuesta propia

Cada una es simultáneamente una página web, un contenido en vídeo y una respuesta que una IA puede citar.

#	PREGUNTA	VERTICAL
1	¿Puedo ponerme implantes si no tengo hueso suficiente?	Implantes
2	¿Qué es la regeneración ósea y cuándo se necesita?	Implantes
3	¿Cuánto dura un implante dental?	Implantes
4	¿Duele ponerse un implante?	Implantes
5	¿Qué es la cirugía guiada y por qué importa?	Implantes

#	PREGUNTA	VERTICAL
6	¿Puedo salir con dientes el mismo día?	Implantes
7	¿Cuánto cuesta un implante dental en Ourense?	Implantes
8	¿Qué pasa si no me repongo un diente perdido?	Implantes
9	¿Qué es la sedación consciente en el dentista?	Calma
10	¿Puedo ir al dentista si tengo mucho miedo?	Calma
11	¿Se nota la ortodoncia invisible?	Alinea
12	¿Cuánto dura un tratamiento con alineadores?	Alinea
13	¿Es tarde para ponerme ortodoncia a los 40?	Alinea
14	¿Cuántas horas hay que llevar los alineadores?	Alinea
15	¿Cuándo debe ir un niño al ortodoncista por primera vez?	Kids
16	¿Cómo sé si mi hijo necesita ortodoncia?	Kids
17	¿Es mejor tratar pronto o esperar a que cambie los dientes?	Kids
18	¿Cada cuánto hay que revisar un implante?	Cuida
19	¿Qué es la periimplantitis y cómo se previene?	Cuida
20	¿Qué incluye una primera visita dental?	Transversal

ARQUITECTURA WEB


```

giraldo[.es]
├─ HOME – promesa, prueba social, verticales
├─ IMPLANTES
│   ├─ unitario · varias piezas · rehabilitación
│   ├─ ★ ¿No tiene hueso suficiente?      ← estratégica
│   └─ carga inmediata · guiada · regeneración
├─ ALINEA
│   ├─ adultos · jóvenes
│   └─ ★ Tu Sonrisa en 3D                  ← conversión
├─ KIDS
│   ├─ ¿Cuándo llevar a mi hijo?
│   └─ Primera Sonrisa · ortodoncia infantil
├─ ★ UNIDAD CALMA – miedo al dentista    ← estratégica
├─ CUIDA – mantenimiento
├─ ★ CONSULTA SÍ SE PUEDE                ← captación nuclear
├─ TECNOLOGÍA · EQUIPO · CASOS · FINANCIACIÓN
└─ PREGUNTAS FRECUENTES (las 20 de AE0)

```

Las cuatro páginas marcadas capturan los segmentos que nadie más atiende en Ourense.

PERFIL DE GOOGLE

ACCIÓN	CRITICIDAD
Renombrar el perfil existente, nunca crear uno nuevo	■ PÉRDIDA IRREVERSIBLE DE RESEÑAS
Respuesta al 100 % de las reseñas	■ CRÍTICA
Categoría principal y secundarias correctas	■ ALTA
Servicios listados con descripción	■ ALTA
Fotografía propia actualizada cada mes	■ ALTA
Preguntas y respuestas cubiertas de forma proactiva	■ ALTA
Publicaciones semanales	■ MEDIA

Automatización

FLUJO	FUNCIÓN	IMPACTO
Confirmación de citas	Recordatorio con confirmación de un clic	Reducción de ausencias
Captación 24/7	Asistente que responde y cualifica fuera de horario	Contactos nocturnos y de fin de semana
Lista de espera	Aviso automático ante cancelación	Recuperación de huecos
Reactivación	Contacto automatizado a la cartera inactiva	Recuperación de pacientes
Seguimiento post-tratamiento	Contacto programado	Fidelización y detección precoz
Solicitud de reseña	Envío en el momento adecuado	Reputación

LOS CUATRO ERRORES DE IMPLANTACIÓN

- **Activarlo todo a la vez** — la receta clásica para que nada quede bien hecho. Un flujo al mes, con cuatro semanas de rodaje
- **Tono robótico** — la confirmación cae del 80-90 % al 40-50 % con la misma tecnología
- **Que el asistente suene a venta** — el contacto siente que le van a vender y no responde
- **No formar a Recepción** — el paciente llama preguntando «¿qué es ese mensaje?» y nadie sabe responder

SECUENCIA DE IMPLANTACIÓN

FASE	FLUJO	CRITERIO DE PASO
1	Confirmación de citas	Tasa estable ≥ 80 %
2	Lista de espera	Huecos recuperados medibles
3	Solicitud de reseñas	Flujo constante de reseñas
4	Reactivación de cartera	Segmentos prioritarios contactados
5	Captación 24/7 con IA	Contactos cualificados llegando a agenda

Un flujo cada mes. El sistema completo estará operativo y funcionando en seis meses, en lugar de activado en uno y abandonado en tres.

LO QUE NUNCA SE AUTOMATIZA

La comunicación de resultados clínicos, la gestión de una queja, cualquier dato clínico en un mensaje, la respuesta a una reseña negativa, el primer contacto con un paciente con fobia y el contacto con un paciente con producto pendiente antiguo, que requiere una disculpa personal.

Sistema de contenidos

EL CUADERNO DE PREGUNTAS

El instrumento más barato y más productivo del plan: Recepción y facultativos anotan cada pregunta que les hace un paciente.

Ese registro es a la vez el calendario editorial, la base de las preguntas frecuentes para AEO, el guion de los vídeos y el detector de huecos de información.

PILARES DE CONTENIDO

PILAR	PROPORCIÓN	FUNCIÓN
Educación: respuestas a preguntas reales	40 %	Autoridad y AEO
Casos, con consentimiento	20 %	Prueba social
Equipo y tecnología	20 %	Confianza
Desmitificación	15 %	Reducción de barreras
Institucional	5 %	Posicionamiento

PRODUCCIÓN EN BLOQUE

Una sesión de noventa minutos al mes produce entre cuatro y seis piezas de vídeo. Producir contenido suelto cada semana es lo que hace que el sistema se abandone.

ESTRUCTURA DE VÍDEO (45-60 s)

GANCHO (0-3 s) Pregunta real del paciente

CONTEXTO (3-10 s) Por qué es frecuente

CONTENIDO(10-40 s) Respuesta clara, con apoyo visual

CIERRE (40-55 s) Invitación sin presión

Medición y economía unitaria

CAC (por canal) = Inversión del canal / Pacientes captados

VALOR INICIAL = Ticket medio aceptado × Margen

LTV = Valor inicial

+ (Mantenimiento anual × años × margen)

+ (Tratamientos adicionales × margen)

+ (Pacientes referidos × probabilidad × valor)

El cuarto sumando del valor de vida es el que casi nadie calcula y el que más pesa en implantología.

RELACIÓN	INTERPRETACIÓN	ACCIÓN
CAC < ⅓ del valor inicial	Muy rentable	Escalar con fuerza
CAC < valor inicial	Rentable	Mantener o escalar
CAC > valor inicial	Pierde en la primera transacción	Solo si el valor de vida lo justifica
CAC > valor de vida	Destruye valor	Cortar

PRESUPUESTO POR FASE

FASE	% DE FACTURACIÓN
Lanzamiento y reposicionamiento	7-10 %
Crecimiento	5-7 %
Consolidación	3-5 %

REPARTO DE LA PARTIDA

PARTIDA	ASIGNACIÓN
Producción de contenido	25 %
Publicidad segmentada	25 %
Web y AEO	20 %
Automatización	10 %
Reputación y referidos	10 %
Acciones locales	10 %

Hoja de ruta anual

TRIMESTRE	FOCO	ACCIONES
T1	Cimientos	Verificación legal del naming · arquitectura adoptada · perfil de Google renombrado y optimizado · sistema de reseñas activo · cuaderno de preguntas en marcha · sesión fotográfica propia · web reestructurada con AEO · cuatro páginas estratégicas · flujo 1 de automatización
T2	Contenido y captación	Primera grabación en bloque · publicación sistemática · las 20 preguntas AEO publicadas · «Círculo Alma» lanzado · flujos 2 y 3 · primeras campañas segmentadas · cálculo de CAC por canal
T3	Verticales	Kids activado · charlas en colegios · relación con pediatras · Unidad Calma comunicada · alianzas de derivación · flujo 4
T4	Optimización	Flujo 5 · análisis completo de retorno por canal · reasignación de presupuesto · plan del año siguiente

Las nueve decisiones que requiere

#	DECISIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1	Adopción de la arquitectura de verticales	Gerencia	Semana 1
2	Aprobación del naming propuesto	Gerencia	Semana 2
3	Verificación legal de disponibilidad de marca	Asesoría	Semana 2

#	DECISIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
4	Verificación de dominios y perfiles	Externo	Semana 2
5	Modelo de ejecución: interno, agencia o mixto	Gerencia	Semana 3
6	Presupuesto anual	Gerencia	Semana 3
7	Responsable interno de marca y reseñas	Gerencia	Semana 3
8	Proveedor de automatización	Gerencia	Mes 2
9	Validación de la comunicación con asesoría	Asesoría	Antes de publicar

LAS TRES IDEAS QUE SOSTIENEN EL PLAN

La captación no se organiza por tratamientos, sino por situaciones vitales del paciente. La ventaja digital disponible ahora no está en la publicidad, sino en ser la respuesta que da una IA. Y la automatización no sustituye a las personas: libera capacidad para que hagan lo que solo ellas pueden hacer.

Con una advertencia sobre la secuencia: ninguna de estas acciones tiene sentido antes de haber estabilizado la operación y recuperado la cartera propia.

DOCUMENTO 10

Cuaderno de Campo · Día 1

El único documento de este sistema que está pensado para llevarse encima en papel, con un bolígrafo. No explica: recuerda. Se abre en el momento exacto en que hace falta —una pregunta incómoda de un paciente, un sistema caído, un trabajador con una duda laboral— y da la frase o la casilla que toca.

LA PÁGINA DE EMERGENCIA

Es la primera página del cuaderno y la única que hay que saber encontrar sin mirar el índice.

Está pensada para el momento en que uno se queda en blanco delante de un paciente. Ninguna de estas respuestas es improvisada: todas evitan cerrar una puerta el primer día.

SI PASA ESTO...	QUÉ SE HACE O SE DICE
Un paciente pregunta por dinero pagado	«Le entiendo. La respuesta es no: lo que usted abonó se mantiene íntegro. Déjeme mostrarle el detalle exacto.» Si no se tiene el dato: «Prefiero no darle un número de memoria. Hoy mismo le llamo con el detalle por escrito.»
Un paciente está enfadado	Sentarle. Escuchar sin interrumpir. No rebatir. «Le agradezco que me lo diga directamente.» Después, reunión con calma: nunca una decisión en caliente
Un paciente pide devolución	Ni prometer ni negar. «No le voy a improvisar una respuesta. Nos sentamos [hoy/mañana] con todos los datos delante»
El sistema se cae	Agenda impresa y registro manual en la hoja del cuaderno. Se atiende con normalidad y se vuelca al recuperar el sistema
Un trabajador plantea una duda laboral	Fuera de la vista de pacientes. Se resuelve hoy o se da fecha de respuesta hoy. Nunca «ya lo veremos»
Llega una inspección	Documentación legal accesible y llamada a la asesoría. Nadie improvisa respuestas
Llama un proveedor exigiendo algo	No se negocia en caliente. Se anota quién y qué, y lo gestiona Dirección

La página lleva además los teléfonos críticos rellenados a mano antes de la apertura: asesoría legal, asesoría laboral, corredor de seguros, soporte de Clinic Cloud, laboratorio protésico y Dirección de Centros.

La noche antes · trece verificaciones

- ☐ Autorización sanitaria: ¿a nombre de la nueva titularidad?
- ☐ Director técnico sanitario designado y comunicado
- ☐ **Póliza de RC: fecha de efecto sin carencia**
- ☐ **Póliza de RC: cubre tratamientos iniciados en Arclimedent**
- ☐ **Todos los profesionales cubiertos por la póliza**
- ☐ Situación laboral comunicada por escrito a cada trabajador
- ☐ Acceso comprobado a historiales, abriendo tres fichas al azar
- ☐ Archivo en papel de Arclimedent localizado
- ☐ Inventario de pacientes en tratamiento activo hecho
- ☐ Conciliación financiera del producto pendiente iniciada
- ☐ Agenda de cinco días impresa
- ☐ Cartelería preparada
- ☐ Sistema comprobado: se entra y se busca un paciente

LA REGLA QUE DECIDE SI SE ABRE

Si las tres verificaciones marcadas en negrita —las de la póliza— están en «no», **no hay actuación clínica mañana** hasta resolverlo. Sí puede haber actividad administrativa: recepción, agenda y llamadas de continuidad.

Cronograma hora a hora

07:45 Llegas tú, cuarenta y cinco minutos antes. Vuelta de reconocimiento de cinco minutos:	08:00 Llega el equipo. Se les recibe en persona: que la primera cara que vean sea la tuya, no un cartel nuevo.	08:15 Reunión de equipo, 30-40 minutos, en los siete bloques del guion. Al final, reparto de fichas por perfil.	08:55 Últimos cinco minutos: Recepción con la agenda impresa en la mano, cada Doctor con sus casos revisados,	09:00 Apertura. Tu posición: visible y accesible, nunca en el despacho con la puerta cerrada.
---	--	---	---	---

sistema, archivo de Arclimedent, cartelería, agenda impresa y gabinetes. Y cinco minutos de preparación: casos rojos, reparto de roles y situación laboral de cada uno, delante.			Auxiliar con los equipos comprobados y el cuaderno encima.	
09:00 - 14:00 Cada hora, comprobación mental de treinta segundos: ¿alguien esperando más de lo normal?, ¿alguien del equipo atascado?, ¿ha entrado algún rojo y cómo ha ido? Cada incidencia se registra en el momento.	14:00 Punto de control de mediodía, cinco minutos a solas: rojos atendidos, promesas hechas, dudas laborales abiertas y documentación de la mañana escaneada.	Tarde Misma dinámica, vigilando el cansancio: los errores del primer día se concentran en las dos últimas horas.	Cierre Reunión de 10-15 minutos con el equipo y, después, diez minutos de revisión a solas.	

Los siete guiones de conversaciones difíciles

«¿HE PERDIDO EL DINERO QUE PAGUÉ?»

«Le entiendo perfectamente, y le agradezco que me lo pregunte directamente. La respuesta es no: el tratamiento que usted contrató y abonó se mantiene exactamente en las mismas condiciones. No tiene que volver a pagar nada de lo ya abonado. Si le parece, le muestro ahora mismo el registro de su pago y de lo que queda por realizar, para que quede claro para los dos.»

«MI DOCTOR YA NO ESTÁ, NO ME FÍO DEL NUEVO»

«Es una preocupación totalmente legítima, y me alegra que me la diga en vez de quedársela dentro. Le propongo esto: antes de cualquier actuación, el Dr./Dra. [nombre] se sienta con usted, ya con su caso revisado a fondo, y le explica exactamente en qué punto está y cómo continúa. Sin coste, y sin compromiso de seguir si no se siente cómodo. Nadie le va a tocar nada hasta que usted esté tranquilo.»

«QUIERO QUE ME DEVUELVAN EL DINERO»

«Le escucho. Antes de nada, quiero entender qué le preocupa exactamente, porque quizá lo podemos resolver de otra forma. [...] Le agradezco la franqueza. No le voy a dar una respuesta improvisada a algo así. Le propongo que nos sentemos [hoy/mañana] con todos los datos de su caso delante y lo vemos con calma. ¿Le va bien el [día] a las [hora]?»

Se escucha sin interrumpir y se toma nota delante del paciente: transmite que se le toma en serio. Nunca se promete una devolución en el momento, ni se niega en redondo: ambas cosas cierran una puerta que el primer día no debe cerrarse.

«¿ESTO VA A SEGUIR ABIERTO O CIERRAN EN UNOS MESES?»

«Entiendo la pregunta. Esto no es un cierre, es exactamente lo contrario: hay una inversión detrás para reforzar la clínica, con más recursos y más tecnología. Yo estoy aquí precisamente para eso, y soy su referente directo desde hoy.»

«¿VAN A SUBIR LOS PRECIOS?»

«Lo que usted ya tiene contratado y aceptado no cambia: ni el precio, ni las condiciones, ni las fases acordadas. Si en el futuro hubiera cualquier cambio en tarifas para tratamientos nuevos, se comunicaría siempre por adelantado y por escrito. Nunca se aplicaría a algo ya acordado con usted.»

«LLEVO MESES ESPERANDO MI CIRUGÍA» · EL PACIENTE DE MAYOR RIESGO DE TODA LA TRANSICIÓN

«Tiene toda la razón en reclamar, y le pido disculpas por la espera. Le voy a decir lo que voy a hacer: hoy mismo reviso su caso personalmente y le doy una fecha concreta, no un «ya le llamaremos». ¿Me deja hasta [día] para darle esa fecha con seguridad? Prefiero darle una fecha que se cumpla a una fecha rápida que se caiga.»

UN TRABAJADOR DICE QUE SE PLANTEA IRSE

«Te agradezco que me lo digas de frente en vez de irte sin más. ¿Puedes decirme qué es lo que más te preocupa? [...] No te voy a pedir una decisión hoy. Te pido que me des unos días para enseñarte hacia dónde vamos, y después decides con toda la información. ¿Te parece justo?»

Cada promesa que sale de estas conversaciones se anota en la hoja de compromisos del cuaderno, con fecha. Las de este tipo se cumplen sí o sí.

Las cinco hojas de registro

HOJA	QUÉ SE ANOTA	PARA QUÉ SIRVE DESPUÉS
Incidencias del día	Hora, tipo (paciente, personal, sistema, proveedor, legal), qué pasó, cómo se resolvió y qué queda pendiente	El día 5 permite distinguir un problema estructural de una anécdota

HOJA	QUÉ SE ANOTA	PARA QUÉ SIRVE DESPUÉS
Compromisos adquiridos	Con quién, qué se prometió, para cuándo y si está cumplido	Ninguna promesa del primer día se pierde
Registro manual de emergencia	Hora, paciente, actuación, profesional, cobro y si está volcado al sistema	Se activa si cae el sistema; nadie se va a casa por una caída
Pacientes heredados atendidos	Paciente, tratamiento, doctor y si hubo incidencia	Es la métrica real del día 1
Producto pendiente detectado	Paciente, tratamiento pendiente, importe si se conoce, desde cuándo y si se ha pasado a RAC	Cada caso que aparece de pasada se convierte en trabajo asignado

Semáforo del día 1

INDICADOR	VERDE	ÁMBAR	ROJO
Pacientes heredados sin incidencia	Todos	Alguno con roce	Alguno con reclamación
Casos rojos atendidos	Todos correctos	Alguno reprogramado	Alguno mal gestionado
Documentación subida	100 %	Falta algo menor	Sin subir
Dudas laborales	Ninguna abierta	Alguna con fecha	Alguna sin respuesta
Equipo	Sostiene bien	Cansado pero bien	Alguien al límite
Sistemas	Sin caídas	Alguna incidencia	Caída larga

Se cierra con un balance honesto escrito a mano y solo para uno mismo: qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué se ha visto que es estructural y no anécdota, y qué es lo primero que se hace mañana.

LAS SIETE COSAS QUE NO SE HACEN HOY

- No formar en el protocolo completo: hoy es continuidad
- No delegar las verificaciones críticas
- No prometer para salir del paso
- No encerrarse en el despacho

- No corregir a nadie delante de un paciente
- No dejar el escaneo «para cuando haya menos lío»
- No exigir resultados comerciales: el mes 1 es línea base

LAS SIETE QUE SÍ

- Llegar el primero
- Hablar de la situación laboral antes que de nada
- Nombrar a cada persona por su nombre
- Escuchar más de lo que se habla
- Anotarlo todo
- Decir «no lo sé, lo confirmo hoy» sin miedo
- Agradecer al equipo al cerrar

LO QUE SÍ SE DECIDE MAÑANA

El liderazgo en Ourense no se decide mañana: se decide en los próximos doce meses, con reputación clínica, boca a boca y resultados sostenidos.

Lo que sí se decide mañana es si se arranca con una base sólida o con una grieta. Los pacientes de Arclimedent que hoy se sientan bien tratados serán los primeros prescriptores; los que se sientan perdidos serán reseñas negativas que costarán meses de reparar. Mañana no se compite con nadie: solo se sostiene lo que ya existe.

DOCUMENTO 11

Manual de Puesta en Marcha · operativa por perfil

Qué hace exactamente cada puesto el día 1 y la primera semana de la transición. Cada ficha es autónoma: se imprime y se entrega a cada persona solo la suya, más la parte común. Nadie necesita leer las fichas de los demás para hacer bien su trabajo. No sustituye a los

Protocolos Operativos por Perfil, que rigen la operación ordinaria: esto

es lo que se hace mientras la clínica cambia de manos.

LO QUE TODOS DEBEN SABER · PARTE COMÚN

Cambia la titularidad y la marca. No cambian los pacientes, ni sus tratamientos, ni lo que ya han pagado.

El único objetivo del día 1: que ningún paciente que ya venía a Arclimedent note absolutamente ningún cambio en su atención. Todo lo demás —protocolo nuevo, formación, objetivos comerciales— llega a partir del día 2.

Las cinco frases que nadie dice

LO QUE NO SE DICE

- «Yo ya no trabajo con la clínica de antes»
- «Eso lo llevaba la gestión anterior»
- «Con el cambio no sé cómo queda su caso»
- «Es que ahora todo está un poco desorganizado»
- «No me consta que usted pagara eso»

LO QUE SE DICE EN SU LUGAR

- «La clínica ahora es Centro Alma, y seguimos siendo el mismo equipo»
- «Déjeme que lo revise y le doy respuesta hoy mismo»
- «Su tratamiento continúa exactamente igual»
- «Estamos incorporando sistemas nuevos, pero su atención no cambia»
- «Déjeme confirmarlo y le doy el detalle exacto hoy»

LA FRASE SEGURA UNIVERSAL

Cuando no se sepa qué responder, esta frase siempre es correcta: **«Déjeme que lo confirme bien y le doy respuesta hoy mismo.»** Y después se pasa al Director. Nunca se improvisa una respuesta sobre dinero, tratamientos pendientes o situación de la clínica. Punto único de escalado durante la transición: el Director. Prefiere veinte preguntas hoy a una decisión improvisada.

Ficha A · Recepción

Hoy su trabajo no es administrativo: es transmitir que aquí no se ha perdido nada ni nadie. Además custodia el puente entre el archivo de Arclimedent y el sistema nuevo.

TIPO DE PACIENTE	CÓMO SE RECONOCE	QUÉ SE HACE
1 · De Arclimedent, con cita	Aparece en la agenda heredada	Acogida normal por su nombre. Si pregunta por el cambio, mensaje de continuidad. Cuanta más normalidad, mejor: no se dan explicaciones largas si no ha preguntado
2 · De Arclimedent, sin cita en el sistema	Dice que tiene cita y no aparece	La situación más delicada del día. Se le atiende igual, sin pedirle que demuestre nada: «Por supuesto, siéntese. Estamos migrando el sistema estos días, déjeme un momento que lo localizo.» Se busca en el archivo y se avisa al Director <i>después</i> , nunca delante del paciente
3 · Paciente nuevo	Primera visita	Protocolo estándar completo, sin atajos por ser el primer día. Para él esto es, simplemente, el Centro Alma

Lo que nunca se dice en el caso 2: «pues aquí no me aparece», «¿está seguro de que era hoy?», «eso lo debieron agendar con la gestión anterior». Esas frases convierten un problema nuestro en un problema del paciente.

SI EL PACIENTE SE DESCONCIERTA AL TELÉFONO: «¿ESTO NO ERA ARCLIMEDENT?»

«Sí, sí, es el mismo sitio y el mismo equipo. La clínica ahora es Centro de Excelencia Implantológica Alma. Para usted no cambia nada. ¿En qué puedo ayudarle?»

La regla que no se rompe: todo lo firmado hoy se escanea y sube hoy. Aunque sea el primer día y haya lío. Especialmente porque es el primer día y hay lío: en una transición de titularidad, un documento firmado que no está digitalizado puede no existir a efectos prácticos si alguien reclama.

Ficha B · Doctor

LA REGLA ABSOLUTA DEL DÍA 1

Nunca conozcas un caso a la vez que el paciente.

El historial se revisa antes de que entre por la puerta. No mientras se sienta. No mientras te lavas las manos. Antes. Un paciente perdona que la recepción esté desorganizada el primer día; no perdona que su Doctor no sepa en qué punto está su tratamiento.

Antes de abrir: identificar en la agenda a los pacientes heredados en tratamiento activo, leer su historial completo —diagnóstico, fase, plan restante, última actuación, incidencias— y avisar al Director de aquellos cuya información sea insuficiente *antes* de abrir, no cuando el paciente ya esté esperando.

CÓMO SE ABRE UNA CONSULTA DE UN CASO TRASPASADO

«Buenos días, [nombre]. Soy el Dr./Dra. [nombre]. He estado revisando su caso con detalle: usted está en [fase concreta], le hicimos [actuación previa] en [fecha aproximada], y lo que toca ahora es [siguiente paso]. Quiero que sepa que su tratamiento continúa exactamente igual que estaba previsto. ¿Hay algo que quiera preguntarme antes de empezar?»

Funciona porque demuestra con datos concretos que se conoce el caso. Es lo único que de verdad tranquiliza a un paciente que ha perdido a su profesional de referencia.

SITUACIÓN	QUÉ SE HACE
El historial está incompleto y el paciente ya está delante	Se explora y se documenta lo que se ve ahora; no se inventa historia previa. «Voy a revisarlo todo hoy con detalle para dejarlo perfectamente registrado»
Pregunta por su Doctor anterior	Respuesta neutra y breve: «su caso lo llevo yo ahora y lo tengo revisado a fondo». Nunca criticar al profesional anterior
El plan previo no parece adecuado	No se dice delante del paciente: se habla con el Director después. Cambiar un plan en caliente el día 1 genera desconfianza y puede generar reclamación
Pregunta si lo que pagó cubre lo que falta	No es su conversación: «eso se lo confirma el Director con el detalle exacto»
Ortodoncia cuyo seguimiento digital no está accesible	Se documenta manualmente con fotos de control y se sigue el tratamiento. La falta de acceso a un software nunca justifica interrumpir un tratamiento
Urgencia sin cita de un paciente heredado	Se atiende siempre, con independencia de si su historial está migrado

Hoy se documenta más de lo habitual, no menos: si mañana hay una reclamación sobre un tratamiento iniciado en Arclimedent, el primer registro bajo la nueva titularidad es la referencia. Por cada paciente heredado: estado actual observado, fase confirmada, plan restante, discrepancias entre historial y observación, y lo que el paciente refiere de su propio tratamiento.

Ficha C · Auxiliar

Además de su función habitual, desde hoy es **la fuente de verdad sobre qué material hay realmente en la clínica**. Antes de abrir: encender y comprobar CBCT, OPG, escáner y cámara —no asumirlo—, probar la carga de imágenes, revisar el almacén y localizar los trabajos pendientes en laboratorio de pacientes de Arclimedent.

CÓMO SE RESPONDE A UNA PREGUNTA SOBRE MATERIAL

«Déjame que lo compruebe en almacén y te confirmo» —y se comprueba físicamente—. Nunca «creo que sí», «me suena que quedaba» o «normalmente tenemos». Si se dice que sí y no lo hay, se cancela una cirugía el mismo día con el paciente ya avisado. Si hay que pedirlo, se informa del plazo real de entrega para que se agende en consecuencia.

Control de calidad antes de subir cada imagen: nitidez sin movimiento, encuadre correcto, fotos enderezadas, etiquetado correcto y asociación al paciente correcto. **Si una imagen genera duda, se repite ahora:** una imagen mal hecha hoy es una presentación fallida y una conversión perdida mañana.

Ficha D · RAC

SU PRIMERA TAREA NO ES LO NUEVO

Es sacar a la luz lo heredado: la bolsa de tratamientos ya cobrados por la clínica anterior que nunca llegaron a ejecutarse.

Eso es a la vez una obligación con el paciente, un riesgo reputacional que crece cada semana y un problema de caja: dinero ya cobrado que sigue generando coste.

QUÉ HACE LOS PRIMEROS DÍAS

- Construir el listado de producto pendiente heredado, paciente a paciente
- Anotar importe pagado, tratamiento pendiente, fecha de aceptación y días transcurridos
- Ordenarlo por antigüedad: los más antiguos son los de mayor riesgo
- Presentárselo al Director con los tres casos más urgentes destacados

SU REGLA DE ORO · LAS DOS VERIFICACIONES

Ninguna cirugía se agenda sin verificar que el pago consta y que el material está disponible. Las dos, siempre, aunque haya prisa comercial.

Si el pago está en el sistema de Arclimedent y no en el nuevo, vale igual: se documenta y se comunica que ese caso está pendiente de migrar. Si hay que pedir material, se agenda *después* del plazo real de entrega: mejor una semana más tarde que una cancelación el mismo día.

SITUACIÓN	QUÉ SE HACE
Paciente heredado que lleva meses esperando su cirugía	Se prioriza: es el caso de mayor riesgo reputacional. Se comunica al Director
El pago no consta pero el paciente afirma haber pagado	No se agenda todavía, pero tampoco se le cuestiona: se escala al Director para verificar con archivo y justificantes
El paciente solo puede pagar el mismo día de la cirugía	No se agenda en firme sin autorización expresa del Director
Material con plazo largo, como prótesis de laboratorio	Se inicia el pedido inmediatamente tras la aceptación, no cuando se acerca la fecha
El paciente pide adelantar la cirugía	Solo si pago y material lo permiten realmente. Nunca por presión comercial

SITUACIÓN	QUÉ SE HACE
Una cirugía se cae por falta de material	Se reporta como incidencia grave al Director el mismo día, con la causa raíz

Tabla de decisión rápida · para colgar en zona interna

SI PASA...	ACTÚA	ESCALA A
Paciente sin cita en el sistema	Atender igual	Director, después
Pregunta sobre dinero pagado	No responder cifras	Director, inmediato
Paciente enfadado o desconfiado	Escuchar, sentar, no rebatir	Director, inmediato
Historial no localizable	Buscar en el archivo de Arclimedent	Doctor y Director
Duda clínica en un caso heredado	No intervenir	Director, inmediato
Material dudoso para una cirugía	Comprobar físicamente	RAC y Director
Sistema caído	Papel y registro manual	Director
Llamada de un proveedor	Anotar y derivar	Director
Duda sobre la propia situación laboral	Preguntar fuera de la vista de pacientes	Director
Prensa o consultas externas	No declarar nada	Director

La primera semana, día a día

DÍA	FOCO	QUÉ HACE CADA PERFIL ADEMÁS DE LO NORMAL
1	Continuidad pura	Ningún paciente heredado con incidencia grave
2	Protocolo por perfil	Cada persona lee y practica en voz alta su propia ficha del protocolo, no en grupo genérico
3	Software	Formación práctica con casos ficticios, nunca con datos reales: alta, agenda, documentación, historia clínica, presupuestos
4	Simulacro	Recorrido completo de Primera Visita cronometrado, cada uno haciendo su parte real

DÍA	FOCO	QUÉ HACE CADA PERFIL ADEMÁS DE LO NORMAL
5	Revisión de incidencias	Cada perfil aporta qué ha fallado de forma repetida en su puesto

DOCUMENTO 12

Continuidad legal, financiera y de sistemas

El almacén que sostiene todo lo demás: qué se transmite y qué no en una adquisición, dónde están los huecos de cobertura, cómo se trata el producto pendiente heredado, qué se comunica y a quién, y el plan de las cuatro primeras semanas. Las secciones legales y fiscales son un **checklist operativo de qué verificar y qué preguntar**, no asesoramiento jurídico: las decisiones finales corresponden siempre a la asesoría legal y laboral del proyecto.

Qué se transmite y qué no

En una adquisición de clínica no todo «pasa» automáticamente al nuevo titular. Conviene tener el mapa antes de dar nada por hecho.

ELEMENTO	¿SE TRANSMITE SOLO?	QUÉ HAY QUE HACER
Autorización sanitaria de funcionamiento	 NO	Trámite de cambio de titularidad ante la autoridad sanitaria autonómica
Historia clínica de los pacientes	 SÍ, CON OBLIGACIÓN DE CUSTODIA	Garantizar acceso y conservación conforme a la Ley 41/2002
Contratos laborales	 DEPENDE	Sí, si hay sucesión de empresa del art. 44 ET. Determinar el escenario y comunicarlo por escrito a cada trabajador
Contratos con proveedores	 DEPENDE	Revisar cláusulas de cambio de control y confirmar continuidad por escrito
Contratos de financiación de pacientes	 EL CONTRATO ES DEL PACIENTE CON LA FINANCIERA	Informar a la financiera del cambio de titularidad

ELEMENTO	¿SE TRANSMITE SOLO?	QUÉ HAY QUE HACER
Responsabilidad por tratamientos ya cobrados	■ DEPENDE DE CÓMO SE ESTRUCTURÓ LA COMPRA	Determinar con asesoría; en la práctica, el paciente espera que se ejecute
Seguro de responsabilidad civil	■ NO	Póliza nueva o endoso a la nueva titularidad
Arrendamiento del local	■ DEPENDE DEL CONTRATO	Revisar la cláusula de cesión

Los cuatro huecos de cobertura del seguro

Es el punto donde más transiciones se juegan el patrimonio, y el que más se da por supuesto.

HUECO	EN QUÉ CONSISTE
Temporal	La póliza nueva empieza el día 2 y la clínica abre el día 1. Un solo día sin cobertura es un riesgo desproporcionado
De titular	La póliza sigue a nombre de Arclimedent y las actuaciones se realizan bajo la nueva titularidad
De profesional	La póliza cubre nominalmente a profesionales que ya no están, y no a los nuevos
De retroactividad	El más técnico: un tratamiento iniciado bajo Arclimedent que genera una reclamación después del cambio. Depende de si la póliza opera por ocurrencia —cubre según cuándo pasó el hecho— o por reclamación —según cuándo se reclama—, y de si hay cobertura retroactiva contratada

LA PREGUNTA EXACTA AL CORREDOR

«¿La póliza cubre reclamaciones presentadas a partir de ahora por tratamientos iniciados bajo la titularidad anterior? ¿Opera por ocurrencia o por reclamación? ¿Hay cobertura retroactiva y desde qué fecha?» Y se pide **la póliza completa**, no un correo diciendo que está todo bien.

Personal · sucesión de empresa

La sucesión de empresa del art. 44 ET aplica cuando se transmite una entidad económica que mantiene su identidad. Una clínica en funcionamiento con instalaciones, equipamiento, pacientes y personal encaja habitualmente en ese

supuesto, pero la calificación final es jurídica y depende de cómo se haya estructurado la operación.

QUÉ IMPLICA SI APLICA

- Se mantienen antigüedad, categoría, salario y condiciones esenciales
- No hay nuevo periodo de prueba
- El nuevo titular se subroga en derechos y obligaciones laborales
- Existe responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario durante un periodo
- Existe deber de información a los trabajadores o a sus representantes

En la práctica: no se puede «elegir» a quién subrogar si legalmente aplica, y las deudas laborales pendientes de la titularidad anterior pueden acabar afectando.

CHECKLIST DE PERSONAL

- ☐ Escenario determinado por asesoría
- ☐ Comunicación escrita entregada a cada trabajador
- ☐ Deber de información cumplido
- ☐ Verificación de deudas laborales pendientes
- ☐ Altas y modificaciones en Seguridad Social
- ☐ Registro horario operativo desde el día 1
- ☐ Formación en prevención de riesgos verificada
- ☐ Vigilancia de la salud al día

Protección de datos e historia clínica

El responsable del tratamiento pasa a ser la nueva titularidad, y los datos de salud son categoría especial: exigen especial diligencia.

ACCIÓN	PLAZO	DETALLE
Informar a los pacientes del cambio de responsable	Cuanto antes	Arts. 13-14 RGPD, con el texto informativo preparado

ACCIÓN	PLAZO	DETALLE
Actualizar el registro de actividades de tratamiento	Primeros días	Reflejar el nuevo responsable
Contrato de encargado con el software de gestión	Antes de operar con datos reales	Art. 28 RGPD
Revisar contratos con otros encargados	Primeras semanas	Laboratorio protésico, gestoría y servicios informáticos
Designar delegado de protección de datos si procede	Según análisis	El tratamiento a gran escala de datos de salud puede requerirlo
Revisar cláusulas informativas y consentimientos	Primeras semanas	Los que se firman en la fase de alta del protocolo
Verificar medidas de seguridad	Primeros días	Control de accesos, cifrado y copias de seguridad

LA MIGRACIÓN DE DATOS ES EN SÍ MISMA UN TRATAMIENTO DE DATOS

Vía segura y documentada, sin copias descontroladas en dispositivos personales, con registro de quién accede a qué y verificación cruzada por muestreo tras cada tanda.

Nunca: exportar historiales a un pendrive personal, enviarlos por email o WhatsApp, o dejarlos en carpetas compartidas sin control de acceso. Y el sistema anterior **no se borra ni se da de baja** hasta verificar que la migración está completa: la Ley 41/2002 obliga a conservar la historia clínica un mínimo de cinco años desde el alta de cada proceso asistencial, y algunas comunidades amplían ese plazo.

Producto pendiente heredado · el número más importante

El valor de todos los tratamientos que los pacientes ya han pagado, total o parcialmente, y que aún no se han ejecutado. Es una obligación real con personas concretas, es caja ya cobrada que sigue generando coste, es el mayor riesgo reputacional —cada semana de espera aumenta la desconfianza— y es la primera fuente de reclamaciones en clínicas adquiridas.

CÓMO SE CONSTRUYE · PRIMEROS TRES DÍAS

Cruzando cinco fuentes: presupuestos aceptados en el sistema anterior, registros de cobro, contratos de financiación externa, trabajos pendientes en laboratorio y citas previstas de tratamientos no iniciados. Para cada caso: importe total, importe cobrado, fase ejecutada y pendiente, forma de pago,

fecha de aceptación y días transcurridos.

PRIORIDAD POR ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD	ACCIÓN
Más de 6 meses	CONTACTO PROACTIVO EN 72 H
De 3 a 6 meses	PRIMERA SEMANA
De 1 a 3 meses	DOS PRIMERAS SEMANAS
Menos de 1 mes	CIRCUITO ESTÁNDAR

PAGO DIRECTO A LA CLÍNICA

- La obligación de ejecutar recae sobre la clínica bajo la nueva titularidad
- «El tratamiento que usted contrató y abonó se realizará tal como se acordó, sin ningún coste adicional»

FINANCIACIÓN EXTERNA

- El contrato de crédito es del paciente con la financiera y no cambia; la clínica debe prestar el servicio
- «Su financiación con [entidad] continúa exactamente igual, no cambia nada en sus cuotas. Y nosotros ejecutamos su tratamiento tal como estaba previsto»

Riesgo específico de la financiación externa: si el tratamiento no se ejecuta, el paciente sigue pagando cuotas por algo que no recibe. Esa situación escala rápido a reclamación formal y a incidencia con la entidad. Por eso el producto pendiente financiado es el más urgente de todos.

Otros frentes financieros del primer mes

FRENTE	QUÉ VERIFICAR
Caja y TPV	Titularidad de las cuentas donde se cobra y datos de facturación correctos desde el día 1
Facturación	Que las facturas emitidas desde hoy lleven la razón social y el CIF correctos
Proveedores	Deudas pendientes de la titularidad anterior y quién las asume

FRENTE	QUÉ VERIFICAR
Laboratorio protésico	Trabajos en curso ya pagados o pendientes de pago
Leasing de equipos	CBCT, OPG y escáner: cuotas, titularidad y cláusulas de cambio de control
Arrendamiento	Cesión del contrato, fianza y cláusulas
Suministros y software	Titularidad de luz, agua, telefonía, internet y licencias del software clínico

Comunicación institucional

PRINCIPIO Y LOS TRES ERRORES MÁS CAROS

Continuidad y mejora, nunca incertidumbre: todo lo bueno que ya había se mantiene y ahora suma recursos.

Silencio —el paciente descubre el cambio por sorpresa—, **exceso de explicación** —genera dudas que nadie tenía— y **mensajes distintos según quién responda** —destruye la credibilidad—.

DOCUMENTO	DESTINATARIO	MENSAJE NUCLEAR
Carta de continuidad	Pacientes existentes	«Su tratamiento, sus condiciones y su relación con nuestro equipo continúan exactamente igual. Todo lo que haya contratado y abonado se mantiene en los mismos términos»
Mensaje breve	Pacientes, por WhatsApp o SMS	«Su clínica es ahora Centro de Excelencia Implantológica Alma. Su tratamiento y sus condiciones continúan igual, con el mismo equipo»
Carta a proveedores	Proveedores y laboratorio	Continuidad de la relación y de las condiciones vigentes, con petición de confirmar el suministro, actualizar datos de facturación e indicar trabajos en curso
Comunicado individual	Cada trabajador	Escenario laboral concreto, con mención expresa a antigüedad, categoría, salario y ausencia de periodo de prueba si hay subrogación
Comunicado a financieras	Entidades de financiación	El centro continuará prestando los servicios contratados en los mismos términos, sin afectar a las condiciones ya suscritas
Información RGPD	Pacientes	Nuevo responsable del tratamiento, finalidad, base jurídica, conservación y derechos

DOCUMENTO	DESTINATARIO	MENSAJE NUCLEAR
Cartel de recepción	Quien entra por la puerta	«El mismo equipo. Su mismo tratamiento. Sus mismas condiciones. Ahora con más tecnología y más recursos a su servicio»

PRESENCIA DIGITAL · EL PUNTO QUE NO ADMITE ERROR

Las reseñas acumuladas son un activo real: el perfil de Google se **renombra**, nunca se crea uno nuevo. Igual con el dominio —redirección, nunca eliminación— y con los perfiles sociales, que se renombran en lugar de abrirse de cero. La señalética exterior espera a lo que confirme la asesoría sobre la autorización sanitaria.

Sistemas · convivencia y contingencia

DOBLE CONSULTA MIENTRAS DURA LA MIGRACIÓN

TIPO DE PACIENTE	DÓNDE SE CONSULTA	DÓNDE SE REGISTRA
Alta antes del cambio	Sistema anterior y archivo en papel	Clinic Cloud
Alta a partir de hoy	Clinic Cloud	Clinic Cloud

Debe nombrarse un responsable único de migración que confirme a diario qué queda pendiente. Sin responsable único, la migración se eterniza.

SI EL SISTEMA CAE

- ☐ Sacar la agenda impresa de respaldo
- ☐ Registro manual: paciente, hora, actuación y cobro
- ☐ Los tratamientos y cobros se realizan con normalidad
- ☐ Al restablecerse, volcado completo verificando cada dato
- ☐ Reporte de la incidencia al Director

Lo que nunca se hace: enviar a un paciente a casa porque «el sistema no funciona».

Plan de las cuatro primeras semanas

SEMANA	OBJETIVO	CIERRA CON
1 · Estabilización	Que nadie note el cambio y que el equipo esté formado en lo básico	Rojos atendidos sin incidencia · comunicación enviada a pacientes, proveedores, personal y financieras · inventario de producto pendiente construido · dudas laborales resueltas por escrito · formación básica completada
2 · Consolidación	Que el protocolo se ejecute sin recordatorios y empiece a bajar el producto pendiente	Producto pendiente de más de tres meses contactado en su totalidad · primeras cirugías del backlog ejecutadas · documentación al día · trámites legales cerrados o con fecha
3 · Optimización	Empezar a medir y mejorar, no solo sostener	Indicadores medidos y comunicados al equipo · puntos abiertos del protocolo resueltos · agenda reorganizada por criterios de productividad · producto pendiente descendente
4 · Proyección	Dejar de gestionar la transición y empezar a gestionar la clínica	Revisión del mes con todo el equipo · objetivos del mes 2 definidos · producto pendiente reducido de forma medible · ninguna reclamación abierta sin plan · presencia digital actualizada

Reuniones: diaria de diez minutos al cierre durante la semana 1; dos reuniones de equipo en la semana 2. La semana 1 tiene además un día para cada cosa: día 1 continuidad pura, día 2 protocolo por perfil, día 3 software con casos ficticios, día 4 simulacro cronometrado de Primera Visita, día 5 revisión de incidencias.

Panel de indicadores del primer mes

INDICADOR	CÓMO SE MIDE	OBJETIVO DEL MES 1
Pacientes heredados atendidos sin incidencia	% sobre el total atendido	> 95 %
Producto pendiente heredado	Importe total	Tendencia a la baja
Casos de más de 6 meses resueltos o agendados	% sobre el total	100 %
Documentación subida el mismo día	%	100 %
Reclamaciones abiertas	Número	0 sin plan de resolución
Tasa de conversión de Primera Visita	%	Establecer línea base
Ticket medio	€	Establecer línea base

INDICADOR	CÓMO SE MIDE	OBJETIVO DEL MES 1
Rotación de personal	Bajas voluntarias	0

SOBRE LOS DOS INDICADORES COMERCIALES

En el primer mes se trata de establecer la línea base, no de superar objetivos. Comparar contra un histórico que no se conoce, o exigir resultados comerciales mientras el equipo aún se estabiliza, es contraproducente.

Checklist maestro de trámites

- ☐ Cambio de titularidad de la autorización sanitaria
- ☐ Designación del director técnico sanitario
- ☐ Póliza de RC a la nueva titularidad
- ☐ Comunicación laboral a cada trabajador y altas en Seguridad Social
- ☐ Comunicación RGPD a pacientes y registro de actividades actualizado
- ☐ Contrato de encargado de tratamiento con el software clínico
- ☐ Comunicación a proveedores y a financieras
- ☐ Licencias de software y contratos de suministros a la nueva titularidad
- ☐ Revisión de leasing de equipos y del arrendamiento del local
- ☐ Facturación emitiendo con datos correctos
- ☐ Perfil de Google, web y redes actualizados

Los diez riesgos de esta transición

#	RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
1	Producto pendiente heredado no identificado	Reclamaciones, pérdida de confianza y problema de caja	Inventario completo en los tres primeros días

#	RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
2	Hueco de cobertura de responsabilidad civil	Exposición patrimonial grave	Verificación documental antes de abrir
3	Personal que se marcha	Pérdida de conocimiento y de vínculo con pacientes	Comunicación laboral clara y anticipada
4	Historiales no accesibles	Riesgo clínico y legal	Doble consulta y archivo localizado
5	Autorización sanitaria sin regularizar	Riesgo regulatorio	Trámite iniciado y documentado
6	Paciente que reclama devolución	Efecto contagio si se gestiona mal	Guiones y escalado único a Dirección
7	Deudas laborales heredadas	Responsabilidad solidaria	Verificación previa con asesoría
8	Pérdida de reseñas	Pérdida de captación	Renombrar perfiles, nunca crear nuevos
9	Migración de datos mal ejecutada	Brecha de seguridad y sanción	Reglas de migración estrictas
10	Exigir resultados comerciales demasiado pronto	Desgaste del equipo y errores	Mes 1 igual a línea base, no a objetivos

LA IDEA QUE SOSTIENE LOS TRES BLOQUES

En una transición de titularidad, lo que se gana o se pierde no es cuota de mercado.

Es la confianza de personas concretas —pacientes que ya estaban y profesionales que ya trabajaban aquí— que hoy no saben del todo qué va a pasar con ellos. Todo lo demás es consecuencia de eso.

«No medias sonrisas» · posicionamiento y objetivo

El documento que está por encima de todos los demás. No describe un procedimiento: fija el norte con el que se contrasta cada decisión clínica y de gestión del centro. Si algo deja al paciente a medias, no es la manera Alma de hacer las cosas.

EL MANIFIESTO

«No medias sonrisas.»

No es un eslogan publicitario: es la declaración de lo que somos y de lo que no aceptamos. Una media sonrisa es un tratamiento a medias, una solución provisional que se eterniza, un paciente al que se le resuelve solo una parte del problema, una boca rehabilitada por fases interminables que nunca terminan de cerrarse. Nuestra promesa es la contraria: la rehabilitación integral, definitiva y mínimamente invasiva, resuelta en el menor tiempo posible —idealmente en un solo día—. Cuando un paciente sale de aquí, sale con la boca resuelta, no con una etapa cumplida.

El origen de la filosofía

«No medias sonrisas» se inspira en la filosofía «*No Half Smiles*», concebida por el Dr. Miguel Stanley, fundador de la White Clinic de Lisboa, una de las clínicas de referencia mundial en odontología. Se reconoce y se respeta ese origen, y se hace propia su idea fundacional adaptándola a la identidad y a la especialidad de Alma: se ofrece únicamente el mejor tratamiento para el diagnóstico completo realizado. No se tratan síntomas sueltos, se trata la causa raíz; no se ponen parches, se resuelve la boca entera.

IDEA HEREDADA	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Diagnóstico completo, no parches	Antes de proponer nada se diagnostica la boca entera y se busca la causa raíz. El plan nace de un diagnóstico total, no del motivo puntual de la visita
La sonrisa completa	Se resuelve el caso de forma integral y definitiva, no por fragmentos inconexos que dejan al paciente a medias

IDEA HEREDADA	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Mínima invasión y mínimo tiempo	La mejor técnica con la menor agresión y en el menor tiempo posible, cuidando la experiencia del paciente

Un parche trata lo que duele hoy y deja intacto el problema de fondo. Un diagnóstico completo entiende toda la boca —y su relación con la salud general— y propone la solución definitiva. Esa es la diferencia entre una media sonrisa y una sonrisa completa.

Parte 1 · El objetivo

LA AMBICIÓN

Ser el centro de referencia mundial en implantología dental y rehabilitaciones complejas mínimamente invasivas, resueltas en un solo día, para pacientes de todo el mundo. No es una aspiración retórica: es una dirección que ordena cada inversión, cada contratación, cada protocolo y cada campaña. Todo lo que se hace se pregunta una sola cosa: **¿nos acerca a ser esa referencia, o nos aparta de ella?**

PALABRA	QUÉ SIGNIFICA
Referencia mundial	No competir por precio en el barrio, sino por excelencia reconocible a nivel internacional. Que un caso complejo piense en Alma
Implantología	El eje. La especialidad en la que se quiere ser insuperable, no una más de la carta
Rehabilitación compleja	Los casos que otros derivan o no saben resolver: bocas completas, atrofas severas, fracasos previos
Mínimamente invasiva, en un día	La menor agresión, el menor tiempo, la mayor predecibilidad. Cirugía guiada y carga inmediata como estándar, no como excepción

Por qué este foco y no otro

Una clínica que quiere ser referencia mundial no puede ser referencia de todo. La elección de foco es lo que hace posible la excelencia.

- **Es donde más se sufre y más se transforma una vida.** Recuperar la capacidad de comer, hablar y sonreír de quien ha perdido sus dientes es de los cambios más profundos que puede ofrecer la odontología
- **Es donde la tecnología marca más diferencia.** El 3D, la planificación digital, la cirugía guiada y la carga inmediata convierten en rutina lo que antes era excepcional

- **Es donde el «un solo día» vale más.** Para un paciente internacional, resolver su caso en una estancia corta no es comodidad: es lo que hace viable venir
- **Es donde el lema es más literal.** Rehabilitar completo, no pieza a pieza durante años
- **Es donde tratar la causa raíz cambia una vida.** En rehabilitación compleja no se maquilla un síntoma: se resuelve el origen, con impacto real en la salud general

El paciente al que se sirve

PERFIL	QUÉ BUSCA AQUÍ
Edentulismo total o parcial severo	Una solución completa y definitiva, no un parche
Fracasos previos	Quien sepa resolver lo que otros no pudieron
Atrofia ósea compleja	Técnica avanzada sin cirugías interminables
Paciente internacional	Resolución en pocos días, con planificación previa a distancia
Paciente que valora la excelencia	Tecnología, garantías y trato por encima del precio

Parte 2 · Los cinco pilares

Ser referencia no se declara: se demuestra con hechos comprobables. Cada pilar tiene su prueba tangible.

PILAR	LA PROMESA	LA PRUEBA TANGIBLE
Un solo día	Rehabilitación fija en veinticuatro horas	Cirugía guiada y carga inmediata como estándar
Mínima invasión	La menor agresión posible	Planificación digital, guía quirúrgica, menos cirugía
Diagnóstico total	Ver lo que otros no ven	CBCT 3D, escáner y planificación protésicamente guiada
Predecibilidad	El resultado se planifica antes de operar	Simulación digital del resultado final
Cuidado de por vida	La relación no termina con la cirugía	Programa de mantenimiento y seguimiento

CLÍNICA CONVENCIONAL

- Rehabilita por fases durante meses o años
- Deriva los casos complejos
- Diagnóstico limitado a la zona del dolor
- Compite por precio
- El paciente es local
- La relación acaba al cobrar
- «Le vamos haciendo»

CENTRO DE EXCELENCIA ALMA

- Resuelve en el menor tiempo posible, idealmente en un día
- Los casos complejos son su especialidad
- Diagnóstico integral de boca completa
- Compite por excelencia y resultado
- El paciente puede venir de todo el mundo
- La relación se sostiene de por vida
- «No medias sonrisas»: se resuelve completo

LA PROMESA EN UNA FRASE

«Le devolvemos su sonrisa completa, en el menor tiempo posible, y le cuidamos para siempre.»

Son dos promesas complementarias: la primera es sobre el **resultado** —la sonrisa completa, en un día—; la segunda, sobre la **relación** —el cuidado para siempre, que desarrolla el programa de mantenimiento—. Este documento fija la primera; el programa de mantenimiento del Manual Maestro desarrolla la segunda.

Parte 3 · De lema a comportamiento

Un posicionamiento que no cambia el comportamiento diario es solo un cartel en la pared. Tiene que notarse en cómo se responde al teléfono, cómo se diagnostica, cómo se presenta un plan y cómo se cierra un caso.

PERFIL	CÓMO ENCARNA «NO MEDIAS SONRISAS»
Recepción	Filtra buscando el caso completo, no solo el motivo puntual. Transmite desde la primera llamada que aquí se resuelven casos complejos
Doctor	Diagnostica la boca completa y propone el plan definitivo, no el parche. Piensa en el resultado final desde el primer día
Director	Presenta la solución integral y su valor; nunca fracciona el plan «para que entre» a costa de dejar el caso a medias
RAC	Garantiza que el plan completo se ejecuta hasta el final; persigue los tratamientos que se quedan a medias
Higienista	Sostiene el resultado en el tiempo; detecta a tiempo para que ninguna rehabilitación se degrade
Auxiliar	Garantiza que la tecnología y el material estén a la altura de resolver el caso completo en un día

Dónde se juega en cada fase del recorrido

FASE	DÓNDE SE JUEGA EL POSICIONAMIENTO
Primera llamada	Se comunica que aquí se resuelven casos complejos, no simples urgencias
Tour por la tecnología	La prueba visible del «un solo día» y de la mínima invasión
Diagnóstico integral	Boca completa: se ve el problema entero, no un fragmento
Presentación del plan	Se presenta la solución completa y definitiva
Cierre	Se defiende el plan integral: el fraccionamiento es de pago, no de alcance
Ejecución en un día	La promesa se cumple: rehabilitación fija con la menor cirugía posible
Mantenimiento	El cuidado de por vida garantiza que la sonrisa completa se mantenga completa

LA DISTINCIÓN QUE EVITA MALENTENDIDOS

El **fraccionamiento económico** —pagar por fases— es legítimo y bueno. Lo que «No medias sonrisas» prohíbe es el **fraccionamiento del alcance**: dejar el caso clínicamente a medias. Se puede pagar por partes; no se puede quedar a medias.

Las decisiones que el lema descarta

- Resolver solo la urgencia y no ofrecer el diagnóstico completo
- Vender un tratamiento parcial sabiendo que el paciente necesita más, sin explicárselo
- Alargar innecesariamente por fases lo que puede resolverse en un día
- Dejar tratamientos a medias sin seguimiento ni cierre, que es exactamente lo que es el producto pendiente
- Competir bajando calidad para bajar precio

El producto pendiente y los tratamientos sin finalizar que vigilan el **circuito de RAC** y el **inventario heredado** son, literalmente, medias sonrisas sin cerrar. Reducirlos a cero no es solo buena gestión: es cumplir el posicionamiento.

Parte 4 · Cómo se comunica

HACIA DENTRO · EL EQUIPO

El primero que tiene que creerlo es el equipo: un paciente nota en dos minutos si quien le atiende cree de verdad en lo que ofrece.

- **En la incorporación:** quien entra conoce el posicionamiento el primer día, antes que cualquier procedimiento
- **En las reuniones:** las decisiones se contrastan con el lema —«¿esto deja al paciente a medias?»
- **En la visibilidad:** el lema está presente en las zonas internas del equipo, no solo de cara al paciente

HACIA FUERA · MENSAJES POR AUDIENCIA

AUDIENCIA	MENSAJE PRINCIPAL
Paciente local	Aquí se resuelve su caso completo, en el menor tiempo posible
Paciente complejo o con fracasos	Lo que otros no pudieron resolver, aquí sí
Paciente internacional	Su rehabilitación completa en pocos días, planificada antes de venir
Prescriptores y colegas	El centro de referencia al que derivar el caso difícil

Dónde se comunica: casos reales de rehabilitación completa en un día, con consentimiento, en web y redes; reseñas orientadas a resaltar la resolución completa y el trato; contenido que explique al paciente el «un solo día» y la mínima invasión; y

presencia internacional con idiomas, planificación a distancia y facilidades para quien viaja.

SOMOS

- Excelencia cercana
- Seguros de nuestra técnica
- Claros y honestos
- Centrados en el resultado del paciente
- Referencia internacional

NO SOMOS

- Lujo frío e inaccesible
- Arrogantes
- Vendedores de humo
- Centrados en el precio
- Una clínica de barrio más

LO QUE NUNCA SE DICE NI SE HACE

No se prometen resultados que no se puedan garantizar, no se usan testimonios sin consentimiento y no se menciona a la competencia.

La ambición de ser referencia mundial nunca justifica una promesa que no se pueda cumplir: eso sería, precisamente, una media sonrisa.

SÍNTESIS

Un objetivo —ser referencia mundial—, una especialidad —implantología y rehabilitación compleja mínimamente invasiva en un día— y un criterio que lo ordena todo: **resolver completo, nunca a medias.**

DOCUMENTO 14

ATC · Alma Te Cuida

La otra mitad de la promesa. «No medias sonrisas» dice qué se resuelve; **Alma Te Cuida** dice cómo se acompaña después. No es un extra ni un añadido comercial: es la parte del tratamiento que garantiza que lo hecho siga bien dentro de cinco años.

DÓNDE VIVE ESTE DOCUMENTO

El programa entero —qué es en una tarjeta, por qué se ofrece a todos, los cuatro argumentos, el speech situación por situación, el manejo de objeciones, quién lo ofrece y cuándo, la campaña sobre la base de datos, las herramientas y la formación, el panel de control, el marco legal y el checklist de arranque— está en el Plan Maestro de Marketing, apartado 20, en su Parte VIII.

Se mudó allí porque es donde se usa: el catálogo de marketing trae al paciente y el ATC es lo que hace que se quede. Tenerlo en dos sitios habría creado dos versiones del mismo speech, que es exactamente lo que este sistema existe para evitar.

[Abrir el programa ATC](#)

DÓNDE SE ENGANCHA CON EL RECORRIDO

Se presenta en la Fase 10 al cerrar el tratamiento, se activa en la Fase 11 con su contrato, y se vive en la Fase 14, donde el programa de mantenimiento lo convierte en visitas reales.

C I E R R E

Cómo encajan los catorce documentos

Cada uno resuelve una pregunta distinta y en un momento distinto. Leídos en el orden equivocado se contradicen; leídos en el suyo, se apoyan.

MOMENTO	PREGUNTA	DOCUMENTO QUE LA RESPONDE
Antes de abrir	¿Puedo operar sin riesgo legal?	Verificaciones V1 a V3 y semana 1 del dossier
Día 1	¿Qué he comprado realmente?	Auditoría integral y 322 puntos
Semana 2	¿Con qué marco trabaja el equipo?	Decisiones 1 a 6
Semana 3	¿Va bien o va mal?	Los cinco números
Día 30 al 100	¿Cómo se transforma sin romper nada?	Programa de 100 días
Continuo	¿Qué hace cada puesto, exactamente?	Protocolos por perfil y el Manual Maestro
Continuo	¿Cómo es una primera visita impecable?	Protocolo de Primera Visita
Cada trimestre	¿Qué mejoramos ahora?	Una ficha de innovación
La noche antes y el día 1	¿Qué digo cuando un paciente pregunta por su dinero?	Cuaderno de campo
Día 1 y semana 1	¿Qué hace exactamente mi puesto mientras cambia la titularidad?	Puesta en marcha por perfil
Del día 1 al mes 1	¿Qué se transmite, qué no, y qué hay que verificar?	Continuidad legal y financiera
Siempre, antes que nada	¿Esto deja al paciente a medias?	«No medias sonrisas»
Al cerrar cada tratamiento	¿Quién cuida esto dentro de cinco años?	ATC · Alma Te Cuida
Desde el día 30	¿Cómo llegan los pacientes correctos?	Plan de marca y captación

LA SECUENCIA, EN UNA LÍNEA

Sostener → recuperar → fidelizar → captar.

Y dentro de cada tramo, una sola cosa a la vez: una innovación por trimestre, un flujo de automatización al mes, un área de auditoría por semana. Todo lo que se ha intentado hacer en paralelo en clínicas comparables terminó sin implantarse.



Centro de Excelencia Implantológica Alma

Otros documentos del sistema

Documento interno de uso restringido. Contiene información económica, laboral y estratégica del centro. Toda innovación clínica requiere validación previa del responsable clínico, y toda comunicación externa, validación de la asesoría en publicidad sanitaria.

VERSIÓN

v32.0 · Agosto 2026

Revisión semestral

CONTENIDO

14 documentos del sistema

322 puntos de verificación · 20 decisiones

18 fichas de innovación · 6 perfiles operativos

Manual Maestro de Operaciones

Protocolo de Primera Visita

Instrumento de medición · Ejercicio 2026 · Uso interno

Los números del centro

Un cuaderno donde se apunta, mes a mes, lo que de verdad pasa en la clínica. Diez cosas que se cuentan y siete datos de contabilidad. Con eso, la hoja calcula sola los cinco números que la Junta necesita para decidir con hechos en vez de con impresiones.

Por qué existe

Hoy el centro no tiene ni un solo mes medido. Todas las cifras económicas del Plan de Dirección son **modelos sobre rangos del sector**, no datos propios. Mientras siga así, cualquier objetivo comercial es una opinión bien argumentada. Esta hoja es la que convierte la opinión en dato.

Quién la rellena y cuándo

Gerencia, **una vez al mes**, entre el día 15 y el 21. Se tarda unos veinte minutos: casi todo sale del gestor de clínica y de la contabilidad del mes. Hay doce hojas, una por mes del año.

Qué hay que teclear

Solo las casillas amarillas. **Diez indicadores** —cuántos, sobre cuántos— y **siete entradas** de dinero y capacidad. El resultado, el semáforo de color, el resumen del año y la tendencia se calculan solos.

Qué sale de aquí

Los **cinco números**: lo que cuesta tener el centro abierto, cuánto hay que facturar para no perder dinero, cuántas primeras visitas al día hacen falta para llegar ahí, cuánto trabajo cobrado queda por hacer y cuántos meses aguanta el centro sin ingresar nada.

Dónde se guarda

En este mismo ordenador, dentro del navegador. **No se envía nada a ningún sitio** y no lo ve nadie más. Tampoco se sincroniza: para llevárselo a otro equipo hay que usar «Guardar copia» y «Cargar copia».

La regla que no se salta

Un hueco se declara. Si un mes falta un dato, la casilla dice **SIN DATO** y cuenta como roja; los cinco números dicen **pendiente** en vez de dar una cifra inventada. Un número inventado es peor que un hueco reconocido.

De arriba abajo, este es el recorrido

- 1 Se leen las definiciones: qué cuenta y qué no cuenta en cada indicador, para que un mes se mida igual que el siguiente.
- 2 Cada mes se rellena su hoja: diez numeradores, diez denominadores y una nota de estado.
- 3 El resumen anual junta los doce meses en una rejilla y enseña la tendencia sin que nadie la calcule.
- 4 Con las siete entradas de contabilidad salen los cinco números, que son los que van a la Junta.



CÓMO SE USA

Tres reglas y ninguna más

Regla 1 Solo se teclea lo amarillo Numeradores, denominadores y las siete entradas de los cinco números. El resultado, el semáforo, el resumen anual y la tendencia se calculan solos.	Regla 2 Sin dato es rojo No se deja en blanco ni se sustituye por una impresión. Mientras no haya cifra, la casilla dice SIN DATO y cuenta como roja en la revisión de Junta.	Regla 3 El 6 nace provisional La conversión tiene cohorte cerrada a sesenta días: el dato de un mes no es definitivo hasta dos meses después. Se marca en «Estado del dato» y se corrige en la revisión siguiente.
---	--	---

Dónde vive lo que escribe

En el almacenamiento local de este navegador y de este equipo. No viaja a ningún servidor y no lo ve nadie más, pero tampoco se sincroniza: si abre el archivo en otro ordenador, empieza vacío. Para llevárselo, use **Guardar copia** —descarga un archivo con todo lo introducido— y **Cargar copia** en el otro equipo. Para el acta, **Imprimir** saca las doce hojas y el resumen en papel.

DEFINICIONES

Qué se cuenta arriba, qué se cuenta abajo

Un indicador sin definición operativa no se puede medir dos meses seguidos de la misma manera. Los umbrales de las dos últimas columnas son **supuestos de trabajo**, no objetivos aprobados: se cambian aquí una sola vez y los recogen las doce hojas.

#	INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	FUENTE	QUÉ QUEDA FUERA	VERDE SI	ÁMBAR SI
1	Verificaciones regulatorias cerradas	Verificaciones V1–V11 con evidencia archivada y fechada	11 (fijo)	Expediente de verificaciones externas	Nada: una verificación «en trámite» cuenta como no cerrada	1	0.8
2	Bajas voluntarias del equipo	Ceses a instancia de la persona trabajadora	Plantilla media del mes	Registro laboral	Fin de contrato temporal ya previsto e incapacidades temporales	0	0.05
3	Reclamaciones de pacientes heredados	Reclamaciones formales del mes	—	Registro de incidencias	Quejas verbales resueltas en el acto y registradas como incidencia de nivel 1	0	1
4	Documentación digitalizada el mismo día	Actos con historia, consentimiento e imágenes en el día	Actos clínicos del día	Gestor de clínica	Nada	0.98	0.9
5	Producto pendiente	Importe aceptado y no terminado a fin de mes	—	Informe de tratamientos abiertos	Presupuestos presentados y no aceptados	0	0
6	Tasa de conversión de la primera visita	PV del mes aceptadas y pagadas dentro de 60 días	Primeras visitas del mes	Agenda y presupuestos, cruzados	Urgencias, segundas opiniones y derivaciones a otro centro por criterio clínico	0.45	0.35
7	Pacientes en mantenimiento activo	Con revisión en 12 meses y próxima cita agendada	Pacientes con implantes del centro	Gestor de clínica	Pacientes con cita agendada pero sin ninguna asistencia en 12 meses	0.6	0.4
8	Captación por recomendación	PV cuyo origen declarado es la recomendación	Primeras visitas del mes	Campo obligatorio de origen en la ficha	Nada: el origen «no consta» permanece en el denominador	0.3	0.2
9	Ofrecimiento del programa de cuidado	Cierres con el ofrecimiento registrado	Cierres de tratamiento del mes	Punto de verificación del cierre	Nada: se mide el ofrecimiento, no la contratación	0.9	0.8
10	Auditorías ejecutadas en fecha	Auditorías realizadas con resultado registrado	Auditorías programadas	Calendario de auditoría	Nada: una auditoría sin registro cuenta como no realizada	1	0.5

CAPTURA MENSUAL

Una hoja por mes

Elija el mes y rellene lo amarillo. Lo introducido se guarda al momento.

#	INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	UMBRAL	ESTADO	ESTADO
1	Verificaciones regulatorias cerradas Verificaciones V1–V11 con evidencia archivada y fechada		11		11 de 11	SIN DATO	
2	Bajas voluntarias del equipo Ceses a instancia de la persona trabajadora				0	SIN DATO	
3	Reclamaciones de pacientes heredados Reclamaciones formales del mes		–		0	SIN DATO	
4	Documentación digitalizada el mismo día Actos con historia, consentimiento e imágenes en el día				100 %	SIN DATO	
5	Producto pendiente Importe aceptado y no terminado a fin de mes		–		Descendente	SIN DATO	
6	Tasa de conversión de la primera visita PV del mes aceptadas y pagadas dentro de 60 días				Línea base y mejora	SIN DATO	Provis
7	Pacientes en mantenimiento activo Con revisión en 12 meses y próxima cita agendada				Creciente	SIN DATO	
8	Captación por recomendación PV cuyo origen declarado es la recomendación				Creciente	SIN DATO	
9	Ofrecimiento del programa de cuidado Cierres con el ofrecimiento registrado				90 %	SIN DATO	
10	Auditorías ejecutadas en fecha Auditorías realizadas con resultado registrado				100 %	SIN DATO	

RESUMEN ANUAL

Los doce meses en una rejilla

Meses con dato es la medida honesta de cuánto se sabe realmente. La Junta debe exigir que llegue a doce.

#	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MESES
1	Verificaciones regulatorias cerradas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
2	Bajas voluntarias del equipo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
3	Reclamaciones de pacientes heredados	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
4	Documentación digitalizada el mismo día	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
5	Producto pendiente	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
6	Tasa de conversión de la primera visita	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
7	Pacientes en mantenimiento activo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
8	Captación por recomendación	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
9	Ofrecimiento del programa de cuidado	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€
10	Auditorías ejecutadas en fecha	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	€

El indicador 5 mide euros: su tendencia «Mejora» significa que el producto pendiente baja.

LOS CINCO NÚMEROS

Sin ellos, cualquier objetivo comercial es una opinión

Siete entradas y cinco resultados. Mientras falte una entrada, el resultado dice «pendiente»: un número inventado es peor que un hueco declarado.

COSTES FIJOS MENSUALES €

Nóminas, alquiler, suministros, seguros, cuotas y amortizaciones. Día 15.

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN %

40

Supuesto de trabajo del apartado 18 mientras no haya escandallo propio.

TICKET MEDIO DEL CASO ACEPTADO €

1800

Supuesto de trabajo del apartado 18. Se sustituye por el real.

TASA DE CONVERSIÓN %

45

Enlaza con el indicador 6 en cuanto haya tres meses de serie.

DÍAS LABORABLES AL MES D

21

Parámetro de capacidad.

TESORERÍA DISPONIBLE €

Saldo libre de compromisos a fecha de corte. Día 21.

PRODUCTO PENDIENTE HEREDADO €

Importe cobrado o comprometido y no ejecutado. Día 15.

NATURALEZA DE LO PRECARGADO

Margen, ticket, conversión y días vienen con los supuestos de trabajo del apartado 18, que **no son mediciones del centro**. Sustitúyanse por los reales en cuanto existan; las otras tres casillas nacen vacías porque solo pueden salir de la contabilidad.

1 · COSTES FIJOS MENSUALES

pendiente

El primero de los cinco. Sin él no hay ninguno de los demás.

2 · PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL

pendiente

Facturación mensual necesaria para cubrir los costes fijos, dado el margen de contribución.

3 · PRIMERAS VISITAS AL DÍA

pendiente

Cuántas hacen falta para llegar al equilibrio con la conversión y el ticket actuales.

4 · PRODUCTO PENDIENTE HEREDADO

pendiente

Caja ya cobrada que hay que convertir en producción. Es la palanca 1 del apartado 14.

5 · MESES DE COLCHÓN

pendiente

Cuánto aguanta el centro sin ingresar nada. Por debajo de tres, es riesgo de Junta.

La cifra que más incomoda

Las primeras visitas necesarias al día se comparan con la capacidad real de la agenda.
Rellene costes fijos, margen, ticket, conversión y días para verlo.



Centro de Excelencia Implantológica Alma

Los números del centro · Ejercicio 2026

Documento de uso interno. Los datos se guardan únicamente en este equipo.

Instrumento de

apartado 7 · Línea base

apartado 13 · Cuadro de mando

Documentos de referencia

Plan de Dirección v32.0

Manual Maestro v32.0

Protocolo de Primera Visita v32.0